

AWCA RESOURCE CENTER

Complete Knowledge Base & Guidebook

공식 AWCA 리소스 센터 종합 가이드북 (전 12개 부문 완벽 수록)

A comprehensive, word-for-word archive of all official community resources, social welfare programs, healthcare guides, senior housing directories, Medicaid & Medicare enrollments, and legal planning guides published by the AWCA Resource Center.

12

RESOURCE SECTIONS

200

TOTAL ARTICLES

2 (EN & KO)

LANGUAGES

Published by AWCA Resource Center (<https://awcarc.org/>) • Compiled on September 8, 2026 • Teaneck, NJ

Table of Contents — English Edition (Part I)

Section 1: US Adult Welfare (3 guides)

Older Americans Act (OAA)
Administration for Community Living (ACL)
Administration on Aging (AOA)

Section 2: Financial Assistance (9 guides)

Social Security
Comfort Partners Program (New Jersey)
Senior Farmers' Market Nutrition Program (SFMNP)
Lifeline Utility Assistance Program (New Jersey)
Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
New Jersey Statewide Heating Assistance and Referral for Energy Services (NJ SHARES)
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP aka Food Stamp)
Social Security Disability Insurance (SSDI)
Supplemental Security Income (SSI)

Section 3: Medicare (11 guides)

Medicare Overview
Medicare Buy-In
Healthcare Cost Assistance
Low Income Subsidy (LIS, Extra Help)
Medical Bills: How It Works
Medicare Supplement Insurance (Medigap)
New Jersey Pharmaceutical Assistance to the Aged & Disabled (PAAD) and Senior Gold
Medicare Part C (Medicare Advantage)
Medicare Part D (Prescription Drug Plan, PDP)
Medicare Parts A & B (Medicare Original)
Medicare Savings Programs (MSP)

Section 4: Medicaid (9 guides)

Medicaid Overview
ACA Marketplace
ACA Medicaid (Medicaid Expansion)
Children's Health Insurance Program (CHIP)
Hearing Aid
Long Term Care Medicaid (MLTSS)
Medicaid Managed Care Organization (MCO) System of New Jersey
Pregnancy Medicaid
ABD Medicaid (NJ FamilyCare ABD)

Section 5: Medicaid Specials (9 guides)

Charity Care / Hospital Care Payment Assistance
Dual Eligible Plan (D-SNP)
Emergency Medical Assistance (Emergency Medicaid)
Funeral & Burial Assistance
Medicaid Buy-In (NJ WorkAbility)
Medicaid Estate Recovery
Spousal Impoverishment Rules
Medicaid General Assistance (WFNJ/GA)
Temporary Assistance for Needy Families (TANF)

Section 6: Chronic Diseases (11 guides)

Chronic Diseases
Aging Process
Arthritis
Cancer
Dementia
Diabetes
Heart Disease
Mental Health
Mind-Body Medicine
Obesity
Stroke

Section 7: Long Term Care Program (6 guides)

Long Term Care Overview
Adult Day Care
Hospice Care
Long Term Care Ombudsman
Nursing Home Care
Rehabilitation & Skilled Nursing

Section 8: Hospital Care (9 guides)

Ambulance Services
Bereavement Care
Community Clinics & Free Healthcare
Emergency Room (ER) Care
Inpatient Admission
Inpatient Rehabilitation Care
Medical Home Care
Observation Care
Treatment

Section 9: Housing (12 guides)

Affordable Housing (LIHTC)
ANCHOR(Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters)
Assisted Living
Continuing Care Housing
New Jersey Property Tax Relief Programs
Property Tax Reimbursement (Senior Freeze)
Residential Health Care Facilities (RHCF)
Adult Retirement Communities
Reverse Mortgage
Section 8
Senior Apartments
Stay NJ Program

Section 11: Senior Protection (4 guides)

Adult Protective Services (APS)
Legal Services for Seniors
Ombudsman
Senior Scam & Cyber Security

Section 10: In-Home Care (6 guides)

Congregate Meals
Home Health Care
Jersey Assistance for Community Caregiving (JACC)
Meals on Wheels
Personal Preference Program (PPP)
Respite Care

Section 12: Retirement Planning (11 guides)

AARP (American Association of Retired Persons)
Advance Directive
Age-Friendly Communities
Leisure Activities & Senior Centers
Living Trust
Instruction Directive (Living Will)
Medicaid Trusts
Power of Attorney (POA)
Reverse Immigration to Korea
Senior Transportation Services
Will

목차 (Table of Contents) — 한국어 가이드 (Part II)

제 1 편: 미 성인 복지 (US Adult Welfare) (3개 문서)

노인법 (Older Americans Act, OAA)
커뮤니티 생활 지원청 (Administration for Community Living, ACL)
노인청 (Administration on Aging, AOA)

제 2 편: 재정 지원 (Financial Assistance) (9개 문서)

소셜 시큐리티 연금 (Social Security)
저소득층 에너지 효율 지원 (Comfort Partners Program)
시니어 파머스 마켓 영양 프로그램 (SFMNP)
라이프라인 유틸리티 지원 프로그램 (Lifeline Utility Assistance Program)
LIHEAP (저소득 가정 에너지 지원 프로그램)
NJ SHARES (뉴저지 비상 지원 프로그램)
SNAP 프로그램 (푸드 스탬프)
장애인 소셜 시큐리티 연금 (SSDI)
생활보조금 (Supplemental Security Income, SSI)

제 3 편: 메디케어 (Medicare) (11개 문서)

메디케어 (Medicare) 개요
메디케어 바이-인 (Medicare Buy-In)
의료 및 처방약 보조 프로그램
저소득층 처방약 보조 프로그램 (LIS, Extra Help)
메디케어 의료비 클레임 가이드
메디갭 (Medigap)
뉴저지 저소득층 약값 지원 (PAAD & Senior Gold)
메디케어 파트 C (Medicare Advantage)
메디케어 파트 D (처방약 플랜)
메디케어 파트 A & B (Original Medicare)
메디케어 비용 절감 프로그램 (MSP)

제 4 편: 메디케이드 (Medicaid) (9개 문서)

메디케이드 (Medicaid) 개요
ACA 마켓플레이스
ACA 메디케이드 (Medicaid Expansion)
아동 건강 보험 프로그램 (CHIP)
보청기 지원 (Hearing Aid)
롱텀케어 메디케이드 (MLTSS)
메디케이드 관리 보험사 (MCO) 시스템 (뉴저지)
임산부 메디케이드 (Pregnancy Medicaid)
ABD 메디케이드 (뉴저지 패밀리케어 ABD)

제 5 편: 메디케이드 특별 플랜 (Medicaid Specials) (9개 문서)

병원비 지원 프로그램 (Charity Care)
듀얼 플랜 (D-SNP)
응급 의료비 지원 (Emergency Medicaid)
장례 지원 프로그램 (Funeral & Burial Assistance)
메디케이드 바이-인 (Medicaid Buy-In, NJ WorkAbility)
메디케이드 회수 (Medicaid Estate Recovery)
배우자 생계 보호 규정 (Spousal Impoverishment Rules)
Medicaid General Assistance (WFNJ/GA)
Temporary Assistance for Needy Families (TANF)

제 7 편: 장기 요양 프로그램 (Long Term Care Program) (6개 문서)

롱텀케어 (Long Term Care) 개요
어덜트 데이 케어 (Adult Day Care)
호스피스 케어(Hospice Care)
롱텀케어 옴부즈맨 (Long Term Care Ombudsman)
넬싱홈 케어 (Nursing Home Care)
전문 재활 및 간호 서비스 (Rehabilitation & Skilled Nursing)

제 9 편: 주거·주택 (Housing) (12개 문서)

어포더블 하우스 (LIHTC)
앵커(ANCHOR)
어시스티드 리빙 (Assisted Living)
연속형 은퇴 주거 단지(Continuing Care Housing)
재산세 감면 프로그램(Property Tax Relief Programs)
재산세 환급 (PTR / Senior Freeze)
주거용 요양 시설(Residential Health Care Facilities, RHCF)
시니어 전용 주거 단지(Adult Retirement Communities)
리버스 모기지 (Reverse Mortgage)
섹션 8 (Section 8)
시니어 아파트 (Senior Apartments)
스테이 뉴저지 (Stay NJ)

제 6 편: 만성 질환 (Chronic Diseases) (11개 문서)

만성 질환 (Chronic Diseases)
노화 과정 (Aging Process)
관절염 (Arthritis)
암 (Cancer)
치매 (Dementia)
당뇨병 (Diabetes)
심장 질환 (Heart Disease)
정신 건강 (Mental Health)
심신 의학 (Mind-Body Medicine)
비만 (Obesity)
뇌졸중 (Stroke)

제 8 편: 병원 케어 (Hospital Care) (9개 문서)

구급차 서비스 (Ambulance Services)
유가족 돌봄 (Bereavement Care)
커뮤니티 클리닉 (Community Clinics & Free Healthcare)
응급실 케어 (Emergency Room Care)
입원 (Inpatient Admission)
입원 재활 케어 (Inpatient Rehabilitation Care)
메디컬 홈케어 (Medical Home Care)
관찰 병동 케어 (Observation Care)
병원 진료 (Treatment)

제 10 편: 재택 케어 (In-Home Care) (6개 문서)

시니어 단체 급식(Congregate Meals)
홈케어 (Home Health Care)
뉴저지 간병 지원 프로그램(JACC)
가정 배달 서비스 (Meals on Wheels)
간병인 지정 프로그램(PPP)
간병인 휴식 지원 (Respite Care)

제 11 편: 시니어 권익 보호 (Senior Protection) (4개 문서)

성인 보호 서비스 (Adult Protective Services, APS)
시니어 법률 지원 (Legal Services for Seniors)
옴부즈맨 (Ombudsman)
시니어 대상 사기 및 사이버 보안 (Senior Scam & Cyber Security)

제 12 편: 은퇴·노후 준비 (Retirement Planning) (11개 문서)

AARP (은퇴자협회)
사전 의료 지시서 (Advance Directive)
시니어 친화적 커뮤니티 (Age-Friendly Communities)
레저와 레크리에이션
리빙 트러스트 (Living Trust)
연명의료계획서 (Living Will)
메디케이드 트러스트 (Medicaid Trusts)
위임장 (Power of Attorney, POA)
역이민 (영주귀국 및 국적 회복)
시니어 교통 서비스 (Senior Transportation)
유언장 (Will)

PART I • SECTION 1

US Adult Welfare

미 성인 복지 (US Adult Welfare)

Federal adult welfare laws, the Older Americans Act (OAA), and administration policies supporting senior independence and community welfare.

This section contains 3 comprehensive guides

Older Americans Act (OAA)

The Older Americans Act (OAA), passed in 1965, is a federal law that provides home- and community-based services to help older adults (ages 60 and older) live independently. This law established the National Aging Network to coordinate services and programs at the federal (AoA), state (State Units on Aging), and local (AAA) levels.

KEY ASPECTS

Comprehensive Services for Independent Living

The OAA authorizes a wide array of services, including in-home support, meals, transportation, legal services, and other programs that promote independence and well-being for older adults.

Federal Funding Support for Aging Programs

The OAA is a major source of federal funding for programs aimed at improving the lives of older Americans, particularly those with the greatest economic and social need.

Long-Term Care Ombudsman Program Establishment

The OAA established the Long-Term Care Ombudsman Program, which provides advocates for residents of long-term care facilities to help resolve complaints and ensure their rights are protected.

Prevention of Elder Abuse, Neglect, and Exploitation

The OAA includes provisions for preventing and addressing elder abuse, neglect, and exploitation.

Reauthorization and Legislative Amendments History

Since the Older Americans Act (OAA) was first passed in 1965, the Supporting Older Americans Act of 2020 (P.L. 116-131) authorized appropriations for FY2020 through FY2024, and the official authorization period expired as of September 30, 2024. Discussions regarding subsequent reauthorization are currently underway.

OAA 7 Titles

Title	Name	Key Contents
Title I	Declaration of Objectives; Definitions	- States the goals and philosophy of the OAA - Defines key terms like "older adult" and "family caregiver" - No direct funding allocation
Title II	Administration on Aging	- Establishes the federal Administration on Aging (AoA) - Establish the basis for the creation of State Units on Aging and Area Agencies on Aging (AAA)
Title III	Grants for State and Community Programs on Aging	- Accounts for the largest share of OAA funding. - Covers meals, transportation, caregiving, in-home support - Supports family caregivers, health promotion, and vulnerable seniors
Title IV	Activities for Health, Independence, and Longevity	Alzheimer's disease research, falls prevention, chronic disease self-management programs, workforce training, and demonstration projects.
Title V	Community Service Employment for Older Americans (CSEOA) (commonly known as the Senior Community Service Employment Program, SCSEP)	- Adults aged 55 or older who are currently unemployed and have a household income at or below 125% of the Federal Poverty Guidelines. - Offers training and pathways to permanent jobs - Operated by the U.S. Department of Labor
Title VI	Grants for Services for Native Americans	- Supports American Indian, Alaska Native, and Native Hawaiian elders - Provides meals, in-home services, caregiving support

Title	Name	Key Contents
		Federal government grants directly to tribal organizations without passing through the State.
Title VII	Vulnerable Elder Rights Protection Activities	- Runs long-term care ombudsman programs - Prevents abuse, neglect, and exploitation - Includes legal assistance and rights advocacy

Resources

- [ACL.gov: OAA Overview \(Administration for Community Living\)](#).
- [Overview and funding \(Congressional Research Service\)](#).

Administration for Community Living (ACL)

The Administration for Community Living (ACL) is a federal agency under the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its official mission is to maximize the independence, well-being, and health of older adults, people with disabilities across the lifespan, and their families and caregivers. To achieve this, it provides grants to states, communities, and non-profit organizations; invests in research, education, and innovation; coordinates federal programs; and engages in advocacy.

Key Aspects

Advancing Community Living

ACL supports people with disabilities and older adults so that they can live in the place and environment of their choice—rather than in institutions—and exercise their right to make their own decisions.

Supporting Independent Living

ACL funds and supports programs that help individuals with disabilities gain the skills and resources they need to live independently.

Promoting Health and Well-being

ACL provides funding for evidence-based health promotion programs, including falls prevention, chronic disease self-management, nutrition services, and brain health.

Supporting Family Caregivers

ACL operates programs such as the National Family Caregiver Support Program and the Lifespan Respite Care Program to support family caregivers.

Promoting Inclusion and Equal Opportunity

ACL is committed to ensuring that older adults and people with disabilities have access to the same opportunities as everyone else and are included in all aspects of community life.

Improving Access to Services

ACL ensures that everyone can easily connect to local services through resources such as the Eldercare Locator (eldercare.gov, 800-677-1116) for older adults and the Disability Information and Access Line (DIAL) (888-677-1199) for people with disabilities.

Enhancing Coordination

ACL strives to reduce fragmentation between federal programs and collaborates with more than 20 federal departments and agencies, as well as states, tribal and local governments, and the private sector to ensure individuals can seamlessly receive the support they need.

Resources

[ACL.gov: ACL Programs and Services Overview](#)

Administration on Aging (AOA)

The Administration on Aging (AoA) is a major agency within the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) and a program office under the Administration for Community Living (ACL), serving as the lead federal agency responsible for implementing the provisions of the Older Americans Act (OAA).

Mission

The mission of the AoA is to develop and support a comprehensive, coordinated, and cost-effective system of home- and community-based services that helps older adults live healthy and independent lives in their homes and communities.

Aging Services Network

The AoA collaborates with the National Aging Network—including Area Agencies on Aging (AAAs), State Units on Aging (SUAs), and tribal organizations—to ensure that older adults receive the services necessary to live independently and healthily in their homes and communities. Furthermore, through the aging services network, the AoA supports home- and community-based services, advocates for the interests of older adults and their caregivers, and operates evidence-based health promotion programs such as nutrition, falls prevention, and chronic disease self-management.

Older Americans Act

The AoA was established by the OAA of 1965 and is responsible for implementing the provisions of the Act, including the administration of funding and grant programs. However, Title V (the Community Service Employment for Older Americans, CSEOA, commonly known as the Senior Community Service Employment Program, SCSEP) is separately administered by the Department of Labor (DOL).

Services

The Aging Services Network provides a wide range of services, including homemaker assistance, transportation, adult day care, caregiver support, and home-delivered meals.

State Level

Each state has a SUA, with a total of 56 units operating across the 50 states, the District of Columbia, and the territories. The SUA develops and manages multi-year state plans for older adults and their families, is responsible for the development and administration of OAA-related policies, and coordinates service delivery through AAAs.

Local Level

AAAs are public or private non-profit agencies designated by the state to address the needs and interests of all older adults within a city, a single county, or a multi-county area. They prioritize support for older adults with the greatest economic and social needs. These agencies help seniors remain in their homes through services such as home-delivered meals (commonly known as Meals on Wheels) and homemaker assistance.

Resources

[ACL.gov: AOA Overview](#)

PART I • SECTION 2

Financial Assistance

재정 지원 (Financial Assistance)

Public financial assistance programs including Social Security, SSI, SSDI, SNAP food assistance, energy bill assistance (LIHEAP, Comfort Partners, NJ SHARES, Lifeline), and Senior Farmers Market.

This section contains 9 comprehensive guides

Social Security

Social Security is a federal program that provides financial assistance to qualified individuals, including retirees, people with disabilities, and the survivors of deceased workers. The official name of this program is Old-Age, Survivors, and Disability Insurance (Old-Age, Survivors, and Disability Insurance, OASDI), and it is administered and operated by the Social Security Administration (SSA).

Social Security is funded through payroll taxes from both employees and employers, and the size of future benefits is determined based on an individual's earnings history. This program is designed to provide financial stability and support to individuals who can no longer engage in economic activity due to old age or disability. Types of benefits include Retirement Benefits, Social Security Disability Insurance (SSDI), and Survivor Benefits.

KEY ASPECTS

- **Retirement Benefits:** Provides a set monthly income to retired workers and their families.
- **Disability Benefits:** Provides financial support to workers who become unable to work due to a disability.
- **Survivor Benefits:** Supports the families of deceased workers by providing income for their livelihood.
- **Funded by Taxes:** Social Security funds are raised through payroll taxes from employees and employers.
- **Administered by SSA:** The SSA manages the entire program and oversees the full process of benefit payments.

Eligibility

- **Requirements:** You earn credits by working and paying Social Security taxes. To receive retirement benefits, you generally need 40 credits (approximately 10 years of work).
- **Employment Gaps:** Your credits never expire even if you stop working. However, because benefits are calculated using your 35 highest-earning years, significant gaps in your work history may affect your benefit amount.

Benefit Amounts

- **Average Indexed Monthly Earnings (AIME):** Calculated based on the 35 years of your highest earnings during your working life.

- **Primary Insurance Amount (PIA):** Calculated based on AIME using the following formula (for those reaching age 62 in 2026):
 - 90% of the first \$1,286 of AIME
 - 32% of AIME between \$1,286 and \$7,749
 - 15% of AIME over \$7,749

Timing and Benefit Amounts

- **Full Retirement Age (FRA):** The age at which you can receive full benefits. This varies by birth year; for those born in 1960 or later, it is 67.
- **Early Retirement (Age 62):** You can begin collecting benefits as early as age 62, but your monthly benefits will be permanently reduced. For instance, claiming early retirement at 62 instead of the FRA of 67 may result in a permanent reduction of your monthly benefits by up to 30%.
- **Delayed Retirement (Age 70):** If you wait past your FRA up to age 70, your benefit increases by approximately 8% for each year you delay. These increases stop once you reach age 70.

Social Security and Medicare

If you have been receiving Social Security benefits for at least four months before your 65th birthday, you will be automatically enrolled in Medicare Parts A and B (no separate application is required).

Retirement Planning Checklist

What to Know Before You Apply

- **Definition of "Retirement":** The SSA defines retirement as the point when you begin collecting your Social Security retirement benefits, not when you stop working entirely.
- **Work and Benefit Impact:** If you have income above a certain limit before reaching FRA, your benefits may be temporarily reduced. Once you reach FRA, you receive full benefits regardless of your income.
 - As of 2026: if you are under FRA, **\$1** is withheld for every **\$2** earned above the annual limit of **\$22,320**.
- **Taxation:** If you have other income, a portion of your Social Security benefits may be subject to federal income tax.

Special Benefit Situations

- **Spousal and Survivor Benefits:** You may receive benefits based on a spouse's work record. A spouse can receive up to **50% of the worker's PIA** (at their own FRA), provided the worker has already applied

for benefits. You will receive the higher amount between your own benefit and the spousal benefit.

- **Divorced Spouses:** You can receive benefits based on a former spouse's record if:
 - The marriage lasted at least 10 years;
 - You are currently unmarried;
 - You are age 62 or older; and
 - The former spouse is eligible for Social Security (if divorced for at least 2 years, they do not need to have applied yet for you to claim).

Additional Considerations

- **Application Timing:** You can apply up to **4 months** before the month you wish to begin receiving benefits.

Check My Benefits

- **My Eligibility:** [SSA.gov: Check Eligibility for Benefits](https://www.ssa.gov/checkeligibility/)
- **My Social Security Account:** [SSA.gov/myaccount](https://www.ssa.gov/myaccount)

How to Apply

- **Online:** [SSA.gov/apply](https://www.ssa.gov/apply)
- **Phone:** 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778)
- **In-Person:** Visit your local SSA office ([SSA.gov/locator](https://www.ssa.gov/locator))

Contact

- AWCA provides consultations free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [SSA.gov: Official Website](https://www.ssa.gov)
- [SSA.gov: 2026 COLA/Social Security Fact Sheet \(PDF\)](#)
- [SSA.gov: Retirement Benefits Publication Guide](#)
- [SSA.gov: Retirement Preparation Checklist](#)
- [SSA.gov: Retirement Information for Medicare Beneficiaries](#)

Comfort Partners Program (New Jersey)

The Comfort Partners Program is a free energy-saving and education program in New Jersey that helps income-eligible residents reduce their utility bills while improving their home's safety and comfort. It is run by the New Jersey Board of Public Utilities (NJBPU) in partnership with electric and natural gas utilities.

Benefits and Services

- **Free Energy Efficiency Improvements and Education Program:** Specialists visit your home to provide personalized energy education and install energy-saving equipment—such as insulation, heating and cooling systems, and lighting—at no cost.
- **Energy Efficiency Improvements:** The program provides various energy-saving measures at no cost, including:
 - Adding insulation to the home
 - Sealing air leaks to prevent drafts
 - Installing energy-efficient lighting solutions
 - Inspecting and tuning heating and cooling systems
 - Installing water-saving devices
 - Replacing old refrigerators
 - Installing programmable thermostats
 - Installation of water heater insulation and water-saving showerheads/adapters
 - Potential waiver of utility arrears (subject to agreement on a payment plan)

Eligibility (2026)

Households with an income at or below 250% of the Federal Poverty Level and significant energy usage are eligible for the program. Additionally, beneficiaries of the following programs also qualify for services:

- Home Energy Assistance Program (HEAP / LIHEAP)
- Supplemental Security Income (SSI)
- Lifeline Credit Program
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- General Assistance (GA)
- Pharmaceutical Assistance to the Aged and Disabled (PAAD)
- Universal Service Fund (USF)

- Medicaid
- Section 8 Housing Assistance
- Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
- Ratepayer Status: You must be the ratepayer of record for gas and electricity at your primary residence.
- New Construction Exclusion: Homes built less than 5 years ago or those still under a builder's warranty are ineligible.
- Building Size: You must reside in a building with 14 units or fewer (e.g., apartments, townhouses; individual metering is required). Buildings with 15 or more units are excluded.
- For Homeowners: You must have owned the property for at least one year.

How to Apply

- **Online:** [Cleanenergy.nj.gov: Comfort Partners](https://www.cleaneconomy.nj.gov/ComfortPartners)
 - PSE&G Customers: [NJ PSEG Comfort Partners-Apply](#)
- **Phone:** 866-378-4345

Contact

- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Senior Farmers' Market Nutrition Program (SFMNP)

The Senior Farmers' Market Nutrition Program (SFMNP), often referred to as the "Farmers' Market Program," is a federal and state-funded initiative that helps low-income seniors purchase fresh, locally grown fruits, vegetables, and honey through farmers' markets or community-supported agriculture programs. This program aims to improve the nutritional status of the elderly while simultaneously stimulating the local agricultural economy.

Features of SFMNP

- **Agricultural Purchase Support:** Provides vouchers or benefit cards so that seniors can purchase fresh produce.
- **Encouraging Healthy Eating Habits:** Encourages the consumption of fresh foods and promotes nutrition education.
- **Widespread Operation:** Implemented in most states.

Benefits

- **Benefit Amount:** \$50 per person annually (based on Bergen County, NJ).
- **Payment Method:** Provided in the form of an electronic QR code or a dedicated debit card.
- **Eligible Items:** Fresh fruits, vegetables, and honey produced by local farmers.
- **Note:** Processed foods (jams, canned goods), imported produce, and dairy products cannot be purchased.

Eligibility

- **Target:** Individuals aged 60 or older.
- **Income Criteria:** Household income at or below 185% of the Federal Poverty Level.
 - 2026-27 NJ: Individual \$29,526 per year / 2 People \$40,034 per year
- **Residency:** Proof of address documentation required.
- **Regional Differences:** Operation periods and availability may vary by state and local agencies.

How to Apply

- **Application:** Contact or visit your local ADRC (Aging and Disability Resource Connection).

- **Counseling Number:** 1-877-222-3737 (Automatically connects to your county's Office on Aging).
- **Bergen County Division of Senior Services**
 - **Address:** One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
 - **Phone:** 201-336-7400 | 1-877-222-3737
 - **Email:** seniors@bergencountynj.gov
- **Receiving Benefits:** Upon approval, receive a document with a QR code or a card via mail or in person.
- **Using the Market:** Use at designated farmers' markets displaying the "Certified Farmers Vendor" sign.
- **Balance Check:** [Homegrown Benefits Portal](#)

Contact

- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [FNS.usda.gov: SFMNP Overview](https://fns.usda.gov/sfmnp/overview)
- [FNS.usda.gov: SFMNP Factsheet](https://fns.usda.gov/sfmnp/factsheet)
- [USDA.gov – 2026-27 SFMNP Income Eligibility Guidelines](https://usda.gov/2026-27-sfmnp-income-eligibility-guidelines)
- [bergenfightshunger.org – Bergen County SFMNP Guide](https://bergenfightshunger.org/bergen-county-sfmnp-guide)
- [NJ.gov/health: Farmers' Market Locator](https://nj.gov/health/farmers-market-locator)
- [NJ.gov: DoAS – New Jersey County ADRC List](https://nj.gov/doh/adrc/new-jersey-county-adrc-list)

Lifeline Utility Assistance Program (New Jersey)

The Lifeline Utility Assistance Program is a program operated by the Division of Aging Services under the New Jersey Department of Human Services (NJ DHS), providing an annual utility credit to low-income seniors and individuals with disabilities. It helps eligible residents pay for electric and natural gas costs by offering financial assistance directly applied to their utility bills.

Primary Benefits

- **Lifeline Credit Program:** A \$225 annual credit is applied directly to electric and/or gas bills for utility account holders.
- **Tenants Lifeline Assistance Program:** A \$225 annual check is issued to tenants whose utilities are included in their rent.
- **Special Utility Supplement (SSI recipients):** Lifetime benefits of up to \$18.75 per month are automatically added to your SSI check. SSI recipients are automatically enrolled and do not need to submit a separate application for Lifeline.

Eligibility

- Those who are PAAD beneficiaries or meet PAAD income limits (less than \$54,943 annually for individuals, less than \$62,390 for couples, 2026). This applies to New Jersey residents aged 65 or older, or those aged 18–64 receiving SSDI.
- Beneficiaries of Medicaid programs for seniors.

Application and Coverage

- **Automatic Enrollment:** Medicaid beneficiaries will automatically receive a Lifeline application every August.
- **Household Limit:** Only one application per household is allowed per year. The application must be completed by the person whose name is on the utility bill or the lease agreement.
- **Utility Scope:** Lifeline covers only electricity and natural gas costs.
- **Exclusions:** Lifeline does not cover heating oil, propane, wood, or coal.
- **Primary Residence:** Lifeline benefits apply only to your primary residence in New Jersey. Seasonal or temporary residences are excluded.

How to Apply

- Online: [NJSave Website](#)
- Phone: Lifeline Utility Assistance 1-800-792-9745

Contact

- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ.gov: DoAS – Lifeline Utility Assistance Program Information](#)
- [NJ.gov: DoAS – NJSave Guide](#)

Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

The Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) is a federally funded program that helps low-income households pay for heating and cooling costs. This program provides assistance with heating and cooling costs, emergency energy crisis support, and medically necessary cooling assistance.

In New Jersey, LIHEAP is administered by the Department of Community Affairs, and residents can access these federal benefits through local partners like Greater Bergen Community Action (GBCA).

Eligibility (for Bergen County, NJ)

- Reside in Bergen County
- Income Requirement: Household gross income must be at or below 60% of the New Jersey State Median Income (SMI). (e.g., \$8,014 or less per month for a family of 4, 2026). Please visit the [NJ DCA website](#) for details.
- Utility Status: Households that pay for their own heating or cooling costs directly, or pay for them as part of their rent. (Note: Residents of public housing or those receiving rental assistance who do not pay for their own heating/cooling are generally excluded).
- Meet other specific requirements depending on the assistance program

How to Apply

Residents in Bergen County should apply through GBGA. Applications are available for download on GBGA website.

- **Offline:** Download the form from the [GBGA website](#) and submit it via email, mail, or in person.
- **Online:** [DCAid](#)
- **Email:** LIHEAP@GreaterBergen.org
- **Mail:** Greater Bergen LIHEAP
 - 505 Main Street, 3rd Floor, Suite 300 Hackensack, NJ 07601
- **In-Person(Drop Box):** 392 Main Street Hackensack, NJ 07601
- **Contact:** (201) 488-5100

Required Documentation

- Completed Application Form (Available on the [GBGA website](#))

- Applicant's Photo ID
- Proof of Income for all household members aged 18 and older: Recent pay stubs or pension statements (statements showing gross amount or Form 1099).
- Unemployment Benefit Recipients: A200 printout (issued at 60 State Street, Hackensack, NJ).
- Full-time Students (Aged 18 or older): Class schedule (showing credits) and/or Enrollment Verification Letter.
- Financial Support Verification Letter: For those receiving financial assistance from family or friends (if applicable).
- Recent Income Tax Return or a Statement of Non-Filing.
- Proof of Government Benefits (e.g., SSA, SSI, SSD).
- Social Security Cards for all household members.
- Proof of Legal Residency: Copy of Permanent Resident Card (Green Card). If you do not have a Resident Card, submit a copy of your passport along with a Statement of Non-Possession of a Social Security Number.
- Most Recent Utility Bill
- Proof of Homeownership or Lease/Rental Agreement.
- Cooling Assistance Applicants: Must submit an original Doctor's Certification Form.
- Section 8 Recipients: Must submit an additional Housing Letter.
- Homeowners with Rental Income: Must submit an additional Rental Income Form.

Contact

- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ.gov: DCA Guide on LIHEAP](#)
- [Greaterbergen.org: GBCA – LIHEAP Page](#)

New Jersey Statewide Heating Assistance and Referral for Energy Services (NJ SHARES)

New Jersey Statewide Heating Assistance and Referral for Energy Services (NJ SHARES) is a non-profit organization that provides financial assistance to New Jersey residents who are not currently eligible for other welfare programs and have a history of good-faith payments on their utility bills. Income eligibility varies by program, but NJ SHARES energy grants are available to households with incomes at or below 100% of the State Median Income (SMI).

Primary Assistance Programs

- **Energy Assistance:** Provides financial support for the payment of natural gas and electricity bills.
- **Water Assistance:** Provides dedicated funds to help pay for water utility bills.
- **Housing Assistance:** Provides support for critical housing-related expenses, including rent, mortgage payments, and property taxes.

**For the NJ SHARES Energy Assistance Grant specifically, households already receiving LIHEAP or USF benefits are not eligible to apply.*

NJ SHARES Assistance Programs

Program Name	Category	Assistance Amount	Key Notes
ACE Customer Relief Fund	Energy	Up to \$500 for electric service	For Atlantic City Electric customers with an overdue balance of \$250 or more (income eligibility applies).
NJBPU PAGE Program	Energy	Up to \$500–\$700 per utility (tiered by income)	Households at or below 60% SMI can apply for PAGE if denied LIHEAP/USF. Households between 60%–100% SMI can apply for PAGE directly.
NJ SHARES SMART Utility Assistance Program	Energy	Up to \$500 per utility	Support for households needing additional aid beyond federal/state assistance programs.
NJ SHARES Energy Assistance Grant	Energy	Up to \$700 for gas, \$700 for electric	Supports middle-income and fixed-income households facing financial crises.
NJ SHARES Municipal Customer Assistance Program (MCAP)	Electric, Sewer, Water	Up to \$200 per service	Assistance for households struggling to pay municipal utility bills .
AQUA New Jersey AQUA Aid	Water	Up to \$150 (single) / \$250 (combined)	For AQUA NJ customers facing a water or sewer bill crisis.
NJ American Water H2O Help to Others Program	Water	Up to \$500 grant and 15%–60% monthly bill discount (fixed rate + usage)	For NJ American Water customers who need help paying their water bills.
NJ SHARES Mortgage Assistance, Rent and Tax Program	Housing	Based on income/situation (Up to \$5,000 through partnerships). Income limit: 200% FPL or below.	Resolves housing instability caused by unpaid rent, mortgage, or property taxes.

How to Apply

- Online: [Sharesnation.org: Register](https://sharesnation.org/register)

Contact

- NJ SHARES | sharesnation.org
- Phone: 609-883-1626 / 866-657-4273
- Email: info@sharesnation.org
- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [Sharesnation.org](https://sharesnation.org): NJ SHARES Website
- [Sharesnation.org](https://sharesnation.org): Eligibility
- [NJ.gov/bpu](https://nj.gov/bpu): BPU Utility Assistance Programs

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP aka Food Stamp)

The Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) is a federal program in the United States that helps low-income individuals and families afford nutritious food. It was formerly known as the Food Stamp Program. SNAP benefits are distributed through an Electronic Benefits Transfer (EBT) card, which can be used at grocery stores, farmers' markets, and other authorized retailers to purchase food items.

**OBBA (One Big Beautiful Bill Act) implementations may affect eligibility and program details.*

Eligibility

SNAP eligibility is primarily determined by household size, income levels, and financial resources. These guidelines are effective from October 1, 2025, through September 30, 2026.

Income Limits

Most households must meet both gross and net income tests to qualify for SNAP benefits. The Federal Poverty Level (FPL) is used as the baseline for these calculations.

- **Gross Monthly Income Limit (New Jersey):** Due to the application of Broad-Based Categorical Eligibility (BBCE), New Jersey extends the gross income limit to 185% of the Federal Poverty Level (FPL) for the period from October 1, 2025, to September 30, 2026. This is significantly higher than the standard federal limit of 130%.
- **Net Monthly Income Limit (100% FPL):** This is the income remaining after specific allowable deductions are subtracted. These deductions include the standard deduction, shelter costs, medical expenses for elderly/disabled members, and dependent care costs.
- **Special Rule for Elderly or Disabled Households:** Households with members aged 60 or older or individuals with disabilities are exempt from the gross income test. They only need to meet the net income limit (100% of the FPL).

Household Asset Limits

- **Target Asset:** Cash, bank account balances, stocks, bonds, and other liquid assets that can be immediately converted into cash (Countable Liquid Assets). **Primary residence, first vehicle, retirement accounts, etc., are excluded.*
- **New Jersey Standard:** Principle exemption from asset evaluation (BBCE policy applied) New Jersey completely waives the asset test for households with incomes at or below 200% of the Federal Poverty

Level (FPL). In other words, as long as the income criteria are met, the household can receive SNAP benefits regardless of the balance in their bank accounts.

- **Federal Standard** (For states where BBCE is not applied)
 - General Households: \$3,250 or less
 - Households including an elderly (60 or older) or disabled member: \$4,500 or less

Standard Deductions

Standard deductions are applied to a household's gross income to help determine the final benefit amount. For the 48 contiguous states and New Jersey:

- **Household size of 1–3 persons:** A standard deduction of \$209 is subtracted from gross income (4 persons: \$223, 5 persons: \$261, 6 or more persons: \$299).

*** Additional Allowable Deductions (Beyond Standard Deduction):*

- Earned Income Deduction: 20% of earned income.
- Dependent Care Deduction: Costs for caring for dependents (for work, education, or training purposes).
- Medical Expense Deduction for Elderly/Disabled: Out-of-pocket medical expenses exceeding \$35.
- Excess Shelter Deduction: Monthly shelter costs that exceed 50% of the household's income after other deductions. The maximum deduction for most households is \$744 (FY2026). However, for households with members aged 60+ or individuals with disabilities, there is no limit—the full excess amount can be deducted.
- Homeless Household Standard Shelter Deduction: \$198.99 per month (FY2026).

How to Apply

- **Online**
 - Eligibility Check: [NJHelps.gov](https://www.njhelps.gov) (5-10 minutes)
 - Application: [MyNJHelps.gov](https://www.myNJhelps.gov) (20-45 minutes)
 - You will be notified of your eligibility within 30 days of applying. During this period, an interview (via telephone or in-person) will be conducted.
- **In-Person**
 - Bergen County Board of Social Services
Address: 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
Phone: 201-368-4200
Hours: Weekdays 8:00 am thru 4:30 pm

- NYC Human Resources Administration (HRA) – Queens SNAP Center
Phone: (718) 784-6315
Address: 32-20 Northern Blvd., 2nd Fl., LIC, NY 11101
Hours: Monday – Friday 8:30am to 5:00pm

***Hours are subject to change. Check with each agency prior to visiting.*

Contact

- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [FNS.usda.gov](https://www.fns.usda.gov): Official SNAP Eligibility Information
- [FNS.usda.gov:2026](https://www.fns.usda.gov/2026) Benefit and Deduction Table
- [BCBSS.com](https://www.bcbss.com): Official SNAP Information

Social Security Disability Insurance (SSDI)

Social Security Disability Insurance (SSDI) is a federal disability insurance benefit for individuals who have a qualifying work history of paying Social Security taxes (FICA) but are no longer able to work due to a disability. Administered by the Social Security Administration (SSA), SSDI requires a formal application through the SSA's Disability (SSD) determination process.

Key Features

- **Based on Work history:** Eligibility is determined by your past Social Security tax contributions. Assets and savings are **not** factored into eligibility.
- **Individually Calculated Benefits:** Benefits are calculated based on your Average Indexed Monthly Earnings (AIME). The more you've earned and the longer you've worked, the higher your benefit.
- **Integrated Medicare Coverage:** Medicare eligibility is automatically granted 24 months after your SSDI entitlement begins (the 6th month from the established disability onset date). In practice, Medicare coverage begins approximately 29 months after the onset of the disability.
- **Family Benefits:** Spouses, minor children, and other family members may also receive additional benefits based on the beneficiary's work record.

Eligibility

To qualify for SSDI you must satisfy both the SSA's strict medical definition of disability and the work credit requirements.

SSA's Definition of Disability

The SSA's disability standard is very strict. Short-term or partial disabilities do not qualify. All four of the following conditions must be met:

- **Unable to perform SGA (Substantial Gainful Activity):** Due to a medical condition, you must be unable to perform work activity that generates earnings of \$1,690 or more per month (\$2,830 for individuals who are blind). If your earnings meet or exceed this threshold, your application may be denied before your medical condition is even reviewed.
- **Lasting 12 months or more, or expected to result in death:** The disability must have lasted — or be expected to last — at least 12 consecutive months, or the condition is expected to result in death.
- **Unable to perform past work or any other work:** You must not only be unable to perform your previous work, but also be unable to transition to any other type of work, taking into account your age, education, and work experience.

- **Objective medical evidence required:** Objective medical evidence — such as diagnoses, test results, and treatment records from medical sources recognized by the SSA — must support your claim.

Work Credits

To receive SSDI, you must have work income on which Social Security taxes were paid. As of 2026, you earn **1 credit for every \$1,890** in earnings, up to a maximum of **4 credits per year**. The number of credits required depends on your age at the time your disability begins.

Age at Onset	Min. Credits	Duration of Work Test	Recent Work Test	Notes
Under 24	6 credits (1.5 yrs)	1.5 years	Within 3 yrs before onset	Shorter work periods accepted
24–31	Half the time worked since age 21	Half since age 21	Work record since age 21	E.g., disability at 27 → 12 credits (3 yrs)
31–42	20 credits (within last 10 yrs)	5 years	Within 10 yrs before onset	"At least 5 yrs worked recently"
44	22 credits	5.5 years	Within 10 yrs before onset	—
46	24 credits	6 years	Within 10 yrs before onset	—
48	26 credits	6.5 years	Within 10 yrs before onset	—
50	28 credits	7 years	Within 10 yrs before onset	—
52	30 credits	7.5 years	Within 10 yrs before onset	—
54	32 credits	8 years	Within 10 yrs before onset	—
56	34 credits	8.5 years	Within 10 yrs before onset	—
58	36 credits	9 years	Within 10 yrs before onset	—
60	38 credits	9.5 years	Within 10 yrs before onset	—
62 or older	40 credits (max)	10 years (max)	Within 10 yrs before onset	Same as retirement eligibility

** Special Rule for Blindness: Individuals who meet the definition of Statutory Blindness are only required to satisfy the Duration of Work Test without needing to meet the Recent Work Test.*

Supplemental Security Income (SSI)

SSI is a supplemental living assistance program operated separately from SSD, and it is based on financial need rather than work history. However, since the SSA reviews eligibility for both SSDI and SSI simultaneously when you apply for SSD, you may receive SSI benefits through the SSD application process in the following cases:

- **If you are receiving SSDI but the amount is low enough to meet the SSI income criteria (2026 FBR \$994/month) and your assets are below \$2,000 (individual) / \$3,000 (couple):** You can receive both benefits at the same time (Concurrent Benefits). The actual SSI payment amount will be reduced based on your SSDI benefit amount.
- **If you lack enough work credits to qualify for SSDI, but your disability is recognized and you meet the income and asset criteria:** You may be eligible for SSI alone.
- **If you are 65 or older and meet the income and asset criteria, regardless of whether you satisfy the SSDI work history requirements:** You may be eligible for SSI.
- **If you are a child under the age of 18 with a recognized disability and meet the household income and asset criteria:** You may be eligible for SSI alone, and no parental work history is required.

**For SSI eligibility criteria (income calculation methods, excluded asset items, etc.) and detailed information, please refer to the [SSI page](#).*

Check My Benefits

- **My Eligibility:** [SSA.gov – Check Disability Benefits Eligibility](https://www.ssa.gov/check-disability-benefits-eligibility)
- **My Social Security Account:** [SSA.gov/myaccount](https://www.ssa.gov/myaccount)

How to Apply

- **Apply for Social Security benefits**
 - **Online:** [SSA.gov/apply](https://www.ssa.gov/apply)
 - **Phone:** 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778)
 - **In-Person:** Visit your local SSA office ([SSA.gov/locator](https://www.ssa.gov/locator))
- **AWCA** provides counseling free of charge (201-862-1665(201-862-1665 / info@awcanj.org).

Contact

- **AWCA** provides counseling free of charge (201-862-1665(201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [SSA.gov: Disability Benefits \(PDF\)](#)
- [SSA.gov: 2026 Red Book \(Guide for People with Disabilities\)](#)

Supplemental Security Income (SSI)

Supplemental Security Income (SSI) is a federal program in the United States that provides monthly payments to individuals who have limited income and resources and are either aged (65 or older), blind, or disabled. Unlike Social Security benefits, SSI is not based on prior work history but rather on financial need.

SSI is a federal program that provides monthly cash assistance to individuals with limited income and resources who are blind, aged 65 or older, or disabled. It's a means-tested program, meaning eligibility is based on financial need and specific criteria related to disability, blindness, or age.

Eligibility

Qualifying Status

- **Seniors:** Aged 65 or older.
- **Health:** Blind or disabled (limiting/preventing work).
- **Citizenship:** U.S. citizens or qualified non-citizens (e.g., Green Card holders).

Income & Resource Limits

- **Income:** Little to no income. (Excludes: First \$20, some wages, SNAP, and state aid).
- **Resources:** Individual (\$2,000) or Couple (\$3,000).
- **Exemptions:** Primary home, one vehicle, essential household goods, life insurance with a total face value of \$1,500 or less, burial plots, and a burial fund of \$1,500 or less, etc.

How Much Can You Receive? (2026)

- **Maximum Monthly Payment (Individual):** Approximately \$994
- **Maximum Monthly Payment (Couple):** Approximately \$1,491

** The actual amount depends on your income, resources, and whether your state provides a supplement (e.g., California, New York, etc.).*

Important Responsibilities After Receiving SSI

- You must report any changes in income or resources to the SSA.
- You must report changes in address or family status (marriage, death, etc.).
- Failure to report may lead to overpayment, which you will be required to pay back later.

Other Benefits When Receiving SSI

Medical Benefits

In most states, you are automatically eligible for Medicaid (coverage for hospital visits and prescriptions).

Food Assistance

Receiving SSI often makes the application process for SNAP (Food Stamps) easier. Recipients may also receive priority for housing assistance, transportation subsidies, and other community welfare programs.

Difference between SSI and Social Security

Supplemental Security Income (SSI) is different from Social Security.

- You can receive both at the same time, but receiving Social Security may reduce your SSI payment amount.
- If your Social Security payment is low, SSI can supplement it.

Difference between SSI and SSDI (Social Security Disability Insurance)

SSDI (Social Security Disability Insurance) is based on a work history, while SSI is based on need, regardless of work history.

SSI is a vital program for many individuals who face significant financial hardship due to age, disability, or blindness.

Check My Benefits

- **My Eligibility:** [SSA.gov: Who can get SSI](https://www.ssa.gov/who-can-get-ssi)
- **My Social Security Account:** [SSA.gov/myaccount](https://www.ssa.gov/myaccount)

How to Apply

- **Online:** [SSA.gov/ssi](https://www.ssa.gov/ssi)
- **Phone:** 1-800-772-1213 (Appointment only)
- **In-Person:** Visit your local SSA office ([SSA.gov/locator](https://www.ssa.gov/locator))

Required Documents for Application

- Social Security Number (SSN)
- Original birth certificate or proof of citizenship
- Bank account information

- Proof of income (W-2s, tax returns, etc.)
- Resource documentation (bank statements, vehicle info, real estate, etc.)

Contact

- **AWCA** provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [SSA.gov: About SSI](#)
- [SSA.gov: SSI Benefit Amount](#)
- [SSA.gov: SSI vs Social Security](#)
- [SSA.gov: SSI Eligibility](#)
- [SSA.gov: SSI Income Calculation](#)
- [SSA.gov: SSI Resource Limits](#)
- [Medicaid.gov: 2026 SSI Guide \(PDF\)](#)

PART I • SECTION 3

Medicare

메디케어 (Medicare)

Comprehensive federal health insurance: Parts A & B (Original Medicare), Part C (Medicare Advantage), Part D (Prescription Drug Plans), Medigap supplemental coverage, Medicare Savings Programs (MSP), Buy-in, Low Income Subsidy (LIS / Extra Help), and NJ PAAD / Senior Gold.

This section contains 11 comprehensive guides

Medicare Overview

Medicare is the federal health insurance program for individuals aged 65 or older, as well as those under 65 who have been receiving SSDI benefits for 24 months, or are diagnosed with End-Stage Renal Disease (ESRD) or ALS (Lou Gehrig's disease).

The Four Parts of Medicare

- **Part A:** Covers inpatient hospital stays, care in a skilled nursing facility, hospice care, and some home health care. Most people do not pay a premium for Part A if they or their spouse paid Medicare taxes for at least 10 years (40 quarters of coverage; QCs).
- **Part B:** Covers certain doctors' services, outpatient care, medical supplies, and preventive services. Part B requires a monthly premium (\$202.90 for most in 2026).
 - Part A and B collectively are known as **Original Medicare**.
- **Part C:** Known as **Medicare Advantage**. An alternative to Original Medicare. These are all-in-one plans offered by private insurance companies approved by Medicare. They often include Part D and extra benefits like dental, vision, and hearing.
- **Part D:** Known as PDP. Helps cover the cost of prescription drugs. These plans are run by private insurance companies following rules set by Medicare.

Other Medicare Insurance Programs

- **Supplemental Insurance:** Known as **Medigap**. Helps pay out-of-pocket costs associated with Original Medicare.
- **Medicare Savings Program:** A state-offered program that pays for Medicare out-of-pocket costs.
- **Low Income Subsidy (LIS, Extra Help):** A federal program that provides financial assistance for Medicare Part D prescription drug costs.

Medicare vs Medicaid Q&A

Q1. Both are government programs, so what is the difference?

A. The biggest difference is "who" the target audience is.

- **Medicare:** Based on age. It is a federal program for anyone age 65 or older, or those with certain disabilities, regardless of wealth. Think of it as a "right" earned by paying taxes while working.

- **Medicaid:** Based on income. It is a joint federal and state-funded program, run by individual states, designed to help those with limited income and assets, regardless of their age.

Q2. How do the medical costs differ?

A. Medicare pays "part" of the cost, while Medicaid pays "almost all" of it.

- **Medicare:** Outpatient and physician services (Part B) cover 80% of the Medicare-approved amount, leaving the remaining 20% and the annual deductible as out-of-pocket expenses. Inpatient hospital services (Part A) are subject to a separate cost-sharing structure, which includes a deductible and daily copayments based on the length of the hospital stay.
- **Medicaid:** Covers almost all remaining out-of-pocket costs that Medicare doesn't pay. It also helps cover premiums and prescription drug costs.

Q3. Is the cost of a Nursing Home fully covered?

A. This is where the biggest difference lies.

- **Medicare:** Medicare covers up to **100 days** of **Skilled Nursing Care** only when a physician deems it necessary following a formal **inpatient** hospital stay of at least three days. The cost-sharing structure is as follows: **\$0** for days 1–20; **\$217 per day** for days 21–100 (as of 2026); and the full cost thereafter from day 101. Please note that **Custodial Care**, such as assistance with meals, bathing, and mobility, is not covered by Medicare.
- **Medicaid:** Supports long-term care. Medicaid covers nursing home costs or home health aide services (Home Care).

****Observation Status** is not recognized as a formal inpatient admission, which may result in a denial of Skilled Nursing Facility (SNF) benefits. When admitted, be sure to confirm with the hospital whether your status is officially **inpatient**.*

Q4. I have both. What does that mean?

A. You have "Dual Eligibility."

- If you hold both Medicare and Medicaid cards, you are considered **Dual Eligible**.
- You can enroll in a Dual Special Needs Plan (D-SNP), which coordinates the benefits of both programs into one integrated plan for more efficient care. Specific name of the D-SNP plan may vary by state.
- When you receive medical services under a D-SNP, Medicare acts as the primary payer, covering its portion first. Medicaid then serves as the secondary payer to cover the remaining costs. For more details visit our [D-SNP](#) page.

Q5. What happens if I move to another state?

A. Original Medicare stays the same; Medicaid must be reapplied for.

- **Medicare:** Since it is a federal program, you can use your Medicare plan anywhere in the United States without issue (Original Medicare only).
- **Medicaid:** Policies vary by state. If you move from New Jersey to New York, you must close your New Jersey coverage and apply for New York Medicaid to undergo a new eligibility review.

Medicare Buy-In

For individuals who do not qualify for Medicare Part A, the federal government allows them to buy-in to the program by paying a monthly premium. This typically applies to those who have not earned enough work credits through U.S. social security taxes.

Eligibility (2026)

- **Work Credit System:** Credits are earned based on annual income. One credit is earned per **\$1,890** of quarterly income(quarter of coverage), up to four credits per year.
- **The 40-Credit Rule:** Individuals generally need 40 credits (approximately 10 years of work) to receive Part A without a premium.
- **Spousal Eligibility:** Individuals aged 62 or older may qualify for premium-free Part A based on a spouse's work record. Divorced or widowed individuals may also qualify under specific Social Security guidelines (visit [NCOA.org](https://www.ncoa.org)).

Buy-In Costs (2026)

If an individual does not meet the 40-credit requirement, they may purchase Part A at the following monthly rates:

- **30–39 Credits:** \$311 per month.
- **Fewer than 30 Credits:** \$565 per month.
- **Mandatory Part B:** Typically, individuals who buy into Part A must also enroll in Medicare Part B and pay the standard monthly premium of \$202.90.

How to Buy In

- **Verify Work History:** Individuals should contact the [Social Security Administration \(SSA\)](https://www.ssa.gov) to confirm their total lifetime earned credits.
- **Check Spousal Benefits:** Individuals should determine if they can qualify through a current, former, or deceased spouse's work record to eliminate the Part A premium.
- **Apply via Social Security:** Enrollment is processed by the SSA. Applications can be submitted online at [SSA.gov](https://www.ssa.gov), by phone, or at a local Social Security office.

** If you don't qualify for premium-free Medicare Part A, make sure to review your options as soon as you turn 65. Missing your initial sign-up window could mean paying a permanent late-enrollment penalty. To learn how to protect your coverage and avoid extra costs, visit [Medicare.gov/avoid-late-penalties](https://www.medicare.gov/avoid-late-penalties).*

Resources

- [Medicare.gov: Medicare Savings Programs](https://www.medicare.gov/medicare-savings-programs)
- [SSA.gov: How to Apply for Medicare](https://www.ssa.gov/medicare)
- [CMS.gov: 2026 Medicare Part A & B Premiums and Deductibles](https://www.cms.gov/2026-Medicare-Part-A-B-Premiums-and-Deductibles)
- [NCOA.org: What Are the Medicare Buy-in Programs?](https://www.ncoa.org/what-are-the-medicare-buy-in-programs/)

Healthcare Cost Assistance

Managing the rising costs of healthcare and prescriptions is a significant challenge for many families. Whether a senior is living on a fixed income or a young adult is navigating insurance for the first time, verified programs exist to help reduce these expenses.

Comprehensive Assistance & Discounts

These services act as search engines for savings, connecting patients to public and private assistance programs.

- **NeedyMeds:** A dedicated nonprofit providing extensive resources for medication and healthcare costs. They offer immediate-use pharmacy discount cards and maintain a database of disease-specific financial aid and pharmaceutical Patient Assistance Programs (PAPs).
- **GoodRx:** A popular tool that compares prices at over 70,000 pharmacies. It allows users to compare prices between local pharmacies and use coupons to lower costs instantly.
- **RxAssist:** A comprehensive, searchable directory of pharmaceutical company PAPs. An excellent tool for finding programs specifically tailored to brand-name medications.
- **Medicine Assistance Tool (MAT):** A search engine that focuses exclusively on helping patients find manufacturer-sponsored assistance programs.
- **BenefitsCheckUp(NCOA):** A service of the National Council on Aging (NCOA) specifically designed for adults age 55 and older. It helps seniors find programs for medicine, food, utilities, and more.

Direct Financial Assistance & Grants

These foundations provide actual financial grants to help underinsured patients cover co-pays, premiums, and deductibles.

- **PAN Foundation & HealthWell Foundation:** provide direct financial grants to patients with chronic or rare conditions for out-of-pocket costs that insurance doesn't cover.
- **Patient Advocate Foundation (PAF):** Known for its "Co-Pay Relief" program, PAF provides direct financial aid and professional case management to help patients navigate complex insurance and billing issues.

Local Counseling & Support

- **SHIP (State Health Insurance Assistance Program):** A federally funded statewide program providing free counseling for Medicare beneficiaries. In New Jersey, trained volunteer SHIP counselors help with

navigating coverage options, comparing plans, and resolving complex billing problems to ensure beneficiaries can make informed healthcare decisions.

Access Resources / Contacts

Comprehensive Assistance & Discounts

- **NeedyMeds** 1-800-503-6897 | [NeedyMeds Resource Center](#)
- **GoodRx** 855-268-2822 | [GoodRx Prescription Coupons and Prices](#)
- **RxAssist** 877-537-5537 | [RxAssist Patient Assistance Program Directory](#)
- **PhRMA (MAT)** 571-350-8643 | [Medicine Assistance Tool \(MAT\)](#)
- **NCOA** 1-800-794-6559 | [BenefitsCheckUp for Seniors](#)

Direct Financial Assistance & Grants

- **PAN Foundation** 1-866-316-7263 | [Patient Access Network \(PAN\) Financial Grants](#)
- **HealthWell Foundation** 1-800-675-8416 | [HealthWell Foundation Assistance Programs](#)
- **Patient Advocate Foundation** 1-800-532-5274 | [PAF Co-Pay Relief Program](#)

Local Counseling & Support

- **NJ SHIP** 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP Counseling](#)
- **Bergen County SHIP** 201-336-7413 | [SHIP Medicare Counseling](#)

Other Resources

- [CMS.gov: PAP Program Information](#)
- [CMS.gov: PAP Attestation Form](#)

Low Income Subsidy (LIS, Extra Help)

The Low Income Subsidy (LIS), also known as Extra Help, is a federal program that helps Medicare beneficiaries with limited income and resources pay for their Medicare Part D prescription drug costs. This includes help with monthly premiums, annual deductibles, and copayments.

Key Aspects (2026)

For those who qualify, the program provides substantial savings:

- **Premiums:** The monthly Part D premium is often reduced to **\$0**.
- **Annual Deductible:** The standard Part D deductible (**\$615**) is reduced to **\$0**.
- **Drug Copays:** Beneficiaries pay no more than **\$5.10** for each generic drug and **\$12.65** for each brand-name drug.
- **\$0 Cost-Sharing:** Once Part D's total out-of-pocket drug costs reach the **\$2,100** cap, the beneficiary pays **\$0** for all covered drugs for the rest of the year.
- **No Late Penalties:** Any Part D late enrollment penalties are permanently waived for those who qualify.

Eligibility

Individuals automatically qualify/do not need to apply for LIS if they already receive:

- Full Medicaid coverage (Dual Eligible).
- Supplemental Security Income (SSI).
- Help from a Medicare Savings Program (MSP) to pay Part B premiums.

Income and Asset Limits (2026)

For those who do not qualify automatically, eligibility is based on annual income and total resources/assets:

Status	Annual Income Limit*	Resource/Asset Limit**
Individual	Below \$23,475	Below \$18,090
Married Couple	Below \$31,725	Below \$36,100

**Income limits include a \$20 monthly income disregard.*

***Resource limits include \$1,500 per person set aside for burial expenses.*

Resource/Asset includes cash, bank accounts, stocks, bonds, and real estate (other than a primary residence). It does not count: a primary home, one vehicle, and personal household items.

How to Apply

- **Online:** [SSA: Online Extra Help Application](#)
- Call: 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778).
- **Visit:** Local SSA office support available.
- **Review Notice:** After applying, the Social Security Administration will mail a letter indicating whether the individual qualifies and the level of assistance they will receive.
- **Automatic Enrollment:** If a beneficiary is found eligible but does not have a Part D plan, Medicare will often automatically enroll them in one to ensure they receive the benefit.

Contact

- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [SSA: Online Extra Help Application](#)
- [Medicare.gov: Extra Help Basics](#)
- [NJ DoAS: SHIP Counseling for Extra Help Applications](#)

Medical Bills: How It Works

Medicare and secondary insurance (such as Medigap, NJ FamilyCare/Medicaid, or retiree plans) communicate with each other automatically through a system called the **Coordination of Benefits Agreement (COBA) crossover**. A manual claim option (**CMS Form 1490S**) also exists to ensure that secondary insurance benefits are applied correctly if the automatic process fails and to protect patients from being billed for costs that their insurance should cover.

The Automatic Billing System (COBA, Crossover)

The **Coordination of Benefits Agreement (COBA)** is a national system that allows Medicare to share billing data directly with secondary insurers (such as Medigap, retiree plans, or NJ FamilyCare/Medicaid).

- **The Process:** After Medicare pays its portion of a medical bill, it automatically crosses over (transfers) the claim information to the secondary payer.
- **No Action Required:** In standard scenarios, patients and providers do not need to file separate claims for the secondary insurer to pay its portion of the bill.

Filing a Manual Claim (CMS Form 1490S)

While healthcare providers are generally required to file claims, there are specific instances where a manual claim must be filed directly with Medicare to trigger payment.

Circumstances for Manual Filing

- **Provider Refusal:** A physician or medical supplier refuses to submit a claim to Medicare for a covered service.
- **Non-Participating Providers:** Services were received from a provider who is not enrolled in the Medicare program (often during emergencies or specific travel situations).
- **Technical Failures:** The automatic crossover failed, and the secondary insurer requires an official Medicare payment notice to process the remaining balance.

How to File a Manual Claim Using CMS 1490S

1. **Complete the Form:** [CMS Form 1490S](#) (Patient's Request for Medical Payment).

1. **Gather the Itemized Bill, including:**

- Date and place of service (e.g., doctor's office, hospital).

- A description of each medical service or supply provided.
- The specific charge for each individual service.
- The provider's name, address, and National Provider Identifier (NPI).

3. **Attach a Statement of Reason:**

- The doctor is not enrolled in Medicare.
- The provider refused to file the claim on the patient's behalf.
- The services were received during foreign travel or in an emergency.

4. **Mail the Package**

- **Novitas Solutions** P.O. Box 3030 Mechanicsburg, PA 17055-1834

* **Time Limit:** Claims must be submitted within **12 months** (one full calendar year) of the date the services were provided.

* **Processing Time:** It typically takes Medicare up to **60 days** to review and process a manual claim.

Resources

- [CMS.gov: COBA Overview](#)
- [Medicare.gov: How Medicare works with other insurance](#)
- [CMS Form 1490S \(PDF\)](#)
- [Medicare.gov: Filing a Claim](#)

Medicare Supplement Insurance (Medigap)

Medicare Supplement Insurance, known as Medigap, consists of private insurance policies designed to “fill the gaps” in Original Medicare (Part A and B). Because Original Medicare generally pays for about 80% of covered medical expenses, Medigap plans help beneficiaries cover the remaining out-of-pocket costs, such as deductibles, coinsurance, and copayments.

Medigap Coverage

- Out-of-pocket costs in Original Medicare (copayments, coinsurance, and deductibles)

Medigap and Original Medicare (Part A & B)

Medigap is specifically designed to work only with Original Medicare. It functions as secondary insurance to enhance a beneficiary's primary federal coverage.

- **Prerequisite:** A beneficiary must be enrolled in both Medicare Part A and Part B to purchase a Medigap policy.
- **Secondary Payer:** When a beneficiary receives covered services, Original Medicare pays its share first. The Medigap policy then pays its share of the remaining costs according to the specific plan's benefits.
- **Provider Access:** Because Medigap supplements Original Medicare, beneficiaries can see any doctor or visit any hospital in the U.S. that accepts Medicare. No referrals are required to see specialists.
- **Monthly Premiums:** Beneficiaries pay a monthly premium to a private insurance company for Medigap in addition to the standard monthly Part B premium (\$202.90 in 2026) paid to the federal government.

Important Restriction: Medigap cannot be used with Medicare Advantage (Part C). It is illegal for anyone to sell a Medigap policy to an individual enrolled in a Medicare Advantage plan unless they are switching back to Original Medicare.

How to Buy Medigap Plans

Medigap plans may be purchased using [Medicare.gov](https://www.medicare.gov)'s online tool and contacting private insurers directly.

1. **Select a Plan Online:** Go to [Medicare.gov: Find a Medigap Policy](https://www.medicare.gov) and find various plans and their benefit level.
2. **Find Policies:** Find policies in local areas.
3. **Apply Directly:** Contact the private insurer online or by phone for an official quote.

Contact

- **NJ SHIP (State Health Insurance Assistance Program):** Free counseling from state-trained experts
 - NJ SHIP: 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP website](https://www.nj.gov/ship/)
 - Bergen County SHIP: 201-336-7413 | [Bergencountynj.gov SHIP Counseling](https://www.bergencountynj.gov/SHIP-Counseling)
- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [Medicare.gov: Medicare Basics and Parts](https://www.medicare.gov/medicare-basics-and-parts)
- [Medicare.gov: Medigap Policy Overview](https://www.medicare.gov/medigap-policy-overview)
- [NJ DoAS: Medigap 2026 Benefits Star Chart \(PDF\)](#)
- [NJ DoAS: Medigap 2026 Premium Comparison for Females \(Age 65\) \(PDF\)](#)
- [NJ DoAS: Medigap 2026 Premium Comparison for Males \(Age 65\) \(PDF\)](#)
- [NJ DoAS: Medigap 2026 Coverage for People with Disabilities \(Ages 50–64\) \(PDF\)](#)
- [NJ DoAS: Medigap 2026 Plan Information for People Under Age 50](#)

New Jersey Pharmaceutical Assistance to the Aged & Disabled (PAAD) and Senior Gold

The State of New Jersey offers two primary prescription assistance programs: Pharmaceutical Assistance to the Aged & Disabled (PAAD) and Senior Gold Discount Program (Senior Gold). These programs help eligible seniors and individuals with disabilities save significantly on the cost of prescription drugs, including insulin and other life-saving medications. Both programs are integrated with Medicare Part D to provide a seamless layer of financial protection.

Eligibility: NJ PAAD (2026)

Individuals may be eligible for PAAD program if they meet the following state requirements:

- **Residency:** Applicants must be legal residents of New Jersey.
- **Age or Disability:** Applicants must be age 65 or older, or between the ages of 18 and 64 and receiving Social Security Title II Disability benefits.
- **Medicare Part D Enrollment:** Beneficiaries must be enrolled in a Part D plan or Part C (Medicare Advantage) with prescription benefits.
- **Income Limits:** Annual income must be less than **\$54,943 for single individuals** or less than **\$62,390 for married couples**.
- **Copay:** \$5 for each covered generic drug or \$7 for each covered brand name drug, including premiums.

**Must be renewed every two years through the New Jersey state government.*

Eligibility: Senior Gold (2026)

Senior Gold program provides secondary prescription coverage for those whose income exceeds the PAAD limits:

- **Residency:** Beneficiary must be a legal resident of New Jersey.
- **Age or Disability:** Beneficiary must be 65 years of age or older, or at least 18 years of age and receiving SSDI benefits.
- **Medicare Part D Enrollment:** Beneficiaries must be enrolled in a Part D plan or Part C (Medicare Advantage) with prescription benefits.
- **Income Limits:** Annual income must be between **\$54,943 and \$64,943 if single**, or between **\$62,390 and \$72,390 if married**.

- **Copay: \$15 plus 50%** of the remaining cost of each Senior Gold covered drug.

**Must be renewed through the New Jersey state government every year.*

How to Apply

Use the NJSave portal to streamline applications for multiple senior benefits such as PAAD, Senior Gold, Lifeline, and more.

- Online Application: [NJSave](#)
- Paper Application: [NJSave \(PDF\)](#).

Contact

- **NJSave:** PAAD, Sr. Gold | 1-800-792-9745 | [NJSave Contact Us](#)
- **NJ SHIP (State Health Insurance Assistance Program):** Free counseling from state-trained experts
 - NJ SHIP: 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP Counseling](#)
 - Bergen County SHIP: 201-336-7413 | [Bergencountynj.gov SHIP Counseling](#)
- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ Department of Human Services – PAAD Information](#)
- [NJ Division of Aging Services – Senior Gold Overview](#)
- [NJSave Online Application](#)
- [NJSave Paper Application \(PDF\)](#).

Medicare Part C (Medicare Advantage)

Medicare Part C, also known as Medicare Advantage, is an **all-in-one private alternative** to Original Medicare. These plans bundle Part A, Part B, and usually Part D into a single package. While provided by private insurers, they are strictly regulated and approved by Medicare.

Key Aspects

- **Bundled Coverage:** Combines hospital, medical, and often prescription drug coverage.
- **Extra Benefits:** Most plans include services not covered by Original Medicare, such as routine dental, vision, hearing, and fitness memberships.
- **Spending Limit:** Unlike Original Medicare, these plans have a mandatory **Maximum Out-of-Pocket (MOOP)** limit. Once reached, the plan pays 100% of covered medical services for the rest of the year.
- **Network-Based:** Beneficiaries typically use a specific network of doctors and hospitals (HMO or PPO).
- To enroll in Part C, an individual must already have Medicare Part A and Part B.

Common Plan Types

- **HMO (Health Maintenance Organization):** Usually requires using in-network providers and obtaining referrals for specialists.
- **PPO (Preferred Provider Organization):** Offers more flexibility to see out-of-network providers at a higher cost; referrals are typically not required.
- **SNP (Special Needs Plans):** Tailored for individuals with specific chronic conditions or those eligible for both Medicare and Medicaid.

Costs & Limits (2026)

- **Monthly Premium:** Many plans are \$0 premium. Beneficiaries must pay the standard Part B premium (\$202.90).
- **Out-of-Pocket Cap:** Federal maximum limit for in-network services: **\$9,250/month**
- **Copays:** A fixed copay is usually set for doctor visits or specialist services.

Enrollment

You can enroll in, switch, drop, or change a Medicare Advantage Plan. To join a Medicare Advantage Plan, you must be enrolled in both Medicare Part A and Part B:

Enrollment Period	Timing	Coverage Start	Key Notes
Initial Enrollment Period (IEP)	3 months before and after the 65th birthday month (7 months)	Varies by time of application (typically 1st day of birthday month)	Must have both Part A and Part B to apply. Next is the AEP.
Annual Enrollment Period (AEP)	October 15 – December 7	January 1 of the following year	Critical period for maintaining, changing, or dropping existing plans.
Open Enrollment Period (OEP)	January 1 – March 31 every year	The 1st of the month following application	Only applicable to those with a Medicare Advantage plan. May switch to a different Advantage plan or return to Original Medicare once during this period.
Special Enrollment Period (SEP)	Triggered when qualifying events occur	Varies by case; Generally within 2 months from the date of the qualifying event	Used when your existing coverage suddenly ends, if you relocate out of state, or changes in eligibility.

Automatic Rollover

Your Medicare Advantage plan will automatically renew (rollover) each year without requiring a new application.

- **Review Your ANOC:** Be sure to review the “Annual Notice of Change (ANOC)” sent by your insurance provider around September each year. Check for critical changes regarding premiums, copays, provider networks, and prescription drug formularies.
- **Service Discontinuation by Insurer:** If your current insurance carrier stops offering services in your area or terminates its contract, your existing plan will automatically end.
- If you are unsatisfied with your current plan, or if your benefits are reduced or discontinued by the insurance company, you must find a new plan during the **Annual Enrollment Period (AEP, Oct 15 – Dec 7)** or the **Medicare Advantage Open Enrollment Period (OEP, Jan 1 – Mar 31;** provided your plan is still active).

How to Buy an Medicare Advantage Plan

Medicare Advantage may be purchased directly using Medicare.gov’s online tool.

1. **Select a Plan Online:** Go to [Medicare.gov](https://www.medicare.gov) and find various plans and their benefit level.
2. **Check Service Area:** Plans are location-specific; ensure the plan is available in a specific county.

3. **Verify Providers:** Confirm that preferred doctors and pharmacies are included in the plan's network.

*** Enroll During Specific Windows:** Enrollment must occur during the Initial Enrollment Period or the annual Open Enrollment (Oct 15 – Dec 7).

Contact

- **NJ SHIP (State Health Insurance Assistance Program):** Free counseling from state-trained experts
 - NJ SHIP: 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP Counseling](https://www.nj.gov/ship/counseling)
 - Bergen County SHIP: 201-336-7413 | [Bergencountynj.gov SHIP Counseling](https://www.bergencountynj.gov/ship/counseling)
- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [Medicare.gov: Find and Compare 2026 Plans](https://www.medicare.gov/compare-plans)
- [Medicare.gov: Medicare Advantage Overview \(PDF\)](#)
- [NJ DoAS: 2026 NJ Medicare Advantage List](#)
- [NJ DoAS: SHIP Counseling for Plan Selection](#)

Medicare Part D (Prescription Drug Plan, PDP)

Medicare Part D, known as Medicare drug coverage or PDP, helps cover the cost of outpatient prescription drugs. Because coverage is provided by private insurance companies, plan details—including premiums, pharmacy networks, and which drugs are covered—can vary. Federal laws set standard limits and protections for all plans nationwide.

Part D Coverage: Two Options

1. Medicare Drug Plan (Part D, PDP)

- Original Medicare (Part A & B)
- Some Medicare Cost Plans
- Some Medicare Advantage Private Fee-for-Service Plans
- Medicare Medical Savings Account (MSA) Plans

2. Medicare Advantage (Part C, MAPD) or Other Medicare Plans

- Part A, Part B, and Medicare drug coverage (Part D) through a single plan

Part D Costs (2026)

- **Annual Deductible:** Enrollees pay 100% of their drug costs until the plan's deductible is reached. No plan's deductible can be higher than \$615.
- **Coverage (25% Coinsurance):** After the deductible is met, the plan begins to share costs. The enrollee pays approximately 25% for covered drugs.
- **Out-of-Pocket:** Once out-of-pocket spending reaches \$2,100, the enrollee pays \$0 for all covered drugs for the rest of the year.
- **Monthly Premium:** To keep Part D coverage active, a monthly premium is paid to the insurance provider. They do not count toward the \$2,100 out-of-pocket cap. Only the money spent at the pharmacy (deductibles and coinsurance) counts toward that limit.

How to Choose & Join a Plan

Beneficiaries are encouraged to review their coverage during the **Annual Open Enrollment (Oct 15 – Dec 7)** because plans can change.

- **Use the Official Plan Finder:** Visit [Medicare.gov/plan-compare](https://www.medicare.gov/plan-compare) to enter current medications and see which plans offer the lowest total annual cost.
- **Check Pharmacy Networks:** Confirm if a preferred pharmacy is considered In-Network or Preferred by the plan to ensure the lowest possible copays.
- **Bergen County, NJ Residents:** Bergen County residents can receive free assistance through AWCA at 201-862-1665 or via email at info@awcanj.org.

*Individuals who don't enroll when first eligible may have to pay a late enrollment penalty. For more information visit [Medicare.gov/avoid late penalties](https://www.medicare.gov/avoid-late-penalties).

Contact

- **NJ SHIP (State Health Insurance Assistance Program):** Free counseling from state-trained experts
 - NJ SHIP: 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP Counseling](https://www.nj.gov/SHIP-Counseling)
 - Bergen County SHIP: 201-336-7413 | [Bergencountynj.gov SHIP Counseling](https://www.bergencountynj.gov/SHIP-Counseling)
- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [Medicare.gov: Part D Basics](https://www.medicare.gov/partd-basics)
- [Medicare.gov: Find & Compare Drug Plans](https://www.medicare.gov/find-compare-drug-plans)
- [NJ DoAS.gov: 2026 NJ PDP List \(PDF\)](https://www.njdoas.gov/2026-NJ-PDP-List-PDF)

Medicare Parts A & B (Medicare Original)

Medicare Original is the traditional fee-for-service health insurance program managed by the federal government. It allows beneficiaries to visit any doctor or hospital in the United States that accepts Medicare. Medicare Original consists of two primary components: Part A (Hospital Insurance) and Part B (Medical Insurance).

**OBBA (One Big Beautiful Bill Act) implementations may affect eligibility and program details.*

Medicare Part A (Hospital Insurance)

Part A covers essential inpatient services. Most individuals qualify for premium-free Part A if they or their spouse paid Medicare taxes for at least 10 years (40 quarters). Those with shorter work histories may purchase Part A for a monthly premium.

- **Inpatient Hospital Care:** Includes semi-private rooms, meals, general nursing, and drugs provided during inpatient treatment.
- **Skilled Nursing Facility (SNF):** Covers skilled nursing or rehabilitation services following a qualifying 3-day inpatient hospital stay.
- **Hospice Care:** Specialized care for terminally ill beneficiaries focused on comfort and pain management.
- **Home Health Services:** Covers part-time or intermittent skilled nursing care and physical therapy for homebound individuals.

Part A Costs (2026)

Costs are based on benefit period:

- **Days 1-60:** Deductible of \$1,736 per benefit period.
- **Days 61-90:** Hospital Coinsurance of \$434 per day.
- **Days 91-150:** Lifetime Reserve Days of \$868 per day (up to 60 days available over lifetime).
- **Days 151~:** 100% personal contribution.
- **SNF**
 - **Days 1-20:** \$0 per day.
 - **Days 21-100:** \$217 per day.
 - **Days 101~:** 100% personal contribution.

- **Hospice Care:** \$0 copayment (small copayments may apply for outpatient prescription drugs or short-term respite care).

Medicare Part B (Medical Insurance)

Part B covers medically necessary services and preventive care. Unlike Part A, most beneficiaries must pay a monthly premium for Part B.

- **Doctor Services:** Visits to primary care doctors and specialists.
- **Outpatient Care:** Services received at a hospital without being admitted (e.g., ER visits or outpatient surgery).
- **Preventive Services:** Includes flu shots, screenings (cancer, diabetes), and an annual wellness visit.
- **Durable Medical Equipment (DME):** Covers items like walkers, wheelchairs, and oxygen equipment.

Part B Costs (2026)

- **Standard Monthly Premium:** \$202.90 (May be higher based on income—see IRMAA).
- **Annual Deductible:** \$283 per year.
- **Coinsurance:** Generally **20%** of the Medicare-approved amount after you meet your deductible.

Eligibility

- 65 or older: U.S. citizens or legal permanent residents who have resided in the U.S. for at least five continuous years.
- Under age 65 receiving Social Security Disability Insurance (SSDI) benefits or have Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS, 'Lou Gehrig's disease') or End-Stage Renal Disease (ESRD).

Enrollment

Medicare enrollment may be automatic or manual depending on the applicants' situation. Enrolling into Medicare during the enrollment window is critical; missing it can result in a lifelong monthly premium penalty.

Enrollment Period	Timing	Coverage Start	Key Notes
Initial Enrollment Period (IEP)	3 months before and after the 65th birthday month (7 months)	Varies by time of application (typically 1st day of birthday month)	Critical period to enroll when you become eligible for Medicare. Missing this window may lead to monthly penalties.
Annual Enrollment Period (AEP)	October 15 – December 7	January 1 of the following year	Primary period for maintaining, changing, or dropping existing plans.
Special Enrollment Period (SEP)	Within 8 months of employer-sponsored coverage ending.	The 1st day of the following month of application	For those who delayed Medicare enrollment because they were covered under active employment. Also triggered upon sudden loss of coverage or relocation.
General Enrollment Period (GEP)	January 1 – March 31	The 1st day of the following month of application	For individuals who missed their IEP.

Automatic Enrollment (No Action Needed)

Medicare enrollment is automatic if:

- **Already Receiving Benefits:** The individual has been receiving Social Security or Railroad Retirement Board (RRB) benefits for at least four months before turning 65.
- **Disability:** The individual has been receiving Social Security Disability Insurance (SSDI) for 24 months.
- **ALS/ESRD:** Individuals with Lou Gehrig's disease (ALS) or End-Stage Renal Disease (ESRD) have specific automatic or expedited enrollment rules.

Manual Enrollment (Action Required)

If an individual is not receiving Social Security benefits (for example, because they are still working or delaying retirement), they must manually sign up for Medicare.

- **Initial Enrollment Period (IEP):** A 7-month window that includes the month of the 65th birthday, the three months before, and the three months after.
- **Apply Online:** Enroll directly through [Social Security Administration \(SSA\)](https://www.ssa.gov).

*Individuals who don't enroll when first eligible may have to pay a late enrollment penalty. For more information visit [Medicare.gov/avoid late penalties](https://www.medicare.gov/avoid-late-penalties).

Contact

- **NJ SHIP (State Health Insurance Assistance Program):** Free counseling from state-trained experts
 - NJ SHIP: 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP Counseling](https://www.nj.gov/ship/counseling)
 - Bergen County SHIP: 201-336-7413 | [Bergencountynj.gov SHIP Counseling](https://www.bergencountynj.gov/ship/counseling)
- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [Medicare.gov: Parts of Medicare](https://www.medicare.gov/medicare-plans)
- [Medicare.gov: Fact Sheet – Medicare CostsGuide \(2026\) \(PDF\)](#)
- [CMS.gov: Medicare Part A & B Enrollment](https://www.cms.gov/medicare/medicare-eligibility)
- [SSA.gov: Sign up for Medicare](https://www.ssa.gov/sign-up)
- [SSA.gov: Medicare guide \(2026\) \(PDF\)](#)

Medicare Savings Programs (MSP)

Medicare Savings Programs (MSP) are state-administered programs that help individuals with limited income and resources pay their Medicare costs. Depending on the specific program, an MSP can cover Medicare Part B premiums and, in some cases, Part A premiums, deductibles, and coinsurance.

Program Types and Benefits

There are four primary types of Medicare Savings Programs. If a beneficiary qualifies for QMB, SLMB, or QI, they automatically qualify for Extra Help (LIS) to pay for prescription drug costs.

Qualified Medicare Beneficiary (QMB)

- **Benefits:** Pays for Part A premiums, Part B premiums, deductibles, coinsurance, and copayments.
- **Requirement:** Providers are legally prohibited from billing QMB patients for Medicare-covered services.

Specified Low-Income Medicare Beneficiary (SLMB)

- **Benefits:** Pays for the **Part B premium** (\$202.90 in 2026) only.

Qualifying Individual (QI)

- **Benefits:** Pays for the **Part B premium** only.
- **Note:** Individuals must apply every year, and benefits are granted on a first-come, first-served basis.

Qualified Disabled and Working Individual (QDWI)

- **Benefits:** Pays for the **Part A premium** only.
- **Target:** Specifically for disabled individuals who returned to work and lost their premium-free Part A.

Eligibility (New Jersey)

Program	Individual Income Limit (Monthly)	Married Couple Income Limit (Monthly)	Resource (Asset) Limit
QMB	\$1,330	\$1,803	\$9,950 (Indiv.) / \$14,910 (Couple)
SLMB	\$1,596	\$2,164	\$9,950 (Indiv.) / \$14,910 (Couple)
QI	\$1,795	\$2,434	\$9,950 (Indiv.) / \$14,910 (Couple)
QDWI	\$5,405	\$7,299	\$4,000 (Indiv.) / \$6,000 (Couple)

**Some states, like New York or Connecticut, may have higher limits or no asset test.*

How to Apply

- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov): Official website of Medicare.
- [Medicaid.gov](https://www.medicaid.gov): Official website of Medicaid.
- [SSA.gov](https://www.ssa.gov): Apply for Extra Help for prescription drug costs (may apply with MSP at the same time).

Contact

- **NJ SHIP (State Health Insurance Assistance Program)**: Free counseling from state-trained experts
 - NJ SHIP: 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP Counseling](https://www.nj.gov/ship-counseling)
 - Bergen County SHIP: 201-336-7413 | [Bergencountynj.gov SHIP Counseling](https://www.bergencountynj.gov/ship-counseling)
- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

PART I • SECTION 4

Medicaid

메디케이드 (Medicaid)

State and federal healthcare assistance for low-income individuals: New Jersey FamilyCare / Medicaid, Managed Care Organizations (MCOs), ACA Medicaid expansion, Marketplace coverage, and specialized eligibility rules.

This section contains 9 comprehensive guides

Medicaid Overview

Medicaid is a health insurance program jointly operated by the federal and state governments for low-income adults, children, pregnant women, seniors, and people with disabilities. Because each state manages its own program with federal support, the specific names (e.g., NJFamilyCare in New Jersey) and eligibility requirements may vary by state; however, it fundamentally serves as a vital medical safety net for vulnerable populations.

Features and Benefits

- **Low Cost Burden:** Eligible beneficiaries pay little to no monthly premiums, and out-of-pocket costs (copays) for doctor visits or prescriptions are also free or very inexpensive.
- **Broad Range of Medical Services:** In addition to general doctor visits and hospital services, it provides extensive coverage for dental, vision, prescription drugs, and long-term care services that are often difficult to cover with private insurance.
- **Year-Round Enrollment:** Unlike general health insurance with fixed enrollment periods, beneficiaries can apply for and receive Medicaid benefits at any time of the year as long as they meet the eligibility requirements. Once eligibility is confirmed through the review process after application, coverage begins on either the date of application or the first day of the month in which the application was submitted.

Types of Medicaid

- **Pregnancy Medicaid:** Pregnancy Medicaid covers all medical expenses during pregnancy, including prenatal screenings, childbirth, and newborn care. In many states, including New Jersey, coverage is extended for up to 12 months postpartum. (Availability varies by state.)
- **Children's Health Insurance Program (CHIP):** CHIP is provided at a low cost for children (Under 19 years of age) in families whose income is higher than Medicaid limits but insufficient to afford private insurance.
- **ACA Medicaid (Medicaid Expansion):** ACA Medicaid was expanded through the ACA (Affordable Care Act), widely known as Obamacare. ACA Medicaid expanded eligibility to include all low-income adults with a household income at or below 138% of the Federal Poverty Level, regardless of parental or disability status.
- **Regular Medicaid (ABD Program):** Regular Medicaid provides essential medical services and long-term care benefits to low-income individuals who are Aged (65+), Blind, or Disabled and meet specific income and asset criteria.

- **[Long-Term Care Medicaid \(LTC\)](#)**: LTC provides financial support for low-income seniors or individuals with disabilities who have mobility issues, covering the costs of Nursing Home placement or HCBS (Home and Community-Based Services) so they can receive caregiver assistance within their own homes or community settings.

Eligibility

- **Income and Asset Screening**: Eligibility follows the Federal Poverty Level (FPL) guidelines announced by the government each year. Specifically, Long-Term Care Medicaid involves strict screening of not only income but also held assets (cash, savings, etc.).
- **Immigration Status**: Generally, the primary eligibility is for U.S. citizens or Lawful Permanent Residents (Green Card holders) who have held their status for at least five years. However, for pregnant women or children, more relaxed criteria may apply depending on state regulations.

Medicaid vs. Medicare Q&A

Q1. Both are government programs, so what is the difference?

A. The biggest difference is "who" the target audience is.

- **Medicare**: Based on age. It is a federal program for anyone age 65 or older, or those with certain disabilities, regardless of wealth. Think of it as a "right" earned by paying taxes while working.
- **Medicaid**: Based on income. It is a joint federal and state-funded program, run by individual states, designed to help those with limited income and assets, regardless of their age.

Q2. How do the medical costs differ?

A. Medicare pays "part" of the cost, while Medicaid pays "almost all" of it.

- **Medicare**: Outpatient and physician services (Part B) cover 80% of the Medicare-approved amount, leaving the remaining 20% and the annual deductible as out-of-pocket expenses. Inpatient hospital services (Part A) are subject to a separate cost-sharing structure, which includes a deductible and daily copayments based on the length of the hospital stay.
- **Medicaid**: Covers almost all remaining out-of-pocket costs that Medicare doesn't pay. It also helps cover premiums and prescription drug costs.

Q3. Is the cost of a Nursing Home fully covered?

A. This is where the biggest difference lies.

- **Medicare:** Medicare covers up to **100 days** of **Skilled Nursing Care** only when a physician deems it necessary following a formal **inpatient** hospital stay of at least three days. The cost-sharing structure is as follows: **\$0** for days 1–20; **\$217 per day** for days 21–100 (as of 2026); and the full cost thereafter from day 101. Please note that **Custodial Care**, such as assistance with meals, bathing, and mobility, is not covered by Medicare.
- **Medicaid:** Supports long-term care. Medicaid covers nursing home costs or home health aide services (Home Care).

**Observation Status is not recognized as a formal inpatient admission, which may result in a denial of Skilled Nursing Facility (SNF) benefits. When admitted, be sure to confirm with the hospital whether your status is officially inpatient.*

Q4. I have both. What does that mean?

A. You have Dual Eligibility.

- If you hold both Medicare and Medicaid cards, you are considered **Dual Eligible**.
- You can enroll in a Dual Special Needs Plan (D-SNP), which coordinates the benefits of both programs into one integrated plan for more efficient care. Specific name of the D-SNP plan may vary by state.
- When you receive medical services under a D-SNP, Medicare acts as the primary payer, covering its portion first. Medicaid then serves as the secondary payer to cover the remaining costs. For more details visit our [D-SNP](#) page.

Q5. What happens if I move to another state?

A. Original Medicare stays the same; Medicaid must be reapplied for.

- **Medicare:** Since it is a federal program, you can use your Medicare plan anywhere in the United States without issue (Original Medicare only).
- **Medicaid:** Policies vary by state. If you move from New Jersey to New York, you must close your New Jersey coverage and apply for New York Medicaid to undergo a new eligibility review.

ACA Marketplace

The ACA Marketplace (Affordable Care Act Marketplace) is a government-run insurance exchange established under the healthcare reform law. It is a system where individuals can compare and purchase private health insurance and receive government subsidies based on their income. One of its core purposes is to help those whose income is too high to qualify for Medicaid yet low enough to need assistance, enroll in health insurance at affordable premiums through government subsidies.

Key Features (2026)

- **Subsidy Benefits (Premium Tax Credits):** If your household income is between 100% and 400% of the Federal Poverty Level (FPL), you are eligible for the federal APTC (Advance Premium Tax Credit). If your income exceeds 400% of the FPL, you will not be eligible for federal subsidies, and only the New Jersey State subsidy (NJHPS) will be available.
- **Pre-existing Condition Coverage:** Insurance companies cannot deny coverage or charge higher premiums just because you have a pre-existing condition (such as cancer or diabetes).
- **10 Essential Health Benefits:** Emergency services, hospitalization, pregnancy and maternity care, mental health services, and prescription drugs must be included.
- **Dependent Coverage:** Children can remain on their parents' health insurance plan until the age of 26.

Health Plan Levels

Plans are divided into four categories based on how you and your plan share costs.

Level	Plan Pays	You Pay	Features
Bronze	60%	40%	Lowest monthly premiums, but high out-of-pocket costs when you receive care.
Silver	70%	30%	The level where subsidies are maximized (Cost-Sharing Reductions for lower income).
Gold	80%	20%	Higher monthly premiums, but lower out-of-pocket costs for medical services.
Platinum	90%	10%	Highest monthly premiums; ideal for those who require frequent medical care.

Subsidy Benefit Guide (2026)

Household Size	Federal Subsidy (APTC)	NJ State Subsidy (NJHPS)	No Subsidy
Eligibility Basis	138% – 400% FPL	400% – 600% FPL	Over 600% FPL
1 Person	\$22,025 – \$62,600	\$62,601 – \$93,900	Over \$93,900
2 People	\$29,864 – \$84,600	\$84,601 – \$128,840	Over \$128,840
3 People	\$37,702 – \$106,600	\$106,601 – \$159,900	Over \$159,900
4 People	\$45,540 – \$128,600	\$128,601 – \$192,900	Over \$192,900

- **Federal Marketplace Subsidy (APTC):** The previous year's (2025) FPL guidelines are used to calculate subsidies. (The 400% FPL ceiling is \$62,600 for a 1-person household and \$128,600 for a 4-person household.)
- **NJ State Subsidy (NJHPS):** A separate benefit provided by the state of New Jersey (NJ Health Plan Savings). By applying through **GetCoveredNJ**, applicants with incomes up to 600% FPL can receive additional financial assistance.
- **Eligibility Verification:** The figures provided in this document are for reference purposes only. Final eligibility and benefit amounts are subject to the official determination results from GetCoveredNJ or the NJ FamilyCare website. **Starting in 2026, individuals with incomes exceeding 400% FPL are no longer eligible for federal subsidies (APTC) and can only receive NJ state subsidies.*

Enrollment Periods

- **Open Enrollment Period:** Because New Jersey operates its own state-based marketplace (**GetCoveredNJ**) rather than using the federal marketplace (**HealthCare.gov**), it offers a longer enrollment deadline.
 - Dates: **November 1 – January 31**
 - Enroll by December 31 for January 1 start
 - Enroll by January 31 for February start
- **Special Enrollment Period:** If certain changes (Qualifying Life Events) occur, you can enroll within 60 days even outside the regular period:
 - Marriage or Divorce
 - Birth or Adoption of a child
 - Relocation (Moving to a different state, etc.)
 - Loss of existing employer-sponsored insurance

How To Apply

- **Documents Needed for Application**
 - Social Security Numbers (SSN) for all household members or immigration documents (Green card, etc.)
 - Proof of household income (Tax returns, pay stubs, etc.)
 - Residential address information
- **Federal Marketplace**
 - Online Application: [HealthCare.gov](https://www.healthcare.gov) – Texas, Florida, Georgia, and approx. 30 other states.
 - Phone Application: 1-800-318-2596 (24/7, Korean interpretation available)
- **State-Based Marketplaces:**
 - New Jersey: [GetCoveredNJ](https://www.getcoverednj.com)
 - New York: [NY State of Health](https://www.nystateofhealth.com)
 - California: [Covered California](https://www.coveredcalifornia.com)
 - Pennsylvania: [Pennie](https://www.pennie.com)
- **Professional Assistance:** local Navigators or certified agents can help at no cost.

Contact

- **AWCA** can provide counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [HealthCare.gov](https://www.healthcare.gov): Official Marketplace Enrollment
- [HealthCare.gov](https://www.healthcare.gov) – Other Language Resources (Included Korean).
- [KFF.org](https://www.kff.org) – Health Insurance Marketplace Subsidy Calculator

ACA Medicaid (Medicaid Expansion)

The Affordable Care Act (ACA) is a federal law that allows each state government to expand Medicaid eligibility to low-income adults with incomes up to 138% of the Federal Poverty Level (FPL).

Officially named as NJ FamilyCare in New Jersey, this Medicaid program allows low-income adults, including those without dependent children, to receive comprehensive health insurance benefits through NJ FamilyCare with no monthly premiums.

**OBBA (One Big Beautiful Bill Act) implementations may affect eligibility and program details.*

Eligibility

- **Target:** New Jersey residents between 19 and 64
- **Immigration Status:** Lawful Permanent Resident (LPR) status for at least 5 years.
 - **Refugee/Asylee and LPR:** Under OBBA rules, refugees or asylees who haven't adjusted to LPR status may lose eligibility starting **October 1, 2026**.
- **Work and Community Engagement Requirements (OBBA):** Proof of at least **80 hours** per month of work, education, vocational training, or community service is required. (Effective January 1, 2027)

**Work exempt groups: ① Children 18 and under, ② ABD (Aged, Blind, and Disabled) beneficiaries, ③ Parents or caregivers of children under 14 or persons with disabilities, ④ Individuals with serious physical or mental health conditions, ⑤ Pregnant women and those within one year postpartum, ⑥ Former foster youth under age 26, ⑦ Individuals who are incarcerated or recently released from incarceration. *For details refer to the [NJ DHS](#) page*

Income Guidelines (2026)

At or below 138% of the Federal Poverty Level (FPL)

Household Size	Maximum Monthly Income (138% FPL)
1 Person	\$1,836 or less
2 Persons	\$2,489 or less
3 Persons	\$3,142 or less
4 Persons	\$3,795 or less
5 Persons	\$4,449 or less
6 Persons	\$5,102 or less
7 Persons or more	Add +\$654 per additional person

- **No Cost Sharing:** Individuals within 0-138% FPL range have no monthly premium and no copayments for any covered medical services.
- **Household Size:** Includes total number of parents or caretakers, tax-dependent children under the age of 21, and any other tax dependents residing within the same household.
- **Income Verification:** Eligibility is calculated based on Modified Adjusted Gross Income (MAGI) This is typically verified electronically using federal tax reporting data to ensure a streamlined application process.
- **Annual Renewal:** Eligibility is re-evaluated on an annual basis. Once renewal documents are received, information must be updated within the specified deadline to maintain health benefits.

Comprehensive Benefits

- **Basic Medical Services:** visits to primary care physicians and specialists, routine physical check-ups, and essential immunizations.
- **Diagnostic and Specialized Care:** blood tests, X-rays, CT/MRI scans, and both inpatient and outpatient surgical procedures.
- **Dental and Vision Care:** basic dental examinations and treatments, eye exams, prescription eyeglasses.
- **Prescriptions and Mental Health:** prescription drug support, psychological counseling, and various services for substance use disorder treatments.

How to Apply

- **Online:** [NJ FamilyCare/quickstart](#) or [NJHelps.gov](#)
 - Contact: 1-800-701-0710 / TTY: 711

- **In-Person:** visit local County Board of Social Services
 - Bergen County, NJ Board of Social Services
 - 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - 201-368-4200
 - Hours: Weekdays 8:00 am thru 4:30 pm

**Enrollment is open year-round for NJ FamilyCare*

Contact

- **AWCA** can provide counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [NJ FamilyCare – Official Eligibility Requirements Guide](#)
- [NJ DHS – Online Application and Service Guide](#)
- [NJ.gov – County Social Service Office Location Search](#)
- [NJ FamilyCare – Q&A](#)

Children's Health Insurance Program (CHIP)

The Children's Health Insurance Program (**CHIP**) in New Jersey is a critical component of the **NJ FamilyCare** system. It is designed to provide comprehensive, affordable health coverage to children in families who earn too much to qualify for traditional Medicaid but cannot afford private health insurance.

Eligibility

- **Age:** Children under the age of 19
- **Residency:** Residents of New Jersey
- **Immigration Status:** As of 2026, under the '**Cover All Kids**' act, all children in the following household **Income Guidelines (2026)** receive the same cost benefits regardless of their immigration status.
- CHIP applications are open year-round and there is no waiting period.

Income Guidelines (2026)

Household Size	FPL 147% or below	FPL 147% – 150%	FPL 150% – 200%	FPL 200% – 355%
Premium	None	None	None	None
Copay	None	None	\$5 - 10	\$5 - \$35
1 Person	\$1,955 or less	\$1,956 ~ \$1,995	\$1,996 ~ \$2,660	\$2,661 ~ \$4,722
2 People	\$2,650 or less	\$2,651 ~ \$2,705	\$2,706 ~ \$3,606	\$3,607 ~ \$6,401
3 People	\$3,347 or less	\$3,348 ~ \$3,416	\$3,417 ~ \$4,554	\$4,555 ~ \$8,083
4 People	\$4,043 or less	\$4,044 ~ \$4,125	\$4,126 ~ \$5,500	\$5,501 ~ \$9,763
Each Add'l	+ \$696	+ \$711	+ \$947	+ \$1,682

**Children with income at or below 147% of the FPL are classified under Medicaid rather than CHIP, and all medical costs are fully covered at no charge.*

Comprehensive Benefits

- **Primary & Specialty Care:** Routine checkups, immunizations, and visits to specialists.
- **Dental Care:** Cleanings, fillings, X-rays, and essential orthodontic work.
- **Vision Care:** Eye exams and prescription eyeglasses.

- **Hospitalization:** Emergency room visits, inpatient hospital stays, and outpatient surgery.
- **Mental Health:** Counseling, behavioral health therapies, and substance abuse treatment.
- **Prescriptions:** Access to a wide network of pharmacies with low copays.

Key Changes in 2026

- **Continuous Eligibility:** Children now benefit from **multi-year continuous eligibility**, meaning they do not lose coverage due to minor fluctuations in family income during the year.
- **Telehealth Expansion:** Enhanced coverage for pediatric specialized telehealth services, including speech and occupational therapy.

Managed Care Enrollment (MCOs)

Families in New Jersey must choose an MCO to manage their child's healthcare. If families do not choose one, an MCO and a Primary Care Provider (PCP) is automatically assigned.

- Check if your preferred pediatrician is in the MCO's network.
- Review "Value-Added Services" such as free sports physicals or extra vision benefits.

* For details check the [New Jersey MCO](#) page.

How to Apply

- **Online:** [NJ FamilyCare website](#)
 - Contact: 1-800-701-0710 / TTY: 711
- **In-Person:** visit local County Board of Social Services
 - Bergen County, NJ Board of Social Services
 - 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - 201-368-4200
 - Hours: Weekdays 8:00 am thru 4:30 pm

*Enrollment is open year-round for NJ FamilyCare

Contact

AWCA can provide counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [NJ FamilyCare – Official CHIP Eligibility Guide](#)

- [NJ state official 'coverallkids' website](#)
- [CMS.gov – Insure All Kids Now \(CHIP\)](#)
- [CMS.gov – New Jersey CHIP \(PDF\)](#)
- [Medicaid.gov – NJ Medicaid and CHIP](#)

Hearing Aid

New Jersey operates hearing aid assistance and prescription drug subsidies in conjunction for low-income seniors and individuals with disabilities.

Reimbursement for hearing aid costs is available through the Hearing Aid Assistance to the Aged and Disabled (HAAD) program, administered by the New Jersey Division of the Deaf and Hard of Hearing (DDHH). Eligibility for this program is linked to the Pharmaceutical Assistance to the Aged and Disabled (PAAD) income standards.

Hearing Aid Assistance for the Aged and Disabled (HAAAD)

PAAD-enrolled NJ residents can receive reimbursements for hearing aids already purchased through the HAAAD program.

- **Reimbursement Amount:** \$500 per hearing aid, up to a **maximum of \$1,000 (for both ears)**. However, reimbursement is limited to once per calendar year; if you make an additional purchase in the following year, a new application must be submitted.
- **Eligibility:**
 - Must meet PAAD income limits and must be currently enrolled in PAAD or Lifeline.
 - Reimbursement is only available if the cost was not fully covered by Medicaid or other private insurance.

**If the cost of your hearing aid is fully covered by Medicaid, private health insurance, or retiree insurance, you are ineligible for the HAAAD reimbursement. If you have partial coverage, you may apply for the remaining balance. Additionally, Senior Gold beneficiaries are excluded from HAAAD eligibility.*

New Jersey Hearing Aid Project (NJHAP)

NJHAP provides free, high-quality refurbished hearing aids.

- **Age:** Individuals aged 65 or older, or those with hearing loss who have been determined disabled and are receiving SSDI (Social Security Disability Insurance).
- **Income:** Must meet NJ PAAD criteria (Single \$54,943 / Couple \$62,390).
- **Required Documents:**
 - PAAD Enrollees: [Form A](#) (Simplified process).
 - Non-PAAD Enrollees: [Form B](#) (Requires additional income verification).
 - Must submit a medical clearance or hearing exam from a physician or licensed audiologist.

Horizon NJ Health (Medicaid) Coverage

Members enrolled in Medicaid (FamilyCare/MLTSS) receive hearing aid benefits directly through their insurance without needing to apply for separate reimbursements.

- **Key Coverage:** Hearing exams, hearing aid devices, accessories, supplies, fitting, and repair services.
- **Procedures:** Coverage is typically available once every **48 months (4 years)**; a physician's exam and **Prior Authorization** from the insurer are mandatory.

**Benefit cycles may vary depending on your specific Managed Care Organization (MCO) plan; please contact your insurance provider (MCO) directly to confirm your coverage details.*

Under 21: Through the [EPSDT program](#), children and young adults receive broader access to hearing technology and related services.

How To Apply

- **HAAAD**
 - **Online Application:** [NJSave](#)
 - **Postal Submission:** Download application form from [NJ.gov HAAAD](#) and submit it by mail.
 - **Contact:** 1-800-792-9745 *PAAD/Lifeline enrollees must complete the HAAAD application and submit it with the required documentation.
- **NJHAP**
 - **Postal Submission:** Download application form from the [New Jersey Hearing Aid Project](#) and submit it by mail.
 - **Contact:** DDHH 609-588-2648 | communications2@dhs.nj.gov

**The processing period is approximately 2 weeks upon receipt of the application. Once eligibility is verified, the DDHH will mail a confirmation letter and a list of participating audiologists. However, depending on the inventory of donated hearing aids, actual delivery may take between 8 to 12 weeks.*

Contact

- **AWCA** can provide counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [NJ DDHH – NJ Hearing Aid Project Official Guide & Application](#)
- [NJ DHS – PAAD and HAAAD Reimbursement Procedure Guide](#)

- [Horizon NJ Health – Medicaid Hearing Aid Benefit Summary](#)
- [Horizon NJ Health – Hearing Aid Policies and Prior Authorization](#)

Long Term Care Medicaid (MLTSS)

Long Term Care Medicaid is a joint federal and state program for individuals with chronic illnesses, disabilities, or cognitive disorders who cannot care for themselves.

New Jersey's LTC Medicaid is operated by the Managed Long Term Services and Supports (MLTSS) program. Delivered as part of NJ FamilyCare, MLTSS coordinates all services through designated Managed Care Organizations (MCOs), also known as HMOs or health plans. The program's core objective is to provide a comprehensive support system that enables patients to maintain an independent life in a familiar environment for as long as possible.

Key Covered Services

- **Home Care Services:** Household assistance and personal care services provided at the patient's residence.
- **Community Residential Care:** Support for admission to Assisted Living facilities and community-based residential facilities.
- **Nursing Home Care:** Coverage for professional skilled nursing facility (Nursing Home) admission and intensive care.
- **Medical Services:** Hospital visits, specialist consultations, and prescription drug support.
- **Other Support:** Connections to customized long-term care resources based on the patient's specific condition.

LTC Management Systems

When a Medicaid beneficiary requires nursing home admission or long-term care, services are managed through one of the following two pathways:

- **NJ FamilyCare MCO:** Services are managed via selected health plans, where a care manager establishes a personalized care plan.
- **PACE (Program of All-Inclusive Care for the Elderly):** A one-stop integrated program for seniors aged 55+, providing medical and long-term care while prioritizing community living.

Eligibility

Category	Detailed Eligibility Criteria
Target	Individuals 65 or older, or those under 65 determined to have a disability by the SSA or the State of New Jersey.
Income	Monthly Gross Income Limit: \$2,982 (Individual)
Financial Requirements	Asset (Resource) Limit: \$2,000 (Individual) Spousal Impoverishment (Only one spouse applying): • MMMNA: if the spouse's monthly income falls below \$2,643.75 they are entitled to a portion of the applicant spouse's income. • CSRA: spouse living in the community may retain up to \$162,660 in assets.
Clinical Requirements	A formal determination of the need for Nursing Facility Level of Care (NFLOC) Evaluation Criteria: Comprehensive evaluation of Activities of Daily Living (ADLs)—eating, bathing, dressing, toileting, and mobility.

**For higher income, use a Qualified Income Trust (QIT) to meet the eligibility.*

**Countable Assets: Includes cash, checking/savings accounts, stocks, bonds, and secondary properties.*

**Excluded Assets: primary residence, one vehicle, and certain prepaid funeral arrangements are not counted toward the \$2,000 limit.*

**Couple both applying have different financial requirements.*

The Asset Look-back Period

The most rigorous part of the application is the Asset Look-back Period. The state verifies if assets were improperly transferred to qualify for Medicaid.

- **Cash Withdrawal Prohibition:** Unexplained high-value cash withdrawals (generally over \$500) in 5-year bank records are often flagged as 'gifts.'
- **Importance of Records:** Every spend-down expenditure must be backed by receipts and contracts to avoid being judged as an improper transfer.
- **Expert Consultation:** Medicaid rules are complex. Consulting an Elder Law Attorney is the safest way to manage high-value assets.

Application Checklist

Essential Basic Proof Documents

- **Identification:** Citizenship certificate, birth certificate, or Permanent Resident Card (I-551).
- **Residence:** Utility bills or lease agreements showing the current residence address.
- **Social Security:** Copy of the Social Security Card and current health insurance cards (Medicaid, etc.).

Income and Asset Proof Documents (5-Year Records)

- **Income:** Benefit verification letters from the SSA, pension records, and proof of all rental or interest income.
- **Financials:** Full bank statements for the last 60 months for all accounts, including closed or zero-balance accounts.
- **Property:** Property tax bills, mortgage info, life insurance policies (cash value), and vehicle titles.

Clinical and Legal Documents

- **Disability:** Official determination letters from the SSA for applicants under 65.
- **Legal:** Power of Attorney (POA) or guardianship documents, and fair market value proof for any asset movements.

Legal Asset Spend-down Strategies for Eligibility

If assets exceed the \$2,000 limit, applicants may use qualified expenditures to reduce assets to the required level legally.

Modernization of Personal and Household Assets

- **Debt Repayment:** Prioritize the payment of mortgages, credit card debts, unpaid taxes, and other legal loans.
- **Home Improvement:** Necessary repairs such as roof fixing, wheelchair ramp installation, or replacing old appliances in the primary residence.
- **Medical Equipment:** Purchasing devices not covered by insurance, such as specialized beds, wheelchairs, or hearing aids.

Irrevocable Pre-paid Funeral Contracts

Funds deposited into an Irrevocable Prepaid Funeral Trust—typically around \$15,000 to cover standard funeral expenses—are excluded from Medicaid asset calculations, provided they are supported by a detailed statement of goods and services.

- Depositing excessive sums—specifically amounts exceeding \$20,000 to \$30,000—may be flagged as an attempt to “shield” assets and may trigger a Medicaid investigation or audit.

- It is recommended to consult with a licensed funeral professional or an Elder Law Attorney before finalizing any irrevocable contracts.

Payment for Professional Services

Fees paid for legal services (estate planning), accounting, and Medicaid application assistance are considered valid spend-down expenses.

How to Apply

- **Contact your local Aging and Disability Resource Connection (ADRC)** to request an MLTSS application. Simultaneously, apply for financial eligibility (Medicaid) through the Board of Social Services. They will verify if your income and assets meet the required criteria.
- A Managed Care Organization (MCO) representative will visit your home for a clinical assessment. They will evaluate your functional needs, such as how much assistance you require with Activities of Daily Living (ADLs), including bathing, dressing, and mobility.
- Select a health insurance plan. Once you have cleared both the clinical and financial screenings, you will choose an MCO. Options include: Horizon, UnitedHealthcare, Aetna, etc. **The online application ([NJ FamilyCare/quickstart](#)) only addresses **the Financial Screening**. The ADRC consultation and the Clinical Assessment must be coordinated separately. *If you are already enrolled in NJ FamilyCare please contact your MCO's directly to request an MLTSS clinical assessment, rather than contacting your county ADRC.*

Contact

- **Long-Term Care Medicaid (MLTSS):** Contact your local Aging and Disability Resource Connection (ADRC) and the Board of Social Services.
 - Bergen County Division of Senior Services
 - Address: One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
 - Phone: 201-336-7400
 - Email: seniors@bergencountynj.gov
 - Bergen County Board of Social Services
 - Address: 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - Phone: 201-368-4200
 - NJ ADRC Statewide Toll-Free Number: 1-877-222-3737
- AWCA can provide counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [NJ DMAHS – Official Long-Term Care Medicaid Information](#)
- [National PACE Association – Understanding the PACE Model](#)

Medicaid Managed Care Organization (MCO) System of New Jersey

The Medicaid Managed Care Organization (MCO) system is a healthcare delivery framework designed to manage the cost, utilization, and quality of services provided to beneficiaries.

New Jersey began transitioning from the traditional fee-for-service model to a managed care approach in 1995. Under this system, the state Medicaid agency contracts with MCOs—health insurance companies—to provide a comprehensive package of healthcare services.

This structure aims to improve health outcomes by streamlining the delivery of care and enhancing service quality.

MCO System Framework

New Jersey's Medicaid and public health insurance services are collectively known as **NJ FamilyCare**.

Medicaid recipients in New Jersey enroll in a specific health plan managed by an MCO through the NJ FamilyCare program. The MCO is responsible for coordinating the member's overall medical care, ensuring that services are efficient and accessible.

Key Aspects

- **Structured Network:** Provides better care coordination than traditional methods through a network of verified doctors and hospitals.
- **Value-Added Services:** MCOs have the authority to offer additional benefits (such as dental, vision care, and health incentives) that go beyond the standard requirements of regular Medicaid.
- **Integrated Care:** There is an increased emphasis on the integration of behavioral health and physical health services, ensuring beneficiaries receive more comprehensive care.

List of New Jersey Managed Care Providers

Five major health plans participate in the NJ FamilyCare program. These insurers provide services in all 21 counties in the state, including Bergen, Hudson, and Essex.

**Fidelis Care does not provide services in Hunterdon County.*

- **Aetna Better Health of New Jersey**
 - Address: 3 Independence Way, Suite 400, Princeton, NJ 08540

- Member Services: 1-855-232-3596 (Available 24/7)
- TTY for Hearing Impaired: 711
- Website: aetnabetterhealth.com/newjersey
- **Fidelis Care (formerly WellCare of New Jersey)**
 - Address: 33 Washington Street, 1st Floor, Newark, NJ 07102
 - Member Services: 1-888-453-2534 (Mon-Fri, 8 AM–6 PM)
 - TTY for Hearing Impaired: 711 or 1-877-247-6272
 - Website: fideliscarenj.com
- **Horizon NJ Health**
 - Address: 1700 American Blvd., Pennington, NJ 08534
 - Member Services: 1-800-682-9090 (Mon-Fri, 8 AM–8 PM)
 - Provider Only: 1-800-682-9091
 - TTY for Hearing Impaired: 711
 - Website: horizonnjhealth.com
- **UnitedHealthcare Community Plan**
 - Address: 333 Thornall St, 9th Floor, Edison, NJ 08837
 - Member Services: 1-800-941-4647
 - Provider Only: 1-888-362-3368 (Mon-Fri, 8 AM–6 PM)
 - TTY for Hearing Impaired: 711
 - Website: uhccommunityplan.com/nj
- **Wellpoint (formerly Amerigroup New Jersey)**
 - Address: 101 Wood Avenue South, 8th Floor, Iselin, NJ 08830
 - Member Services: 1-800-600-4441 / Provider Only: 1-800-454-3730 (Mon-Fri, 8 AM–6 PM)
 - TDD: 1-800-852-7899
 - Website: wellpoint.com/nj

Resources

- [Medicaid.gov](https://www.medicaid.gov) – Official Medicaid Program Overview
- [NJ Department of Human Services – Managed Care Organization Guide](#)

Pregnancy Medicaid

Medicaid for pregnant women is administered by each individual state, and New Jersey's pregnancy Medicaid is operated as follows:

NJ FamilyCare/Medicaid provides essential health insurance to pregnant women residing in New Jersey. This program ensures that expectant mothers have access to the medical care necessary for a healthy pregnancy and delivery. Benefits cover all medical costs for the mother's health from early pregnancy through the first year after childbirth.

Eligibility

- **Residency:** current residents of New Jersey.
- **Immigration Status:** U.S. citizenship or lawful immigration status. (DACA not eligible)
- **Income Limit:** Total household income at or below 205% of the Federal Poverty Level (FPL).

Income Limit (2026)

**For pregnant women, the fetus is included in the household size (e.g., a single pregnant woman is considered a 2-person household)*

Household Size (Including Fetus)	Monthly Income Limit	Annual Income Limit
2 Persons (1 pregnant individual)	\$3,697	\$44,362
3 Persons	\$4,668	\$56,006
4 Persons	\$5,639	\$67,650
Each Add'l	+ \$971	+ \$11,644

Benefits and Extension of Care

NJ FamilyCare provides comprehensive medical services throughout all stages of pregnancy to ensure healthy childbirth and postpartum recovery.

Major Medical Coverage

Service Category	Detailed Coverage Content
Prenatal Care	Regular checkups, ultrasounds, genetic testing, prenatal vitamins, prenatal education
Delivery and Birth	Vaginal delivery, C-section, epidurals, all hospital inpatient fees, newborn care
Postpartum Care	Post-birth checkups, breastfeeding counseling, mental health (postpartum depression) support
Other Essential Benefits	Prescription drugs, dental care, vision care, specialist visits, mental health and substance abuse treatment

Postpartum Extension

Pregnancy Medicaid recipients maintain their insurance eligibility for **12 months (365 days)** after childbirth, regardless of changes in income.

- **Extension Period:** Coverage is provided for 12 months from the date of childbirth or the end of the pregnancy. (including miscarriage and stillbirth)
- **Maintenance of Benefits:** All comprehensive benefits received during pregnancy remain identical during the postpartum period.
- **Automatic Renewal:** Once approved under the pregnancy category, coverage continues for one year postpartum without a separate income redetermination.

Special Support for Older and High-Risk Pregnancies

Starting in 2026, additional monitoring and care management services for older pregnant women and high-risk pregnancy groups have been strengthened. Care management services for high-risk pregnant women are provided through MCOs (Managed Care Organizations).

OB/GYN Assignment and First Appointment

The first thing to do after Medicaid approval is to find an obstetrician/gynecologist (OB/GYN) within the network of insurance company

- **Check Insurance Network:** check the list of OB/GYNs that accept Medicaid through MCO website or customer center.
- **Use Care Management Services:** once the insurance company is informed of pregnancy, they will assign a Care Manager. Care Manager determines high-risk status and help with appointment scheduling and transportation support (Non-Emergency Medical Transportation).
- **What to Bring to First Visit:** bring NJ FamilyCare card and ID; during the special approval period for pregnancy, there are no separate copays.

Dental Care for Pregnant People

Service Item	Coverage Content
Regular Exams and Cleaning	Coverage for two basic cleanings and comprehensive exams per year
Periodontal Treatment	Support for deep cleaning (scaling) for gum disease that may worsen during pregnancy
Cavity Treatment	Fillings and crown treatments if necessary
Emergency Care	Extractions or root canals due to sudden toothaches

Additional Medicaid-Related Benefits

Each Managed Care Organization (MCO) provides incentives in addition to basic Medicaid benefits to encourage healthy childbirth (Benefits and incentive types may vary by MCO).

- **Rewards Cards:** Gift cards (\$25–\$50) for retailers like Walmart or CVS for attending prenatal or postpartum checkups.
- **Free Baby Supplies:** Providing items such as breast pumps, car seats, or diaper bags for free or via discount coupons.
- **Transportation Support:** Free taxi service or bus cards for hospital visits.

Alternative Programs

Even if you do not qualify for Pregnancy Medicaid, several assistance programs are available for pregnant residents in New Jersey to ensure healthy childbirth.

Major Alternative Options

Program Name	Target Audience and Purpose	Key Support Content
GetCoveredNJ	Individuals exceeding Medicaid income limits	Affordable private insurance through state subsidies
MEPP (Emergency)	Undocumented individuals and non-citizens	Full coverage of emergency hospital costs for labor and delivery
NJSPCP (Prenatal)	Individuals meeting NJ FamilyCare income criteria but not immigration status	Prenatal exams, ultrasounds, vitamins, and 60-day postpartum contraception
FQHC (Health Center)	Everyone regardless of income/status	Low-cost medical services based on a sliding scale
Charity Care	Low-income uninsured patients	Full or partial reduction of hospital and delivery costs

How to Apply

- **Online:** [NJ FamilyCare/quickstart](#)
 - Contact: 1-800-701-0710 / TTY: 711
- **In-Person:** visit local County Board of Social Services
 - Bergen County, NJ Board of Social Services
 - 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - 201-368-4200
 - Hours: Weekdays 8:00 am thru 4:30 pm

**Enrollment is open year-round for NJ FamilyCare*

Contact

- AWCA can provide counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [NJ Department of Human Services – Pregnant People Medicaid Guide](#)
- [NJ FamilyCare – Eligibility for Pregnant Women](#)

ABD Medicaid (NJ FamilyCare ABD)

The NJ FamilyCare ABD (Aged, Blind, Disabled) program, also known as Regular Medicaid, is a comprehensive healthcare initiative jointly funded by the federal and state governments. It provides essential medical coverage to New Jersey residents aged 65 or older, as well as those determined to be blind or disabled by the Social Security Administration (SSA) or the State of New Jersey.

The ABD program is not a single entity but consists of several sub-programs, including SSI-Related Medicaid, NJ Care Special Medicaid, Medicaid Only, NJ WorkAbility, and Long Term Care Medicaid (MLTSS). The specific program for which an individual qualifies depends on their income, asset levels, and personal circumstances.

Eligibility (2026)

- **Age/Status:** Must be 65+, blind, or disabled.
- **Income Limit:** \$1,330/month (Single) | \$1,804/month (Couple).
- **Asset Limit:** \$4,000 (Single) | \$6,000 (Couple).

Benefits

- **Primary and Specialist Care:** Routine physical exams, immunizations, primary care physician (PCP) visits, and specialist consultations across all medical fields.
- **Dental Services:** Routine examinations, X-rays, fillings, extractions, and other essential dental treatments.
- **Vision and Hearing:** Coverage includes regular eye exams, prescription eyewear, and hearing screening services.
- **Prescription Drug Benefits:** Access to a wide range of prescription medications through an extensive network of participating pharmacies.
- **Mental Health Services:** Comprehensive outpatient and inpatient counseling services for mental health maintenance and substance abuse recovery.

**Dual Eligibility: Individuals enrolled in Medicare may also apply for Regular Medicaid. Upon qualification, Medicaid provides assistance with Medicare premiums, copays, and deductibles.*

**Automatic Eligibility: Supplemental Security Income (SSI) recipients are automatically eligible for ABD Medicaid and are not required to submit a separate application.*

How To Apply

- **Online:** [NJ FamilyCare/quickstart](#)
 - Contact: 1-800-701-0710 / TTY: 711
- **In-Person:** visit local County Board of Social Services
 - Bergen County, NJ Board of Social Services
 - 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - 201-368-4200
 - Hours: Weekdays 8:00 am thru 4:30 pm
- **Mail:** [ABD program Application Form \(PDF\)](#)
 - Complete form and mail to local Board of Social Services

**Enrollment is open year-round for NJ FamilyCare*

Contact

- **AWCA** can provide counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [NJ FamilyCare – Official Eligibility Requirements Guide](#)
- [NJ.gov – County Social Service Office Location Search](#)
- [NJ DHS – WorkFirst NJ \(WFNJ\) Cash Assistance Application Guide](#)
- [NJ DHS – NJ SNAP Food Stamp Application Official Guide](#)

PART I • SECTION 5

Medicaid Specials

메디케이드 특별 플랜 (Medicaid Specials)

Specialized Medicaid safety nets: Dual Eligible Special Needs Plans (D-SNP), Spousal Impoverishment protection, Charity Care hospital assistance, Emergency Medical Assistance, WFNJ/GA & TANF, Funeral Assistance, Medicaid Buy-In for disabled workers, and Medicaid Estate Recovery.

This section contains 9 comprehensive guides

Charity Care / Hospital Care Payment Assistance

The **New Jersey Hospital Care Payment Assistance Program** (also known as **Charity Care**) is a medical bill reduction program provided by state-designated acute care hospitals and university hospitals for low-income individuals who are uninsured or underinsured.

The New Jersey Hospital Care Payment Assistance Program is regulated by the **NJ Department of Health** and is funded by the state; however, the application process and eligibility screening are conducted directly by the hospital where the treatment was received.

Eligibility

- **Residency & Insurance Status:**

- Must be uninsured or have insurance that leaves the patient with excessive out-of-pocket costs.
- Individuals who are ineligible for government-subsidized insurance, such as **Medicaid**, or private health insurance.

- **Assets:**

- **Individual:** \$7,500 or less
- **Family:** \$15,000 or less

**Note: One's primary residence is excluded from asset calculations. However, cashable retirement accounts such as IRAs may be included in asset calculations (N.J.A.C. 10:52-11.10). For non-withdrawable accounts like certain 401(k)s, individual verification with the hospital is required.*

Income Levels (2026)

Income Level (% of Federal Poverty Level)	Patient Responsibility	Assistance Type
200% FPL or Below	0% (Fully Waived)	Free Care
201% – 225% FPL	20%	Partial Discount
226% – 250% FPL	40%	Partial Discount
251% – 275% FPL	60%	Partial Discount
276% – 300% FPL	80%	Partial Discount

**Patients with incomes between 201% and 300% of the FPL (eligible for partial discounts) can receive 100% additional coverage for any out-of-pocket medical expenses that exceed 30% of their annual income.*

Considerations

- Applied to medically necessary inpatient and outpatient services provided at **acute care hospitals**. Cosmetic or elective procedures are excluded.
- **Separate Physician Bills:** While hospital facility charges may be reduced, you may receive separate bills from independent specialists (e.g., anesthesiologists, radiologists) who are not hospital employees.
- **Medicaid Screening:** Hospitals will first screen for Medicaid eligibility. If you qualify for Medicaid, you must apply for it before being considered for Charity Care.

Application & Contact

- **Where to apply:** Financial Counseling or Patient Billing Department at any general hospital.
- **AWCA** provides expert consultations free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ DOH.gov – Official Charity Care Information](#)
- [NJ DOH.gov – 2026 Hospital Care Assistance Fact Sheet](#)
- [DollarFor.org – NJ Charity Care Eligibility & FPL Calculator](#)

Dual Eligible Plan (D-SNP)

A **Dual Eligible** refers to individuals who have **Medicare**, the health insurance for seniors age 65 or older and people with disabilities, while simultaneously receiving **Medicaid**, medical assistance for low-income individuals.

Dual eligibles can receive more efficient medical services by enrolling in a **D-SNP (Dual Special Needs Plan)**, which integrates the benefits of both insurances into one. Under federal guidance, D-SNP plans are managed according to unique names and operating policies in each state.

**OBBA (One Big Beautiful Bill Act) implementations may affect eligibility and program details.*

Three Types of D-SNPs

D-SNPs are divided into three types based on the level of integration, with FIDE SNP being the highest level of full integration.

- **CO D-SNP (Coordination-Only):** A basic plan that coordinates Medicare and Medicaid benefits. The management entities for the two insurances remain separate.
- **HIDE SNP (Highly Integrated):** A highly integrated plan where a single insurance carrier manages most Medicare and Medicaid services.
- **FIDE SNP (Fully Integrated Dual Eligible SNP):** A fully integrated plan where a single insurance carrier provides 100% integrated management of Medicare and Medicaid (including MLTSS long-term care services) benefits. In New Jersey, major carriers operate FIDE SNPs, and available plans may vary by county.

Similar Program Names by State:

- New Jersey, Massachusetts, etc.: FIDE SNP
- New York: MAP (Medicaid Advantage Plus) — A New York-specific integrated plan combining D-SNP and Medicaid Long-Term Care (MLTC)
- California: Medi-Medi Plans (Official Name)

Eligibility

- **D-SNP (CO D-SNP / HIDE SNP):** Anyone who is dually eligible for both Medicare and Medicaid can consider enrollment. Receiving **MLTSS** (long-term care) is not required.
- **FIDE SNP (New Jersey Criteria):** Must meet all four of the following conditions:

- Hold Medicare Parts A and B
- Hold full NJ Medicaid (NJ FamilyCare)
- Not enrolled in a PACE program
- Resident of New Jersey

**Receiving MLTSS (Long-Term Care) itself is not a mandatory requirement for FIDE SNP enrollment. However, those receiving MLTSS can also join a FIDE SNP to have all services managed in one place.*

D-SNP Benefits

D-SNPs coordinate Medicare and Medicaid benefits and include various additional services linked to state Medicaid.

Minimizing Medical and Drug Costs (Cost Sharing)

- **Premium:** For those receiving full Medicaid medical benefits, there is no monthly premium, and there are no out-of-pocket costs (copays) for hospital visits or tests.
- **Copay:** Generally, there are no out-of-pocket costs for **In-Network** doctor visits, specialist visits, tests, or hospitalizations. However, Medicaid beneficiaries who only receive premium assistance (QI, SLMB, etc.) from the state may pay some copays.
- **Prescription Drugs:** Through Medicare Part D **Extra Help**, most prescription drug copays are eliminated, regardless of annual limits.

Benefits Card (OTC & Grocery)

- **OTC (Over-the-Counter) Support:** Monthly or quarterly credits are provided to purchase non-prescription drugs, vitamins, and first-aid supplies. Amounts may be slightly lower than FIDE SNP.
- **Grocery & Utilities:** Provided only to eligible individuals with **chronic conditions** (diabetes, hypertension, etc.) to pay for groceries or electricity/gas bills.

Supplemental Medical Benefits

- **Dental:** Provides comprehensive dental benefits, including not only basic exams but also fillings, crowns, dentures, and implants within an annual limit.
- **Vision:** Supports annual eye exams and a set amount for prescription glasses.
- **Hearing:** Supports hearing exams along with the cost of hearing aids and fitting.

Transportation & Wellness

- **Medical Transportation:** Provides a set number of rides (Uber/Lyft or dedicated vans) for doctor appointments and pharmacy visits.
- **Fitness:** Provides free gym memberships such as **Silver&Fit** or **SilverSneakers**.

- **24-Hour Nurse Line:** Provides telephone consultation services with professional nurses 24/7 for urgent health advice.

FIDE SNP Benefits

FIDE SNP benefits from major New Jersey carriers (**Horizon, UnitedHealthcare, Aetna, Wellcare**, etc.) are as follows:

Medical Costs (Cost Sharing)

- **Copay:** Doctor visits, specialist visits, and hospitalization costs are fully waived.
- **Prescription Drugs:** Most prescription drug copays are eliminated, including Medicare Part D (Extra Help).

Integrated Card Benefits (OTC & Grocery)

- **OTC (Over-the-Counter) Support:** Monthly or quarterly amounts are loaded onto a card to purchase supplements and non-prescription drugs at CVS, Walgreens, etc.
- **Grocery & Utilities:** Most FIDE SNP plans provide an integrated card for purchasing groceries or paying utility bills (electricity, gas, water). (Approximately **\$150–\$300** per month depending on the plan).

Supplemental Benefits

- **Dental:** Covers comprehensive dental care, including implants, dentures, and scaling within an annual limit.
- **Vision:** Supports annual eye exams and the cost of purchasing glasses/contact lenses.
- **Hearing:** Provides hearing exams along with hearing aid costs and fitting services.

Transportation & Wellness

- Provides **unlimited or a set number** of rides (Uber/Lyft or dedicated vans) for hospital visits or pharmacy use.
- **Free Fitness Membership:** Access to local gyms and the YMCA, home fitness kits, and online exercise classes through **SilverSneakers** or **Silver&Fit**.
- **Healthy Rewards:** Rewards users with gift cards or cash-equivalent points for completing preventive activities such as regular checkups, flu shots, and blood sugar tests.
- **In-home Visits:** Provides the '**HouseCalls**' service where a specialist visits your home annually to check your health status and create a personalized care plan.
- **24-Hour Nurse Consultation:** Free phone consultations with professional nurses are available 24/7 for health inquiries or emergencies.
- **Wellness Digital App:** Access to real-time health tracking and wellbeing coaching (diet, exercise, etc.) via a smartphone app.

Key Differences

Category	D-SNP (CO/HIDE)	FIDE SNP
Key Features	Medicare and Medicaid are operated by separate entities, with the insurance company acting as a bridge.	A single insurance company integrates all services and finances, directly managing all decisions.
Ease of Management	Management of medical and long-term care (MLTSS) is separate, and you may need to carry separate Medicare and Medicaid cards.	Integrated Management (Access hospital, pharmacy, and caregiver services all at once with a single ID card).
Communication	You may need to contact the insurance carrier for medical inquiries and the county for social services separately.	One-Stop Service through a dedicated Care Manager who handles both medical and social service needs.
Dental/Vision	Very High (Relatively generous limits for implants and vision hardware allowances).	Moderate (Focuses on standard Medicaid coverage; additional limits may be lower).
Benefit Card	Usage is often restricted to OTC items rather than groceries. Chronic condition verification is required.	Higher limits for groceries and utilities (usually \$50–\$100 more per month). Higher combined amounts (up to approx. \$300/month).
Transportation	Primarily focused on medical purposes. Limited to a set number of trips (e.g., 24–48 times per year).	Unlimited or broader support. Available for groceries, dental/vision visits, and affiliated gyms as well as hospitals.

2026 Changes & Reminders (OBBBA Updates)

- Alignment: Federal and state governments (CMS/NJ DHS policies) actively encourage enrollment in FIDE SNPs, which unify Medicare and Medicaid carriers into one for administrative efficiency.
- Automatic Transition: Some D-SNP enrollees may be automatically transitioned to a FIDE SNP with enhanced benefits according to state guidelines; you must check enrollment notices sent by mail.
- Monthly Switching: Starting in 2025, full-benefit dual eligibles have a Monthly Integrated Care SEP (Special Enrollment Period) that allows switching between integrated plans (FIDE SNP, HIDE SNP, etc.) every month.

If you are receiving MLTSS, choose a plan based on your priorities:

- If a wider doctor network or higher dental surgery limits are important → D-SNP
- If cash-equivalent support (grocery card) and convenient administration are important → FIDE SNP

How to Apply

D-SNP

- **Online:** Medicare.gov — Find a Medicare Plan or individual insurance carrier websites.
- **Phone:** 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; 24/7) or individual insurance carrier phone numbers.

**Benefits generally begin on the 1st of the month following approval.*

FIDE SNP (New Jersey)

FIDE SNP is a fully integrated dual-eligible plan that manages Medicare and Medicaid benefits in one health plan. Choose the method that fits your situation:

- **To enroll in a FIDE SNP without MLTSS (Long-Term Care):** Contact 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) or contact the specific insurance carriers listed below directly.
- **If you also need MLTSS (Long-Term Care):** Contact your local county **ADRC** first for an **MLTSS clinical screening**. Once approved, request integration with a FIDE SNP carrier.

Bergen County Residents: Contact the Bergen County Division of Senior Services.

- Address: One Bergen County Plaza, Hackensack, NJ 07601
- Phone: 201-336-7400 | 1-877-222-3737
- Email: seniors@bergencountynj.gov

**Once MLTSS is approved, you must contact your chosen FIDE SNP insurance carrier and request to "Fully Integrate" your Medicare and Medicaid benefits with that carrier.*

Online/Phone: Individual FIDE SNP carriers (refer to the comparison table below or the official [NJ DHS page](#)).

**Once the process is complete, Medicaid management will automatically transfer from the state to your chosen FIDE SNP carrier. Keep your old cards, but use the single ID card issued by the FIDE SNP for all benefits.*

FIDE SNP Overview by Insurer (2026)

Carrier	D-SNP (Plan Name)	FIDE SNP (Plan Name)	Contact & Website	2026 Key Features
Horizon BCBS	Horizon NJ TotalCare	Horizon NJ TotalCare	1-800-543-5656 (TTY: 711) / Horizonblue.com	New Jersey's largest network. Provides up to \$3,000+ in annual benefits via the Horizon &more Card.
UnitedHealthcare	UHC Dual Complete	UHC Dual Complete	1-800-514-4911 (TTY: 711) / UHC.com	Enhanced UCard benefits. Provides approximately \$246+ in monthly credits for groceries/utilities, etc.
Aetna	Aetna Medicare D-SNP	Aetna Medicare FIDE	1-844-362-0934 (TTY: 711) / AetnaBetterHealth.com/NJ	Strong CVS pharmacy network. Provides an additional benefit card of approximately \$255 per month.
Wellcare (Fidelis)	Wellcare Dual Access	Fidelis Dual Align	1-866-892-8340 (TTY: 711) / Fideliscare.org	Expertise in Medicaid management. Excellent approval and coordination processes for MLTSS (Long-Term Care) services.
Wellpoint	Wellpoint Dual Advantage	Full Dual Advantage	1-844-765-5160 (TTY: 711) / Wellpoint.com	Community-focused service. Concentrates on simplified approval procedures and practical supplemental services.

*Carrier contact info and plan names may change annually. Check [Medicare.gov](https://www.medicare.gov) or [FIDE SNP Consumer and Provider Information](#) for the latest info.

Contact

- **NJ SHIP (State Health Insurance Assistance Program):** 1-800-792-8820 (Free counseling from state-trained experts)
- **AWCA** provides free consultations regarding these plans: (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJDHS.gov – FIDE SNP](https://www.njdhs.gov/fide-snp)
- [Medicare.gov – Medicare & You 2026 Handbook](https://www.medicare.gov/medicare-and-you/2026-handbook)
- [CMS.gov – D-SNP](https://www.cms.gov/d-snp)
- [ACL.gov – ADRC](https://acl.gov/adrc)

Emergency Medical Assistance (Emergency Medicaid)

Emergency Medicaid provides financial support through the **Medical Emergency Payment Program (MEPP)** and State Medicaid to ensure that low-income residents can receive treatment during emergencies, regardless of immigration status or insurance coverage.

Medical Emergency Payment Program (MEPP)

MEPP covers emergency room and labor/delivery costs for residents who do not qualify for regular Medicaid or adults who have held a Green Card for less than 5 years.

Eligibility

- **Immigration Status:** New Jersey residents who do not meet the status requirements for U.S. citizenship or Lawful Permanent Residency (5-year bar), but otherwise meet the **Medicaid income and asset eligibility criteria**.
- **Application Deadline:** Application must be filed within **3 months** of the date the emergency occurred.
- **Scope of Coverage:** Life-threatening emergencies, labor and delivery, and related inpatient costs.
- **Monthly Income Limits:**
 - **Adults (Ages 19-64):** Approx. **\$1,800** (Single) / **\$2,433** (Family of 2) — *Based on 138% FPL*
 - **Pregnant Women:** Approximately **\$2,647** for a single-person household (based on **199% of the FPL**).
 - **Seniors (65+) / Disabled:** Monthly income of **\$1,305** and an asset limit of **\$4,000** for a single-person household; for a two-person (couple) household, a monthly income of **\$1,763** applies, with a separate asset limit of **\$6,000**.

NJ FamilyCare & Cover All Kids

- **Target Population:** All children under 19 years of age residing in New Jersey, regardless of immigration status.
- **Income Limit:** Household income up to 355% FPL (Approx. **\$9,512/month** for a family of 4 – Deductibles may vary depending on the income bracket).
- **Benefits:** Comprehensive benefits including general checkups, dental, vision, and mental health, in addition to emergency care.

*See [CHIP](#) for more details.

NJ Supplemental Prenatal and Contraceptive Program (NJSPCP)

- **Target Population:** Pregnant women who are ineligible for **NJ FamilyCare** due to their immigration status.
- **Services Provided:** Prenatal exams, contraceptive/family planning services. (Does not cover labor, delivery, or postpartum care)
- **MEPP Linkage:** As the due date approaches, you can apply for MEPP in advance through your prenatal care provider to cover labor and delivery costs.

*See [Pregnancy Medicaid](#) for more details.

WIC Supplemental Nutrition Program

The New Jersey Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) provides essential food and nutrition education to all low-income pregnant individuals. Managed by the State of New Jersey, this program operates independently from Medicaid and is available to those in need regardless of immigration status.

- **Eligibility:** Low-income pregnant and postpartum individuals, regardless of immigration status
- **Benefits:** Vouchers for essential nutritious foods (such as milk, eggs, and cheese) and professional nutrition education/counseling
- **Key Note:** Can be utilized alongside medical assistance programs such as NJSPCP. WIC is a supplemental initiative dedicated to supporting healthy pregnancies and infant development.

*See [NJ Official WIC Program](#) for more details.

Key Notes

- **Eligibility Review:** All enrollees must renew annually. If home address changes, the enrollee must contact **1-800-701-0710** to update records and prevent a lapse in coverage.
- **Hospital Cooperation:** Upon visiting an Emergency Room, patient or representative must clearly inform the hospital social worker or financial counselor of the **intent to apply for MEPP**.
- **Post-Emergency Application:** If an application was not completed at the hospital, the applicant must visit the local **County Board of Social Services** to submit an application **within 3 months** of the emergency.

Contact

- **General Application & Counseling:** NJ FamilyCare Hotline 1-800-701-0710
- **MEPP (Emergency Payment):** 1-800-356-1561

- **Eligibility Self-Screening:** [NJHelps.gov](https://njhelps.gov/)
- **Renewal & Status Checks:** [Stay Covered NJ](#)
- **AWCA** provides expert consultations free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ DHS.gov – Medical Emergency Payment Program \(MEPP\)](#)
- [NJ FamilyCare.gov – Cover All Kids](#)
- [NJ DHS.gov – County Social Service Agencies](#)

Funeral & Burial Assistance

State's Department of Human Services (DHS) and county social service agencies provide financial assistance for funeral, burial, or cremation costs for residents who were receiving specific public assistance programs at the time of death, or for indigent residents without assets.

Eligibility

The deceased must meet one of the following criteria at the time of death:

- WFNJ/GA beneficiaries who had been receiving benefits continuously for at least **6 months** at the time of death.
- WFNJ recipients who passed away within the first 6 months of residency in a New Jersey public institution (excluding correctional facilities).
- New applicants whose benefits were approved within 15 days after their death.
- Recipients of community care programs (such as CCPED, AACAP, or Adult Foster Care).
- Participants in the NJ Workability Program.

**Note: Since there are various other eligibility categories, please contact your County Board of Social Services for specific inquiries.*

NJ DHS Public Assistance Burial Allowance Rates (2026)

Age Group	Funeral Allowance	Cemetery/Cremation Allowance	Total State Payment	Max Family Supplement	Max Permitted Total
Adults & Children (2+ Years)	\$3,056	\$714	\$3,770	\$1,570	\$5,340
1 Week to Under 2 Years	\$2,494	\$583(approx.)	\$3,077 (approx.)	\$1,178	\$4,255
Stillborn to 6 Days	\$1,933	\$452	\$2,385	\$785	\$3,170

**Family Supplement: According to regulations, family members may contribute up to the specified amount to supplement the cost of the funeral services without affecting the state's contribution.*

**These rates are based on official NJ DHS regulations as cited by providers such as Whigham Funeral Home.*

Coverage and Limitations

- **Covered Items:**
 - Body preparation and disposition, casket, or urn
 - Use of funeral home facilities and basic services
 - Cemetery burial plot costs or cremation fees
- **Excluded Items (Non-Covered Items):**
 - Fees for clergy, church use, or memorial hall rentals
 - Costs for publishing obituaries or death notices
 - Post-cremation expenses (such as scattering of ashes, niche interments, or other costs incurred after the cremation process)
 - Other items not explicitly listed above
- **Exclusions and Deductions:**
 - If the deceased leaves behind any **assets** (such as bank balances, life insurance, securities, real estate, or payments issued before or after death), the state will **recoup** these funds. However, this does not affect the actual allowance paid to the funeral director and the cemetery.
 - If there is a pre-established **Irrevocable Prepaid Funeral Account**, those funds must be utilized first to cover funeral expenses. Any remaining balance after the funeral costs have been paid is subject to **recoupment by the state**.

Key Notes

- **Prior Approval Required:** It is very difficult to receive reimbursement after funeral costs have already been paid in full. The responsible party **must** request the **Funeral Director** to apply for **Public Assistance Funeral** before proceeding with the services.
- **Asset Investigation:** The state will investigate the deceased's bank accounts. If the balance exceeds the support amount, the application may be denied.
- **Supplement Limit:** If family members pay an amount exceeding the **Maximum Family Supplement (\$1,570)**, the state's contribution will be reduced by the exact amount of that excess.

Example: If the family pays **\$1,670** as a supplement (**\$100 over the limit**), the state's total funeral allowance for an adult will be reduced from **\$3,770** to **\$3,670**.

How to Apply

Before or during the funeral arrangements, the Funeral Director must request eligibility verification and approval from the respective county on behalf of the family.

Contact

- **Local county social service offices**
 - New Jersey directory by county: [NJ DHS.gov – County Social Service Agencies](#)
- **NJSFDA (NJ State Funeral Directors Association):** 1-800-734-3712 | njsfda@njsfda.org
- **Applying for the Social Security Lump-Sum Death Payment (\$255):**
 - Eligibility: If the deceased had a Social Security work history, a one-time payment of \$255 may be payable to a surviving spouse or child who meets specific eligibility requirements. If there is no eligible spouse, the payment may be made to a child who meets certain criteria.
 - Application Deadline: Within 2 years from the date of death.
 - How to Apply: Call the SSA at 1-800-772-1213 or visit your local Social Security Administration (SSA) office.
 - Social Security Administration website | [SSA.gov](#)
- **AWCA** provides expert consultations free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJSFDA \(NJ State Funeral Directors Association\) Financial Assistance Guide](#)
- [Penn Jersey Cremation – Medicaid Cremation Assistance Guide](#)
- [Woody Home for Services – Public Assistance Benefits](#)

Medicaid Buy-In (NJ WorkAbility)

NJ WorkAbility is a program that allows New Jersey residents with a disability who are currently working to receive full **Medicaid** benefits, even if their income or assets exceed the limits for standard Medicaid (NJ FamilyCare).

**SSDI recipients can also use this program to bridge the health insurance gap during the 24-month waiting period before they become eligible for Medicare.*

**While Medicare eligibility is based on a 24-month period starting from the date you begin receiving SSDI, the SSDI payments themselves do not start until after a 5-month waiting period from the established onset of the disability. Therefore, the actual total waiting period is approximately 29 months from the date the disability began.*

Eligibility

- **Age:** 16 years or older (Individuals aged **65 or older** may apply; however, the disability determination must have been established **before the age of 65**).
- **Disability:** Must have a disability determination from the **Social Security Administration (SSA)** or the **Medical Review Team** under the **DMAHS (Division of Medical Assistance and Health Services)**. If you are already receiving **SSDI**, you automatically meet the disability requirement without needing a separate determination.

**Note: If you are not currently receiving SSDI, you can contact the NJ DDS (Division of Disability Services) at 1-888-285-3036 to pre-verify your eligibility.*

- **Employment:** Must be employed part-time, full-time, or self-employed (Proof of earned income is required).
- **No Asset Limit:** Eligible regardless of the size of assets such as savings or stocks.
- **No Income Limit:** High-income earners can join (However, premiums apply based on income level).

**Income Calculation Method: Earned income and unearned income are calculated using different formulas. Since your actual premium bracket may vary based on your specific circumstances, please contact NJ DDS (1-888-285-3036) or your County Board of Social Services for an individual assessment to verify your exact eligibility and premium amounts.*

- **Spousal Income Excluded:** Eligibility and premiums are determined solely based on **the applicant's own income**.

Medicaid Buy-In Premiums (2026)

Tier Level	Income Bracket (vs. FPL)	Monthly Premium	Notes
Exempt	250% or less	None (\$0)	If you have no unearned income (such as SSDI, interest, or investment returns), you may be exempt from premiums for annual earned income up to \$80,820.
Tier 1	251% – 350%	\$203	
Tier 2	351% – 450%	\$406	
Tier 3	451% – 550%	\$609	
Tier 4	551% – 650%	\$812	
Tier 5	651% – 750%	\$1,015	
Tier 6	Over 750%	\$1,218	Maximum premium cap

** Note: The salary figures mentioned above assume zero unearned income and are examples based on the application of the earned income disregard (approximately 50%). While SSDI benefits based on your own work history are excluded from the income calculation, benefits based on others—such as a spouse's or parent's disability or survivors' benefits—are counted as unearned income. Applicants are encouraged to check eligibility as unearned income (e.g., interest, investment returns, or alimony) may change your actual premium exemption threshold.*

Key Benefits

- **Comprehensive Medicaid Coverage:** Includes hospital bills, prescription drugs, and all other standard Medicaid benefits.
- **Managed Long-Term Services and Supports (MLTSS):** It provides coverage for **Personal Care Assistant (PCA)** services, which are typically not covered by private insurance. The number of service hours provided is determined through an individual **care assessment** based on the recipient's specific needs.
- **Job Retention Support:** Even if your salary increases or you become a high-income earner, you can maintain full Medicaid coverage simply by paying the designated premium.
- **Coverage Maintenance After Job Loss:** If you lose your job through no fault of your own (e.g., layoffs, business closures, etc.), your **Medicaid coverage** will be maintained for up to **12 months** following the

loss of employment.

How to Apply

- [NJHelps.gov](https://njhelps.gov) (**Benefit Screening Portal**): You can pre-check your eligibility for various benefits, such as **SNAP**, **TANF**, and **NJ FamilyCare**, in approximately **5 to 10 minutes**. Please note that the actual application must be submitted through [MyNJHelps.gov](https://mynjhelps.gov).
- [NJFamilyCare.gov](https://njfamilycare.gov): **ABD** (Dedicated application path for **NJ WorkAbility**. You may apply online or in person at your local **County Board of Social Services**.)
- [GetCoveredNJ.gov](https://getcoverednj.gov) (If you do not qualify for Medicaid, you can enroll in a private health plan through the **ACA (Affordable Care Act) Marketplace** and receive a **Premium Tax Credit** to help lower your cost.)
- [Stay Covered NJ.gov – Website for current members' keeping coverage](https://staycoverednj.gov)

Contact

- **NJ 211:** 211 / nj211.org
- **NJ DDS:** 1-888-285-3036 / [NJ DDS.gov](https://njdds.gov)
- **NJ FamilyCare:** 1-800-701-0710 / [NJ FamilyCare.gov](https://njfamilycare.gov)
- **AWCA** provides expert consultations free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Medicaid Estate Recovery

The Medicaid Estate Recovery Program (MERP) seeks to recover the costs of Medicaid benefits paid on behalf of a recipient aged 55 or older from the deceased recipient's estate.

Target and Scope of Recovery

New Jersey utilizes an **Expanded Estate** definition, which covers a broader range of assets beyond just **Probate Assets**. This means that assets such as joint accounts, life insurance, and retirement pensions—which might otherwise pass directly to heirs without a will—can be subject to recovery.

- **Included Assets:**

- **Real Estate:** The home (including Primary Residence) and land held in the deceased's name.
- **Financial Assets:** Bank accounts, stocks, bonds, and cash.
- **Non-Probate Assets:** Life insurance proceeds (if paid to the estate), annuities, trust assets, and jointly owned property.

**Notice Regarding Life Insurance: Life insurance proceeds paid directly to a designated beneficiary are generally not subject to estate recovery. However, recovery will apply in the following cases:*

- *Estate as Beneficiary: If the estate itself is named as the beneficiary.*
- *Lapsed Beneficiary: If the designated beneficiary predeceases the recipient, causing the insurance proceeds to revert to the estate.*

- **Recoverable Amount:** All medical costs paid by Medicaid after the recipient reached age 55 (including monthly HMO capitation fees).

**Exception: As of January 1, 2010, Medicare cost-sharing expenses paid by Medicaid through Medicare Savings Programs (such as QMB) are exempt from estate recovery.*

- **Minimum Threshold:** Estate recovery may be waived if the claim amount is less than **\$500**, if the total value of the estate is less than **\$3,000**, or if the **cost of recovery** would exceed the amount to be recovered.

Conditions for Deferment or Waiver

- **Surviving Spouse:** Recovery is indefinitely deferred as long as the spouse is alive.
- **Minor Child:** Recovery is deferred if there is a surviving child under the age of 21.
- **Disabled Child:** Regardless of age, recovery is deferred if you have a child who is determined to be **blind** or **permanently and totally disabled** according to **SSA** standards.
- **Caregiver Child Exception:** The recovery of the home may be waived if the child has resided in the parent's home for at least **two consecutive years** immediately prior to the parent's admission to a nursing facility and can prove that they provided a **sufficient level of care** to allow the parent to remain at home rather than entering a facility.

**Note: The child may have outside employment or income, and care provided alongside a home health aide is still eligible for consideration. The child does not need to be the sole caregiver; the decision is based on the quality and scope of care provided. Strict documentation, such as a physician's statement, is required.*

- **Sibling Exception:** An exemption for the home may be granted if the beneficiary's **sibling** holds an **equity interest** in the property and resided in the home for at least **one year** immediately prior to the beneficiary's admission to a **nursing home**.
- **Undue Hardship Waiver:** You may apply for a waiver if the assets subject to recovery are the **sole source of income** for a surviving family member, and if the recovery would likely force that family member to rely on **public assistance** (including Medicaid). However, if assets were transferred in advance for the purpose of avoiding Medicaid recovery, a **rebuttable presumption** applies that no undue hardship exists, which may result in the waiver request being denied.

**A written request for a waiver must be submitted within 20 days of receiving the notice of recovery claim from the DMAHS. Failure to meet this deadline may result in the denial of your waiver request.*

Key Notes

- **Prior Notification:** Before distributing estate assets to heirs or other creditors, the estate executor (representative) must notify the **NJ DMAHS Estate Recovery Unit** in writing to confirm if there is an outstanding claim. **DMAHS** will initiate the initial claim process within **90 days** of receiving written notice, and the final claim or lien filing will occur within **three years** from the date of receipt of the written notice.
- **Funeral Expenses:** Before Medicaid estate recovery proceeds, the following items may be paid from the estate assets with priority:
 - **Reasonable funeral and burial expenses**

- **Reasonable costs and fees** related to the administration of the estate
- Debts owed to the **Office of the Public Guardian for Elderly Adults**
- **DMAHS recovery** (processed only after the above items have been settled)
- **Deferral of Lien Enforcement for Residing Family Members:** If a family member has continuously resided in the home since before the beneficiary's death, and the home was the beneficiary's **primary residence** and remains the primary residence of that family member, **DMAHS** may record a **lien** on the property. However, it will not enforce the lien until the family member moves out, passes away, or the property is voluntarily sold.

Contact

- **Direct Line for Inquiries: NJ DMAHS 1-609-588-2900 / 1-609-588-3016** – Direct line for all inquiries regarding Trusts, Liens, and Estate Recovery.
- **General Inquiries & Information: NJ FamilyCare 1-800-701-0710** – For general guidance
- **Mailing Address for Document Submission (Estate Unit):**
NJ DMAHS – Office of Legal and Regulatory Affairs
Attn: Estates
P.O. Box 712, Mail Code #6 Trenton, NJ 08625-0712
- **AWCA** provides expert consultations free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [Medicaid.gov](https://www.Medicaid.gov) – Estate Recovery
- [NJ Medicaid Program and Estate Recovery – What You Should Know](#)

Spousal Impoverishment Rules

These rules are designed to protect the financial well-being of the spouse remaining at home (**Community Spouse**) while the other spouse receives Nursing Home care or Home Care through **MLTSS (Long Term Care)**, preventing the community spouse from falling into poverty.

Spouses do not need to file a separate application for Spousal Impoverishment protections; they are automatically evaluated during your Medicaid (MLTSS) application process

**OBBA (One Big Beautiful Bill Act) implementations may affect eligibility and program details.*

CSRA (Community Spouse Resource Allowance: Asset Protection)

The CSRA allows the community spouse to retain a certain amount of assets without affecting the applicant's Medicaid eligibility.

- **Total Assets:** Calculated by combining all countable assets (cash, savings, stocks, etc.) owned by either or both spouses.
- **Retention Limit:** In New Jersey, the community spouse can retain up to **\$162,660** in 2026.

**Spend Down: If combined assets exceed the allowed limit, the excess must be "spent down" on medical expenses, home repairs, or funeral trusts before the applicant can be approved for Medicaid.*

MMMNA (Minimum Monthly Maintenance Needs Allowance: Income Protection)

MMMNA ensures that if the community spouse has little to no income of their own, a portion of the applicant spouse's income can be transferred to them.

**New Jersey income standards; vary by state*

Minimum Allowance: If the community spouse's monthly income is below **\$2,643.75**, they can receive an allocation from the applicant's income to bridge the gap.

- *The current standard of **\$2,643.75** is effective from **July 1, 2025, through June 30, 2026**. This minimum guaranteed amount is subject to change every **July 1st** based on updates to the **Federal Poverty Level (FPL)**.

- **Maximum Allowance:** If the community spouse has high shelter expenses (rent, mortgage, taxes, etc.), they may be allowed to keep up to **\$4,066.50** per month.
- **Benefit:** This transfer reduces the applicant's share of cost (the amount they must pay the facility), helping the household retain more total income.

Estate Recovery

While the home is generally excluded from the asset limit during the spouse's lifetime, strategic planning is required due to the **Estate Recovery** program.

- **Exemption During Residency:** The home is exempt only if the applicant or their spouse resides in it, a minor or disabled child resides in it, or if the applicant expresses an **"intent to return"** and the home equity is **\$1,130,000 or less**.
- **Estate Recovery:** After the death of a Medicaid beneficiary, the State may attempt to recover the costs of care from the deceased's estate (most commonly the home). In New Jersey, the state may file a claim for **Estate Recovery** for **Medicaid benefits received after the age of 55**.
- **Conditions for Postponement of Recovery:**
 - If a **surviving spouse** still resides in the home.
 - If there is a surviving child under age 21, or a child who is blind or permanently disabled.
 - **Caretaker Child Exception:** If a child lived in the home for at least 2 years before the parent's institutionalization and provided care that delayed the need for a nursing home, the home may potentially be transferred to that child without penalty.

**Statute of Limitations: The right to recovery is permanently forfeited once the period for filing a claim (e.g., one year) has expired.*

**\$1M Home Equity Cap: A unified federal \$1M home equity cap for Medicaid LTC eligibility with no inflation adjustments effective Jan 1, 2028. (OBBBA Update).*

Spousal Asset and Income Protection Standards (2026, New Jersey)

Category	Item	Standard Amount	Remarks
Asset Protection	CSRA (Max Asset Limit)	\$162,660	Excludes home; kept by community spouse
Income Protection	MMMNA (Monthly Income)	\$2,643.75 – \$4,066.50	Adjustable based on shelter costs
Applicant Limit	Individual Asset Limit	\$2,000	Limit for the spouse receiving care
Home Exemption	Home Equity Limit	\$1,130,000 (NJ)	Based on the home's net equity value

Contact

- **AWCA** provides expert consultations free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [Medicaid.gov – 2026 Federal Spousal Impoverishment Standards](#)
- [Medicaid.gov – 2026 SSI and Spousal Impoverishment Standards](#)
- [NJ DHS.gov – 2026 Medicaid Only Income and Resource Standards \(26-01\)](#)

Medicaid General Assistance (WFNJ/GA)

The Medicaid General Assistance program is a core welfare system in New Jersey that provides integrated cash assistance, job training, and emergency housing support for low-income adults and couples without children. In New Jersey, it is known as **WFNJ/GA (Work First New Jersey/General Assistance)**.

**OBBA (One Big Beautiful Bill Act) implementations may affect eligibility and program details.*

Eligibility

- **Target:** Adults aged 18 or older residing in New Jersey (single or couples without dependent children).
- **Status:** U.S. citizens or qualified immigrants (Green Card holders for 5+ years / Refugees and Asylees are eligible immediately).
- **Income:** Eligibility is determined based on the 'Schedule I/III (Initial Maximum Allowable Income)' limits, which are significantly low—representing only about 20% to 22% of the Federal Poverty Level (FPL).
- **Assets:** Liquid assets must be **\$2,000 or less**. (Primary residence, one vehicle, and retirement assets such as 401k or IRA plans are excluded from eligibility review).
- **Employable:** Mandatory participation in **30 hours per week** of work activities, job searches, vocational training, or designated work assignments (N.J.A.C. 10:90-4.1).
- **Unemployable:** If you obtain and submit a medical certification of illness or disability (a Med-1 form) from a healthcare provider, you will receive a higher benefit amount and be fully exempt from all work requirements.

Benefit Amounts by Household Size

Category	Recipient	Maximum Benefit (Monthly)
Employable	Single Adult (1 person)	\$185
	Couple (2 people)	\$254
Unemployable (Disabled)	Disabled Adult (1 person)	\$277
	Disabled Couple (2 people)	\$382

Benefits

WFNJ/GA provides multifaceted services for self-sufficiency beyond simple cash payments.

- **Cash Assistance:** Provided for a lifetime limit of 60 months. (The clock stops if you gain employment).
- **Emergency Housing Assistance:** If you are facing a housing crisis, the program provides support for unpaid rent, emergency shelter, or utility arrears. Extensions for **Emergency Assistance (EA)** benefits are also available.

**Under NJ DHS Emergency Assistance (EA) program regulations, there is a lifetime limit of 12 months (combined for TANF and GA). Extensions are available for up to two 6-month periods for TANF and one 6-month period for GA.*

- **Employment and Education Support:**
 - Support for obtaining a High School Equivalency (GED) and Vocational Training.
 - Assistance with transportation costs for commuting and job preparation expenses.
- **Healthcare Linkage:** Enrollment in WFNJ/GA automatically grants enrollment in [ACA Medicaid \(NJ FamilyCare\)](#).

How to Apply

- **Online:** [MyNJHelps.gov](#)
- **In-Person:** Local county social service offices
 - **Bergen County Board of Social Services**
 - Address: 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - Phone: 201-368-4200
 - Hours: Weekdays (Mon–Fri) 8:00 AM – 4:30 PM

Contact

- **NJ Division of Family Development Hotline:** 1-800-792-9773
- **AWCA** provides expert consultations free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [NJ DHS.gov – Work First New Jersey](#)
- [NJ FamilyCare – 2026 Income Limits & Eligibility](#)
- [NJHelps.gov](#)

- [NJ S2201 – WFNJ Program Modernization Act \(2026 Reforms\)](#)
- [Bergen County Board of Social Services](#)

Temporary Assistance for Needy Families (TANF)

Temporary Assistance for Needy Families (TANF) is a core welfare program that provides cash assistance, childcare support, and job training to help low-income households with children under 18 (or pregnant women) achieve self-sufficiency. In New Jersey, it is known as **WFNJ/TANF (Work First New Jersey/Temporary Assistance for Needy Families)**. **OBBA (One Big Beautiful Bill Act) implementations may affect eligibility and program details.*

Eligibility

- **Target:** Low-income households residing in New Jersey with children under 18 (or children under 19 if still in high school).
- **Income:** Monthly income of **\$5,379 or less** for a family of 3 (within 250% of the Federal Poverty Level – FPL).
- **Status:** U.S. citizens or qualified immigrants (Green Card holders for 5+ years / Refugees and Asylees are eligible immediately).
- **Assets:** Liquid assets must be **\$2,000 or less**. (Primary residence, one vehicle, and retirement assets such as 401k or IRA plans are excluded from eligibility review).
- **Employable:** Parents must participate in **job search activities, vocational training, or designated work activities** for at least **35 hours per week** (Standard WFNJ Regulations).
- **Unemployable:** If you submit a **medical certification of illness or disability (Med-1 Form)** through a healthcare provider, you will be **exempted from work requirements**.
- **Child Support Cooperation (If Applicable):** To receive cash assistance for your children, you must provide information about the other parent and cooperate in the assignment of child support rights. From the child support collected each month, an additional payment of up to **\$100 for one child**, or up to **\$200 for two or more children**, will be passed through to the recipient. Failure to cooperate without good cause may result in the **denial of benefits**.

Benefits

WFNJ/TANF provides multifaceted services for self-sufficiency beyond simple cash payments.

- **Financial Assistance**
 - **Monthly Assistance: \$559 per month** for a family of 3 – this amount is based on having **zero income**; if there is any income, the benefit amount will be **adjusted**.
 - Amounts may be adjusted based on household size and income.

- Cash assistance is provided for a **lifetime limit of 60 months**. If cash assistance stops due to employment, the remaining months are preserved and can be used in the future if help is needed again. Upon reaching **48 months** of assistance, individuals are automatically assigned to the **SAIF (Supportive Assistance to Individuals and Families) program**. After the 60-month limit is exhausted, extensions of **6 months** (up to two times) may be granted. Additionally, if specific criteria are met, you may apply for up to **24 months of additional cash assistance** through the SAIF program.
- **Post-TANF (\$200 Monthly)**: If your cash assistance ends due to employment after receiving TANF for at least 6 months, a monthly post-assistance subsidy of **\$200** is provided for up to **24 months** to support your self-sufficiency. This subsidy does **not** count toward the lifetime 60-month limit and serves as a powerful incentive for independence unique to New Jersey.

***Eligibility:** You become eligible if you voluntarily close your case after maintaining employment of at least **20 hours per week** for a minimum of **4 consecutive months**.

- **Diversions Payment (\$750 Lump Sum):**
 - **A one-time \$750 payment** provided to families to overcome temporary crises during a job search.***Consultation Required Upon Application:** The **Diversions Payment** is a one-time lump sum provided in lieu of ongoing cash assistance. Please note that receiving this payment may restrict your eligibility to apply for **TANF cash assistance** for a specified period.
- **Emergency Housing Assistance:** If you are facing a crisis or at risk of homelessness, you may receive support for back rent, emergency shelter, utility arrears, moving expenses, and security deposits. This assistance is available to **TANF, GA, and SSI** recipients, as well as certain low-income households not currently receiving ongoing benefits.
 - **Benefit Period:** Assistance is generally capped at **12 months** per case. However, **TANF** recipients may be eligible for up to two extensions (6 months each), and **GA** recipients may receive one extension (up to 6 months).
 - **Co-payment Requirement:** While receiving EA, you are required to contribute **30% of your household income** (including cash assistance) toward your housing costs.
- **Employment and Education Support:**
 - Support for obtaining a High School Equivalency (GED) and Vocational Training.
 - Assistance with transportation costs for commuting and job preparation expenses.
- **Healthcare Linkage:** Enrollment in WFNJ/TANF automatically grants enrollment in [ACA Medicaid \(NJ FamilyCare\)](#).

How to Apply

- **Online:** [MyNJHelps.gov](https://mynjhelps.gov)

- **In-Person:** Local county social service offices
 - **Bergen County Board of Social Services**
 - **Address:** 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - **Phone:** 201-368-4200
 - **Hours:** Weekdays (Mon–Fri) 8:00 AM – 4:30 PM

Contact

- **NJ Division of Family Development Hotline:** 1-800-792-9773
- **AWCA** provides expert consultations free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [NJ DHS.gov – Work First New Jersey](https://www.njdhhs.gov/work-first-new-jersey)
- [NJHelps.gov – Benefit Screening & Application Portal](https://njhelps.gov/benefit-screening-application-portal)
- [NCCP.org – New Jersey TANF State Profile \(2026\)](https://nccp.org/new-jersey-tanf-state-profile-2026)

PART I • SECTION 6

Chronic Diseases

만성 질환 (Chronic Diseases)

Managing chronic health conditions in older adults: the aging process, heart disease, diabetes, obesity, stroke, cancer, arthritis, mental health, dementia, and mind-body integrative medicine.

This section contains 11 comprehensive guides

Chronic Diseases

Disclaimer: This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Chronic diseases are health conditions that last for one year or more, requiring ongoing medical attention or limiting activities of daily living if not properly managed. Most chronic diseases are **noncommunicable diseases**, meaning they are not directly transmitted to others. While most chronic conditions are difficult to cure, they can be effectively managed by combining professional medical treatment with proactive lifestyle improvements.

Chronic diseases represent a major public health challenge both domestically and internationally. They are the leading causes of death and disability in the United States. Beyond their impact on physical health, 90% of the nation's \$4.9 trillion in annual healthcare expenditures is used for people with chronic and mental health conditions, and these illnesses deeply affect an individual's overall quality of life. Understanding chronic diseases is the first step toward effective management and maintaining an independent life.

Types of Chronic Diseases

The following are some of the most common chronic diseases.

Lifestyle Diseases

- [Obesity](#)
- [Diabetes](#)
- [Heart Disease](#)
- [Stroke](#)
- [Cancer](#)
- [Arthritis](#)

Brain & Mental Health

- [Mental Health](#)
- [Dementia](#)
- [Mind-Body Medicine](#)

Who Gets Chronic Diseases?

Chronic diseases can affect people of all ages, races, and backgrounds. However, the risk increases with age. More than 3 out of 4 U.S. adults (approximately 76%) suffer from at least one chronic disease, and more than half (approximately 51%) have two or more conditions. Notably, over 90% of seniors aged 65 and older suffer from at least one chronic disease. Certain groups may be at higher risk due to genetics, socioeconomic factors, or access to healthcare.

Causes of Chronic Diseases

Chronic diseases are often caused by a combination of factors, including genetics, environment, lifestyle choices, and behavioral patterns. Some major risk factors include:

- Smoking and tobacco use
- Unhealthy eating habits
- Lack of physical activity
- Excessive alcohol consumption
- Genetics and family history
- Exposure to environmental hazards

Signs & Symptoms of Chronic Diseases

Symptoms vary widely depending on the specific condition. Common signs include persistent pain, fatigue, loss of function in certain body parts, or mood changes. Because these conditions are long-lasting, symptoms may fluctuate in intensity over time.

Stages of Chronic Diseases

Most chronic diseases progress through stages:

1. **Susceptibility:** Presence of risk factors.
2. **Subclinical:** Disease is present but shows no outward symptoms.
3. **Clinical:** Symptoms appear, and a diagnosis is made.
4. **Recovery, Disability, or Chronicity:** The condition is managed long-term.

Diagnosis of Chronic Diseases

Diagnosis typically involves a medical history review, physical examinations, and specific screenings such as blood tests, imaging (X-rays, MRIs), or biopsies depending on the suspected condition.

Treatment of Chronic Diseases

While many chronic diseases cannot be cured, they are managed through:

- **Medications:** To control symptoms or prevent complications.
- **Lifestyle Changes:** Diet, exercise, and stress management.
- **Therapies:** Physical, occupational, or speech therapy.
- **Surgery:** In cases like heart disease or certain cancers.

Prevention of Chronic Diseases

Many chronic diseases are preventable. Key strategies include maintaining a healthy weight, eating a balanced diet, staying physically active, avoiding tobacco, and attending regular medical checkups for early detection.

Living with Chronic Diseases

Living with a chronic condition requires proactive management. Patients often work with a healthcare team to monitor their health, adhere to treatment plans, and make adjustments to daily routines to maintain a high quality of life.

Resources

- [MedlinePlus.gov: Chronic Pain](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/101101101/)
- [MedlinePlus.gov: Encyclopedia – Chronic Illness](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/101101101/)
- [CDC.gov: About Chronic Diseases](https://www.cdc.gov/chronicdiseases/about/index.htm)
- [WHO.gov: Noncommunicable Diseases](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases)

Aging Process

Disclaimer: This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Aging is a natural, gradual process affecting all body systems. Beyond visible signs like gray hair and wrinkles, internal changes often impact cardiovascular, musculoskeletal, digestive, and cognitive health. Understanding these shifts is essential for maintaining a high quality of life throughout the senior years.

Aging is not a chronic disease, but the two are closely intertwined. Natural physiological changes often increase the risk of developing new health issues or accelerating the progression of existing ones. Recognizing this connection is vital for effective wellness planning and maintaining independence during the aging process.

Causes of Aging

Aging occurs as damage progressively accumulates at the molecular and cellular levels, driven by cellular senescence, oxidative stress, increased inflammatory response, decline in immune function, and telomere shortening.

Physical and Cognitive Changes with Aging

- **Cardiovascular:** Arteries stiffen (due to decreased elasticity), causing blood pressure to rise and requiring the heart to exert more effort to pump blood.
- **Musculoskeletal:** Loss of bone density (**Osteopenia**) and muscle mass (**Sarcopenia**), leading to decreased strength and balance.
- **Cognitive:** Slower processing speeds and occasional “tip-of-the-tongue” forgetfulness. Significant memory loss is **not** a normal part of aging. (see [Dementia](#))
- **Digestive & Bladder:** Slower movement through the digestive tract (constipation) and decreased bladder elasticity or weakened pelvic floor muscles (incontinence).
- **Sensory:** The lens of the eye stiffens, causing presbyopia (farsightedness), and age-related hearing loss (presbycusis)—where hearing declines due to aging and various factors such as noise exposure and genetic factors—can occur.

Stages of Aging

- **Early Adulthood (20s–30s):** Peak physical function and reproductive health.

- **Middle Adulthood (40s–60s):** Subtle declines in metabolism, skin elasticity, and the beginning of “wear and tear” on joints.
- **Late Adulthood (65+):** More pronounced physical and cognitive changes requiring proactive health management to maintain independence.

Assessing Health in Aging

- **Geriatric Assessments:** Comprehensive reviews of physical, mental, and social health.
- **Bone Density Scans (DEXA):** To monitor for osteoporosis.
- **Sensory Screenings:** Regular vision and hearing exams to prevent social isolation.
- **Cognitive Screenings:** To establish a baseline and differentiate normal aging from dementia.

How to Age Well

While aging cannot be stopped, its negative impacts can be delayed through the following methods:

- **Preventive Healthcare:** Stay current with recommended vaccinations, including Flu, Shingles, Pneumonia, RSV, and COVID-19.
 - Be sure to follow the correct dosing schedule. For example, adults 50 and older should receive two doses of the Shingles vaccine (Shingrix), spaced 2 to 6 months apart.
- **Physical Activity:** Exercise daily to maintain muscle strength and protect bone health.
 - Include **Kegel exercises** in your routine to help prevent urinary incontinence.
- **Nutrition:** Eat a balanced diet rich in fiber, calcium, vitamin D, and lean protein.
 - Staying well hydrated and limiting sodium intake are equally important for healthy aging.
- **Mental Health:** Manage stress and prioritize getting enough sleep each night
- **Social Engagement:** Keep your mind active by pursuing hobbies or joining community events.
- **Smoking and Alcohol:** Work toward quitting smoking and limiting alcohol consumption.
- **Fall Prevention:** Reduce your risk of falls through balance exercises, home safety improvements (such as grab bars and non-slip mats in the bathroom), regular vision and hearing checkups, and periodic medication reviews.

Embracing Life as an Older Adult

Aging well means adapting wisely, staying proactive, and focusing on sustaining physical, emotional, and social quality of life. Open communication with healthcare providers and partners about changes can help preserve overall well-being.

Resources

- [MedlinePlus.gov: Older Adult Health](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)
- [NIA.nih.gov: Healthy Aging](https://www.nia.nih.gov/health/healthy-aging)
- [CDC.gov: Healthy Aging Overview](https://www.cdc.gov/healthyaging/healthy-aging-overview)

Arthritis

Disclaimer: This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Arthritis is a broad term for a group of conditions that cause pain and swelling in the joints. It is a leading cause of disability among older adults, often impacting mobility and quality of life.

Types of Arthritis

While there are many forms of arthritis, the following are the most common:

- **Osteoarthritis (OA):** The most frequent type, often called “wear and tear” arthritis. It occurs when the protective cartilage that cushions the ends of one’s bones wears down over time.
- **Rheumatoid Arthritis (RA):** An autoimmune and inflammatory disease where one’s immune system attacks healthy cells in one’s body by mistake, causing painful swelling in the affected joints.
- **Psoriatic Arthritis:** Affects some people who have psoriasis—a condition that features red patches of skin topped with silvery scales.
- **Gout:** High levels of uric acid in the blood lead to the formation of crystals that accumulate in the joints. It can be triggered by impaired kidney function—where the body fails to excrete uric acid efficiently—or by a diet high in meat and alcohol. Gout is typically characterized by sudden, intense pain and swelling, most commonly affecting the big toe.
- **Ankylosing Spondylitis:** An inflammatory disease that, over time, can cause some of the small bones in one’s spine to fuse.

Who Gets Arthritis?

The prevalence of arthritis increases sharply after age 65, with approximately 54% of adults aged 75 and older having been diagnosed with the condition. Key risk factors include:

- **Obesity:** Excess weight puts added stress on joints, particularly the knees and hips.
- **Previous Injuries:** Joints damaged by past injuries are more likely to develop arthritis later.
- **Genetics:** Certain genes are linked to a higher risk of RA and ankylosing spondylitis.
- **Repetitive Stress:** Jobs or sports that require repetitive joint bending can increase the risk of OA.

While the risk of stroke increases with age, younger populations face a rise in arthritis conditions. Approximately one in five U.S. adults—roughly 21% or 53 million people—live with arthritis. Notably, over half of those affected (51.7%) are within the working-age population (18 to 64 years old). Arthritis is more

prevalent in women than in men, with both osteoarthritis and rheumatoid arthritis being significantly more common among women.

Causes of Arthritis

Causes depend on the type. Osteoarthritis results from the physical breakdown of cartilage due to age or injury. Rheumatoid arthritis is caused by a dysfunctional immune response. Other forms, like Gout, are metabolic, resulting from an imbalance of chemicals in the blood.

Signs & Symptoms of Arthritis

- Persistent joint pain and stiffness, especially in the morning.
- Visible swelling, redness, or warmth around the joints.
- A “grating” sensation or sound during movement.
- Reduced range of motion that makes daily tasks difficult.

Stages of Arthritis

1. **Early Stage:** Marked by mild inflammation and the onset of cartilage wear. Patients typically experience morning stiffness and occasional aches that subside with rest, having little impact on daily routines.
2. **Intermediate Stage:** As tissue damage progresses, pain and swelling become more frequent and persistent. Everyday tasks like climbing stairs become difficult, and discomfort may begin to interfere with sleep and energy levels.
3. **Late Stage:** Severe cartilage loss leads to joint deformity and constant chronic pain. With range of motion significantly restricted, daily independence declines, often requiring assistive devices or joint replacement surgery.

Diagnosis of Arthritis

- **Physical Exams:** Checking joints for fluid, redness, and range of motion.
- **Imaging:** X-rays to see bone changes and cartilage loss; MRI for detailed views of soft tissue.
- **Laboratory Tests:** Blood tests to look for inflammation markers (like C-reactive protein) or specific antibodies (like Rheumatoid Factor).
- **Surgery:** Joint replacement surgery (Arthroplasty) for severely damaged hips or knees.

Treatment of Arthritis

- **Medications:** Including nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) or disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) for RA.

- **Physical Therapy:** Exercises to strengthen muscles around the joints and increase flexibility.
- **Weight Management:** Reducing body weight significantly lowers pressure on weight-bearing joints.
- **Surgery:** Joint replacement surgery (arthroplasty) for severely damaged hips or knees.

Prevention of Arthritis

- **Maintaining a Healthy Weight:** Engaging in regular physical activity—such as 150 minutes of moderate-intensity exercise per week (e.g., swimming, cycling, or walking)—is the most effective way to reduce joint pain, improve function, and slow the progression of the disease.
- **Joint Protection:** Using proper form when lifting and wearing protective gear during sports.
- **Low-Impact Exercise:** Activities like swimming, cycling, or walking keep joints flexible without excessive strain.

Living with Arthritis

Living with arthritis involves pacing activities to avoid overexertion. The use of heat therapy (to relax muscles) and cold therapy (to reduce inflammation), along with assistive devices like jar openers or canes, can help reduce joint strain and preserve independence.

Support Groups for Arthritis

- [Arthritis Foundation – Your Connect Group](#)

Resources

- [MedlinePlus.gov: Arthritis](#)
- [NIH.niams.gov: Arthritis and Rheumatic Diseases](#)

Cancer

Disclaimer: This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Cancer encompasses over 100 diseases where abnormal cells grow uncontrollably. While cancer remains the second leading cause of death in the United States (accounting for roughly 20% of all deaths) and the primary cause of death for those under 65,, early detection and support services improve outcomes.

Types of Cancer

Cancer is categorized by the type of cell or part of the body where it starts. Common categories include:

- **Carcinomas:** The most common type, originating in the skin or tissues that line internal organs.
- **Sarcomas:** Originate in the bone, cartilage, fat, or muscle.
- **Leukemias:** Originate in the blood-forming tissue of the bone marrow.
- **Myelomas:** Originate in the plasma cells of the bone marrow.
- **Lymphomas:** Originate in the cells of the immune system.

**Beyond these, there are mixed-type cancers and other rare variations, each differing in their primary site and clinical characteristics.*

Most Common Cancers in the United States

- **Breast Cancer:** The most common cancer diagnosed in women.
- **Prostate Cancer:** The most common cancer diagnosed in men.
- **Lung Cancer:** The leading cause of cancer death for both men and women.
- **Colorectal Cancer:** Affects the colon or rectum.
- **Stomach (Gastric) Cancer:** Cancer that starts in the lining of the stomach. While less common in the general U.S. population, it represents a significant health disparity for Asian Americans.

Who Gets Cancer?

The average age at cancer diagnosis in the U.S. is 67, with the risk of developing the disease increasing significantly as people age. Risk increases with age. Genetics and ethnicity also play a role: for example, African Americans have higher death rates than all other racial groups for many cancer types. Lifestyle factors, especially tobacco use, remain the largest preventable risk factor.

Stomach cancer represents a critical health disparity for Asian Americans, particularly those of Korean descent. Korean Americans are roughly five times more likely to develop stomach cancer compared to non-Hispanic whites. Stomach cancer remains a leading oncological concern within the Korean American community. Clinical data indicates it is the most frequently diagnosed cancer among Korean men and the second most common among Korean women.

Causes of Cancer

Cancer is caused by mutations to the DNA within cells, which may be inherited or acquired. Common triggers include:

- **Carcinogens:** Exposure to chemicals (like tobacco smoke) and radiation (UV rays).
- **Lifestyle:** Poor diet, obesity, and lack of exercise.
- **Biological Factors:** Chronic inflammation or viral infections (such as HPV or Hepatitis B/C).

Signs & Symptoms of Cancer

- Unexplained weight loss or persistent fatigue.
- Persistent cough or trouble breathing.
- Changes in skin or unusual lumps.
- Changes in bowel or bladder habits.

Stages of Cancer

Most cancers are staged from 0 to 4:

- **Stage 0:** Abnormal cells are present but have not spread.
- **Stages I–3:** Cancer is present; higher numbers indicate larger tumors or deeper spread.
- **Stage 4:** Cancer has spread to distant parts of the body (Metastasis).

Diagnosis of Cancer

- **Physical Exams & Lab Tests:** Checking for lumps and analyzing blood, urine, or tissue samples to identify tumor markers. These are proteins or specific substances produced in higher amounts by cancer cells—or by the body in response to cancer—and are measured to confirm a diagnosis.
- **Imaging:** CT scans, MRI, PET scans, or X-rays to see inside the body.
- **Biopsy:** Taking a small tissue sample to look at cells under a microscope. This is the only way to be certain of a cancer diagnosis.

Treatment of Cancer

- **Surgery:** To remove the tumor.
- **Chemotherapy:** Using drugs to kill fast-growing cancer cells.
- **Radiation Therapy:** Using high-energy beams to destroy cancer cells.
- **Immunotherapy:** Helping your own immune system fight cancer.
- **Targeted Therapy:** Blocks the growth of cancer by specifically targeting the unique genes or proteins found within cancer cells.

Prevention of Cancer

- Avoiding tobacco and limiting alcohol consumption.
- Protecting skin from UV rays (sunscreen and shade).
- Maintaining a healthy weight and staying active.
- **Getting regular screenings:** Routine mammograms, colonoscopies, and Pap tests can find cancer early when it is easiest to treat.
- **Vaccinations:** The HPV vaccine prevents cervical cancer and other HPV-related malignancies, while the Hepatitis B (HBV) vaccine helps reduce the risk of developing liver cancer.

Living with Cancer

Living with cancer involves more than just medical treatment. It includes managing physical symptoms (pain, nausea) and emotional health through integrative care, nutrition, and psychological counseling for both the patient and their family.

Support Groups for Cancer

- [National Cancer Institute – Support Service Finder](#)
- [American Cancer Society – Patient Programs](#)
- [Cancer Care – NJ Support Groups](#)
- [Holy Name Support Group for Cancer](#)

Resources

- [National Library of Medicine – Cancer Overview](#)
- [National Cancer Institute Official Portal](#)
- [CDC – Types of Cancer](#)

Dementia

Disclaimer: This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Dementia refers to a group of conditions characterized by cognitive decline severe enough to interfere with daily life. Alzheimer's is the most common type, but others like Lewy body dementia and vascular dementia also affect many adults.

Dementia or Alzheimer's?

Dementia is an umbrella term, not a single disease. It describes a group of symptoms like memory loss and confusion. **Alzheimer's** is a specific disease and the most common cause of dementia.

Other types of dementia include **Vascular Dementia** (caused by strokes) and **Lewy Body Dementia**. While they all affect the brain, they can start with different symptoms.

Because many types of dementia share similar symptoms, it is very difficult to distinguish between them. A definitive diagnosis can only be made by a healthcare professional.

Who Gets Dementia?

Dementia primarily affects older adults, but it is not a normal part of aging. Risk increases significantly after age 65. Factors such as family history, race (older African Americans and Hispanics are at higher risk), and cardiovascular health play a role.

Causes of Dementia

Dementia is caused by damage to brain cells. This damage interferes with the ability of brain cells to communicate with each other. When cells cannot communicate normally, thinking, behavior, and feelings can be affected. Different types of dementia are associated with specific types of brain cell damage in particular regions of the brain.

Signs & Symptoms of Dementia

- **Cognitive Changes:** Memory loss; difficulty communicating or finding appropriate words; trouble performing complex tasks, planning, reasoning, or problem-solving; confusion regarding time or place (disorientation); and difficulty understanding visual images and spatial relationships.

- **Psychological Changes:** Noticeable personality shifts; symptoms of depression or anxiety; inappropriate social behavior; and the presence of paranoia or hallucinations.
- **Physical Changes:** Poor coordination, loss of balance, and a general reduction in motor functions.

Stages of Dementia

1. **No Impairment:** No visible symptoms, but brain changes may be starting.
2. **Early-stage (Mild Decline):** Forgetfulness, losing items, or difficulty finding words.
3. **Middle-stage (Moderate Decline):** Difficulty with complex tasks (like managing finances) and increased confusion.
4. **Late-stage (Severe Decline):** Requires significant help with daily activities; eventually, the individual may lose the ability to speak or perform basic motor skills.

Diagnosis of Dementia

Medical professionals perform cognitive and neuropsychological tests, neurological evaluations, brain scans, and lab tests to determine the specific type of dementia.

Treatment of Dementia

While most types of dementia are irreversible, symptoms can often be managed through:

- **Medications:** Cholinesterase inhibitors and memantine to help manage cognitive symptoms.
- **Occupational Therapy:** To make the home safer and teach coping behaviors.
- **Environmental Modifications:** Reducing clutter and noise to help the person focus and reduce confusion.

Prevention of Dementia

While there is no guaranteed prevention, a **heart-healthy** lifestyle may reduce risk:

- Staying physically active and maintaining a healthy weight.
- Not smoking and limiting alcohol.
- Managing heart health factors like blood pressure and cholesterol.
- Keeping the brain active through lifelong learning and social interaction.

Living with Dementia

Living with Dementia requires a strong support system. Safety modifications in the home (like removing trip hazards), routine-based daily living, and caregiver support are vital as the disease progresses.

Support Groups for Dementia

- [Alz.org: Support Groups](#)
- [Alzfdn.org: Caregiving Resources](#)
- [Actnowfoundation.org: Dementia Programs](#)
- [Dfamerica.org:- Memory Cafe Directory](#)

Resources

- [National Library of Medicine – Dementia Overview](#)
- [National Library of Medicine – Lewy Body Dementia](#)
- [Dementia Society of America](#)

Diabetes

Disclaimer: This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Diabetes is a chronic health condition that affects how the body turns food into energy. Most of the food eaten is broken down into sugar (glucose) and released into the bloodstream. When blood sugar goes up, it signals the pancreas to release insulin, which acts like a key to let blood sugar into the body's cells for use as energy. In individuals with diabetes, the body either doesn't make enough insulin or can't use it as well as it should.

Approximately 40.1 million people—about 1 in 8—have diabetes, and more than 1 in 4 of them do not know they have the disease in the United States.

Types of Diabetes

- **Type 1 Diabetes:** An autoimmune condition where the immune system attacks and destroys insulin-producing cells in the pancreas. People with Type 1 diabetes must take insulin every day to survive. It is usually diagnosed in children and young adults.
- **Type 2 Diabetes:** The **most common form** of diabetes. The body does not use insulin properly (insulin resistance) and cannot keep blood sugar at normal levels. It is often linked to weight, genetics, and lifestyle factors.
- **Prediabetes:** A condition where blood sugar levels are higher than normal, but not yet high enough to be classified as Type 2 diabetes. This is a critical stage where lifestyle changes can prevent the progression to full diabetes. Around 115.2 million adults have prediabetes, and about 8 out of 10 of them are unaware that they have the condition in the United States.
- **Gestational Diabetes:** Develops in pregnant women who have never had diabetes. It usually goes away after the baby is born but increases the mother's risk for Type 2 diabetes later in life.

Who Gets Diabetes?

Type 1 is often diagnosed in youth. Type 2 is common in adults, especially those who are overweight or have a family history. Especially, 52% of adults aged 65 and older (about 31.3 million people) have prediabetes. Regular screening is recommended for those who are older, overweight, or have a family history of the condition.

Signs & Symptoms of Diabetes

- Frequent urination, often at night.
- Extreme thirst and unexplained weight loss.
- Extreme hunger (feeling hungry even while eating).
- Very dry skin or slow-healing sores.
- Numbness or tingling in the hands or feet (neuropathy).
- Blurry vision and increased fatigue.

Stages of Diabetes (for Type 2)

The condition begins with insulin resistance (a decline in the body's ability to utilize insulin), progresses through prediabetes, and eventually leads to full-blown type 2 diabetes. If not properly managed, the final stage is accompanied by chronic complications affecting the heart, kidneys, eyes, nerves, and feet.

Diagnosis of Diabetes

- **A1C Test:** Measures average blood sugar over the past 3 months.
- **Fasting Plasma Glucose Test:** Measures blood sugar after an overnight fast.
- **Glucose Tolerance Test:** Known as Oral Glucose Tolerance Test (OGTT). Measures the body's response to a sugary drink.

Treatment of Diabetes

- **Type 1:** Requires daily insulin injections or an insulin pump.
- **Type 2:** Managed with healthy eating, active living, and oral medications (like Metformin) or insulin if necessary.
- **Monitoring:** Frequent blood sugar checks using a glucose meter or continuous glucose monitor (CGM).

Prevention of Diabetes

There is currently no known way to prevent Type 1 diabetes. However, **Type 2 diabetes can often be prevented or delayed** through lifestyle modifications:

- Losing a modest amount of weight (5% to 7% of body weight).
- Engaging in regular physical activity (at least 150 minutes per week).
 - Combining a 5–7% weight loss with at least 150 minutes of physical activity per week can reduce the risk of developing type 2 diabetes by up to 58%.

Living with Diabetes

Living with diabetes requires a proactive approach to prevent complications. This includes regular foot exams to check for sores, annual eye exams for retinopathy, and kidney function tests. Consistent medical follow-ups are vital to ensure blood pressure and cholesterol remain within target ranges.

Support Groups for Diabetes

- [Diabetes.org: Get Connected](https://diabetes.org/get-connected)

Resources

- [MedlinePlus.gov: Diabetes](https://medlineplus.gov/diabetes)
- [MedlinePlus.gov: Diabetes Encyclopedia](https://medlineplus.gov/diabetes-encyclopedia)
- [NIDDK.nih.gov: What Is Diabetes?](https://niddk.nih.gov/what-is-diabetes)
- [CDC.gov: Diabetes Basics](https://cdc.gov/diabetes-basics)
- [CDC.gov: National Diabetes Prevention Program](https://cdc.gov/national-diabetes-prevention-program)

Heart Disease

Disclaimer: This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Heart disease refers to several types of heart conditions, the most common being Coronary Artery Disease (CAD), which can lead to a heart attack. A heart attack occurs when blood flow to a part of the heart muscle is severely reduced or blocked. Heart disease is the leading cause of death in the United States.

Heart Attack vs. Cardiac Arrest vs. Heart Failure

Condition	Primary Issue	Description and Impact
Heart Attack	Plumbing	A blocked artery prevents blood flow, causing heart muscle tissue to die if not treated immediately.
Cardiac Arrest	Electrical	The heart suddenly stops beating due to an arrhythmia (abnormal heart rhythm) such as ventricular fibrillation. Without immediate CPR and the use of an Automated External Defibrillator (AED), death can occur within minutes.
Heart Failure	Pumping	A chronic condition where the heart is too weak or stiff to pump enough blood to meet the body's demands.

Who Gets Heart Disease?

Individuals with high blood pressure, high cholesterol, or diabetes are at the highest risk. Lifestyle factors like smoking and physical inactivity also contribute. Nearly half of all Americans have at least one of these risk factors.

While the risk increases with age, heart disease does not only affect older adults. In 2023, approximately 1 in 6 deaths from cardiovascular disease occurred in individuals under the age of 65.

Causes of Heart Disease

Heart disease is often caused by **Atherosclerosis**, a condition where plaque (a buildup of fat and cholesterol) accumulates in the walls of the arteries. This narrows the vessels over time and restricts the flow of oxygen-rich blood to the heart.

Signs & Symptoms of Heart Disease

- **Chest pain (Angina):** Pressure, squeezing, or discomfort.
- **Shortness of breath:** Especially during physical activity or while lying down.
- **Referred Pain:** Pain or numbness in areas outside the heart, such as the shoulders, arms, neck, jaw, back, or upper abdomen. These atypical symptoms are especially common in women.
- **Extreme Fatigue:** Feeling unusually tired for no clear reason.

Stages of Heart Disease

1. **Stage A (At Risk):** No structural heart damage but presence of risk factors like hypertension or diabetes.
2. **Stage B (Pre-Heart Failure):** Structural damage is present (like a low ejection fraction) but no outward symptoms.
3. **Stage C (Symptomatic):** Structural damage with current or prior symptoms like fatigue or breathlessness.
4. **Stage D (Advanced):** Severe symptoms that do not improve with standard treatment.

Diagnosis of Heart Disease

- **ECG/EKG:** Records the electrical activity of the heart.
- **Echocardiogram:** An ultrasound used to examine the structure of the heart (atria, ventricles, valves, etc.) and evaluate the pumping function of the ventricles (including ejection fraction, etc.).
- **Stress Testing:** Monitoring the heart during physical exercise.
- **Cardiac Catheterization:** A procedure to check for blockages using a catheter and special dye.

Treatment of Heart Disease

- **Lifestyle Changes:** Adopting a heart-healthy diet (low sodium/trans fats) and regular exercise.
- **Medications:** Beta-blockers, statins (for cholesterol), and ACE inhibitors to manage blood pressure.
- **Procedures:** Angioplasty (using a balloon to open arteries), stents, or coronary artery bypass surgery.

Prevention of Heart Disease

- Managing stress through healthy outlets.
- Quitting smoking and avoiding secondhand smoke.
- Maintaining blood pressure, blood sugar, and cholesterol levels within target ranges through regular screenings.

- Adopting a healthy diet (recommended: low-sodium, low-saturated fat, the DASH diet, etc.).
- Engaging in regular physical activity.
- Consuming alcohol in moderation.

Living with Heart Disease

Living with heart disease requires a proactive approach. This includes daily monitoring of vitals (blood pressure and weight), strictly adhering to medication schedules, and participating in cardiac rehabilitation—a medically supervised program designed to improve cardiovascular health after a heart event.

Sudden Cardiac Arrest - CPR/AED Instructions

Emergency Response Guidelines:

- **Call 911** immediately.
- **Start CPR.**
- **Use a nearby AED** (Automated External Defibrillator).

**Rapid response saves lives.*

Support Groups for Heart Disease

- [Heart.org – Support Network](https://www.heart.org)
- [AACVPR.org – Cardiac Program Directory](https://www.aacvpr.org)

Resources

- [MedlinePlus.gov: Heart Disease](https://medlineplus.gov)
- [CDC.gov: About Heart Attack](https://www.cdc.gov)
- [NHLBI.nih.gov: What Is Coronary Heart Disease?](https://www.nhlbi.nih.gov)

Mental Health

Disclaimer: This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Mental health covers emotional, psychological, and social well-being. It affects how people think, feel, and act, and helps determine how they handle stress, relate to others, and make choices. Accessible treatment and early intervention are essential for recovery and well-being.

Common Types of Mental Health Disorders

- **Anxiety Disorders:** Characterized by persistent, excessive fear or worry. This includes **Panic Disorders** and **Phobias**.
- **Obsessive-Compulsive and Related Disorders (OCD and Related Disorders):** Characterized by uncontrollable, recurring thoughts (obsessions) and behaviors (compulsions).
- **Mood Disorders:** Affect a person's emotional state.
 - **Depression:** Persistent sadness and loss of interest.
 - **Bipolar Disorder:** Cycles of extreme highs (mania) and lows (depression).
 - **Seasonal Affective Disorder (SAD):** Depression triggered by changing seasons.
- **Trauma-Related Disorders:** Such as **Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)**, which develops after experiencing or witnessing a terrifying event.
- **Psychotic Disorders:** Conditions like Schizophrenia that involve a loss of contact with reality, such as hallucinations or delusions.
- **Eating Disorders:** Severe disturbances in eating behaviors and related thoughts and emotions.
- **Personality Disorders:** Long-term patterns of thoughts and behaviors that are unhealthy and inflexible.
- **Substance Use Disorders:** Occur when the recurrent use of alcohol and/or drugs causes significant impairment.

Who Gets Mental Health Challenges?

Mental health issues are very common. Approximately 23% of U.S. adults (more than 1 in 5) live with a mental health condition. This affects all age groups, regardless of income, geography, or education level. While certain issues—such as depression resulting from cognitive decline or isolation—may increase in later life, mental health problems are also rising significantly among younger populations. Approximately 1 in 5 adolescents aged 12–17 in the U.S. currently has a diagnosed mental or behavioral health disorder.

In particular, a significant number of those aged 65 and older experience mental health issues such as depression and anxiety disorders, which often tend to go undiagnosed or untreated. It is important to seek early help from a doctor or mental health professional if symptoms appear.

Causes of Mental Health Challenges

There is no single cause for mental health conditions. Development is typically influenced by:

- **Biology:** Brain chemistry (neurotransmitters like serotonin) and genetic predispositions.
- **Life Experiences:** Exposure to trauma, abuse, or significant chronic stressors.
- **Medical Conditions:** Chronic physical illnesses (such as cancer or heart disease) can increase the risk of developing mental health struggles.

Signs & Symptoms of Mental Health Challenges

Signs vary but often include:

- Persistent sadness, “empty” mood, or irritability.
- Excessive fear, worry, or anxiety.
- Extreme mood swings or difficulty controlling emotions.
- Withdrawal from social activities and loved ones.
- Significant changes in sleeping (insomnia) or eating habits.
- Delirium: Sudden confusion or disorientation, often seen in seniors.
- Suicidal Ideation: Thoughts of self-harm or suicide
 - If you have thoughts of self-harm or suicide, call or text **988** (Suicide & Crisis Lifeline, free 24/7) immediately. In a life-threatening emergency, call **911**.

Stages of Mental Health Challenges

Various mental health conditions manifest in different ways and can range from mild states to crisis situations.

1. **Mild Disruption:** Difficulty sleeping or temporary distress.
2. **Moderate/Severe Illness:** Symptoms interfere with work, relationships, or daily function.
3. **Crisis:** High risk of harm or inability to care for oneself.

Diagnosis of Mental Health Challenges

A mental health professional (Psychiatrist, Psychologist, or Licensed Counselor) uses clinical interviews and the DSM-5 manual to evaluate symptoms. They may also use physical exams to rule out other medical

causes.

Treatment of Mental Health Challenges

- **Therapy:** Cognitive Behavioral Therapy (CBT) helps identify and change negative thought patterns.
- **Medication:** Antidepressants, mood stabilizers, or anti-anxiety medications.
- **Mind-Body Practices:** Meditation, yoga, and mindfulness to support emotional regulation.
- **Faith-Based Care:** Complementary support and recovery through spirituality and pastoral care.

Prevention of Mental Health Challenges

While not all conditions can be prevented, health can be supported by:

- Maintaining strong social connections.
- Prioritizing consistent sleep and physical activity.
- Practicing stress-management techniques.
- Seeking professional help early before symptoms escalate.

Living with Mental Health Challenges

Living with mental health challenges or recovery involves professional treatment, a strong support network, and healthy lifestyle choices. Many individuals with mental health conditions live full, productive lives by adhering to their treatment plans and utilizing community resources.

Support Groups for Mental Health

Organization	Key Services	Contact/Link
Bergen New Bridge Medical Center	Inpatient Care: Provides 24/7 inpatient services and intensive treatment for mental health and substance use disorders.	NewBridgeHealth.org (201) 967-4000
SAMHSA (Substance Abuse & Mental Health Services Admin)	Federal agency under the US HHS that provides local resources and support for substance use disorders and mental health.	SAMHSA.gov - Find Help FindTreatment.gov
NAMI (National Alliance on Mental Illness)	Peer-led support groups and educational programs for individuals with mental illness.	NAMI.org - Support Groups
Mental Health America	Mental health screening tools and connections to specialized professionals.	mhanational.org

24/7 Crisis Assistance

SAMHSA's free, confidential national hotline, available in English/Spanish.

- **Substance abuse/mental health helpline:** treatment referral and information service.
 - **1-800-662-HELP (4357)**
- **Suicide & Crisis Lifeline:** Immediate support via call, text, or chat.
 - **988**

Care Plus NJ

New Jersey-based nonprofit specializing in comprehensive mental health counseling and care for children, adults, and families.

Headquarters

- **Address:** 610 Valley Health Plaza, Paramus, NJ 07652
- **Primary Phone:** (201) 986-5000
- **Website:** CarePlusNJ.org

Regional Outpatient OfficesBergen County Office (Rochelle Park)

- **Address:** 365 W. Passaic Street, Suite 115, Rochelle Park, NJ 07662
- **Hours:** Monday – Thursday | 9:00 AM – 3:00 PM

Essex County Office (Bloomfield)

- **Address:** 650 Bloomfield Avenue, Suite 106, Bloomfield, NJ 07003
- **Hours:** Monday – Thursday | 9:00 AM – 1:00 PM

Morris County Office (Morris Plains)

- **Address:** 520 Speedwell Avenue, Ste 216, Morris Plains, NJ 07950
- **Hours:** Wednesday & Thursday | 9:00 AM – 1:00 PM

Resources

- [MedlinePlus.gov: Mental Health Topics](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)
- [NIMH.nih.gov: Caring for Your Mental Health](https://www.nimh.nih.gov/health/topics/mental-illnesses-and-conditions/)
- [Christianhealth.org : Faith-Based Behavioral Health](https://www.christianhealth.org/)
- [NAMI: Benefits of Religion & Spirituality](https://www.nami.org/About-NAMI/Benefits-of-Religion-and-Spirituality/)
- [SAMHSA.gov: Substance Use Disorder](https://www.samhsa.gov/substance-use-disorder/)
- [SAMHSA.gov: Mental Health](https://www.samhsa.gov/mental-health/)

Mind-Body Medicine

Mind-body practices include a variety of techniques such as meditation, yoga, and mindfulness, which are designed to enhance the mind's positive impact on physical and emotional health. These practices are increasingly integrated into mainstream medical settings as **complementary and integrative therapies**, working alongside conventional treatments to improve overall patient outcomes.

Core Mind-Body Practices

Several techniques form the foundation of mind-body medicine, each offering unique benefits for the nervous system and physiological health:

- **Meditation:** A practice that involves focusing attention or suspending the stream of thoughts to achieve mental clarity and emotional stability.
- **Mindfulness:** The practice of maintaining a non-judgmental state of heightened or complete awareness of one's thoughts, emotions, or experiences on a moment-to-moment basis.
- **Yoga:** A system of physical postures, breathing techniques, and meditation used to improve flexibility, strength, and mental focus.
- **Tai Chi and Qi Gong:** Mind-body exercises that combine slow, deliberate movements with meditation and breathing.
- **Deep Breathing and Progressive Relaxation:** Techniques used to physically lower the body's stress response and reduce muscle tension.

Benefits and Effectiveness

Mind-body medicine is utilized to manage symptoms and improve the quality of life for various conditions:

- **Pain Management:** Practices such as yoga and meditation can help reduce chronic pain, including back pain and headaches.
- **Mental Health:** Mindfulness practices can be effective in alleviating symptoms of anxiety, depression, and stress.
- **Cardiovascular Health:** Research findings suggest that regular meditation and mind-body practices can help lower blood pressure.
- **Cancer Care:** Mind-body practices can be used to manage side effects experienced by cancer patients during treatment, such as nausea, fatigue, and emotional distress.

Mind-Body Medicine and Standard Medical Care

Mind-body practices are not a replacement for standard medical treatment, but are **complementary and integrative** health therapies used alongside it. Certain physical postures (such as yoga) may require the guidance of a trained instructor for individuals with existing injuries or chronic conditions. In particular, seniors aged 65 and older, and those with osteoporosis, joint diseases, or heart disease, should consult with a healthcare provider before beginning.

Local Mind-Body Medicine Providers

- **Mind-Body Clinics**
 - Acupuncture
 - Oriental Medicine
 - Massage Therapy
 - Meditation/Qi Gong
 - Yoga, Pilates
 - Chiropractic
 - Psychotherapy

- **Major Mind-Body Medicine Providers in New Jersey**
 - [Englewood Health – Integrative Medicine](#)
 - [Hackensack Meridian Health – Integrative Health & Medicine](#)
 - [Valley Health – Integrative Medicine](#)
 - [RWJBarnabas Hamilton – Holistic Integrative Medicine](#)

- **Mind-Body Medicine Academic and Specialty Centers**
 - [Columbia University – Integrative Health](#)
 - [Mount Sinai Hospital – Integrative Medicine](#)
 - [Memorial Sloan Kettering Cancer Center – Integrative Medicine](#)

**When choosing a facility, verify their certifications and professional training. Please refer to the NCCIH guide on selecting a complementary health practitioner.*

Resources

- [NCCIH.nih.gov: Mind and Body Practices](https://nccih.nih.gov/mind/body/practices)

- [NCCIH.nih.gov: Meditation and Mindfulness](https://nccih.nih.gov/meditation)
- [Cancer.gov: Complementary and Alternative Medicine](https://cancer.gov/complementary)

Obesity

Disclaimer: This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Obesity is a complex, chronic disease characterized by excessive body fat that presents a risk to health. It is not merely a cosmetic concern but a medical condition that increases the risk of other diseases and health problems,

Who Gets Obesity?

Obesity affects individuals of all ages, races, and socioeconomic groups. While the risk of obesity increases with age—partly due to metabolic changes and decreased muscle mass—younger populations face a significant rise in obesity rates. 2 out of 5 adults in the United States (40.3%) are diagnosed with obesity, and approximately one in five U.S. children and adolescents ages 2 to 19 (about 19–20%) are obese, which stands as a factor that threatens lifelong health.

Causes of Obesity

Obesity generally results from a long-term energy imbalance where more calories are consumed than are used by the body. Contributing factors include:

- **Lifestyle Choices:** Sedentary behaviors, high screen time, and diets high in processed, calorie-dense foods.
- **Environment:** Limited access to affordable healthy foods or safe places for physical activity.
- **Genetics and Metabolism:** Genetic traits can affect how the body processes food into energy and how it stores fat.
- **Health Conditions and Medications:** Certain diseases (like hypothyroidism) or medications (like steroids) can contribute to weight gain.

Signs & Symptoms of Obesity

The primary indicator of obesity in adults is a **Body Mass Index (BMI) of 30 or higher**. Associated symptoms and physical signs include:

- Increased body fat, particularly around the waist.
- Breathlessness during minor physical exertion.
- Increased sweating and snoring (often linked to sleep apnea).

- Persistent joint and back pain due to excess strain on the musculoskeletal system.

Diagnosis of Obesity

- **BMI Calculation:** A screening tool that compares height and weight.
 - CDC Official BMI Classifications:
 - Stage 1: BMI 30–34.9
 - Potential risk factors (such as borderline hypertension) or mild physical symptoms.
 - Stage 2: BMI 35–39.9
 - Chronic diseases related to obesity (such as type 2 diabetes, sleep apnea, etc.).
 - Stage 3: BMI 40 or higher (Severe)
 - Serious disabilities occurring due to obesity-related chronic diseases, such as End-Stage Renal Disease (ESRD), severe heart disease, and cirrhosis of the liver.
- **Waist Circumference:** Measuring fat stored around the middle, which is a key indicator of health risk. Waist circumference of 35 inches (88 cm) or more for women and 40 inches (102 cm) or more for men may lead to increased health risks.
- **Blood Tests:** Checking cholesterol, glucose levels, and liver function to assess metabolic health.

Treatment of Obesity

Treatment focuses on sustainable health improvements rather than quick weight loss:

- **Dietary Changes:** Shifting toward nutrient-dense foods and reducing calorie intake.
- **Physical Activity:** Aiming for at least **150 minutes of moderate-intensity aerobic activity** per week, along with muscle-strengthening exercises at least twice a week.
- **Behavioral Counseling:** Identifying triggers for overeating and developing healthier coping mechanisms.
- **Medical Interventions:** In some cases, healthcare providers may prescribe weight-loss medications or recommend bariatric surgery.

Prevention of Obesity

- Limiting the consumption of sugary beverages and highly processed snacks.
- Eat healthy foods and engage in safe physical activity.
- Reducing sedentary “screen time” and increasing daily movement.
- Prioritizing consistent, quality sleep, as sleep deprivation can disrupt hormones that control hunger.

Living with Obesity

Living with obesity involves long-term lifestyle management. Success is often measured by improvements in cardiovascular fitness, blood pressure, and blood sugar levels, rather than just the number on a scale.

Support Groups for Obesity

- [Obesity Action Coalition – Community Support](#)

Resources

- [MedlinePlus.gov: Obesity](#)
- [CDC.gov: About Obesity](#)
- [NHLBI.nih.gov: BMI Calculator: Calculate Your BMI](#)
- [NIDDK.nih.gov: Weight Management in Older Adults \(Research\)](#)
- [NCOA – Obesity in Older Adults](#)

Stroke

Disclaimer: This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

A stroke occurs when the brain's blood supply is interrupted or reduced, preventing brain tissue from getting oxygen and nutrients. Within minutes, brain cells begin to die. A stroke is a critical medical emergency that requires immediate intervention to minimize brain damage and potential complications.

Who Gets Stroke?

Stroke risk increases significantly with age. High-risk individuals include those with:

- **High blood pressure (Hypertension):** The leading cause of stroke, which is increasingly found in younger populations.
- **Atrial Fibrillation (AFib):** An irregular heart rhythm that can cause blood clots.
- **High Cholesterol and Diabetes:** Both conditions damage blood vessels over time.

While the risk of stroke increases with age, younger populations face a notable rise in stroke cases. 10 to 15% of all strokes occur in individuals between the ages of 18 and 50. In particular, the prevalence of stroke among adults aged 18 to 64 has been steadily increasing in recent years.

Causes of Stroke

- **Ischemic Stroke (Most Common):** Occurs when a blood clot or fatty deposits (plaque) block an artery leading to the brain. Approximately 87% of all strokes are ischemic.
- **Hemorrhagic Stroke:** Occurs when a weakened blood vessel in the brain bursts and bleeds into the surrounding tissue.
- **Transient Ischemic Attack (TIA):** Often called a "mini-stroke," this is a temporary blockage that serves as a warning sign of a future full-scale stroke. TIA is also a medical emergency that requires immediate attention. If left untreated, the risk of a major stroke significantly increases following a TIA. Even if symptoms disappear within minutes, call 911 or go to the emergency room immediately.

Signs & Symptoms of Stroke

Health professionals emphasize the **F.A.S.T.** acronym to recognize the sudden onset of symptoms:

- **F – Face:** One side of the face droops or is numb.

- **A – Arm:** One arm is weak or numb; when both arms are raised, one drifts downward.
- **S – Speech:** Speech is slurred or the person is unable to speak or understand.
- **T – Time:** Call 911 immediately if any of these symptoms are present.

*A sudden, severe headache with no known cause, may be a major warning sign of a hemorrhagic stroke. Call **911** immediately.*

What to Do During a Stroke

The period immediately following a stroke is known as the **Golden Time**. It is critical to begin receiving treatment within **3 hours** of the onset of symptoms. Since some patients may still be eligible for treatment up to 4.5 hours, do not hesitate to call **911** immediately even if the three-hour window has passed. The success of stroke treatment depends entirely on **‘how quickly the patient arrives at the hospital.’** Faster intervention minimizes brain damage, and taking swift action within the Golden Time is the most decisive factor in a patient’s recovery.

1. **Call 911 Immediately:** Do not attempt to drive the person to the hospital yourself. Paramedics can begin life-saving treatment in the ambulance and will alert the hospital’s “stroke team” so they are ready the moment the patient arrives.
 2. **Note the Time:** Try to identify the exact time the first symptom appeared. This is the most critical piece of information for the medical team, as it determines whether the patient can safely receive “clot-busting” medications (tPA).
 3. **Perform the F.A.S.T. Check.**
 4.
 - **Do not give them food or drink:** Strokes can affect the ability to swallow, leading to choking or aspiration.
 - **Do not give them aspirin:** While aspirin helps with some heart attacks, it can be fatal if the stroke is caused by a brain bleed (hemorrhagic) rather than a clot.
- Keep the Person Calm and Safe:**
- **Positioning:** If the patient is conscious, lay them down in a safe location and take care to ensure an open airway. For specific instructions regarding positioning, please follow the guidance of the emergency medical technicians (EMTs) upon their arrival.

Stages of Stroke Recovery

- **Acute Phase:** The immediate hours following the event, focused on stopping the stroke and stabilizing the patient.
- **Subacute Phase:** The days and weeks following stabilization where medical teams assess damage and prevent secondary complications.
- **Rehabilitation Phase:** The long-term process of regaining lost skills through various therapies.

Diagnosis of Stroke

- **CT Scan or MRI:** To identify the location of the stroke and determine if it is caused by a clot or a bleed.
- **Carotid Ultrasound:** To check for fatty deposits that may have caused an ischemic stroke.
- **Echocardiogram:** To see if a blood clot from the heart traveled to the brain. For large blood clots, a procedure called a mechanical thrombectomy may be performed to physically remove the clot.

Treatment of Stroke

- **For Ischemic Stroke:** Clot-busting drugs like **tPA (tissue plasminogen activator)** can dissolve the clot if administered within a specific timeframe (usually 3 to 4.5 hours).
- **For Hemorrhagic Stroke:** Surgery may be required to repair the vessel or relieve pressure on the brain. For large blood clots, a procedure called a mechanical thrombectomy may be performed to physically remove the clot.
- **Rehabilitation:** Speech, physical, and occupational therapy are used to help survivors relearn motor skills and communication.

Prevention of Stroke

Managing high blood pressure is the most important step in stroke prevention. Other preventive measures include:

- Treating heart disease (especially AFib).
- Maintaining a healthy weight and diet.
- Quitting tobacco use and limiting alcohol.

Living with Stroke

Recovery from stroke continues long after leaving the hospital. Support involves home modifications (like grab bars), the use of assistive devices (like walkers), and emotional support for both survivors and families to manage the psychological impact of the event.

Support Groups for Stroke

- [American Stroke Association – Support Group Finder](#)

Resources

- [MedlinePlus.gov: Stroke](#)
- [NIA.nih.gov: Stroke: Signs, Cause](#)

PART I • SECTION 7

Long Term Care Program

장기 요양 프로그램 (Long Term Care Program)

Long-term healthcare infrastructure: Long-Term Care (LTC) overview, rehabilitation & skilled nursing facilities, nursing home care, hospice palliative care, adult day care, and the Long-Term Care Ombudsman.

This section contains 6 comprehensive guides

Long Term Care Overview

Long term care goes beyond simple medical treatment. It is a comprehensive support system designed to assist individuals who have difficulty performing Activities of Daily Living (ADLs) such as bathing, dressing, eating, etc. due to physical or cognitive limitations.

Types of Long-Term Care Services

Residential Care

- [Assisted Living](#)

A residential setting for those who cannot live independently but do not require the intensive medical care of a nursing home. It provides help with meals, medication management, and personal hygiene. Costs are primarily paid out-of-pocket, though Medicaid benefits may apply in limited cases.

- [Nursing Home / Skilled Nursing Facility](#)

Facilities for individuals requiring 24-hour skilled nursing care and continuous medical supervision. Medicare covers part of the cost for short-term stays, while long-term custodial care are covered by Medicaid or private funds.

[Rehabilitation and Skilled Nursing Care](#)

- Provided directly by medical staff when complex treatments (wound care, IV therapy, etc.) or intensive rehabilitation (physical/occupational/speech therapy) are required.

Home and Community-Based Services (HCBS)

- [Home Health Care](#)

Medical services provided by professionals such as nurses, home health aides, and physical/occupational therapists who visit the home per doctor's prescription.

- [Adult Day Care](#)

Provides social activities and health monitoring in a safe facility during the day, offering respite to family caregivers.

Hospice Care

- A special form of care for terminally ill patients diagnosed with a life expectancy of six months or less, and for their families. It focuses on pain relief (Palliative Care) and physical, emotional, and spiritual support rather than curative treatment. Care can continue beyond six months if recertified by a doctor.

Find a Long-Term Care Facility

- **National Facility Search:** [Medicare.gov Care Compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- **New Jersey:** [NJ.gov/health/ltc/find-facility](https://www.nj.gov/health/ltc/find-facility)

Considerations for Selection

- **Check the 5-Star Quality Rating:** Review the 5-star ratings for each facility on [Medicare.gov Care Compare](https://www.medicare.gov/care-compare). The rating consists of three domains:
 - Health Inspections
 - Staffing
 - Quality Measures
- **Review Survey Reports:** Request the most recent state inspection report kept at the facility, or view it online via [Medicare.gov Care Compare](https://www.medicare.gov/care-compare) and state government websites.
- **Consult the [Long-Term Care Ombudsman](#):** The Long-Term Care Ombudsman is an independent advocacy agency appointed by the Governor to protect the rights of residents in long-term care facilities and investigate reports of abuse, neglect, or complaints. The Ombudsman is the direct, confidential line for intervention and protection for residents, family members, or concerned parties.

References

- [NIA.gov: Residential Care Guide \(Assisted Living, Nursing Homes, etc.\)](https://www.nia.gov/caring/assisted-living/nursing-homes/)
- [NIA.gov: What Is Long-Term Care?](https://www.nia.gov/caring/assisted-living/nursing-homes/)
- [ACL.gov: Long-Term Care Overview and Local Service Connections](https://www.acl.gov/long-term-care/overview-and-local-service-connections)
- [Medicare.gov Care Compare: Compare Facilities and Check Coverage](https://www.medicare.gov/care-compare/compare-facilities-and-check-coverage)
- [New Jersey Long-Term Care Ombudsman \(NJLTCO\)](https://www.njltpco.org/)

Adult Day Care

Adult Day Care provides a safe and supportive environment for seniors during the day. It is an essential community-based service that allows family caregivers to work or take necessary respite while ensuring their loved ones receive proper care.

Key Service Models

Adult Day Care typically operates under two primary models, with memory care options available in both.

- **Adult Social Day Care:** Focuses on social interaction, recreation, meals, and basic personal care.
- **Adult Day Health Care (Medical Model):** Provides professional medical services, including medication management and rehabilitation therapies, with on-site nurses or physical therapists. This model is suitable for those with complex medical needs or those at risk of nursing home placement.
- **Alzheimer's/Dementia Adult Day Services:** Offers a secure environment and cognitive stimulation programs designed for individuals with dementia or cognitive decline. This can be integrated into either social or medical day care centers, and levels of specialization vary by facility.

Cost and Coverage

Medicare

Original Medicare (Parts A and B) does not cover the cost of adult day care services. However, some Medicare Advantage (Part C) plans may provide limited coverage for adult day care.

**Conditions vary by plan, so prior verification is required.*

Private Pay

Costs vary significantly based on location, type of facility, and services provided. Additional fees may apply for transportation, specialized diets, or extended hours.

**For exact pricing, contact facilities directly or use the [Eldercare Locator](#).*

New Jersey MLTSS (Managed Long Term Services and Supports)

In New Jersey, Adult Day Care costs may be covered through the Medicaid MLTSS program. This managed care system involves NJ FamilyCare MCOs (Managed Care Organizations) paying providers directly for services.

**For details, check [LTC Medicaid \(MLTSS\)](#).*

NJ Alzheimer's Adult Day Services Program (AADSP)

Administered by the NJ DHS Division of Aging Services, this program specifically supports dementia care. It subsidizes 20% to 100% of Adult Day Care costs for up to 5 days per week.

- **Eligibility:** Diagnosis of Alzheimer's or a related dementia
- Income requirements: Individual ≤ \$50,256; Couple ≤ \$58,632 (2025 limits)
- Current non-enrollees in government assistance programs such as MLTSS Medicaid or Jersey Assistance for Community Caregiving (JACC).

Contact: NJ DHS Division of Aging Services, 609-438-4733 / www.nj.gov/humanservices/doas/services/a-k/aads/

JACC (Jersey Assistance for Community Caregiving)

Supports seniors aged 60+ who require a nursing facility level of care but choose to live in the community. Services include social adult day care, personal care assistance, and transportation. Cost-sharing may be required based on income.

Contact: County AAA/ADRC (Aging and Disability Resource Connection), 1-877-222-3737

**For details, check [Jersey Assistance for Community Caregiving \(JACC\) program](#).*

VA (Veterans Affairs) Benefits

Registered veterans may be eligible for Adult Day Care support through the VA healthcare system.

Other Payment Methods

Long-Term Care Insurance: Private policies may cover Adult Day Care.

**Reimbursement varies by plan; check your own plan.*

Questions to Ask When Choosing a Facility

- **Staff-to-Participant Ratio:** Verify whether the staff-to-participant ratio is low. While the New Jersey Department of Health (NJDOH) licensing standards establish the minimum requirements, staffing levels may vary by facility.
- **Staff Professionalism:** Verify the availability of on-site nursing staff and, in the case of specialized dementia day care, the presence of dedicated professionals with relevant expertise.

- **Transportation:** Determine whether safe transportation services are available between the residence and the facility.
- **Licensing and Inspection Records:** NJ facilities must be licensed by the NJDOH.

**Verify the facility's licensure status and review the findings of recent inspections:*

Healthapps.nj.gov/facilities

Korean Adult Day Care Centers in Bergen County

Facility Name	Address	Contact
Bergen Adult Day Care Center	139 E Central Blvd, Palisades Park, NJ 07650	201-907-4680
Bergen New Bridge Medical Center	230 E Ridgewood Ave, Paramus, NJ 07652	201-967-4000
Broadway Adult Day Care	24-20 Broadway, Fair Lawn, NJ 07410	201-797-1177
Golden Adult Day Care	53-57 West Fort Lee Road, Bogota, NJ 07603	201-457-1007
Magnolia Adult Day Care	2300 3rd Street, Fort Lee, NJ 07024	201-482-4500
My Home Adult Day Care Center Inc	37 Brook Avenue, Maywood, NJ 07607	201-291-8811
New Jersey Day Care Center-Serenity Gardens	105 Challenger Road, 6th Fl, Ridgefield Park, NJ 07660	201-773-9090
New Life Adult Medical Day Care	340 Evelyn Street, Paramus, NJ 07652	201-265-0606
Our Home Adult Day Care	475 Grand Avenue, Englewood, NJ 07631	201-731-3636
Peaceful Adult Medical Day Care Center	101 Industrial Avenue, Suite C & B, Little Ferry, NJ 07643	201-870-6265
Sunshine Adult Day Health Care Center	16 N. Washington Avenue, Bergenfield, NJ 07621	201-387-8500

References

Government Agencies (Official Sources)

- [Eldercare Locator \(ACL\) Find Local Adult Day Care Facilities](#)
- [NIA.gov — Guide to Home Services and Adult Day Care](#)
- [NJ DHS — NJ MLTSS Program Overview](#)
- [Bergen County Key Service Guide \(PDF\)](#)

Hospice Care

Hospice care is a specialized medical service designed for terminally ill patients for whom curative treatment is no longer the primary goal. The focus shifts from curing the underlying disease to ensuring the patient spends their remaining time with dignity, comfort, and peace. This palliative medical service (comfort care) model prioritizes expert symptom management while providing comprehensive psychological and spiritual support for both the patient and their families.

Service Types and Settings

Hospice is a philosophy of care rather than a specific physical location; it is designed to meet wherever they reside.

- **Settings:** Patient's home (most common), assisted living facilities, nursing homes, dedicated hospice facilities, or hospitals. Hospice service also may be provided in short-term inpatient hospital.
- **Team-Based Care:** A multidisciplinary team consisting of doctors, nurses, social workers, counselors, and volunteers works together to address the physical, emotional, social, and spiritual needs of the patient and their family.

Cost and Coverage

Medicare (Part A)

Eligibility Requirements (Must meet all conditions below):

- **Terminal Diagnosis:** The hospice medical director and the patient's attending physician (if applicable) must certify that the patient has a life expectancy of six months or less, assuming the illness runs its normal course. If the patient does not have a primary physician, the hospice medical director can provide the certification alone.
- **Transition of Care:** The patient must sign an Election Statement choosing hospice care for their terminal illness instead of other Medicare-covered curative treatments.
- **Certified Agencies:** Services must be obtained through a hospice provider officially certified by Medicare (CMS).

**Benefit Periods: Medicare hospice benefits are available for two 90-day periods, followed by an unlimited number of 60-day periods. Even after six months, care can continue in 60-day increments provided the physician recertifies the patient.*

**Medicare Hospice Out-of-Pocket Costs:*

- *General Covered Services: \$0 (No deductible)*
- *Prescription Drugs for Pain Relief (Outpatient): Copay of \$5 or less per prescription*
- *Inpatient Respite Care: 5% coinsurance of the Medicare-approved amount for short-term stays*

LTC Medicaid (MLTSS)

- **Benefit Scope:** Provides comprehensive coverage (with zero or minimal cost-sharing) for professional nursing, physician services, medications for symptom management, and medical equipment.
- **Room and Board:** For residents in nursing homes, room and board costs may be covered if the individual separately meets Medicaid eligibility requirements. Since regulations vary by state, verification is required.

**For details, check [LTC Medicaid \(MLTSS\)](#).*

Hospice Care within Nursing Facilities

In instances where a resident receives hospice care while residing in a nursing home, a distinct cost-sharing structure applies:

- **Hospice Medical Expenses:** Medicare provides full coverage for all clinical hospice services.
- **Nursing Home Room and Board:** Medicare does **not** cover room and board costs. These expenses must be paid out-of-pocket, unless the individual qualifies for **Long-Term Care Medicaid**, which may provide financial assistance for those meeting specific eligibility criteria.

Veterans Affairs (VA) Benefits

U.S. military veterans can receive hospice care through the VA healthcare system.

- **Eligibility:** All veterans enrolled in the VA healthcare system are eligible for hospice care if clinically determined to need it. This benefit is provided regardless of service-connected disability ratings or income levels. (Procedures for enrolling in the VA healthcare system can be found at [VA.gov](#)).
- **Cost Sharing:** There is no copayment (Copay) for services provided by the VA or VA-contracted agencies.
- **Locations:** Care can be received at home, in VA outpatient clinics, VA inpatient facilities (including Community Living Centers), or through VA-contracted community hospice providers.

**For instructions on how to enroll in the VA health care system, please visit [VA.gov](#).*

Private Health Insurance and Long-Term Care (LTC) Insurance

- **Private Plans:** Most private insurers mirror the Medicare hospice model. However, patients may still be responsible for deductibles or copayments.
- **LTC Insurance:** Depending on the specific policy, this may cover hospice costs in a nursing home or at home within a set daily limit.

Charity Care / Uninsured

This serves as the final safety net for individuals without insurance who face financial hardship.

- Many non-profit hospice agencies offer care at no cost or at a discounted rate through community donations or foundation funds.
- **Sliding Scale:** Costs are adjusted based on the patient's income and asset levels.

If hospice care is required while uninsured, please inquire about financial assistance options through non-profit hospice agencies or a designated social worker. (For inquiries regarding **NJ Charity Care, contact 1-866-588-5696.)*

Prescription Drug Benefit (Medicare Part D) — Separate Medicare Benefit

As of 2026, the annual out-of-pocket cap for prescription drugs covered under Medicare Part D is limited to \$2,100. After reaching this limit, the enrollee pays nothing for covered drugs for the remainder of the year.

**Note for Hospice Patients: Medications related to the terminal illness are already covered under the Medicare Hospice benefit with a maximum copay of \$5. The Part D \$2,100 cap primarily applies to medications unrelated to the terminal illness. Additionally, plan premiums and drugs covered under Part B (such as certain injectables) are not included in the calculation toward this cap.*

Prescription Drug Benefits (Medicare Parts A and D) — For Medicare Beneficiaries

- **Medications Related to Terminal Illness:** These are covered under **Medicare Part A**. Beneficiaries are responsible only for a copayment of up to \$5 per prescription.
- **Other Prescription Drugs:** Medications unrelated to the terminal illness are covered under **Medicare Part D**. A deductible of \$2,100 per year (as of 2026) applies.
- **Medicare Advantage (Part C) Enrollees:** You may maintain your existing prescription drug coverage through your current plan without the need to enroll in a separate Medicare Part D plan.
- **Extra Help (Low-Income Subsidy):** Beneficiaries also enrolled in **Medicaid** may qualify for the **Extra Help** program, which significantly reduces or eliminates the cost of medications for conditions unrelated to hospice care.

Find a Hospice Care Facility

- **National Facility Search:** [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- **New Jersey:** [NJ.gov/health/hospice/find-facility](https://www.nj.gov/health/hospice/find-facility)

**Hospice care is voluntary. You can stop hospice services at any time to return to curative treatment and may re-elect hospice benefits again in the future if needed.*

Korean-Speaking Hospice Care Facilities in Bergen County, NJ

Facility Name	Location	Contact
Family of Caring Healthcare at Park Ridge, LLC	120 Noyes Drive, Park Ridge, NJ 07656	201-505-1777
Holy Name Medical Center	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3756

Considerations for Selection

- **Check the 5-Star Quality Rating:** Review the 5-star ratings for each facility on [Medicare.gov Care Compare](https://www.medicare.gov/care-compare). The rating consists of three domains:
 - Health Inspections
 - Staffing
 - Quality Measures
- **Review Survey Reports:** Request the most recent state inspection report kept at the facility, or view it online via [Medicare.gov Care Compare](https://www.medicare.gov/care-compare) and state government websites.
- **Consult the [Long-Term Care Ombudsman](#):** The Long-Term Care Ombudsman is an independent advocacy agency appointed by the Governor to protect the rights of residents in long-term care facilities and investigate reports of abuse, neglect, or complaints. The Ombudsman is the direct, confidential line for intervention and protection for residents, family members, or concerned parties.

Resources

- [Medlineplus.gov – Hospice Care](https://medlineplus.gov/hospice-care)
- [Medicare.gov – Hospice Care](https://www.medicare.gov/hospice-care)
- [Medicaid.gov – Hospice Care](https://www.medicicaid.gov/hospice-care)
- [NIA.gov – Palliative Care and Hospice Care](https://www.nia.gov/palliative-care-and-hospice-care)
- [VA.gov — Hospice card for VA](https://www.va.gov/hospice-card-for-veterans)

Long Term Care Ombudsman

The New Jersey Office of the Long-Term Care Ombudsman (NJLTCO) is an independent agency appointed directly by the Governor, operating without external oversight or control pursuant to the Older Americans Act. The Ombudsman ensures that residents of long-term care facilities, including seniors aged 60 and older, receive high-quality care and are protected from abuse, neglect, and exploitation.

**All services provided by the Ombudsman are free of charge.*

Legal Authority and Role

- **Confidential Complaint Intake:** Anyone can file a complaint via phone, fax, mail, email, or online form. All consultations are held in strict confidence, and anonymous reporting is available.
- **Independent Investigation and Referral:** The office investigates received complaints to resolve them directly or, when necessary, refers cases to jurisdictional regulatory agencies such as the New Jersey Department of Health (NJDOH) or the Department of Community Affairs (NJDCA). Suspected Medicaid fraud or criminal activity may also be referred to local police, County Prosecutors, or the NJ Office of the Attorney General.
- **Unlimited Access Rights:** The Ombudsman has the right to meet with elderly residents of long-term care facilities at any time and possesses full authority to review a resident's medical and administrative records.
- **Power to Hold Hearings and Subpoena Records:** When necessary, the office can hold public or private hearings and legally subpoena relevant documents or testimony.
- **Support for Self-Advocacy:** The office cooperates with Resident Councils and Family Councils to empower long-term care residents to advocate for their own rights and interests.

Problem-Solving Procedures

1. **Complaint Intake:** A resident or their representative files a complaint (anonymous reporting is possible). Complaints must be filed within three months of the incident.
2. **Assignment:** The complaint is reviewed by a supervisor and assigned to a Field Investigator/Advocate.
**The Ombudsman is not an emergency response agency. In an emergency involving immediate danger, call 911 immediately.*
3. **Field Investigation:** Investigators visit the facility unannounced and begin the investigation after obtaining the resident's consent.

4. **Fact-Finding:** They review relevant records and conduct interviews with facility staff and witnesses to identify objective facts.
5. **Resolution and Action:** The primary goal of the investigation is to resolve issues in a manner satisfactory to the resident while ensuring their safety, rights, and dignity are upheld. In cases where abuse or neglect is identified or suspected, the matter is referred to the appropriate authorities.

**Important: The Ombudsman only assists those currently residing in a facility (or those expected to return after hospitalization). If a resident has already been discharged, contact the NJ Department of Health directly at 1-800-792-9770.*

Major Areas of Investigation

- **Financial Exploitation:** Misappropriation of assets or financial loss.
- **Involuntary Transfer and Discharge:** Forced discharge orders that bypass proper legal procedures.
- **Inappropriate Use of Restraints:** Misuse of chemical or physical restraints.
- **Abuse and Neglect:** Physical, verbal, or mental abuse; refusal to provide services necessary to maintain physical or mental health; unreasonable confinement.
- **Low Quality of Care:** Neglect of personal hygiene, delayed response to call bells or requests for help, etc.
- **Violations of Rights and Dignity:** Acts that undermine a resident's basic human rights or dignity.

Major Facilities Covered by the Ombudsman

- Nursing Homes
- Skilled Nursing & Rehab Facilities
- Assisted Living Facilities
- Adult Day Care Centers
- Residential Health Care Facilities
- Continuing Care Retirement Community
- Long-Term Acute Care Hospitals
- Veterans' Hospitals

**For issues in facilities not listed above, contact the following agencies directly:*

- **NJDOH** (Nursing Homes/Assisted Living): 1-800-792-9770
- **NJDCA** (Boarding Homes, etc.): 609-984-1704

Contact

NJ Long-Term Care Ombudsman

Phone: 1-877-582-6995

Fax: 1-609-943-3479

Email: ombudsman@ltco.nj.gov

Online Complaint: nj.gov/ooie/contact/contact-complaint.shtml

Mail: NJ Long-Term Care Ombudsman, P.O. Box 852, Trenton, NJ 08625-0852

**In case of emergency, call 911 immediately.*

References

- [NJ.gov: Long-Term Care Ombudsman](#)
- [NJ.gov Guide on How to File a Complaint to the Ombudsman](#)
- [NJ Department of Health — Long-Term Care Facility Search](#)
- [ACL.gov — National Long-Term Care Ombudsman Program Information](#)

Nursing Home Care

A nursing home provides 24-hour clinical oversight and professional nursing care for individuals who require medical treatment alongside assistance with daily activities. The government applies strict standards to ensure the safety and quality of care for residents.

Key Services

- **Medical and Nursing Care:** Professional medication management, wound care, monitoring of blood pressure and diabetes, etc.
- **Rehabilitative Therapy:** Physical therapy, occupational therapy, and speech therapy to restore physical functions.
- **Personal Support:** Assistance with Activities of Daily Living (ADLs) that are difficult to perform independently, including eating, bathing, dressing, and mobility.
- **Dietary and Management:** Customized diets designed by nutritionists and 24-hour safety monitoring.

Cost and Coverage

Short-Term Rehabilitation

Contrary to the common perception of nursing homes as permanent residences, many nursing homes also function as specialized **Short-Term Rehabilitation Centers**. They provide intensive professional care designed to help patients regain functional strength after surgery or hospitalization, ensuring a safe and successful transition back to their homes.

**For details regarding costs and coverage for short-term stays, check [Rehabilitation & Skilled Nursing](#).*

Long-Term Care: MLTSS

If continued residency in a nursing facility is required after the 100-day Medicare benefit period concludes, Medicaid-enrolled patients receive long-term coverage through **Managed Long-Term Services and Supports (MLTSS)**.

- **Coverage:** Unlike Medicare, MLTSS covers long-term **Room and Board** and assistance with activities of daily living without a specific time limit.
- **Financial Eligibility (2026)**
 - **Income and Assets:**

- **Income: \$2,982/Month**
- **Assets: \$2,000** for individuals / **\$3,000** for couples
- **Excluded Assets:** Primary residence (valued up to **\$1,130,000** in New Jersey), one vehicle, and personal effects.
- **5-Year Look-back Period:** At the time of application, the state examines all financial records from the previous 60 months to identify any assets gifted to family members or sold below fair market value.

- **Clinical Eligibility**

- A state-appointed clinician conducts an in-person assessment **NJ Choice**, a comprehensive assessment tool used to determine clinical eligibility for Nursing Facility Level of Care (NFLOC).
- The applicant must require significant assistance with at least **three Activities of Daily Living (ADLs)**, such as eating, bathing, or mobility.

**Spousal Protections: Under the [Community Spouse Resource Allowance \(CSRA\)](#), a spouse living at home may protect assets up to a maximum of \$162,660 (as of 2026) to prevent spousal impoverishment.*

- *Cost Structure: Beneficiaries must contribute nearly all of their monthly income toward the facility's costs. They are permitted to keep a \$50/month Personal Needs Allowance (PNA). MLTSS covers the remaining balance of the facility's fees.*

Important Considerations

- **Application Timing:** Begin preparations **2 to 3 months** before short-term rehabilitation benefits end. The approval process typically takes **3 to 9 months**, though coverage is applied retroactively to the date of application.
- **Distinction from Standard Medicaid:** Holding a NJ FamilyCare Medicaid does not automatically grant access to long-term care. You must undergo a specific clinical and financial review to be authorized for the MLTSS program.
- **Professional Consultation Advised:** Due to the state's rigorous audit of all financial records from the 60 months (5 years) preceding your application, it is strongly advised to consult with a professional social worker or an elder law attorney before submitting your application.

**For details, check [LTC Medicaid \(MLTSS\)](#).*

Prescription Drug Benefits (Medicare Part D) — For Medicare Beneficiaries

For individuals receiving long-term care in a nursing home, prescription medications are covered under **Medicare Part D**.

- **Out-of-Pocket Costs (2026):** The annual out-of-pocket cap is **\$2,100**. Once you reach this limit, you will have **\$0 copays** for all covered drugs for the remainder of the calendar year.

- **Medicare Advantage (Part C) Enrollees:** If you are enrolled in a Medicare Advantage plan that includes drug coverage (MAPD), you maintain your benefits through that plan. You do not need to enroll in a separate Part D plan.
- **Patients Without Part D:** Individuals without a Part D plan are responsible for the full cost of their medications out-of-pocket.
 - **Special Enrollment Period (SEP):** Nursing home residents have a **Special Enrollment Period**, allowing you to join, switch, or drop a Part D plan or Medicare Advantage plan that better suits their needs at any time during their facility stay.

Find a Nursing Home Facility

- **National Facility Search:** [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- **New Jersey:** [NJ.gov/health/ltc/find-facility](https://www.nj.gov/health/ltc/find-facility)

Korean-Speaking Nursing Home Facilities in Bergen County, NJ

Facility Name	Location	Contact
<u>ExcelCare at Norwood</u>	100 McClellan Street, Norwood, NJ 07648	201-768-6222
<u>Family of Caring Healthcare at Park Ridge, LLC</u>	120 Noyes Drive, Park Ridge, NJ 07656	201-505-1777
<u>Holy Name Medical Center</u>	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3756

Considerations for Selection

- **Check the 5-Star Quality Rating:** Review the 5-star ratings for each facility on [Medicare.gov Care Compare](https://www.medicare.gov/care-compare). The rating consists of three domains:
 - Health Inspections
 - Staffing
 - Quality Measures
- **Review Survey Reports:** Request the most recent state inspection report kept at the facility, or view it online via [Medicare.gov Care Compare](https://www.medicare.gov/care-compare) and state government websites.
- **Consult the [Long-Term Care Ombudsman](#):** The Long-Term Care Ombudsman is an independent advocacy agency appointed by the Governor to protect the rights of residents in long-term care

facilities and investigate reports of abuse, neglect, or complaints. The Ombudsman is the direct, confidential line for intervention and protection for residents, family members, or concerned parties.

Rights Residents and Families Must Know

- **Participation in Care Plan:** The right for the individual or family to participate directly in establishing the direction of treatment and care plans.
- **Protection of Assets:** The right to manage one's own funds or to receive transparent reports when entrusting fund management to the facility.
- **Defense Against Improper Discharge:** The right to not be arbitrarily evicted. Must receive written notice and the right to object to and appeal unilateral discharge actions by the facility.
- **Prevention of Abuse:** The right to be protected from physical and mental abuse or neglect. Facilities cited for abuse are identified with a warning icon on [Medicare.gov Care Compare](#).

**For details check [Long-Term Care Ombudsman](#).*

Resources

- [NIA.gov: Long-Term Care Facilities](#)
- [Medicare.gov Care Compare](#)
- [NJ DOH.gov: New Jersey Long-Term Care Facility Search](#)
- [New Jersey Long Term Care Ombudsman \(NJLTCO\)](#)

Rehabilitation & Skilled Nursing

Rehabilitation and skilled nursing services are specialized medical services intended to maintain, restore, improve, or prevent the deterioration of daily living functions and skills that have been lost or impaired due to illness, injury, or disability.

These services are designed for seniors aged 65 and older, individuals with disabilities eligible for Medicare, and anyone recovering from surgery, illness, or injury with the goal of returning to daily life and achieving independent living.

Key Services

- **Skilled Nursing:** Procedures requiring the skills of a nurse or specialized therapist, such as intravenous (IV) therapy, wound care, feeding tube management, and monitoring of diabetes or complex conditions.
- **Physical Therapy:** Improving mobility through gait training, muscle strengthening, and restoration of joint range of motion.
- **Occupational Therapy:** Functional rehabilitation for independent living, including eating, dressing, and grooming.
- **Speech Therapy:** Restoration of communication skills and treatment for swallowing disorders (dysphagia).

Cost and Coverage

Insurance coverage depends on the specific level of care you receive. Medicare classifies rehabilitation into two distinct settings based on the intensity of care needed:

- **Skilled Nursing Facilities (SNF):** Short-term skilled nursing and therapy care provided at a nursing home.
- **[Inpatient Rehabilitation Facilities \(IRF\)](#):** An inpatient rehab hospital or unit for those requiring intensive therapy.

Medicare (Part A) — Short-term Rehabilitation

Coverage Conditions (Must meet all 4):

1. **3-Day Inpatient Stay (SNF Only):** A minimum of 3 consecutive days of formal hospital **Inpatient Admission** is required before entering SNF (the day of discharge does not count). Time spent in the Emergency Room or under Observation Status is excluded from the count. This requirement does not

apply to IRF.

**Confirm your inpatient status with the hospital.*

2. **Admission within 30 Days:** Patients must enter SNF within generally 30 days of hospital discharge.
3. **Provider Certification:** A physician or healthcare provider must certify that you require daily skilled nursing or intensive rehabilitative therapy provided by or under the supervision of professional staff.
4. **Medicare-Certified Facility:** You must receive care at a Medicare-certified facility.

Out-of-Pocket Costs (Based on Benefit Period)

- **Skilled Nursing Facilities (SNF)**
 - 1~20 days: **\$0/day** (given \$1,736 deductible already spent at inpatient care).
 - 21~100 days: **\$217/day** coinsurance
- **Inpatient Rehabilitation Facilities (IRF):** An inpatient rehab hospital or unit for those requiring intensive therapy.
 - Covered under Part A with the same cost structure as a hospital stay
 - 1–60 days: **\$0/day** after paying \$1,736 deductible
 - 61–90 days: **\$434/day**
 - 91 days+: **\$868/day**; Lifetime Reserve Days is used when beyond 91 days at IRF.

**Benefit Period Note: A Benefit Period ends when you have not received SNF care for 60 consecutive days. A new period requires a new \$1,736 deductible.*

**Doctor services while at SNF/IRF are covered under Medicare Part B.*

**Out-of-pocket costs change annually; check [Medicare.gov](https://www.medicare.gov) for the latest amounts.*

**For details, check [Medicare Part A/B](#).*

Medicare Advantage (Part C) & Private Insurance

- **Prior Authorization:** Most **Medicare Advantage** and private insurance plans require **Prior Authorization** prior to admission.
- For beneficiaries enrolled in **Medicare Advantage**, the **3-day inpatient hospital stay requirement** may be waived.
- Benefits typically apply only when using in-network facilities.

**Prior authorization process and inpatient stay requirements vary by plan; please check your own plan for specific requirements.*For details, check [Medicare Part C](#).*

Medicare Supplement Insurance (Medigap)

Depending on the specific plan, Medigap can cover the \$217 daily coinsurance for days 21–100 in full or in part. Since coverage varies by plan type, it is essential to verify these benefits before enrolling.

*Medigap does not cover non-medical long-term residency costs (custodial care, room and board) at SNF.

*For details, check [Medigap](#).

Medicaid (NJ FamilyCare)

Unlike Medicare, Medicaid (NJ FamilyCare) beneficiaries incur no out-of-pocket costs for services at Skilled Nursing and Rehabilitation Facilities. However, if care transitions from short-term rehab to long-term residency, coverage shifts to the **Managed Long-Term Services and Supports (MLTSS)** program.

- For **NJ FamilyCare** beneficiaries aged 64 and under, if rehabilitation becomes prolonged and exceeds the 100-day threshold, a **Resource Test (Asset Review)** will be applied. While NJ FamilyCare waived asset limits, MLTSS has strict asset limitations (\$2,000 for individuals, \$3,000 for married couples). Proactive financial planning is encouraged to ensure eligibility and coverage.

*For details, check [ACA Medicaid](#).

Private Pay

If insurance benefits have ended or an individual does not meet eligibility requirements for assistance, they must pay for care directly. This includes lodging, meals, and care costs, which vary significantly by region and facility.

Find a Rehab & Skilled Nursing Facility

- **National Facility Search:** [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- **New Jersey:** [NJ.gov/health/ltc/find-facility](https://www.nj.gov/health/ltc/find-facility)

Major Rehab & Skilled Nursing Facilities in Bergen County

Facility Name	Location	Contact
Bergen New Bridge Medical Center	Paramus	551-383-6019
Jewish Home at Rockleigh	Rockleigh	201-784-1414
Christian Health	Wyckoff	201-729-3711
The Actors' Fund Home	Englewood	201-871-8882
Emerson Health & Rehab Center	Emerson	201-265-3700
Maple Glen Center	Fair Lawn	201-797-9522
Oakland Rehabilitation & Healthcare Center	Oakland	201-337-3300

**For details check directly on [Medicare.gov Care Compare](#)*

References

- [Medicare.gov: SNF Care](#)
- [Medicare.gov: IRF Care](#)
- [Medicare.gov: SNF Care Costs and Coverage \(PDF\)](#)
- [Medicare.gov Care Compare: Find and Compare Nearby Rehab Facilities](#)
- [CMS.gov — Skilled Nursing Facility Services](#)
- [Medicare.gov: 2026 Medicare Costs Summary Fact Sheet \(PDF\)](#)
- [Bergen County Key Services Guide \(Includes List of Rehab Facilities\) \(PDF\)](#)
- [Medicare.gov: Compare Medigap Plan](#)

PART I • SECTION 8

Hospital Care

병원 케어 (Hospital Care)

Navigating acute hospital and medical services: ambulance services, emergency room care, observation care status vs. inpatient admission, inpatient rehabilitation, medical home care, community healthcare, and bereavement support.

This section contains 9 comprehensive guides

Ambulance Services

This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Ambulance services provide emergency transportation to a hospital or skilled nursing facility when a patient's health condition is in serious danger and safe transportation by other means is not possible. This service ensures that individuals receive immediate medical attention and stabilization while en route to a healthcare facility.

Emergency Medical Condition Definition

An **Emergency Medical Condition** is defined as "An illness, injury, symptom or condition so serious that a reasonable person would seek care right away to avoid severe harm." (healthcare.gov). This is determined based on the **Prudent Layperson Standard**, meaning a situation that any person with average health knowledge would reasonably consider an emergency.

Specifically, **ambulance services** are reserved for life-threatening or severe conditions—such as chest pain or difficulty breathing—where the patient's state makes it unsafe to transport them by a standard vehicle.

Coverage & Benefits

Medicare Part B

- **Coverage:** Covers ambulance costs when the service is medically necessary.
- **Limited Coverage for Non-Emergency Transport:** Medicare may provide limited coverage for non-emergency ambulance transportation if a doctor provides a written order stating it is medically necessary (e.g., for End-Stage Renal Disease patients requiring dialysis transport).
 - If non-emergency transport occurs multiple times within 30 days, prior authorization from Medicare may be required starting with the 4th trip.
- **Facility Limits:** Medicare only covers transportation to the nearest appropriate facility capable of providing required care. If a patient requests transportation to a more distant facility, they must pay the additional costs.
- **Air Transportation:** Emergency transportation by airplane or helicopter is covered only if the location is inaccessible by ground or if medical obstacles, such as long distances or heavy traffic, prevent rapid access to care.

- **Patient Cost:** After meeting the deductible, the patient is responsible for 20% of the Medicare-approved amount. The Part B coinsurance may be covered through a [Medigap](#) plan.

Medicare Advantage (Part C)

- **Coverage:** Like Original Medicare, Medicare Advantage covers ground and air ambulance services when medically necessary in an emergency.
- **Non-Emergency Transport:** Coverage requires a physician's order and prior authorization from the insurer. Some plans may also include a Non-Emergency Medical Transportation (NEMT) benefit for routine medical appointments.
- **Facility Limits:** Coverage is limited to the nearest appropriate facility. Using an out-of-network provider or a more distant facility may result in higher out-of-pocket costs.
- **Air Transportation:** Covered only when ground transport is not feasible or when a delay would put the patient's life at risk. Higher cost-sharing may apply compared to ground ambulance.
- **Patient Cost:** Plans often charge a fixed copay instead of the 20% coinsurance, and costs count toward the plan's annual out-of-pocket maximum.

Medicaid (NJ FamilyCare)

- **Coverage:** Ground and air ambulance services are covered when immediate medical help is required. Prior authorization is not required for emergency transport.
- **Non-Emergency Medical Transportation (NEMT):** NEMT is available for individuals who lack a working vehicle, do not have a driver's license, or have a physical or mental disability preventing them from traveling alone. In New Jersey, NEMT is coordinated through Modivcare (phone: 1-866-527-9933; tripcare.modivcare.com). Rides for medical appointments must generally be scheduled at least two to three days in advance.

Private Insurance

- **Coverage:** Services are covered when immediate medical help is required.
- **In-Network vs. Out-of-Network:** Patients are responsible for paying the deductibles and co-payments as defined by their specific insurance plan. In New Jersey, Patient Cost for ambulance services in an emergency are adjusted to in-network rates even when the service is provided by an out-of-network provider. Note that in-network protections for ambulance services may vary by state.
- **Prior Authorization:** While not required for emergencies, prior authorization from the insurer may be necessary for non-emergency inter-facility transfers (e.g., moving from a hospital to a specialized rehabilitation center).

** **In-Network** refers to hospitals, physicians, and providers (including doctors, nurse practitioners, and physical therapists) who have a contracted agreement with your insurance*

plan.

* **Out-of-Network** providers do not have a contract with your insurer, which can result in significantly higher out-of-pocket costs.

Cost Sharing per Coverage Type (2026)

Insurance Type	Deductible	Coinsurance / Copayment
Medicare Part B	\$283	20% of the Medicare-approved amount
Medicaid (NJ FamilyCare)	\$0	Typically \$0 for eligible services
Medicare Advantage (Part C), Private Insurance	Varies by plan	Varies by plan; Out-of-network providers billed at In-network rates for emergencies

Hospitals and Providers Search

- National Directory: [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- New Jersey Directory: [Healthapps.nj.gov/facilities](https://healthapps.nj.gov/facilities)

Ambulance Service Providers in Bergen County

The following are non-emergency contacts. In case of an emergency, immediately call 911.

Hospital Name	Address	Phone Number	Website
Bergen New Bridge Health Emergency Medical Services	230 East Ridgewood Avenue, Paramus, NJ 07652	201-967-4000	newbridgehealth.org/emergency-care
Englewood Health Emergency Medical Services	350 Engle Street, Englewood, NJ 07631	201- 894-3000	englewoodhealth.org/emergency-services
Hackensack Meridian Health-Pascack Valley Emergency Medical Services	250 Old Hook Road, Westwood, NJ 07675	201- 383-1035	pascackmedicalcenter.com/emergency-care
Hackensack University Medical Center Emergency Medical Services	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-2000	hackensackmeridianhealth.org/emergency-care
Holy Name Medical Center BLS Ambulance	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org/emergencycare
The Valley Hospital EMS Fleet	4 Valley Health Plaza, Paramus, NJ 07652	201-447-8000	valleyhealth.com/emergency-services

Resources

- Medicare.gov – Ambulance Services (Medicare Part B)
- NJ FamilyCare.org
- NJ DoHS.gov – Modivcare Medical Transportation

Bereavement Care

This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Bereavement care is the process of supporting individuals through the emotional and physical grief that follows a loss. Through professional grief counseling and therapy, bereavement care helps people navigate the pain of loss in a healthy way. While everyone's grief journey is different, recovery and a return to daily life are supported by family, community, and access to appropriate mental health resources.

Coverage & Benefits

Medicare Part A (Hospice Benefit)

- **Eligibility:** Bereavement care is included as part of the Medicare hospice benefit for those with a terminal illness (life expectancy of 6 months or less).
- **Support for Family:** Social workers, chaplains, or bereavement coordinators provide emotional and spiritual support to the family. Counseling services are available for up to **13 months** after the patient's death.
- **Patient Costs:** There are typically **\$0** out-of-pocket costs for bereavement counseling provided by a Medicare-approved hospice program.

Medicare Advantage (Part C)

- **Coverage:** Medicare Advantage plans are required to cover all services provided by Original Medicare (Parts A and B), including bereavement care under the hospice benefit.
- **Supplemental Benefits:** Some Part C plans may offer additional grief counseling or expanded family support programs through supplemental benefits.
- **Claims Processing:** Even for Part C members, hospice-related bereavement services are generally processed through Original Medicare (Part A), while the Part C plan continues to manage other supplemental services and prescription drug coverage (Part D).
- **Patient Costs:** Standard bereavement services provided through the hospice benefit generally have **\$0 out-of-pocket costs**. Costs for using a private counseling network outside of the hospice benefit will vary by plan.

Medicaid (NJ FamilyCare)

- **Hospice Care:** NJ FamilyCare covers hospice services, including bereavement support for the family, when medical necessity criteria are met.

- **Patient Costs:** For eligible recipients in New Jersey, there are generally **\$0 copayments** for hospice-related services, including bereavement counseling provided through the hospice team.
- **Palliative Care:** The Community-Based Palliative Care (CBPC) benefit provides additional support for NJ FamilyCare members with serious illnesses — a terminal diagnosis is not required. Services include symptom management, caregiver support, and psychosocial counseling. This benefit operates separately from hospice and can be used while continuing current treatment.

Private Insurance

- **Hospice Benefits:** Most private insurance plans follow Medicare guidelines for hospice care, which include bereavement services for surviving family members.
- **Mental Health Parity:** If counseling is sought outside of a hospice program, coverage is typically governed by the plan's outpatient mental health benefits. These services must be covered at a level comparable to medical and surgical benefits.
- **Continuity of Care:** After the death of a policyholder, dependents may qualify for a **60-day Special Enrollment Period** to secure new coverage (for Marketplace plans). Those on employer plans should inquire about COBRA or other available options.

Medicare Part A (Hospice Benefit)

- **Eligibility:** Bereavement care is included as part of the Medicare hospice benefit for those with a terminal illness (life expectancy of 6 months or less).
- **Support for Family:** Social workers, chaplains, or bereavement coordinators provide emotional and spiritual support to the family. Counseling services are available for up to **13 months** after the patient's death.
- **Patient Costs:** There are typically **\$0** out-of-pocket costs for bereavement counseling provided by a Medicare-approved hospice program.

Cost Sharing by Insurance Type (2026)

Insurance Type	Deductible	Coinsurance / Copayment
Medicare Part A (Hospice)	\$0 for Hospice	\$0 for Bereavement Counseling
Medicaid (NJ FamilyCare)	\$0	\$0 for covered hospice/bereavement services
Medicaid Advantage (Part C), Private Insurance	Varies by Plan	Varies by plan; Hospice services often have \$0 or low cost-sharing

Hospice and Bereavement Providers in Bergen County

The following are non-emergency contacts. In case of an emergency, immediately call 911.

Hospital/Provider Name	Address	Phone Number	Website
Family of Caring Hospice (Korean-speaking staff)	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org
Valley Hospice	15 Essex Road, Paramus, NJ 07652	201-447-8000	valleyhealth.com
Hackensack Meridian Health Hospice	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-2000	hackensackmeridianhealth.org
Ennoble Care (In-Home)	Serving Bergen County	800-548-3249	ennoblecare.com

Contact

- 988lifeline.org 988 (call/text)
- [AARP Grief and Loss Program](#): 800-687-2277
- [Vantage Health – Survivors After Suicide](#) : 201-385-4400 / info@vantagenj.org

Resources

- Medicare.gov: Hospice Care Coverage
- NJFamilyCare.org
- [SAMHSA: Grieving Resources](#)
- NJ 211.org

Community Clinics & Free Healthcare

This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

For residents without insurance or those with limited financial means, community clinics provide high-quality medical and dental care. These facilities offer services on a sliding fee scale or at no cost to ensure that every community member has access to essential healthcare.

Free and Charitable Clinics

Free and Charitable Clinics are non-profit organizations that provide medical, dental, vision, and mental health services at no cost or low cost to vulnerable and uninsured residents.

- [**Bergen Volunteer Medical Initiative \(BVMI\)**](#): A volunteer-based nonprofit community clinic providing free primary and preventive care for **working uninsured residents of Bergen County**. Services include chronic disease management, women's health, and mental health.
 - **Eligibility (all criteria must be met):**
 - Bergen County residents 19 and above
 - At least one working member in the household
 - Household income at or below 250% of the Federal Poverty Level (FPL)
 - No health insurance coverage (including Medicare or Medicaid)

**Eligibility requirements and services vary by clinic.*

Mobile Health Units

Mobile health units are medical vehicles equipped with professional equipment that bring care directly to the community. Mobile health units are especially helpful for residents who have difficulty visiting a physical office due to medical or geographical barriers.

- [**Zufall Health Mobile Medical**](#): Providing screenings, primary care, and dental services across Morris, Warren, Sussex, Hunterdon, Essex, Somerset, and Middlesex Counties.

Federally Qualified Health Centers (FQHC)

Federally Qualified Health Centers (FQHCs) are community-based healthcare organizations certified and funded by the Health Resources and Services Administration (HRSA) to provide comprehensive care to local communities.

- **[North Hudson Community Action Corporation \(NHCAC\)](#)**: Operates multiple sites in Bergen County, including Hackensack, Englewood, and Garfield. Services include adult medicine, pediatrics, dentistry, and behavioral health.
- **[Zufall Health Center](#)**: Provides affordable healthcare across multiple counties in Northern/Central NJ, specializing in primary care, dental services, and chronic condition management.
 - Eligibility (largely the same across FQHCs)
 - Open to all regardless of status
 - Uninsured individuals with incomes at or below 200% FPL are charged based on income and family size
 - Low-income patients may pay little to nothing
 - Medicare, Medicaid, and private insurance are accepted.

Hospital-Based Services & Support

Hospitals often provide outpatient community clinics, mobile health unit services, and financial assistance programs for financially disadvantaged members of the community.

Hospital-Run Community Clinics

- **Valley Health Family Care Center (Ridgewood)**: An outpatient clinic providing high-quality care to all ages regardless of insurance status. Services include primary care, pediatrics, OB/GYN, and chronic disease management. Multilingual staff available.
- **Hackensack MH Internal Medicine Academic Practice (Hackensack)**: A residency-based clinic where resident doctors provide care under specialist supervision. Offers internal medicine and preventive care with flexible fees for low-income and uninsured patients.
- **Hackensack MH Adult Health Center (Glen Ridge)**: A community clinic located at the Mountainside Medical Center campus providing primary care and chronic disease management for uninsured adults.

[Charity Care \(Hospital Financial Assistance\)](#)

Charity Care is a medical bill reduction program provided by state-designated acute care hospitals and university hospitals for low-income individuals who are uninsured or underinsured. Please note that Charity Care is not health insurance.

Community Clinics & Free Healthcare Search

- National Charitable Clinics Search: NAFCclinics.org/find-clinic
- FQHC Search: HRSA.gov/Find a Health Center
- NJ Free/Low Cost Services: NJ.gov/Free or Low Cost Medical Treatment
- NJ Community Health Search: <https://healthapps.nj.gov/fhs>

Community Clinics in Northern New Jersey

The following are non-emergency contacts. In case of an emergency, immediately call 911.

Clinic	Clinic Type	Address	Phone	Website
Bergen Volunteer Medical Initiative (BVMI)	Free and Charitable Clinic	75 Essex Street, Suite 100 Hackensack, NJ 07601	201-342- 2478	bvmi.org
NHCAC Health Center - Englewood	FQHC	197 South Van Brunt Street Englewood, NJ 07631	201-210- 0200 (Main Number)	nhcac.org
NHCAC Health Center - Hackensack	FQHC	25 East Salem Street Hackensack, NJ 07055	201-210- 0200 (Main Number)	nhcac.org
NHCAC Health Center - Garfield	FQHC	535 Midland Ave Garfield, NJ 07026	201-210- 0200 (Main Number)	nhcac.org
NHCAC Health Center - Passaic	FQHC	220 Passaic Street Passaic, NJ 07055	201-210- 0200 (Main Number)	ennoblecare.com
NHCAC Health Center - West New York (Main Site)	FQHC	5301 Broadway West New York, NJ 07093	201-210- 0200 (Main Number)	ennoblecare.com
Zufall Health Center - Morristown	FQHC	4 Atno Ave Morristown, NJ 07960	973-267- 0002	zufallhealth.org
Zufall Health Center - Newton	FQHC	238 Spring Street Newton, NJ 07860	973-862- 6650	zufallhealth.org
Zufall Health Center - Plainsboro	FQHC	One Plainsboro Road Plainsboro, NJ 08536	609-853- 7600	zufallhealth.org
Zufall Health Center - West Orange	FQHC	49 Mount Pleasant Ave West Orange, NJ 07052	973-325- 2266	zufallhealth.org
Zufall Health Center - Mobile Medical	FQHC Mobile Health Unit	Middlesex, Morris, Sussex, Warren, Hunterdon,	973-328- 3344	zufallhealth.org/about-us/locations/zufall-health-mobile-medical/

Clinic	Clinic Type	Address	Phone	Website
		Somerset, and Essex Counties		
Valley Health Family Care Center	Hospital-Run Community Clinic	223 N. Van Dien Ave Ridgewood, NJ 07450	201-689-3900	valleyhealth.com/services/family-care-center
Hackensack MH Internal Medicine Academic Practice	Hospital-Run Community Clinic	385 Prospect Ave Suite 204 Hackensack, NJ 07061	551-996-9150	getcare.hackensackmeridianhealth.org/en/locations/hmh-internal-medicine-academic-practice-hackensack
Hackensack MH Mountainside Medical Center - Adult Health Center	Hospital-Run Community Clinic	123 Highland Ave. Suite 201 Glen Ridge, NJ 07028	862-333-4700	mountainsidemedicalcenter.com/services/adult-health-center

Resources

- HRSA.gov
- nafcclinics.org
- NJ.gov – [Charity Care](#)

Emergency Room (ER) Care

This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Emergency Department services provide immediate evaluation and treatment for sudden illnesses or injuries. These services are essential when a person's health or life is at risk and requires rapid medical intervention to stabilize their condition.

Coverage & Benefits

Medicare Part B

- **Coverage:** Emergency room services are generally covered under Medicare Part B as **outpatient services**. This applies even if the patient stays in the ER overnight for observation.
- **Observation Services:** Patients may be kept in a "Clinical Decision Unit" or under "Observation Status" to determine if they need to be admitted as an inpatient. Typically, this stay does not exceed two nights.
- **Admission to Inpatient Care:** If a patient is formally admitted to the same hospital as an inpatient for the same condition within 3 days of the ER visit, the ER services are generally covered under **Medicare Part A** instead of Part B.
- **Patient Cost:** After meeting the Part B **deductible**, the patient is responsible for 20% of the Medicare-approved amount for the doctor's services(**coinsurance**) and a **copayment** for each hospital outpatient department visit.

Medicaid (NJ FamilyCare)

- **Coverage:** Medicaid covers emergency room visits when a medical need is immediate. For eligible recipients, emergency services are a mandatory benefit.
- **Cost Sharing:** In New Jersey, Medicaid recipients typically have **\$0** copayments for emergency room services that meet the medical necessity criteria.
- **Prior Authorization:** No prior authorization is required for emergency department services.

Private Insurance

- **Coverage:** Most private plans cover ER visits based on the prudent layperson standard.
- **In-Network vs. Out-of-Network:** Under the federal No Surprise Act and New Jersey's Consumer Protection Act, emergency services and subsequent observation care costs for patients are In-Network rates even if the facility or provider is out-of-network.

- **Admission Notice:** While the initial ER visit does not require pre-approval, the hospital must notify the insurer if the patient is subsequently admitted to the hospital.

* **In-Network** refers to hospitals, physicians, and providers (including doctors, nurse practitioners, and physical therapists) who have a contracted agreement with your insurance plan.

* **Out-of-Network** providers do not have a contract with your insurer, which can result in significantly higher out-of-pocket costs.

Cost Sharing by Insurance Type (2026)

Insurance Type	Deductible	Coinsurance / Copayment
Medicare Part B	\$283	20% of the Medicare-approved amount + Hospital Copayment
Medicaid (NJ FamilyCare)	\$0	Typically \$0 for eligible services
Medicare Advantage (Part C), Private Insurance	Varies by plan	Varies; In-network rates apply to emergencies and observation cares

Hospitals and Providers Search

- National Directory: [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- New Jersey Directory: [Healthapps.nj.gov/facilities](https://healthapps.nj.gov/facilities)

Emergency Care Providers in Bergen County

The following are non-emergency contacts. In case of an emergency, immediately call 911.

Hospital Name	Address	Phone Number	Website
Bergen New Bridge Health Emergency Medical Services	230 East Ridgewood Avenue, Paramus, NJ 07652	201-967-4000	newbridgehealth.org/emergency-care
Englewood Health Emergency Medical Services	350 Engle Street, Englewood, NJ 07631	201- 894-3000	englewoodhealth.org/emergency-services
Hackensack Meridian Health-Pascack Valley Emergency Medical Services	250 Old Hook Road, Westwood, NJ 07675	201- 383-1035	pascackmedicalcenter.com/emergency-care
Hackensack University Medical Center Emergency Medical Services	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-2000	hackensackmeridianhealth.org/emergency-care
Holy Name Medical Center Emergency Care Center	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org/emergencycare
The Valley Hospital Clinical Decision Unit	4 Valley Health Plaza, Paramus, NJ 07652	201-447-8000	valleyhealth.com/emergency-services

Resources

- [Medicare.gov: Emergency Department Services](https://www.medicare.gov/emergency-department-services)
- [Medicare.gov – Outpatient hospital services](https://www.medicare.gov/outpatient-hospital-services)
- [NJ FamilyCare.org](http://NJFamilyCare.org)

Inpatient Admission

This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Inpatient Care refers to health care services provided to a patient who has been formally admitted to a hospital based on a doctor's order. This level of care is generally required for serious medical conditions, surgeries, or treatments that require continuous monitoring by a medical team.

Hospital Status and Admission

A person is considered an inpatient starting the moment they are formally admitted to the hospital with a physician's order. It is important to note that staying in a hospital bed overnight—even in the Emergency Room—does not automatically make someone an "inpatient."

If a patient is placed under Observation Status, they are classified as an outpatient. This distinction matters because it affects how much you pay and whether Medicare will cover follow-up care at a skilled nursing or rehabilitation facility. Time spent under observation does not count toward Medicare's required 3-consecutive-day inpatient stay for skilled nursing facility (SNF) coverage.

Coverage and Benefits

Medicare Part A (Hospital Facility Costs)

- **Coverage:** Covers semi-private rooms, meals, general nursing, drugs provided as part of inpatient treatment, and other hospital services and supplies. Private rooms and private-duty nurses are not covered.
- **Patient Cost:** Patient pays the inpatient deductible (\$1,736 in 2026) first. Part A covers the rest.
- **Benefit Period:** Benefit period begins the day you are formally admitted as an inpatient. If you are readmitted within 60 days of discharge, it counts as the same benefit period—and the same deductible applies. If readmitted after 60 days, a new benefit period begins and a new \$1,736 deductible applies. There is no limit on the number of benefit periods.
- **Lifetime Reserve Days:** If a hospital stay exceeds 90 days in a single benefit period, Medicare provides an additional 60 days of coverage over your lifetime. Once these reserve days are used up, you are responsible for the full cost of any remaining hospital days.

Medicare Part B (Physician Services)

- **Coverage:** Covers physician and surgical services received while you are an inpatient.

- **Patient Cost:** Patient pays the annual deductible (\$283 in 2026). After that, Part B generally covers 80% of physician costs, and the patient pays the remaining 20%.

**Even during an inpatient stay, physician services are billed separately under Part B and not Part A.*

Medicare Advantage (Part C)

- **Coverage:** Covers semi-private rooms, meals, general nursing, drugs provided as part of inpatient treatment, and other hospital services and supplies. Private rooms and private-duty nurses are not covered.
- **Prior Authorization:** Most Advantage plans require prior authorization (PA) from the insurer before a non-emergency inpatient admission. Skipping this step may result in reduced or denied coverage.
- **Patient Cost:** Many plans charge a set daily copayment for the first few days of a hospital stay, after which coverage is typically \$0. All costs count toward your plan's annual Maximum Out-of-Pocket limit.

**Coverage and cost vary by plan—always review your plan details.*

Medicaid (NJ FamilyCare)

- **Coverage:** Medicaid covers all medically necessary inpatient hospital services for eligible residents.
- **Patient Cost:** Medicaid recipients typically have little to no copayment for inpatient hospital stays.
- **Prior Authorization:** Some elective (non-emergency) inpatient admissions may require prior authorization from the plan or the state to confirm medical necessity.

**OBBA (One Big Beautiful Bill Act) implementations may affect eligibility and program details. Refer to the [official website](#) for the most current information.*

Private Insurance

- **Coverage:** Most private plans cover inpatient admissions, but often require prior authorization unless the admission follows an emergency.
- **In-Network vs. Out-of-Network:** Costs are significantly lower when using in-network hospitals. Out-of-network admissions may result in much higher out-of-pocket expenses or no coverage at all for elective procedures.
- **Patient Cost:** Some plans charge a per-day copayment for the first several days, while others apply a flat deductible per admission. Cost structures vary by plan—always review your plan documents.

** **In-Network** refers to hospitals, physicians, and providers (including doctors, nurse practitioners, and physical therapists) who have a contracted agreement with your insurance plan.*

** **Out-of-Network** providers do not have a contract with your insurer, which can result in significantly higher out-of-pocket costs.*

Cost Sharing by Insurance Type (2026)

Insurance Type	Deductible	Coinsurance / Copayment
Medicare Part A (Hospital Facility Costs)	\$1,736	Days 1–60: \$0 Days 61–90: \$434/day Days 91+: \$868/day (per reserve day). After reserve days: full cost
Medicare Part B (Physician Services)	\$283	20% of Medicare-approved amount
Medicaid (NJ FamilyCare)	\$0	Typically \$0 for eligible services
Medicare Advantage (Part C) Private Insurance	Varies by plan	Varies by plan ; Prior authorization may be required

Hospitals and Providers Search

- National Directory: [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- New Jersey Directory: [Healthapps.nj.gov/facilities](https://healthapps.nj.gov/facilities)

Inpatient Care Hospitals in Bergen County

The following are non-emergency contacts. In case of an emergency, immediately call 911.

Hospital Name	Address	Phone Number	Website
Bergen New Bridge Medical Center	230 East Ridgewood Avenue, Paramus, NJ 07652	201-967-4000	newbridgehealth.org
Englewood Health	350 Engle Street, Englewood, NJ 07631	201- 894-3000	englewoodhealth.org
Hackensack Meridian Health-Pascack Valley	250 Old Hook Road, Westwood, NJ 07675	201- 383-1035	pascackmedicalcenter.com
Hackensack University Medical Center	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-2000	hackensackmeridianhealth.org
Holy Name Medical Center	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org
The Valley Hospital	4 Valley Health Plaza, Paramus, NJ 07652	201-447-8000	valleyhealth.com

Resources

- Medicare.gov: Inpatient Hospital Care Coverage
- [NJ FamilyCare.org](http://NJFamilyCare.org): Benefit Overview

Inpatient Rehabilitation Care

This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Inpatient rehabilitation services provide intensive therapy for patients recovering from serious surgery, illness, or injury. This level of care is designed for individuals who require a coordinated team of doctors and therapists, including at least three hours of intensive therapy per day (such as physical, occupational, or speech therapy).

Coverage and Benefits

Medicare Part A

- **Qualification:** Inpatient rehabilitation is covered under Medicare Part A (Hospital Insurance) when a physician certifies that the patient requires intensive rehabilitation, ongoing medical supervision, and coordinated interdisciplinary care. Services must be provided in a specialized Rehabilitation Hospital or a dedicated inpatient rehabilitation unit of a general hospital.
- **Qualifying Stay:** For most facilities, transfer to a rehabilitation facility following a qualifying inpatient hospital stay is a standard requirement. Certain inpatient rehabilitation facilities (IRFs) may apply specific clinical criteria for admission based on the intensity of therapy needed.
- **Coverage:** Covers semi-private rooms, meals, general nursing, drugs provided as part of inpatient treatment, and other hospital services and supplies. Private rooms and private-duty nurses are not covered.
- **Duration of Care:** Medicare covers up to 100 days of care per benefit period. A benefit period begins on the day of admission. If a patient is readmitted within 60 days of discharge, it counts as the same benefit period. If readmitted after 60 days, a new benefit period begins—resetting the day count and triggering a new deductible.
- **Patient Cost:** After meeting the Part A deductible, there is \$0 coinsurance for days 1–20. Daily coinsurance applies for days 21 through 100.

Medicare Part B (Physician Services)

- **Coverage:** Covers physician and specialist services received while you are an inpatient.
- **Patient Cost:** After meeting the annual Part B deductible (\$283 in 2026), Medicare covers 80% of the approved cost for physician services, and the patient pays the remaining 20%.

**Even during an inpatient stay, physician services are billed separately under Part B and not Part A.*

Medicaid (NJ FamilyCare)

- **Coverage:** NJ FamilyCare covers inpatient rehabilitation services when they are medically necessary and prescribed by a physician. Coverage typically includes room and board, nursing care, and rehabilitative therapies.
- **Cost Sharing:** For most NJ FamilyCare beneficiaries, there is a \$0 copayment for inpatient services
- **Prior Authorization:** Most Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) in New Jersey require prior authorization from the insurance provider before admission to a rehabilitation facility.

Private Insurance

- **Coverage:** Most private health plans cover inpatient rehabilitation, but the duration and facility types depend on the specific policy.
- **In-Network vs. Out-of-Network:** Patients are protected from balance billing for certain services. However, for non-emergency inpatient rehab, using in-network facilities is essential to minimize out-of-pocket costs.
- **Clinical Review:** Private insurers often require concurrent review—periodically checking the patient's progress to determine whether continued inpatient care remains medically necessary.

Cost Sharing by Insurance Type (2026)

Insurance Type	Deductible	Coinsurance / Copayment
Medicare Part A (Hospital Facility Costs)	\$1,736	Days 1–60: \$0 Days 61–90: \$434/day Days 91+: \$868/day (per reserve day). After reserve days: full cost
Medicare Part B (Physician Services)	\$283	20% of Medicare-approved amount
Medicaid (NJ FamilyCare)	\$0	Typically \$0 for eligible services
Medicare Advantage (Part C) Private Insurance	Varies by Plan	Varies by plan ; Prior authorization may be required

Rehabilitation Facilities Search

- **National Directory:** [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- **New Jersey Directory:** [Healthapps.nj.gov/facilities](https://healthapps.nj.gov/facilities)

Inpatient Rehabilitation Providers in Bergen County

The following are non-emergency contacts. In case of an emergency, immediately call 911.

Hospital Name	Address	Phone Number	Website
Allendale Rehabilitation & Healthcare Center	85 Harreton Rd, Allendale, NJ 07401	201-825-0660	allendalehc.com
Christian Health (Bolger Short-Term Rehab)	301 Sicomac Ave, Wyckoff, NJ 07481	201-848-5200	christianhealthnj.org
Encompass Health Rehabilitation Hospital	250 Old Hook Road, Westwood, NJ 07675	201-358-5800	encompasshealth.com
Hackensack University Medical Center - Rehab Unit	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-5555	hackensackmeridianhealth.org
Holy Name Medical Center - Rehab Unit	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org
Kessler Institute for Rehabilitation	300 Market St, Saddle Brook, NJ 07663	201-368-6000	kessler-rehab.com

Resources

- [Medicare.gov: Inpatient Rehabilitation Care](https://www.medicare.gov/inpatient-rehabilitation-care)
- [NJ FamilyCare: Member Benefits Overview](https://www.njfamilycare.org/member-benefits-overview)
- [Medicare.gov: Official Medicare Booklet: Medicare & You 2026](https://www.medicare.gov/publications/official-medicare-booklet-medicare-you-2026)

Medical Home Care

This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Medical home care brings professional medical services directly to patients in the comfort of their own home without the need for a hospital stay or nursing facility. It allows people recovering from illness or injury to maintain their independence and daily routines while still receiving skilled care from nurses and therapists.

Medical home care is provided through Medicare and/or Medicaid-certified Home Health Agencies (HHAs), under a physician's orders. Services may include hospital-based home care programs, visiting nurse services, physical, occupational, and speech therapy, and medical social services.

For day-to-day assistance such as bathing, meal preparation, or light housekeeping, please visit our [Home Care](#) page.

Coverage and Benefits

Original Medicare (Part A & B)

- **Eligibility:** Original Medicare covers home health care for patients who are homebound. A doctor or nurse practitioner must conduct a face-to-face evaluation to certify the need for home care. This evaluation must occur within 90 days before or 30 days after care begins. Brief, infrequent absences, such as attending a religious service or a medical appointment, are permitted.
- **Coverage:** Costs may be covered under Medicare Part A (Hospital Insurance) or Part B (Physician Insurance).
- **Prior Hospitalization:** Both Part A and Part B can cover home health care. A prior hospital stay is not required if the homebound requirement and physician's order are met, Part B can provide coverage. Part A may apply following a hospitalization or a Skilled Nursing Facility (SNF) stay.
- **Coverage Scope and Limitations:**
 - **Skilled Nursing & Rehab Services:** Covered for as long as care is medically necessary and the patient remain homebound (physician re-certification required every 60 days; no visit limit).
 - **Home Health Care:** Covered without a time limit, as long as it is medically necessary (physician re-certification required every 60 days). Typically limited to up to 8 hours per day and 28 hours per week; may be temporarily expanded to up to 35 hours per week (under 8 hours/day) when medically needed.

- **Not Covered:** 24-hour around-the-clock care, meal delivery, housekeeping (cleaning, laundry), shopping, and other non-medical custodial services.
- **Patient Costs:** There is no copay for approved home health services. If durable medical equipment (DME, wheelchair or walker) is included, a 20% coinsurance applies under Part B.

Medicare Advantage (Part C)

- **Coverage:** Includes all standard Original Medicare benefits, and some plans may offer additional support beyond what Original Medicare covers.
- **Extra Benefits:** Some plans provide additional services not covered by Original Medicare, such as transportation to medical appointments or limited in-home assistance.
- **In-Network vs. Out-of-Network:** Benefits apply when using home care providers that are in-network with your plan. Using out-of-network providers may result in significantly higher out-of-pocket costs, or no coverage at all, depending on the plan.

** **In-Network** refers to hospitals, physicians, and providers (including doctors, nurse practitioners, and physical therapists) who have a contracted agreement with your insurance plan.*

** **Out-of-Network** providers do not have a contract with your insurer, which can result in significantly higher out-of-pocket costs.*

**Most Medicare Advantage plans require prior authorization before home care services begin. Contact your plan ahead.*

Long-Term Care Medicaid (MLTSS)

- **Eligibility:** MLTSS is available to Medicaid recipients who require nursing home-level care (assistance with 3 or more Activities of Daily Living) and meet income and asset requirements. For those who have both Medicare and Medicaid (**dual eligibles**), Medicare generally covers skilled home health care, while MLTSS covers long-term personal care services.
- **Patient Costs:** For those who qualify, services are typically provided at no cost to the patient.

**For details visit our [MLTSS](#) Page.*

Private Insurance

- **Coverage:** Coverage scope and duration vary by plan. Review your policy or contact your insurer before receiving services.
- **Prior Authorization:** Most private insurers require prior authorization before services begin.

Cost Sharing by Insurance Type (2026)

Insurance Type	Deductible	Coinsurance / Copayment
Original Medicare (Part A & B)	\$0 for approved services)	\$0; 20% coinsurance for DME after Part B deductible of \$283 is met
Long Term Care Medicaid (MLTSS)	\$0	\$0
Private Insurance	Varies by Plan	Varies by plan; Prior authorization may be required

Medical Home Care Agency Search

- [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- [NJ.gov Official NJ Home Care License Lookup](https://www.nj.gov/office-of-the-attorney-general/divisions/health-care-licensing/)
- [NJ Home Care Accreditation Council Registry \(cahcusa\)](https://www.cahcusa.org/)
- [National Alliance of Care at Home Provider Directory](https://www.nationalallianceofcareathome.org/provider-directory/)

Skilled Nursing Providers in Bergen County

The following are non-emergency contacts. In case of an emergency, immediately call 911.

Agency	Phone Number	Website
Adoration Home Health	973-365-5200	adorationhealth.com/location/adoration-home-health-clifton-new-jersey
Amedisys Home Health and Hospice Services	201-342-6311	locations.amedisys.com/nj
Ascend Home Health	201-358-2666	ascendhealth.com
Holy Name Home Care	201-833-3740	holyname.org/forseniors/home-health-care
VNA of Englewood	201-894-3333	allianceforcareathome.org/nahc_provider/vna-of-englewood-home-health-hospice
Hackensack MH Home Health Care/Visiting Health Services NJ	1-844-777-0711	hackensackmeridianhealth.org/en/services/home-health-care-service
Valley Home Care	201-291-6000	valleyhealth.com/homecare

Resources

- Medicare.gov: Home Health Services
- Medicare.gov: What's not covered by Part A & Part B?
- NJ.gov MLTSS

Observation Care

This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Observation care is a hospital-based outpatient service that includes short-term monitoring, assessment, and treatment, provided to determine whether a patient requires formal inpatient admission or can be safely discharged.

Observation Status Definition

- **Duration:** Observation care is a short-term service. The decision on whether formal inpatient admission is needed is typically made within 24 to 48 hours.
- **Transition to Inpatient:** If the medical condition worsens or requires long-term care, the status may convert to formal inpatient admission.
- **Impact on Follow-up:** Time spent in observation status does not count toward the 3-consecutive-day inpatient stay requirement for Medicare coverage of skilled nursing facility (SNF) or rehabilitation facility care.

Coverage & Benefits

Medicare Part B

- **Coverage:** Observation care is classified as an outpatient service and is covered under Medicare Part B.
 - **Medicare Outpatient Observation Notice:** Hospitals are required to provide a formal notice to Medicare beneficiaries who have been in observation status for more than 24 hours, informing them that they are being treated as an outpatient.
- **Patient Cost:** After meeting the Part B deductible (\$283 in 2026), patients are responsible for 20% coinsurance for each of the following: the ER visit copayment, ancillary emergency services (such as X-rays, CT scans, and EKGs), and physician services based on the Medicare-approved amount. Part B coinsurance may be covered through a Medigap plan.
- **Prescription Drug Coverage:** Prescription drugs taken during an ER visit or observation stay — including your regular medications — are not covered under Medicare Part B. They are covered under your **Part D plan**. If the hospital pharmacy is out-of-network for your Part D plan, you may need to pay the full cost upfront and then submit a claim for reimbursement.

** Copayments for ancillary emergency services will not exceed the Part A inpatient deductible (\$1,736*

in 2026) per service. However, receiving multiple services simultaneously may lead to the combined copayment amounts exceeding this limit.

** Original Medicare (Part A and Part B) generally does not cover emergency services received outside the United States, with limited exceptions.*

Medicare Advantage (Part C)

- **Coverage:** Observation care is classified as an outpatient service under Medicare Advantage as well.
 - **Medicare Outpatient Observation Notice:** Hospitals are required to provide a formal notice to Medicare Advantage beneficiaries in observation status.
- **Skilled Nursing Facility Eligibility:** Time spent in observation status does not count toward the 3-day inpatient stay requirement for SNF benefits. However, many Medicare Advantage plans waive this 3-day requirement. Check your healthcare plan for details.
- **Patient Cost:** Outpatient copayments apply instead of an inpatient deductible. Separate copayments may apply for individual services such as tests or medications, but the copayment for any single service typically does not exceed the inpatient deductible.

**Coverage and cost vary by plan—always review your plan details.*

Medicaid (NJ FamilyCare)

- **Coverage:** NJ FamilyCare covers observation care when it is determined to be medically necessary to evaluate a patient's condition.
- **Patient Cost:** For most eligible NJ FamilyCare members, there is little to no copayment for observation care provided at a participating hospital.
- **Prior Authorization:** Emergency observation typically does not require upfront approval, but the facility must follow standard notification protocols.

Private Insurance

- **Coverage:** Most private insurance plans cover observation care as an outpatient service.
- **In-Network vs. Out-of-Network:** Under the federal No Surprise Act and New Jersey's Consumer Protection Act, patients in New Jersey receive in-network rates for observation care even if the facility is out-of-network.

** **In-Network** refers to hospitals, physicians, and providers (including doctors, nurse practitioners, and physical therapists) who have a contracted agreement with your insurance plan.*

** **Out-of-Network** providers do not have a contract with your insurer, which can result in significantly higher out-of-pocket costs.*

Cost Sharing by Insurance Type (2026)

Insurance Type	Annual Deductible	Coinsurance / Copayment
Medicare Part B	\$283	Observation care copay + 20% coinsurance for physician services and each individual service
Medicaid (NJ FamilyCare)	\$0	Typically \$0 for eligible services
Medicare Advantage (Part C), Private Insurance	Varies by plan	Varies by plan ; In-network rates apply to emergencies and observation cares

Hospitals and Providers Search

- National Directory: [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- New Jersey Directory: [Healthapps.nj.gov/facilities](https://healthapps.nj.gov/facilities)

Observation Care (Emergency Room) Providers in Bergen County

The following are non-emergency contacts. In case of an emergency, immediately call 911.

Hospital Name	Address	Phone Number	Website
Bergen New Bridge Health Emergency Medical Services	230 East Ridgewood Avenue, Paramus, NJ 07652	201-967-4000	newbridgehealth.org/emergency-care
Englewood Health Emergency Medical Services	350 Engle Street, Englewood, NJ 07631	201- 894-3000	englewoodhealth.org/emergency-services
Hackensack Meridian Health-Pascack Valley Emergency Medical Services	250 Old Hook Road, Westwood, NJ 07675	201- 383-1035	pascackmedicalcenter.com/emergency-care
Hackensack University Medical Center Emergency Medical Services	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-2000	hackensackmeridianhealth.org/emergency-care
Holy Name Medical Center Emergency Care Center	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org/emergencycare
The Valley Hospital Clinical Decision Unit	4 Valley Health Plaza, Paramus, NJ 07652	201-447-8000	valleyhealth.com/emergency-services

Resources

- [Medicare.gov: Inpatient vs. Outpatient Status and Costs](https://www.medicare.gov/inpatient-vs-outpatient-status-and-costs)
- [Medicare.gov – Outpatient hospital services](https://www.medicare.gov/outpatient-hospital-services)
- [NJFamilyCare.org: Benefits and Covered Services](https://www.njfamilycare.org/benefits-and-covered-services)

Treatment

This content is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a healthcare professional. In case of an emergency, immediately call 911.

Treatment, usually chronic pain management, involves medical care and services designed to manage persistent or recurring pain lasting longer than 3 months. These services aim to improve a patient's quality of life through a coordinated care plan that includes assessment, treatment planning, and ongoing management.

Coverage and Benefits

Medicare Part A (Hospital Facility Costs)

- **Coverage:** Covers semi-private rooms, meals, general nursing, drugs provided as part of inpatient treatment, and other hospital services and supplies. Private rooms and private-duty nurses are not covered.
- **Patient Cost:** Patient pays the inpatient deductible (\$1,736 in 2026) first. Part A covers the rest.
- **Benefit Period:** Benefit period begins the day you are formally admitted as an inpatient. If you are readmitted within 60 days of discharge, it counts as the same benefit period—and the same deductible applies. If readmitted after 60 days, a new benefit period begins and a new \$1,736 deductible applies. There is no limit on the number of benefit periods.
- **Lifetime Reserve Days:** If a hospital stay exceeds 90 days in a single benefit period, Medicare provides an additional 60 days of coverage over your lifetime. Once these reserve days are used up, you are responsible for the full cost of any remaining hospital days.

Medicare Part B (Physician Services)

- **Coverage:** Outpatient chronic pain management (CPM) services are covered under Medicare Part B. This includes diagnosis, pain rating scale administration, medication management, and care coordination.
- **Integrated Services:** Coverage extends to physical therapy, occupational therapy, and acupuncture (specifically for chronic low back pain) when performed by Medicare-enrolled providers.
- **Patient Cost:** After meeting the annual Part B deductible, patients are responsible for 20% of the Medicare-approved amount. If services are received in a hospital outpatient clinic, an additional copayment to the hospital may apply.

Medicare Advantage (Part C)

- **Coverage:** Plans cover integrated pain management services that are medically necessary for patients with chronic pain lasting 3 months or longer.
- **Covered Services:** Includes pain assessment, medication management (both opioid and non-opioid), physical therapy, behavioral health counseling, and individualized care planning.
- **Prior Authorization & Limits:** Procedures such as epidural injections or nerve blocks, as well as opioid prescriptions, may require prior authorization. Physical therapy and certain other services may have annual visit limits.
- **Integrated Care Approach:** Plans are encouraged to go beyond prescriptions alone — specialists and therapists work together under a coordinated care plan to help restore function and improve quality of life.
- **Patient Cost:** Copays vary by service type. All costs count toward the plan's annual maximum out-of-pocket limit.

**Coverage and cost vary by plan—always review your plan details.*

Medicaid (NJ FamilyCare)

- **Coverage:** NJ FamilyCare covers all medically necessary treatment, including specialist visits, surgery, physical therapy, occupational therapy, and pain management services.
- **Patient Cost:** Most eligible recipients pay \$0 for covered services. Adults at or below 138% of the Federal Poverty Level (FPL) have no out-of-pocket costs. Only CHIP enrollees may have a small copay.
- **Prior Authorization:** Some specialized treatments or long-term therapy may require prior authorization from the managed care organization (MMO).

**OBBA (One Big Beautiful Bill Act) implementations may affect eligibility and program details. Refer to the [official website](#) for the most current information.*

Private Insurance

- **Coverage:** Most private plans cover chronic pain treatments including injections, physical therapy, and behavioral health services when they are medically necessary.
- **Medical Necessity:** Insurers typically require detailed documentation from a physician showing that conservative treatments such as medication or exercise were tried first.
- **New Jersey Regulations:** Under New Jersey law, providers must enter into a formal **pain management agreement** with the patient when prescribing certain medications for chronic pain, and the treatment plan must be reviewed every 3 months.
- **In-Network vs. Out-of-Network:** Costs are significantly lower when using in-network hospitals. Out-of-network admissions may result in much higher out-of-pocket expenses or no coverage at all for elective procedures.

* **In-Network** refers to hospitals, physicians, and providers (including doctors, nurse practitioners, and physical therapists) who have a contracted agreement with your insurance plan.

* **Out-of-Network** providers do not have a contract with your insurer, which can result in significantly higher out-of-pocket costs.

Cost Sharing by Insurance Type (2026)

The following are non-emergency contacts. In case of an emergency, immediately call 911.

Insurance Type	Deductible	Coinsurance / Copayment
Medicare Part A (Hospital Facility Costs)	\$1,736	Days 1–60: \$0 Days 61–90: \$434/day Days 91+: \$868/day (per reserve day). After reserve days: full cost
Medicare Part B (Physician Services)	\$283	20% of Medicare-approved amount
Medicaid (NJ FamilyCare)	\$0	Typically \$0 for eligible services
Medicare Advantage (Part C) Private Insurance	Varies by Plan	Varies by plan ; Prior authorization may be required

* **In-Network**: Healthcare facilities and providers (physicians, nurse practitioners, physical therapists, etc.) that have a contract with your insurance company.

* **Out-of-Network** providers do not have a contract with your insurer, which can result in significantly higher out-of-pocket costs.

Hospitals and Providers Search

- National Directory: [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- New Jersey Directory: [Healthapps.nj.gov/facilities](https://healthapps.nj.gov/facilities)

Major Hospitals in Bergen County

Hospital Name	Address	Phone Number	Website
Bergen New Bridge Medical Center	230 East Ridgewood Avenue, Paramus, NJ 07652	201-967-4000	newbridgehealth.org
Englewood Health	350 Engle Street, Englewood, NJ 07631	201- 894-3000	englewoodhealth.org
Hackensack Meridian Health-Pascack Valley	250 Old Hook Road, Westwood, NJ 07675	201- 383-1035	pascackmedicalcenter.com
Hackensack University Medical Center	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-2000	hackensackmeridianhealth.org
Holy Name Medical Center	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org
The Valley Hospital	4 Valley Health Plaza, Paramus, NJ 07652	201-447-8000	valleyhealth.com

Resources

- [Medicare.gov: Chronic Pain Management & Treatment Services](https://www.medicare.gov/chronic-pain-management)
- [Medicare.gov: Pain Management Coverage](https://www.medicare.gov/pain-management-coverage)
- [NJ FamilyCare.org](http://NJFamilyCare.org)

PART I • SECTION 9

Housing

주거·주택 (Housing)

Senior and affordable housing options: Senior Apartments (Section 202/HUD), Section 8 Housing Choice Vouchers, Affordable Housing (LIHTC), Retirement Communities, Continuing Care Retirement Communities (CCRC), Residential Health Care Facilities, Assisted Living, Reverse Mortgages, and NJ Property Tax Relief (Senior Freeze, ANCHOR, Stay NJ).

This section contains 12 comprehensive guides

Affordable Housing (LIHTC)

The Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) program is a program in which the federal government provides tax credits to private developers, who then sell these credits to investors to construct and operate affordable rental housing. Unlike general public housing, it operates under a fixed rent system tailored to the "local income level."

Eligibility

- **Income Limit:** Most LIHTC developments use a criteria of 50% or 60% of the AMI or less, though some developments may allow up to 80% by applying the Average Income Test (AIT).
- **Asset Screening:** Earnings from assets such as bank balances, stocks, and real estate (interest, dividends, etc.) are included in annual income and can affect the income eligibility review.
- **Direct Application:** Applications must be submitted individually through each apartment management office or the development's Administrative Agent, and checking the Waiting List is essential.

Rent Determination Principle

Rent for affordable housing is predetermined based on the Area Median Income (AMI) of the region, rather than individual income.

- **Fixed Amount:** Rent is set at a level that cannot exceed 30% of the income corresponding to that specific AMI percentage.
- **Minimum Income Requirement:** Since government subsidies are not paid monthly to the landlord, tenants must prove they have a minimum income sufficient to pay the fixed rent.
- **Rent Adjustment:** Rents may increase based on changes to HUD MTSP (Multifamily Tax Subsidy Projects) limits. However, this may vary depending on the policies of each individual housing development.

New Jersey (Region 1) Income Limits (2025)

Applicable Areas: Bergen, Hudson, Passaic, and Sussex Counties.

To qualify for affordable housing, the annual Gross Income based on household size must be below the following amounts:

Household Size	30% AMI (Very Low)	50% AMI (Low)	60% AMI (Typical LIHTC)	80% AMI (Moderate)
1 Person	\$26,730	\$44,550	\$53,460	\$71,280
2 Persons	\$30,540	\$50,900	\$61,080	\$81,440
3 Persons	\$34,350	\$57,250	\$68,700	\$91,600
4 Persons	\$38,160	\$63,600	\$76,320	\$101,760
5 Persons	\$41,220	\$68,700	\$82,440	\$109,920

Source: HUD FY2025 MTSP Income Limits (huduser.gov/portal/datasets/mtsp.html)

Minimum Income

In addition to the maximum limits set by the government (table above), leasing offices usually require a monthly income of approximately 2.5 times the rent to verify the ability to pay.

New Jersey (Region 1) Estimated Rent

Actual rent may vary depending on whether utilities are included, but the general guidelines are as follows:

- 1 Bedroom (at 50% AMI): Approx. \$1,100 – \$1,200
- 2 Bedroom (at 50% AMI): Approx. \$1,350 – \$1,500
- 3 Bedroom (at 50% AMI): Approx. \$1,550 – \$1,750

Recertification

Even after moving in, you must report changes in household income and composition to the management office annually.

- **140% Rule (Tenant Protection):** Even if your income has increased since the time of move-in, you can continue to reside in the unit as long as it does not exceed 140% of the currently applicable income limit (based on AMI) during recertification.
- **Exceeding the Limit:** Even if your income exceeds 140%, you will not be evicted immediately. However, if your income exceeds 140%, the next available unit in the building will be assigned to a qualifying low-income household, and the rent for your current unit will remain the same.

Household Composition Regulations

- **Adding Members:** The income of any new adult entering the household will be combined for a new eligibility screening. Living together without approval is a lease violation and grounds for eviction.

- **Reducing Members:** If family members move out and the number of occupants becomes too small for the unit size, you may be requested to transfer according to the building's policy (this varies by development).
- **Student Household Restriction:** Eligibility may be restricted if the entire household consists only of "full-time students." (Exceptions exist for single parents, welfare recipients, etc.).

Application and Search

- [NJHRC](#) (NJ Housing Resource Center)
- [Affordable Homes New Jersey \(CGP&H\)](#)
- [Piazza & Associates](#)
- AWCA provides counseling free of charge. (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ.gov – New Jersey Department of Community Affairs \(NJDC\)](#)
- [NJ.gov – New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency \(NJHMFA\)](#)
- [Fair Share Housing Center: Non-Profit Organizations for Tenant Rights Protection](#)

ANCHOR(Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters)

ANCHOR is a property tax relief program implemented annually to alleviate the property tax burden on New Jersey residents. Benefits are determined based on residency status, income, and age for the corresponding year.

Eligibility

The ANCHOR program is available to those who owned or rented a home in New Jersey as of a specific date (usually October 1st) set by the State.

Homeowners

- **Qualification:** Residents who owned and occupied a home in New Jersey as of the base date and paid property taxes.
- **Benefit Amount:**
 - Annual income of \$150,000 or less: \$1,500 (Age 65+ receives \$1,750)
 - Annual income between \$150,001 and \$250,000: \$1,000 (Age 65+ receives \$1,250)

Renters

- **Qualification:** Residents who resided in and paid rent for a rental property in New Jersey (subject to local property taxes) as of the base date. However, tenants of government-owned, tax-exempt housing, or tax-exempt buildings owned by non-profit organizations are excluded.
- **Benefit:**
 - Annual income of \$150,000 or less: \$450 (Age 65+ receives \$700)
 - Renters with an income exceeding \$150,000 are generally excluded from benefits.

*Even if you do not have a Social Security Number (SSN), you may apply if you are a New Jersey resident and possess an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN).

How to Apply

- **General Applicants (Under age 65)**

- For most eligible applicants (under age 65 and non-disabled), the state government will automatically process the application.
 - If there are no changes to the information on the confirmation letter, the application is filed automatically without any further action required. You should only apply manually, either online or by mail, if you need to correct information or if you did not receive a confirmation letter.
- **Seniors and Disability Benefit Recipients** (Individuals aged 65 or older, or recipients of Social Security Disability Insurance (SSDI) or Railroad Retirement Disability benefits)
 - The government does not automatically submit the application for you. You must apply manually each year, either online or by mail, using the [PAS-1 integrated application](#).
 - Through the integrated application, you can have your eligibility for ANCHOR, Senior Freeze (PTR), and Stay NJ benefits reviewed all at once, ensuring you receive all applicable benefits without omission.
- **Deadline:** Generally, the application closes between late October and early November each year.
- **Documents to Prepare**
 - Social Security Number (SSN) or ITIN.
 - New Jersey Gross Income information for the designated base year.
 - For homeowners: Block and Lot numbers from your property tax bill.

Key Considerations

- Social Security benefits are not included in New Jersey Gross Income; please ensure your income excluding Social Security is within the limits.
- If a property is jointly owned or if multiple people are registered as renters (e.g., spouses), the combined income must not exceed the limit.
- Choosing Direct Deposit when applying online allows you to receive your refund faster than a paper check.

Contact

- ANCHOR Dedicated Hotline: 1-888-238-1233/609-826-4282
- Text Telephone (for hearing impaired): 1-800-285-3036
- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ Division of Taxation – ANCHOR Portal](#)
- [PAS-1 integrated application](#)

Assisted Living

Assisted Living is a form of housing for those who need a certain level of help with daily activities but generally require routine care rather than 24-hour intensive medical nursing. The core concept is to receive support for a safe and dignified life through 24-hour on-site staff while respecting individual independence to the fullest extent.

Services and Features

- **Personalized Care (ADLs):** Provides support for Activities of Daily Living, such as bathing, dressing, mobility, and personal hygiene, tailored to individual needs.
- **24-Hour Safety Management:** Every unit is equipped with an emergency call system, and professional staff are on-site 24/7 to respond immediately to emergencies.
- **Health and Medication Management:** A system is in place where nurses (RN/LPN) are reachable 24 hours a day, and depending on the facility, full-time nurses may be stationed on-site. They provide medication management and basic health monitoring.
- **Quality Dining:** Provides balanced meals designed by nutritionists in a dining hall, with customized menus available for those requiring special diets.
- **Enriching Social Programs:** Offers various programs such as fitness, arts, outdoor excursions, and educational lectures to promote cognitive function and emotional vitality.

Eligibility

- **Age:** Under NJ state statutes, there is no specific age requirement, and each facility sets its own admission criteria.
- **Health Status:**
 - Suitable for those who are ambulatory or can move with the use of assistive devices, though individual consultation with the facility is required depending on their condition.
 - It may not be appropriate for those requiring 24-hour intensive nursing supervision or those who are medically unstable; in such cases, a transition to a Long-term Care Facility may be necessary.
- **Cognitive State:** A level of cognitive health that does not pose a threat to others and allows for communal living is required. (For those with progressing dementia, admission to an on-site 'Memory Care' section is available.)
- **Financial Support:** In New Jersey, Long Term Care Medicaid (MLTSS) provides partial coverage for Assisted Living care costs for eligible low-income seniors. However, it is important to note that Room & Board costs are generally not included and must be paid by the resident.

*Eligibility requirements must be verified directly with the facility prior to moving in.

Considerations When Choosing

- **Care Levels (Tiered Costs):** It is important to verify how additional costs are applied based on the level of service required beyond the base fee.
- **Staff-to-Resident Ratio:** Check if the number of staff members relative to residents is sufficient to ensure meticulous care.
- **Continuum of Care:** It is recommended to choose a facility that allows for a transition to Skilled Nursing services within the same community if health conditions decline.

Assisted Living Facilities in New Jersey

Town	Community Name	Features	Contact
Englewood	The Bristol at Englewood	A luxury Assisted Living facility offering gourmet dining and a diverse range of activity programs. Famous for its sophisticated programs for active seniors and exceptional dining.	201-331-9204
Wyckoff	Courtyard at Longview (Christian Health	Operated by a non-profit foundation with a history of over 100 years. It focuses on the quality of care rather than profit, and offers excellent medical connectivity as specialized medical facilities and skilled nursing facilities are operated together within the complex.	201-528-1295
Tenaflly	Brightview Tenaflly	Provides access to the high-level community infrastructure of Tenaflly. Assisted Living with a rich variety of educational and arts programs.	201-228-3135
Old Tappan	Sunrise of Old Tappan	Prioritizes personalized care and emotional bonding over large-scale facility feel. Located in a quiet, prestigious residential area.	848-317-8670
Montville	The Chelsea at Montville	A facility consistently ranked at the top of New Jersey evaluations. Renowned for its modern safety systems and systematic medication management.	973-791-9649
West Caldwell	Crane's Mill	Beyond simple Assisted Living, it provides a CCRC (Continuing Care Retirement Community) model, offering everything from independent living to Skilled Nursing within a single campus. This ensures a stable transition as health conditions change.	973-276-6700

** Facility information and service details are subject to change; please verify directly with each facility prior to moving in.*

Contact

- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ.gov DOH – Residential Health Care Facility Search](#)

- [NJ MLTSS](#)
- [NJ.gov – Assisted Living Facility Search](#)
- [NJ 211.org](#)

Continuing Care Housing

Continuing Care Housing, commonly known as CCRC (Continuing Care Retirement Community) or Life Plan Community, is a comprehensive retirement complex designed to provide a continuous spectrum of housing and care services as a resident's health status changes over time.

Residents start with Independent Living and, as they require more assistance over time, are guaranteed continuous care by transitioning within the same community through the stages of Assisted Living and Skilled Nursing Facility.

Eligibility

Continuing Care Housing typically has more stringent entry requirements than standard senior housing.

- **Age:** The standard age is generally 55 years or older, though this may vary by community.
- **Health Status**
 - Residents must be healthy enough to sustain Independent Living at the time of entry.
 - An entrance physical exam and cognitive testing are required; if a resident already requires intensive care, admission to an independent living unit may be denied.
- **Finances**
 - Proof of assets and income is required to cover the high entrance fees and monthly service fees.
 - The community conducts a strict financial review to ensure the resident can afford the costs for the duration of their life.
- **Insurance:** Many communities require enrollment in Medicare Parts A & B as well as Medigap (supplemental insurance).

**Verify directly with each individual CCRC prior to moving in.*

Financial Structure

Continuing Care Housing involves significantly high initial costs.

- **Entrance Fee:** Varies from \$50,000 to over \$1,000,000, depending on the region and unit size. The total amount depends on whether the fee is Refundable or not.
- **Monthly Service Fee:** Includes meals, housekeeping, facility access, and security; typically costs several thousand dollars per month and varies significantly depending on the community and level of care (direct verification with the community is required).

Contract Types

Contracts are generally divided into three types based on cost and the scope of services provided.

Contract Type	Name	Features
Type A	Life Care	Most expensive, but monthly fees remain largely stable even if you move to a nursing facility. (Minimizes financial risk for medical care)
Type B	Modified	Lower entrance fee. When nursing services are needed, they are provided free or at a discount for a limited period; additional costs apply thereafter.
Type C	Fee-for-Service	Lowest initial cost. However, if care services are needed, the resident must pay the full Market Rate at that time.

Pros

- Spouses can remain close within the same community even if only one person requires medical care.
- Reduces the financial and physical burden of caregiving on children.
- Predictable future healthcare costs (specifically with a Type A contract).

Cons

- Very high initial entry costs.
- Risk that the entrance fee may not be easily refundable if the community's finances are unstable.
- Requires a quick decision while still healthy, as early entry is mandatory.

Continuing Care Retirement Communities in New Jersey

Town	Community Name	Key Features	Contact
Wyckoff	The Vista	Operated by Christian Health, which is based on Christian principles. It features the most modern facilities and customized wellness systems within Bergen County.	201-689-5513
Pompton Plains	Cedar Crest	A large-scale community situated on a 130-acre site. It features its own on-site medical center and a system of dedicated medical staff.	973-834-8513
Monroe	Monroe Village	History of winning Newsweek's America's Best CCRCs. It features robust infrastructure in the Monroe area and high levels of community satisfaction.	732-521-6400
Maplewood	Winchester Gardens	Awarded U.S. News "Best Facility" for 2026. It features historic architecture and an elegant environment.	973-762-5050
East Windsor	Meadow Lakes	2025 Newsweek award winner, this community is chosen by seniors who prefer a quiet and intellectual living environment.	609-448-4100
Basking Ridge	Fellowship Village	Operates wellness and health management programs. It combines a pleasant 72-acre environment with high-quality professional nursing services.	908-498-7302

Before deciding to move in, you must review the NJ DCA's CCRC Disclosure Statement and consult with financial and legal professionals.

Contact

- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ.gov – Department of Community Affairs \(DCA\) Housing Laws](#)
- [NJ DCA CCRC Consumer Guidebook\(PDF\)](#)
- [NJ 211.org](#)

New Jersey Property Tax Relief Programs

The State of New Jersey has integrated its property tax relief application processes to reduce the tax burden on homeowners and renters. In particular, the PAS-1 Integrated Application, introduced for seniors aged 65 or older and disability benefit recipients, is the most efficient way to be evaluated for three major benefits through a single application.

Integrated Application (PAS-1) Programs

Program Name	Primary Eligibility	Benefit
Senior Freeze	Individuals aged 65 or older, or recipients of Social Security Disability or Railroad Retirement Disability benefits.	Property Tax Increase Reimbursement (Reimbursement only for the increase compared to the base year)
ANCHOR	Homeowners and Renters	Based on 2025 Tax Year • Homeowners income ≤\$150K: \$1,500 (Age 65+: \$1,750) • Homeowners income \$150K–\$250K: \$1,000 (Age 65+: \$1,250) • Renters income ≤\$150K: \$450 (Age 65+: \$700)
Stay NJ	Homeowners aged 65 or older (Disability status alone does not qualify)	50% of property taxes — paid after subtracting ANCHOR and Senior Freeze benefits. Maximum net payment limit of \$6,500 for 2025.

Key Considerations

Please note the difference in application methods. Automatic filing depends on your specific situation.

- General Homeowners/Renters under age 65 (ANCHOR only):
 - For previous beneficiaries, the state government will process the application on your behalf and send a 'Confirmation Letter.' If there are any changes to your address, bank account, or information, you must apply directly.

- Seniors aged 65+ or disability benefit recipients (SSDI/SSI, etc.):
 - The application must be renewed annually
 - Caution: Even if you only qualify for the ANCHOR benefit, if you are a senior, you must directly submit the PAS-1 integrated application online or by mail.
- Payments may be delayed if income or homeownership information does not match your NJ-1040; please verify all data against your tax return before submission.

Eligibility

- **Age Criteria:** Must be at least 65 years old by December 31 of the tax year for which you are applying.
- **Disability Recipient Criteria:** Even if you are under the age of 65, if you are receiving Social Security Disability (SSDI) from the Social Security Administration (SSA) or Railroad Retirement Disability benefits, you are eligible to apply under the same criteria as seniors.
- **Residency Requirement:** You must own or rent your primary residence in New Jersey. (For Senior Freeze, you must have resided in NJ and owned the same home for at least 3 consecutive years, including the application tax year.)

How to Apply

- **Online Filing (Recommended):** Visit propertytaxreliefapp.nj.gov.
 - **ID.me Verification:** For security, identity verification via driver's license, state-issued ID, or passport is required.
 - ANCHOR application(under 65 years of age): [ANCHOR](#)
- **Documents to Prepare:** * Social Security Number (SSN) or ITIN.
 - **ANCHOR:** NJ-1040 Line 29 Gross Income / Senior Freeze · Stay NJ: Separate income calculation form (includes non-taxable income; refer to PAS-1 instructions)
 - **PAS-1 Applicants (Age 65+):** NJ-1040 for the past two years and property tax bills (County Code, Block/Lot/Qualifier, tax amount) are required.

Resources

- [NJ Division of Taxation](#)
- [Property Tax Relief Filing](#)
- [NJ Division of Taxation – FAQ](#)

Property Tax Reimbursement (Senior Freeze)

The New Jersey Property Tax Reimbursement (PTR) program, also known as Senior Freeze, is designed for eligible seniors and individuals with disabilities to reimburse them for any property tax increases. The core of this program is to “freeze” your property taxes at the amount paid during your first year of eligibility (Base Year Amount) by refunding any taxes paid above that level.

Eligibility

- **Age and Disability:**
 - Must be 65 or older as of December 31 of the tax year.
 - Must be receiving Social Security Disability benefit payments or Railroad Retirement Disability benefit payments from the Social Security Administration (SSA) on your own behalf; cases where you receive benefits on behalf of someone else are excluded.
- **Residency Requirement:** Must have owned and lived in the same home as your principal residence in New Jersey for at least 3 years, including the application year.
- **Property Tax Payment:** Property taxes for each year of application must be paid in full.
- Immigration status is not a requirement as long as you have an ITIN for tax purposes.

Income Limits

Filing Year	Source Income Year	Income Limit (Gross Income)
Filing in 2024	2023 Income	\$163,050 or less
Filing in 2025	2024 Income	\$168,268 or less
Filing in 2026	2025 Income	\$172,475 or less

***Definition of Income:** Based on Gross Income, which includes Social Security, pensions, IRA withdrawals, and all other sources of income.

How to Apply

Seniors can apply easily through the PAS-1 Integrated Application.

- **New Applicants (PTR-1):** First-time applicants must submit income and tax information for the past two years to establish their “Base Year.”

- **Previous Recipients (PTR-2):** The State will mail a pre-printed application containing your information.
- **Integrated Portal:** The government does not automatically submit your application. You must apply manually every year—either online or by mail—using the [PAS-1 integrated application form](#) to ensure you are reviewed for Senior Freeze as well as other senior benefits (Stay NJ, ANCHOR).
- **Deadline:** Generally, the application closes between late October and early November each year.
- **Payment Timeline:** Generally, payments are issued sequentially starting from July 15, depending on the timing of the application.

Key Considerations

- **Interaction with Stay NJ:** Stay NJ is applied after the Senior Freeze and ANCHOR benefits are first calculated. The Stay NJ amount is adjusted to ensure that the combined total of all three benefits does not exceed 50% of the property tax (up to a \$6,500 limit).
- **Moving:** If you move within New Jersey, you must meet the 3-year ownership and residency requirements at your new home before you can apply again. A new “Base Year” will be established.
- **Multi-Unit Properties:** Your property must not exceed 4 units, and you must occupy one of the units yourself. Properties with more than one commercial unit are excluded.

Contact

- **NJ Division of Taxation Official Hotline:** 1-800-882-6597
- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ Division of Taxation -Senior Freeze\(PTR\)](#)
- [Online Integrated Application for PTR](#)

Residential Health Care Facilities (RHCF)

Residential Health Care Facilities (RHCF) are residential settings designed for individuals who can maintain a certain level of independence but require some medical supervision and support with daily living due to chronic illness or aging. It is commonly understood as an intermediate stage between living at home and Assisted Living, and its purpose is to provide residents with a safe living environment along with basic health care services.

Services and Support

RHCF provides supervised health care services that go beyond simple housing, including the following:

- **24-Hour Supervision:** Professional staff are on-site to manage and respond to emergencies.
- **Healthcare Services:** Basic medical monitoring, such as blood pressure checks and Medication Management, is provided.
- **Daily Living Assistance:** Includes meal services, laundry, housekeeping, and personal hygiene support.
- **Social Activities:** Various recreational and social programs are operated for the emotional well-being of residents.
- **Dietary Management:** Provides a balanced diet considering nutrition (some facilities operate under the guidance of a nutritionist).

Eligibility

- **Age:** Mainly for seniors aged 60 and older
- **Health Status:**
 - **Medical Necessity:** The individual must be in a condition where hospital-level care is not required, but living alone at home poses safety concerns or requires regular help, such as medication management.
 - **Mobility:** Most RHCFs prefer individuals who can move to some extent independently or with the help of assistive devices (canes, walkers).
 - **Mental Health:** Must have a cognitive state capable of communal living without posing a risk to others. (In cases of severe dementia or serious mental illness, specialized Memory Care or mental health facilities may be more appropriate.)
- **Financial Proof:** Evaluation of the economic ability to pay monthly rent and service fees. Generally, these facilities are not covered by Medicaid. Approximately 40% of NJ RHCF residents utilize SSI, 50%

pay out-of-pocket, and the remainder use Veterans Benefits or other sources. Please verify SSI eligibility in advance.

Residential Healthcare Facilities in New Jersey

Town	Community Name	Features	Contact
Allendale	Allendale Senior Living	Located in Bergen County, it provides basic care services.	201-825-0660
Montclair	Horizon Manor South	Provides basic care (RHCF) and Memory Care, focusing on housing, meals, and basic health monitoring. It is suitable for those who prefer a small, family-like community atmosphere.	973-746-9047
Bloomfield	Job Haines Home	A non-profit facility with over 120 years of history.	973-743-0792

Contact

- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ.gov DOH Search for Residential Health Care Facilities](#)
- [NJ.gov – Residential Health Care Facility Search](#)
- [NJ 211.org](#)

Adult Retirement Communities

Adult Retirement Communities, commonly referred to as “Active Adult Communities” or “55+ Communities,” are managed residential complexes designed for seniors capable of healthy and independent living. Unlike Assisted Living or nursing homes, these communities do not provide medical services or assistance with daily living activities. Instead, they focus on fostering an environment where residents can lead socially vibrant lives alongside peers in a similar life stage. The primary appeal of these communities lies in a quiet living environment secured by age restrictions, resort-style amenities, and the elimination of burdensome home maintenance tasks such as landscaping and snow removal. These communities vary widely in form, ranging from large-scale planned cities with thousands of households to small-scale gated communities.

Eligibility

Age

- Under the federal law, at least 80% of the occupied units must be occupied by at least one person who is 55 years of age or older.
- Communities for those 62 years of age or older are subject to separate HOPA(Housing for Older Persons Act) exemption provisions, in which case 100% of the residents must be 62 or older without exception, rather than the 80% rule).
- Co-residents must generally be at least 18 years of age, though this may vary depending on the specific regulations of each complex.

Restrictions on Minor Residency

- Most 55+ communities do not allow the permanent residency of minor children. However, as this may vary depending on the specific community bylaws, it must be verified prior to moving in.
- The permitted length of stay for visitors varies from 2 weeks up to 90 days per year according to the community’s covenants, conditions, and restrictions (CC&Rs), and must be verified prior to moving in.

Independent Living Ability

- These communities are intended for independent residents capable of managing their own daily routines. Medical services or caregiving are not provided.

Financial and Identification Verification

- Along with documents to prove age (such as a passport or ID), a screening process is required: income and credit checks for rentals, and financial capability assessments for ownership. Specific criteria vary by community.

Pet Policies

- Even if permitted, there are restrictions on weight and the number of pets, so verification by the community is required.

Housing Options and Ownership Structures

Adult Retirement Communities offer various housing styles to suit residents' budgets and preferences. Single-family detached homes are popular for those seeking privacy, while townhouses, villas, and condominiums are preferred by those looking for easier-to-manage homes. In urban areas, they may operate as luxury high-rise apartments. Ownership structures also vary as follows:

- **Fee Simple:** The resident directly owns both the home and the land; commonly found in traditional suburban developments.
- **Condominium/Co-op:** A form where you either hold direct ownership of the unit or own corporate shares that grant the right to reside in a specific unit. In addition, there are shared common areas, and the HOA manages the exterior and landscaping.
- **Lease/Rental:** There is a growing trend toward premium rental models that offer luxury amenities at a fixed monthly rent.

New Jersey Adult Retirement Communities (55+)

Town	Community Name	Housing Type	Features	Contact
Florham Park	Del Webb at Florham Park	Single-family homes + Townhouses (attached) + Condominiums (Total of 3 housing types)	Representative 55+ brands. These feature indoor and outdoor swimming pools, smart home systems, and an on-site dedicated lifestyle director.	973-969-3495
Wayne	Four Seasons at Wayne	1–2 story condominiums (elevator accessible)	A 55+ gated community consisting of 230 units constructed	503-746-4122
Wanaque	Del Webb's Wanaque Reserve	Mid-rise Condo	A large-scale luxury 55+ community	1-800-870-0010
Livingston	The Pointe at Livingston	Condo (Gated)	Located in Essex County. Offers a quiet, formal atmosphere with highly active community engagement among residents.	973-810-8208
Livingston	The Enclave at Livingston	Rental apartments (gated)	Provides a private and quiet living environment for seniors who wish to enjoy Livingston's excellent local infrastructure.	973-422-9300
Tinton Falls	Enclave at Tinton Falls	Single-family Home	A 55+ detached housing community where the association manages all maintenance, including landscaping and snow removal.	732-800-2005

***Items to Check During Visit:** Be sure to verify if the Homeowners Association (HOA) has healthy Reserve Funds, if the current resident age group matches your preferences, and if there are high-quality general hospitals nearby.

**Community policies (age requirements, HOA regulations, etc.) are subject to change, so you must verify them directly with each community's management office prior to moving in.*

Contact

- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ 211.org](http://NJ211.org)
- [NJ Housing Resource Center \(NJHRC\)](#)

Reverse Mortgage

Reverse Mortgage is a loan designed for seniors aged 62 and older, allowing them to receive cash by using their home equity as collateral while continuing to live in their home for life. The most representative product is the HECM (Home Equity Conversion Mortgage), which is insured by the Federal Housing Administration (FHA).

Eligibility

- **Age:** 62 or older / Spouses under the age of 62 can be registered as a Non-Borrowing Spouse (NBS). If HUD eligibility requirements are met, the spouse's right to reside in the home can be protected even after the borrower's death. (Subject to separate verification of eligibility requirements).
- **Residency:** The property must be your Principal Residence, and you must live there for more than 6 months out of the year.
- **Home Equity:** You must own the home outright or have a very low existing mortgage balance that can be fully paid off with the Reverse Mortgage proceeds.
- **Financial Assessment:** Prior to loan origination, the borrower's credit history, income and cash flow, and ability to pay property taxes and insurance are comprehensively evaluated. Additionally, the loan may be restricted if there is any delinquent federal debt.

Loan Limits (2026)

- **Maximum Claim Amount:** \$1,249,125 is the maximum home value limit recognized by the FHA for loan calculation purposes; the actual amount received is determined based on factors such as age, interest rates, and home value.
- **Payment Options:** You can choose from a lump sum, monthly annuity-style payments, or a Line of Credit. You can also combine multiple payment methods.

Mandatory Procedures

For Reverse Mortgage, counseling with a Department of Housing and Urban Development (HUD) approved counselor is a legal requirement before applying.

- **Counseling Content:** Includes a review of loan costs, tax implications, inheritance issues, and alternatives (such as downsizing).
- **Waiting Period:** Under federal HECM regulations, a loan application can only be submitted at least 3 business days after the completion of the counseling session.

- **Validity Period:** The HECM counseling certificate is valid for 180 calendar days from the date of issuance.

Key Considerations

Reverse Mortgage is not free money. Rather, it is a loan that must be repaid eventually.

- **Repayment Timing:** The full loan amount must be repaid when the last borrower passes away, sells the home, or vacates the residence for more than 12 consecutive months (e.g., admission to a nursing home).
- **Default Risk:** Failure to pay property taxes, maintain insurance, or neglect home maintenance can lead to foreclosure and eviction.
- **Non-Recourse Protection:** Even if the loan balance exceeds the home's value, the borrower or heirs are not responsible for paying the excess amount.
 - *For example, if the loan balance is \$500,000 but the home value has dropped to \$400,000 at the time of the borrower's death, the heirs do not need to pay the \$100,000 deficit.*

Options for Heirs

Within 30 days of the borrower's date of death, the servicer must be notified of the intent regarding the home. However, it is crucial that the heirs inform the servicer of the death as soon as possible.

- **Option 1:** Sell the home and keep the remaining equity
 - If the home value exceeds the loan balance: The remaining equity (the difference) belongs to the heirs.
 - If the loan balance exceeds the home value: In cases where the debt is greater than the home's worth, the home can be sold for at least 95% of its current appraised value. The remaining balance is then covered by FHA insurance, ensuring that the heirs are not held personally liable for the deficiency.
- **Option 2:** Pay off the loan and keep the home
 - If the heirs wish to keep the home, the lender (not HUD) may approve a 90-day extension upon submission of documentation, and a total processing time of approximately 6 months may be granted.
 - To keep the home, you must pay the lesser of the full loan balance or 95% of the home's appraised value.
- **Option 3:** Surrender the deed to the lender (Deed in Lieu of Foreclosure)

- If the debt is higher than the home's value or if the selling process is too burdensome, heirs can voluntarily transfer the deed to the lender.

Contact

- HUD (U.S. Dept. of Housing and Urban Development): 1-800-569-4287
- Bergen County Reverse Mortgage Housing Counseling: 201-336-7431
- NJ Housing and Mortgage Finance Agency (NJHMFA): 1-800-654-6873 -Housing financial program management for seniors
- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [HUD.gov – Find a HUD-Approved Housing Counseling Agency](#)
- [HUD.gov – Official Reverse Mortgage Regulations and Loan Limits](#)
- [CFPB.gov – Consumer Protection Guide and Risk Factors](#)

Section 8

Section 8 is a program where the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) subsidizes a portion of rent so that low-income households can enjoy a safe and pleasant living environment in the private market. Its official name is the Housing Choice Voucher (HCV) program.

The most significant feature of Section 8 is that the amount paid by the tenant is linked to their income.

- Tenants generally pay 30% of their adjusted monthly income, and if the gross rent exceeds the payment standard at initial occupancy, they may pay up to a maximum of 40%.
- Public Housing Authority pays the landlord directly in the form of Housing Assistance Payment.

Two Types of Section 8

Category	Housing Choice Voucher (Tenant-Based)	Project-Based Voucher (Project-Based)
Target	Voucher is issued to the tenant (individual)	Subsidy is assigned to a specific apartment unit
Mobility	The voucher stays with the tenant when moving	When moving, the voucher remains with the specific unit. However, for PBV (Project-Based Vouchers) only, after residing there for 12 months, you may apply for a tenant-based voucher to relocate.
Housing Choice	Any private housing that accepts the voucher	Must move into the designated apartment to receive benefits
Remarks	Commonly known as the "Section 8 Voucher"	Specific units designated by the PHA, such as senior apartments, housing for individuals with disabilities, and redeveloped housing.

Eligibility

- **Income Standards**
 - Annual Gross Income of the household must be 50% or less of the Area Median Income (AMI).
 - 75% of vouchers are allocated to 'Extremely Low-Income' households, whose income is at or below 30% of the Area Median Income.

- **Household Composition:** Seniors aged 62 or older, individuals with disabilities, households with children, and veterans may be considered for priority.
- **Status:** U.S. citizens or those with eligible immigration status (Permanent Residents, etc.).
- **Exclusions:** Eligibility may be restricted for individuals with records of drug-related crimes or sex offenses. Detailed criteria vary by PHA. Additionally, eligibility may be restricted if there is a record of prior eviction from public housing.
- **Asset Limit:** Eligibility may be restricted if Net Family Assets exceed \$105,574 (2026) or if you own habitable real property. (Essential assets such as vehicles and medical equipment may be excluded.)
- **Income Deductions:** Income deduction standards (such as medical expenses) applied to senior and disabled households are being adjusted according to HOTMA (Housing Opportunity Through Modernization Act).

**Policies may vary by PHA; please check with each individual agency.*

Application and Leasing Process

1. **Application:** Submit an application to the [Public Housing Authority \(PHA\)](#) of your desired area.
 - At [HABCNJ](#), you can check and apply for all housing program waiting lists operated by the HABC (Section 8 vouchers, public housing, senior apartments, etc.) in one place.
 - However, the opening period for the Section 8 (HCV) voucher waiting list is irregular and may remain closed for several years. You must check the official HABC website frequently.
2. **Waitlist Registration:** Since demand is high, waitlists are often closed; you must register immediately when a list opens. (Seniors/Disabled individuals may receive priority).
3. **Eligibility Interview:** When your turn comes, the PHA will contact you. At this stage, you will submit supporting documents for income, assets, and family composition and undergo an interview.
4. **Voucher Issuance:** Once approved, the voucher is issued. You must find housing within a minimum of 60 days to a maximum of 120 days after the voucher is issued. (Extensions may be granted at the PHA's discretion.)
5. **Housing Inspection:** Once you find a home, you must submit a Request for Tenancy Approval (RFTA) together with the landlord, and the unit must pass a housing safety standards inspection (HQS or NSPIRE — standards may vary by PHA) conducted by the Public Housing Authority.
6. **Contract Execution:** A Housing Assistance Payments (HAP) contract is signed between the PHA and the landlord, and a lease agreement is signed between the tenant and the landlord simultaneously.

Contact

- [HUD.gov PHA Contact Information](#)

- AWCA provides counseling free of charge. (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [HUD.gov – Housing Choice Vouchers Fact Sheet](#)
- [NJ.gov – New Jersey Housing Authority Contact List](#)
- Bergen County Section 8 Official Links
 - Official Website: habcnj.org
 - Application Portal (HCV Applicant Portal): habcnj.org/apply_for_housing
 - Waitlist Status Check: waitlistcheck.com

Senior Apartments

Senior apartments are housing facilities designed for independent seniors aged 62 and older. They are independent rental apartments that feature senior-friendly designs and social services without providing medical care or nursing assistance.

Income-Linked Type Housing

HUD (U.S. Department of Housing and Urban Development) Section 202 (non-profit operated, HUD subsidized) and Public Housing (PHA operated) are the methods adopted by most low-income senior apartments supported by the federal government.

- **Rent:** Residents pay approximately **30% of their Adjusted Monthly Income (AMI)**.
- **Utilities:** Public utilities such as electricity and gas are often included. If not included, a certain amount (Utility Allowance) may be deducted from the rent.

Eligibility

- At least one household member must be a U.S. citizen or an eligible non-citizen (including Lawful Permanent Residents) aged 62 or older.
- Eligibility may vary by property; generally, a history of HUD housing evictions and specific criminal records are subject to screening.

Income Limits

Household Size	30% AMI (Extremely Low)	50% AMI (Very Low)
1 Person	Approx. \$28,850 or less	Approx. \$48,000 or less
2 Persons	Approx. \$32,950 or less	Approx. \$54,850 or less

These figures are the income standards commonly used by HUD for all federal housing assistance programs. The eligibility ceiling for Senior Apartments is 50% AMI (Very Low Income), while 30% AMI is the threshold used for granting admission priority.

Asset Limits

- **Asset Limit:** Asset limit (**\$105,574 as of 2026**) may apply. Since implementation may vary by building, you must verify with the property manager.

- **Home Ownership:** Eligibility may be restricted if you own habitable real property, although exceptions related to disabilities and other specific circumstances may be recognized.

Fixed Rent Type (LIHTC / Affordable Housing)

The LIHTC (Low-Income Housing Tax Credit) is a program that encourages private developers to provide affordable rental housing through federal tax incentives.

- Instead of paying 30% of your income, you pay a predetermined fixed amount based on the Area Median Income (AMI).
- While much cheaper than market prices, you must pay the designated minimum rent even if your income is very low. (Usually set at 50%–60% of the AMI).
- Rent may be adjusted according to changes in the regional AMI announced annually by HUD.

How to Apply

Information Gathering

In New Jersey, you must apply online or visit the specific apartment in person. Since waitlist opening periods vary, you should inquire by phone in advance. Check the following sites frequently:

- **NJHRC (New Jersey Housing Resource Center):** njhrc.gov – New Jersey's official housing search site.
- **Affordable Homes New Jersey:** affordablehomesnewjersey.com – Operated by a NJ DCA-approved private administrative agent (CGP&H) (Applications for some low-income housing waitlists are available).
- **Local Housing Authority:** Visit the website of the Housing Authority in your county to check for "Senior Housing" announcements. HUD.gov [PHA Contact Information](#)

Waitlist Registration

Wait times can be long in most popular areas. You may apply to multiple senior apartment locations.

Contact

- HUD.gov [PHA Contact Information](#)
- AWCA provides counseling free of charge. (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- NJ.gov – [Housing Resource Center \(NJHRC\)](#)
- HACBNJ.org – [Bergen County Housing Authority](#)

- [Income Limit](#)
- [HUD Income Limits by Region\(PDF\)](#)

Stay NJ Program

Stay NJ is a groundbreaking property tax relief program introduced to help New Jersey seniors remain in their cherished homes despite high tax burdens. Stay NJ operates as a separate benefit program alongside ANCHOR and Senior Freeze, and it is designed so that the combined benefits of all three programs reach 50% of property taxes (up to a maximum of \$6,500).

Benefit Calculation

- A benefit equivalent to 50% of the property taxes paid will be provided.
- Based on a maximum annual property tax of \$13,000, the refund is capped at \$6,500 (even if the property tax exceeds \$13,000, the maximum limit remains \$6,500).
- **Calculation Method:** Stay NJ benefits are not issued in isolation. Instead, the total amounts from ANCHOR and Senior Freeze are calculated first, and Stay NJ covers the remaining balance to reach the 50% threshold.

**Example: Property tax \$10,000 → Target benefit \$5,000. If you receive \$1,750 from ANCHOR and \$500 from Senior Freeze (totaling \$2,250), Stay NJ will provide an additional \$2,750.*

Eligibility

- **Age:** Individuals who are 65 years of age or older as of the application year (Social Security Disability Insurance (SSDI) recipients are not eligible for Stay NJ. Eligibility for Senior Freeze and ANCHOR may be reviewed separately).
- **Income:** Annual Gross Income of \$500,000 or less.
- **Homeownership:**
 - You must have resided in your own home in New Jersey for the entire period from January 1 to December 31 of the applicable tax year. However, if you moved within New Jersey during that same year, you are required to complete a separate Schedule.
 - Mobile home owners are not eligible for Stay NJ. However, Senior Freeze includes mobile homes, and ANCHOR treats mobile home owners as “tenants,” allowing for a separate application.
- **Immigration Status:** If you have an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) for tax filing, **your immigration status does not matter.**

How to Apply

- **First-Time Applicants:** Submit information regarding your income and property taxes for the current and previous years through the [PAS-1 integrated application](#). (Income data from two years is used for the Senior Freeze eligibility review).
- **Returning Applicants:** You must apply for Stay NJ manually each year through the [PAS-1 integrated application](#). There is no automatic application or automatic mailing of benefits. You must file online or by mail every year to have your eligibility reviewed for Stay NJ along with other senior benefits (ANCHOR and Senior Freeze).

Disbursement Methods

- Stay NJ benefits are distributed in equal quarterly installments (February, May, August, and November).
- Online applicants may choose Direct Deposit for certain benefits (primarily ANCHOR). Those who submit paper applications will receive all benefits via check.
- Quarterly schedules are announced annually based on the State budget and the time of application.

Contact

- Stay NJ & Integrated Application Hotline: 1-888-238-1233
- NJ Division of Taxation Main Line: 1-609-292-6400
- AWCA provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NJ Division of Taxation – Stay NJ Portal](#)
- [PAS-1 integrated application](#)

PART I • SECTION 10

In-Home Care

재택 케어 (In-Home Care)

Services supporting aging in place at home: Personal Preference Program (PPP), Jersey Assistance for Community Caregiving (JACC), Respite Care for family caregivers, Home Health Care, Meals on Wheels, and Congregate Meal sites.

This section contains 6 comprehensive guides

Congregate Meals

Congregate Meals is a nutritious meal service provided in group settings such as senior centers, churches, schools, and community centers. This program is designed to provide healthy food to the elderly while promoting social interaction among seniors to alleviate feelings of isolation. Beyond simply providing a meal, it plays a vital community role as a place where seniors can communicate with neighbors and gain emotional support.

Key Features

Nutritious Diet: Provide balanced nutritional meals that meet the Dietary Guidelines for Americans (DGA) and Dietary Reference Intakes (DRI) in accordance with Older Americans Act (OAA) standards.

- **Social Engagement:** Reduces feelings of alienation in old age and improves overall well-being through interaction with others.
- **High Accessibility:** Various locations, including senior centers, religious facilities, community centers, and select partner facilities.
- **Additional Services:** Provides beneficial programs alongside meals, such as wellness checks, chronic disease management education, and fall prevention training.

Eligibility

- Seniors aged 60 or older, or the spouse of a beneficiary (regardless of age).
- Individuals with disabilities who reside with a beneficiary aged 60 or older (regardless of age).
- Program volunteers who provide services during meal hours

**Specific eligibility requirements may vary by local program, so please contact your local ADRC for inquiries.*

Cost

Meals are provided free of charge. To support the program, a voluntary donation of \$1.25 per meal is encouraged; services are provided regardless of whether a donation is made. All donation records are kept confidential.

Application and Contact

- **Advance Reservation Required:** As the number of meals per location is limited, reservations must typically be made 24 hours in advance.
- Contact your local Aging and Disability Resource Connection (ADRC).
 - **Bergen County Division of Senior Services**
 - Address: One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
 - Phone: 201-336-7400
 - Email: seniors@bergencountynj.gov
 - **NJ ADRC Toll-Free Hotline:** 1-877-222-3737
- **AWCA** provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [ACL.gov: Nutrition Services Official Guide](#)
- [Bergen County Nutrition and Wellness Services Information](#)
- [Bergen County Senior Lunch Brochure \(English\) \(PDF\)](#)

Home Health Care

Home Health Care is a program that dispatches professional caregivers to residents with mobility issues, allowing them to live safely and independently in their own homes instead of a nursing home.

Features

A Certified Home Health Aide (CHHA) from an accredited home care agency will visit your home. The agency is regulated by the New Jersey Department of Health, and the individual caregiver (CHHA) is managed by the New Jersey Board of Nursing.

- **Personal Hygiene Support:** Assistance with bathing, hair washing, dressing, oral care, and toileting.
- **Mobility Assistance:** Help with transferring from bed to wheelchair and walking indoors or outdoors.
- **Nutritional Management:** Meal preparation, feeding assistance, and special diet management.
- **Household Support:** Light cleaning of the patient's living space, laundry, grocery shopping, and medication reminders (Note: Caregivers cannot directly administer medication).
- **Professionalism:** All services are performed according to a "Plan of Care" established under the supervision of a Registered Nurse (RN).

Eligibility (2026)

To receive home health care services, both financial and medical requirements must be met.

Financial Requirements

- Home health care services require eligibility for Long-Term Care Medicaid (MLTSS), rather than just simple general Medicaid (NJ FamilyCare). Even if you already possess general Medicaid, additional enrollment is required through an MLTSS clinical assessment.
- **Income Limit:** Monthly income of \$2,982 or less.
 - If income exceeds this limit, eligibility can be secured through a "Qualified Income Trust (QIT)."
- **Asset Limit:** Total assets of \$2,000 or less.
 - One primary residence and one automobile are excluded from the asset calculation.

Medical Requirements

- **Nursing Facility Level of Care:** Must receive a clinical determination that independent living is impossible and that assistance from another person is required for at least three Activities of Daily Living (ADLs).

- **Doctor's Prescription:** A physician must issue a medical opinion stating that "home health care services are necessary."

Application Process

1. **Consultation and Pre-screening:** Contact your local county Aging and Disability Resource Connection (ADRC) for an initial telephone screening.
2. **Financial Eligibility Review:** Financial qualification for Medicaid is conducted through the County Board of Social Services.
3. **Clinical Assessment:** A nurse from a Managed Care Organization (MCO) visits the home to assess the patient's condition (ADLs) and determine the number of hours available per week.
4. **Agency Assignment:** Select a home care agency to provide services for the approved hours.
Commencement of Service: A caregiver is dispatched to begin care according to the fixed schedule.

**The processing time for home health care services varies by case. If services are needed urgently, please contact the ADRC or your 담당 CSSA (Care Management agency) regarding Fast-Track processing.*

Contact

- Long-Term Care Medicaid (MLTSS):
Contact your local Aging and Disability Resource Connection (ADRC) and the Board of Social Services.
 - **Bergen County Division of Senior Services**
 - Address: One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
 - Phone: 201-336-7400
 - Email: seniors@bergencountynj.gov
 - **Bergen County Board of Social Services**
 - Address: 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - Phone: 201-368-4200
 - **NJ ADRC Statewide Toll-Free Number:** 1-877-222-3737
- **AWCA** can provide counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)
- **AWCA Homecare Agency**
 - **Korean:** 201-862-9111
 - **Chinese:** 201-862-0006

Resources

[NJ Division of Disability Services \(DDS\) PCA Guide](#)

[NJ FamilyCare \(Application\)](#)

[Long-Term Care Medicaid \(MLTSS\) Detailed Guide](#)

[cahcosa.org: Home Care Agency Search](#)

[NJ.gov: Official New Jersey License Verification](#)

[NJ.gov: Certified Home Health Aide \(CHHA\) Overview](#)

Jersey Assistance for Community Caregiving (JACC)

The Jersey Assistance for Community Caregiving (JACC) is a program designed to prevent or delay nursing home placement for New Jersey seniors who require physical assistance, supporting them in maintaining an independent lifestyle at home. This program includes a variety of customized services to help seniors live safely and independently in a familiar environment.

Benefits

- **Care Management:** A dedicated care manager develops a personalized care plan for each individual.
Personal Care Assistance /
- **Homecare Services:** Assistance with Activities of Daily Living (ADLs), such as bathing and eating
- **Respite Care:** Provides temporary relief and substitute care for family caregivers.
- **Chore Services:** Assistance with daily household tasks such as cleaning, laundry, and errands.
- **Home Modifications:** Residential modifications to improve safety and accessibility (e.g., wheelchair ramp installation, doorway widening, bathtub replacement).
- **Specialized Medical Equipment and Supplies:** Provides essential equipment and items necessary for home care.
- **Personal Emergency Response System (PERS):** Installation of a system that allows for 24-hour emergency assistance requests.
- **Home-Delivered Meals:** Support for nutritious meal delivery services for seniors.
Adult Day Care: Access to daytime programs providing social interaction and medical support.
- **Transportation Assistance:** Provision of transportation services needed for medical appointments and other essential visits.
- New Jersey pays the service provider on behalf of each participant up to a maximum of \$1,090 per month (care management costs excluded).

Eligibility

- **Age/Status:** New Jersey residents aged 60 or older who are U.S. citizens or have qualified alien status (including permanent residents; however, eligibility may vary depending on the type of visa).
- **Living Environment:** Must reside at home (excludes nursing homes or other facilities).
- **Health Status:** Individuals who are clinically assessed as requiring assistance with at least three Activities of Daily Living (ADLs), such as bathing, toileting, dressing, and mobility.
Must not be eligible for Medicaid or Managed Long Term Services and Supports (MLTSS).

- **Assets:** Liquid assets must be \$40,000 or less for an individual, or \$60,000 or less for a couple.
- **Income(2026):** Countable income must be at or below 365% of the Federal Poverty Level (\$4,854/month for a single, \$6,582/month for a couple).
- **No Duplicate Benefits:** If you are already receiving benefits from any of the following—the Alzheimer’s Adult Day Services Program (AADSP), the Statewide Respite Care Program (SRCP), or the Personal Assistance Service Program (PASP)—you must either terminate your current program before applying for JACC or continue with your existing program instead of JACC.
- If eligibility requirements are met, a self-directed care option is provided, allowing you to hire family members or friends as your direct care providers.

Copay

JACC is not a free program. Copays are determined on a sliding scale based on the income of the participant (and their spouse).

Application and Contact

- Contact your local Aging and Disability Resource Connection (ADRC)
 - **Bergen County Division of Senior Services**
 - **Address:** One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
 - **Phone:** 201-336-7400
 - **Email:** seniors@bergencountynj.gov
 - **NJ ADRC Toll-Free Hotline:** 1-877-222-3737
- **AWCA** provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

[NJ.gov](https://www.nj.gov) – Official New Jersey JACC Program

Meals on Wheels

Meals on Wheels helps seniors live independently, improves their health, and promotes social connection by delivering meals directly to their homes.

Beyond just providing food, it is a welfare service that delivers the warmth of community care, supporting many seniors so they can stay healthy in their own homes for as long as possible instead of moving into a nursing home.

Key Features

- **Home-Delivered Meals:** Meals are delivered during lunchtime from Monday to Friday (5 days a week). Each meal consists of a nutritionist-planned, balanced diet, including a main dish, vegetables, bread, fruit, milk, and dessert.
- **Social Interaction:** Volunteers provide companionship and check on the recipient's well-being while delivering meals.
- **Safety and Wellbeing Support:** Helps prevent malnutrition among seniors, maintains independence, and ensures they can live safely.
- **Community-Based Operation:** Operated through the participation of various local non-profit organizations and volunteers.
- **Cost:** The service is free, but a voluntary donation of \$1.25 per meal is encouraged. Services are provided regardless of whether a donation is made.
- After registering for the service, a representative will visit your home every six months to conduct an assessment for continued eligibility.

Eligibility

- Seniors aged 60 or older, or their spouses and caregivers.
- Individuals with disabilities (ages 18–59): Those living alone who have difficulty preparing meals due to physical or mental disabilities (permanent or temporary). Eligibility can be determined through a doctor's note (Medical Necessity) or other documentation proving disability status
- Homebound status (unable to leave home without assistance), inability to purchase groceries or prepare nutritious meals independently, having no family or friends to provide help, and not receiving home care services for more than 4 hours per day (Eligibility is granted only to those receiving 4 hours or less).
- Non-recipients of Long-Term Care Medicaid (MLTSS).

**Specific eligibility requirements may vary by region and operating agency.*

Meals on Wheels Services in Northern New Jersey

Agency	Phone	Hours	Service Area
Bergen County Division of Senior Services	201-336-6000	Mon ~ Fri 8am ~ 4pm	33 towns including Bergenfield, Cliffside Park, E. Rutherford, Edgewater, Englewood, Englewood Cliffs, Fort Lee, Leonia, Palisades Park, Ridgefield, etc. *Check link for full list
Meals on Wheels North Jersey	201-358-0050	24/7 Inquiry available	32 towns including Alpine, Closter, Cresskill, Demarest, Dumont, etc. *Check link for full list
Community Meals, Inc.	201-447-8295	Mon ~ Fri 10am ~ 2pm	Allendale, Glen Rock, Ho-Ho-Kus, Midland Park, Ridgewood, Waldwick, and parts of Saddle River
Essex County Office of Senior Services	973-395-8375	Mon ~ Fri 10am ~ 2pm	All of Essex County
Jersey City Meals On Wheels	201-547-5750	Mon ~ Fri 8am ~ 4pm	All of Jersey City
Middlesex County Nutrition Services	732-745-3295	Mon ~ Fri 8:30am ~ 2:30pm	All of Middlesex County
Passaic County Nutrition Services	973-569-4099	Mon ~ Fri 8:30am ~ 4:30pm	All of Passaic County
Rockland County Meals on Wheels	845-624-6325	Mon ~ Fri 9am ~ 5pm	All of Rockland County
KCS NJ Home-Delivered Meals Program *Korean Meals Provided	201-212-1054	Mon, Wed, Fri	Fort Lee, Leonia, Palisades Park. [Check link for details]

Application and Contact

- [Meals on Wheels Application](#)
- Contact your local Aging and Disability Resource Connection (ADRC).
 - **Meals on Wheels Hotline:** 201-336-7420 (월-금 8:00 AM – 4:00 PM)
 - **Bergen County Division of Senior Services**
 - Address: One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
 - Phone: 201-336-7400
 - Email: seniors@bergencountynj.gov
 - **NJ ADRC Toll-Free Hotline:** 1-877-222-3737
- **AWCA** provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [Meals on Wheels America: Find a Local Program](#)
- [Bergencountynj.gov – Bergen County Meals on Wheels Overview](#)
- [Bergencountynj.gov – Meals on Wheels Online Application Form](#)

Personal Preference Program (PPP)

The Personal Preference Program (PPP) is a New Jersey Medicaid (NJ FamilyCare) program that allows qualified individuals to directly manage their own personal care services instead of using a traditional home health care agency. This program grants patients greater control, flexibility, and choice over their own care.

Key Features

- **Direct Hiring:** You can directly hire a spouse, family member, relative, friend, or neighbor who is at least 18 years old. However, a legal guardian serving as an Authorized Representative cannot simultaneously be the caregiver (worker). Caregivers must have legal authorization to work in the United States.
- **Self-Directed Operation:** You can set the caregiver's work schedule and wages within the budget range approved by the MCO (Managed Care Organization).
- **Monthly Budget Support:** The monthly budget is calculated by converting the MCO-approved PCA hours into a dollar amount based on the current reimbursement rate, minus administrative fees.
- **Flexible Funding Use:** Funds can be used to purchase approved goods and services that support independent living. Examples: Laundry services, errand services, and equipment for independent living (e.g., microwave, washing machine, etc.). However, medical services such as Private Duty Nursing are excluded from coverage.
- **Non-Duplication:** Using both the PPP and traditional Agency PCA services simultaneously is considered a duplication of benefits and is not permitted.

Eligibility

- The patient must be enrolled in NJ FamilyCare.
- There must be a physician's prescription stating that PCA services are required for at least 6 months.
- The individual must practically require assistance with ADLs (Activities of Daily Living) such as bathing, eating, and mobility. Minors may also apply if they meet the requirements (with a guardian acting as a representative).
- The individual must have the ability to manage services directly or be able to manage them through an Authorized Representative.
- Residents of private homes, apartments, or group homes are eligible. However, those residing in assisted living facilities, adult foster care, or facilities where PCA services are already included in the service package are excluded.

Application and Contact

- **Contact Your MCO:** Contact your MCO and the state that you are “interested in the PPP” or request a “PCA Assessment.” An MCO Care Manager will then provide options counseling and guide you through the application process.
- **Assessment & PPP Selection:** During the nurse’s home visit assessment, clearly state your preference to use the PPP (Self-Directed) option instead of an agency-provided service.
- After MCO approval, a Financial Consultant from the assigned Fiscal Intermediary will assist with developing the budget plan and completing the enrollment process.

Managed Care Organizations (MCO) in New Jersey

Managed Care Organization (MCO)	Inquiry & Application Phone Number
Aetna Better Health	1-855-232-3596
Fidelis Care (formerly WellCare)	1-855-642-6185 (Select option 3, then option 2)
Horizon NJ Health	1-855-465-4777
UnitedHealthcare Community Plan	1-800-645-9409 (Select option 3)
Wellpoint (formerly Amerigroup)	1-855-661-1996 (Select option 1)

- **NJ PPP Direct Inquiry:** 609-631-2481 / MAHS.PPP@dhs.nj.gov
- **AWCA** provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [Official New Jersey PPP Website](#)
- [New Jersey PPP Application Phone Number List](#)
- [New Jersey PPP Program \(Fact Sheet\)](#)

Respite Care

Respite Care is a program designed for caregivers. While the services are provided to the care recipient (the patient), the primary purpose is to provide the caregiver with a much-needed break. This service ensures that the patient receives professional care and supervision while the caregiver takes time to rest.

Types of Respite Care

Respite care can be provided in various ways depending on the patient's condition and the situation of the primary caregiver (usually a family caregiver):

- **In-Home Respite:** A professional caregiver visits the home to care for the patient and provide light housekeeping support.
- **Adult Day Care:** A structured daytime program that provides social interaction and medical support.
- **Residential Respite Care:** This is a service where the patient stays away from home in a professional facility for a short period—ranging from a few days to several weeks—to receive 24-hour care.

Benefits

- **Caregiver Stress Relief:** Prevents mental and physical burnout caused by continuous caregiving.
- **Social Interaction:** Provides the patient with opportunities for new social contacts and activities.
- **Guaranteed Continuity of Care:** Ensures that medical and personal needs are met even when the caregiver is absent.
- **Securing Personal Time:** Helps caregivers attend their own medical appointments, travel, or get sufficient rest.

Eligibility

- **Age/Target:** New Jersey residents aged 18 or older.
Living Environment: Must reside at home (excludes nursing homes or other facilities).
- **Health Status:** Those who have a functional impairment and have received confirmation from their attending physician that they require assistance from others.
- **Caregiving Condition:** Those who receive daily basic care and/or supervision from an unpaid caregiver aged 18 or older, such as a spouse, family member, friend, or neighbor.
- **Assets:** Liquid assets must be \$40,000 or less for an individual, or \$60,000 or less for a couple.
- **Income:** Monthly income of \$2,982 or less for a single person, or \$5,964 or less for a couple.

- **Duplicate Program Participation:** Those who do not participate in Long-Term Care (MLTSS), Jersey Assistance for Community Caregiving (JACC), Alzheimer's Adult Day Services Program (AADSP), Congregate Housing Services Program (CHSP), or other NJ FamilyCare programs. Transitioning to Respite Care from JACC or AADSP is possible.

Copay

Respite Care is not a free program. Depending on the recipient's income, a copayment ranging from 0% to a maximum of 25% of the service cost may be required.

Application and Contact

- Contact your local Aging and Disability Resource Connection (ADRC)
 - **Bergen County Division of Senior Services**
 - **Address:** One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
 - **Phone:** 201-336-7400
 - **Email:** seniors@bergencountynj.gov
 - **NJ ADRC Toll-Free Hotline:** 1-877-222-3737
- **AWCA** provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org)

Resources

- [NIA.gov National Institute on Aging \(NIA\): What Is Respite Care?](#)
- [NJ.gov Statewide Respite Care Program \(SRCP\) Official Guide](#)
- [ARCH.net National Respite Locator Service](#)

PART I • SECTION 11

Senior Protection

시니어 권익 보호 (Senior Protection)

Protecting older adults from harm and abuse: Adult Protective Services (APS), Senior Scam and Cyber Security prevention, Ombudsman advocacy, and legal services for seniors.

This section contains 4 comprehensive guides

Adult Protective Services (APS)

This content is for informational purposes only. In case of an emergency, call 911 immediately.

Adult Protective Services (APS) is a state-mandated safety net designed to support vulnerable adults aged 18 and older who are unable to protect themselves due to physical or mental limitations. County-designated APS agencies receive, investigate, and respond to reports to ensure the safety of those at risk and connect them with the services they need.

Focus Areas

- **Physical & Emotional Abuse:** Acts of violence, threats, verbal abuse, or any conduct that inflicts psychological distress.
- **Neglect & Self-Neglect:** Failure to provide essential food, medication, or hygiene care, including instances where a senior can no longer care for themselves.
- **Financial Exploitation:** The unauthorized or improper use of a senior's funds, property, or assets for someone else's benefit.

** APS reporting is open to the public, and the identity of the reporter is protected by law. Healthcare professionals, law enforcement officers, firefighters, and EMTs are designated as mandatory reporters.*

Investigation & Support Procedures

- **Rapid Field Investigation:** Within 72 business hours of receiving a report, an APS caseworker will conduct a home visit to thoroughly assess the situation.
- **Tailored Service Connection:** To eliminate immediate risks, APS connects individuals with essential services, including:
 - **Medical Support:** Access to emergency medical treatment and ongoing healthcare services.
 - **Housing Safety:** Assistance with relocating to a safe shelter or alternative housing if necessary.
 - **Financial & Legal Aid:** Connection to financial management services and legal counseling to protect personal rights.

Reporter Protection Policy

- **Strict Confidentiality:** The identity of anyone reporting in good faith is strictly protected by law.

- **Immunity from Liability:** As long as a report is made with reasonable cause, the reporter is immune from any civil or criminal liability, regardless of the investigation's ultimate outcome.

Major APS Contacts in Northern New Jersey

County	APS Agency	Address	Phone
Bergen	Bergen County Board of Social Services	218 Route 17 North Rochelle Park, NJ 07662	Daytime: 201-368-4300 After Hours: 1-800-624-0275
Essex	FOCUS Hispanic Center for Human Dev.	441-443 Broad St. Newark, NJ 07102	Daytime: 866-903-6287 After Hours: 911
Hudson	Hudson County Adult Protective Services	6100 Adams Street West New York, NJ 07093	Daytime: 201-537-5631 After Hours: 911
Middlesex	Family and Children's Service	191 Bath Avenue Long Branch, NJ 07740	Daytime: 732-745-3635 After Hours: 911
Passaic	Passaic County Board of Social Services	80 Hamilton Street Paterson, NJ 07505	Daytime: 973-592-1954 After Hours: 1-800-315-4561

Resources

- [NJ Adult Protective Services \(APS\)](#).

Legal Services for Seniors

This content is for informational purposes only. In case of an emergency, call 911 immediately.

Legal Services for Seniors connects low-income older adults with free or low-cost legal assistance for civil legal matters, ensuring their rights and dignity are protected.

Key Areas of Support

- **Abuse Response:** Legal support and counseling to protect seniors from physical, emotional, or verbal abuse, isolation, and threats, including obtaining restraining orders and other protective measures.
- **Advance Planning:** Assistance with Power of Attorney (POA), Healthcare Proxy Directives, and Living Wills to ensure your future wishes are legally documented.
- **Housing Rights:** Legal counsel for eviction defense, landlord-tenant disputes, and maintaining housing stability.
- **Financial Protection:** Legal response to consumer fraud, debt management, and safeguarding personal assets.
- **Public Benefits:** Support for issues regarding Medicare, Medicaid, Social Security, and other essential public assistance programs, including eligibility reviews and appeals for denied benefits.

Legal Support Network

- **Adult Protective Services (APS):** Serves vulnerable or at-risk adults 18 and older, especially those who may have difficulty protecting themselves due to disability or aging, to quickly ensure their safety and connect them with needed services.
 - For details check the [Adult Protective Services \(APS\)](#) page.
- **LSNJ (Legal Services of New Jersey):** Operates a statewide legal hotline specifically for low-income seniors, offering expert legal advice from experienced attorneys.
- **Local Legal Representation:** Coordination with county-level legal service offices for case handling and courtroom representation.
- **Advocacy & Education:** Regular educational resources to help seniors understand their legal rights and prevent legal complications before they arise.

How to Access Services

1. **Application:** Request an initial consultation via the statewide hotline or online portal.
2. **Eligibility Review:** Assessment of household income, age, residency, and the nature of the legal issue.

3. **Expert Assignment:** Matching the case with a qualified attorney or legal advocate for counsel, document preparation, or representation.

Contact

- **LSNJ Hotline:** 1-888-576-5529 | lsnjlawhotline.org/intake | lsnj.org
- **Bergen County NJ APS:** 201-368-4300 | 24-Hour Hotline 1-800-624-0275
- **National Domestic Violence Hotline:** 1-800-799-7233 | thehotline.org/
- [NJ 211.org: Find Legal Services for Seniors](https://nj211.org/)
- [NNJLS.org – Free Legal Services for Bergen, Hudson, and Passaic](https://nnjls.org/)
- [CHLP.org – New Jersey advocacy for seniors and people with disabilities](https://chlp.org/)

Ombudsman

This content is for informational purposes only. In case of an emergency, call 911 immediately.

An Ombudsman is an independent advocate who receives, investigates, and resolves complaints regarding the operations of government agencies, long-term care facilities, or specific organizations. Acting as a neutral third party, they provide fair and transparent mediation for citizens facing complex administrative procedures or unfair treatment.

**All Ombudsman services are free and confidential.*

Core Service Areas

- **Rights Advocacy & Investigation:** Conducting independent inquiries into government errors, delays, lack of response, or unfair decisions.
- **Long-Term Care Oversight:** Ensuring the safety, quality of care, and dignity of residents in Nursing Homes and Assisted Living facilities.
- **Conflict Mediation:** Facilitating communication between complainants and agencies to seek informal, efficient resolutions before legal litigation.
- **Policy Recommendations:** Analyzing recurring complaints to recommend systemic improvements to government departments or legislative bodies.
- **Information & Education:** Providing consultations and resources to help citizens understand their rights and comply with relevant regulations.

Operational System

The Ombudsman operates independently across federal, state, and local departments.

- **Long-Term Care Ombudsman (LTCO):** Specializes in issues of abuse, neglect, or service dissatisfaction within long-term care facilities across New Jersey.
 - For details check the [Long-Term Care Ombudsman](#) page.
- **Agency-Specific Ombudsmen:** Offices within departments such as the State Department or the Social Security Administration (SSA) to handle grievances related to specific administrative services.
- **Independence & Confidentiality:** Ombudsmen maintain an independent status free from agency interference. Consultation details and complainant identities are strictly protected by law.

Ombudsman Process

1. **Intake:** Submit grievance details via phone, email, or official website forms.
2. **Initial Review:** Verification of whether the complaint falls within the Ombudsman's jurisdiction and collection of preliminary data.
3. **Investigation & Mediation:** Conducting neutral inquiries through interviews and document reviews to recommend solutions.
4. **Resolution Notice:** Formal delivery of investigation results and subsequent action plans to the complainant.

Resources

- [U.S. Department of State \(Civil Rights & Ombudsman\)](#)
- [NJ Long-Term Care Ombudsman \(NJ LTCO\)](#) | 1-877-582-6995
- [NJ Dept. of Human Services \(DHS\) Ombudsman](#) | 1-800-357-2260
- [Administrative Conference \(ACUS\) Resources](#)
- [NJ 211.org](#)

Senior Scam & Cyber Security

This content is for informational purposes only. In case of an emergency, call 911 immediately. For fraud recovery and reporting, contact the National Elder Fraud Hotline: 1-833-372-8311 (Weekdays 6am–11pm ET).

Scams targeting seniors are growing more sophisticated every day—from government impersonators to AI-generated voice fraud to social media deception. Staying informed about how these crimes work is one of the most powerful ways to protect yourself and the people you love.

Common Scam Types & Warnings

- **Government Impersonation:** Scammers pose as Social Security Administration (SSA), IRS, or Medicare representatives to steal personal information or pressure you into sending money under threat of legal action. Real government agencies will never demand immediate payment or sensitive data by phone or text.
- **Financial Exploitation:** Trusted individuals—family members, caregivers, or legal representatives—exploit a senior’s physical or cognitive vulnerabilities to gain unauthorized access to their finances or assets.
- **Tech Support Scams:** A fake pop-up warns that your device has been compromised and tells you to click a link or call a number for help. The “technician” then asks to remotely access your device and uses that access to steal financial information and drain accounts.
- **Fake Ads & Social Media Scams:** Fraudulent ads exploit celebrity names or promise free prizes to get you to enter personal information, sign up for fake investments, or unknowingly authorize charges for paid services.
- **Grandparent / Family Emergency Scams:** A scammer poses as a grandchild or other family member in crisis—claiming to be arrested, in an accident, or in danger—and demands an immediate wire transfer before you have time to think it through.
- **Romance Scams:** After building trust and affection through social media or messaging apps, the scammer fabricates emergencies—medical bills, travel costs, legal fees—and repeatedly requests money.
- **Phishing & Malicious Links:** Text messages pretending to be from government agencies or delivery services contain links designed to hack your device and steal personal and financial information.

Prevention & Response

- **Hang Up First — Then Verify**
 - Government agencies like the SSA, IRS, and local police will never call demanding immediate payment, threatening arrest, or asking for a card number. If something feels off, hang up.
 - If someone claims your grandchild was in an accident and needs money right away, hang up and call your family member directly at the number you already know.
- **Never Click Unknown Links or Install Unknown Apps**
 - Do not tap links in texts about package deliveries, fines, or account alerts from numbers you don't recognize.
 - Never install an app someone sends you or that appears in a pop-up ad, especially one claiming to be a security tool.
- **Gift Cards and Wire Transfers Are Always a Scam**
 - No legitimate government agency or business will ever ask you to pay a fine, fee, or penalty using gift cards, Bitcoin, or a cash wire transfer.
 - Never allow someone you don't know to remotely access your computer or phone, even if a warning screen tells you to call for help.
- **Never Share Personal Information**
 - Keep your bank passwords and full Social Security Number private, even from family members.
 - If a stranger on social media reaches out, becomes friendly quickly, and then asks to borrow money or recommends an investment, block them immediately.
- **Ask for Help the Moment You Suspect Fraud**
 - Being scammed is never your fault. It takes courage to speak up. Ask for help right away.
 - If you sent money or shared account information, call your bank immediately and ask them to place a hold on your card or cancel it.

Scam Types	Government Contacts
Government Impersonation SSA, IRS, or Medicare reps demanding personal info or payment	National Elder Fraud Hotline 1-833-372-8311 FTC: Report Fraud reportfraud.ftc.gov
Financial Exploitation Trusted individuals misusing a senior's finances or assets	NJ Division of Consumer Affairs 1-800-242-5846 APS (Bergen County) 1-800-624-0275 201-368-4300
Tech Support Scams Fake virus warnings leading to remote device access and theft	FTC: Report Fraud reportfraud.ftc.gov NJ Division of Consumer Affairs 1-800-242-5846
Fake Ads & Social Media Fraudulent ads using celebrities or prizes to steal info or charge cards	FTC: Report Fraud reportfraud.ftc.gov NJ Division of Consumer Affairs 1-800-242-5846
Family Emergency Scams Impersonating a grandchild or family member to demand urgent money	Local Police (911) National Elder Fraud Hotline 1-833-372-8311
Romance Scams Building online trust, then repeatedly requesting money for fake situations	FTC: Report Fraud reportfraud.ftc.gov
Phishing & Malicious Links Fake agency or delivery texts with links that hack your device	FTC: Report Fraud reportfraud.ftc.gov

**In case of an emergency, call 911 immediately. For fraud recovery and reporting, contact the National Elder Fraud Hotline: 1-833-372-8311 (Weekdays 6am–11pm ET).*

Contacts

- **National Elder Fraud Hotline:** 1-833-372-8311
- **FTC Reporting:** reportfraud.ftc.gov
- **NJ Division of Consumer Affairs:** 1-800-242-5846

- **NJ Office of Attorney General:** 609-984-5828

Resources

- [FTC.gov – Identity Theft](#) | [FTC.gov – Report Fraud](#) | [FTC.gov – Do Not Call](#)
- [OVC.gov – Helping Victims Find Their Justice](#)
- [NJ Consumer Affairs.org](#)
- [NJ OAG.gov – Office of Attorney General](#)

PART I • SECTION 12

Retirement Planning

은퇴·노후 준비 (Retirement Planning)

Essential legal and lifestyle planning for retirement: Durable Power of Attorney (POA), Advance Healthcare Directives, Living Wills, Last Wills & Testaments, Revocable Living Trusts, Medicaid Asset Protection Trusts, AARP benefits, Age-Friendly Communities, Senior Transportation Services, Leisure & Recreation, and reverse immigration considerations.

This section contains 11 comprehensive guides

AARP (American Association of Retired Persons)

AARP is the nation's largest nonprofit, **nonpartisan** organization dedicated to empowering people aged 50 and older to choose how they live as they age. While its core focus is on those 50+, membership is open to anyone aged 18 or older. AARP provides an extensive array of resources and benefits covering health, financial security, leisure, and overall quality of life.

Areas of Support

- **Finance and Fraud Prevention:** Provides retirement planning guides and manages the **Fraud Watch Network**, which offers education on preventing phone scams (voice phishing) and financial fraud, along with victim support services.
- **Health and Medical Resources:** Offers Medicare comparison tools, dementia and caregiving resources, and access to discounts and information regarding vision and hearing health.
- **Cost-of-Living Discounts:** Members gain access to exclusive savings across various sectors, including travel (hotels, flights), dining, retail, and auto/home insurance.
- **Employment and Career Support:** Provides job-search tools tailored for workers over 50, skills retraining programs, and a job board featuring employers who have signed the **AARP Employer Pledge**.
- **Driver Safety Education:** Operates the **AARP Smart Driver™ Course** in both online and in-person formats, helping seniors improve road safety skills and potentially qualify for auto insurance discounts.

Support Systems

- **AARP Foundation:** The organization's charitable affiliate, which manages programs for low-income seniors, including housing stability, food security, and the **Tax-Aide** program.
 - **Tax-Aide:** Provides free tax preparation assistance with a focus on low-to-moderate-income taxpayers aged 50 and older. However, this service is open to everyone regardless of age, income, or AARP membership status.
- **Fraud Watch Network:** Operates a dedicated fraud helpline to share information on the latest scams and provide real-time guidance to victims.
- **State Offices (AARP New Jersey):** Local state chapters, including New Jersey, conduct community-based advocacy work and host social events for residents.
- **AARP Publications:** Delivers the latest trends in health, finance, and technology through **AARP The Magazine** (published bimonthly) and the **AARP Bulletin**.

Contact

- [AARP](#) General Line: 1-888-OUR-AARP (1-888-687-2277)
- [AARP New Jersey State Office](#)
- [AARP Foundation Job Board / Career Center](#)

Advance Directive

This content is provided for informational purposes only. For specific legal advice, please consult with a qualified professional or an official government agency.

An **Advance Directive** is a legal document that allows you to specify the scope of medical treatment you wish to receive and designate a representative in advance, should you become unable to make or communicate your own decisions due to future illness or accident. This is an essential planning process to preserve your dignity and alleviate the burden of decision-making for your family.

In New Jersey, an Advance Directive only takes effect when your attending physician determines that you lack the capacity to make your own healthcare decisions. Any individual aged 18 or older may execute an Advance Directive.

Key Components

Advance Directives typically include the following two elements, which can be prepared together or separately:

Category	Primary Content	Role
Instruction Directive (Commonly known as a Living Will)	Specifies the wish to withhold or continue life-sustaining treatment in particular circumstances.	Communicate your treatment guidelines.
Proxy Directive (Durable Power of Attorney for Healthcare)	Designates a representative to make medical decisions on your behalf.	Ensure the legal representative's decision-making authority.

Five Wishes: A Comprehensive Advance Directive

Created by the non-profit organization Aging with Dignity, Five Wishes covers not only medical decisions but also your emotional and personal desires. It is legally recognized in most U.S. states, including New Jersey, and is available in 31 languages, including English and Korean, making it highly accessible for Korean-American seniors.

It is legally valid in all 50 states and Washington D.C., though four states (Kansas, New Hampshire, Ohio, and Texas) may require additional procedures such as attaching state-specific forms.

**Can be obtained for free through healthcare providers and hospice partners.*

Elements of Five Wishes

1. **The Person I Want to Make Care Decisions for Me When I Can't:** Legally designates a person who will communicate with medical staff and make final decisions when you cannot. This can be a family member or a friend.
2. **The Kind of Medical Treatment Desired or Refused:** Specifies the extent of life-sustaining treatment you wish to receive, such as CPR, ventilator use, or artificial nutrition.
3. **How Comfortable I Want to Be:** Details specific requests for pain management and creating a peaceful environment (e.g., music, bathing, bedding).
4. **How I Want People to Treat Me:** Requests specific emotional considerations, such as how staff and family should interact with you, having family present, physical touch (holding hands), or religious support.
5. **What I Want My Loved Ones to Know:** Includes final messages to loved ones, funeral arrangements, and the philosophical legacy of how you wish to be remembered.

Execution Procedures (New Jersey)

- **Decision-Making and Consultation:** Reflect on your values and consult thoroughly with your primary care physician and family.
- **Document Preparation:** Complete the New Jersey standard form or the Five Wishes form.
 - Five Wishes is available for purchase (\$5) on their [official site](#) or for free through healthcare/hospice partners. **Korean version available.*
- **Legal Requirements:** Requires signatures from two adult witnesses (18 and above).
 - The designated Health Care Agent cannot serve as a witness.
 - To prevent disputes, it is recommended to choose a third party who is not a beneficiary of your estate.
 - **Notarization:** In lieu of witness signatures, you may sign before a Notary Public or an attorney-at-law.
- **Storage and Distribution:** Keep the original in a safe but accessible place (avoid locked safes). Provide copies to your family, primary physician, Health Care Agent (including alternates), and any hospital you expect to be admitted to.

Contact

Agency	Services Provided	Contact Information
NJ ADRC (Aging & Disability Resource Connection)	Service connection and counseling for seniors, individuals with disabilities (18 and above), and family caregivers by county.	1-877-222-3737 (Connects automatically to your local county office)
Bergen County Division of Senior Services	Information, assistance, and referrals for legal services.	One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601 201-336-7400 seniors@bergencountynj.gov
NNJLS (Northeast New Jersey Legal Services)	Free legal aid for low-income residents, seniors, and the disabled (subject to eligibility).	190 Moore Street, Suite 100, Hackensack, NJ 07601 201-487-2166 NNJLS.ORG
LSNJ (Legal Services of New Jersey Hotline)	Statewide legal hotline providing free legal advice and information.	1-888-576-5529 lsnjlawhotline.org

Resources

- [Medicare.gov: Advance Care Planning coverage for beneficiaries](https://www.medicare.gov/advance-care-planning-coverage-for-beneficiaries)
- [Official NJ Advance Directive Page \(including Downloadable Forms\)](#)
- [Five Wishes Forms and Information](#)
- [NJ211.org — Legal Assistance Available to Seniors](http://NJ211.org)

Age-Friendly Communities

An **Age-Friendly Community** is a global initiative dedicated to fostering physical and social environments where individuals can age safely, healthily, and actively within their own neighborhoods (**Aging in Place**). The criteria for age-friendly communities are applied in accordance with the standard guidelines established by the World Health Organization (WHO).

Key Areas of Support

- **Mobility and Transportation (Bergen Busing):** Complimentary **door-to-door** transportation services for Bergen County residents aged 60 and older, individuals with disabilities, and veterans.
 - This includes the operation of specialized **Senior Van** services.
- **Housing Modification and Stability:** Assistance with **home modifications** (such as installing grab bars for fall prevention), expanding access to low-income senior housing, and providing resources for property tax relief.
- **Social and Human Connection:** Socialization programs offered through over 20 senior centers in Bergen County, along with **reassurance call services** for socially isolated seniors.
- **Bridging the Digital Divide:** Education on smartphone and tablet usage to empower seniors to apply for government benefits online and stay connected with their families.
- **Safe Pedestrian Environments:** Improvements to the physical infrastructure, including extended crosswalk signal times, lowered curb heights, and the installation of adequate seating in public parks.

Support Systems

- **AARP Network of Age-Friendly States and Communities:** Provides technical guidelines for cities across the U.S. to improve the **8 Domains of Livability**.
 - **The 8 Domains of Livability include:**
 1. Outdoor Spaces and Buildings
 2. Transportation
 3. Housing
 4. Social Participation
 5. Respect and Social Inclusion
 6. Civic Participation and Employment
 7. Communication and Information

8. Community Support and Health Services

- **Age-Friendly North Jersey (AFNJ):** A statewide network of over 10 municipalities in Northern New Jersey, including Bergen County, focused on sharing best practices for aging-friendly environments.
- **Bergen County Division of Senior Services:** Oversees county-level age-friendly policies and provides comprehensive resources through the **Key Services Guide**.
 - In May 2022, Bergen County was officially designated as an Age-Friendly Community by AARP and the WHO.

How to Access Services

- **Verify Residency:** Confirm if your specific municipality is currently operating age-friendly initiatives.
- **Request Services:** Contact the county or local municipal senior center via telephone to book transportation or request housing assistance.
- **Community Engagement:** Participate in local age-friendly surveys or town hall meetings to suggest necessary improvements for your community.

Korean Community Support Agencies in Bergen County

Agency	Services Provided	Contact Information
AWCA	Senior Activity Center (social programs, congregate meals, health screenings). Home Care Services (Korean-speaking Home Health Aides) and a Welfare Consultation Hotline.	9 Genesee Ave., Teaneck, NJ 07666 201-862-1665 awcanj.org
Family Touch	Non-profit providing family counseling and mental health education. Offers senior depression programs with 50% fee subsidies (sliding scale based on income).	218 Main St, Little Ferry, NJ 07643 201-242-4422 familytouchusa.org
Give Chances	After-school education and art programs for low-income children and the disabled. Seniors can participate as mentors or volunteers.	500 Broad Ave, Palisades Park, NJ 07650 201-266-0640 givechances.org
KAANJ (Korean American Association of New Jersey)	Established in 1975 as a non-profit 501(c)(3). Focused on community advocacy, settlement assistance for new residents, local networking, and cultural event programming.	21 Grand Ave. #216-B, Palisades Park, NJ 07650 201-945-9456 kaanj.org
Korean American Senior Citizens Assoc. of NJ (KASCA NJ)	Integrated support for health, finance, and well-being. Operates a social welfare counseling center, medical info center, and beauty/barber volunteer services.	133 Fort Lee Rd. #3FL, Leonia, NJ 07605 201-945-2400 kascanj.org
KACE (Korean American Civic Empowerment)	Established in 1996 as a non-profit, nonpartisan organization. Conducts voter education, civic advocacy, youth leadership development, and grassroots community organizing.	263 Broad Ave., 2A Palisades Park, NJ 07650 201-488-4201 kace.org
KCS New Jersey (Korean Community Services of NJ)	Provides integrated programs for Korean and Asian immigrants, including mental health counseling, immigration services, workforce development, and public health programs. *Income and eligibility requirements apply.	100 Grove St., Tenafly, NJ 07670 201-541-1200 kcsus.org
MinKwon Center (MinKwon Center for Community Action)	Established in 1984. Provides social services for Korean, Asian, and immigrant communities, including immigration legal aid, citizenship application assistance, housing rights	316 Broad Ave., 2nd Fl., Palisades Park, NJ 07650

Agency	Services Provided	Contact Information
	advocacy, and public benefit enrollment (SNAP, HEAP). Also conducts civic engagement and voter education.	201-546-4657 minkwon.org

Contact

- **Bergen County Division of Senior Services:** 201-336-7400 | co.bergen.nj.us/division-of-senior-services
- **Age-Friendly North Jersey:** agefriendlynj.org
- **AARP Livable Communities:** aarp.org/livable
- **Bergen County Transportation (ADAPT):** 201-336-7400 (Senior shuttle reservations)
- **NJ 211:** Dial 211 or visit nj211.org

Resources

- [Bergen County Social Services Directory\(PDF\)](#)
- [Bergen County Key Services Guide \(PDF\)](#)
- [WHO Age-Friendly World](#)

Leisure Activities & Senior Centers

Structured physical activity and social engagement are critical factors in preserving cognitive function and extending longevity for older adults. Local **Senior Centers** provide a diverse array of programs designed to meet these needs.

Core Activities

- **Social Engagement:** Playing games (Chess, Cards) with peers, video calling family, and joining hobby-based clubs.
- **Learning Opportunities:** Classes in culinary arts, fine arts, and foreign languages; participating in book or film clubs; and learning musical instruments.
- **Community Involvement:** Volunteering at schools, libraries, or hospitals; participating in community gardening; and joining choral groups.
- **Physical Activity:** Gardening and yard work, senior-specific fitness classes, walking with friends, and swimming.
- **Stress Management:** Reading, practicing mindfulness, Tai Chi, or Yoga.

Senior Centers

Municipal and county-run senior centers throughout Bergen County, New Jersey, operate specialized programs. We encourage you to participate based on your personal interests and health status.

• Health & Wellness

- **Congregate Meals:** Balanced, nutritionist-designed lunches provided at an affordable rate (typically via a suggested donation). For those with limited mobility, these centers coordinate with [Meals on Wheels](#) delivery services.
- **Specialized Fitness Programs:**
 - **SilverSneakers:** A fitness program offered at no cost to many **Medicare Advantage** and **Supplement** plan members. Please verify eligibility with your insurance provider.
 - **Fall Prevention Education:** Balance training designed to prevent falls, the leading cause of accidental injury among seniors.
 - **Zumba Gold & Chair Yoga:** Low-impact dance and yoga sessions designed to be gentle on the joints.

- **Health Screenings:** Routine blood pressure monitoring, glucose checks, and guidance for seasonal Flu and COVID-19 vaccinations.

- **Lifelong Learning & Hobbies**

- **Digital Literacy:** Training on smartphone usage, video conferencing (**Zoom/FaceTime**), online banking, and **fraud/scam prevention** education.
- **Arts & Crafts:** Activities such as watercolor painting, calligraphy, knitting, and origami to strengthen cognitive function through fine motor skills.
- **Language Classes:** English as a Second Language (**ESL**) classes and multicultural language exchange programs unique to Bergen County's diverse community.

- **Transportation Services**

- **Shuttle Services:** Dedicated senior shuttles for center visits, local grocery shopping, and medical appointments. (Advance reservations are mandatory).

Senior Center Directory in Bergen County

Center Name	Address	Phone Number
AWCA Senior Activity Center	9 Genesee Ave., Teaneck, NJ 07666	201-862-1665
Bergenfield Senior Center	293 Murray Hill Ter., Bergenfield, NJ 07621	201-387-7212
East Rutherford Senior Center	147 Hackensack St., East Rutherford, NJ 07073	201-935-8920
Elmwood Park Senior Center	387 Market St., Elmwood Park, NJ 07407	201-796-3342
Garfield Senior Center	480 Vreeland Ave., Garfield, NJ 07026	973-478-0502
KCS New Jersey Social Adult Daycare(Private)	100 Grove St., Tenafly, NJ 07670	201-541-1200 x 111
North Arlington Senior Center	11 Bayard Ave., North Arlington, NJ 07031	201-998-5636
Northwest Senior Center	46-50 Center St., Midland Park, NJ 07432	201-445-5690
Ridgefield Park Senior Center	159 Park St., Ridgefield Park, NJ 07660	201-641-7170
Wallington Senior Center	24 Union Blvd., Wallington, NJ 07057	973-777-5815

Contact

- **Bergen County Division of Senior Services:** 201-336-7400
- [AARP Official Website](#)
- **NJ 211:** Statewide helpline for community resource connection. Call 211.
- [NJ Division of Parks & Forestry:](#) Information on the **Senior Pass** (Free admission to state parks for NJ residents 62+).
 - Call 1-800-843-6420
- **AWCA** provides counseling free of charge (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [List of County-Operated Senior Centers in Bergen County](#)
- [Bergen County Key Services Guide \(PDF\)](#)

Living Trust

This content is provided for informational purposes only. For specific legal advice, please consult with a qualified professional or an official government agency.

A **Living Trust** is a legal arrangement in which the asset owner (**Grantor/Settlor**) transfers the authority to manage their assets to a **Trustee** during their lifetime. It serves as a vital supplement to a Will by specifying how assets will be managed and distributed after the Grantor's passing.

Types of Living Trusts

- **Revocable Living Trust:** The most common form of trust. The Grantor retains full control over the assets and can modify or dissolve the trust at any time during their lifetime.
- **Irrevocable Living Trust:** Once established, this trust is extremely difficult to amend or revoke. It is primarily used for **asset protection**, estate tax reduction, or qualifying for government benefits such as **Medicaid (Long-term Care)**.

Key Advantages of a Living Trust

Avoidance of Probate

While a Last Will and Testament must go through the **Surrogate's Court** for **Probate**, a Living Trust allows assets to pass directly to beneficiaries without court intervention. Although New Jersey's probate process is relatively streamlined compared to other states, a trust ensures an even more immediate transfer of assets.

Privacy Protection

A Living Trust remains a private document; therefore, the size of the estate and the details of the distribution are not disclosed to the public. In contrast, a Will becomes a **Public Record** once filed with the court, making it accessible to anyone.

Incapacity Planning

If the Grantor becomes unable to manage their affairs due to illness (such as dementia) or accident, a pre-designated **Successor Trustee** can immediately step in to manage the assets. This bypasses the need for a costly and time-consuming court-ordered **Conservatorship** or **Guardianship** proceeding.

Protection of Assets for Minor Children

A Living Trust allows you to set specific conditions—such as milestone ages—for when children receive their inheritance, which promotes long-term financial stability.

Considerations

- **Setup and Maintenance Costs:** Establishing and maintaining a trust requires significant initial legal fees and administrative effort. For smaller estates, these costs may potentially exceed the eventual cost of probate.
- **Requirement of a "Pour-Over Will":** Even with a trust, a **Pour-Over Will** is essential. This ensures that any assets accidentally left out of the trust's name are legally "poured" into the trust upon the owner's death.
- **Funding the Trust:** Simply signing the trust documents is insufficient. For the trust to be effective, you must **"fund"** it by changing the titles of your assets—such as real estate (**Deeds**) and bank accounts—into the name of the trust (e.g., *The [Name] Living Trust*).
- **Alternative Options:** Simpler and more cost-effective methods for asset transfer exist, such as **Payable on Death (POD)** or **Transfer on Death (TOD)** designations on accounts.
- **Professional Selection:** Seek advice from a certified **Estate Planning Attorney**. If you meet certain income requirements, you may be eligible for free legal assistance through organizations such as the **Northeast New Jersey Legal Services (NNJLS)**.

Contact

Agency	Primary Services	Contact Information
NJ ADRC (Aging & Disability Resource Connection)	Service connection and counseling for seniors, individuals with disabilities (18 and above), and family caregivers by county.	1-877-222-3737 (Calls are automatically routed to your local county office)
Bergen County Division of Senior Services	Information, assistance, and referrals for legal services.	One Bergen County Plaza 2nd Floor Hackensack, NJ 07601 201-336-7400 seniors@bergencountynj.gov
NNJLS (Northeast New Jersey Legal Services)	Free legal aid for low-income residents, seniors, and the disabled (subject to eligibility).	190 Moore Street, Suite 100, Hackensack, NJ 07601 201-487-2166 NNJLS.ORG
LSNJ (Legal Services of New Jersey Hotline)	Statewide legal hotline providing free legal advice and information.	1-888-576-5529 lsnjlawhotline.org

Resources

- [New Jersey Will Registry Information](#)
- [NIH.gov–Getting Your Affairs in Order Checklist](#)
- [NCOA \(National Council on Aging–Estate Planning Checklist & Guide](#)

Instruction Directive (Living Will)

This content is provided for informational purposes only. For specific legal advice, please consult with a qualified professional or an official government agency.

An Instruction Directive, commonly referred to as a Living Will, is a component of an Advance Directive. It is a legal document in which you explicitly state the medical treatments you wish to receive or refuse under specific circumstances. This document becomes effective only after an attending physician formally determines that you have lost the capacity to make your own healthcare decisions. It serves as a crucial guide for family members and medical providers to honor your values and make informed decisions on your behalf.

Key Characteristics

- **Life-Sustaining Treatment:** Specific instructions regarding the refusal or acceptance of interventions intended to prolong life, such as Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) or mechanical ventilation.
- **Artificial Nutrition and Hydration:** Decisions on whether to continue artificial nutrition (feeding tubes) or intravenous (IV) hydration when you are no longer able to take food or water by mouth.
- **Renal Dialysis:** Instructions on whether to undergo blood filtration via a dialysis machine in the event of kidney failure.
- **Palliative and Hospice Care:** Choices regarding comfort-oriented care focused on pain management and a dignified end-of-life experience rather than life-prolonging interventions.

The Role of a Living Will

- **Secures Self-Determination:** Legally protects your right to make medical choices aligned with your personal values and religious beliefs.
- **Alleviates Family Burden:** Prevents potential guilt or conflict among family members who might otherwise struggle with treatment decisions during a crisis.
- **Provides Clear Clinical Guidance:** Communicates your wishes directly to medical staff, preventing unnecessary or unwanted aggressive interventions.

Drafting and Execution Procedures

Applications or inquiries can be made by individuals, legal representatives, government agencies, or hospitals. (You may draft this document yourself without the involvement of an attorney or physician.)

1. **Consultation:** Carefully consider your preferred scope of treatment and discuss these values with your family and primary care physician.
2. **Document Preparation:** New Jersey does not mandate a specific format; the NJ Department of Health standard form, Five Wishes, or a self-drafted document are all valid. (Often drafted alongside a Proxy Directive/Healthcare POA.)
3. **Legal Requirements:** Must be signed by two adult witnesses (excluding the designated Health Care Agent) OR signed before a Notary Public or attorney.
 - *Notarization is not mandatory if two witnesses are present.
4. **Storage and Sharing:** Provide copies to your primary physician, family, and your designated Health Care Agent.
 - *Keep the original in an accessible location. **Do not** store it in a locked safe or a Safe Deposit Box where it cannot be reached in an emergency.*

POLST

POLST (Practitioner Orders for Life-Sustaining Treatment) is an actual **Medical Order** used in conjunction with an Advance Directive along with Living Will. While an Advance Directive outlines your “wishes,” a POLST is an official order signed by a physician (or APN/PA) based on those wishes. It is a binding document that first responders, ER staff, and nursing home personnel must follow immediately in an emergency.

****A POLST does not replace an Advanced Directive and Living Will. The Advance Directive sets the general direction, while the POLST provides specific, actionable instructions for **emergency scenes**.***

When is a POLST Necessary?

A POLST is not for everyone. Consultation with a physician is recommended for individuals who:

- Have a serious, chronic, or progressive illness, or a life expectancy of less than 5 years.
- Are planning to enter a nursing home or long-term care facility.
- Are receiving in-home hospice services.
- Have an increased risk of emergency due to advanced age.

Medical Treatment Level Codes

- **Full Code**
 - Perform all possible resuscitative measures (CPR, ventilator, defibrillation) in the event of cardiac or respiratory arrest.
 - This is the hospital default unless otherwise specified.

- **DNR (Do Not Resuscitate)**

- Instructs medical staff **not** to perform CPR if your heart or breathing stops.
- Other treatments (oxygen, medication, pain relief) will continue.

- **DNI (Do Not Intubate)**

- Refuses the insertion of a breathing tube (intubation) for mechanical ventilation.
- This is distinct from DNR; if only DNI is specified, CPR may still be performed.

- **DNH (Do Not Hospitalize)**

- Directs that you receive **Comfort Care** at your current residence (home, nursing home) rather than being transferred to a hospital during an emergency.
- Typically applied to hospice or long-term care patients.

Keep your completed POLST (green paper) in a prominent location (refrigerator door, bedside, etc.) and share copies with your doctor and agent.

Contact

Agency	Services Provided	Contact Information
NJ ADRC (Aging & Disability Resource Connection)	Service connection and counseling for seniors, individuals with disabilities (18 and above), and family caregivers by county.	1-877-222-3737 (Connects automatically to your local county office)
Bergen County Division of Senior Services	Information, assistance, and referrals for legal services.	One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601 201-336-7400 seniors@bergencountynj.gov
NNJLS (Northeast New Jersey Legal Services)	Free legal aid for low-income residents, seniors, and the disabled (subject to eligibility).	190 Moore Street, Suite 100, Hackensack, NJ 07601 201-487-2166 NNJLS.ORG
LSNJ (Legal Services of New Jersey Hotline)	Statewide legal hotline providing free legal advice and information.	1-888-576-5529 lsnjlawhotline.org

Resources

- Medlineplus.gov – Advance Care Directive
- NJ.gov – Advance Directive
- NJ.gov – Living Will (Instruction Directive) Form (PDF)
- [NJ 211.org](http://NJ211.org)–Legal Assistance for Seniors
- [Five Wishes](#)
- [Five Wishes – Sample \(PDF\)](#)
- NJ.gov – POLST

Medicaid Trusts

This content is provided for informational purposes only. For specific legal advice, please consult with a qualified professional or an official government agency.

A **Medicaid Trust** is a legal instrument designed to help seniors or individuals with disabilities protect and manage their assets while maintaining eligibility for government benefits. It is essential to select the appropriate trust type based on your specific objectives and circumstances.

Primary Types

- **Revocable Trusts:** Offers high flexibility as the grantor can modify or terminate the trust at any time. While useful for **probate avoidance**, they are generally not suitable for Medicaid asset protection because the assets are still considered countable resources in eligibility assessments.
- **Irrevocable Trusts:** Once established, these trusts generally cannot be modified or revoked. While any portion that could potentially be paid to the grantor may still be counted as an asset, a properly structured Irrevocable Trust is highly effective for **Medicaid planning and asset protection**.
- **Pooled Trusts:** Managed by non-profit organizations, these trusts are available to individuals with disabilities of all ages. Assets from multiple beneficiaries are pooled for investment purposes to increase returns, though individual sub-accounts are maintained. *In New Jersey, if your income exceeds the Medicaid limit, a **Qualified Income Trust (QIT/Miller Trust)** is required. Pooled trusts are primarily used to safeguard a disabled person's assets to enhance their quality of life without disqualifying them from Medicaid.*
 - Individuals 65 or older should consult a professional before transferring assets to a pooled trust, as a **Look-back Penalty** may apply.
- **Qualified Income Trust (QIT / Miller Trust):** In New Jersey, if an individual's monthly income exceeds the institutional Medicaid limit (\$2,982 as of 2026), the excess income must be deposited into a QIT to maintain eligibility.

** Limits are subject to annual update; check the latest [NJ DHS](#) standards.*

Benefits

- **Asset Protection:** Prevents the depletion of your estate by high medical or long-term care costs, establishing a foundation for passing assets to the next generation.
 - Medicaid may seek to recover costs for services provided to individuals 55 and older from their estate after death.

- Recovery is deferred if there is a surviving spouse, a child under 21, or a disabled child. A properly established trust helps shield assets from this recovery process.
- **Maintenance of Eligibility:** Assists in receiving necessary welfare benefits while complying with Medicaid's strict asset and income limitations.
 - 2026: *Individual Asset Limit \$2,000 / Income Limit \$2,982 per month. (Subject to annual [NJ DHS updates](#)).*
- **Professional Management:** Especially in the case of Pooled Trusts, professional non-profits manage the assets, ensuring transparency and stability.
- **Long-Term Care Planning:** The **Look-back Period** involves a 60-month (5-year) review of asset transfers prior to a long-term care Medicaid (MLTSS) application. Transfers made for less than **Fair Market Value** during this window will trigger a **Penalty Period** (delay in benefits). Advance planning is essential.

Implementation Procedures

1. **Professional Consultation:** Work with a specialized attorney to analyze your financial situation and Medicaid eligibility.
2. **Determination of Trust Type:** Select the optimal trust model based on asset size, health status, and family needs.
3. **Drafting and Notarization:** Legal requirements vary by trust type. Notarization is recommended for standard trusts; a QIT requires DHS-approved templates and the opening of a dedicated bank account.
4. **Funding the Trust:** Complete the process by retitling assets (e.g., real estate, accounts) into the name of the trust.

Contact

Agency	Services Provided	Contact Information
NJ ADRC (Aging & Disability Resource Connection)	Service connection and counseling for seniors, individuals with disabilities (18 and above), and family caregivers by county.	1-877-222-3737 (Connects automatically to your local county office)
Bergen County Division of Senior Services	Information, assistance, and referrals for legal services.	One Bergen County Plaza 2nd Floor Hackensack, NJ 07601 201-336-7400 seniors@bergencountynj.gov
NNJLS (Northeast New Jersey Legal Services)	Free legal aid for low-income residents, seniors, and the disabled (subject to eligibility).	190 Moore Street, Suite 100, Hackensack, NJ 07601 201-487-2166 NNJLS.ORG
LSNJ (Legal Services of New Jersey Hotline)	Statewide legal hotline providing free legal advice and information.	1-888-576-5529 lsnjlawhotline.org

References

- [NJ.gov – Qualified Income Trusts](#)
- [NJ.gov – Estates and Trusts \(PDF\)](#)

Power of Attorney (POA)

This content is provided for informational purposes only. For specific legal advice, please consult with a qualified professional or an official government agency.

A **Power of Attorney (POA)** is a legal instrument that authorizes a trusted third party (referred to as the “Attorney-in-Fact” or “Agent”) to act on your behalf in legal, financial, and medical matters. This is typically established to ensure your affairs are managed if you become unable to make decisions due to physical or mental incapacity, or absence. It serves as a vital safeguard to honor your wishes and protect your interests in unforeseen circumstances.

Under New Jersey law, an agent must be **at least 18 years of age and must possess the mental capacity to act.*

Key Characteristics

- **Flexible Configuration:** POA documents can be tailored to specific needs, such as a “Limited POA” for a set duration or a “Springing POA” that only becomes effective upon a specific condition.
- **Revocability and Amendment:** As long as the principal (the person granting the power) remains mentally competent, they may modify or revoke the POA at any time in writing. Such changes must be communicated to the agent and relevant institutions.
- **Legal Continuity:** In New Jersey and New York, a standard POA is typically terminated if the principal loses mental capacity. (varies by state)
 - To ensure continued authority after the principal becomes incapacitated, a “**Durable Power of Attorney**” clause must be explicitly included in the document.

Primary Authorities of the Agent

- **Financial and Legal Matters:** Managing bank accounts, buying/selling assets, filing tax returns, and executing legal contracts.
- **Healthcare and Medical Decisions (Medical POA):** Selecting treatment options, consenting to surgical procedures, and managing hospital admissions/discharges.
 - *In New Jersey, a Medical POA is formally known as a **Proxy Directive** (Durable Power of Attorney for Health Care) and is a component of an **Advance Directive**.*
- **Personal Care and Welfare:** Making decisions regarding daily residence and selecting personal care services.

- **Educational Decisions:** Acting on behalf of minor children or the principal regarding academic services and educational matters.
- **Travel and Logistics:** Planning travel, managing passports, and handling administrative tasks related to relocation.

Considerations for Drafting

- **Selection of Agent:** Since the agent is legally bound to act in your best interest, you must choose a highly trustworthy individual. The principal must be at least 18 years old and mentally competent at the time of signing.
- **Notarization:** In New Jersey, a **Financial POA** must be signed before a Notary Public to be legally enforceable. A **Proxy Directive** requires either two adult witnesses or notarization.
- **Expiration:** A POA expires immediately upon the death of the principal. Following death, asset management is governed by a **Last Will and Testament** or through the **Estate Probate Process**.

**New Jersey does not provide a standard official form for a Financial POA; professional legal consultation is recommended.*

Contact

Agency	Services Provided	Contact Information
NJ ADRC (Aging & Disability Resource Connection)	Service connection and counseling for seniors, individuals with disabilities (18 and above), and family caregivers by county.	1-877-222-3737 (Connects automatically to your local county office)
Bergen County Division of Senior Services	Information, assistance, and referrals for legal services.	One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601 201-336-7400 seniors@bergencountynj.gov
NNJLS (Northeast New Jersey Legal Services)	Free legal aid for low-income residents, seniors, and the disabled (subject to eligibility).	190 Moore Street, Suite 100, Hackensack, NJ 07601 201-487-2166 NNJLS.org
LSNJ (Legal Services of New Jersey Hotline)	Statewide legal hotline providing free legal advice and information.	1-888-576-5529 lsnjlawhotline.org

Resources

- [NJ Department of Health — Official Proxy Directive \(Medical POA\) Form \(PDF\)](#)
- [NJ211.org — Legal Assistance Available to Seniors](#)

Reverse Immigration to Korea

This content is provided for informational purposes only. For specific legal advice, please consult with a qualified professional or an official government agency.

Reverse Immigration refers to the process where overseas Koreans relocate their primary residence back to South Korea. Legally, this involves "Reporting Permanent Return" and "Restoration of Nationality." It is crucial to understand the resulting changes in taxation, health insurance, and welfare benefits beforehand.

Strategic Considerations: Which Path is Best for You?

Scenario A: Maintaining Dual Citizenship

- **U.S. Pension Recipients:** Those who wish to receive stable Social Security (SSA) benefits while accessing Korea's affordable, high-quality healthcare.
- **Parents with Children in the U.S.:** Those who may need to stay in the U.S. long-term at any time to visit family.
- **Asset Holders in the U.S.:** Those who need to manage or bequeath U.S. real estate or investment assets.

Scenario B: Formal Renunciation of U.S. Status

- **High-Net-Worth Individuals:** Those wishing to eliminate complex U.S. tax reporting obligations and the burden of double taxation (requires an **Expatriation Tax** assessment).
- **Individuals with No Intent to Return:** Those who, due to health or personal reasons, have no future plans to return to the U.S.
- **Seekers of Exclusive Domestic Benefits:** Specific situations where foreign citizenship may be a hurdle, such as entering public office or high-level national security roles.

Procedures

- **Report of Permanent Return:** A procedure for overseas Koreans returning with the intent to reside permanently in Korea, filed at the local immigration office.
- **Nationality Restoration (Ages 65+):** U.S. citizens aged 65 or older may enter Korea, apply for nationality restoration, and maintain dual citizenship by signing a "**Vow Not to Exercise Foreign Nationality**" within Korea.

- **Resident Card (F-4/Residence Report):** Used as a substitute for a Resident Registration Card for financial and medical transactions prior to nationality restoration or for long-term stays as a citizen of another country.

Areas of Review

Considerations

The following sections regarding the **Expatriation Tax, Final Tax Filing, Formal Renunciation Procedures**, and **South Korean Nationality Verification** apply specifically to **<Scenario 2: Renunciation of U.S. Status>**. For **<Scenario 1: Maintaining U.S. Citizenship>** and **<Scenario 3: Maintaining U.S. Permanent Residency>**, the sections on **Foreign Account Reporting (FBAR/FATCA)** and **Double Taxation Prevention** apply globally.

1. Taxation and Asset Management

- **Expatriation Tax (Exit Tax):** Citizens exceeding specific asset or income thresholds must evaluate their tax obligations before renouncing citizenship. You are considered a **"Covered Expatriate"** if you meet any of the following:
 - **Net Worth Test:** Global net worth of **\$2,000,000** or more at the time of expatriation.
 - **Tax Liability Test:** Your average annual net income tax for the 5 years prior exceeds the statutory threshold (**\$206,000 for 2025 / \$211,000 for 2026** — adjusted annually).
 - **Compliance Test:** Failure to certify that you have met all U.S. federal tax obligations for the 5 years preceding expatriation.
 - *Even if your assets are minimal, you must verify that you have filed for the past 5 years to avoid this status.*
- **Foreign Account Reporting (FBAR/FATCA):** If you retain U.S. citizenship or a Green Card after relocating to Korea, you must report your Korean financial accounts to the IRS annually.
 - **Pre-Renunciation:** Ensure all tax filings are up to date through the year of expatriation.
 - **Reporting Compliance:** *Continue FBAR and FATCA reporting through the official date of expatriation.*
- **Prevention of Double Taxation:** Professional consultation is essential to determine which country has taxing rights over your pension or rental income based on the **U.S.-Korea Tax Treaty**.

2. Final Tax Filing (The Year Following Renunciation)

- You must submit **Form 8854 (Initial and Annual Expatriation Statement)** to the IRS. Your tax relationship with the U.S. is not officially terminated until this form is filed.
 - *Failure to file Form 8854 may result in an **annual penalty of \$10,000** and ongoing U.S. tax obligations.*

3. Formal Renunciation Procedures

- **For U.S. Citizens:**

- Schedule an appointment with the **U.S. Embassy in Seoul** (or a consulate in the U.S.) for a renunciation interview. *Wait times may span several months.*
- The consular officer will verify that you fully comprehend the legal implications and consequences of renouncing.
- Perform the official **Oath of Renunciation** and receive your **Certificate of Loss of Nationality (CLN)**.
- **Fee: \$450** (Effective April 13, 2026 — *reduced from the previous \$2,350*).

- **For Green Card Holders (LPRs):**

- Complete **Form I-407 (Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status)** and submit it to USCIS or the U.S. Embassy.
- This is processed via documentation without an interview; you must surrender your **Green Card** at this time.

4. Verification or Restoration of South Korean Nationality

- **If you already hold South Korean Nationality:** File for the reinstatement of your **Resident Registration** without additional procedures.
- **If South Korean Nationality was lost:** Apply for **Nationality Restoration** through the Korea Immigration Service or the **Overseas Koreans Agency (OKA)**. *Processing takes approximately 6 months to 1 year.*
- *Once completed, you can receive your **Resident ID Card** at a local community center and begin applying for health insurance and other welfare benefits.*

5. Health Insurance and Welfare Benefits

- **National Health Insurance (NHI):** You may become eligible after residing in Korea for a specific period (typically 6 months) or immediately upon reporting your **Permanent Return**.
- **Basic Pension and Senior Welfare:** After Resident Registration is complete, you may access senior benefits, such as the **Basic Pension** (subject to income tests) and free subway transit for seniors.

6. Receipt of Social Security Benefits

- Eligible individuals can continue to receive **U.S. Social Security** payments while residing in Korea.
 - However, since eligibility conditions may vary between citizens and Green Card holders, direct verification with the **Social Security Administration (SSA)** is required.

7. Relocation and Housing

- **Duty-Free Moving Goods:** If you have resided abroad for more than one year and import your household goods within 6 months of your return, you may be eligible for a **Customs Duty Exemption**. *Contact the **Korea Customs Service** (1544-1285 / customs.go.kr) for specific requirements.*

- **Document Authentication:** U.S.-issued documents (Birth/Marriage Certificates, FBI Background Checks) **must** be authenticated with an **Apostille** to be legally valid in Korea.
- **Green Card Maintenance:** If a Green Card holder stays in Korea long-term without a **Re-entry Permit**, they may be deemed to have abandoned their residency. Decide whether to apply for this permit before departure.
- **Administrative Gap:** Account for the “administrative gap” between surrendering your U.S. passport and receiving South Korean identification. Consolidate financial transactions and banking matters beforehand.

Comparison of Reverse Immigration Scenarios

Scenario 1. Maintaining U.S. Citizenship & Restoring South Korean Nationality (Dual Citizenship)

This applies to individuals who lost their South Korean nationality upon acquiring U.S. citizenship but now wish to restore their Korean nationality while retaining their U.S. status.

Key Procedures

1. Pre-Departure Preparation (3–6 months prior to relocation)

- **FBI Criminal Background Check:** Obtain your **Identity History Summary** from the FBI and secure an **Apostille** from the U.S. Department of State.
 - This document is generally valid for only 6 months.
- **Document Gathering:** Organize originals and copies of essential records, including your **Certificate of Naturalization** and Marriage Certificate.
- **Tax Review:** Consult with a CPA to understand that your **U.S. Tax Filing (IRS)** and **Foreign Account Reporting (FBAR/FATCA)** obligations continue even while residing in Korea.
- **U.S. Asset Management:** Decide whether to maintain U.S. bank accounts, dispose of real estate, and set up a mail forwarding service.
- **SSA International Payment Setup:** Research and plan for a Korean bank account (e.g., a foreign currency account) to receive your Social Security benefits.

2. Entry into Korea & Report of Nationality Loss

- **Entry on U.S. Passport:** You **must** use your U.S. passport to enter South Korea. (A visa-free entry typically allows for a 90-day stay).
- **Report of Nationality Loss:** This is an administrative step to formally record the loss of your Korean nationality that occurred when you naturalized in the U.S. Visit the local Immigration Office or the **Overseas Koreans Agency (OKA)** Service Center.
 - *The nationality restoration process cannot begin until your Family Relationship Register is updated to reflect this loss.*

3. F-4 Visa Issuance & Nationality Restoration Application (Ages 65+)

- **F-4 (Overseas Korean) Visa & Residence Report:** Apply for a **Domestic Residence Card** first. This card serves as your legal ID for financial and medical services during your long-term stay.
- **Application for Nationality Restoration:** Once the Residence Card is issued, submit your application for nationality restoration to the Immigration Office.
 - **Processing Time:** Typically 6 months to 1 year (varies by Ministry of Justice workload).
- **Notification of Approval:** Upon receiving the official approval notice from the Ministry of Justice, visit your local community service center.

4. Vow Not to Exercise Foreign Nationality & Resident Registration

- **The Non-Exercise Vow:** Within one year of approval, you must visit the Immigration Office to sign a formal declaration stating you will **not exercise your rights as a U.S. citizen** while within South Korean territory.
 - *Failure to do this within the one-year window may result in the cancellation of your nationality restoration.*
- **Resident ID Issuance:** Take your Vow Confirmation to a local community center to receive your **Resident Registration Card**. At this stage, you legally hold both ROK and U.S. passports.
- **Surrender of Residence Card:** Your old Residence Card must be returned. From this point forward, you must use your **Korean passport** for entry and exit in South Korea.

5. Post-Settlement Procedures

- **Health Insurance Enrollment:** Immediately after Resident Registration, visit the **National Health Insurance Service (NHIS)** to verify your eligibility.
- **Basic Pension Application:** If you are 65+ and meet the income criteria, apply at your local community center.
 - **2026 Criteria:** Monthly recognized income of 2.47 million KRW or less for single-person households. Standards are updated annually by the Ministry of Health and Welfare (check bokjiro.go.kr).
 - **Note:** U.S. Social Security benefits are included in income calculations.
- **Update SSA Records:** Update the **Social Security Administration (SSA)** with your new Korean address and banking information.

Pros	Cons
Dual Welfare Benefits: Concurrent access to Korea's National Health Insurance and senior perks (e.g., free subway transit) alongside U.S. Social Security (SSA) benefits.	Dual Tax Reporting: You remain obligated to file annual income tax returns with the U.S. IRS on your worldwide income while living in Korea.
Freedom of Residence: Ability to travel freely between the U.S. and Korea without visa concerns and the right to reside indefinitely in either country.	Financial Transaction Constraints: Due to FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) , you may face complex administrative hurdles when opening certain bank accounts or managing assets in Korea.
Full Property Rights: Full legal protection for acquiring real estate, managing inheritances, or gifting assets in both nations.	Non-Exercise Vow: You are legally prohibited from asserting your rights or protections as a U.S. citizen while in South Korea.

Scenario 2. Renouncing U.S. Status & Maintaining/Restoring South Korean Nationality

This applies to individuals who choose to fully relinquish their U.S. Citizenship or Legal Permanent Residency to settle exclusively under South Korean nationality.

Key Procedures

1. Tax Preparation (6 months to 1 year prior to departure)

- Consult with a CPA or tax professional to determine if you meet any of the three criteria for **"Covered Expatriate"** status. Meeting even one of these may trigger the **Expatriation Tax (Exit Tax)**:
 - **Net Worth Test:** Global net worth of **\$2,000,000** or more at the time of expatriation.
 - **Tax Liability Test:** Your average annual net income tax for the 5 years prior exceeds the statutory threshold (**\$206,000 for 2025 / \$211,000 for 2026** — *adjusted annually*).
 - **Compliance Test:** Failure to certify tax compliance for the 5 years preceding expatriation.
 - *This applies regardless of asset size. You must verify that you have fulfilled all filing obligations for the past 5 years.*

2. Complete Final U.S. Tax Filings (Prior to Renunciation)

- **FBAR/FATCA Reporting:** Maintain up-to-date filings for the year of expatriation. Ensure all **Foreign Bank Account Reports (FBAR)** and **FATCA** obligations are fulfilled up to the date of status relinquishment.

3. Formal Renunciation Process

- **For U.S. Citizens:**
 - Schedule an appointment for a renunciation interview at the **U.S. Embassy in Seoul** (or a consulate in the U.S.). *Wait times may span several months.*

- Participate in a consular interview to confirm you fully understand the legal implications and consequences of renouncing.
 - Perform the official **Oath of Renunciation** and receive your **Certificate of Loss of Nationality (CLN)**.
 - **Fee: \$450** (Effective April 13, 2026 — *reduced from \$2,350*).
- **For Green Card Holders (LPRs):**
 - Complete and submit **Form I-407 (Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status)** to USCIS or the U.S. Embassy.
 - This process is handled via documentation without an interview; you must surrender your **Green Card** upon submission.

4. Final Tax Filing (The year following renunciation)

- Submit **Form 8854 (Initial and Annual Expatriation Statement)** to the IRS. This document is required to officially terminate your tax relationship with the United States.
 - *Failure to file Form 8854 may result in an **annual penalty of \$10,000** and the continuation of your U.S. tax obligations.*

5. Verification or Restoration of South Korean Nationality

- **If you already hold South Korean Nationality:** Apply for the reinstatement of your **Resident Registration** at a local community center.
- **If South Korean Nationality was previously lost:** Apply for **Nationality Restoration** through the Immigration Office or the **Overseas Koreans Agency (OKA)**.
 - *Approximately 6 months to 1 year (subject to Ministry of Justice workload).*
- Obtain your Resident Registration Card at your local community center and begin applications for National Health Insurance, the Basic Pension, and other senior welfare benefits.

Pros	Cons
Termination of Tax Obligations: You are no longer required to file income tax returns or FBAR/FATCA reports with the U.S. IRS.	U.S. Re-entry Restrictions: Future visits to the U.S. will require a visa-free waiver (ESTA) or a visitor visa, and your duration of stay will be limited.
Administrative Simplification: Financial and real estate transactions are streamlined as you only need to manage your identity as a South Korean citizen.	Expatriation Tax (Exit Tax): For high-net-worth individuals, the IRS may treat assets as if they were sold on the day of expatriation, resulting in significant tax liability.
Emotional Stability: Provides a sense of complete integration and belonging as a full member of South Korean society.	Irreversibility: Once U.S. citizenship is formally renounced, it is extremely difficult to regain in the future.

Scenario 3. Maintaining U.S. Permanent Residency & South Korean Nationality

This applies to U.S. Green Card holders who relocate to South Korea but wish to preserve their Lawful Permanent Resident (LPR) status.

Key Procedures

1. Application for a Re-entry Permit (Mandatory Before Departure)

- File **Form I-131 (Application for Travel Document)** with **USCIS** while you are still physically present in the United States.
- **Timing is Critical:** *You must apply **before** leaving the U.S.* It is highly recommended to remain in the country until your **Biometrics (fingerprinting)** appointment is completed, as the application cannot be initiated from abroad.
- **Validity:** A Re-entry Permit is typically valid for **2 years**. You must return to the U.S. within this period to maintain your Green Card status.
 - *Staying outside the U.S. for more than one year without a Re-entry Permit may lead to the automatic loss of your Permanent Resident status.*

2. Entry into Korea & Report of Permanent Return

- Enter South Korea with your valid Re-entry Permit and Green Card.
- File a **Report of Permanent Return** at the local Immigration Office or the **Overseas Koreans Agency (OKA)** Service Center.
- Upon filing, your administrative status changes from "Overseas Citizen" to "Resident," and your **Resident Registration** is restored.
 - **Identification:** *As a Green Card holder, you will be issued a **Resident Registration Card for Overseas Koreans** rather than a standard Resident ID. Please note that there may be slight variations in how certain administrative services are accessed with this card.*

3. Enrollment in Health Insurance and Welfare Benefits

- You are eligible to enroll in the **National Health Insurance (NHI)** program immediately upon the restoration of your Resident Registration.
- If you are aged 65 or older and meet the income threshold, you may apply for the **Basic Pension** at a local community center.
 - *U.S. Social Security (SSA) benefits are included in your total income calculation, so verify your eligibility for the Basic Pension in advance.*

4. Ongoing U.S. Tax Compliance

- As a Green Card holder, you maintain **U.S. Tax Resident** status even while living in Korea.
- You are required to report all worldwide income—including wages, rental income, and pensions earned in Korea—to the **IRS**.
- Foreign Account Reporting (FBAR/FATCA):

- **FBAR:** You must file **FinCEN Form 114** if the aggregate value of your Korean financial accounts exceeds **\$10,000** at any time during the year.
- **FATCA:** You must file **Form 8938** if you meet the specific asset thresholds.
 - *FATCA Standards for Residents in Korea (Single Filers):* Filing is required if assets exceed **\$200,000** at year-end (December 31st) or **\$300,000** at any point during the year. (These limits differ significantly from the \$50,000/\$75,000 thresholds for U.S. residents; consult a CPA for specific guidance based on your filing status).

5. Renewal of Re-entry Permit and Long-Term Strategy

- You must return to the United States to confirm your intent to maintain residency before your 2-year permit expires.
- If necessary, you may re-apply for a new **I-131 Re-entry Permit** while in the U.S.
 - Repeated renewals may lead USCIS to determine that you lack a **“bona fide intent to reside permanently”** in the U.S., which could result in the revocation of your Green Card. Long-term, it is more practical to either apply for **U.S. Naturalization** or formally abandon your **Green Card (Scenario 2)**.

Pros	Cons
Preservation of U.S. Residency: Serves as a reliable " Backup Plan " should you decide to return to the United States in the future.	Maintenance Hardships: You must renew your Re-entry Permit every two years, and frequent renewals carry the risk of status revocation.
South Korean Health Insurance: You gain immediate access to the South Korean National Health Insurance system through the Permanent Return report.	Ambiguous Administrative Status: In South Korea, you are classified as an "Overseas Citizen," requiring the use of a specialized Resident ID card rather than a standard one.
	Dual Tax Obligations: You remain burdened with reporting all income and foreign accounts (FBAR/FATCA) to the IRS while residing in Korea.

Key Agencies and Contacts

	Agency	Primary Services	Contact Information
South Korean Government Agencies	Overseas Koreans Agency (OKA)	Comprehensive guidance on permanent return, nationality restoration, and general services for overseas Koreans (Established 2023).	oka.go.kr +82-2-6747-0404
	Hi Korea (Immigration Service)	Ministry of Justice portal for domestic residence reporting, immigration control, visa information, and online applications.	hikorea.go.kr 1345 (Direct line within Korea)
	Consulate General of the Republic of Korea in New York	Reporting loss or restoration of nationality, Apostille authentication, and passport services.	overseas.mofa.go.kr/us-newyork-ko/index.do 646-674-6000
	National Health Insurance Service (NHIS)	Inquiries regarding health insurance eligibility and enrollment for overseas Koreans; verification of immediate coverage upon return.	nhis.or.kr +82-1577-1000
U.S. Federal Agencies	Social Security Administration (SSA)	Information on benefit eligibility for residents abroad and applications for international direct deposit to Korean accounts.	ssa.gov/foreign 800-772-1213
NJ Korean Community Resources	Korean American Association of New Jersey (KAANJ)	Established in 1975 as a 501(c)(3) nonprofit. Provides networking for the reverse immigration community, resettlement support, and local resource guidance.	21 Grand Ave. #216-B, Palisades Park, NJ 07650 201-945-9456 kaanj.org/

Senior Transportation Services

Senior transportation support provides safe and convenient mobility options for older adults at little to no cost. These services are designed to help seniors maintain independent living, prevent social isolation, and facilitate easier access to medical facilities.

Key Features

- **Door-to-Door Service**
 - **Customized Pickup:** Safe and convenient transit from your doorstep to your final destination.
 - **Personalized Assistance:** Drivers can provide physical support during boarding or operate wheelchair lifts upon request.
- **Cost-Effective Benefits**
 - **Complimentary Access:** Most county and municipal shuttles are free of charge or operate on a "Suggested Donation" basis.
 - **Affordable Rates:** Private non-profit transportation organizations provide specialized services at reduced costs.
- **Reservation-Based Systems**
 - **Scheduled Bookings:** Vehicles arrive and depart at pre-arranged times, requiring advance reservations.
 - **Monitoring Systems:** Select services offer real-time vehicle tracking, allowing family members or caregivers to monitor the transit process.

Major Transportation Services in Bergen County

Service Category	Bergen County Community Transportation	EZ Ride (Non-profit TMA)	NJ Transit (Public Transit)	Municipal Senior Shuttles
Eligibility	Seniors (60+), Adults with Disabilities (18+), and Veterans.	Adults 18 and older.	Reduced Fare: Seniors (62+). Access Link: Individuals with disabilities unable to use fixed-route transit.	Seniors residing in the specific municipality.
Service Description	Transportation to senior centers, medical facilities, supermarkets, etc.	Provision of Uber/Lyft rides and dedicated shuttle vehicles.	Statewide access via bus, rail, and light rail. Access Link provides paratransit services. *MicroLink service available (pilot test)	Local circulation within the town, including senior centers, hospitals, and shopping malls.
Cost	Free of charge.	Fee-based (at discounted rates).	Reduced Fare: 50% discount on bus/rail. Access Link: Fee-based (standard bus fare equivalent; Reduced Fare cards not accepted).	Free of charge (or suggested donation).
How to Access	Pre-registration and advance booking with the County Division of Transportation.	Pre-registration required. 201-939-4242 ext.4 *on-demand request available. *no reservation needed	Reduced Fare: Present Senior ID or Medicare Card Access Link: Mandatory advance reservation (973-491-4224)	Contact your local Town Hall for specific routes and schedules.
Contact	201-368-5955	201-939-4242	Reduced Fare: 973-275-5555	Fort Lee: 201-592-3500 ext.

Service Category	Bergen County Community Transportation	EZ Ride (Non-profit TMA)	NJ Transit (Public Transit)	Municipal Senior Shuttles
			Access Link: 973-491-4224	1518 Palisades Park: 201-585-4114 Teaneck: 201-837-7130 ext. 7040

***MicroLink**(from home to nearest bus stop) from NJ Transit is currently in a pilot service phase. Please refer to the [official page](#) for more details.

Considerations

- **Advance Reservations:** Most county and municipal services require booking at least a few days to two weeks in advance.
- **Service Boundaries:** County and local shuttles typically operate only within designated regional limits.
- **Companion Policies:** Please specify if you use a wheelchair or require a caregiver companion at the time of booking.

Resources

- [NJ DOT — Transportation Management Association \(TMA\) Directory](#)
- [NJ Transit — Reduced Fare Program for Seniors & Persons with Disabilities](#)
- [NJ.gov — Transportation Application Guide for Seniors & Disabled Individuals](#)
- [EZRide.org Bergen County Mobility Guide \(PDF\)](#)
- [NJ Transit Access Link — ADA Paratransit Service](#)
- [Bergen County Community Transportation Guide \(2025 PDF\)](#)
- [NJ 211 — Comprehensive Guide to NJ Transportation Services](#)

Will

This content is provided for informational purposes only. For specific legal advice, please consult with a qualified professional or an official government agency.

A **Will** is a legal document that formally outlines an individual's final wishes regarding the distribution of assets, guardianship of minor children, and the appointment of an executor after their passing. A Will helps prevent confusion and disputes among surviving family members, ensuring that the estate is managed according to the decedent's wishes rather than by court-mandated procedures.

Any adult who is at least 18 years of age and mentally competent (possessing testamentary capacity) may execute a Will.

Key Characteristics

- **Clarity of Asset Distribution:** You designate specific beneficiaries for all assets, including real estate, bank accounts, and personal belongings.
 - *New Jersey does not impose an Estate Tax, but an **Inheritance Tax** may apply. Immediate family members (Class A beneficiaries, such as spouses, children, parents, and grandchildren) are exempt.*
 - *However, Class C or D beneficiaries (siblings, friends, etc.) may be subject to taxation.*
 - * For specific legal advice consult a tax professional.*
- **Protection of Minors:** Protect your children's welfare by pre-designating a legal Guardian to care for them in the event of your passing.
- **Appointment of an Executor:** Designate a trusted individual or institution to faithfully carry out the terms and conditions of the Will.
- **Simplified Legal Procedures:** Without a Will, assets are distributed according to **Intestacy Laws**, and the court will oversee the estate administration at its discretion. With a Will, assets are distributed according to your wishes through the **Probate** process, overseen by the **Surrogate's Court**.

Primary Components

1. **Appointment of an Executor:** Designate a representative to manage the entire process, including funeral arrangements, tax payments, and the distribution of assets.
2. **Specification of Beneficiaries:** Clearly identify individuals or charitable organizations intended to receive your assets.
3. **Guardianship Provisions:** If you have children under 18, designate a guardian to provide care in your absence.

4. **Settlement of Debts and Taxes:** Include instructions on how to settle outstanding debts and pay any applicable inheritance taxes.
5. **Residuary Clause:** Determine the distribution of any remaining property not specifically mentioned elsewhere in the document.

Considerations

- **Holographic Wills:** A Will that is entirely handwritten and signed by the testator (Holographic Will) may be valid without witnesses, but it is generally discouraged due to the risk of legal errors.
- **Testamentary Capacity:** The testator must be of sound mind and fully understand the implications of the document at the time of signing.
- **Witnesses and Notarization:** Per New Jersey law, a Will must be signed by at least two adult witnesses.
 - *While notarization is not mandatory, executing a “**Self-Proving Will**” before a Notary Public simplifies the probate process by exempting witnesses from having to appear in court later.*
 - Beneficiaries may serve as witnesses, but it is highly recommended to use disinterested third parties to prevent potential disputes.
- **Continuous Updates:** You should revise your Will (via a **Codicil**) or draft a new one following major life events such as marriage, divorce, birth, or significant changes in assets.
- **Secure Storage:** Keep the original in a safe location and share its location with your executor. **The New Jersey Will Registry** offers a voluntary service to record the existence and location of your Will to prevent loss or disputes.
 - *Registration/Search Fee: \$10 each.*

Contact

Agency	Primary Role and Content	Contact Information
New Jersey Will Registry (Secretary of State)	Voluntary registration of the existence and storage location of a Will. *Registration/Search Fee: \$10 each	Mail: P.O. Box 300, Trenton, NJ 08625-0300 (Include \$10 check/money order) 609-777-2581 nj.gov/state/archives/catstate.html
Bergen County Surrogate's Court	Oversees legal procedures including Probate, estate administration, and guardianship appointments. *Guide materials available in Korean.	Two Bergen County Plaza, Suite 5000, Hackensack, NJ 07601 201-336-6700
NNJLS (Northeast New Jersey Legal Services)	Free legal aid for low-income residents, seniors, and the disabled (subject to eligibility).	190 Moore Street, Suite 100, Hackensack, NJ 07601 201-487-2166 NNJLS.ORG
LSNJ (Legal Services of New Jersey Hotline)	Free legal consultation and information provision.	1-888-576-5529 lsnjlawhotline.org

Resources

- [New Jersey Will Registry Information](#)
- [NIH.gov–Getting Your Affairs in Order Checklist](#)
- [NCOA \(National Council on Aging–Estate Planning Checklist & Guide](#)

PART II • 제 1 편

미 성인 복지 (US Adult Welfare)

US Adult Welfare

연방 성인 복지법, 노인 복지법(Older Americans Act, OAA), 성인 지원 행정 정책 및 지역사회 복지 프로그램.

본 부문 총 3개 상세 안내 문서 수록

노인법 (Older Americans Act, OAA)

1965년에 통과된 노인법(OAA)은 고령자(60세 이상)들이 독립적으로 생활할 수 있도록 돕는 가정 및 지역사회 기반 서비스를 제공하는 연방법입니다. 이 법은 연방(AoA), 주(State Units on Aging), 지역(AAA) 수준에서 서비스와 프로그램을 조정하기 위한 전국 노인 지원망(National Aging Network)을 구축했습니다.

주요 특징

독립적 생활을 위한 포괄적 서비스 지원 체계

노인법(OAA)은 가사 지원, 식사, 교통, 법률 서비스 및 노인의 독립성과 웰빙을 증진하는 기타 프로그램을 포함한 다양한 서비스를 승인합니다.

고령화 프로그램을 위한 연방 정부의 재정 지원

노인법(OAA)은 노인, 특히 경제적 및 사회적 욕구가 가장 큰 노인들의 삶을 개선하기 위한 프로그램의 주요 연방 자금원입니다.

롱텀케어 옴부즈맨 프로그램의 설립 및 운영

노인법(OAA)은 롱텀케어 시설 거주자를 위한 옴호자를 제공하여 불만 사항을 해결하고 권리가 보호되도록 돕는 롱텀케어 옴부즈맨 프로그램을 설립했습니다.

노인 학대, 방임 및 착취 방지를 위한 법적 근거

노인법(OAA)에는 노인 학대, 방임 및 착취를 예방하고 대처하기 위한 조항이 포함되어 있습니다.

재승인 및 입법 수정안의 역사와 발전 과정

노인법(OAA)은 1965년 처음 통과된 이후 2020년 재승인법(P.L. 116-131)이 FY2020~FY2024년까지의 예산 지출을 승인했으며, 2024년 9월 30일부로 공식 승인 기간이 만료되었습니다. 이후 재승인에 대한 논의가 진행 중입니다.

OAA 7 Titles

타이틀	명칭	주요 내용
Title I	선언 및 정의 (Declaration of Objectives; Definitions)	- OAA의 목표와 철학 명시 '노인' 및 '가족 간병인'과 같은 주요 용어 정의 - 직접적인 자금 할당 없음
Title II	노인청 설립 및 행정체계 (Administration on Aging)	- 노인청(AoA) 설립 - 주 및 지역 노인 기관(AAA) 설치 근거 마련
Title III	주 및 지역 지원 프로그램 보조금 (Grants for State and Community Programs on Aging)	- OAA 자금의 가장 큰 비중 차지 - 식사, 교통, 간병, 가사 지원 포함 - 가족 간병인, 건강 증진 및 취약 노인 지원
Title IV	연구 및 시범사업 (Activities for Health, Independence, and Longevity)	알츠하이머 연구, 낙상 예방, 만성질환 자기관리 프로그램, 인력 훈련 및 시범사업
Title V	고령자 공익근무 일자리 (Community Service Employment for Older Americans, CSEOA) Senior Community Service Employment Program(SCSEP)으로도 알려짐	- 현재 미취업(무직) 상태이며, 가구 소득이 연방 빈곤 가이드라인 (Federal Poverty Guidelines)의 125% 이하인 55세 이상 성인 지원. - 교육 및 정규직 전환 경로 제공 - 노동부에서 운영
Title VI	원주민 고령자 지원 (Grants for Services for Native Americans)	- 미국 인디언, 알래스카 원주민, 하와이 원주민 노인 지원 - 식사, 가사 서비스, 간병 지원 제공 - 주(State) 경우 없이 연방정부가 부족 조직에 직접 교부
Title VII	취약 고령자 권익 보호 (Vulnerable Elder Rights Protection)	롱텀케어 옴부즈맨 프로그램 운영

타이틀	명칭	주요 내용
	Activities)	• 학대, 방임 및 착취 예방 • 법률 지원 및 권익 옹호 포함

참고 자료

[ACL.gov: OAA 개요](#)

[Congress.gov: OAA 개요 및 자금 지원](#)

커뮤니티 생활 지원청 (Administration for Community Living, ACL)

커뮤니티 생활 지원청(ACL)은 보건복지부(HHS) 산하 연방 기관으로, 고령자·전 생애에 걸친 장애인 및 그 가족과 간병인의 독립성·웰빙·건강을 최대화하는 것을 공식 미션으로 하며, 주(State)·지역사회·비영리단체에 보조금 지원, 연구·교육·혁신 투자, 연방 프로그램 간 조정, 권익 옹호 등을 수행합니다.

주요 특징

커뮤니티 내에서의 생활 지원

커뮤니티 생활 지원청(ACL)은 장애인과 고령자가 시설이 아닌 본인이 원하는 장소와 환경에서 생활하고 스스로 선택권을 행사할 수 있도록 지원합니다.

독립적인 생활 지원

커뮤니티 생활 지원청(ACL)은 장애인이 독립적으로 생활하는 데 필요한 기술과 자원을 확보할 수 있도록 돕는 프로그램에 자금을 지원하고 보조합니다.

건강 및 웰빙 증진

커뮤니티 생활 지원청(ACL)은 낙상 예방, 만성질환 자기관리, 영양 서비스, 뇌 건강 등 건강 증진 프로그램에 자금을 지원합니다.

가족 간병인 지원

커뮤니티 생활 지원청(ACL)은 가족 간병인을 지원하기 위해 전국가족간병인지원프로그램(National Family Caregiver Support Program), 일시적 돌봄 휴식 프로그램(Lifespan Respite Care Program) 등을 운영합니다.

포용성 및 동등한 기회 장려

커뮤니티 생활 지원청(ACL)은 고령자와 장애인이 다른 모든 사람과 동일한 기회를 누리고 지역사회 생활의 모든 측면에 포함될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

서비스 접근성 향상

커뮤니티 생활 지원청(ACL)은 고령자를 위한 Eldercare Locator(eldercare.gov, 800-677-1116)와 장애인을 위한 Disability Information and Access Line, DIAL (888-677-1199) 등을 통해 누구나 쉽게 지역 서비스를 연결받을 수 있도록 지원합니다.

조정 기능 강화

커뮤니티 생활 지원청(ACL)은 연방 프로그램 간의 연계를 위해 20개 이상의 연방 부처 및 기관, 주(State), 지방정부(Local government), 민간 부문과 협력하여 개인이 필요한 지원을 원활하게 받을 수 있도록 노력합니다.

참고 자료

[ACL.gov: ACL 프로그램 및 서비스 개요](#)

노인청 (Administration on Aging, AOA)

노인청(AoA)은 미국 보건복지부(HHS)의 주요 기관이며 커뮤니티생활지원청(Administration for Community Living, ACL) 산하 프로그램 오피스로, 노인법(OAA)의 조항을 이행할 책임을 지는 연방 주관 기관입니다.

미션

노인청(AoA)의 미션은 고령자가 가정과 지역사회에서 건강하게 독립적으로 생활할 수 있도록, 종합적이고 조정된 비용 효율적인 가정 및 지역사회 기반 서비스 체계를 구축·지원하는 것입니다.

노인 서비스 네트워크에서의 역할

노인청(AoA)은 지역 노인 기관(Area Agency on Aging, AAA), 주 노인국(State Unit on Aging, SUA), 부족 단체 등 전국 노인 서비스 네트워크와 협력하여, 고령자가 가정과 지역사회에서 독립적이고 건강하게 지내는 데 필요한 서비스를 받을 수 있도록 보장합니다. 또한 노인 서비스 네트워크를 통해 가정 및 지역사회 기반 서비스를 지원하고, 노인과 간병인의 이해관계를 옹호하며, 영양·낙상예방·만성질환 자기관리 등 증거기반 건강 증진 프로그램을 운영합니다.

노인법 (Older Americans Act)

노인청(AoA)은 1965년 노인법(OAA)에 의해 설립되었으며, 자금 지원 및 보조금 프로그램 운영을 포함하여 해당 법안의 규정을 이행할 책임을 집니다. 단, Title V(고령자 지역사회 고용프로그램, CSEOA/SCSEP)는 노동부(DOL)가 별도 관할합니다.

서비스

노인 서비스 네트워크는 가사 보조, 교통편, 성인 주간 보호, 간병인 지원 및 가정 식사 배달 등 광범위한 서비스를 제공합니다.

주 단위 (State Level)

각 주에는 주 노인국(SUA)이 있으며, 50개 주·DC·영토를 포함해 총 56개가 운영됩니다. 주 노인국(SUA)은 노인과 가족을 위한 다년간 주 계획을 수립·관리하고, 노인법(OAA) 관련 정책 개발 및 행정을 담당하며, 지역 노인 기관(AAA)을 통해 서비스 전달을 조정합니다.

지역 단위 (Local Level)

지역 노인 기관(AAA)은 주(state)가 지정한 공공 또는 민간 비영리 기관으로, 시(city), 단일 카운티(county), 또는 복수 카운티 지역 내 모든 고령자의 필요와 관심사를 해결하는 역할을 합니다. 특히 경제적·사회적 필요가 큰 고령자를 우선 지원합니다. 이들은 식사 배달 서비스(Home-Delivered Meals, 흔히 Meals on Wheels로 불림) 및 가사 보조와 같은 서비스로 노인들이 자택에 거주할 수 있도록 돕습니다.

참고 자료

[ACL.gov: AoA 개요 및 안내](#)

PART II • 제 2 편

재정 지원 (Financial Assistance)

Financial Assistance

사회보장(Social Security), SSI, SSDI, 푸드스탬프(SNAP), 공과금 및 에너지 지원(LIHEAP, Comfort Partners, NJ SHARES, Lifeline), 시니어 파머스 마켓 등 공공 재정 보조.

본 부문 총 9개 상세 안내 문서 수록

소셜 시큐리티 연금 (Social Security)

소셜 시큐리티(Social Security, 또는 사회보장)는 퇴직자, 장애인, 그리고 사망한 근로자의 유가족 등 자격 요건을 갖춘 개인에게 재정적 지원을 제공하는 연방 프로그램입니다. 이 프로그램의 공식 명칭은 노인, 유족 및 장애 보험(Old-Age, Survivors, and Disability Insurance, OASDI)이며, SSA(Social Security Administration, 또는 사회보장국)에서 이를 관할하고 운영합니다.

Social Security 재원은 근로자와 고용주의 급여세를 통해 마련되며, 향후 수령하게 되는 혜택의 규모는 개인의 소득 이력을 바탕으로 결정됩니다. 이 프로그램은 고령이나 장애로 인해 더 이상 경제 활동을 할 수 없는 개인에게 재정적 안정과 지원을 제공하기 위해 설계되었습니다. 혜택의 종류에는 은퇴 연금(Retirement Benefits), SSDI(Social Security Disability Insurance, 또는 사회보장 장애보험), 그리고 유족 연금(Survivor Benefits)등이 포함됩니다.

주요 특징 및 요소

- **은퇴 연금(Retirement Benefits):** 은퇴한 근로자와 그 가족에게 매달 일정 금액의 소득을 제공합니다.
- **장애 혜택(Disability Benefits):** 장애로 인해 업무 수행이 불가능해진 근로자에게 재정적 지원을 제공합니다.
- **유족 연금(Survivor Benefits):** 사망한 근로자의 가족에게 소득을 지원하여 생계를 돕습니다.
- **세금을 통한 자원 마련(Funded by Taxes):** 소셜 시큐리티 재원은 근로자와 고용주의 급여세를 통해 마련됩니다.
- **SSA의 역할(Administered by SSA):** SSA는 프로그램 전체를 관리하며 혜택 지급 전체 과정을 관장합니다.

자격 요건

- **자격 요건:** 일을 하고 소셜 시큐리티를 납부함으로써 크레딧(Credit)을 쌓게 됩니다.
- 은퇴 연금을 받으려면 40크레딧(약 10년 근로)이 필요합니다.
- **근로 중단 시:** 일을 그만두더라도 이미 쌓은 크레딧은 유지됩니다. 다만 연금 수령액은 최고 소득 35년 기록을 기준으로 산정되므로, 근로 공백 기간이 길수록 수령액에 영향을 줄 수 있습니다.

연금 수령액 계산 방법

- **평균 조정 월 소득 (Average Indexed Monthly Earnings, AIME):** 근로 기간 중 소득이 가장 높았던 35년의 기록을 바탕으로 산출됩니다.
- **기본 보험 금액 (PIA):** 2026년에 62세가 되는 이들을 기준으로 다음과 같은 공식으로 계산됩니다:
 - AIME의 첫 \$1,286 까지의 90%

- \$1,286 에서 \$7,749 사이 AIME의 32%
- \$7,749 를 초과하는 AIME의 15%

연금 수령 시기 및 수령액

- **만기 은퇴 연령(FRA):** 연금 전액을 받을 수 있는 나이. 출생 연도에 따라 다르며, 1960년 이후 출생자의 경우 67세입니다.
- **조기 은퇴:** 최소 62세부터 혜택을 받을 수 있으나, 만기 은퇴 연령 이전에 수령하면 금액이 영구적으로 감액됩니다(예: 67세(FRA) 대신 62세에 시작하면 최대 30%까지 영구 감액됩니다.).
- **지연 은퇴:** 67세(FRA)이후 70세까지 수령을 늦출 경우 매년 약 8%씩 혜택이 증가합니다. 70세 이후에는 추가 증가가 없습니다.

소셜 시큐리티와 메디케어(Medicare)

65세 생일 최소 4개월 전부터 소셜 시큐리티 혜택을 수령하고 있다면, 별도 신청 없이 파트 A와 파트 B에 자동 가입됩니다.

은퇴 계획 체크리스트

신청 전 알아야 할 사항

- **은퇴(Retirement)의 정의:** SSA에서는 은퇴를 일을 완전히 그만두는 시점이 아닌, 연금 수령을 시작하는 시점으로 정의하고 있습니다.
- **근로와 혜택의 관계:** 만기 은퇴 연령 전에 일정 한도 이상의 소득이 있으면 혜택이 일시적으로 줄어든 수 있습니다. 단, 만기 은퇴 연령에 도달하면 소득에 관계없이 전액을 받게 됩니다.
 - 2026년 기준: FRA 도달 전 연간 \$22,320 초과 시 초과분 \$2당 \$1 감액.
- **과세:** 다른 수입이 있는 경우 소셜 시큐리티 혜택의 일부에 대해 연방 소득세가 부과될 수 있습니다.

특수한 수령 상황

- **배우자 및 유족 혜택:** 배우자의 근로 기록을 바탕으로 혜택을 받을 수 있습니다. 배우자는 근로자가 먼저 소셜 시큐리티 혜택을 신청한 후, 자신의 만기 은퇴 연령(FRA) 기준으로 근로자 기본 보험 금액(PIA)의 최대 50%까지 수령할 수 있습니다. 본인의 혜택과 배우자 혜택 중 더 높은 금액을 받게 됩니다.
- **이혼한 배우자의 경우,** ①혼인 기간 10년 이상 ②현재 미혼 ③62세 이상 ④전 배우자의 소셜 시큐리티 수급 자격(이혼 후 2년 이상 경과 시 전 배우자의 실제 신청 여부 무관)의 조건을 모두 충족하면 전 배우자의 근로 기록을 기준으로 혜택을 받을 수 있습니다.

추가 고려 사항

- **신청 시기:** 혜택 받기 원하는 월(month)을 기준으로 최대 4개월 전부터 신청할 수 있습니다.

내 혜택 알아보기

- 내 소셜 시큐리티 계정: [SSA.gov/myaccount](https://ssa.gov/myaccount)
- 자격 여부 확인: [SSA.gov](https://ssa.gov) – 혜택 자격 확인

신청 방법

- 온라인: [SSA.gov/apply](https://ssa.gov/apply)
- 전화: 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778)
- 방문: 각 지역 SSA 사무소 ([SSA.gov/locator](https://ssa.gov/locator))

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org).

참고 자료

- [SSA.gov](https://ssa.gov): 공식 웹사이트
- [SSA.gov: 2026년 COLA/사회보장 팩트 시트 \(PDF\)](#)
- [SSA.gov: 은퇴 혜택 발행물 안내](#)
- [SSA.gov: 은퇴 준비 체크리스트](#)
- [SSA.gov: 메디케어 수혜자를 위한 은퇴 정보](#)

저소득층 에너지 효율 지원 (Comfort Partners Program)

저소득층 에너지 효율 지원 (Comfort Partners Program)은 뉴저지의 소득 자격 요건을 갖춘 거주자가 공과금을 줄이는 동시에 주택의 안전과 편안함을 개선할 수 있도록 돕는 무료 에너지 절약 및 교육 프로그램입니다. 이 프로그램은 뉴저지 공공사업위원회(NJBPU)가 전기 및 천연가스 유틸리티 회사들과 협력하여 운영하고 있습니다.

주요 혜택 및 서비스

- **무료 에너지 효율 개선 및 교육 프로그램:** 전문가가 가정을 방문해 단열재, 냉난방 장비, 조명 등 에너지 절약 설비를 무료로 설치하고 맞춤형 에너지 교육을 제공합니다.
- **에너지 효율 개선 조치:** 이 프로그램은 다음과 같은 다양한 에너지 절약 조치를 무료로 제공합니다.
 - 주택 단열재 추가 설치
 - 외풍 방지를 위한 공기 누출 밀봉 작업
 - 에너지 효율 조명 솔루션 설치
 - 냉난방 시스템 점검 및 조정
 - 절수 장치 설치
 - 오래된 냉장고 교체
 - 프로그래밍 가능한 온도 조절기 설치
 - 온수기 단열 및 절수 샤워헤드·어댑터 설치
 - 공과금 연체금 면제 가능성(지불 계획 동의 시)

자격 요건 (2026)

가구 소득이 연방 빈곤선의 250% 이하이며, 에너지 사용량이 많아 절감이 필요한 가구는 프로그램 참여 자격이 있습니다. 또한 다음 프로그램의 수혜자도 서비스를 받을 자격이 있습니다.

- 가정 에너지 지원 프로그램 (Home Energy Assistance Program, HEAP / LIHEAP)
- 생활보조금(SSI)
- 라이프라인 크레딧 프로그램 (Lifeline Credit Program)
- 저소득층 임시 지원(TANF)
- 제너럴 어시스턴스(GA)
- 노인 및 장애인 처방약 보조(PAAD)
- 유니버설 서비스 펀드(USF)

- 메디케이드(Medicaid)
- 섹션 8 주택 지원
- 보충 영양 지원 프로그램(SNAP)
- 주 거주지로 사용하는 주택의 가스·전기 요금 납부자(ratepayer of record)일 것
- 완공 후 5년 미만이거나 건설사 보증 기간 중인 신축 주택은 신청 대상에서 제외됩니다.
- 14세대 이하 건물(아파트, 타운하우스 등, 개별 계량 필수)에 거주할 것. 15세대 이상 건물은 제외.
- 주택 소유자의 경우: 최소 1년 이상 소유한 주택이어야 함

신청 방법

- 온라인 신청: 뉴저지 Comfort Partners 웹사이트 (cleanenergy.nj.gov: [Comfort Partners](#))
 - PSEG 이용자: [PSE&G: Comfort Partners](#)
- 전화 신청: 866-378-4345

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

시니어 파머스 마켓 영양 프로그램 (SFMNP)

시니어 파머스 마켓 영양 프로그램(Senior Farmers' Market Nutrition Program, SFMNP), 일명 파머스 마켓은 저소득층 시니어가 파머스 마켓이나 지역사회 지원 농업 프로그램을 통해 신선하고 현지에서 재배된 과일, 채소, 꿀을 구매할 수 있도록 돕는 연방 및 주정부 지원 프로그램입니다. 이 프로그램은 고령층의 영양 상태를 개선하고 지역 농가의 경제 활성화를 동시에 추구합니다.

SFMNP 프로그램 특징

- **농산물 구매 지원:** 시니어가 신선한 농산물을 구매할 수 있도록 바우처 또는 혜택 카드를 제공합니다.
- **건강한 식습관 장려:** 신선한 식품 섭취를 유도하고 영양 교육을 장려합니다.
- **광범위한 운영:** 대부분의 주에서 시행하고 있습니다.

혜택

- **지원 금액:** 1인당 연간 **\$40**(뉴저지 버겐카운티 기준)
- **지급 방식:** 전자 QR 코드 또는 전용 체크카드(Debit Card) 형태.
- **구매 가능 품목:** 지역 농가가 생산한 신선한 과일, 채소, 꿀 등.
*가공식품(잼, 통조림), 수입 농산물, 유제품 등은 구매할 수 없습니다.

자격 요건

- **대상:** 60세 이상
- **소득 기준:** 가구 소득이 연방 빈곤 수준의 185% 이하
 - 2026-27년 뉴저지 기준: 개인 연 **\$29,526** / 2인 가구 연 **\$40,034**
- **거주지:** 주소 증명 서류
- **지역별 차이:** 주 및 지역 기관에 따라 운영 시기와 가용성이 다를 수 있습니다.

신청 및 이용 방법

- **신청:** 거주 지역의 **ADRC**(노인 및 장애인 지원 안내 센터) 연락 및 방문 신청
 - **상담 번호:** **1-877-222-3737** (전화 시 거주 카운티 노인국으로 자동 연결)
 - **버겐 카운티 노인국 (Bergen County Division of Senior Services)**
주소: One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
전화: 201-336-7400 | 1-877-222-3737
이메일: seniors@bergencountynj.gov

- **혜택 수령:** 승인 시 QR 코드가 담긴 서류나 카드를 우편으로 받거나 현장에서 수령합니다.
- **마켓 이용:** "Certified Farmers Vendor" 표지판이 있는 지정 파머스 마켓에서 사용합니다.
- **잔액 확인:** [Homegrown Benefits Portal](#)

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- FNS.usda.gov: 농무부 – SFMNP 개요
- FNS.usda.gov: SFMNP Factsheet
- USDA.gov – 2026-27 SFMNP 소득 자격 가이드
- bergenfightshunger.org – 버겐 카운티 SFMNP 안내
- NJ.gov/health: Farmers Market 찾기
- NJ.gov: 뉴저지 노인 서비스부 – 카운티별 ADRC 리스트

라이프라인 유틸리티 지원 프로그램 (Lifeline Utility Assistance Program)

라이프라인 유틸리티 지원 프로그램(Lifeline Utility Assistance Program)은 뉴저지 인적서비스부(NJ DHS) 산하 노인서비스과(Division of Aging Services)에서 운영하는 프로그램으로 저소득 노인 및 장애인에게 연간 공과금 크레딧을 제공합니다. 이 프로그램은 전기 및 천연가스 비용을 지원하기 위해 공과금 청구서에 직접 적용되는 재정 지원을 제공함으로써 자격 요건을 갖춘 거주민을 돕습니다.

자격별 지원방법

- **라이프라인 크레딧 프로그램(Lifeline Credit Program):** 유틸리티 계정 소유자에게 전기 및 가스 고지서로 직접 적용되는 연간 \$225의 크레딧을 제공합니다.
- **세입자 지원 프로그램(Tenants Lifeline Assistance Program):** 전기·가스 비용이 임대료에 포함된 세입자에게 연간 \$225의 수표를 발행합니다. (전기·가스 요금이 임대료와 별도인 세입자는 해당 없음)
- **SSI 수혜자를 위한 유틸리티 보조금(Special Utility Supplement):** 라이프라인 혜택(월 최대 \$18.75)이 SSI 수표에 자동으로 포함되어 지급됩니다. SSI 수혜자는 별도로 라이프라인을 신청하면 안 됩니다.

자격 요건

- PAAD 수혜자이거나 PAAD 소득 기준(개인 연 \$54,943 미만, 부부 연 \$62,390 미만, 2026)을 충족하는 경우(뉴저지 거주자, 65세 이상, SSDI를 수령 중인 18~64세).
- 노인 대상 메디케이드 프로그램 수혜자

신청 및 보장 범위

- **자동 등록:** 메디케이드 수혜자는 매년 8월에 자동으로 라이프라인 신청서를 받게 됩니다.
- **가구당 제한:** 가구당 연 1회 허용. 신청서는 공과금 청구서 또는 임대 계약서상 명의인이 작성해야 합니다.
- **유틸리티 범위:** 라이프라인은 전기 및 천연 가스 비용만을 보장합니다.
- **제외 항목:** 라이프라인은 석유 또는 프로판 가스, 나무, 석탄 등은 보장하지 않습니다.
- 라이프라인 혜택은 뉴저지 내 주 거주지(Primary Residence)에만 적용됩니다. 계절적·임시 거주지는 대상에서 제외됩니다.

신청 방법

- 온라인: [NJSave 웹사이트](#)

- 전화: Lifeline Utility Assistance 1-800-792-9745

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ.gov: 뉴저지 노인 서비스 부서 – 라이프라인 유틸리티 지원 프로그램 상세 정보](#)
- [NJ.gov: 뉴저지 노인 서비스 부서 – 공식 NJSave 가이드](#)

LIHEAP (저소득 가정 에너지 지원 프로그램)

저소득 가정 에너지 지원 프로그램(LIHEAP)은 저소득 가구가 냉난방 비용을 감당할 수 있도록 돕는 연방 정부 지원 프로그램입니다. 고지서 납부 보조부터 긴급 위기 지원, 의료 목적의 냉방 지원까지 폭넓은 혜택을 제공합니다. 또한 WAP과 연계하여 주택의 에너지 효율을 높이는 수리를 지원합니다. 보일러 수리 및 교체, 창문 틈새 차단, 단열재 보강 등을 통해 근본적인 에너지 비용 절감을 도와드립니다.

뉴저지주에서 저소득 가정 에너지 지원 프로그램(LIHEAP)은 Department of Community Affairs에 의해 관리되며, 거주자들은 Greater Bergen Community Action(GBCA)과 같은 지역 파트너 기관을 통해 혜택을 받을 수 있습니다.

자격 요건 (뉴저지 버겐 카운티 기준)

- 버겐 카운티에 거주해야 함
- 가구 총소득이 뉴저지 주 중위소득(State Median Income)의 60% 이하여야 합니다. (예: 4인 가족 기준 월 \$8,014 이하, 2026) 자세한 소득 기준표는 [NJ DCA 공식 웹사이트](#)를 참고하세요.
- 난방 또는 냉방 비용을 직접 납부하거나, 임대료에 포함된 형태로 부담하고 있는 가구 (단, 공공주택 거주자나 임대 보조를 받는 경우로서 냉난방 비용을 직접 납부하지 않는 경우는 제외)
- 지원 프로그램에 따른 기타 특정 요건을 충족해야 함

신청 방법

버겐 카운티 거주자는 GBCA를 통해 신청해야 합니다. 신청 양식은 GBCA 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

- 오프라인 신청: [GBCA 웹사이트](#)에서 다운로드 후 이메일 또는 우편, 방문으로 제출.
- Online: [DCAid 웹사이트](#)
- 이메일 접수: LIHEAP@GreaterBergen.org
- 우편 접수: Greater Bergen LIHEAP, 505 Main Street, 3rd Floor, Suite 300 Hackensack, NJ 07601
- 방문 접수(드롭박스): 392 Main Street Hackensack, NJ 07601
- 문의: (201) 488-5100

신청 시 필수 서류

- 작성 완료된 신청서 ([GBCA 웹사이트에서 제공](#))
- 신청인 사진 신분증
- 18세 이상 모든 가구 구성원의 소득 증명서
- 최근 급여 명세서 또는 연금 내역서(총액 표시된 명세서 또는 1099 양식)

- 실업급여 수혜자: A200 출력본 (60 State Street, Hackensack, NJ에서 발급)
- 18세 이상 풀타임 재학생: 수강 시간표(학점 표시) 및/또는 재학 확인서
- 가족이나 지인으로부터 받은 경제 지원 확인서 (해당자)
- 최근 소득세 신고서 또는 세금 미신고 확인서
- 정부 혜택 증명서 (예: SSA, SSI, SSD)
- 모든 가구 구성원의 사회보장카드(Social Security cards)
- 법적 거주 증명서— 영주권카드(Permanent Resident Card) 사본. Resident Card가 없는 경우 여권 사본 및 사회보장 번호 미보유 확인서 제출
- 가장 최근의 공과금 고지서
- 주택 소유 증명서 또는 임대 계약서
- 냉방 지원 신청자: 의사 소견서(Doctor's certification form) 원본 추가 제출
- Section 8 수혜자: Housing letter 추가 제출
- 임대 수입이 있는 주택 소유자: Rental Income Form 추가 제출

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- NJ.gov: 뉴저지 지역 사회부 – 공식 LIHEAP 프로그램 정보
- Greaterbergen.org: GBCA 버겐 카운티 에너지 지원 신청 안내

NJ SHARES (뉴저지 비상 지원 프로그램)

NJ SHARES는 현재 복지 수혜 자격이 없으며, 공과금 성실 납부 이력(good-faith payments)이 있는 뉴저지 주민들에게 재정적 지원을 제공하는 비영리 단체입니다. 소득 기준은 프로그램별로 상이하며, NJ SHARES 에너지 보조금은 주 중위소득 (SMI) 100% 이하 가구를 대상으로 합니다.

주요 지원 프로그램

- **에너지 지원:** 천연가스 및 전기 요금 납부를 위한 재정적 지원을 제공합니다.
- **수도 요금 지원:** 수도 요금을 지불할 수 있도록 전용 자금을 지원합니다.
- **주거 지원:** 임대료, 모기지 납입금, 재산세를 포함한 중요한 주거 관련 비용을 지원합니다.

**NJ SHARES 에너지 보조금(Energy Assistance Grant)에 한해, LIHEAP 또는 USF 수혜 가구는 신청 자격이 없습니다.*

NJ SHARES 프로그램 유형 및 지원 내용

프로그램 명칭	카테고리	지원 금액	주요 참고 사항
ACE 고객 구호 기금 (ACE Customer Relief Fund)	에너지	전기 서비스 최대 \$500	\$250 이상 연체 중인 ACE 고객 지원 (소득 자격 요건 충족 필요)
NJBPU PAGE 프로그램	에너지	유틸리티당 최대 \$500~\$700 (소득 구간별 차등)	SMI 60% 이하 가구는 LIHEAP/USF 신청 후 미지원 시 PAGE 신청 가능. SMI 60~100% 가구는 PAGE 직접 신청 가능.
NJ SHARES SMART Utility Assistance Program	에너지	유틸리티당 최대 \$500	연방/주 정부 지원 외에 추가 지원이 필요한 가구 지원
NJ SHARES 에너지 지원 보조금 (Energy Grant)	에너지	가스 최대 \$700, 전기 최대 \$700	재정 위기에 처한 중산층 및 고정 소득 가구 지원
NJ SHARES 타운 별 고객 지원 프로그램(MCAP: Municipal Customer Assistance Program)	전기, 하수, 수도	서비스당 최대 \$200	시립 유틸리티 요금 납부에 어려움을 겪는 가구 지원
AQUA New Jersey AQUA Aid	수도	최대 \$150 (단일) / \$250 (복합)	AQUA NJ 수도 및 하수도 요금 납부 위기 가구 지원
NJ American Water H2O Help to Others Program	수도	최대 \$500 보조금 및 월 15~60% 요금 할인 (고정요금+사용량 포함)	수도 요금 납부 지원이 필요한 NJ American Water 고객 지원
NJ SHARES Mortgage Assistance, Rent and Tax Program	주거	지원 금액은 소득 및 상황별 결정 (파트너십에 따라 최대 \$5,000 가능). 소득 기준 FPL 200% 이하.	임대료, 모기지 또는 재산세 미납으로 인한 주거 불안 해소

신청 방법

- 온라인: [Sharesnation.org: Register](https://sharesnation.org/register)

문의

- NJ SHARES | sharesnation.org
- 전화: 609-883-1626 / 866-657-4273
- 이메일: info@sharesnation.org
- AWCA에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [Sharesnation.org: NJ SHARES 프로그램 안내](https://www.sharesnation.org/nj-shares-program-overview)
- [Sharesnation.org: 자격 요건](https://www.sharesnation.org/eligibility)
- [NJ.gov/bpu: BPU 유틸리티 지원 프로그램](https://www.nj.gov/bpu/utility-support-program)

SNAP 프로그램 (푸드 스탬프)

SNAP 프로그램은 저소득층 개인과 가구가 영양가 있는 음식을 구매할 수 있도록 돕는 연방 프로그램입니다. 과거에는 푸드 스탬프 프로그램으로 불렸습니다. SNAP 프로그램 혜택은 EBT 카드(뉴저지에서는 Families First Card)를 통해 지급되며, 식료품점, 파머스 마켓 및 기타 공인된 소매점에서 식품을 구매하는 데 사용할 수 있습니다.

*OBBBA 법안 시행에 따라 자격 요건이 달라질 수 있습니다.

자격 요건

SNAP 프로그램 자격은 주로 가구 구성원 수, 소득 수준 및 재정 자산에 의해 결정됩니다. 본 가이드라인은 2025년 10월 1일부터 2026년 9월 30일까지 유효합니다.

소득 기준(48개 주, 알래스카/하와이 제외)

대부분의 가구는 SNAP 프로그램 혜택을 받기 위해 총수입(Gross)과 순수입(Net)이 연방 빈곤선(FPL)을 모두 충족해야 합니다.

- **월 총수입 한도**
 - **뉴저지주 기준:** BBCE(Broad-Based Categorical Eligibility) 적용으로 총수입 한도가 FPL 185%로 확대 적용됩니다(2025년 10월~2026년 9월).
 - **연방 기준:** 세금이나 공제가 적용되기 전의 총수입이 연방 빈곤선 130% 이하가 되어야 합니다.
- **월 순수입 한도 (FPL 100%):** 표준 공제, 주거비, 노인/장애인 의료비, 부양가족 간병비 등 허용된 특정 항목을 차감한 후 남은 수입이 연방 빈곤선 100% 이하가 되어야 합니다.
- **노인/장애인 가구 특례:** 60세 이상 또는 장애인이 포함된 가구는 총수입(gross) 기준 테스트가 면제됩니다. 순수입(net, FPL 100%)만 충족하면 됩니다.

가구 자산 한도

- **대상:** 현금, 은행 계좌 잔고, 주식·채권 등 즉시 현금 가능한 유동 자산(Countable Liquid Assets). (주 거주 주택, 첫 번째 차량, 은퇴 계좌 등은 제외)
- **뉴저지주 기준:** 원칙적 자산 심사 면제 (BBCE 정책 적용)
뉴저지주는 연방 빈곤선(FPL) 200% 이하인 가구에 대해 자산 조사를 완전히 면제합니다. 즉, 소득 기준만 충족하면 통장에 잔고가 얼마가 있든 상관없이 SNAP을 받을 수 있습니다.
- **연방(Federal) 기준 (BBCE 미적용 주 기준)**
 - 일반 가구: \$3,250 이하
 - 노인(60세 이상) 또는 장애인 포함 가구: \$4,500 이하

표준 공제액(Standard Deduction)

최종 혜택 금액 결정을 위해 가구 총수입에 표준 공제(Standard Deduction)가 적용됩니다(48개 주, 알래스카/하와이 제외).

- **가구원 1~3인:** 총수입에서 월 \$209가 공제됩니다(4인 가구: \$223, 5인: \$261, 6인 이상: \$299)

**표준 공제 외 추가 허용 공제 항목(Allowable Deductions):*

- 근로 소득의 20% 공제
- 부양가족 돌봄 비용 공제 (근로·교육·훈련 목적)
- 노인/장애인 의료비 공제 (\$35 초과분)
- 주거비 초과 공제 (Excess Shelter Deduction): 소득의 50% 초과 주거비 공제 가능, 단 일반 가구 상한 \$744(FY2026). 60세 이상 또는 장애인 포함 가구는 상한 없이 전액 공제.
- 무주택 가구 표준 주거 공제: \$198.99/월 (FY2026)

신청 방법

- **온라인**
 - 자격 사전 확인: [NJHelps.gov](https://www.njhelps.gov) (5~10분 소요 예상)
 - 온라인 신청 제출: [MyNJHelps.gov](https://my.njhelps.gov) (20~45분 소요 예상)
 - 신청 후 최대 30일 이내에 자격 여부를 통보받으며, 그 기간 내에 인터뷰(전화 또는 대면)가 진행됩니다.
- **방문**
 - Bergen County Board of Social Services
주소: 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
전화: 201-368-4200
운영 시간: 평일 오전 8시 ~ 오후 4시 30분
 - 뉴욕 거주자: NYC Human Resources Administration Queens SNAP Center
주소: 32-20 Northern Blvd, 2nd Fl, LIC, NY 11101
전화: 718-784-6315
운영 시간: 평일 오전 8시 30분 ~ 오후 5시

**기관별로 운영 시간은 변경될 수 있으므로 방문 전 전화 확인 권장*

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [FNS.usda.gov](https://www.fns.usda.gov): 농무부 – 공식 SNAP 자격 정보 안내
- [FNS.usda.gov](https://www.fns.usda.gov): 2026 수당 및 공제액 표
- [BCBSS.com](https://www.bcbss.com): 버겐 카운티 사회복지국 – 공식 SNAP 정보 센터

장애인 소셜 시큐리티 연금 (SSDI)

장애인 소셜 시큐리티 연금(Social Security Disability Insurance, SSDI, 또는 사회보장 장애보험)은 소셜 시큐리티 세금(FICA)을 납부하며 일정 기간 근무한 경력이 있는 분이, 장애로 인해 더 이상 일을 할 수 없게 되었을 때 받는 연방 장애 보험급여입니다. 사회보장국(SSA)이 운영하며, SSDI를 받으려면 SSA에 장애인 소셜 시큐리티(Social Security Disability, SSD)를 신청해야 합니다.

주요 특징

- **근로 이력 기반:** 과거 납부한 소셜 시큐리티 세금 기록을 바탕으로 자격이 결정됩니다. 자산이나 저축액과는 무관합니다.
- **지급액 개인별 산정:** 생애 평균 소득(AIME)을 기반으로 개인별로 산출됩니다. 더 많이, 더 오래 일할수록 수령액이 높아집니다.
- **메디케어 포함:** SSDI 수급 자격 발생(장애 인정일로부터 6번째 달)로부터 24개월 후 메디케어(Medicare) 자격이 자동 부여됩니다. 실제로는 장애 발생 후 약 29개월 후 메디케어가 시작됩니다.
- **가족 혜택 가능:** 수혜자의 근로 기록을 바탕으로 배우자, 미성년 자녀 등 가족도 추가 혜택을 받을 수 있습니다.

자격 요건

SSDI 자격을 받으려면 의학적 장애 기준과 근로 크레딧 두 조건을 모두 충족해야 합니다.

장애(Disability) 기준

SSA의 장애 기준은 매우 엄격합니다. 단기 또는 부분적 장애는 해당되지 않으며, 아래 4가지 조건을 모두 충족해야 합니다.

- **SGA(실질적 유급 활동) 수행 불가:** 의학적 상태로 인해 월 **\$1,690(시각장애인 \$2,830)** 이상의 소득을 올리는 근로 활동을 수행할 수 없어야 합니다. 이 기준 이상 소득이 있으면 의학적 상태 검토 전에 신청이 기각될 수 있습니다.
- **12개월 이상 지속 또는 사망 예상:** 장애 상태가 최소 12개월 연속 지속되었거나 지속될 것으로 예상되어야 합니다. 또는 해당 상태가 사망을 초래할 것으로 예상되는 경우도 포함됩니다.
- **과거 업무 및 다른 업무도 수행 불가:** 과거에 했던 일을 할 수 없을 뿐 아니라, 나이·학력·경력을 종합적으로 고려했을 때 다른 업무로의 전환도 불가능해야 합니다.
- **객관적 의학적 증거 필수:** SSA가 인정하는 의료 기관의 진단서, 검사 결과, 치료 기록 등 객관적인 의학적 증거가 반드시 뒷받침되어야 합니다.

근로 크레딧(Work Credits)

SSDI를 받으려면 소셜 시큐리티 세금이 납부된 근로 소득이 있어야 합니다. **2026년 기준 소득 \$1,890당 크레딧 1점**이 적립되며, 연간 최대 4크레딧까지 쌓을 수 있습니다. 필요한 크레딧 수는 장애 발생 당시 나이에 따라 다릅니다.

장애 발생 당시 나이	필요 크레딧 (최소)	기간 근로 테스트 (Duration of Work Test)	최근 근로 요건 (Recent Work Test)	비고
24세 미만	6크레딧 (1.5년)	1.5년	장애 시작 전 3년 이내	짧은 근무 기간도 인정
24-31세	만 21세 이후 근무 기간의 절반	만 21세 이후 근무의 절반	만 21세 이후 근무 기록	예) 27세 장애 시 → 3년(12크레딧) 필요
31-42세	20크레딧 (최근 10년 이내)	5년	장애 시작 전 10년 이내	일반적으로 "최근 5년 이상 근무" 기준
44세	22크레딧	5.5년	장애 시작 전 10년 이내	—
46세	24크레딧	6년	장애 시작 전 10년 이내	—
48세	26크레딧	6.5년	장애 시작 전 10년 이내	—
50세	28크레딧	7년	장애 시작 전 10년 이내	—
52세	30크레딧	7.5년	장애 시작 전 10년 이내	—
54세	32크레딧	8년	장애 시작 전 10년 이내	—
56세	34크레딧	8.5년	장애 시작 전 10년 이내	—
58세	36크레딧	9년	장애 시작 전 10년 이내	—
60세	38크레딧	9.5년	장애 시작 전 10년 이내	—
62세 이상	40크레딧 (상한)	10년 (상한)	장애 시작 전 10년 이내	크레딧 최대치. 은퇴 연금 자격 기준과 동일.

*시각장애인 특례 — 법정 시각장애인(Statutory Blind)은 최근 근로 테스트(Recent Work Test) 없이, 기간 근로 테스트(Duration of Work Test)만 충족하면 됩니다.

SSI (Supplemental Security Income, 생활보조금)

SSI는 SSD와는 별개로 운영되는 생활보조 프로그램으로, 근로 기록이 아닌 재정적 필요를 기준으로 합니다. 단, SSD를 신청할 때 SSA가 SSD와 SSI 두 가지 자격을 동시에 검토하기 때문에, 다음과 같은 경우 SSD 신청 과정에서 SSI 혜택도 함께 받을 수 있습니다.

- SSD를 받고 있지만 수령액이 낮아 SSI 소득 기준(2026년 FBR \$994/월)을 충족하고, 자산도 개인 \$2,000 / 부부 \$3,000 이하인 경우: 두 혜택을 동시에 수령할 수 있습니다 (Concurrent Benefits). 실제 SSI 지급액은 SSD 수령액에 따라 차감됩니다.
- 근로 크레딧이 부족해 SSD 자격이 없지만, 장애가 인정되고 소득·자산 기준을 충족하는 경우: SSI 단독 수혜 가능
- 65세 이상으로, SSD 근로 기록 요건 충족 여부와 관계없이, 소득·자산 기준을 충족하는 경우: SSI 수혜 가능
- 18세 미만 아동으로 장애가 인정되고 가구 소득·자산 기준을 충족하는 경우: SSI 단독 수혜 가능/부모 근로 기록 불필요

* SSI 자격 기준(소득 계산 방식, 자산 산정 제외 항목 등)과 상세 안내는 [SSI page](#)를 참고하세요.

내 혜택 알아보기

- 내 소셜 시큐리티 계정: [SSA.gov/myaccount](https://ssa.gov/myaccount)
- 자격 여부 확인: [SSA.gov – 장애 혜택 자격 확인](#)

신청 방법

- 온라인: [SSA.gov/apply](https://ssa.gov/apply)
- 전화: 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778) – 예약 필수
- 방문: 각 지역 SSA 사무소 ([SSA 사무소 검색하기](#))

문의

- AWCA에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org).

참고 자료

- [SSA.gov: 장애 연금 \(PDF\)](#).
- [SSA.gov: 2026 Red Book \(장애인 고용 지원 가이드\)](#).

생활보조금 (Supplemental Security Income, SSI)

생활보조금(Supplemental Security Income, SSI)은 수입과 자산이 제한적이며 65세 이상의 고령자, 시각장애인 또는 12개월 이상 지속되는(혹은 사망에 이를 수 있는) 의료적 장애가 있는 개인에게 매월 일정 금액의 지급금을 제공하는 연방 프로그램입니다. 소셜 시큐리티(Social Security benefits)와 달리, 생활보조금(SSI)은 과거의 근로 기록이나 세금 납부 이력에 기반하여 지급되는 것이 아니라 전적으로 수혜자의 경제적 필요에 근거하여 운영됩니다.

자격 요건

- **노인:** 65세 이상인 경우
- **장애/시각장애:** SSA의 장애 기준을 충족하는 시각장애 또는 기타 장애가 있는 경우
- **시민권:** 미국 시민권자 또는 자격이 있는 비시민권자(예: 영주권자)로서, 미국 50개 주, 워싱턴 D.C., 또는 북마리아나 제도 에 거주하는 경우. (푸에르토리코, 괌, 미국령 버진아일랜드, 아메리칸 사모아 거주자는 대상 제외)

소득 및 자산 한도

- **소득:** 소득이 거의 없거나 전혀 없어야 합니다.
 - 소득 공제 항목: 월 첫 \$20은 근로·비근로 소득 모두에서 공제(일반 소득 공제), 근로 소득의 경우 추가 \$65 및 그 초과분의 50% 추가 공제, SNAP 혜택, 에너지 지원금, 연방·주 needs-based 지원금 등.
- **자산:** 개인 기준 \$2,000 이하, 부부 기준 \$3,000 이하.
- **주요 제외 자산:** 주 거주 주택, 차량 1대, 필수 가계용품, 액면가(Face Value) 합계 \$1,500 이하의 생명보험, 매장지(burial plots), \$1,500 이하의 매장 기금 등

수령 가능 금액 (2026)

- **개인 최대 월별 지급액:** 약 \$994
- **부부 최대 월별 지급액:** 약 \$1,491

*실제 수령액은 소득, 자산 및 거주하는 주에서 별도의 추가 보조금을 제공하는지 여부(예: 캘리포니아, 뉴욕 등)에 따라 달라질 수 있습니다.

SSI 수령 후 주요 준수 사항

소득이나 자산의 모든 변경 사항을 SSA에 보고해야 합니다. 또한 주소 변경이나 가족 관계의 변화(결혼, 사망 등)도 반드시 보고해야 합니다. 변경 사항을 보고하지 않을 경우 과다 지급이 발생할 수 있으며, 이 경우 나중에 해당 금액을 반환해야 할 의무가 생깁니다.

SSI 수령 시 받을 수 있는 기타 혜택

의료 혜택 제공

대부분의 주에서 SSI 수령 시 메디케이드(Medicaid) 자격이 자동으로 연계됩니다. 단, 일부 주에서는 별도 신청이 필요하거나 더 엄격한 자격 기준이 적용될 수 있으므로 거주 주의 메디케이드 규정을 확인하세요.

식품 지원 혜택

SSI 수령자는 SNAP(푸드 스탬프) 신청할 수 있으며, SSI가 SNAP 자격에 도움이 될 수 있습니다. 단, SNAP은 별도 프로그램으로 가구 구성·소득 등 자체 자격 기준이 적용됩니다. 또한 수혜자는 주택 지원, 교통비 보조 및 기타 지역 사회 복지 프로그램에서 우선순위 혜택을 받을 수 있습니다.

SSI와 소셜 시큐리티의 차이

SSI는 소셜 시큐리티와 다릅니다. 두 가지를 동시에 받을 수도 있지만, 소셜 시큐리티 수령액은 비근로 소득으로 처리되어, 첫 \$20을 제외한 나머지 금액만큼 SSI 지급액이 차감됩니다. 만약 소셜 시큐리티 수령액이 낮다면, SSI가 이를 보충해 줄 수 있습니다.

SSI와 SSDI의 차이

장애인 소셜 시큐리티 연금(Social Security Disability Insurance, SSDI)은 근로 이력을 바탕으로 하는 반면, SSI는 근로 이력과 관계없이 재정적 필요에 기반합니다. SSI는 65세 이상 또는 장애, 시각 장애로 인해 심각한 경제적 어려움을 겪는 많은 이들에게 필수적인 프로그램입니다.

내 혜택 알아보기

- 내 소셜 시큐리티 계정: [SSA.gov/myaccount](https://www.ssa.gov/myaccount)
- 자격 여부 확인: [SSA.gov](https://www.ssa.gov) – [혜택 자격 확인](#)

신청 방법

- 온라인: [SSA.gov/apply/ssi](https://www.ssa.gov/apply/ssi)
- 전화: 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778) – 예약 필수
- 방문: Visit your local SSA office ([SSA 사무소 검색하기](#))

신청 시 필요 서류

- 사회보장번호(SSN)
- 출생 증명서(원본 또는 발급 기관 인증 사본), 시민권 증명서, 또는 영주권 카드(비시민권자의 경우)

- 은행 계좌 정보
- 소득 증명서(W-2, 세금 신고서 등)
- 자산 증빙 서류(은행 거래 내역서, 차량 정보, 부동산 서류 등)

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [SSA.gov: SSI 개요](#)
- [SSA.gov: SSI 지급 안내](#)
- [SSA.gov: SSI와 소셜 시큐리티 연금의 차이점 비교](#)
- [SSA.gov: SSI 자격 요건](#)
- [SSA.gov: SSI 소득 계산](#)
- [SSA.gov: SSI 자산 기준](#)
- [Medicaid.gov: 2026 SSI 가이드 \(PDF\)](#)

PART II • 제 3 편

메디케어 (Medicare)

Medicare

연방 건강보험 종합 가이드: 오리지널 메디케어(Part A & B), 파트 C(Medicare Advantage), 파트 D(처방약 플랜), 메디갭(보충보험), 메디케어 저축 프로그램(MSP), 바이인, 저소득층 보조금(LIS / Extra Help), 뉴저지 PAAD 및 시니어 골드.

본 부문 총 11개 상세 안내 문서 수록

메디케어 (Medicare) 개요

Medicare는 65세 이상 고령자, 그리고 65세 미만 중 장애연금(SSDI)을 24개월 이상 수령한 분, 말기 신부전증(ESRD)이나 루게릭병(ALS)을 앓고 있는 개인을 위한 연방 정부 건강보험 프로그램입니다.

메디케어의 네 가지 구성 요소 (파트 A, B, C, D)

- **파트 A:** 입원 치료, 전문 간호 시설(Skilled Nursing Facility), 호스피스 및 일부 홈케어 서비스를 보장합니다. 본인 또는 배우자가 최소 10년(40크레딧; QC) 이상 직장 생활을 하며 세금을 납부했다면 대부분 프리미엄을 내지 않습니다.
- **파트 B:** 의사 진료, 외래 환자 서비스, 의료 기기 및 예방 서비스를 보장합니다. Part B는 매월 프리미엄을 지불합니다.
 - 파트 A와 파트 B를 합쳐 오리지널 메디케어(Original Medicare)라고 부릅니다.
- **파트 C: 메디케어 어드밴티지 (Medicare Advantage).** 오리지널 메디케어의 대안으로, 메디케어의 승인을 받은 민간 보험사가 운영하는 통합 플랜입니다. 대부분 Part D를 포함하며 치과, 안과, 청력 등 추가 혜택을 제공하기도 합니다.
- **파트 D: 처방약 플랜 (Prescription Drug Plan, PDP).** 처방 약품 비용을 보장합니다. Medicare가 정한 규정에 따라 민간 보험사에서 운영하며, 파트 D 가입자는 별도의 민간 보험사에서 제공하는 처방약 플랜을 선택해야 합니다.

기타 보충 보험 프로그램

- **메디갭 (Medigap): Supplemental Insurance.** 오리지널 메디케어에서 본인 부담 비용을 지불해주는 보충 보험 플랜입니다.
- **Medicare Savings Program:** 연방-주 정부 공동 프로그램으로, 저소득층 수혜자를 위해 메디케어 본인 부담 비용을 대신 지불해 줍니다.
- **Low Income Subsidy (LIS, Extra Help):** LIS (Low Income Subsidy, Extra Help)은 소득과 자산이 제한적인 메디케어 수혜자가 메디케어 파트 D 처방약 비용을 지불할 수 있도록 지원하는 연방 프로그램입니다.

메디케어 vs 메디케이드 자주 묻는 질문들

Q1. 메디케이드와 메디케어는 모두 국가에서 제공하는 혜택인데 차이점이 무엇인가요?

A. “누가” 대상인지가 가장 큰 차이입니다.

- **메디케어:** 나이를 봅니다. 65세 이상이거나 특정 장애가 있으면 소득에 상관없이 누구나 받는 연방 정부의 건강보험입니다. 젊어서 세금을 낸 것에 대한 ‘권리’에 가깝습니다.
- **메디케이드:** 소득을 봅니다. 소득과 재산이 적은 분들을 돕기 위한 연방-주 정부 공동의 복지 프로그램입니다. 나이와 상관없이 재정적으로 어려운 분들을 지원합니다.

Q2. 병원비 내는 건 어떻게 다른가요?

A. 메디케어는 '일부'만 내주고, 메디케이드는 '거의 다' 내줍니다.

- **메디케어:** 외래 및 의사 서비스(파트 B)는 메디케어 승인 금액의 80%를 커버하며, 나머지 20%와 연간 Deductible은 본인 부담입니다. 입원 서비스(파트 A)는 별도의 본인 부담 구조(입원 기간에 따른 Deductible 및 일별 본인 부담)가 적용됩니다.
- **메디케이드:** 메디케어가 커버하지 않는 나머지 비용까지 거의 무료로 처리해 줍니다. 또한, 약값이나 보험료도 대신 내줍니다.

Q3. 널싱홈(Nursing Home) 비용도 다 나오나요?

A. 여기서 가장 큰 차이가 납니다.

- **메디케어:** 장기 입원은 안 됩니다. 최소 3일 이상 정식 입원(Inpatient) 후 의사가 필요하다고 판단한 **재활 및 전문 간호 케어(Skilled Nursing Care)**에 한해 부분적으로 지원합니다. 1~20일은 본인 부담 \$0, 21~100일은 하루 \$217(2026 기준), 101일 이후는 전액 본인 부담입니다. 식사, 목욕, 이동 등 일상생활 보조(Custodial Care)는 메디케어 대상이 아닙니다.
- **메디케이드:** 롱텀케어를 지원합니다. 널싱홈이나 홈케어 비용을 메디케이드가 커버해 줍니다.

***관찰 케어(Observation Status)**은 정식 입원으로 인정되지 않아 **재활 및 전문 간호 케어(SNF)** 혜택을 받지 못할 수 있습니다. 입원 시 반드시 **Inpatient(정식 입원)** 여부를 병원에 확인하세요.

Q4. 저는 둘 다 가지고 있는데, 이건 뭔가요?

A. 'Dual Eligibility' 입니다.

- 메디케어와 메디케이드 두 카드를 다 가지고 계시면 이중 자격자(Dual eligible)라고 부릅니다.
- 이중 자격자 분들은 두 보험의 혜택을 하나로 통합한 D-SNP(Dual Special Needs Plan)에 가입함으로써 보다 효율적인 의료 서비스를 받을 수 있는데 주별로 D-SNP 플랜 명칭이 다릅니다.
- D-SNP 플랜에 가입하면 병원 갈 때는 메디케어가 먼저 1차로 병원비를 내고, 남은 돈은 메디케이드가 2차로 해결해 줍니다. 자세한 내용은 [D-SNP](#) 페이지를 참조하세요.

Q5. 타주로 이사 가면 어떻게 되나요?

A. 오리지널 메디케어(파트 A&B)은 그대로, 메디케이드는 다시 신청해야 합니다.

- **메디케어:** 연방 프로그램이라서 미국 어디를 가든 현재 메디케어 플랜 그대로 쓸 수 있습니다. (오리지널 메디케어 한정).
- **메디케이드:** 주(State)마다 다릅니다. 뉴저지에서 뉴욕으로 이사 가면, 뉴저지 메디케이드를 취소하고 뉴욕 메디케이드를 새로 신청해서 심사받아야 합니다.

메디케어 바이-인 (Medicare Buy-In)

메디케어 파트 A 를 가입하지 못하는 경우 연방 정부는 '바이-인(Buy-in) 프로그램'을 통해 메디케어 플랜을 구매할 수 있도록 허용합니다. 일반적으로 소셜 시큐리티 세금(social security taxes)납부를 통해 쌓을 수 있는 크레딧(Work Credits)이 부족한 분들에게 적용됩니다.

자격 요건 (2026)

- **크레딧 시스템(Work Credits):** 크레딧은 연간 수입에 따라 적립됩니다. 분기별 최소 수입 **\$1,890** 당 1 크레딧이 적립되며 연간 최대 4 크레딧까지 쌓을 수 있습니다.
- **40 크레딧 규칙:** 일반적으로 보험료 없이 파트 A를 받으려면 40 크레딧(약 10년 세금 보고)이 필요합니다.
- **배우자 자격:** 본인의 크레딧이 부족하더라도 62세 이상이며 배우자의 크레딧이 충분한 경우 파트 A 자격을 받을 수 있습니다. 이혼 또는 사별한 경우에도 소셜 시큐리티 가이드라인에 따라 자격이 될 수 있습니다 ([NCOA.org](https://www.ncoa.org) 참조).

구매 비용 (2026)

40 크레딧 요건을 충족하지 못한 경우, 다음과 같이 파트 A를 구매할 수 있습니다:

- **30~39 크레딧 보유자:** 월 **\$311**.
- **30 크레딧 미만 보유자:** 월 **\$565**.
- **파트 B 의무 가입:** 일반적으로 파트 A를 구매하면 파트 B에도 반드시 가입해야 하며, 파트 B 월 보험료인 **\$202.90**을 지불해야 합니다.

가입 방법

- **근로 기록(Earning Record) 확인:** 소셜 시큐리티(SSA)에 연락하여 적립된 크레딧을 확인해야 합니다.
- **배우자 혜택 확인:** 현재 또는 전 배우자, 사망한 배우자의 근로 기록을 통해 파트 A 보험료를 면제받을 수 있는지 확인.
- **SSA를 통해 신청:** 가입 절차는 SSA에서 처리합니다. SSA.gov에서 온라인으로 신청하거나, 전화 또는 지역 SSA 사무소에서 신청할 수 있습니다.

* 40 크레딧이 되지 않아도 65세가 되면 반드시 메디케어 파트 A를 가입하셔야 합니다. 그렇지 않을 경우 벌금이 부과될 수 있습니다. 자세한 내용은 [Medicare.gov/avoid-late-penalties](https://www.medicare.gov/avoid-late-penalties)에서 확인할 수 있습니다.

참고 자료

- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov): 메디케어 저축 프로그램(MSP) 안내
- [SSA.gov](https://www.ssa.gov): 메디케어 신청 방법

- [CMS.gov: 2026년 메디케어 파트 A 및 B 보험료와 디덕터블 정보](#)

의료 및 처방약 보조 프로그램

치솟는 의료비와 처방약값을 관리하는 것은 많은 가정에 큰 과제입니다. 고정 수입으로 생활하는 시니어부터 처음 보험 시스템을 접하는 청년에 이르기까지, 이러한 비용 부담을 줄이는 데 도움이 되는 검증된 지원 프로그램들이 존재합니다.

종합 지원 및 할인 서비스 재단

아래 서비스들은 공공 및 민간 지원 프로그램을 환자와 연결해 주는 '절약 검색 엔진' 역할을 합니다.

- **NeedyMeds:** 약값 및 의료비 지원을 위한 자료를 제공하는 비영리 단체입니다. 즉시 사용 가능한 약국 할인 카드를 제공하며, 특정 질환별 재정 지원 및 제약회사의 환자 지원 프로그램(PAP) 데이터베이스를 운영합니다.
- **GoodRx:** 7만 개 이상의 약국 가격을 비교해 주는 유명한 도구입니다. 지역 약국 간의 가격을 비교하고 쿠폰을 사용하여 즉석에서 비용을 낮출 수 있습니다.
- **RxAssist:** 제약회사의 환자 지원 프로그램(PAP)에 대한 포괄적인 디렉토리를 제공합니다. 특히 브랜드 의약품에 특화된 보조 프로그램을 찾는 데 탁월한 도구입니다.
- **Medicine Assistance Tool (MAT):** 제약 제조사가 후원하는 지원 프로그램을 환자가 쉽게 찾을 수 있도록 돕는 검색 엔진입니다.
- **BenefitsCheckUp:** 전미 노인협회(NCOA)에서 운영하며 55세 이상 성인을 위해 설계되었습니다. 약값뿐만 아니라 식품, 공공요금 지원 프로그램 등을 통합적으로 찾아줍니다.

직접 재정 지원

아래 재단들은 보험이 있는 환자 중 코페이(Copay), 보험료(Premium), 디덕터블(Deductible) 비용 감당이 어려운 분들에게 실제 현금을 제공합니다.

- **PAN 재단 및 HealthWell 재단:** 만성 질환이나 희귀 질환이 있는 환자에게 보험이 보장하지 않는 본인 부담 비용을 위해 직접적으로 현금을 제공합니다.
- **환자 옹호 재단 (PAF):** '코페이 구제(Copay Relief)' 프로그램으로 잘 알려져 있으며, 직접적인 재정 지원과 더불어 복잡한 보험 및 청구 문제를 해결할 수 있도록 전문가가 직접 매니지먼트를 제공합니다.

지역 상담 및 지원

- **SHIP (주정부 건강보험 지원 프로그램):** 메디케어 수혜자를 위해 무료 상담을 제공하는 연방 정부 지원 프로그램입니다. 뉴저지주에서는 훈련된 SHIP 자원봉사 상담가들이 메디케어 옵션 안내, 플랜 비교, 복잡한 청구 문제 해결을 도와줍니다.

참고 자료 및 문의

종합 지원 및 할인

- [NeedyMeds: 리소스 센터](#) 1-800-503-6897
- [GoodRx: 처방약 쿠폰 및 가격 비교](#) 855-268-2822
- [RxAssist: 환자 지원 프로그램 디렉토리](#) 877-537-5537
- [PhRMA \(MAT\): 약값 지원 도구](#) 571-350-8643
- [NCOA: 시니어를 위한 혜택 확인 서비스](#) 1-800-794-6559

직접 재정 지원 및 그랜트

- [PAN 재단: 재정 지원 그랜트](#) 1-866- 316-7263
- [HealthWell 재단: 비용 지원 프로그램](#) 1-800-675-8416
- [환자 옹호 재단 \(PAF\): 코페이 구제 프로그램](#) 1-800-532-5274

지역 상담 및 지원

- [NJ SHIP](#) 1-800-792-8820
- [버겐카운티 SHIP](#) 201-336-7413

기타 자료

- [CMS.gov: 환자 지원 프로그램\(PAP\) 정보](#)
- [CMS.gov: PAP 증명서 양식](#)

저소득층 처방약 보조 프로그램 (LIS, Extra Help)

저소득층 처방약 보조 프로그램 (Low Income Subsidy, Extra Help)은 소득과 자산이 제한적인 메디케어 수혜자가 메디케어 파트 D 처방약 비용을 지불할 수 있도록 지원하는 연방 프로그램입니다. 이 프로그램은 월 보험료, 연간 디덕터블 및 코페이 비용을 보조합니다.

주요 특징 (2026)

저소득층 처방약 보조 프로그램 자격 요건을 충족하는 경우, 다음과 같은 실질적인 비용 절감 혜택을 누릴 수 있습니다:

- **플랜 보험료:** 대부분의 경우 월간 파트 D 보험료가 면제 됩니다.
- **연간 디덕터블 (Deductible):** 파트 D 디덕터블(\$615)이 면제 됩니다.
- **약값 코페이 (Copay):** 일반(Generic) 의약품은 각 \$5.10 이하, 브랜드 의약품의 경우 각 \$12.65 이하만 지불합니다.
- **본인 부담금 없음:** 연간 Part D 본인 부담 비용(Out-of-pocket)이 **\$2,100** 한도에 도달하면, 해당 연도의 남은 기간 동안 모든 보장 의약품을 무료로 받게 됩니다.
- **지연 가입 벌금 면제:** 자격 요건을 충족하는 경우, 파트 D 지연 가입 벌금이 영구적으로 면제됩니다.

자격 요건

다음 중 하나를 이미 받고 있는 개인은 별도의 신청 없이 자동으로 저소득층 처방약 보조 프로그램 자격이 부여됩니다:

- 통합 메디케어-메디케이드 플랜 수혜자 (Dual Eligible).
- Supplemental Security Income(SSI) 수혜자.
- 파트 B 보험료를 지원하는 메디케어 세이빙 프로그램(MSP) 수혜자.

소득 및 자산 한도 (2026)

자동 자격 대상이 아닌 경우, 자격 여부는 연간 소득과 총 자산/리소스(Asset/Resources)를 기준으로 결정됩니다:

구분	연간 소득 한도*	자산/리소스 한도** (Asset/Resources)
개인 (Individual)	\$23,475 미만	\$18,090 미만
부부 (Married Couple)	\$31,725 미만	\$36,100 미만

*소득 한도에는 월 \$20의 기본 소득 공제(Income Disregard)가 포함되어 있습니다.

**자산 한도에는 장례 비용으로 책정된 1인당 \$1,500가 포함되어 있습니다.

자산/리소스 항목에는 현금, 은행 계좌, 주식, 채권, 부동산(거주 주택 제외)이 포함됩니다. 거주 중인 주택, 차량 1대, 개인 가계 용품은 자산 산정에 포함되지 않습니다.

신청 방법

- 온라인: [SSA.gov](https://ssa.gov) 온라인 LIS 신청
- 전화: 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778).
- 방문: 지역 SSA 사무소에서 지원을 받을 수 있습니다.
- 통지서 확인: 신청 후 SSA가 자격 여부와 지원 수준을 명시한 서신을 우편으로 발송합니다.
- 자동 가입: 자격은 확인되었으나 파트 D 플랜이 없는 경우 혜택을 받을 수 있도록 메디케어가 특정 플랜에 자동으로 가입시켜줍니다.

문의

- AWCA에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [사회보장국\(SSA\): 온라인 엑스트라 헬프 신청](#)
- [Medicare.gov: 엑스트라 헬프 기초 정보](#)
- [NJ DoAS: 엑스트라 헬프 신청을 위한 SHIP 상담](#)

메디케어 의료비 클레임 가이드

대부분의 메디케어와 메디갭, 뉴저지 패밀리카레/메디케이드, 은퇴자 보험 의료비는 **Coordination of Benefits Agreement(COBA)/Crossover** 라는 시스템을 통해 자동으로 청구가 진행됩니다. 특정 상황에서 환자가 부당한 클레임으로부터 보호받을 수 있도록 직접 클레임(**CMS Form 1490S**)하는 방법도 있습니다.

자동 클레임 시스템 (COBA, Crossover)

COBA는 메디케어가 2차 보험사(메디케이드, 메디갭, 은퇴자 보험, 뉴저지 패밀리케어 등)와 데이터를 직접 공유하여 환자의 의료비가 자동으로 클레임 되게 하는 전국적인 시스템입니다.

진행 과정: 메디케어는 의료비의 해당 몫(80%)을 지불하며 나머지 20%의 청구 정보를 2차 보험사(메디케이드 포함)로 자동 전송(크로스오버)합니다. 따라서 이러한 COBA 시스템 하에서는 통상 환자는 지불할 비용이 없습니다.

직접 클레임 방법 (CMS Form 1490S)

일반적으로 의료 제공자가 청구서를 제출해야 하지만, 특정 상황에서는 환자가 메디케어에 클레임을 직접 제출해야 할 수도 있습니다.

직접 클레임이 필요한 경우

- **의료 제공자의 거부:** 의사나 의료 공급업체가 메디케어 청구서 제출을 거부할 때.
- **메디케어 미가입 의료 제공자:** 메디케어 프로그램에 등록되지 않은 의료진에게 진료를 받았을 때 (주로 응급 상황이나 특정 타주 여행 상황).
- **기술적 오류:** 시스템 오류로 인해 자동 크로스오버가 실패하여 2차 보험사가 메디케어 지불 통지서를 환자에게 요구할 때.

클레임 단계(CMS 1490S)

1. **양식 작성:** [CMS Form 1490S](#)(환자 의료비 지불 요청서)를 다운로드하여 작성합니다.
2. **항목별 명세서(Itemized Bill) 준비:** 영수증과는 다른 상세 명세서가 반드시 필요합니다. 명세서에는 다음 내용이 포함되어야 합니다:
 - 서비스 날짜 및 장소 (예: 병원, 의사 사무실).
 - 각 의료 서비스 또는 공급품에 대한 상세 설명.
 - 각 서비스별 구체적인 비용.
 - 의료 제공자의 성함, 주소 및 국가 제공자 식별 번호(NPI).

3. **사유서 첨부:** 의료 제공자가 청구를 제출하지 않은 이유를 설명하는 짧은 편지를 동봉합니다. (예: 의사가 메디케어에 가입되지 않음, 대리 청구 거부, 해외 여행 중 발생한 응급 상황 등)

4. **우편 발송:** 작성된 양식, 명세서, 사유서를 서비스가 제공된 주(State)를 담당하는 메디케어 행정 계약자(MAC)에게 우편으로 보냅니다.

◦ **Novitas Solutions** P.O. Box 3030 Mechanicsburg, PA 17055-1834

* **제출 기한:** 서비스 제공일로부터 12개월(만 1년) 이내에 제출해야 합니다.

* **처리 기간:** 메디케어에서 직접 청구서를 검토하고 처리하는 데는 보통 최대 60일이 소요됩니다.

참고 자료

- [CMS.gov: COBA 시스템 개요](https://www.cms.gov/COBA)
- [Medicare.gov: 메디케어와 타 보험 간의 작동 원리](https://www.medicare.gov)
- [CMS Form 1490S 신청 양식 \(PDF\)](#)
- [Medicare.gov: 의료비 청구 방법 안내](https://www.medicare.gov)

메디갭(Medigap)

메디갭(Medigap, also known as Medicare Supplemental Insurance) 은 오리지널 메디케어(파트 A 및 파트 B)의 보장 공백을 메우기 위해 설계된 민간 보험입니다. 오리지널 메디케어는 일반적으로 승인된 의료 비용의 약 80%만 지불하므로, 메디갭 플랜은 수혜자가 부담해야 하는 나머지 20%의 비용(디덕터블, 코인슈어런스, 코페이)을 보조하는 역할을 합니다.

메디갭 보장 범위

- 오리지널 메디케어 본인 부담금 (디덕터블, 코인슈어런스, 코페이)

메디갭과 오리지널 메디케어 (파트 A 및 B)

How to Buy Medigap Plans

- **가입 전제 조건:** 메디갭 플랜을 구매하려면 반드시 메디케어 파트 A와 파트 B에 모두 가입되어 있어야 합니다.
- **2차 지불자(Secondary Payer):** 오리지널 메디케어가 먼저 해당 몫을 지불한 후 메디갭 플랜이 혜택에 따라 남은 비용을 지불합니다.
- **의료진 선택:** 메디케어를 받는 모든 의사나 병원을 이용할 수 있습니다. 전문의 진료 시 추천서(Referral)가 필요하지 않습니다.
- **월 보험료(Premium):** 가입자는 연방 정부에 납부하는 파트 B 보험료(2026년 기준 \$202.90)와 별도로 메디갭을 제공하는 민간 보험사에 매월 보험료를 납부해야 합니다.
- **연간 디덕터블:** 메디갭 일부 플랜은 파트 B의 연간 디덕터블(2026년 기준 연 \$283)을 커버합니다.

**메디갭은 메디케어 어드밴티지(파트 C)와 함께 사용할 수 없습니다. 메디케어 어드밴티지에 가입된 사람에게 메디갭 정책을 판매하는 것은 불법이며, 오리지널 메디케어로 다시 전환하는 경우에만 가입이 가능합니다. *메디갭은 처방약 보장을 포함하지 않습니다.*

가입 방법

메디갭 플랜은 공식 메디케어 웹사이트([Medicare.gov](https://www.medicare.gov)) 에서나 민간 보험사에 직접 연락하여 구매할 수 있습니다.

1. **온라인 플랜 선택:** Medicare.gov의 메디갭 플랜 찾기([Find a Medigap Policy](#)) 페이지를 방문하여 다양한 플랜과 보장 수준을 확인합니다.
2. **지역 정책 검색:** 거주 지역에서 이용 가능한 플랜을 확인합니다.
3. **직접 신청:** 온라인 또는 전화로 민간 보험사에 연락하여 견적(Quote)확인후 신청합니다.

문의

- **NJ SHIP (주정부 건강보험 지원 프로그램):** 주정부에서 인증받은 SHIP 상담가들이 메디케어 플랜, 혜택, 청구서에 대해 무료로 상담을 제공합니다.
 - NJ SHIP: 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP website](https://www.nj.gov/ship)
 - Bergen 카운티 SHIP: 201-336-7413 | [Bergencountynj.gov SHIP Counseling](https://www.bergencountynj.gov/SHIP-Counseling)
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov): 메디케어 기초 및 각 파트 안내
- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov): 메디갭 정책 개요
- [NJ DoAS: 2026년 메디갭 혜택 비교 차트 \(PDF\)](#)
- [NJ DoAS: 2026년 메디갭 보험료 비교 – 여성 \(65세\) \(PDF\)](#)
- [NJ DoAS: 2026년 메디갭 보험료 비교 – 남성 \(65세\) \(PDF\)](#)
- [NJ DoAS: 2026년 장애인 메디갭 보장 안내 \(50~64세\) \(PDF\)](#)
- [NJ DoAS: 2026년 50세 미만 대상 메디갭 플랜 정보](#)

뉴저지 저소득층 약값 지원 (PAAD & Senior Gold)

뉴저지주는 두 가지 주요 저소득층 약값 지원 프로그램인 PAAD (Pharmaceutical Assistance to the Aged & Disabled) 와 Senior Gold Prescription Discount Program (Senior Gold)을 운영하고 있습니다. 이 프로그램들은 자격 요건을 충족하는 시니어와 장애인이 인슐린을 포함한 필수 생활 의약품 비용을 대폭 절감할 수 있도록 돕습니다. 두 프로그램 모두 메디케어 파트 D와 통합되어 저소득층의 약값을 지원합니다.

뉴저지 PAAD 자격 요건 (2026)

- **대상:** 뉴저지주에 법적으로 거주 중인 65세 이상 수혜자, 또는 18세 – 64세의 SSDI 수혜자
- **메디케어 파트 D**에 가입되어 있어야 합니다. 파트 D에 가입되어 있지 않을 경우, PAAD 신청과 동시에 파트 D 신청을 해야 합니다.
 - 메디케어 어드밴티지 (파트 C) 가입자도 반드시 처방약 혜택(Prescription Benefit)을 플랜에 추가해야 하며, PAAD는 총 보험료 중 처방 부분에 대해 지역 기준금액(regional benchmark)까지만 지원합니다.
- **소득 한도:** 개인 \$54,943 미만 / 부부 \$62,390 미만
- **코페이:** 일반(Generic) 의약품은 각 \$5, 브랜드 의약품은 각 \$7 씩 발생(프리미엄 포함)

**2년마다 한번씩 뉴저지주 정부를 통해 갱신 필요*

Senior Gold 자격 요건 (2026)

Senior Gold 프로그램은 소득이 PAAD 한도를 초과하는 분들을 위해 제공됩니다:

- **대상:** 뉴저지주에 법적으로 거주 중인 65세 이상 수혜자, 또는 18세 – 64세의 SSDI 수혜자
- **메디케어 파트 D**에 가입되어 있어야 합니다. 파트 D에 가입되어 있지 않을 경우, PAAD 신청과 동시에 파트 D 신청을 해야 합니다.
- **소득 한도:** 개인 \$54,943 ~ \$64,943 사이 / 부부 \$62,390 ~ \$72,390 사이
- **코페이:** \$15 + 잔여 50%, 연간 한도(\$2,000/\$3,000) 초과 시 \$15 씩 지불합니다.

**매년 뉴저지주 정부를 통해 갱신 필요*

신청 방법

NJSave 웹사이트에서 PAAD, Senior Gold, Lifeline(공공요금 지원) 등 다양한 시니어 혜택을 한 번에 편리하게 신청할 수 있습니다.

- 온라인 신청: [NJSave 온라인 포털](#)

- 우편 신청: [NJSave 신청서 양식 \(PDF\)](#).

문의

- **NJSave:** PAAD, Sr. Gold | 1-800-792-9745 | [NJSave Contact Us](#)
- **NJ SHIP (주정부 건강보험 지원 프로그램):** 주정부에서 인증받은 SHIP 상담가들이 메디케어 플랜, 혜택, 청구서에 대해 무료로 상담을 제공합니다.
 - NJ SHIP: 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP Counseling](#)
 - Bergen 카운티 SHIP: 201-336-7413 | [Bergencountynj.gov SHIP Counseling](#)
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ DoAs.gov: PAAD 상세 정보](#)
- [NJ DoAs.gov: Senior Gold 프로그램 개요](#)
- [NJSave 온라인 신청 바로가기](#)
- [NJSave 종이 신청서 다운로드 \(PDF\)](#).

메디케어 파트 C (Medicare Advantage)

메디케어 파트 C는 메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage)로도 불리며, 오리지널 메디케어를 대체할 수 있는 포괄적인 민간 보험입니다. 이 플랜은 파트 A, 파트 B, 그리고 일반적으로 파트 D를 하나의 패키지로 통합하여 제공합니다. 민간 보험사에서 운영하지만, 연방 정부(Medicare)의 엄격한 규제와 승인을 통해 관리됩니다.

주요 특징

- **통합 보장:** 병원 입원, 의료 서비스, 그리고 대체로 처방약 보장까지 하나로 결합합니다.
- **추가 혜택:** 치과 검진, 시력 및 청력 관리, 피트니스 멤버십 등 오리지널 메디케어에서 보장하지 않는 다양한 추가 서비스를 제공합니다.
- **본인 부담 한도:** 오리지널 메디케어와 달리, 연간 최대 본인 부담금(MOOP) 한도가 설정되어 있습니다. 이 한도에 도달하면 해당 연도의 남은 기간 동안 승인된 의료 서비스 비용은 플랜에서 100% 지불합니다.
- **네트워크 기반:** 가입자는 일반적으로 특정 네트워크 내의 의사와 병원(HMO 또는 PPO)을 이용해야 합니다.
- **파트 C에 가입하기 위해서는 반드시 메디케어 파트 A와 파트 B에 등록된 상태여야 합니다.**

주요 플랜 유형

- **HMO (Health Maintenance Organization):** 일반적으로 인-네트워크(in-network) 의료진을 이용해야 하며, 전문 의(Specialist) 진료 시 주치의의 추천서(Referral)가 필요합니다.
- **PPO (Preferred Provider Organization):** 네트워크 밖의 의료진을 이용할 수 있으나 비용이 더 높을 수 있습니다. 대체로 추천서(Referral)가 필요하지 않습니다.
- **SNP (Special Needs Plans):** 특정 만성 질환이 있거나 롱텀케어 시설 거주자, 메디케어와 메디케이드를 모두 보유한 수혜자(Dual Beneficiaries)를 위해 설계된 통합 플랜입니다.

비용 및 한도 (2026)

- **월 보험료:** 플랜마다 다르며 보험료가 무료인 플랜도 많습니다. 파트 B 보험료(\$202.90)는 계속 납부해야 합니다.
- **본인 부담 상한선(Out-of-Pocket):** 네트워크 내 서비스에 대한 연방 최대 한도는 \$9,250이나, 대부분의 보험사들이 이 보다 낮은 한도를 제공합니다.
- **코페이(Copay):** 가입자는 의사 진료 또는 전문의 서비스 이용 시 일반적으로 정해진 금액의 코페이를 지불합니다.

플랜 가입

메디케어 어드밴티지 플랜에 가입, 전환, 탈퇴, 변경할 수 있습니다. 메디케어 어드밴티지 플랜에 가입하려면 파트 A 및 파트 B가 둘 다 있어야 합니다:

구분	신청 및 변경 기간	효력 발생	핵심 요약 및 전략
최초 가입 (Initial Enrollment Period, IEP)	65세 생일 전후 3개월 (총 7개월)	신청 시점에 따라 다름 (보통 생일달 1일)	파트 A, B가 모두 있어야 신청 가능. 이때 안 하면 AEP까지 대기해야 함.
연례 가입 (Annual Enrollment Period, AEP)	매년 10월 15일 ~ 12월 7일	다음 해 1월 1일	가장 중요한 시기. 기존 플랜 유지, 변경, 탈퇴가 모두 자유로움.
어드밴티지 공개 가입 (Open Enrollment Period, OEP)	매년 1월 1일 ~ 3월 31일	신청 다음 달 1일	이미 어드밴티지 사용 중인 사람만 해당. 매년 1회 다른 어드밴티지로 바꾸거나 오리지널로 복귀 가능.
특별 가입 (Special Enrollment Period, SEP)	이사, 보험사 계약 해지, 메디케이드 자격 변동 등	사유 발생 시점부터 보 통 2개월 이내	기존 보험이 갑자기 끊어졌거나 타주로 이사 가는 경우.

자동 갱신 (Automatic Rollover)

메디케어 어드밴티지 플랜은 별도의 신청없이 매년 자동으로 갱신(Rollover)됩니다.

- **ANOC 확인:** 매년 9월경 보험사로부터 발송되는 '연례 혜택 변경 통지서(Annual Notice of Change, ANOC)' 내에서 보험료, 코페이, 네트워크 의사, 처방약 목록(Formulary) 등 주요 변경사항들을 확인하세요.
- **보험사에 의한 서비스 중단:** 가입된 보험사가 해당 지역에서 서비스를 중단하거나 계약을 해지하는 경우 기존 플랜은 자동으로 종료됩니다.
- 만약 기존 플랜이 만족스럽지 않으시거나 보험사에 의해 혜택이 축소 또는 서비스가 중단될 경우 반드시 **연례 가입 기간 (AEP, 10월 15일 – 12월 7일)**이나 **어드밴티지 공개 가입 기간 (OEP, 1월 1일~3월 31일; 플랜이 아직 유효할 경우)**에 새로운 플랜을 찾아야 합니다.

가입 방법

메디케어 어드밴티지 플랜은 공식 메디케어 웹사이트([Medicare.gov](https://www.Medicare.gov)) 에서 직접 구매할 수 있습니다.

1. **온라인 플랜 선택:** [Medicare.gov](https://www.Medicare.gov) 에 접속하여 다양한 플랜과 혜택 수준을 확인합니다.
2. **서비스 지역 확인:** 플랜은 지역별로 다르므로, 해당 카운티에서 이용 가능한지 확인해야 합니다.
3. **네트워크 확인:** 이용 중인 의사와 약국이 해당 플랜의 네트워크에 포함되어 있는지 확인합니다.*

* 가입 기간 준수: 최초 가입 기간(IEP) 또는 연례 가입 기간(AEP, 10월 15일 – 12월 7일)에 가입해야 합니다.

문의

- **NJ SHIP (주정부 건강보험 지원 프로그램):** 주정부에서 인증받은 SHIP 상담가들이 메디케어 플랜, 혜택, 청구서에 대해 무료로 상담을 제공합니다.
 - NJ SHIP: 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP Counseling](https://www.nj.gov/ship-counseling)

- 버겐 카운티 SHIP: 201-336-7413 | Bergencountynj.gov SHIP Counseling
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- Medicare.gov: 2026년 플랜 검색 및 비교
- Medicare.gov: 메디케어 어드밴티지 개요 (PDF)
- [NJ DoAS](http://NJ.DoAS.gov): 2026년 뉴저지 메디케어 어드밴티지 리스트
- [NJ DoAS](http://NJ.DoAS.gov): 플랜 선택을 위한 SHIP 상담

메디케어 파트 D (처방약 플랜)

메디케어 파트 D는 외래(Outpatient) 처방약 비용을 지원하는 프로그램입니다. 이 프로그램은 민간 보험사를 통해 제공되므로 보험료, 약국 네트워크, 보장 의약품 목록(Formulary) 등의 세부 사항은 플랜마다 다를 수 있습니다. 모든 플랜은 연방 정부가 정한 표준 한도와 보호 규정이 동일하게 적용됩니다.

파트 D: 두 가지 옵션

1. 메디케어 처방약 플랜 (Prescription Drug Plan, PDP)

- 메디케어 파트 A와 파트 B 가입자
- 일부 메디케어 코스트 플랜(Cost Plans) 가입자
- 일부 메디케어 어드밴티지 PFFS 플랜 가입자
- 메디케어 의료 저축 계좌(MSA) 플랜 가입자

2. 메디케어 어드밴티지 (Part C) 또는 약값이 포함된 기타 플랜

- 파트 A, 파트 B, 그리고 메디케어 처방약 플랜(파트 D)이 하나로 통합된 플랜(메디케어 어드밴티지/파트 C) 가입자

파트 D 비용 (2026)

- **디덕터블(Deductible):** 가입자는 플랜에서 정한 디덕터블 금액에 도달할 때까지 약값의 100%를 부담합니다 (한도: \$615).
- **코인슈어런스(Coinsurance):** 디덕터블 금액에 도달하면 플랜과 가입자가 비용을 분담하기 시작합니다. 가입자는 승인된 약값의 약 25%를 지불합니다.
- **본인 부담 상한선(Out-of-Pocket):** 디덕터블과 코인슈어런스 총비용이 \$2,100에 도달하면 가입자는 해당 연도의 남은 기간 동안 모든 보장 의약품에 대해 비용을 지불하지 않습니다.
- **월 보험료 (Premium):** 파트 D 보장을 유지하기 위해 매월 보험사에 보험료를 납부합니다. 월 보험료는 본인 부담 상한선 한도(\$2,100) 산정에 포함되지 않으며, 오직 약국에서 지불한 비용(디덕터블 및 코인슈어런스)만 해당 한도에 포함됩니다.

플랜 선택 및 가입 방법

매년 약품 목록과 비용이 변경될 수 있으므로 수혜자는 매년 **공개 가입 기간(10월 15일 – 12월 7일)** 동안 혜택 내용을 검토하는 것이 좋습니다.

- **플랜 검색과 약값 비교:** [Medicare.gov/plan-compare](https://www.medicare.gov/plan-compare) 방문 후 현재 복용 중인 약물을 입력하면 가격을 비교할 수 있습니다.

- **약국 네트워크 확인:** 본인이 선호하는 약국이 해당 플랜의 인-네트워크(In-Network) 또는 선호(Preferred) 약국인지 확인하면 코페이를 최소화할 수 있습니다.

* 파트 D 가입 자격이 되었을 때 등록하지 않으면 벌금이 부과될 수도 있습니다. 자세한 내용은 [Medicare.gov/avoid-late-penalties](https://www.medicare.gov/avoid-late-penalties)를 방문하여 확인하세요.

문의

- **NJ SHIP (주정부 건강보험 지원 프로그램):** 주정부에서 인증받은 SHIP 상담가들이 메디케어 플랜, 혜택, 청구서에 대해 무료로 상담을 제공합니다.
 - NJ SHIP: 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP Counseling](https://www.nj.gov/SHIP/Counseling)
 - Bergen 카운티 SHIP: 201-336-7413 | [Bergencountynj.gov SHIP Counseling](https://www.Bergencountynj.gov/SHIP/Counseling)
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov): 파트 D 기초 정보
- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov): 처방약 플랜 검색 및 비교
- [NJ DoAS.gov](https://www.njdoas.gov): 2026년 뉴저지 PDP 리스트 (PDF)

메디케어 파트 A & B (Original Medicare)

오리지널 메디케어는 연방 정부가 관리하는 전통적인 서비스별 수가제(fee-for-service) 건강 보험 프로그램입니다. 수혜자는 미국 내에서 메디케어를 수락하는 모든 의사나 병원을 방문할 수 있습니다. 오리지널 메디케어는 두 가지 주요 구성 요소인 파트 A와 파트 B로 이루어져 있습니다.

* OBBBA(One Big Beautiful Bill Act) 법안 시행에 따라 자격 및 내용이 달라질 수 있으니 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.

메디케어 파트 A

파트 A는 입원 치료(inpatient)를 보장합니다. 본인 또는 배우자가 최소 10년(40크레딧; QC) 동안 메디케어 세금을 납부한 경우 대부분 보험료 없이 파트 A 자격을 얻습니다. 근로 기록이 짧은 경우 매월 보험료를 지불하고 파트 A를 구매할 수 있습니다.

- **입원 환자 진료:** 2인실 이상의 병실, 식사, 일반 간호 및 입원 치료 중 제공되는 약품 포함.
- **전문 간호 시설 (SNF):** 3일 이상의 적절한 입원 치료 후 이어지는 전문 간호 또는 재활 서비스 보장.
- **호스피스 케어:** 말기 질환자를 위한 편안함과 통증 관리에 집중된 전문 케어.
- **홈 헬스 서비스:** 거동이 불편한 개인(homebound)을 위한 파트타임 또는 간헐적인 전문 간호 및 물리 치료 보장.

파트 A 비용 (2026)

혜택 기간(benefit period) 기준

- **1일 – 60일:** 혜택 기간당 \$1,736 디덕터블 발생
- **61일 – 90일:** 매일 \$434 지불
- **91일 – 150일:** Lifetime Reserve Days(최대 60 Reserve Days 사용 가능)을 사용하며 매일 \$868 지불
- **150일 이후:** 전액 납부
- **전문 간호 시설(SNF) 비용**
 - **1일 – 20일:** 부담금 없음
 - **21일 – 100일:** 매일 \$217
 - **100일 이후:** 전액 납부
- **호스피스 케어:** 부담금 없음 (처방약, 단기 영양 서비스 시 소액의 코페이 발생 가능)

메디케어 파트 B

파트 B는 외래 서비스(outpatient) 및 예방 진료를 보장합니다. 대부분의 수혜자의 경우 파트 A와 달리 파트 B는 매월 보험료(premium)가 발생합니다.

- **의사 서비스:** 주치의 및 전문의 방문
- **외래 진료:** 입원하지 않고 병원에서 받는 서비스 (예: 응급실 방문 또는 외래 수술)
- **예방 서비스:** 독감 예방 접종, 검진 (암, 당뇨병) 및 연례 건강 상담(Annual Wellness Visit)
- **내구 의료 장비 (DME):** 보행기, 휠체어, 산소 장비 등 보장

파트 B 비용 (2026)

- **표준 월 보험료:** \$202.90 (소득에 따라 더 높을 수 있음)
- **디덕터블(Deductible):** 연간 \$283
- **코인슈어런스(Coinsurance):** 일반적으로 디덕터블 발생 후 메디케어 승인 금액의 20% 지불

자격 요건

- **65세 이상:** 미국 시민권자 또는 영주권자 (신청 시점 기준 5년 연속 미국 거주).
- **65세 미만:** SSDI 수령자, 루게릭병(ALS) 또는 말기 신부전증(ESRD) 환자.

가입 시기 및 방법

메디케어는 상황과 가입 시기에 따라 자동으로 가입되거나 수동으로 가입해야 합니다. 가입 시기를 놓치면 평생 동안 매달 내야 하는 보험료에 벌금이 추가됩니다.

구분	신청 기간	효력 발생	특징
최초 가입 (Initial Enrollment Period)	65세 생일 전후 3개월 (총 7개월)	신청 시점에 따라 다름 (보통 생일달 1일)	처음 메디케어 자격이 되었을 때 가입.
연례 가입 (Annual Enrollment Period)	매년 10월 15일 ~ 12월 7일	다음 해 1월 1일	가장 중요한 시기. 기존 플랜 유지, 변경, 탈퇴가 모두 자유로움.
특별 가입 (Special Enrollment Period)	직장 건강보험 종료 후 8개월 이내	신청한 다음 달 1일	직장에 다니고 있을 때 가입을 연기했던 경우.
일반 가입 (General Enrollment Period)	매년 1월 1일 ~ 3월 31일	신청한 다음 달 1일	IEP를 놓친 경우 신청. 기존 보험이 갑자기 끊겼거나 타주에서 이사오는 경우에도 해당됩니다.

자동 가입 대상

- **이미 소셜 시큐리티 수령 중:** 65세가 되기 최소 4개월 전부터 소셜 시큐리티 또는 철도 퇴직 위원회(RRB) 혜택을 받고 있는 경우
- **SSDI** 를 24개월 동안 받고 있는 경우
- **루게릭병(ALS)** 또는 **말기 신부전증(ESRD)** 환자

수동 가입이 필요한 경우

소셜 시큐리티 혜택을 받고 있지 않은 경우 (여전히 직장에 다니거나 은퇴를 연기한 경우 등) 메디케어에 직접 가입해야 합니다.

- **최초 가입 기간 (IEP):** 65세 생일이 포함된 달과 그 전후 3개월씩을 포함한 총 7개월의 기간
- **온라인 신청:** [SSA.gov](https://www.ssa.gov) 를 통해 직접 가입

* 메디케어 가입 자격이 되었을 때 등록하지 않으면 벌금이 부과될 수도 있습니다. 자세한 내용은 [Medicare.gov/avoid-late-penalties](https://www.medicare.gov/avoid-late-penalties) 를 방문하여 확인하세요.

문의

- **NJ SHIP (주정부 건강보험 지원 프로그램):** 주정부에서 인증받은 SHIP 상담가들이 메디케어 플랜, 혜택, 청구서에 대해 무료로 상담을 제공합니다.
 - NJ SHIP: 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP Counseling](https://www.nj.gov/SHIP/Counseling)
 - 버겐 카운티 SHIP: 201-336-7413 | [Bergencountynj.gov SHIP Counseling](https://www.bergencountynj.gov/SHIP/Counseling)
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [Medicare.gov: 메디케어와 나 \(2026\)](https://www.medicare.gov/medicare-and-you).
- [Medicare.gov: Parts of Medicare](https://www.medicare.gov/parts-of-medicare)
- [Medicare.gov: Fact Sheet – Medicare CostsGuide \(2026\) \(PDF\)](https://www.medicare.gov/fact-sheet-medicare-costs-guide).
- [CMS.gov: Medicare Part A & B Enrollment](https://www.cms.gov/medicare-part-a-b-enrollment)
- [SSA.gov: Sign up for Medicare](https://www.ssa.gov/sign-up-for-medicare)
- [SSA.gov: Medicare guide \(2026\) \(PDF\)](https://www.ssa.gov/medicare-guide).

메디케어 비용 절감 프로그램 (MSP)

메디케어 비용 절감 프로그램(MSP)은 소득과 자산이 제한적인 개인의 메디케어 비용 지불을 돕기 위해 주 정부에서 운영하는 프로그램입니다. 프로그램 종류에 따라 메디케어 파트 B 보험료를 지원하며, 경우에 따라 파트 A 보험료, deductible, coinsurance 까지 지원받을 수 있습니다.

프로그램 종류 및 혜택

주요 메디케어 비용 절감 프로그램은 네 가지가 있습니다. 수혜자가 **QMB, SLMB, QI** 중 하나에 해당하면 처방약 비용을 지원하는 **엑스트라 헬프(Extra Help, LIS)** 자격도 자동으로 주어집니다.

QMB (Qualified Medicare Beneficiary)

- **혜택:** 파트 A 및 파트 B 보험료, 디덕터블, 코인슈어런스 및 코페이(본인 부담금)를 지원합니다.
- **참고:** 의료 서비스 제공자는 QMB 혜택 환자에게 메디케어 적용 서비스에 대한 비용을 법적으로 청구할 수 없습니다.

SLMB (Specified Low-Income Medicare Beneficiary)

- **혜택:** 파트 B 보험료(2026년 기준 \$202.90)를 지불합니다.

QI (Qualifying Individual)

- **혜택:** 파트 B 보험료를 지불합니다.
- **참고:** 매년 신청해야 하며, 전년도 QI 수혜자에게 우선권이 주어진 후 선착순으로 처리됩니다.. 메디케이드 혜택을 이미 받고 계신 분들은 신청할 수 없습니다.

QDWI (Qualified Disabled and Working Individual)

- **혜택:** 파트 A 보험료만 지불합니다.
- **대상:** 직장 복귀로 인해 보험료 면제 파트 A 자격을 상실한 장애인.

자격 요건 (뉴저지 기준)

The limits below are federal guidelines; some states, like New York or Connecticut, may have higher limits or no asset test.

프로그램	개인 소득 한도 (월)*	부부 소득 한도 (월)*	자산 한도*
QMB	\$1,330	\$1,803	\$9,950 (개인) / \$14,910 (부부)
SLMB	\$1,596	\$2,164	\$9,950 (개인) / \$14,910 (부부)
QI	\$1,795	\$2,434	\$9,950 (개인) / \$14,910 (부부)
QDWI	\$5,405	\$7,299	\$4,000 (개인) / \$6,000 (부부)

*소득 한도 및 자산 한도는 주별로 상이합니다. 일부 주는 자산 심사를 하지 않을 수 있습니다.

신청

- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov): MSP 공식 안내 웹사이트
- [Medicaid.gov](https://www.Medicaid.gov): 주별 메디케이드 신청 사무소 찾기
- [SSA.gov](https://www.SSA.gov): Extra Help(처방약 비용 지원 프로그램) 신청 (MSP와 동시 신청 가능)

문의

- **NJ SHIP (주정부 건강보험 지원 프로그램)**: 주정부에서 인증받은 SHIP 상담가들이 메디케어 플랜, 혜택, 청구서에 대해 무료로 상담을 제공합니다.
 - NJ SHIP: 1-800-792-8820 | [NJ.gov SHIP website](https://www.nj.gov)
 - Bergen 카운티 SHIP: 201-336-7413 | [Bergencountynj.gov SHIP Counseling](https://www.Bergencountynj.gov)
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

PART II • 제 4 편

메디케이드 (Medicaid)

Medicaid

저소득층 공공 의료보장 제도: 뉴저지 패밀리케어(NJ FamilyCare / Medicaid), 관리의료기구(MCO), ACA 오바마케어 메디케이드 확장 및 마켓플레이스, 자격 요건과 신청 절차.

본 부문 총 9개 상세 안내 문서 수록

메디케이드 (Medicaid) 개요

메디케이드는 저소득층 성인, 아동, 임산부, 노인, 그리고 장애인을 위해 연방정부와 주 정부가 공동으로 운영하는 의료보험 프로그램입니다. 연방정부의 지원을 받아 각 주 정부가 개별적으로 운영하기 때문에, 주에 따라 명칭(예: 뉴저지의 NJFamilyCare)이나 세부 자격 요건은 조금씩 다를 수 있지만 기본적으로 취약 계층의 의료 안전망 역할을 합니다.

특징 및 혜택

- **저렴한 비용 부담:** 자격 조건에 부합하는 수혜자는 매달 내는 보험료가 거의 없으며, 병원 진료비나 약값에 대한 코페이(Copay) 역시 무료이거나 매우 저렴합니다.
- **폭넓은 의료 서비스:** 일반적인 의사 진료와 입원 서비스는 물론, 치과, 안과, 처방약, 그리고 민간 보험에서는 보장받기 어려운 롱텀케어 서비스까지 폭넓게 제공합니다.
- **연중 상시 신청 가능:** 가입 기간이 정해져 있는 일반 건강보험과 달리, 메디케이드는 자격 요건만 충족한다면 일년 중 언제라도 신청하여 혜택을 받을 수 있습니다. 신청 후 심사를 거쳐 자격이 인정되면, 신청일 또는 신청한 달의 첫 날부터 커버리지가 시작됩니다.

메디케이드 종류

- **임산부 메디케이드 (Pregnancy Medicaid):** 저소득 임산부에게 임신 기간부터 산후 12개월까지 산전 검사, 출산, 신생아 케어 등 모든 의료 비용을 전액 지원합니다.
- **아동 건강 보험 프로그램 (CHIP):** 부모의 소득이 메디케이드 기준보다는 높지만 민간 보험에 가입하기에는 부족한 가정의 자녀(18세 이하)에게 저렴한 비용으로 제공됩니다.
- **ACA 메디케이드 (Medicaid Expansion):** ACA 메디케이드를 통해 자녀 유무나 장애 여부에 상관없이 가구 소득이 연방 빈곤선의 138% 이하인 모든 저소득 성인으로 가입 대상을 확대합니다. 오바마케어(Obamacare)로 잘 알려져 있습니다.
- **레귤러 메디케이드 (ABD 프로그램):** 65세 이상 노인(Aged), 시각장애인(Blind), 또는 신체장애인(Disabled) 중 소득과 자산 기준을 충족하는 분들에게 필수 의료 서비스와 장기 요양 혜택을 제공합니다.
- **롱텀케어 메디케이드 (Long-Term Care Medicaid):** 거동이 불편한 저소득층 노인이나 장애인이 널싱홈(Nursing Home)에 입소하거나 자택에서 간병인의 도움을 받을 수 있도록 롱텀케어 비용을 지원합니다.

자격 요건

- **소득 및 자산 심사:** 매년 정부가 발표하는 연방 빈곤선(FPL) 소득 기준을 따릅니다. 특히 롱텀케어 메디케이드의 경우 소득 뿐만 아니라 보유하고 있는 자산(현금, 예금 등)에 대해서도 엄격한 심사를 거칩니다.
- **체류 신분:** 일반적으로 시민권자 또는 5년 이상 거주한 영주권자가 기본 대상이지만, 임산부나 아동의 경우 주 정부 규정에 따라 더 완화된 기준이 적용되기도 합니다.

메디케이드 vs 메디케어 자주 묻는 질문들

Q1. 메디케이드와 메디케어는 모두 국가에서 제공하는 혜택인데 차이점이 무엇인가요?

A. “누가” 대상인지가 가장 큰 차이입니다.

- **메디케어:** 나이를 봅니다. 65세 이상이거나 특정 장애가 있으면 소득에 상관없이 누구나 받는 연방 정부의 건강보험입니다. 젊어서 세금을 낸 것에 대한 ‘권리’에 가깝습니다.
- **메디케이드:** 소득을 봅니다. 소득과 자산이 적은 분들을 돕기 위한 연방-주 정부 공동의 복지 프로그램입니다. 나이와 상관없이 재정적으로 어려운 분들을 지원합니다.

Q2. 병원비 내는 건 어떻게 다른가요?

A. 메디케어는 ‘일부’만 내주고, 메디케이드는 ‘거의 다’ 내줍니다.

- **메디케어:** 외래 및 의사 서비스(파트 B)는 메디케어 승인 금액의 80%를 커버하며, 나머지 20%와 연간 디덕터블은 본인 부담입니다. 입원 서비스(파트 A)는 별도의 본인 부담 구조(입원 기간에 따른 디덕터블 및 일별 본인 부담)가 적용됩니다.
- **메디케이드:** 메디케어가 커버하지 않는 나머지 비용까지 거의 무료로 처리해 줍니다. 또한, 약값이나 보험료도 대신 내줍니다.

Q3. 낄싱홈(Nursing Home) 비용도 다 나오나요?

A. 여기서 가장 큰 차이가 납니다.

- **메디케어:** 장기 입원은 안 됩니다. 최소 3일 이상 정식 입원(Inpatient) 후 의사가 필요하다고 판단한 **재활 및 전문 간호 케어(Skilled Nursing Care)**에 한해 부분적으로 지원합니다. 1~20일은 본인 부담 \$0, 21~100일은 하루 \$217(2026 기준), 101일 이후는 전액 본인 부담입니다. 식사, 목욕, 이동 등 일상생활 보조(Custodial Care)는 메디케어 대상이 아닙니다.
- **메디케이드:** 롱텀케어를 지원합니다. 낄싱홈이나 홈케어 비용을 메디케이드가 커버해 줍니다.

***관찰 케어(Observation Status)**은 정식 입원으로 인정되지 않아 **재활 및 전문 간호 케어(SNF)** 혜택을 받지 못할 수 있습니다. 입원 시 반드시 **Inpatient(정식 입원)** 여부를 병원에 확인하세요.

Q4. 저는 둘 다 가지고 있는데, 이건 뭔가요?

A. ‘Dual Eligibility’ 입니다.

- 메디케어와 메디케이드 두 카드를 다 가지고 계시면 이중 자격자(Dual eligible)라고 부릅니다.
- 이중 자격자 분들은 두 보험의 혜택을 하나로 통합한 D-SNP(Dual Special Needs Plan)에 가입함으로써 보다 효율적인 의료 서비스를 받을 수 있는데 주별로 D-SNP 플랜 명칭이 다릅니다.

- D-SNP 플랜에 가입하면 병원 갈 때는 메디케어가 먼저 1차로 병원비를 내고, 남은 돈은 메디케이드가 2차로 해결해 줍니다. 자세한 내용은 [D-SNP](#) 페이지를 참조하세요.

Q5. 타주로 이사 가면 어떻게 되나요?

A. 오리지널 메디케어(파트 A&B)은 그대로, 메디케이드는 다시 신청해야 합니다.

- **메디케어:** 연방 프로그램이라서 미국 어디를 가든 현재 메디케어 플랜 그대로 쓸 수 있습니다. (오리지널 메디케어 한정).
- **메디케이드:** 주(State)마다 다릅니다. 뉴저지에서 뉴욕으로 이사 가면, 뉴저지 메디케이드를 취소하고 뉴욕 메디케이드를 새로 신청해서 심사받아야 합니다.

ACA 마켓플레이스

ACA 마켓플레이스(Affordable Care Act Marketplace)는 건강보험 개혁법에 따라 정부가 운영하는 보험 거래소입니다. 개인이 민간 건강보험을 비교하고 구입할 수 있으며, 소득에 따라 정부 보조금을 받을 수 있는 시스템입니다. 소득 수준이 낮아도 메디케이드(Medicaid) 자격 요건에는 미치지 못하는 계층이 정부 보조금을 통해 저렴한 보험료로 의료보험을 가입할 수 있도록 돕는 것이 핵심 목적 중 하나입니다.

주요 특징(2026)

- **보조금 혜택 (Premium Tax Credits):** 가구 소득이 연방 빈곤선(FPL) 100%~400% 사이인 경우 보험료 세금 공제를 받을 수 있습니다. FPL 400%를 초과하면 연방 보조금은 받을 수 없으며, 뉴저지 주 보조금(NJHPS)만 가능합니다.
- **기저질환 보장:** 과거에 앓았던 질병(암, 당뇨 등)이 있다는 이유로 가입을 거절하거나 보험료를 더 높게 책정할 수 없습니다.
- **10대 필수 건강 혜택:** 응급 서비스, 입원, 임신 및 출산, 정신 건강 서비스, 처방약 등이 반드시 포함되어야 합니다.
- **자녀 동반 가입:** 만 26세까지 부모의 건강보험에 함께 가입되어 있을 수 있습니다.

보험 플랜 등급

보험료와 본인 부담금 비율에 따라 4단계로 나뉩니다.

등급	보험사 부담(평균)	코페이/코인슈어런스	특징
브론즈 (Bronze)	60%	40%	월 보험료가 가장 낮지만, 병원 이용 시 본인 부담금이 큼
실버 (Silver)	70%	30%	보조금 혜택이 가장 극대화되는 등급 (저소득층 보조금(CSR) 적용 시 본인 부담이 6%~27%까지 대폭 낮아짐.)
골드 (Gold)	80%	20%	월 보험료는 높지만, 진료비 본인 부담이 적음
플래티넘 (Platinum)	90%	10%	보험료가 가장 비싸며, 병원을 자주 가는 사람에게 유리

소득별 보조금 혜택 가이드(2026)

가구 인원	연방 보조금 (APTC)	NJ 주 보조금 (NJHPS)	보조금 없음
소득 기준	연방빈곤선 138% ~ 400%	연방빈곤선 400% ~ 600%	연방빈곤선 600% 초과
1인 가구	\$22,025 – \$62,600	\$62,601 – \$93,900	\$93,900 초과
2인 가구	\$29,864 – \$84,600	\$84,601 – \$128,840	\$128,840 초과
3인 가구	\$37,702 – \$106,600	\$106,601 – \$159,900	\$159,900 초과
4인 가구	\$45,540 – \$128,600	\$128,601 – \$192,900	\$192,900 초과

- **연방 마켓플레이스 보조금 (APTC):** 규정에 따라 보조금 산정 시 **전년도(2025년) FPL**을 기준으로 적용합니다. (1인 기준 \$62,600, 4인 기준 \$128,600이 400% 상한선임)
- **NJ 주 자체 보조금 (NJHPS):** 연방 보조금과는 별도로 뉴저지주에서 제공하는 혜택(NJ Health Plan Savings)으로, **갯 커버드 뉴저지(GetCoveredNJ)**를 통해 신청 시 연방빈곤선 600%까지 추가 지원을 받을 수 있습니다.
- **자격 확인:** 본 자료는 참고용 수치이며, 최종 수혜 자격 및 금액은 **갯커버드 뉴저지** 또는 **뉴저지 패밀리케어** 공식 홈페이지의 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

*2026년부터 연방빈곤선 400%를 초과하는 소득자의 경우 연방 보조금(APTC) 수령이 불가하며 뉴저지주 보조금만 가능합니다.

가입 시기

- **정기 가입 기간 (Open Enrollment):** 뉴저지는 연방 마켓플레이스(Healthcare.gov)를 사용하지 않고 주정부 자체 마켓플레이스(**GetCoveredNJ**)를 운영하기 때문에 가입 마감 기한이 더 깁니다.
 - 가입 기간: **11월 1일 ~ 1월 31일**
 - 12월 31일까지 가입 완료 시 1월 1일부터 보장 시작
 - 1/1~1/31 가입 시 2월 1일부터 보장 시작
- **특별 가입 기간:** 다음과 같은 변화가 발생하면 정기 가입 기간 이후 60일 이내에 가입이 가능합니다.
 - 결혼 또는 이혼
 - 자녀 출산 또는 입양
 - 거주지 이전 (주 이동 등)

- 기존 직장 보험 상실

신청 방법

- 필요한 서류
 - 가구원 전체의 소셜 번호(SSN) 또는 이민 서류 (영주권 등)
 - 가구 소득 증명 (세금 보고서, 급여 명세서 등)
 - 거주지 주소 정보
- 연방 마켓플레이스
 - 온라인 신청: [HealthCare.gov](https://www.healthcare.gov) – 텍사스, 플로리다, 조지아 등 약 30개 주
 - 전화 신청: **1-800-318-2596** (24시간 운영, 한국어 통역 가능)
- 주 정부 자체 마켓플레이스
 - 뉴저지: [GetCoveredNJ](https://www.getcoverednj.com)
 - 뉴욕: [NY State of Health](https://www.nystateofhealth.com)
 - 캘리포니아: [Covered California](https://www.coveredcalifornia.com)
 - 펜실베이니아: [Pennie](https://www.pennie.com)
- 전문가 도움: 지역 내 내비게이터(Navigator)나 공인 에이전트를 통해 무료 도움을 받을 수 있습니다.

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- 공식 가입 신청 (연방): [HealthCare.gov](https://www.healthcare.gov)
- 한국어 서비스 안내: [HealthCare.gov – Language Resource](https://www.healthcare.gov/language-resource)
- 보조금 계산기: [KFF Subsidy Calculator](https://www.kff.org/subsidy-calculator)

ACA 메디케이드 (Medicaid Expansion)

연방 건강보험개혁법(Affordable Care Act, ACA)은 주정부가 메디케이드 적용 대상을 연방 빈곤선(FPL) 138% 이하 저소득 성인까지 확대할 수 있도록 한 연방 법률입니다. 뉴저지주에서는 **뉴저지 패밀리케어(NJ FamilyCare)** 라고 불리며, 저소득층 가구가 월 보험료 없이 포괄적인 의료보험 혜택을 받을 수 있도록 하고 있습니다. *OBBBA 법안 시행에 따라 자격 요건이 달라질 수 있습니다.

자격 요건

- **대상:** 19세 이상 64세 이하의 뉴저지 거주자
- **신분:** 미국 시민권/합법적 영주권 취득 후 **5년** 경과
 - OBBBA 규정에 의해 난민(Refugees)이나 망명자(Asylees)는 합법적 영주권자로 신분 조정이 되지 않은 경우 2026년 10월 1일부터 뉴저지 패밀리케어 자격이 박탈될 수 있습니다.
- **근로 및 커뮤니티 참여 요건 신설 (OBBBA 규정):** 매월 **80시간** 이상의 근로, 교육, 직업 훈련 또는 봉사활동 참여 증빙이 필요합니다. (2027년 1월 1일부터 적용)

*근로 요건 면제 대상: ① 19세 미만 ② ABD(고령·시각장애·장애) 수혜자 ③ 14세 미만 자녀 또는 장애인의 부모·간병인 ④ 심각한 신체·정신 건강 상태 ⑤ 임신부 및 출산 후 1년 이내 ⑥ 26세 미만 전 위탁 청소년 ⑦ 수감 중이거나 최근 출소한 자.

*자격 요건 관련 자세한 내용은 [뉴저지 복지부\(DHS\)](#) 공식 페이지 확인

소득 기준 (2026)

가구 총소득: 연방 빈곤선(FPL) **138% 이하**

가구 인원수	월 최대 소득 한도 (138% FPL)
1인	\$1,836 이하
2인	\$2,489 이하
3인	\$3,142 이하
4인	\$3,795 이하
5인	\$4,449 이하
6인	\$5,102 이하
7인 이상	추가 1인당 +\$654 가산

- **비용:** 소득 구간 0-138%에 해당할 경우 **월 보험료(Monthly Premium)**가 없고, **코페이도 전혀 없습니다.**
- **가구 규모 산정:** 부모/간병인, 21세 미만의 세금 부양가족 자녀, 그리고 집에 함께 거주하는 기타 세금 부양가족의 총 인원수로 결정됩니다.
- **소득 검증:** Modified Adjusted Gross Income(MAGI)을 기준으로 하며, 연방 세금 보고 데이터 등을 통해 자동 검증됩니다.
- **연례 자격 갱신:** 매년 자격 재심사가 이루어집니다. 갱신 서류를 받으면 반드시 기한 내에 정보를 업데이트해야 혜택이 유지됩니다.

종합 의료 혜택

- **기본 의료:** 주치의 및 전문의 진료, 정기 검진, 예방 접종.
- **정밀 검사:** 혈액 검사, X-레이, CT/MRI, 입원 및 외래 수술.
- **치과 및 안과:** 기본 검진 및 치료, 시력 검사, 처방 안경.
- **처방약 및 정신 건강:** 처방약 지원, 심리 상담, 약물 오남용 치료 서비스.

신청 방법

- **온라인 신청:** [NJ FamilyCare QuickStart](#) 또는 [NJHelps.gov](#) 접속
 - **전화 문의:** 뉴저지 패밀리케어 고객센터 (**1-800-701-0710** / TTY: 711)
- **방문 신청:** 거주 지역의 사회복지국(County Board of Social Services) 방문
 - 버겐 카운티 (Bergen County) Board of Social Services
 - **주소:** 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - **전화번호:** 201-368-4200
 - **업무 시간:** 평일(월~금) 오전 8:00 ~ 오후 4:30

*뉴저지 패밀리케어는 연중 상시 등록이 가능합니다.

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org).

참고 자료

- [NJ FamilyCare – 공식 자격 요건 안내](#)
- [NJ DHS – 온라인 신청 및 서비스 가이드](#)
- [NJ.gov – 카운티별 소셜 서비스 사무소 위치 검색](#)
- [NJ FamilyCare – 자주 묻는 질문\(Q&A\)](#)

아동 건강 보험 프로그램 (CHIP)

아동 건강 보험 프로그램(Children's Health Insurance Program)은 NJ FamilyCare 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 이 프로그램은 메디케이드 자격을 충족하기에는 소득이 높지만 민간 건강보험을 감당할 수 없는 가정의 아동들에게 포괄적이고 저렴한 의료 혜택을 제공하도록 설계되었습니다.

자격 요건

- **연령:** 19세 미만 아동.
- **거주지:** 뉴저지주 거주 아동.
- **체류 신분 무관:** 아동은 'Cover All Kids' 정책에 따라 체류 신분과 관계없이 아래 소득 기준(2026)만 충족하면 동일한 비용 혜택을 받습니다.
- CHIP은 연중 언제든 신청 가능하며 별도 대기 기간이 없습니다.

소득 기준 (2026)

가구 인원수	연방빈곤선 147% 이하	연방빈곤선 147% ~ 150%	연방빈곤선 150% ~ 200%	연방빈곤선 200% ~ 355%
보험료	없음	없음	없음	없음
코페이	없음	없음	\$5 - 10	\$5 - \$35
1인	\$1,955 이하	\$1,956 ~ \$1,995	\$1,996 ~ \$2,660	\$2,661 ~ \$4,722
2인	\$2,650 이하	\$2,651 ~ \$2,705	\$2,706 ~ \$3,606	\$3,607 ~ \$6,401
3인	\$3,347 이하	\$3,348 ~ \$3,416	\$3,417 ~ \$4,554	\$4,555 ~ \$8,083
4인	\$4,043 이하	\$4,044 ~ \$4,125	\$4,126 ~ \$5,500	\$5,501 ~ \$9,763
추가 1인당	+ \$696	+ \$711	+ \$947	+ \$1,682

*연방빈곤선 147% 이하인 아동은 CHIP이 아닌 Medicaid로 분류되며 진료비용이 전액 무료입니다.

종합 의료 혜택

- **주치의 및 전문 치료:** 정기 검진, 예방 접종, 전문의 진료.
- **치과 치료:** 클리닝, 충치 치료, X-레이 및 의학적으로 필요한 교정.
- **안과 진료:** 시력 검사 및 처방 안경.

- **입원 치료:** 응급실 방문, 입원 및 외래 수술.
- **정신 건강:** 상담, 행동 건강 치료 및 약물 치료.
- **처방약:** In-Network 약국을 통한 약 처방.

신설 주요 규정(2026)

- **지속적 보장 자격:** 아동은 이제 '지속적 가입 자격 보장(Multi-Year Continuous Eligibility)' 혜택을 받습니다. 이를 통해 연중 소득이 일시적으로 상승하거나 변동되더라도, 자녀의 건강보험 혜택이 중단되지 않고 안정적으로 유지됩니다.
- **원격 의료 보장 강화:** 원격 의료 보장 범위가 대폭 확대되었습니다. 이제 병원을 직접 방문하지 않고도 언어 치료, 심리 상담, 행동 발달 상담 등의 전문적인 케어를 집에서 편리하게 이용할 수 있습니다.

관리 보험사(MCO) 선택

모든 가입자는 의료 서비스를 관리해 줄 관리 보험사(MCO)를 선택해야 합니다.
선택하지 않을 시에는 관리 보험사가 임의로 지정되며, 주치의(PCP) 또한 임의로 지정됩니다.

- 자주 가는 소아과 의사가 해당 보험 네트워크에 있는지 확인.
 - 무료 신체검사나 추가 안경 혜택 등 각 보험사의 '부가 서비스' 비교.
- *더 자세한 정보는 [뉴저지 관리 보험사\(MCO\) 페이지](#)를 참조하세요.*

신청 방법

- 온라인 신청: [NJ FamilyCare website](#)
 - 전화 문의: NJ FamilyCare 고객센터 (1-800-701-0710 / TTY: 711)
- 방문 신청: 거주 지역의 사회복지국(County Board of Social Services) 방문
 - 버겐 카운티 (Bergen County) Board of Social Services
 - 주소: 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - 전화번호: 201-368-4200
- 업무 시간: 평일(월~금) 오전 8:00 ~ 오후 4:30 *NJ FamilyCare는 연중 언제든지 신청 가능합니다.

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ FamilyCare: 공식 CHIP/Medicaid 수혜 자격 가이드](#)
- [NJ 주정부 공식 'coverallkids' 웹사이트](#)

- [CMS.gov: 연방 정부 CHIP \(Insure All Kids Now\).](#)
- [CMS.gov – 뉴저지주 CHIP 가이드 \(PDF\).](#)
- [Medicaid.gov – 뉴저지 메디케이드와 CHIP 프로그램](#)

보청기 지원 (Hearing Aid)

뉴저지주는 저소득층 고령자와 장애인의 복지를 위해 보청기 구입 지원과 처방약 보조금 프로그램을 연계하여 운영하고 있습니다.

보청기 구입 비용 지원은 뉴저지주 청각장애인 지원국(DDHH)의 HAAAD(Hearing Aid Assistance to the Aged and Disabled) 프로그램을 통해 환급받을 수 있습니다. 해당 혜택의 자격 요건은 뉴저지주의 대표적인 처방약 보조 프로그램인 PAAD의 소득 기준을 동일하게 적용하여 심사합니다.

노인 및 장애인 보청기 지원 프로그램 (HAAAD)

PAAD에 등록된 뉴저지 거주자는 HAAAD 프로그램을 통해 이미 구입한 보청기 비용을 환급받을 수 있습니다.

- **환급 금액:** 보청기 1개당 \$500, 최대 \$1,000(양쪽)까지 환급 가능합니다. 다만, 환급은 연 1회에 한하며, 다음 연도에 추가 구입 시 새 신청서 제출이 필요합니다.
- **자격 요건:** PAAD 소득 기준을 충족해야 합니다. 현재 PAAD 또는 Lifeline(유틸리티 지원 프로그램)에 등록되어 있는 경우 바로 신청 가능하며, 미등록자도 NJSave 신청서를 먼저 제출하면 HAAAD를 신청할 수 있습니다.

메디케이드, 개인 의료보험 또는 퇴직자 보험으로 보청기 비용이 전액 지원되는 경우 **HAAAD 환급 대상에서 제외됩니다. 일부 만 지원되는 경우 차액에 대해 신청 가능합니다. 또한, **Senior Gold** 수급자는 HAAAD 환급 대상에서 제외됩니다.*

뉴저지 보청기 지원 프로젝트 (NJ Hearing Aid Project - NJHAP)

경제적 어려움이 있는 주민에게 중고 보청기(Refurbished Hearing Aids)를 무료로 제공합니다.

- **대상:** 65세 이상이거나, 청력 손실로 장애 판정을 받고 SSDI를 수급 중인 자.
- **소득:** 뉴저지 **PAAD 소득 기준**을 충족해야 함 (개인 \$54,943 이하 / 부부 \$62,390 이하).
- **구비 서류:**

PAAD 등록자: [양식 A \(Form A\)](#) – 간소화된 절차로 신청 가능.

PAAD 미등록자: [양식 B \(Form B\)](#) – 추가적인 소득 증빙 서류 필요.

- **필수 제출 사항:** 의사나 면허를 소지한 전문가(Audiologist)로부터 받은 **의료 진단서(Medical Clearance)** 또는 청력 검사 결과를 반드시 제출해야 합니다.

호라이즌 뉴저지 헬스 프로그램 (Horizon NJ Health Program)

메디케이드(NJFamilyCare/MLTSS) 가입자는 별도의 환급 신청을 할 필요 없이, **보험을 통해 직접 보청기 관련 혜택을 받을 수** 있습니다.

- **주요 보장 내용:** 청력 검사, 보청기 지급, 부속품, 소모품, 피팅(Fitting) 및 수리 서비스.
- **이용 절차:** 혜택은 통상 **48개월마다 1회** 제공됩니다. 의사의 검진과 보험사로부터의 사전 승인이 반드시 필요합니다.

**혜택 주기는 가입한 보험사(MCO) 플랜에 따라 다를 수 있으므로, 가입된 MCO에 직접 확인하시기 바랍니다.*

21세 미만: [EPSDT 프로그램](#)을 통해 보청기 및 관련 서비스에 대해 더 폭넓은 지원을 받을 수 있습니다.

신청 방법

• HAAAD

- 온라인 신청: [NJSave Online Application](#)
- 우편 제출: [HAAAD 공식 웹사이트](#) 에서 신청서 다운로드 후 작성
*PAAD/Lifeline 등록자는 HAAAD 신청서 작성 후 관련 서류와 함께 제출
- 전화번호: 1-800-792-9745

• NJHAP

- 우편 신청: [New Jersey Hearing Aid Project](#) 에서 NJHAP 신청서 다운로드 / 작성 후 우편 신청
- 전화번호: 청각장애인 지원국(DDHH) 609-588-2648 | communications2@dhs.nj.gov

신청서 접수 후 처리 기간은 약 **2주이며, 자격이 확인되면 뉴저지 청각장애인 지원국(DDHH)에서 승인 편지와 함께 참여 전문의(Audiologist) 명단을 우편으로 발송합니다.*

*다만, 기증 보청기 프로그램의 경우 재고 상황에 따라 실제 보청기를 수령하기까지는 약 **8~12주**가 소요될 수 있습니다.*

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org).

참고 자료

- [NJ DDHH – Hearing Aid Project 공식 안내 및 신청서](#)
- [NJ DHS – PAAD 및 HAAAD 프로그램 환급 절차 가이드](#)
- [Horizon NJ Health – 메디케이드 보청기 보장 혜택 요약](#)
- [Horizon NJ Health – 보청기 지원 절차 및 요건](#)

롱텀케어 메디케이드 (MLTSS)

롱텀케어 메디케이드는 만성 질환, 장애 또는 인지 장애로 인해 스스로를 돌볼 수 없는 개인을 위한 연방 및 주 정부 공동 운영 프로그램입니다. 뉴저지의 롱텀케어 메디케이드는 **MLTSS**(Managed Long Term Services and Supports) 프로그램을 통해 운영됩니다. 뉴저지 패밀리케어의 일환으로 제공되는 MLTSS는 HMO 또는 지정 관리 보험사(MCO)를 통해 모든 서비스를 조정합니다. 이 프로그램의 핵심 목표는 환자들이 가능한 한 오랫동안 익숙한 환경에서 독립적인 삶을 유지할 수 있도록 종합적인 지원 체계를 제공하는 것입니다.

주요 보장

- **홈케어 서비스:** 자택에서 받을 수 있는 가사 도움 및 개인 간병 서비스.
- **지역사회 기반 주거:** 어시스티드 리빙(Assisted Living) 입소 지원.
- **넬싱홈 케어:** 넬싱홈(Nursing Home) 입소 및 집중 케어.
- **의료 서비스:** 병원 방문, 전문의 진료 및 처방약 지원.
- **기타 지원:** 환자의 상태에 따른 맞춤형 롱텀케어 프로그램 연결(성인 데이케어, 주택 개조 등).

롱텀케어 관리 시스템

메디케이드 수혜자가 넬싱홈 입소나 롱텀케어 서비스를 필요로 할 때, 다음 두 가지 경로 중 하나를 통해 관리됩니다.

- **NJ FamilyCare MCO (관리 보험사):** 선택한 보험사를 통해 서비스가 관리되며, 케어 매니저가 개인별 맞춤형 케어 플랜을 수립합니다.
- **PACE (노인 포괄 케어 프로그램):** 55세 이상의 시니어를 위한 통합 서비스 프로그램으로, 지역사회 거주를 최우선으로 하며 의료 및 롱텀케어 서비스를 한곳에서 종합적으로 제공합니다.

자격 요건

항목	자격 요건
대상	65세 이상 고령자 또는 65세 미만 중 SSA나 뉴저지 주 정부에 의해 장애 판정을 받은 분.
소득	월 총소득 한도 (Gross Income): \$2,982 이하 (개인)
자산	자산 한도 (Resource Limit): \$2,000 이하 (개인) 배우자 생계 보호 규정 (부부 중 한 명만 신청 시) - 배우자의 월 소득이 \$2,643.75 미만이면 신청자의 소득에서 차액만큼 가져온다.(MMMNA) - 커뮤니티에 남은 배우자가 최대 \$162,660까지 보유 가능(CSRA)
의학적 요건	요양원 입소 기준(NFLOC)에 부합한다는 공식 판정 필수. 평가 기준: 평가 기준: 식사, 목욕, 옷 입기, 화장실 이용, 이동 등 일상생활(ADLs)에 대한 종합적인 평가.

*소득이 한도를 초과할 경우, Qualified Income Trust(QIT)계좌를 개설하여 자격 요건 충족.

*포함 자산 (Countable Assets): 현금, 당좌/저축 예금 계좌, 주식, 채권, 투자용 부동산 등이 포함됩니다.

*제외 자산 (Excluded Assets): 현재 거주 중인 주택(1채), 차량 1대, 그리고 특정 요건을 갖춘 선불 장례 보험 등은 \$2,000 자산 한도 계산에서 제외됩니다.

*부부 동시 신청 시: 부부합산 자산 한도 \$3,000 적용.

자산 조사 (Asset Look-back Period)

MLTSS 신청 시 가장 엄격한 부분은 주 정부가 실시하는 자산 조사(Look-back Period)입니다.

- 현금 인출 금지:** 5년 치 내역서에서 설명되지 않는 고액 현금 인출(대략 \$500 이상)은 모두 '증여'로 간주되어 증여 액수에 따라 메디케이드 승인이 지연됨.
- 기록의 중요성:** 모든 지출은 영수증과 계약서를 반드시 보관해야 하며, 증빙이 없으면 자산 양도로 판정됨.
- 전문가 상담 필수:** 규정이 매우 복잡하므로 고액 자산이 있는 경우 전문 변호사(Elder Law Attorney)와 상담하는 것이 안전함.

신청 서류

필수 기본 증빙 서류

- 신분 증명:** 시민권 증서, 출생 증명서, 또는 영주권 카드(I-551).

- **거주지 확인:** 주소지가 명시된 최근 유틸리티 빌 또는 임대 계약서.
- **소셜 시큐리티/메디케이드 카드:** 소셜 시큐리티 카드 및 현재 가입된 메디케이드 카드 앞뒷면 사본.

소득 및 재정 증빙 서류 (5년치 기록)

- **소득:** 소셜시큐리티 급여 확인서, 연금 수령 내역서, 임대/이자 수입 증빙 서류.
- **금융:** 모든 은행 계좌의 최근 60개월(5년)치 전체 내역서 (해지 계좌 포함).
- **재산:** 부동산 재산세 고지서, 담보 대출 정보, 생명 보험(현금 가치 포함), 차량 등록증(Title).

65세 미만 신청자

- 공식 장애 판정서.
- 위임장(Power of Attorney) 또는 가디언십 서류, 자산 이동에 대한 시장가 입증 서류.

합법적 자산 소진 (Spend-down) 전략

자산 한도(\$2,000)를 초과하는 경우, 규정 내에서 적격한 지출을 통해 자산을 줄일 수 있습니다.

개인 및 가계 자산 처분

- **부채 상환:** 모기지, 신용카드 대금, 미납 세금 및 기타 법적 대출금 우선 상환.
- **주택 수리 및 개조:** 지붕 수리, 휠체어 경사로 설치, 노후 가전 교체 등 주거 가치 높이는 지출 허용.
- **의료 장비 구입:** 보험 미적용 전동 침대, 휠체어, 보청기 등 필수 의료 기기 구입.

사전 지불 장례사 계약 (Irrevocable Prepaid Funeral)

최소 불가능한(Irrevocable) 조건의 사전 지불 장례 계약금은 메디케이드 자산 한도 산정에서 제외됩니다.

- 실제 서비스 범위를 초과하는 과도한 금액 예치는 자산 은닉으로 간주될 위험이 있습니다. 만약 2~3만 불 이상의 과도한 금액을 예치할 경우, 자산을 숨기려는 의도로 간주되어 조사를 받을 수 있습니다.
- 안전한 자산 정리(Spend-down)를 위해 계약 전 장례 전문 상담가나 노인법 전문 변호사(Elder Law Attorney)와의 상담을 권장합니다.

전문가 서비스 비용 지불

변호사 비용(Estate Planning), 회계사 비용, 메디케이드 신청 대행 비용 지출은 합법적 자산 소진으로 간주됩니다.

신청

- **거주 카운티 노인국(ADRC)에 MLTSS 신청** 요청하여 초기 전화 스크리닝을 받습니다. **동시에 사회복지국(Board of Social Services)에 재정 심사(메디케이드)도 신청**해서 소득과 재산이 기준에 맞는지 확인함.
- **건강 평가를 위해** 관리 보험사(MCO)가 집에 방문. 목욕, 옷 입기, 이동 등 일상생활에 얼마나 도움이 필요한지 확인함.
- **보험 플랜을 고르기:** 임상과 재정심사 모두 통과되면 관리 보험사(MCO)를 통해 플랜을 선택함.

*온라인 신청: [NJ FamilyCare/quickstart](https://www.njfamilycare.com/quickstart): 온라인 신청은 재정심사만 해결됨. ADRC 상담과 건강 평가는 별도로 진행해야 함.

*이미 NJ FamilyCare(메디케이드)가 있는 경우 카운티 ADRC 대신 담당 MCO 고객센터에 연락하여 MLTSS 임상 평가를 신청함.

문의

- **롱텀케어 메디케이드(MLTSS)**: 거주 지역의 노인 및 장애인 지원 센터(ADRC) 및 사회복지국 에 연락.
 - **버겐 카운티 노인국 (Bergen County Division of Senior Services)**
 - 주소: One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
 - 전화: 201-336-7400
 - 이메일: seniors@bergencountynj.gov
 - **버겐 카운티 사회복지국 (Bergen County Board of Social Services)**
 - 주소: 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - 전화: 201-368-4200
 - **뉴저지 ADRC 공통 무료전화: 1-877-222-3737**
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org).

Resources

- [NJ DMAHS – 장기 요양 메디케이드 공식 정보](#)
- [National PACE Association – PACE 모델 이해하기](#)

메디케이드 관리 보험사 (MCO) 시스템 (뉴저지)

메디케이드 관리 보험사(Managed Care Organization) 시스템은 수혜자에게 제공되는 서비스의 비용, 이용 및 품질을 관리하기 위해 설계된 의료 서비스 제공 체계입니다.

뉴저지주는 1995년부터 기존의 서비스별 수가제(Fee-for-Service) 모델에서 벗어나 관리 의료(Managed Care) 방식으로의 전환을 시작했습니다. 이 시스템은 주정부가 민간 관리 보험사(MCO)와 계약을 맺고, 메디케이드 관리국(DMAHS)에 등록된 회원들에게 주정부를 대신하여 종합적인 의료 서비스 패키지를 제공하도록 운영하는 방식입니다.

이러한 구조는 의료 서비스 제공을 간소화하고 서비스 품질을 높임으로써 건강 결과를 개선하는 것을 목표로 합니다.

뉴저지 MCO 시스템의 운영 체계

뉴저지 메디케이드 및 공적 건강 보험 서비스의 공식 명칭은 뉴저지 패밀리케어(NJ FamilyCare)입니다.

뉴저지의 메디케이드 수혜자들은 NJ FamilyCare 프로그램을 통해 특정 MCO가 관리하는 건강 플랜에 가입하게 됩니다. MCO는 회원의 의료 서비스 전반을 관리하며, 효율적으로 서비스에 접근 가능하도록 보장합니다.

주요 특징

- **체계적인 네트워크:** 검증된 의사 및 병원 네트워크를 통해 전통적인 방식보다 더 나은 서비스를 받을 수 있도록 돕습니다.
- **부가 서비스:** 일반 메디케이드의 표준 요구 사항을 넘어서는 추가 혜택(치과, 시력 관리, 건강 인센티브 등)을 제공할 권한이 있습니다.
- **통합 관리:** 건강한 신체와 정신을 위한 서비스의 통합이 더욱 강조되어 수혜자는 더욱 포괄적인 케어를 받게 됩니다.

뉴저지 내 MCO(2026)

NJ FamilyCare 프로그램에는 5개의 주요 관리 보험사(MCO)들이 참여하고 있습니다. 이 보험사들은 버겐(Bergen), 허드슨(Hudson), 에섹스(Essex)를 포함한 주 내 21개 모든 카운티에서 서비스를 제공하고 있습니다.

**Fidelis Care는 Hunterdon 카운티에서 서비스를 제공하지 않습니다.*

- **Aetna Better Health of New Jersey**
 - 주소: 3 Independence Way, Suite 400, Princeton, NJ 08540
 - 회원 서비스: 1-855-232-3596 (24시간 운영)
 - 청각 장애인 지원(TTY): 711
 - 웹사이트: aetnabetterhealth.com/newjersey
- **Fidelis Care (구 WellCare of New Jersey)**

- 주소: 33 Washington Street, 1st Floor, Newark, NJ 07102
- 회원 서비스: 1-888-453-2534 (월-금, 오전 8시~오후 6시)
- 청각 장애인 지원(TTY): 711 또는 1-877-247-6272
- 웹사이트: fideliscarenj.com

- **Horizon NJ Health**

- 주소: 1700 American Blvd., Pennington, NJ 08534
- 회원 서비스: 1-800-682-9090 (월-금, 오전 8시~오후 8시)
- 의료 제공자 전용: 1-800-682-9091
- 청각 장애인 지원(TTY): 711
- 웹사이트: horizonnjhealth.com

- **UnitedHealthcare Community Plan**

- 주소: 333 Thornall St, 9th Floor, Edison, NJ 08837
- 회원 서비스: 1-800-941-4647
- 의료 제공자 전용: 1-888-362-3368 (월-금, 오전 8시~오후 6시)
- 청각 장애인 지원(TTY): 711
- 웹사이트: uhccommunityplan.com/nj

- **Wellpoint (구 Amerigroup New Jersey)**

- 주소: 101 Wood Avenue South, 8th Floor, Iselin, NJ 08830
- 회원 서비스: 1-800-600-4441 / 의료 제공자 전용: 1-800-454-3730 (월-금, 오전 8시~오후 6시)
- TDD: 1-800-852-7899
- 웹사이트: wellpoint.com/nj

참고 자료

- Medicaid.gov: 공식 Medicaid 프로그램 개요
- NJ.gov: MCO 디렉토리

임산부 메디케이드 (Pregnancy Medicaid)

임산부 메디케이드는 각 주 정부별로 운영되며, 뉴저지주의 임산부 메디케이드는 다음과 같이 운영됩니다.

뉴저지 패밀리케어(메디케이드)는 뉴저지에 거주하는 임산부에게 필수적인 건강 보험을 제공합니다. 이 프로그램은 산모들이 건강한 임신과 출산에 필요한 의료 서비스를 받을 수 있도록 보장합니다. 혜택은 임신 초기부터 출산 후 첫 1년까지 산모를 위한 모든 의료 비용을 보장합니다.

자격 요건

- **거주지** : 뉴저지주 거주자
- **신분** : 시민권자 또는 합법적인 이민 신분자 (DACA는 불가)
- **소득** : 가구 총소득 연방빈곤선(FPL)의 205% 미만

소득 상한선 (2026)

*임산부의 경우 가구 규모 산정 시 태아를 가구원 수에 포함시킵니다. (예: 임신한 여성은 2인 가구로 간주)

가구 수 (태아 포함)	월 소득 한도	연 소득 한도
2인 (임신한 1인 가구)	\$3,697	\$44,362
3인	\$4,668	\$56,006
4인	\$5,639	\$67,650
추가 1인당	+ \$971	+ \$11,644

혜택 및 보장 연장

뉴저지 패밀리케어는 임산부의 건강한 출산과 산후 회복을 위해 임신 전 단계에 걸쳐 포괄적인 의료 서비스를 제공합니다.

주요 의료 보장 항목

서비스 범주	세부 보장 내용
산전 관리 (Prenatal)	정기 검진, 초음파, 유전 검사, 비타민 처방, 산전 교육
분만 및 출산 (Delivery)	자연분만, 제왕절개, 무통 주사, 병원 입원비 일체, 신생아 케어
산후 관리 (Postpartum)	출산 후 검진, 모유 수유 상담, 정신 건강(산후 우울증) 지원
기타 필수 혜택	처방약, 치과 진료, 시력 관리, 전문의 진료, 정신 건강 및 약물 남용 치료

산후 보장 연장 (Postpartum Extension)

수혜자는 출산 후 소득 변화와 관계없이 **12개월(365일)** 동안 지속적으로 보험 자격을 유지합니다.

- **연장 기간:** 출산 또는 임신 종료일로부터 12개월 동안 보장됩니다. (유산·사산 포함)
- **혜택 유지:** 임신 중 받던 모든 종합 혜택(Comprehensive Benefits)이 산후 기간에도 동일하게 유지됩니다.
- **자동 갱신:** 임신 카테고리 승인받은 경우, 산후 1년 동안은 별도의 소득 재심사 없이 보장이 지속됩니다.

고령 임신부 및 고위험군 특별 지원

2026년부터 고령 임신부나 고위험 임신군을 위한 추가적인 모니터링 및 케어 매니지먼트 서비스가 강화되었습니다. MCO(관리 보험사) 를 통해 고위험 임신부를 위한 케어 매니지먼트 서비스가 제공됩니다.

산부인과 주치의(OB/GYN) 배정 및 첫 진료 방법

메디케이드 승인 후 가장 먼저 해야 할 일은 본인이 가입한 보험사의 네트워크 내(In-Network)에 있는 산부인과 의사를 찾는 것입니다.

- **보험사 네트워크 확인:** 본인의 MCO 웹사이트나 고객센터를 통해 메디케이드를 받는 산부인과(OB/GYN) 리스트를 확인해야 합니다.
- **Care Management 서비스 활용:** 임신 사실을 보험사에 알리면, 보험사에서 케어 매니저(Care Manager)를 배정해 줍니다. 이들은 고위험군 여부를 판단하고, 병원 예약 및 교통편 지원(Non-Emergency Medical Transportation)을 도와 줍니다.
- **첫 진료 시 준비물:** 뉴저지 패밀리케어 카드와 신분증을 지참해야 하며, 임신으로 인한 특별 승인 기간에는 별도의 코페이가 없습니다.

임신 중 치과 혜택

서비스 항목	보장 내용
정기 검진 및 클리닝	연 2회 기본 클리닝 및 정밀 검사 보장
잇몸 치료 (Periodontal)	임신 중 심해질 수 있는 잇몸 질환에 대한 딥 클리닝(Scaling) 지원
충치 치료	레진(Fillings) 및 필요한 경우 크라운 치료
응급 처치	갑작스러운 치통으로 인한 발치 또는 신경 치료

메디케이드 연관 추가 혜택

각 보험사(MCO)는 임산부의 건강한 출산을 독려하기 위해 메디케이드 기본 혜택 외에 다음과 같은 인센티브를 제공하기도 합니다 (MCO별로 혜택 종류와 범위가 다를 수 있음).

- **보상 카드 (Rewards Cards):** 산전 검사를 제때 받거나 산후 검진을 완료하면 \$25~\$50 상당의 기프트 카드(Walmart, CVS 등) 제공.
- **무료 육아 용품:** 유축기(Breast Pump), 카시트, 기저귀 가방 등을 무료로 제공하거나 할인 쿠폰 증정.
- **교통 지원:** 병원 방문을 위한 무료 택시 또는 버스 카드 지원.

대체 프로그램

임산부 메디케이드 신청 자격이 되지 않더라도, 뉴저지 내 임산부는 안전한 출산을 위해 다양한 보조 프로그램의 도움을 받을 수 있습니다.

주요 대안 프로그램 비교

프로그램 명칭	대상자 및 목적	주요 지원 내용
갯허버드 뉴저지	메디케이드 소득 기준 초과자	주 정부 보조금을 통한 저렴한 민간 건강보험 가입
응급 의료비 지원 (MEPP)	서류 미비자 및 비시민권자	분만 및 출산과 관련된 응급 병원 비용 전액 보장
보충 산전 관리 (NJSPCP)	뉴저지 패밀리케어 소득 기준은 충족하나 이민 신분 요건이 미충족인 경우	산전 검사, 초음파, 비타민 및 산후 60일간의 피임 관리
연방 공인 의료 센터 (FQHC)	소득/체류 신분 불문 전체	소득 비례에 따른 저렴한 의료 서비스
병원비 지원(Charity Care)	저소득 무보험 환자	병원 입원비 및 분만 비용의 전액 또는 일부 감면

신청 방법

- 온라인 신청: [NJ FamilyCare QuickStart](#) 접속
 - 전화 문의: 뉴저지 패밀리케어 고객센터 (1-800-701-0710 / TTY: 711)
- 방문 신청: 거주 지역의 사회복지국(County Board of Social Services) 방문
 - Bergen 카운티 사회복지국 (Bergen County Board of Social Services)
 - 주소: 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - 전화번호: 201-368-4200
 - 업무 시간: 평일(월~금) 오전 8:00 ~ 오후 4:30

*뉴저지 패밀리케어는 연중 언제든지 신청 가능합니다.

문의

- AWCA에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ DHS.gov – 임신부를 위한 메디케이드 가이드](#)
- [NJ FamilyCare – 임신부 수혜 자격 안내](#)

ABD 메디케이드 (뉴저지 패밀리케어 ABD)

ABD(Aged, Blind, Disabled) 메디케이드는 65세 이상 고령자나 사회보장국(SSA) 등 정부 기관으로부터 장애 판정을 받은 분들을 위한 종합 의료 보장 프로그램입니다. 뉴저지주에서는 'NJ FamilyCare ABD'라는 공식 명칭으로 운영되며, 연방과 주 정부가 공동으로 재원을 부담합니다.

이 프로그램은 단일 체계가 아닌 SSI 연계, NJ Care Special, Medicaid Only, NJ WorkAbility, 롱텀케어(MLTSS) 등 다양한 하위 프로그램으로 세분화되어 있으며, 신청자의 소득·자산 수준 및 세부 상황에 따라 적용 프로그램이 결정됩니다.

자격 요건 (2026)

- **연령/대상:** 65세 이상 또는 시각 장애인, 일반 장애인
- **소득:** 월 \$1,330 이하 (개인) | \$1,804 이하 (부부)
- **자산:** \$4,000 이하 (개인) | \$6,000 이하 (부부)

혜택

- **기본 및 전문의 진료:** 일반 검진, 예방 접종, 주치의 방문 및 각 분야 전문의 진료.
- **치과 서비스:** 정기 검진, X-레이, 충치 치료(충전), 발치 및 기타 필수적인 치과 치료.
- **안과 및 청력:** 정기적인 시력 검사, 처방 안경 및 청력 검사 서비스가 포함.
- **처방약 지원:** 방대한 규모의 참여 약국 네트워크를 통한 다양한 처방 약품.
- **정신 건강 서비스:** 정신 건강 유지 및 약물 남용 회복을 위한 포괄적인 외래 및 입원 상담 서비스.

**이중 수혜 자격(Dual Eligibility): 메디케어(Medicare)에 가입된 개인도 ABD 메디케이드 신청이 가능합니다. 자격이 인정될 경우, 메디케이드가 메디케어 프리미엄, 코페이 및 본인 디덕터블 지분을 지원합니다.*

**자동 수혜 자격(Automatic Eligibility): 생활보조금(SSI) 수령자는 ABD 메디케이드 자격이 자동으로 부여되므로, 별도의 가입 신청서를 제출할 필요가 없습니다.*

신청 방법

- **온라인 신청:** [NJ FamilyCare/quickstart](https://njfamilycare.com/quickstart)
 - 전화 문의: 1-800-701-0710 / TTY: 711
- **방문 접수:** 거주 지역의 카운티 사회복지국(Board of Social Services) 방문
 - 버겐 카운티 사회복지국 (Bergen County Board of Social Services)
 - 주소: 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - 전화: 201-368-4200

- 운영 시간: 평일 오전 8:00 ~ 오후 4:30

- 우편 접수: [ABD 프로그램 신청서\(PDF 양식\)](#)
 - 작성 후 거주지 카운티 사회복지국으로 우송

*뉴저지 패밀리케어는 연중 상시 등록이 가능합니다.

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ FamilyCare – 공식 자격 요건 안내 가이드](#)
- [NJ.gov – 카운티별 소셜 서비스 사무소 위치 검색](#)
- [NJ DHS – WorkFirst NJ \(WFNJ\) 현금 지원 신청 가이드](#)
- [NJ DHS – NJ SNAP 푸드 스탬프 신청 공식 안내](#)

PART II • 제 5 편

메디케이드 특별 플랜 (Medicaid Specials)

Medicaid Specials

메디케이드 특별 제도 및 안전망: 듀얼 플랜(D-SNP), 배우자 빈곤 방지 규정(Spousal Impoverishment), 채리티 케어(자선병원비 지원), 응급 의료 지원, WFNJ/GA & TANF, 장례비 보조, 장애인 근로자 메디케이드 바이인, 메디케이드 자산 환수 규정(Estate Recovery).

본 부문 총 9개 상세 안내 문서 수록

병원비 지원 프로그램 (Charity Care)

병원비 지원 프로그램(Charity Care/New Jersey Hospital Care Payment Assistance Program)은 건강보험이 없거나 혜택이 부족한 저소득층을 위해 주 정부가 지정한 종합병원(Acute Care Hospitals)에서 제공하는 병원비 감면 프로그램입니다.

New Jersey Hospital Care Payment Assistance Program은 뉴저지주 보건부(NJ Department of Health)가 규정하고 주 기금으로 재원을 지원하는 프로그램으로, 신청 및 자격 심사는 진료받은 병원에서 진행합니다.

자격 요건

- 거주 및 보험 상태:
 - 건강보험이 없거나 보험이 있어도 본인 부담금이 과도한 경우.
 - 메디케이드 등 정부 보조 보험 또는 민간 건강보험에 가입할 자격이 없는 사람.
- 자산 (Assets):
 - 개인: \$7,500 이하
 - 가족: \$15,000 이하

*주 거주지 1채는 자산에서 제외됩니다. 단, IRA 등 현금화 가능한 은퇴 계좌는 자산 산정에 포함될 수 있습니다 (N.J.A.C. 10:52-11.10). 401k 등 인출 불가능한 계좌는 병원과 개별 확인이 필요합니다.

소득 수준 (Income Levels, 2026)

소득 수준 (연방 빈곤선 FPL% 기준)	환자 본인 부담률	지원 형태
FPL 200% 이하	0% (전액 면제)	무료 진료 (Free Care)
201% – 225% FPL	20%	부분 감면
226% – 250% FPL	40%	부분 감면
251% – 275% FPL	60%	부분 감면
276% – 300% FPL	80%	부분 감면

*소득이 FPL 201~300% 구간(부분 감면 대상)인 환자가 연간 본인 부담 의료비가 연 소득의 30%를 초과할 경우, 초과분에 대해 100% 추가 지원을 받을 수 있습니다.

주의사항

- 종합병원(Acute Care Hospital)에서 제공되는 미용 목적의 수술이나 선택적 진료를 제외한 입원·외래 진료에 적용.
- **의사 비용 별도:** 병원 시설 이용료(Hospital Charges)는 감면되지만, 병원에 소속되지 않은 **개별 전문의(마취과, 방사선과 등)의 진료비**는 별도로 청구될 수 있음.
- **메디케이드 우선 확인:** 병원은 Charity Care 심사 전 환자가 메디케이드 대상자인지 먼저 확인하며, 대상자인 경우 메디케이드 신청을 먼저 요구함.

신청

- 종합 병원의 **재무 상담 부서(Financial Counseling)**

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ DOH.gov – Charity Care 공식 안내](https://www.nj.gov/doh/charity-care/)
- [NJ DOH.gov – 2026 병원비 지원 팩트 시트](#)
- [DollarFor.org – 뉴저지 FPL 기반 의료비 감면 계산기](https://dollarfor.org/)

듀얼 플랜 (D-SNP)

듀얼 플랜 (Dual Eligible, 이중 자격자)이란 65세 이상 어르신이나 장애인을 위한 의료 보험인 메디케어와 메디케어를 보유하면서 동시에 저소득층을 위한 의료 보조인 메디케이드까지 함께 받는 분들을 말합니다.

이중 자격자 분들은 두 보험의 혜택을 하나로 통합한 D-SNP(Dual Special Needs Plan)에 가입함으로써 보다 효율적인 의료 서비스를 받을 수 있습니다. D-SNP 플랜은 연방 정부의 가이드 아래 각 주별로 고유한 명칭과 운영 방침에 따라 관리됩니다.

**OBBA 법안 시행에 따라 자격 요건이 달라질 수 있습니다.*

D-SNP의 세 가지 유형

D-SNP는 통합 수준에 따라 세 가지 유형으로 나뉘며, FIDE SNP는 그 중 가장 높은 완전 통합형입니다.

- **CO D-SNP (Coordination-Only):** 메디케어와 메디케이드 혜택을 조율해주는 기본형 플랜입니다. 두 보험의 관리 주체는 여전히 분리되어 있습니다.
- **HIDE SNP (Highly Integrated):** 메디케어와 메디케이드 대부분의 서비스를 하나의 보험사가 담당하는 고통합형 플랜입니다.
- **FIDE SNP (Fully Integrated Dual Eligible SNP):** 하나의 보험사가 메디케어와 메디케이드(MLTSS 포함) 혜택을 100% 통합 관리하는 완전 통합형 플랜입니다. 뉴저지에서는 주요 보험사들이 FIDE SNP를 운영하고 있으며, 카운티에 따라 이용 가능한 플랜이 다를 수 있습니다.

주별 유사 프로그램 명칭:

- 뉴저지, 매사추세츠 등: FIDE SNP
- 뉴욕: MAP (Medicaid Advantage Plus) — D-SNP와 Medicaid 롱텀케어플랜(MLTC)이 결합된 뉴욕 특화 통합플랜
- 캘리포니아: Medi-Medi Plans (공식 명칭)

자격 요건

- **D-SNP (CO D-SNP / HIDE SNP):** 메디케어와 메디케이드 자격을 동시에 갖춘 분이라면 누구나 가입을 검토할 수 있습니다.
- **FIDE SNP (뉴저지 기준):** 아래 네 가지 조건을 모두 충족해야 합니다.
 - Medicare Parts A 및 B 보유
 - Full NJ Medicaid(NJ FamilyCare) 보유
 - PACE 프로그램 미가입
 - 뉴저지 거주자

*MLTSS(롱텀케어) 수급 자체는 FIDE SNP 가입 필수 조건이 아닙니다. 다만, MLTSS를 받고 계신 분도 FIDE SNP에 가입하여 모든 서비스를 한 곳에서 통합 관리받을 수 있습니다.

D-SNP 혜택

D-SNP는 메디케어와 메디케이드 혜택을 조율(Coordinate)하여 제공하며, 주 정부 메디케이드와 연계된 다양한 추가 서비스를 포함합니다.

의료비 및 약값 부담 최소화 (Cost Sharing)

- 보험료(Premium): 메디케이드의 모든 의료 혜택을 받는 분들은 매달 내는 보험료는 물론, 병원 진료나 검사를 받을 때 내는 본인 부담금(코페이)이 없습니다.
- 코페이: In-Network 의사 진료, 전문의 방문, 검사, 입원 등에 대해 본인 부담금이 없는 것이 일반적입니다. 단, 주 정부로부터 보험료 지원(QI, SLMB 등)만 받는 메디케이드 수혜자는 일부 코페이를 지불하는 경우가 있습니다.
- 처방약: 메디케어 파트 D 처방약 보조(Extra Help)를 통해 연간 한도와 무관하게 대부분의 약값 코페이는 없습니다.

혜택 카드 (Benefits Card / OTC)

- OTC(비처방약) 지원: 매달 또는 분기별로 지급되는 크레딧으로 상비약, 비타민, 구급용품 등을 구매할 수 있습니다. FIDE SNP보다 금액이 다소 적을 수 있습니다.
- 식료품 및 유틸리티: 자격 대상자 중 만성 질환(당뇨, 고혈압 등)이 있는 경우에 한해 식료품 구매 및 전기·가스비를 결제할 수 있는 카드를 제공합니다.

부가 의료 혜택

- 치과: 기본 검진뿐만 아니라 충치 치료, 크라운, 틀니, 임플란트 등 포괄적인 치과 혜택을 연간 한도 내에서 제공합니다.
- 안과: 매년 시력 검사와 일정 금액의 처방 안경을 지원합니다.
- 청각: 청력 검사와 함께 보청기 구입 및 피팅(Fitting) 비용을 지원합니다.

교통 및 웰니스(Wellness)

- 병원 교통편: 병원 진료 및 약국 방문을 위한 차량 서비스(우버/리프트 또는 전용 밴)를 정해진 횟수만큼 제공합니다.
- 피트니스: Silver&Fit 또는 SilverSneakers와 같은 무료 체육관 멤버십을 제공합니다.
- 24시간 간호사 라인: 긴급한 건강 상담을 위해 24시간 전문 간호사와 연결되는 전화 상담 서비스를 제공합니다.

FIDE SNP 혜택

뉴저지 내 주요 보험사(Horizon, UnitedHealthcare, Aetna, Wellcare 등)의 FIDE SNP 혜택은 다음과 같습니다.

의료비 (Cost Sharing)

- 코페이: 의사 진료, 전문의 방문, 입원비 등이 전액 면제됩니다.
- 처방약: 메디케어 Part D 처방약(Extra Help)을 포함하여 대부분의 처방약 코페이가 없습니다.

통합 카드 혜택 (OTC & Grocery)

- OTC(비처방약) 지원: 매달 또는 분기별로 일정한 금액을 카드에 충전해 주며, CVS나 Walgreens 등에서 영양제, 상비약을 구매할 수 있습니다.
- 식료품 및 유틸리티: 대부분의 FIDE SNP 플랜들이 식료품(Grocery) 구매나 공공요금(전기, 가스, 수도) 결제에 사용할 수 있는 통합 카드를 제공합니다. (플랜에 따라 월 약 \$150~\$300 내외)

부가 혜택

- 치과: 연간 한도 내에서 임플란트, 틀니, 스케일링 등을 포함한 포괄적 치과 치료를 보장합니다.
- 안과: 매년 시력 검사와 안경/콘택트렌즈 구입 비용을 지원합니다.
- 청각: 청력 검사와 함께 보청기 구입 비용 및 피팅(Fitting) 서비스를 제공합니다.

교통 및 웰니스(Wellness)

- 병원 방문이나 약국 이용을 위해 연간 무제한 또는 정해진 횟수의 차량 지원(우버/리프트 또는 전용 밴)을 제공합니다.
- 무료 피트니스 멤버십: SilverSneakers 또는 Silver&Fit 프로그램을 통해 지역 체육관 및 YMCA 무료 이용, 홈 피트니스 키트 및 온라인 운동 강의를 제공합니다.
- 건강 보상 프로그램 (Healthy Rewards): 정기 검진, 독감 예방 접종, 당뇨 수치 검사 등 질병 예방 활동을 완료할 때마다 기프트 카드나 현금성 포인트로 보상에 드립니다.
- 방문 건강 상담 (In-home Visits): 매년 전문가가 직접 자택을 방문하여 건강 상태를 확인하고 맞춤형 케어 계획을 세워주는 'HouseCalls' 서비스를 제공합니다.
- 24시간 간호사 상담: 건강상 궁금증이나 긴급 상황 발생 시 24시간 언제든지 전문 간호사와 무료로 전화 상담이 가능합니다.
- 웰니스(Wellness) 디지털 어플: 스마트폰 어플을 통해 실시간 건강 수치 관리 및 웰빙 코칭(식단, 운동 등) 서비스를 이용할 수 있습니다.

주요 차이점

구분	D-SNP (CO/HIDE)	FIDE SNP
핵심 특징	메디케어와 메디케이드 운영 주체가 나뉘어 있어 보험사가 중간에서 연결해 주는 구조입니다.	단일 보험사가 모든 서비스와 재정을 하나로 통합하여 직접 결정하고 관리합니다.
관리 편리성	의료와 간병(MLTSS) 관리가 분리되어 소통이 다소 복잡할 수 있으며, 메디케어와 메디케이드 카드를 각각 따로 지참해야 할 수 있습니다.	통합 관리 (ID 카드 하나로 병원, 약국, 간병인 서비스를 한 번에 해결할 수 있습니다).
의사소통 (상담)	의료 상담(보험사)과 복지 상담(카운티)을 위해 각각 따로 연락해야 할 수도 있습니다.	원스톱 서비스 (전담 케어 매니저 한 명을 통해 의료와 복지 상담을 한 번에 해결할 수 있습니다).
치과/안과 혜택	매우 높음 (임플란트 한도나 안경 지원금이 상대적으로 넉넉한 편입니다).	보통 (메디케이드 표준 보장에 집중하며, 추가 지원 한도는 상대적으로 낮을 수 있습니다).
혜택 카드	사용 범위가 식료품보다는 상비약(OTC) 위주로 제한되는 경우가 많으며, 만성질환 확인 절차가 필요합니다.	식료품 및 공공요금 지원 한도가 더 높음 (보통 월 \$50~\$100 더 많음). 보험사가 메디케이드 재정까지 직접 관리하므로 통합 사용 금액(월 최대 약 \$300 내외)이 더 높습니다.
교통편	주로 병원 방문 등 의료적 목적에 집중하며, 연 24~48회 등 정해진 횟수 내에서만 이용 가능합니다.	무제한 또는 더 넓은 범위의 이동 지원. 병원뿐만 아니라 식료품 구매, 치과·안과 방문, 제휴 체육관 등 일상적인 외출에도 이용 가능합니다.

2026년 변경사항 및 주의점

- 통합 가입 (Alignment): 연방 및 주 정부(CMS·NJ DHS 정책)는 행정 효율을 위해 가급적 메디케어와 메디케이드 보험사를 하나로 통일하는 FIDE SNP 가입을 적극 권장하고 있습니다.
- 자동 전환: 일부 D-SNP 가입자는 주 정부 지침에 따라 더 혜택이 강화된 FIDE SNP로 자동 전환될 수 있으므로, 우편으로 오는 가입 통지서를 반드시 확인해야 합니다.
- 매월 전환 가능: full-benefit 이중 자격자는 매월 통합 플랜(FIDE SNP, HIDE SNP 등) 간 전환이 가능한 월간 특별 가입 기간(Monthly Integrated Care SEP)이 적용됩니다.

MLTSS를 받고 계신 분들은 우선순위에 따라 맞는 플랜을 정해보세요:

- 치과 수술 한도나 더 넓은 의사 네트워크가 중요하다면 → D-SNP
- 현금성 지원(식료품 카드)과 편리한 행정 서비스가 중요하다면 → FIDE SNP

신청 방법

D-SNP

- 온라인: [Medicare.gov](https://www.Medicare.gov) — 메디케어 플랜 찾기 또는 각 보험사 웹사이트
 - 전화: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; 24시간 연중무휴) 또는 각 보험사 전화번호
- *혜택은 일반적으로 가입 승인 후 다음 달 1일부터 시작됩니다.

FIDE SNP (뉴저지)

FIDE SNP는 Medicare와 Medicaid 혜택을 하나의 건강플랜에서 통합 관리하는 완전 통합형 이중 자격자 플랜입니다.

FIDE SNP에 가입하려는 경우, 아래 두 가지 경로 중 본인 상황에 맞는 방법을 선택하세요.

- MLTSS 없이 FIDE SNP만 가입하려는 경우 → 1-800-MEDICARE(1-800-633-4227) 또는 아래 각 보험사에 직접 연락하여 가입을 진행합니다.
- MLTSS도 함께 필요한 경우 → 지역 카운티 ADRC에 먼저 연락하여 MLTSS clinical screening을 받은 후, 승인이 나면 FIDE SNP 보험사에 통합 요청합니다. 지역 ADRC 검색은 eldercare.acl.gov에서 확인할 수 있습니다.

Bergen County 거주자는 Bergen County Division of Senior Services로 문의하세요.

- 주소: One Bergen County Plaza, Hackensack, NJ 07601
- 전화: 201-336-7400 | 1-877-222-3737
- 이메일: seniors@bergencountynj.gov

**MLTSS가 승인되면, 본인이 선택한 FIDE SNP 보험사에 연락하여 메디케어와 메디케이드 혜택을 해당 보험사 한 곳으로 완전히 통합(Fully Integrate)해 달라고 요청해야 합니다.*

온라인/전화: 각 FIDE SNP 보험사 (아래 보험사별 플랜 비교표 또는 [NJ DHS 공식 페이지](#) 참조)

**절차가 완료되면, 메디케이드 관리 주체가 주 정부나 별도 기관에서 본인이 선택한 FIDE SNP 보험사로 자동 전환됩니다. 기존 Medicare·Medicaid 카드는 보관하되, 이후에는 FIDE SNP에서 발급한 단일 ID 카드 하나로 모든 혜택을 이용하게 됩니다.*

FIDE SNP 보험사별 플랜 비교 (2026)

보험사 (Carrier)	D-SNP (플랜 이름)	FIDE SNP (플랜 이름)	연락처 및 웹사이트	2026년 주요 특징
Horizon BCBS	Horizon NJ TotalCare	Horizon NJ TotalCare	1-800-543-5656 (TTY: 711) / Horizonblue.com	뉴저지 최대 네트워크. Horizon &more Card를 통해 연간 최대 \$3,000+ 혜택 제공.
United Healthcare	UHC Dual Complete	UHC Dual Complete	1-800-514-4911 (TTY: 711) / UHC.com	UCard 혜택 강화. 식료품/공공요금 등 으로 매월 약 \$246+ 크레딧 지원.
Aetna	Aetna Medicare D- SNP	Aetna Medicare FIDE	1-844-362-0934 (TTY: 711) / AetnaBetterHealth.com/NJ	CVS 약국 네트워크 강점. 매월 약 \$255의 추가 혜택 카드 제공.
Wellcare (Fidelis)	Wellcare Dual Access	Fidelis Dual Align	1-866-892-8340 (TTY: 711) / Fideliscare.org	메디케이드 관리 전문성. MLTSS(장기 요양) 서비스 승인 및 조율 프로세스 우수.
Wellpoint	Wellpoint Dual Advantage	Full Dual Advantage	1-844-765-5160 (TTY: 711) / Wellpoint.com	지역 밀착형 서비스. 승인 절차 간소화 및 실용적인 부가 서비스 집중.

*보험사 연락처, 플랜명은 매년 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 Medicare.gov or FIDE SNP Consumer and Provider Information 에서 확인하시기 바랍니다.

문의

- 뉴저지 SHIP (주정부 보험 상담): 1-800-792-8820 (주정부 교육을 받은 전문가의 무료 상담)
- AWCA에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ DHS — FIDE SNP 통합 플랜 소비자 정보](#)
- [Medicare.gov — 2026년 메디케어 앤 유 핸드북 \(통합 플랜 섹션\)](#)
- [CMS.gov — D-SNP](#)

응급 의료비 지원 (Emergency Medicaid)

Emergency Medicaid 는 저소득층 주민이 응급 상황 발생 시 체류 신분이나 보험 유무와 관계없이 치료받을 수 있도록 MEPP(Medical Emergency Payment Program)와 주 메디케이드를 통해 비용을 지원합니다.

Medical Emergency Payment Program (MEPP)

이 프로그램은 영주권 취득 후 5년이 지나지 않은 성인 등 **일반 메디케이드 자격이 없는 주민**의 응급실 및 출산 비용을 지원합니다.

자격 요건

- **대상:** 이민 신분과 상관없이 Medicaid 소득/자산 요건을 충족하는 뉴저지 거주자
- **신청 기한:** 응급 상황 발생일로부터 **3개월 이내**에 반드시 신청해야 함
- **적용 범위:** 생명에 지장이 있는 응급 상황, **분만(Labor and Delivery)** 및 관련 입원 비용
- **소득 기준 (월 소득):**
 - **성인 (19-64세):** 1인 가구 약 **\$1,800** / 2인 가구 약 **\$2,433** (FPL 138% 기준)
 - **임산부:** 1인 기준 약 **\$2,647** (FPL 199% 기준)
 - **65세 이상/장애인:** 1인 기준 월 소득 **\$1,305** / 자산 한도 **\$4,000**, 부부 기준 월 소득 **\$1,763** / 자산 한도 **\$6,000** 별도 적용

NJ FamilyCare & Cover All Kids

- **대상:** 이민 신분과 상관없이 뉴저지에 거주하는 19세 미만 모든 아동
- **소득 한도:** 가구 소득이 FPL 355% 이하인 경우 (4인 가구 기준 월 약 **\$9,512** – 소득 구간에 따라 본인부담이 달라질 수 있음)
- **혜택:** 응급 처치뿐만 아니라 일반 진료, 치과, 안과, 정신 건강 등 포괄적 혜택 제공
*자세한 내용은 [CHIP](#) 항목 참조

임산부 특별 지원 (NJSPCP)

- **대상:** 이민 신분 상관 없이 보험이 없는 임산부
- **지원 내용:** 산전 검사, 피임/가족 계획 등. (출산 및 산후 진료는 커버하지 않음)

- **MEPP 연계:** 출산 시기가 되면 산전 진료 기관을 통해 출산 비용을 커버하는 **MEPP**를 미리 신청할 수 있습니다.

*자세한 내용은 [Pregnancy Medicaid](#) 항목 참조

영양 지원 프로그램 (WIC)

모든 저소득 임산부는 **New Jersey Supplemental Nutrition Program for Women Infants and Children(WIC)** 프로그램을 통해 우유, 계란, 치즈 등 필수 식품과 영양 교육을 받을 수 있습니다. 이는 체류 신분과 관계없이 신청 가능합니다. 이 프로그램은 뉴저지 주정부에서 운영하며 메디케이드와는 별도의 프로그램입니다.

- **대상:** 체류 신분과 관계없이 신청 가능한 저소득층 임산부 및 수유부
- **지원 내용:** 우유, 계란, 치즈 등 필수 식품 바우처 제공 및 전문 영양 교육/상담
- **특이 사항:** 의료비 지원 프로그램(NJSPCP 등)과 별개로 중복 수혜가 가능하며, 건강한 출산과 영유아 성장을 돕는 영양 보조 프로그램입니다.* 자세한 내용은 [주정부 공식 WIC 홈페이지](#) 참조

문의

- 일반 신청 및 상담: NJ FamilyCare 상담 핫라인 **1-800-701-0710**
- MEPP (응급 의료비 지원): **1-800-356-1561**
- 자격 요건 자가 진단: [NJHelps.gov 공식 웹사이트](#)
- 자격 갱신 및 유지 확인: [StayCoveredNJ.gov 공식 웹사이트](#)
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 사항

- **자격 심사:** 모든 가입자는 연 1회 갱신해야 합니다. 주소가 변경되었다면 반드시 **1-800-701-0710**으로 연락하여 업데이트해야 보험 중단을 막을 수 있습니다.
- **병원 협조:** 응급실 방문 시 병원 소셜 워커나 재무 상담원(Financial Counselor)에게 “MEPP 신청을 원한다”고 명확히 알려야 합니다.
- **사후 신청:** 병원에서 신청하지 못했다면 지역 카운티 사회복지국(County Board of Social Services)을 직접 방문하여 **3개월 이내**에 신청서를 제출해야 합니다.

참고 자료

- [NJ DHS.gov – Medical Emergency Payment Program \(MEPP\) 공식 안내](#)
- [NJ FamilyCare.gov – Cover All Kids 안내](#)
- [NJ DHS.gov – 카운티별 사회복지국 연락처](#)

장례 지원 프로그램 (Funeral & Burial Assistance)

사망 당시 특정 공공 보조 프로그램을 받고 있었거나, 자산이 없는 무연고/저소득층(Indigent) 주민을 위해 주정부 보건복지부(DHS) 및 각 카운티 사회복지국(county social service offices)이 장례 및 매장/화장 비용을 지원합니다.

자격 요건

사망자가 사망한 시점에 다음 중 하나에 해당해야 합니다.

- **수급자 기준:**
 - WFNJ/GA 수혜자로서 사망 시점을 기준으로 **최소 6개월 이상** 지속적으로 혜택을 받아온 자
 - NJ 공공기관(교정 시설 제외)에서 처음 6개월 내 사망한 WFNJ 수급자
 - 사망 후 15일 이내에 신규 승인된 신청자
 - 지역사회 돌봄 프로그램(CCPED, AACAP, Adult Foster Care) 수급자
 - NJ Workability Program 참여자

**이외에도 다양한 자격 범주가 있으므로 카운티 사회복지국에 문의 필요*

뉴저지 DHS 장례 보조금 지원 기준

사망자 연령 (Age Group)	장례 지원금 (Funeral Allowance)	매장/화장 지원금 (Cemetery)	주 정부 합계 지원액 (Total State Payment)	가족 최대 추가 부담 (Max Family Supplement)	최대 허용 총액 (Max Permitted Total)
성인 및 2세 이상	\$3,056	\$714	\$3,770	\$1,570	\$5,340
1주 ~ 2세 미만	\$2,494	약 \$583	약 \$3,077	\$1,178	약 \$4,255
사산 ~ 6일 이하	\$1,933	\$452	\$2,385	\$785	\$3,170

**가족 추가 부담(Family Supplement): 규정에 따라 유가족이 장례의 질을 높이기 위해 명시된 금액 한도 내에서 추가로 비용을 지불할 수 있습니다.*

**위 금액은 Whigham Funeral Home 등 뉴저지 복지국(DHS) 규정을 따르는 기관에서 인용하는 공식 기준입니다.*

보장 및 제한 사항

- **보장 항목:**
 - 시신 수습 및 처리, 관(Casket) 또는 유골함(Urn)
 - 장례식장 시설 이용 및 기본 서비스
 - 묘지 매장지 비용 또는 화장 비용
- **지원제외 항목:**
 - 성직자·교회·예식홀 이용료
 - 부고 및 사망 공고 게재 비용
 - 화장 후 유골 처리 비용 (산골, 유골함 안치 등 화장 이후 발생하는 비용)
 - 위에 명시되지 않은 기타 항목
- **제외 및 차감:**
 - 사망자가 남긴 자산(은행 잔고, 생명 보험, 유가 증권, 부동산, 사망 전후 지급된 금액 등)이 있을 경우, 주 정부가 이를 회수합니다. 단, 이는 장례지도사와 묘지가 받는 지원금 자체에는 영향을 주지 않습니다.
 - 사전에 개설된 취소 불가 선불 장례 계좌(Irrevocable Prepaid Funeral Account)가 있다면 해당 자금을 장례 비용에 먼저 사용해야 합니다. 단, 장례 비용 지불 후 남은 잔액은 주 정부가 회수할 수 있습니다.

참고 사항

- **사전 승인 필수:** 이미 모든 장례 비용을 지불한 후에는 환급(Reimbursement)을 받기가 매우 어렵습니다. 반드시 **장례 진행 전**에 장례 지도사(Funeral Director)에게 **Public Assistance Funeral** 을 신청해달라고 요청하세요.
- **자산 조사:** 주 정부는 사망자의 은행 계좌를 조사하며, 잔액이 지원 금액을 초과할 경우 지원을 거절할 수 있습니다.
- **유가족 추가 비용 허용 한도:** 유가족이 추가 부담 허용 한도(\$1,570)를 초과하여 비용을 지불할 경우, 초과한 금액만큼 주 정부 지원금이 동일하게 차감됩니다.

예: 유가족이 \$1,670을 추가 부담할 경우(한도 \$100 초과), 주 정부의 성인 장례 지원금은 \$3,770에서 \$3,670으로 줄어듭니다.

신청

장례 절차를 진행하기 전, 또는 진행 중 장례 지도사(Funeral Director)가 유가족을 대신해 해당 카운티에 자격 확인 및 승인을 요청해야 합니다.

문의

- **지역 카운티 사회복지국(county social service offices)**
 - 뉴저지주 카운티별 연락처: [NJ DHS.gov – 카운티별 사회복지국](https://www.nj.gov/dhs/county-social-service-offices/) 연락처

- **NJSFDA (뉴저지 주 장례지도사 협회):** 1-800-734-3712 | njsfda@njsfda.org
- **사회보장 사망 일시금 (Lump-Sum Death Payment, \$255) 신청:** 사망자의 Social Security 가입 이력이 있는 경우, 자격 요건을 충족하는 배우자 또는 자녀에게 \$255의 일시금이 지급될 수 있습니다. 자격 요건을 갖춘 배우자가 없을 경우에는 일정 조건을 충족하는 자녀가 수령할 수 있습니다.
 - 신청 기한: 사망일로부터 2년 이내
 - 신청 방법: SSA 전화 1-800-772-1213 또는 가까운 SSA 지역 사무소 방문
 - 공식 웹사이트 [SSA.gov](https://www.ssa.gov)
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJSFDA.org](https://www.njsfda.org) – 뉴저지 공공 장례 지원 안내
- [Penn Jersey Cremation](#) – 메디케이드 화장 지원 가이드
- [Woody Home for Services](#) – 수급자 대상 장례비 환급 한도표

메디케이드 바이-인 (Medicaid Buy-In, NJ WorkAbility)

NJ WorkAbility는 장애 판정을 받고 일하고 있는 뉴저지 주민이 소득이나 자산 때문에 일반 메디케이드(NJ FamilyCare) 자격이 안 되는 경우에도 전체 메디케이드 혜택을 받을 수 있도록 하는 프로그램입니다.

**SSDI 수급자의 경우, 메디케어 자격이 생기는 24개월 대기 기간 동안 건강보험 공백을 메우는 데에도 활용할 수 있습니다.*

**메디케어 자격은 SSDI 수급 시작 후 24개월이 기준이지만, SSDI 수급 자체가 장애 발생일로부터 5개월 대기 후 시작되므로 실제 대기 기간은 장애 발생일 기준 최대 약 29개월입니다.*

자격 요건

- **연령:** 16세 이상 (**65세 이상도 신청 가능하나, 장애 판정은 반드시 65세 이전에 받아야 합니다.**)
- **장애:** 사회보장국(SSA)의 장애 판정을 받았거나, DMAHS(뉴저지 주 의료부조 및 건강서비스국) 산하 Medical Review Team을 통해 장애 판정을 받아야 합니다. **SSDI**를 이미 수급 중인 경우 별도 판정 없이 자동으로 장애 요건을 충족합니다.
**현재 SSDI를 받지 않는 경우, NJ DDS(1-888-285-3036)에 문의하면 자격 여부를 사전에 확인할 수 있습니다.*
- **근로:** 파트타임 또는 풀타임, 자영업자(근로 소득 증빙 필요).
- **자산 제한 없음:** 예금, 주식 등 자산 규모에 상관없이 가입 가능.
- **소득 제한 없음:** 고소득자도 가입 가능 (단, 소득에 따라 보험료 발생).
**소득 산정 방식: 근로 소득과 비근로 소득은 각각 다른 방식으로 산정됩니다. 본인 상황에 따라 실제 보험료 구간이 달라질 수 있으므로, 정확한 자격 및 보험료 확인은 NJ DDS(1-888-285-3036) 또는 카운티 사무소를 통해 개별 심사를 받으시기 바랍니다*
- **배우자 소득 제외:** 오직 본인의 소득만으로 자격 및 보험료를 결정함.

메디케이드 바이-인 보험료(Premium) (2026)

Tier 레벨	소득 구간 (FPL 대비)	월 보험료	비고
면제	250% 이하	없음 (\$0)	비근로 소득(SSDI, 이자, 투자 수익 등)이 없는 경우, 연간 근로 소득 \$80,820까지 보험료 면제 가능
Tier 1	251% – 350%	\$203	
Tier 2	351% – 450%	\$406	
Tier 3	451% – 550%	\$609	
Tier 4	551% – 650%	\$812	
Tier 5	651% – 750%	\$1,015	
Tier 6	750% 초과	\$1,218	최대 보험료 상한선

*주의: 위 연봉 수치는 비근로 소득(earned income)이 전혀 없는 경우를 가정하며, 근로 소득 공제(약 50%)를 적용한 예시입니다. 본인의 근로 이력에 기반한 SSDI 수당은 소득 산정에서 제외되나, 배우자·부모의 장애급여 등 타인 기반 수당은 비근로 소득으로 산정될 수 있습니다. 이자·투자 수익·알리모니 등 비근로 소득이 있는 경우 실제 면제 기준이 달라지므로 개별 자격 확인을 권장합니다.

주요 혜택

- 병원비, 처방약 등 메디케이드 전체 혜택 포함.
- 커뮤니티 기반 장기 요양(MLTSS): 민간 보험에서 지원하지 않는 개인 간병(PCA) 서비스를 지원합니다. 서비스 시간은 개인별 필요도 평가(care assessment)를 통해 결정됩니다.
- 직업 유지 지원: 연봉이 오르거나 고소득자가 되어도 일정 보험료만 납부하면 메디케이드의 모든 보장 유지 가능.
- 실직 후 보장 유지: 본인의 귀책 사유 없이 직장을 잃은 경우(예: 해고, 폐업 등), 실직 후에도 최대 12개월간 메디케이드 보장이 유지됩니다.

신청

- [NJHelps.gov](https://www.njhelps.gov) (자격 확인 스크리닝 포털): SNAP, TANF, NJ FamilyCare 등 각종 혜택의 자격 여부를 약 5~10분 내 사전 확인 가능. 실제 신청은 [MyNJHelps.gov](https://www.myNJHelps.gov)를 통해 진행.
- [NJ FamilyCare.gov: ABD](https://www.njfamilycare.gov) (NJ WorkAbility 전용 신청 경로. 온라인 신청 또는 가까운 카운티 사무소 방문 신청 가능)
- [GetCoveredNJ.gov](https://www.getcoverednj.gov) (메디케이드 자격이 되지 않는 경우, ACA(Affordable Care Act) 마켓플레이스를 통해 보험료 세액공제(Premium Tax Credit)를 받아 민간 보험에 가입할 수 있습니다.)
- [Stay Covered NJ.gov](https://www.staycoverednj.gov) (자격 갱신 안내- 기존 가입자들이 자격을 잃지 않도록 가이드)

문의

- **NJ 211:** 211 | nj211.org
- **NJ DDS:** 1-888-285-3036 | NJ.DDS.gov
- **NJ FamilyCare:** 1-800-701-0710 (한국어 통역 가능) | NJ.FamilyCare.gov
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org).

메디케이드 회수 (Medicaid Estate Recovery)

메디케이드 회수 프로그램은 55세 이상의 수혜자가 사망한 경우, 그동안 지출된 메디케이드 비용을 사망자의 유산(Estate)으로부터 회수합니다.

회수 대상 및 범위

검인 자산(Probate Asset) 외에도 더 넓은 범위의 자산을 회수 대상으로 삼는 **확장된 유산(Expanded Estate)** 을 포함합니다. 이는 유언장 없이 자녀에게 바로 승계되는 **공동 계좌, 생명 보험, 은퇴 연금** 등도 메디케이드 비용 회수 대상에 포함될 수 있습니다.

- **포함 자산:**
 - **부동산:** 사망자 명의의 집(Primary Residence 포함) 및 토지.
 - **금융 자산:** 은행 계좌, 주식, 채권, 현금.
- **비검인 자산:** 생명보험금(유산으로 지급될 경우), 연금, 신탁 자산, 공동 소유 재산.

**생명보험 관련 중요 안내: 지정 수익자에게 직접 지급되는 생명보험 수익금은 회수 대상이 아닙니다. 단, 아래의 경우에는 회수 대상이 됩니다.*

- 유산(estate) 자체를 수익자로 지정한 경우
- 지정 수익자가 본인보다 먼저 사망하여 보험금이 유산으로 귀속된 경우

- **회수 금액:** 메디케이드가 55세 이후 지불한 **모든 의료 비용**(HMO 월 보험료 포함).
**예외: 2010년 1월 1일부터, Medicare Savings Programs(QMB 등)을 통해 메디케이드가 대신 납부한 Medicare 본인부담금은 회수 대상에서 제외됩니다.*
- **최소 기준:** 회수 청구 금액이 \$500 미만이거나 유산 총액이 \$3,000 미만인 경우, 또는 회수 경비가 회수 금액을 초과하는 경우 회수가 포기될 수 있습니다.

회수 연기 및 면제 조건

- **생존 배우자 (Surviving Spouse):** 배우자가 살아있는 동안에는 회수 절차가 무기한 연기됩니다.
- **미성년 자녀 (Minor Child):** 만 21세 미만의 자녀가 있는 경우 회수가 연기됩니다.
- **장애 자녀 (Disabled Child):** 연령에 관계없이, SSA 기준에 따라 시각 장애(Blind)이거나 영구적·전적 장애(Permanently and Totally Disabled)로 판정된 자녀가 있는 경우 회수가 연기됩니다.
 - **간병 자녀 예외 (Caregiver Child Exception):** 자녀가 부모의 집에서 요양원 입소 직전까지 최소 2년 이상 연속으로 거주하며, 부모가 요양원에 입소하지 않고 가정에서 생활할 수 있도록 충분한 수준의 간병을 제공했음을 증명하는 경

우 해당 주택에 대한 회수가 면제될 수 있습니다.

**참고: 자녀가 직장을 다니거나 별도 소득이 있어도 되며, 홈헬스 에이드(home health aide)와 함께 간병을 제공해도 인정됩니다. 자녀가 유일한 간병인일 필요는 없으며, 간병의 질과 범위가 판단 기준입니다. (의사 소견서 등 엄격한 증빙 필요)*

**거주 형제자매 예외 (Sibling Exception): 수혜자의 형제자매가 해당 주택의 지분을 일부 소유하고 있으며, 수혜자가 낯선 환경에 입소하기 직전 최소 1년 이상 해당 주택에 거주한 경우 해당 주택에 대한 면제 혜택을 받을 수 있습니다.*

- **경제적 어려움에 의한 면제 (Undue Hardship Waiver):** 회수 대상 자산이 생존 가족의 유일한 소득 창출 원천이며, 회수가 진행될 경우 해당 가족이 공공 보조(Medicaid 포함)에 의존하게 될 가능성이 있는 경우 면제를 신청할 수 있습니다. 단, 메디케이드 회피를 목적으로 사전에 자산을 이전한 경우에는 경제적 어려움이 존재하지 않는다는 반박 가능한 추정(rebuttable presumption)이 적용되어 면제가 인정되지 않을 수 있습니다.

**중요: 뉴저지주 DMAHS로부터 회수 청구 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 서면으로 면제 신청을 제출해야 합니다. 이 기한을 놓치면 면제 요청이 기각될 수 있습니다.*

참고 사항

- **사전 통지 의무 (Prior Notification):** 상속 재산을 상속인이나 다른 채권자들에게 분배하기 전에, 상속 집행인(대표자)은 반드시 뉴저지 DMAHS 재산 회수 부서에 서면으로 통지하여 회수 대상 금액(Claim)이 있는지 확인해야 합니다. DMAHS는 서면 통지를 받은 날로부터 90일 이내에 초기 청구 절차를 시작하며, 최종 청구 또는 유치권 설정은 서면 통지 수령일로부터 3년 이내에 이루어집니다.
- **장례 비용 처리 (Funeral Expenses):** 장례 비용 및 우선 지급 항목 (Priority Payments): 메디케이드 회수가 진행되기 전에, 아래 항목들을 상속 재산에서 우선적으로 지불할 수 있습니다.
 - 합리적인 수준의 장례비 및 매장 비용
 - 유산 행정 관련 합리적인 비용 및 수수료
 - 공공후견인 사무소(Office of the Public Guardian for Elderly Adults)에 대한 채무와 항목들이 처리된 이후, 연방·주 법률상 우선권을 가진 세금 및 기타 채무와 함께 동순위로 DMAHS가 회수 청구를 합니다.
- **가족 구성원 거주 시 유치권 집행 연기:** 수혜자 사망 전부터 가족 구성원이 해당 주택에 지속적으로 거주하고 있었으며, 그 주택이 수혜자의 주요 거주지(primary residence)였고 현재도 해당 가족 구성원의 주요 거주지인 경우, DMAHS는 주택에 유치권(lien)을 기록할 수 있으나 해당 가족 구성원이 이사하거나 사망할 때까지, 또는 주택이 자발적으로 매각될 때까지 유치권을 집행하지 않습니다.

문의

- **전화 상담 (NJ DMAHS): 1-609-588-2900 / 1-609-588-3016** – 신탁(Trusts), 유치권(Liens), 유산 회수(Estates) 등 모든 회수 관련 문의 담당.
- **일반 문의 및 안내 (NJ FamilyCare): 1-800-701-0710** – 한국어 통역 제공 – “Korean Interpreter” 요청.
- **서신 및 서류 제출 주소 (Estate Unit):**
NJ DMAHS – Office of Legal and Regulatory Affairs

Attn: Estates

P.O. Box 712, Mail Code #6 Trenton, NJ 08625-0712

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고자료

- [Medicaid.gov – Estate Recovery](#)
- [NJ Medicaid Program and Estate Recovery – What You Should Know](#)

배우자 생계 보호 규정 (Spousal Impoverishment Rules)

배우자 생계 보호 규정(Spousal Impoverishment Rules)은 배우자 중 한 명이 뇌성마비나 홈케어(MLTSS)를 받을 때, 커뮤니티에 남은 배우자(communitary spouse)가 경제적 궁핍에 빠지지 않도록 자산과 소득을 보호하는 제도입니다. 이 규정은 롱텀 케어 메디케이드 신청 시 별도의 추가 신청 없이 자동으로 적용됩니다.

*OBBA 법안 시행에 따라 자격 요건이 달라질 수 있습니다.

CSRA (Community Spouse Resource Allowance: 배우자 자산 보호)

커뮤니티에 남은 배우자가 신청자의 메디케이드 자격에 영향을 주지 않고 보유할 수 있는 자산 한도입니다.

- **자산 합산:** 부부의 모든 자산(현금, 예금, 주식 등)을 합산한 후 계산합니다.
- **보유 한도:** 커뮤니티에 남은 배우자가 최대 **\$162,660**까지 자산을 유지할 수 있습니다.

***자산 소진(Spend Down):** 합산 자산이 한도를 초과할 경우, 초과분은 의료비 지불이나 장례 플랜 가입 등으로 소진해야 신청자의 메디케이드 승인이 가능합니다.

MMMNA (Minimum Monthly Maintenance Needs Allowance: 배우자 소득 보호)

신청자 배우자의 소득이 낮을 경우, 신청자의 소득 일부를 배우자에게 이전하여 최소 생계를 보장하는 제도입니다.

*아래 소득 요건은 뉴저지 기준이며 주별로 다를 수 있습니다

- **최소 보장액:** 배우자의 월 소득이 **\$2,643.75** 미만이면 신청자의 소득에서 차액만큼 가져올 수 있습니다.
*단, MMMNA는 매년 7월 1일에 갱신됩니다. 현재 기준(\$2,643.75)은 2025년 7월 1일~2026년 6월 30일까지 적용되며, 매년 7월 1일을 기해 갱신되는 연방빈곤선(FPL) 기준으로 최소 보장액이 변경될 수 있습니다.
- **최대 보장액:** 주거비(임대료, 모기지, 세금 등)가 높을 경우 최대 **\$4,066.50**까지 소득 이전이 허용됩니다.
- **장점:** 신청자의 소득이 줄어들어 롱텀케어 메디케이드 소득 요건(월 \$2,982)을 맞추는 데 도움이 될 수 있습니다.

비용 환수 (Estate Recovery) 프로그램

집은 자산 계산 시 제외되지만, 사후 환수 절차가 존재하므로 유의가 필요합니다.

- **거주 시 면제:** 주택은 신청자 또는 배우자가 거주하거나, 미성년 자녀·장애 자녀가 거주하거나, 신청자가 '귀가 의사(intent to return)'를 표명하고 주택 자산 가치 \$1,130,000 이하인 경우에만 면제됩니다.
- **비용 환수(Estate Recovery):** 메디케이드 수혜자가 사망한 후, 주 정부는 그동안 지불한 간병 비용을 고인의 유산(주로 집)을 통해 회수합니다. 연방 메디케이드법에 따라 주 정부는 **55세 이후 수령한 메디케이드 급여**에 대해 사후 환수를 청구할

수 있습니다.

- **환수 유예 조건:**

- **생존 배우자**가 집에 거주하고 있는 경우.
- 21세 미만의 자녀 또는 나이와 상관없이 시각장애/영구장애 자녀가 있는 경우.
- **간병 자녀(Caretaker Child):** 자녀가 부모와 함께 2년 이상 거주하며 널싱홈 입소를 늦추는 수준의 간병을 제공했음을 증명할 경우 주택 소유권 이전을 통해 보호받을 수 있습니다.

**공과시효(Statute of Limitations): 환수를 청구할 수 있는 기간(예: 1년)이 지나면 영구적으로 환수가 불가능해집니다. 뉴저지주의 경우, 사망 통보를 받은 후로부터 주 정부가 3년 이내에 환수 청구를 제기해야 합니다.*

**100만 달러 주택 자산 한도: 2028년 1월 1일부터 시행되며, 인플레이션과 상관 없이 롱텀케어 메디케이드 수급 자격을 위해 연방 차원에서 주택 자산 한도가 주와 상관없이 100만 달러로 통일될 예정입니다. (OBBBA 규정)*

배우자 자산 및 소득 보호 기준 (2026 뉴저지 기준)

구분	항목	기준 금액	비고
자산 보호	CSRA (최대 자산 보유액)	\$162,660	주택 제외, 커뮤니티에 남은 배우자 몫
소득 보호	MMMNA (최소 월 소득 보장)	\$2,643.75 – \$4,066.50	주거비용에 따라 조정 가능
신청자 제한	Individual Asset Limit	\$2,000	요양 서비스 신청자 본인 한도
주택 면제	Home Equity Limit	\$1,130,000 (뉴저지 기준)	주택의 순 가치(Equity) 기준

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [Medicaid.gov – 2026 배우자 생계 보호 연방 표준 가이드](#)
- [Medicaid.gov – 2026 Spousal Impoverishment Standards](#)
- [NJ DHS.gov – 메디케이드 자산 및 소득 기준\(26-01\)](#)

Medicaid General Assistance (WFNJ/GA)

Medicaid General Assistance 프로그램은 자녀가 없는 저소득층 성인 및 부부를 위해 현금 지원, 취업 훈련, 그리고 긴급 주거 지원을 통합적으로 제공하는 뉴저지주의 핵심 복지 제도입니다. 뉴저지주에서는 **WFNJ/GA(Work First New Jersey/General Assistance)** 로 알려져 있습니다.

*OBBA 법안 시행에 따라 자격 요건이 달라질 수 있습니다.

자격 요건

- **대상:** 뉴저지 거주 18세 이상 성인 (독신 또는 부양자녀 없는 부부)
- **신분:** 시민권자 또는 합법적 이민자 (영주권 5년 경과 / 난민·망명자는 즉시 가능)
- **소득:** 'Schedule I/III(초기 허용 소득)' 금액으로 판정하며, 이는 실제 FPL의 약 **20~22%** 수준으로 매우 낮습니다.
- **자산:** 현금성 자산 **\$2,000 이하** (거주 주택 1채, 차량 1대, 은퇴 자산 – 401k, IRA 플랜 등은 자격 심사에서 제외됨)
- **근로 가능:** 주 **30시간**의 취업 활동, 구직, 직업 훈련, 또는 지정 근로 활동 참여 의무 (N.J.A.C. 10:90-4.1)
- **근로 불능:** 의료기관 통해 질병이나 장애 판정(Med-1 소견서) 받아 제출시 더 높은 금액을 수령하게 되고, 근로 요건 전체가 면제됩니다.

가구 수별 혜택 금액

구분	대상	실제 급여액 (월 기준)
취업 가능자 (Employable)	개인	\$185
	부부	\$254
취업 불가능자 (Unemployable)	장애 개인	\$277
	장애 부부	\$382

혜택

WFNJ/GA는 단순 현금 지급을 넘어 자립을 위한 다각적인 서비스를 제공합니다.

- **현금 보조 :** 평생 60개월 한도 내에서 현금 지원. (취업 시 기간 카운트 중단)
- **메디케이드 지원:** WFNJ/GA 가입 시 [메디케이드\(NJ FamilyCare\)](#)가 자동으로 가입됩니다.
- **긴급 주거 지원 :** 노숙 위기에 처한 경우 임대료 미납금 지원, 쉼터 제공, 또는 유틸리티 체납금 지원. EA(Emergency Assistance) 수혜 기간 연장이 가능합니다.

*NJ DHS 긴급 지원(EA) 프로그램 규정에 따라 평생 최대 12개월(TANF·GA 통합), 연장은 TANF는 6개월씩 2회, GA는 6개월씩 1회 가능

- 취업 및 교육 지원:
 - 고등학교 검정고시(GED) 취득 지원, 직업 기술 교육(Vocational Training).
 - 출퇴근을 위한 교통비 및 취업 준비 비용 지원.
- 헬스케어 연계: WFNJ/GA 가입 시 [ACA 메디케이드\(NJ FamilyCare\)](#)에 자동으로 가입됩니다.

신청

- 온라인: [MyNJHelps.gov](#)
- 방문: 카운티 사회복지국 (local county social service offices)
 - **Bergen County Board of Social Services**
 - 주소: 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - 전화번호: 201-368-4200
 - 업무 시간: 평일(월~금) 오전 8:00 ~ 오후 4:30

문의

- **NJ Division of Family Development** 핫라인: 1-800-792-9773
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ DHS.gov – Work First New Jersey](#)
- [NJ FamilyCare – 2026 소득 한도 및 가입 자격](#)
- [NJHelps.gov – 원스톱 자격 확인 및 신청 포털](#)
- [NJ S2201 – WFNJ 프로그램 현대화 및 자산 규정 개정 법안\(2026\)](#)
- [Bergen County Board of Social Services](#)

Temporary Assistance for Needy Families (TANF)

Temporary Assistance for Needy Families (TANF)는 18세 미만 자녀(또는 임신부)가 있는 저소득 가구의 자립을 돕기 위해 현금 지원, 보육 지원, 취업 훈련 등을 제공하는 핵심 복지 프로그램입니다. 뉴저지에서는 WFNJ/TANF(Work First New Jersey/Temporary Assistance for Needy Families)로 알려져 있습니다.

*OBBBA 법안 시행에 따라 자격 요건이 달라질 수 있습니다.

자격 요건

- **대상:** 뉴저지 거주 18세 미만 자녀(또는 고교 재학 중인 19세 미만 자녀)를 둔 저소득 가구.
- **소득:** 3인 가구 기준 월 \$5,379 이하 (연방 빈곤선 FPL의 250% 이내).
- **신분:** 시민권자 또는 합법적 이민자 (영주권 5년 경과 / 난민·망명자는 즉시 가능)
- **자산:** 현금성 자산 \$2,000 이하 (거주 주택 1채, 차량 1대, 은퇴 자산 – 401k, IRA 플랜 등은 자격 심사에서 제외됨)
- **근로 가능:** 부모는 주당 35시간 이상 구직 활동, 취업 훈련 또는 지정 근로 활동에 참여해야 함 (WFNJ 기본 규정)
- **근로 불능:** 의료기관을 통해 질병 또는 장애 판정(Med-1 소견서)을 제출하면 근로 참여 의무가 면제됨.
- **양육비 협조 (해당자에 한함):** 자녀를 위한 현금 지원을 받으려면 상대 부모에 대한 정보 제공 및 양육비 권리 양도에 협조해야 합니다. 매월 징수된 양육비 중 자녀 1명인 경우 최대 \$100, 2명 이상인 경우 최대 \$200까지 수급자에게 추가로 지급됩니다. 정당한 사유 없이 협조를 거부할 경우 수급이 거절될 수 있습니다.

혜택

WFNJ/TANF는 단순 현금 지급을 넘어 자립을 위한 다각적인 서비스를 제공합니다.

- **지원금:**
 - **월 지원금:** 3인 가구 기준 월 \$559 – 소득이 전혀 없는 경우 기준임, 소득 있을 경우 지급액 조정
 - 가구 수와 소득에 따라 조정될 수 있음.
 - **평생 60개월 한도 내에서 현금 지원.** 취업으로 현금 지원이 중단되면 남은 기간이 보존되어, 향후 다시 도움이 필요할 때 사용 가능. 48개월 도달 시 SAIF(Supportive Assistance to Individuals and Families) 프로그램 자동 배정. 60개월 소진 후에도 최대 2회(6개월씩) 연장 가능하며, 별도 조건 충족 시 SAIF를 통해 최대 24개월 추가 현금 지원 신청 가능.
 - **Post-TANF (월 \$200):** TANF를 최소 6개월 이상 받은 후 취업으로 현금 지원이 중단된 경우, 자립을 돕기 위해 최대 24개월간 월 \$200의 사후 보조금을 제공합니다. 평생 60개월 한도에 포함되지 않으며, 뉴저지만의 강력한 자립 인센티브입니다. *주당 최소 20시간 이상 근무를 최소 4개월간 지속한 후 케이스를 자발적으로 종료시 자격 부여
 - **Diversions Payment (\$750 일시금):**

- 구직 활동 중 일시적인 위기를 넘기기 위한 가족에게 **\$750**을 1회 제공함. *신청 시 상담 필요. Diversionary Payment는 현금 지원 대신 지급되는 일시금으로, 수령 시 일정 기간 **TANF 현금 지원 신청이 제한될 수 있음**.
- **메디케이드 지원:** WFNJ/TANF 가입 시 [메디케이드\(NJ FamilyCare\)](#)가 자동으로 가입됩니다.
- **긴급 주거 지원 (Emergency Assistance, EA):** 노숙 위기에 처한 경우 임대료 미납금 지원, 긴급 쉼터 제공, 유틸리티 체납금 지원, 이사비·보증금 등을 받을 수 있습니다. TANF, GA, SSI 수급자 및 일부 비수급 저소득 가구도 신청 가능합니다.
 - 수혜 기간: 케이스 기간 중 최대 12개월이며, TANF는 최대 2회(각 6개월), GA는 최대 1회(6개월) 연장이 가능합니다.
 - EA 수혜 중 가구 소득(현금 지원 포함)의 30%를 주거 비용으로 본인이 부담해야 합니다.
- **취업 및 교육 지원:**
 - 고등학교 검정고시(GED) 취득 지원, 직업 기술 교육(Vocational Training).
 - 출퇴근을 위한 교통비 및 취업 준비 비용 지원.

신청

- 온라인: [MyNJHelps.gov](#)
- 방문: Local county social service offices
 - **Bergen County Board of Social Services**
 - 주소: 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - 전화번호: 201-368-4200
 - 업무 시간: 평일(월~금) 오전 8:00 ~ 오후 4:30

문의

- **NJ Division of Family Development** 핫라인: 1-800-792-9773
- **AWCA:** 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ DHS.gov – Work First New Jersey](#)
- [NJHelps.gov – 통합 자격 확인 포털](#)
- [NCCP.org – 뉴저지 TANF 주별 프로필 \(2026\)](#)

PART II • 제 6 편

만성 질환 (Chronic Diseases)

Chronic Diseases

노년기 만성 질환 예방 및 관리: 노화 과정, 심장 질환, 당뇨병, 비만, 뇌졸중, 암, 관절염, 정신 건강, 치매, 심신 의학(Mind-Body Medicine).

본 부문 총 11개 상세 안내 문서 수록

만성 질환 (Chronic Diseases)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조연이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

만성 질환은 1년 이상 지속되며, 지속적인 의학적 관리를 필요로 하거나 적절히 관리되지 않을 경우 일상 활동을 제한하는 건강 상태를 말합니다. 대부분의 만성 질환은 비감염성 질환(noncommunicable diseases)으로, 타인에게 직접 전염되지 않습니다. 대부분의 만성 질환은 완치가 어렵지만, 전문적인 의학적 치료와 적극적인 생활 습관 개선을 병행함으로써 효과적으로 관리할 수 있습니다.

만성 질환은 국내외적으로 주요한 보건 과제입니다. 만성 질환은 미국 내 사망 및 장애의 주요 원인이며, 이러한 질환은 신체적 건강에 미치는 영향 외에도 연간 \$4.9조에 달하는 국가 의료비 지출의 90%가 만성 질환 및 정신 건강 질환을 가진 사람들을 위해 사용되며, 개인의 전반적인 삶의 질에 깊은 영향을 미칩니다. 만성 질환에 대해 이해하는 것은 효과적인 관리와 독립적인 삶을 유지하기 위한 첫 걸음입니다.

만성 질환의 종류

생활습관병 (Lifestyle Diseases)

- [비만 \(Obesity\)](#)
- [당뇨병 \(Diabetes\)](#)
- [심장 질환 \(Heart Disease\)](#)
- [뇌졸중 \(Stroke\)](#)
- [암 \(Cancer\)](#)
- [관절염 \(Arthritis\)](#)

정신 및 뇌 건강 (Brain & Mental Health)

- [정신 건강 \(Mental Health\)](#)
- [치매 \(Dementia\)](#)
- [심신 의학 \(Mind-Body Medicine\)](#)

누가 만성 질환에 걸릴 수 있나요?

만성 질환은 모든 연령, 인종, 배경의 사람들에게 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 연령이 높아질수록 위험도는 증가합니다. 미국 성인 4명 중 3명 이상(약 76%)이 최소 하나의 만성 질환을 앓고 있으며, 절반 이상(약 51%)이 두 개 이상의 질환을 보유하고

있습니다. 특히 65세 이상 시니어의 90% 이상이 최소 한 가지 이상의 만성 질환을 앓고 있습니다. 특정 집단은 유전적 요인, 사회경제적 요인 또는 의료 서비스 접근성으로 인해 더 높은 위험에 처할 수 있습니다.

만성 질환의 원인

만성 질환은 흔히 유전, 환경, 생활 방식의 선택 및 행동 양식의 복합적인 요인으로 인해 발생합니다. 주요 위험 요인은 다음과 같습니다:

- 흡연 및 담배 사용
- 부적절한 식습관 / 영양 불량
- 신체 활동 부족
- 과도한 음주
- 유전 및 가족력
- 환경적 유해 요소 노출

만성 질환의 징후 및 증상

증상은 특정 질환에 따라 매우 다양합니다. 일반적인 징후로는 지속적인 통증, 피로, 특정 신체 부위의 기능 상실 또는 기분 변화 등이 있습니다. 만성 질환은 장기간 지속되기 때문에 증상의 강도는 시간이 지남에 따라 변할 수 있습니다.

만성 질환의 단계

대부분의 만성 질환은 다음의 단계를 거쳐 진행됩니다:

1. 위험 요인이 존재하는 단계. 아직 병에 걸린 것은 아니지만, 몸이 병에 걸리기 쉬운 상태(예: 가족력, 술, 담배)
2. 질병은 존재하나 겉으로 드러나는 증상이 없는 단계.
3. 증상이 나타나고 진단이 내려지는 단계.
4. 질병이 만성화되어 평생 관리하며 함께 살아가야 하는 단계.

만성 질환의 진단

만성 질환 진단은 일반적으로 의학적 이력 검토, 신체 검사, 그리고 의심되는 질환에 따라 혈액 검사, 영상 검사(X-ray, MRI) 또는 조직검사(Biopsy)와 같은 특정 정밀 검사를 통해 이루어집니다.

만성 질환의 치료

많은 만성 질환이 완치될 수는 없지만, 다음과 같은 방법으로 관리됩니다:

- **약물 치료:** 증상을 조절하거나 합병증을 예방합니다.
- **생활 습관 개선:** 식단 조절, 운동 및 스트레스 관리.

- **재활 치료:** 물리 치료, 작업 치료 또는 언어 치료.
- **수술:** 심장 질환이나 특정 암과 같은 경우에 시행됨.

만성 질환의 예방

대부분의 만성 질환은 예방이 가능합니다. 주요 예방법으로는 건강한 체중 유지, 균형 잡힌 식단, 규칙적인 신체 활동, 금연, 그리고 조기 발견을 위한 정기적인 건강 검진 등이 있습니다.

만성 질환과 함께 살아가기

만성 질환과 함께 산다는 것은 적극적인 관리가 필요함을 의미합니다. 환자들은 의료진과 협력하여 건강 상태를 모니터링하고, 치료 계획을 준수하며, 높은 삶의 질을 유지하기 위해 일상을 조정해 나갑니다.

참고 자료

- [MedlinePlus.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/): 국립의학도서관 – 만성 통증 의학 정보
- [MedlinePlus.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/): 만성 질환 종합 정보
- [CDC.gov](https://www.cdc.gov/): 질병통제예방센터 – 만성 질환 개요
- [WHO.gov](https://www.who.int/): 세계보건기구 – 비감염성 질환

노화 과정 (Aging Process)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조연이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

노화는 모든 신체 시스템에 영향을 미치는 자연스러운 과정입니다. 흰머리나 주름과 같은 외적인 변화 외에도, 내부적으로는 심혈관, 근골격계, 소화기 및 인지 건강에 변화가 일어납니다. 이러한 변화를 이해하는 것은 노년기 내내 높은 삶의 질을 유지하는 데 필수적입니다.

노화 자체는 만성 질환이 아니지만 이 둘은 서로 밀접하게 연관되어 있습니다. 자연적인 생리적 변화는 새로운 건강 문제가 발생할 위험을 높이거나 기존 질환의 진행을 가속화하기도 합니다. 이러한 연결 고리를 인식하는 것은 노화 과정에서 효과적인 건강 계획을 세우고 독립적인 생활을 유지하는 데 매우 중요합니다.

노화의 원인

노화는 세포 노화, 산화 스트레스, 염증 반응 증가, 면역 기능 저하, 그리고 텔로미어 단축으로 인해 분자와 세포 수준에서 손상이 점진적으로 축적되며 발생합니다.

노화에 따른 신체적 및 인지적 변화

- **심혈관계:** 동맥이 경직되어(탄성이 감소하여) 혈압이 상승하고, 심장이 혈액을 내보내기 위해 더 많은 힘을 써야 합니다.
- **근골격계:** 골밀도 감소 및 근육량 감소가 발생하여 근력과 균형 감각이 떨어질 수 있습니다.
- **인지 능력:** 정보 처리 속도가 느려지거나 일시적으로 단어가 생각나지 않는 건망증이 생길 수 있습니다. 그러나 심각한 기억력 상실은 정상적인 노화의 일부가 아닙니다([치매 참조](#)).
- **소화기 및 방광:** 소화기 운동이 느려져 변비가 생기기 쉽고, 방광 탄력 저하나 골반저근 약화로 인해 요실금이 발생할 수 있습니다.
- **감각 기능:** 눈의 수정체가 굳어져 노안이 발생하고 노화 및 다양한 요인(소음 노출, 유전적 요인 등)으로 인해 청력이 저하되는 노인성 난청이 생길 수 있습니다.

노화의 단계

- **성인 초기(20대~30대):** 신체 기능과 생식 건강이 정점에 달하는 시기입니다.
- **중년기(40대~64세):** 신진대사와 피부 탄력이 감소하며, 관절이 마모되기 시작하는 시기입니다.
- **노년기(65세 이상):** 신체적, 인지적 능력 감소가 더욱 뚜렷해지며 독립적 생활 유지를 위해 적극적인 건강 관리가 필요한 시기입니다.

노화 과정의 진단

노화는 진단해야 할 질병이 아니라, 다음을 통해 지속적으로 관리해야 합니다:

- **노인 종합 평가(Geriatric Assessments):** 신체적, 정신적, 사회적 건강에 대한 포괄적인 검토입니다.
- **골밀도 검사(DEXA):** 골다공증 여부를 모니터링합니다.
- **감각기 선별 검사:** 사회적 고립을 방지하기 위해 정기적인 시력 및 청력 검사를 시행합니다.
- **인지 선별 검사:** 정상적인 노화와 치매를 구분하기 위한 검사를 미리 진행합니다.

지혜로운 노화를 위한 관리 방법

노화를 막을 수는 없지만, 다음과 같은 방법으로 부정적인 영향을 늦출 수 있습니다:

- **예방 의료:** 예방 접종(독감, 대상포진*, 폐렴, RSV, 코로나19 등)을 반드시 합니다.
 - 접종 간격을 지키는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어, 대상포진의 경우 50세 이상 성인에게는 백신(Shingrix)을 2~6개월 간격으로 2회 접종할 것이 권고됩니다.
- **신체 활동:** 근손실을 막고 뼈를 보호하기 위해 매일 근육을 움직이고 운동을 병행합니다.
 - 요실금 등 비뇨기 문제 예방을 위한 케겔 운동을 합니다.
- **영양 공급:** 섬유질, 칼슘, 비타민 D, 저지방 단백질이 풍부한 균형 잡힌 식단을 섭취합니다.
 - 충분한 수분 섭취와 나트륨 제한도 건강한 노화 식단의 중요한 요소입니다.
- **정신 건강:** 스트레스 관리 및 충분한 수면을 갖습니다.
- **사회적 참여:** 취미 활동이나 지역사회 행사에 참여하여 뇌를 활성화합니다.
- **금연 및 절주:** 금연을 실천하고 가급적 술을 절제합니다.
- **낙상 예방:** 균형 운동, 가정 내 미끄럼 방지 조치(욕실 손잡이·미끄럼 방지 매트), 정기 시력·청력 검사, 복용 중인 약물 점검 등으로 낙상을 예방합니다.

노년의 삶 수용하기

지혜롭게 나이가 든다는 것은 변화에 현명하게 적응하고, 선제적으로 대응하며, 신체적·정서적·사회적 삶의 질을 유지하는 데 집중하는 것을 의미합니다. 신체 변화에 대해 의료진 및 파트너와 솔직하게 소통하는 것이 전반적인 삶의 안녕을 지키는 데 도움이 됩니다.

참고 자료

- [MedlinePlus.gov](https://medlineplus.gov): 국립의학도서관 – 노인 건강 정보
- [NIA.nih.gov](https://nia.nih.gov): 국립노화연구소 – 건강한 노화 가이드
- [CDC.gov](https://cdc.gov): 질병통제예방센터 – 노화 개요

관절염 (Arthritis)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

관절염은 관절의 통증과 부종을 유발하는 다양한 유형의 질환을 통칭합니다. 이는 고령층 장애의 주요 원인 중 하나로 삶의 질에 큰 영향을 미칩니다.

관절염의 종류 및 원인

- **퇴행성 관절염 (Osteoarthritis, OA):** 가장 빈번하게 발생하는 유형으로 뼈 끝을 보호하면서 쿠션 역할을 하는 연골이 시간이 지나면서 마모되어 발생합니다.
- **류마티스 관절염 (Rheumatoid Arthritis, RA):** 자가면역 및 염증성 질환으로, 면역 체계가 자신의 건강한 세포를 실수로 공격하여 해당 관절에 통증과 부종을 유발합니다.
- **건선성 관절염 (Psoriatic Arthritis):** 건선 환자 중 일부에게 발생하는 관절염입니다.
- **통풍 (Gout):** 혈중 요산(uric acid) 수치가 높아지면 요산 결정이 관절에 쌓여 발생합니다. 신장의 요산 배출 기능 저하나 육류·알코올을 과다 섭취가 요인이 될 수 있습니다. 주로 엄지발가락에 갑작스럽고 심한 통증과 부종을 특징으로 합니다.
- **강직성 척추염 (Ankylosing Spondylitis):** 염증성 질환으로, 시간이 지나면서 척추의 작은 뼈들이 서로 붙어버리는 현상을 초래할 수 있습니다.

누가 관절염에 걸릴 수 있나요?

65세 이상에서 관절염 유병률이 크게 증가하며, 75세 이상 성인의 약 54%가 관절염 진단을 받습니다. 주요 위험 요인은 다음과 같습니다:

- **비만:** 과도한 체중은 관절, 특히 무릎과 엉덩이(고관절)에 추가적인 압박을 줍니다.
- **과거 부상:** 과거에 부상을 입었던 관절은 나중에 관절염이 발생할 가능성이 더 높습니다.
- **유전:** 특정 유전자는 류마티스 관절염이나 강직성 척추염의 위험을 높이는 것과 관련이 있습니다.
- **반복적인 고강도 활동:** 관절을 반복적으로 구부려야 하는 직업이나 스포츠는 퇴행성 관절염의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

관절염 위험은 연령에 따라 증가하지만, 젊은 층에서도 발생 빈도가 높아지고 있습니다. 미국 성인 약 5명 중 1명(약 21%, 5,300만 명)이 관절염을 앓고 있습니다. 관절염 환자의 절반 이상(약 51.7%)이 18~64세의 노동 연령층에 해당하며, 여성은 남성보다 관절염 유병률이 높고 특히 퇴행성 관절염과 류마티스 관절염은 여성에서 더 흔합니다.

관절염의 징후 및 증상

- 지속적인 관절 통증 및 경직 (특히 아침 시간).
- 관절 주위에 눈에 띄는 부종, 붉은 기 또는 열감.

- 움직일 때 관절에서 느껴지는 사각거리는 감각이나 소리.
- 일상적인 업무를 가능하게 하는 관절의 활동 범위의 감소.

관절염의 단계

1. **초기:** 관절 조직에 경미한 염증이나 연골 변화가 시작되며, 아침 관절 뻣뻣함과 간헐적인 통증이 나타납니다. 휴식 후 완화되는 경우가 많고 일상생활에 큰 지장은 없습니다.
2. **중기:** 연골 및 관절 조직 손상이 진행되어 통증과 부종이 더 자주, 오래 지속됩니다. 계단 오르기, 물건 들기 등 일상 활동이 어려워지고, 통증이 수면 장애와 피로를 유발하기도 합니다.
3. **말기:** 연골이 심하게 손상되거나 소실되어 관절 변형과 지속적인 만성 통증이 나타납니다. 관절 가동 범위가 크게 제한되고 일상생활 수행 능력이 현저히 저하되어 보조 기구 사용이나 인공 관절 치환술(joint replacement surgery)이 필요할 수 있습니다.

관절염의 진단

- **신체 검사:** 관절의 부기, 붉은 기, 가동 범위를 확인합니다.
- **영상 검사:** X-ray를 통해 뼈의 변화와 연골 손실을 확인하며, MRI를 통해 연부 조직의 상세한 상태를 확인합니다.
- **혈액 검사:** 염증 수치나 특정 항체(류마티스 인자 등)를 확인하기 위한 혈액 검사를 시행합니다.

관절염의 치료

- **약물 치료:** 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs)나 류마티스 관절염을 위한 항류마티스제(DMARDs) 등이 포함됩니다.
- **물리 치료:** 관절 주변 근육을 강화하고 유연성을 높이는 운동을 병행합니다.
- **체중 관리:** 체중 감량은 체중이 관절에 가하는 압력을 현저히 낮춰줍니다.
- **수술:** 심하게 손상된 고관절이나 무릎을 위한 공관절 수술.

관절염의 예방

- **건강한 체중 유지:** 골관절염을 예방하거나 진행을 늦추는 가장 효과적인 방법입니다.
- **관절 보호:** 무거운 물건을 들 때 올바른 자세를 유지하고 운동 시 보호 장비를 착용합니다.
- **저충격 운동:** 수영, 자전거 타기, 걷기와 같은 활동은 관절에 과도한 무리를 주지 않으면서 유연성을 유지해 줍니다.

관절염과 함께 살아가기

관절염과 함께 살아가는 데는 과도한 활동을 피하는 것이 중요합니다. 근육 이완을 위한 온열 요법과 염증 감소를 위한 냉요법을 적절히 활용하고, 병 따개나 지팡이와 같은 보조 기구를 사용하여 관절의 부담을 줄임으로써 독립적인 생활을 유지할 수 있습니다.

지원 단체 (Support Groups)

- [Arthritis Foundation – Connect Group](#) 관절염 재단

참고 자료

- [NIM Medlineplus – 관절염 의학 정보](#)
- [NIH NIAMS.gov – 관절염 및 근골격·피부질환 연구소](#)

암 (Cancer)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조연이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

암은 비정상적인 세포가 통제 불능으로 증식하는 100가지 이상의 질병을 통칭합니다. 암은 미국 내 주요 사망 원인 2위(전체 사망의 약 20%)이며, 65세 미만에서는 사망 원인 1위지만, 조기 발견과 적절한 지원 서비스를 통해 치료 성과를 크게 향상시킬 수 있습니다.

암의 종류

암은 세포의 종류나 발생 부위에 따라 분류됩니다.

- **암종(Carcinomas):** 가장 흔한 유형으로, 피부나 내부 장기의 벽을 이루는 조직에서 시작됩니다.
- **육종(Sarcomas):** 뼈, 연골, 지방 또는 근육에서 시작됩니다.
- **백혈병(Leukemias):** 골수의 혈액 형성 조직에서 시작됩니다.
- **골수종(Myeloma):** 골수의 형질세포(plasma cells)에서 시작됩니다.
- **림프종(Lymphomas):** 면역 체계 세포에서 시작됩니다.

*이 외에도 혼합형 암 및 기타 유형이 있으며, 암마다 발생 위치와 특성이 다릅니다.

주요 발생 암

- **유방암:** 여성에게 가장 많이 진단되는 암입니다.
- **전립선암:** 남성에게 가장 많이 진단되는 암입니다.
- **폐암:** 남녀 모두에게 암 사망의 가장 주요한 원인입니다.
- **대장암:** 결장이나 직장에 영향을 미칩니다.
- **위암:** 위 내벽에서 시작되는 암입니다. 타 인종에게는 발생 빈도가 낮은 편이지만 아시아인들에게는 발병률이 현저히 높습니다.

누가 암에 걸릴 수 있나요?

미국 내 전체 암 진단의 평균 연령은 67세이며, 연령이 높아질수록 발병 위험이 크게 증가하며, 유전과 인종적 요인도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 아프리카계 미국인은 많은 암 유형에서 타 인종 그룹보다 사망률이 높게 나타납니다. 생활 습관 요인, 특히 흡연은 여전히 예방 가능한 가장 큰 위험 요인입니다.

위암은 아시아계 미국인, 특히 한인들에게서 매우 높은 발병률을 보입니다. 한국계 미국인은 비히스패닉 백인에 비해 위암 발병률이 약 5배 높습니다. 위암은 한인 남성에게는 가장 많이 발생하는 암 1위이며, 한국인 여성에게는 두 번째로 흔한 암으로

나타납니다.

암의 원인

암은 세포 내 DNA의 변이에 의해 발생하며, 이는 유전되거나 후천적으로 발생할 수 있습니다. 주요 원인은 다음과 같습니다:

- **발암 물질:** 담배 연기와 같은 화학 물질 및 방사선(자외선 등) 노출.
- **생활 습관:** 부적절한 식단, 비만, 운동 부족.
- **생물학적 요인:** 만성 염증 또는 바이러스 감염(HPV, B형/C형 간염 등).

암의 징후 및 증상

- 설명되지 않는 체중 감소 또는 지속적인 피로.
- 지속적인 기침이나 호흡 곤란.
- 피부의 변화나 비정상적인 멍울.
- 배변 또는 배뇨 습관의 변화.

암의 진행 단계

대부분의 암은 0기에서 4기로 나뉩니다:

- **0기:** 비정상 세포가 존재하지만 주변으로 퍼지지 않은 상태.
- **1기~3기:** 암이 존재하며, 숫자가 높을수록 종양의 크기가 크거나 더 깊이 퍼졌음을 의미합니다.
- **4기:** 암이 신체의 먼 부위까지 전이(Metastasis)된 상태.

암의 진단

- **신체 검사 및 실험실 검사:** 멍울이나 **혈액·소변·조직** 검사를 통해 **종양 표지자(tumor markers)**, 암세포 또는 암에 반응한 신체 세포가 더 많은 양으로 생성하는 단백질이나 특정 물질을 측정해 확인합니다.
- **영상 검사:** CT, MRI, PET 스캔 또는 X-ray를 통해 신체 내부를 확인합니다.
- **조직 검사 (Biopsy):** 조직 샘플을 채취하여 현미경으로 세포를 관찰합니다.

암의 치료

- **수술:** 종양을 제거합니다.
- **화학요법 (항암치료):** 약물을 사용하여 빠르게 증식하는 암 세포를 죽입니다.
- **방사선 치료:** 고에너지 빔을 사용하여 암 세포를 파괴합니다.
- **면역요법:** 환자 자신의 면역 체계가 암과 싸우도록 돕습니다.
- **표적 치료(Targeted Therapy):** 암세포의 특정 유전자나 단백질을 표적으로 삼아 암의 성장을 차단합니다.

암의 예방

- 금연 및 절주.
- 자외선으로부터 피부 보호(자외선 차단제 및 그늘 이용).
- 적정 체중 유지 및 규칙적인 운동.
- **정기 검진:** 유방 촬영(Mammogram), 위 내시경, 대장 내시경, 자궁경부암 검사(Pap test) 등 정기적인 검진은 치료가 가장 쉬운 초기에 암을 발견할 수 있게 해줍니다.
- **백신 접종:** HPV 백신 접종은 자궁경부암 등 HPV 관련 암을 예방하며, B형 간염 백신 접종은 간암 예방에 도움이 됩니다.

암과 함께 살아가기

암과 싸우는 것은 단순히 의학적 치료 이상의 과정을 포함합니다. 통증, 구역질과 같은 신체적 증상 관리뿐만 아니라 통합 케어, 영양 관리, 환자와 가족을 위한 심리 상담을 통해 정서적 건강을 돌보는 것이 매우 중요합니다.

지원 단체 (Support Groups)

- [NCI.gov: 국립암연구소 – 커뮤니티 지원 그룹 찾기](#)
- [Cancer.org: 암 협회 – 서포트 그룹 찾기](#)
- [CancerCare.org: 뉴저지 지원 단체 찾기](#)
- [Holy Name 서포트 그룹 찾기](#)

참고 자료

- [MedlinePlus.gov: 국립의학도서관 – 암 정보](#)
- [Cancer.gov: 암 협회 – 암 종합 정보](#)
- [CDC.gov: 질병통제예방센터- 암 개요](#)

치매 (Dementia)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

치매는 일상생활을 방해할 정도로 심각한 인지 기능 저하를 특징으로 하는 여러 상태를 통틀어 일컫는 말입니다. 알츠하이머병이 가장 흔한 유형이지만, 루이소체 치매나 혈관성 치매 등도 많은 영향을 미칩니다.

치매인가요, 알츠하이머인가요?

- **치매(Dementia):** 단일 질환이 아닌, 기억력 저하와 혼란 등 여러 증상을 설명하는 포괄적인 용어(Umbrella Term)입니다.
- **알츠하이머병(Alzheimer's Disease):** 치매를 일으키는 구체적인 질병이며, 가장 흔한 원인입니다.
- **기타 치매:** 뇌졸중으로 인한 혈관성 치매(Vascular Dementia), 루이소체 치매(Lewy Body Dementia)등이 있습니다. 이들은 모두 뇌에 영향을 미치지만, 초기 증상은 각기 다를 수 있습니다.

많은 유형의 치매가 유사한 증상을 공유하기 때문에 이를 정확히 구별하는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 확진은 반드시 의료 전문가를 통해서만 내려져야 합니다.

누가 치매에 걸릴 수 있나요?

치매는 주로 노인층에 영향을 미치지만, 정상적인 노화 과정의 일부는 아닙니다. 65세 이후에는 위험이 크게 증가합니다. 가족력, 인종(아프리카계 미국인과 히스패닉계 노인이 백인 노인보다 발병 위험이 높음), 그리고 심혈관 건강 상태 등이 중요한 요인으로 작용합니다.

치매의 원인

치매는 뇌세포의 손상으로 인해 발생합니다. 이 손상은 뇌세포들이 서로 소통하는 능력을 방해하며, 세포 간의 정상적인 통신이 이루어지지 않을 때 사고, 행동, 감정에 문제가 생기게 됩니다. 치매의 유형에 따라 특정 뇌 부위의 세포 손상 방식이 다르게 나타납니다.

치매의 징후 및 증상

- **인지적 변화:** 기억력 감퇴, 의사소통 및 적절한 단어 찾기의 어려움, 복잡한 작업 수행이나 계획 수립, 문제 추론 및 해결의 어려움, 시간이나 장소에 대한 혼동, 시각적 이미지 및 공간 관계 이해의 어려움 등.
- **심리적 변화:** 성격 변화, 우울증, 불안, 부적절한 행동, 피해망상 또는 환각.
- **신체적 변화:** 조정 능력 부족 및 운동 기능 저하.

치매의 단계

1. **임상 전 단계** 겉으로 드러나는 증상은 없으나 뇌 내부의 변화가 시작될 수 있는 단계.
2. **초기 단계(경도 인지 저하)**: 건망증, 물건 분실, 또는 적절한 단어를 찾는 데 어려움을 겪는 단계.
3. **중기 단계(중등도 인지 저하)**: 재정 관리와 같은 복잡한 작업 수행이 어려워지고 혼란이 증가하는 단계.
4. **말기 단계(중증)**: 일상 활동이 거의 불가능하며 점차 말하거나 기본적인 운동 능력을 상실하는 단계.

치매의 진단

의료 전문가들은 인지 및 신경 심리 검사, 신경학적 평가, 뇌 스캔 및 실험실 검사를 병행하여 특정 치매 유형을 진단합니다.

치매의 치료

치매는 원래대로 되돌릴 수 없지만, 다음과 같은 방법으로 증상을 관리할 수 있습니다:

- **약물 치료**: 인지 증상 관리를 돕는 콜린에스테라제 억제제 및 메만틴 등.
- **작업 치료 (Occupational Therapy)**: 집안 환경을 더 안전하게 만들고 일상 생활을 위한 적절한 행동을 교육합니다.
- **환경 수정**: 어수선한 환경과 소음을 줄여 환자가 집중할 수 있도록 돕고 혼란을 줄입니다.

치매의 예방

확실한 예방법은 없으나, 심장 건강에 좋은 생활 습관이 위험을 낮출 수 있습니다:

- 규칙적인 신체 활동과 적정 체중 유지.
- 금연 및 절주.
- 혈압, 콜레스테롤 등 심혈관 질환 관리.
- 평생 학습과 사회적 교류를 통해 뇌의 활성화 유지.

치매와 함께 살아가기

치매와 함께 살아가기 위해서는 강력한 지원 체계가 필요합니다. 질병이 진행됨에 따라 낙상 위험 제거와 같은 집안 내 안전 시설 보완, 규칙적인 일과 수립, 그리고 간병인 지원 서비스가 필수적입니다.

지원 단체 (Support Groups)

- [Alzheimer's Association – Support Groups](#) ([알츠하이머 협회](#)).
- [Alzheimer's Foundation of America – Caregiver Resources](#) ([미국 알츠하이머 재단](#)).
- [Act Now Foundation – Support Solutions](#) ([뉴저지 비영리 치매 지원 단체](#)).
- [dfamerica.org](#): [치매 친화 협회 – 메모리 카페 찾기](#)

참고 자료

- [NIM Medlineplus.gov](http://NIM.Medlineplus.gov) – 치매 의학 정보
- [NIH NIA.gov](http://NIH.NIA.gov) – 치매 의학 정보
- [NIM Medlineplus.gov](http://NIM.Medlineplus.gov) – 루이소체 치매 의학 정보
- [Dementia Society of America](http://Dementia.Society.of.America) (미국 치매 협회)

당뇨병 (Diabetes)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

당뇨병은 신체가 음식을 에너지로 전환하는 방식에 영향을 미치는 만성 질환입니다. 우리가 섭취하는 대부분의 음식은 포도당(혈당)으로 분해되어 혈류로 방출됩니다. 혈당이 상승하면 췌장에서 인슐린을 분비하라는 신호를 보냅니다. 인슐린은 혈당이 체세포로 들어가 에너지로 사용될 수 있도록 하는 '열쇠' 역할을 합니다. 당뇨병 환자의 경우, 신체가 충분한 인슐린을 만들지 못하거나 만들어진 인슐린을 제대로 사용하지 못합니다.

미국에서 약 4,010만명, 즉 8명 중 1명꼴로 당뇨병을 앓고 있으며 이 중 4명 중 1명 이상은 자신이 당뇨병을 앓고 있는지 모르고 있습니다.

당뇨병의 종류

- **제1형 당뇨병:** 면역 체계가 췌장의 인슐린 생성 세포를 공격하고 파괴하는 자가면역 질환입니다. 제1형 당뇨병 환자는 생존을 위해 매일 인슐린을 투여해야 합니다. 주로 어린이와 젊은 성인에게서 진단됩니다.
- **제2형 당뇨병:** 가장 흔한 형태의 당뇨병입니다. 신체가 인슐린을 적절하게 사용하지 못하는(인슐린 저항성) 상태로, 혈당을 정상 수준으로 유지할 수 없습니다. 주로 체중, 유전 및 생활 습관 요인과 관련이 있습니다.
- **당뇨 전단계 (Prediabetes):** 혈당 수치가 정상보다 높지만 아직 제2형 당뇨병으로 분류될 만큼 높지는 않은 상태입니다. 이는 생활 습관 개선을 통해 당뇨병으로의 진행을 막을 수 있는 매우 중요한 시기입니다. 미국 성인 약 1억 1,520만명이 당뇨 전단계 상태이며, 이 중 약 10명 중 8명은 자신이 당뇨 전단계인지 모르고 있습니다.
- **임신성 당뇨병:** 당뇨병 병력이 없던 임산부에게 발생합니다. 보통 아기를 출산한 후에 사라지지만, 나중에 어머니가 제2형 당뇨병에 걸릴 위험을 높입니다.

누가 당뇨병에 걸릴 수 있나요?

제1형은 대개 어린 시절이나 청소년기에 진단됩니다. 제2형은 성인에게서 흔히 발생하며, 특히 과체중이거나 가족력이 있는 경우 위험이 높습니다. 특히 65세 이상 성인의 약 52%(약 3,130만 명)가 당뇨 전단계 상태입니다. 나이, 과체중, 가족력이 있는 경우 정기 검사를 권장합니다.

당뇨병의 원인

- **제1형:** 자가면역 반응이 인슐린 생성을 중단시킵니다.
- **제2형:** 인체가 인슐린에 대해 저항성을 갖게 됩니다.

당뇨병의 징후 및 증상

- 빈번한 배뇨 (특히 밤에 심함).
- 극심한 갈증 및 설명되지 않는 체중 감소.
- 극심한 공복감(식사 중에도 배가 고프).
- 매우 건조한 피부 또는 잘 낫지 않는 상처.
- 손이나 발의 감각 저하 또는 따끔거림.
- 시야 흐림 및 피로감 증가.

당뇨병의 단계 (제2형 당뇨)

일반적으로 인슐린 저항성(체내 인슐린 활용 능력 저하)에서 시작하여 당뇨 전단계를 거쳐 본격적인 당뇨병으로 진행됩니다. 적절히 관리되지 않을 경우, 마지막 단계에서는 심장, 신장, 눈, 신경, 발에 만성 합병증이 동반될 수 있습니다.

당뇨병의 진단

- **당화혈색소(A1C) 검사:** 지난 3개월간의 평균 혈당 수치를 측정합니다.
- **공복 혈당 검사:** 하룻밤 금식 후 혈당 수치를 측정합니다.
- **경구 포도당 내성 검사(OGTT):** Oral Glucose Tolerance Test 로 알려져있습니다. 당분이 든 음료를 마신 후 신체의 반응을 측정합니다.

당뇨병의 치료

- **제1형:** 매일 인슐린 주사 또는 인슐린 펌프 사용이 필수적입니다.
- **제2형:** 건강한 식단, 활발한 신체 활동, 경구용 약물(메트포르민 등)로 관리하며, 필요한 경우 인슐린을 처방받습니다.
- **모니터링:** 혈당 측정기 또는 연속 혈당 측정기(CGM)를 사용하여 자주 혈당을 확인해야 합니다.

당뇨병의 예방

현재 제1형 당뇨병을 예방할 수 있는 방법은 없습니다. 그러나 제2형 당뇨병은 다음과 같은 생활 습관 개선을 통해 예방하거나 지연시킬 수 있습니다:

- 적정량의 체중 감량 (체중의 5%~7% 감량).
- 규칙적인 신체 활동 (일주일에 최소 150분).
 - 체중의 5~7% 감량과 주 150분 이상 신체 활동을 병행하면 제2형 당뇨병 발생 위험을 최대 58%까지 줄일 수 있습니다.

당뇨병과 함께 살아가기

당뇨병 관리는 합병증 예방을 위한 선제적인 접근이 필수적입니다. 상처 확인을 위한 정기적인 발 검사, 망막병증 확인을 위한 연례 안과 검사, 그리고 신장 기능 검사가 포함됩니다. 혈압과 콜레스테롤이 목표 범위 내에 있는지 확인하기 위해 꾸준히 정기 검진을 받는 것도 매우 중요합니다.

지원 단체 (Support Groups)

- [Diabetes.org](https://diabetes.org): 미국 당뇨병 협회 – 커뮤니티 지원 그룹

참고 자료

- [MedlinePlus.gov](https://medlineplus.gov): 국립의학도서관 – 당뇨병 정보
- [MedlinePlus.gov](https://medlineplus.gov): 당뇨병 백과사전
- [NIDDK.nih.gov](https://niddk.nih.gov): 국립당뇨·소화기·신장질환연구소 – 당뇨병이란 무엇인가?
- [CDC.gov](https://cdc.gov): 질병통제예방센터 – 당뇨병 안내
- [CDC.gov](https://cdc.gov): 국가 당뇨병 예방 프로그램

심장 질환 (Heart Disease)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

심장 질환은 심장에 영향을 미치는 여러 유형의 상태를 통틀어 일컫는 말입니다. 가장 흔한 유형은 관상동맥 질환(CAD)으로, 이는 심장마비로 이어질 수 있습니다. 심장마비는 심장 근육의 일부로 가는 혈류가 크게 감소하거나 차단될 때 발생합니다. 심장 질환은 미국 내 주요 사망 원인 중 하나입니다.

주요 심장 질환의 종류

질환명	주요 문제	상세 설명 및 영향
심장마비 (Heart Attack)	혈관 문제	동맥 폐쇄로 혈류가 차단되어, 즉각적인 조치가 없을 경우 심장 근육이 괴사하기 시작합니다.
심정지 (Cardiac Arrest)	전기 신호 문제	심실세동 등 부정맥(비정상적 심장 리듬)으로 인해 심장이 갑자기 박동을 멈추는 응급상황입니다. 즉각적인 CPR 및 제세동기(AED) 처치가 없으면 수분 내 사망할 수 있습니다.
심부전 (Heart Failure)	펌프 기능 문제	심장 근육이 약해지거나 굳어져 신체가 필요로 하는 혈액을 충분히 공급하지 못하는 만성 상태입니다.

누가 심장 질환에 걸릴 수 있나요?

고혈압, 콜레스테롤 또는 당뇨병이 있는 사람은 위험도가 가장 높습니다. 흡연 및 신체 활동 부족과 같은 생활 습관 요인도 영향을 미칩니다. 미국인의 거의 절반이 이러한 위험 요인 중 적어도 하나를 보유하고 있습니다.

심장 질환 위험은 연령에 따라 증가하지만, 청장년에게 생각보다 높은 확률로 발생하기도 합니다. 2023년 심혈관 질환 사망자 약 6명 중 1명은 65세 미만이었습니다.

심장 질환의 원인

심장 질환은 흔히 동맥경화증(Atherosclerosis)에 의해 발생합니다. 이는 동맥 벽에 플라크(지방과 콜레스테롤의 축적물)가 쌓이는 상태를 말합니다. 시간이 지나면서 혈관이 좁아지고 심장으로 가는 혈액의 흐름이 제한되면서 산소 공급이 줄어 듭니다.

심장 질환의 징후 및 증상

- **흉통 (협심증):** 가슴을 압박하거나 쥐어짜는 듯한 통증 또는 불편함.
- **호흡 곤란:** 신체 활동 중이나 누워 있을 때 숨이 차는 증상.

- **연관통:** 어깨, 팔, 목, 턱, 등 또는 상복부 등 심장 외 부위에도 통증. 특히 여성에게서 이러한 비전형적 증상이 더 흔히 나타남.
- **극도의 피로:** 특별한 이유 없이 평소보다 심하게 피로를 느낌.

심장 질환의 진단

- **심전도(ECG/EKG):** 심장의 전기적 활동을 기록합니다.
- **심장 초음파(Echocardiogram):** 초음파를 통해 심장의 구조(심방, 심실, 판막 등)와 심실의 혈액 펌프 기능(박출률 등)을 확인합니다.
- **스트레스 테스트 (Stress Testing):** 신체 운동 중 심장 상태를 모니터링합니다.
- **심장 도관술(Cardiac Catheterization):** 도관과 특수 조영제를 사용하여 혈관의 폐쇄 여부를 확인합니다.

심장 질환의 치료

- **생활 습관 개선:** 심장 건강에 좋은 식단(저염/저지방)을 채택하고 규칙적으로 운동합니다.
- **약물 치료:** 베타 차단제, 스타틴(콜레스테롤 관리), ACE 억제제(혈압 관리) 등.
- **시술 및 수술:** 관상동맥 확장술, 스텐트 삽입술, 또는 관상동맥 우회술.

심장 질환의 예방

- 건강하게 스트레스 관리하기.
- 금연 및 간접흡연 피하기.
- 정기 혈압, 혈당 및 콜레스테롤 검사를 통해 수치를 목표 범위 내로 유지하기.
- 건강한 식단 채택하기 (저염·저포화지방, DASH 식단 권장).
- 규칙적인 신체 활동하기.
- 음주 절제하기.

심장 질환과 함께 살아가기

심장 질환 관리를 위해서는 선제적인 접근이 필요합니다. 여기에는 매일 혈압과 체중을 모니터링하고, 처방된 약물 복용 일정을 엄격히 준수하며, **심장 재활(Cardiac Rehabilitation)** 프로그램에 참여하는 것이 포함됩니다. 심장 재활은 심장 질환 발생 후 심혈관 건강을 개선하기 위해 설계된 의료 감독 프로그램입니다.

심정지 시 CPR/AED 안내

심정지 발생 시 응급 대응 지침:

- 즉시 911 신고
- CPR 시작

- 근처 AED(자동 제세동기) 사용

**신속한 대응이 생명을 구합니다.*

지원 단체 (Support Groups)

- Heart.org: 미국심장협회 – 커뮤니티 지원 그룹
- ACVPR.org – 심장 재활 프로그램 검색 웹사이트

참고 자료

- MedlinePlus.gov: 국립의학도서관 – 심장 질환 정보
- CDC.gov: 질병통제예방센터 – 심장 질환 안내
- NHLBI.nih.gov: 국립심장폐혈액연구소 – 심장 질환 의학 정보

정신 건강 (Mental Health)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

정신 건강은 정서적, 심리적, 사회적 안녕을 포괄합니다. 이는 생각하고 느끼고 행동하는 방식에 영향을 미치며, 스트레스에 대처하고 타인과 관계를 맺으며 선택을 내리는 방식을 결정하는 데 도움을 줍니다. 원활한 치료 접근성과 조기 개입은 회복과 안녕을 위해 필수적입니다.

주요 정신 질환의 종류

- **불안 장애(Anxiety Disorders):** 지속적이고 과도한 공포나 걱정이 특징입니다. 공황 장애, 공포증 등이 포함됩니다.
- **강박 및 관련 장애(OCD 및 관련 장애):** 통제할 수 없는 반복적인 생각(강박)과 행동(충동)이 특징입니다.
- **기분 장애(Mood Disorders):** 감정 상태에 영향을 미칩니다.
 - **우울증:** 지속적인 슬픔과 흥미 상실.
 - **조울증 (양극성 장애):** 극심한 고조(조증)와 저조(우울증)의 주기적 반복.
 - **계절성 정동 장애(SAD):** 계절의 변화에 따라 유발되는 우울증.
- **트라우마 관련 장애:** 충격적인 사건을 경험하거나 목격한 후 발생하는 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 등.
- **정신병적 장애:** 환각이나 망상과 같이 현실감을 상실하는 상태. 조현병이 포함됩니다.
- **섭식 장애:** 식이 행동과 그에 관련된 생각 및 감정의 심각한 교란.
- **인격 장애:** 건강하지 못하고 경직된 사고 및 행동 양식이 장기간 지속되는 상태.
- **물질 사용 장애(Substance Use Disorder):** 술 및 약물의 반복적인 사용으로 인해 육체적, 심리적 건강이 매우 악화되는 상태.

누가 정신 질환의 어려움을 겪을 수 있나요?

정신 건강 문제는 매우 흔하게 발생합니다. 미국 성인 약 23%(5명 중 1명 이상)가 정신 건강 질환을 앓고 있습니다. 이는 소득, 지역, 교육 수준에 관계없이 모든 연령층에 영향을 미칩니다. 인지 능력 저하나 고립으로 인한 우울증 등 특정 문제는 노년기에 증가할 수 있지만, 젊은 층에서도 정신 건강 문제가 크게 늘고 있습니다. 미국 내 12~17세 청소년 약 5명 중 1명이 현재 진단된 정신 또는 행동 건강 장애를 앓고 있습니다.

특히 65세 이상의 상당수가 우울증, 불안 장애 등 정신 건강 문제를 경험하며, 이는 흔히 진단되지 않거나 치료되지 않는 경향이 있습니다. 증상이 나타나면 의사나 정신 건강 전문가에게 조기에 도움을 구하는 것이 중요합니다.

정신 건강 문제의 원인

정신 건강 상태를 유발하는 단일 원인은 없으며, 일반적으로 다음과 같은 요인들이 복합적으로 영향을 미칩니다:

- **생물학적 요인:** 뇌 화학 물질(세로토닌과 같은 신경전달물질)의 불균형 및 유전적 소인.
- **삶의 경험:** 트라우마, 학대 또는 심각한 만성 스트레스 노출.
- **의학적 상태:** 암이나 심장 질환과 같은 만성 신체 질환은 정신적 고통을 겪을 위험을 높일 수 있습니다.

정신 건강 문제의 징후 및 증상

증상은 다양하지만 흔히 다음과 같은 징후가 나타납니다:

- 지속적인 슬픔 또는 공허한 기분, 짜증.
- 과도한 공포 또는 걱정, 불안.
- 극심한 기분 변화 또는 감정 조절의 어려움.
- 사회 활동 및 사랑하는 이들과의 고립.
- 수면 습관(불면증)이나 식습관의 현저한 변화.
- 섬망(Delirium): 주로 노인들에게서 나타나는 갑작스러운 혼란이나 방향 감각 상실.
- 자살 충동: 자해나 자살에 대한 생각.
 - 자해나 자살에 대한 생각이 들면 즉시 **988**

(자살위기 상담전화, 24시간 무료)에 전화하거나 문자를 보내세요. 생명을 위협하는 응급 상황에는 **911**에 전화하십시오.

정신 건강 문제의 중증도

다양한 정신 건강 문제는 각기 다른 양상을 보이며, 경미한 상태부터 위기 상황까지 다양할 수 있습니다.

1. **경미한 교란:** 수면 장애나 일시적인 괴로움을 겪는 단계.
2. **중등도/중증 질환:** 증상이 업무, 대인 관계 또는 일상 기능에 지장을 주는 단계.
3. **위기(Crisis):** 자신을 해칠 위험이 높거나 스스로를 돌볼 능력을 상실한 단계.

정신 건강의 진단 및 치료

- **진단:** 정신과 의사, 심리학자 또는 전문 상담가의 임상 면담과 진단 매뉴얼(DSM-5)을 통해 진단합니다.
- **치료:**
 - **상담 치료:** 인지 행동 치료(CBT)를 통한 부정적인 사고 방식 식별 및 개선.
 - **약물 치료:** 항우울제 또는 기분 조절제, 항불안제 등을 복용.
 - **심신 수련:** 정서 조절을 돕는 명상, 요가 및 마음챙김.
 - **신앙 기반 케어:** 영성과 목회적 돌봄을 통한 보완적 지원(complementary support) 및 회복.

지원 단체 (Support Groups)

기관명 (Organization)	주요 서비스 (Key Services)	연락처 및 링크 (Contact/Link)
버겐 뉴브릿지 병원 (Bergen New Bridge Medical Center)	입원 환자 치료(Inpatient Care). 정신 건강 및 약물 남용 대상 24시간 입원 및 집중 치료 서비스 제공.	NewBridgeHealth.org (201) 967-4000
약물 남용 및 정신건강 서비스국 (SAMHSA)	미국 보건복지부 산하 기관. 약물 남용과 정신 건강 관련 지역별 지원 프로그램 및 치료 시설 정보 제공.	SAMHSA.gov - Find Help FindTreatment.gov
정신 건강 연합 (NAMI)	정신 질환자를 위한 모임 및 교육 프로그램	NAMI.org - Support Groups
Mental Health America	정신 건강 전문가 연결 및 정신 건강 자가 진단	mhanational.org

전국 24시간 위기 지원 헬프라인

SAMHSA 운영 무료, 비밀 보장 연락 서비스 – 영어/스페인어로 제공됨.

- 정신 건강·약물 사용: **1-800-662-HELP (4357)**
- 자살 및 위기 상담 전화·문자·채팅: **988**

Care Plus NJ (케어 플러스 뉴저지)

뉴저지 소재 아동, 성인, 가족 대상 정신 건강 상담 전문 비영리 기관.

케어 플러스 본부

- 주소: 610 Valley Health Plaza, Paramus, NJ 07652
- 대표 연락처: (201) 986-5000 | CarePlusNJ.org
- 한국어 상담: Jeannie Kang-Suh

지역별 외래 진료소 (Outpatient Offices)

버겐 카운티 오피스 (Rochelle Park)

- 주소: 365 W. Passaic Street, Suite 115, Rochelle Park, NJ 07662
- 운영 시간: 월요일 ~ 목요일 | 오전 9시 ~ 오후 3시

에식스 카운티 오피스 (Bloomfield)

- 주소: 650 Bloomfield Avenue, Suite 106, Bloomfield, NJ 07003
- 운영 시간: 월요일 ~ 목요일 | 오전 9시 ~ 오후 1시

모리스 카운티 오피스 (Morris Plains)

- 주소: 520 Speedwell Avenue, Ste 216, Morris Plains, NJ 07950
- 운영 시간: 수요일, 목요일 | 오전 9시 ~ 오후 1시

참고 자료

- [MedlinePlus.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/): 국립의학도서관 – 정신 건강 종합 정보
- [NIMH.nih.gov](https://www.nimh.nih.gov/): 국립정신건강연구소 – 정신 건강 관리법
- [Christianhealth.org](https://www.christianhealth.org/): 신앙 기반 행동 건강 서비스
- [NAMI](https://www.nami.org/): 정신건강연합 – 종교와 영성이 정신 건강에 미치는 이점
- [SAMHSA.gov](https://www.samhsa.gov/): 약물남용 및 정신건강 서비스국 – 약물 남용 종합 정보
- [SAMHSA.gov](https://www.samhsa.gov/): 정신 건강 종합 정보

심신 의학 (Mind-Body Medicine)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조연이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

심신 의학(Mind-Body Medicine)은 뇌, 마음, 신체, 그리고 행동 사이의 상호작용을 과학적으로 활용하여 질병의 근본적인 치유를 지향합니다. 심신 의학 치료법은 명상, 요가, 마음챙김 등 다양한 방법을 통해 신체적 및 정서적 건강을 체계적으로 증진합니다. 이러한 실천법은 현대 의학 체계 내에서 **보완·통합 건강 요법(Complementary and integrative)**으로서 그 가치를 인정받고 있으며, 표준 의학 치료(Conventional)와 병행하여 환자의 전반적인 회복과 삶의 질을 높이는 데에 기여하고 있습니다.

주요 심신 수련 종류

심신 의학의 기초를 이루는 몇 가지 기술은 신경계와 생리적 건강에 도움이 됩니다:

- **명상 (Meditation):** 정신적 명료함과 정서적 안정을 얻기 위해 주의를 집중하거나 생각의 흐름을 잠시 멈추는 수련입니다.
- **마음챙김 (Mindfulness):** 매 순간 자신의 생각, 감정, 경험을 비판하지 않고 온전히 인식하고 받아들이는 수련입니다.
- **요가 (Yoga):** 신체의 유연성 및 근력, 정신적 집중력을 향상하기 위해 신체적 자세, 호흡법, 명상을 결합한 수련입니다.
- **태극권(Tai Chi) 및 기공(Qi Gong):** 느리고 의도적인 동작을 명상 및 호흡과 결합한 심신 운동입니다.
- **심호흡 및 점진적 이완법:** 신체의 스트레스 반응을 물리적으로 낮추고 근육의 긴장을 완화하는 수련법입니다.

심신 수련 효과

- **통증 관리:** 요가와 명상 같은 수련은 요통, 두통을 포함한 만성 통증을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
- **정신 건강:** 마음챙김 수련은 불안, 우울증 및 스트레스 증상을 완화하는 데 효과적일 수 있습니다.
- **심혈관 건강:** 정기적인 명상/심신 수련은 혈압을 낮추는 데 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 있습니다.
- **암 케어:** 심신 수련은 암 환자가 치료 과정에서 겪는 메스꺼움, 피로, 정서적 고통 등의 부작용을 관리하기 위해 사용될 수 있습니다.

표준 의학 치료와의 상호작용

심신 수련은 표준 의학 치료를 대체하는 것이 아니라 함께 사용되는 **보완·통합 건강 요법(complementary and integrative)** 치료법입니다. 특정 신체 자세(요가 등)는 기존 부상이나 만성 질환이 있는 개인의 경우 숙련된 지도자의 가이드가 필요할 수 있습니다. 특히 65세 이상 시니어, 골다공증·관절 질환·심장 질환이 있는 분은 시작 전 반드시 의료진과 상담하세요.

지역 기관 안내

- 심신 의학 치료 기관
 - 한의원
 - 침술원
 - 마사지 테라피
 - 명상/기 수련원
 - 요가 및 필라테스
 - 도수 치료사(chiropractic)
 - 심리 치료사(psychotherapy)
- 뉴저지 병원내 심신 의학 프로그램
 - [Englewood Health – Integrative Medicine](#)
 - [Hackensack Meridian Health – Integrative Health & Medicine](#)
 - [Valley Health – Integrative Medicine](#)
 - [RWJBarnabas Hamilton – Holistic Integrative Medicine](#)
- 심신 의학 학술 및 전문 센터
 - [Columbia University – Integrative Health](#)
 - [Mount Sinai Hospital – Integrative Medicine](#)
 - [Memorial Sloan Kettering Cancer Center – Integrative Medicine](#)

*기관을 선택할 때 자격증 및 전문 교육을 확인하세요. NCCIH의 보완 건강 전문가 선택 가이드를 참고하시기 바랍니다.

참고 자료

- [NCCIH.nih.gov](https://nccih.nih.gov): 국립보완통합보건센터
- [NCCIH.nih.gov](https://nccih.nih.gov): 명상과 마음챙김의 효과
- [Cancer.gov](https://cancer.gov): 국립암연구소 – 심신 요법 안내

비만 (Obesity)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

비만은 건강에 위험을 초래할 정도로 체지방이 과도하게 축적된 상태를 말하는 것으로 복합적인 만성 질환입니다. 이는 단순히 외견상의 문제가 아니라, 질병 및 건강 문제를 일으킬 위험을 높이는 의학적 상태입니다.

누가 비만해질 수 있나요?

비만은 모든 연령, 인종, 사회경제적 위치에 상관없이 영향을 미칠 수 있습니다. 신진대사의 변화와 근육량 감소로 인해 연령이 높아질수록 비만 위험이 증가하는 경향이 있지만, 젊은 층의 비만율도 크게 높아지고 있습니다. 미국 성인 5명 중 2명(40.3%)이 비만 진단을 받으며, 미국 어린이 및 청소년(2~19세) 약 5명 중 1명(약 19~20%)이 비만이며, 이는 평생의 건강을 위협하는 요인이 됩니다.

비만의 원인

비만은 일반적으로 신체가 사용하는 에너지보다 더 많은 칼로리를 장기간 섭취하여 발생하는 에너지 불균형에서 비롯됩니다. 주요 기여 요인은 다음과 같습니다:

- **생활 습관:** 앉아서 지내는 습관, 과도한 화면 시청 시간, 가공식품 및 고칼로리 중심의 식단.
- **환경:** 저렴하고 건강한 식품에 대한 접근성 부족, 또는 신체 활동을 하기에 안전한 장소의 부재.
- **유전 및 신진대사:** 유전적 특성은 신체가 음식을 에너지로 처리하는 방식과 지방을 저장하는 방식에 영향을 줄 수 있습니다.
- **건강 상태 및 약물:** 갑상선 기능 저하증과 같은 특정 질환이나 스테로이드와 같은 특정 약물 복용이 체중 증가의 원인이 될 수 있습니다.

비만의 징후 및 증상

성인 비만의 일차적인 지표는 **체질량 지수(BMI)**가 30 이상인 경우입니다. 이와 관련된 증상 및 신체적 징후는 다음과 같습니다:

- 체지방 증가, 특히 허리 주변의 복부 지방.
- 가벼운 신체 활동 시에도 나타나는 숨 가쁨.
- 땀 분비 증가 및 코골이(흔히 수면 무호흡증과 관련됨).
- 근골격계에 가해지는 과도한 부담으로 인한 지속적인 관절 및 통증.

비만의 진단

- **BMI 계산:** 키와 몸무게를 비교하는 선별 도구입니다.

- CDC 공식 BMI 분류:
 - 1단계: BMI 30~34.9
 - 잠재적인 위험 요인(경계선상의 고혈압 등)이나 가벼운 신체적 증상.
 - 2단계: BMI 35~39.9
 - 비만과 관련된 만성 질환(제2형 당뇨병, 수면 무호흡증 등).
- 3단계: BMI 40 이상 (중증)
 - 비만 관련 만성 질환으로 인해 말기 신부전(ESRD), 중증 심장질환, 간경화 등 심각한 장애가 발생.
- **허리둘레 측정:** 복부에 저장된 지방을 측정하며, 이는 건강 위험을 나타내는 핵심 지표입니다. 여성 35인치(88cm) 이상, 남성 40인치(102cm) 이상일 경우 복부 비만으로 건강 위험이 증가할 수 있습니다.
- **혈액 검사:** 콜레스테롤, 혈당 수치, 간 기능을 확인하여 대사 건강을 평가합니다.

비만의 치료

치료는 단기간의 체중 감량보다는 **지속 가능한 건강 개선**에 초점을 맞춥니다:

- **식단 변화:** 영양 밀도가 높은 식품 위주로 섭취하고 칼로리 섭취량을 줄입니다.
- **신체 활동:** 일주일에 최소 150분의 중강도 유산소 활동과 함께, 주 2회 이상 근력 운동을 권장합니다.
- **습관 개선:** 과식을 유발하는 요인을 파악하고 더 건강한 생활 습관을 개발합니다.
- **의학적 개입:** 경우에 따라 의료진이 체중 감량 약물을 처방하거나 비만 대사 수술을 권장할 수 있습니다.

비만의 예방

- 당분이 함유된 음료와 고도로 가공된 간식 섭취 제한하기.
- 건강한 식품 섭취와 안전한 신체 활동하기.
- 앉아서 지내는 미디어 시청 시간을 줄이고 일상적인 움직임 늘리기.
- 수면 부족은 허기를 조절하는 호르몬을 교란할 수 있으므로, 규칙적이고 질 좋은 수면 우선시하기.

비만 극복의 삶

비만 관리는 장기적인 생활 습관 관리가 핵심입니다. 성공 여부는 단순히 체중계의 숫자보다는 심혈관 건강, 혈압, 혈당 수치의 개선 정도를 통해 평가되어야 합니다.

지원 단체 (Support Groups)

- Obesityaction.org: 비만 협회 – 커뮤니티 지원 그룹

참고 자료

- [MedlinePlus.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/): 국립의학도서관 – 비만 의학 정보
- [CDC.gov](https://www.cdc.gov/): 질병통제예방센터 – 비만 개요
- [NHLBI.nih.gov](https://www.nhlbi.nih.gov/): 국립심장폐혈액연구소 – 온라인 BMI 계산기
- [NIDDK.nih.gov](https://www.niddk.nih.gov/): 국립당뇨·소화기·신장질환연구소 – 노인 체중 관리 및 비만 정보 (연구자료)
- [NCOA.org](https://www.ncoa.org/):全美노인협회 – 노인 비만 개요

뇌졸중 (Stroke)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

뇌졸중은 뇌로 가는 혈액 공급이 중단되거나 감소하여 뇌 조직이 산소와 영양분을 받지 못할 때 발생합니다. 단 몇 분 만에 뇌세포가 죽기 시작하므로, 뇌 손상과 잠재적인 합병증을 최소화하기 위해 즉각적인 조치가 필요한 매우 위급한 의료 응급 상황입니다.

누가 뇌졸중에 걸릴 수 있나요?

뇌졸중 위험은 연령에 따라 크게 증가합니다. 특히 다음과 같은 경우 고위험군에 속합니다:

- **고혈압:** 뇌졸중의 가장 주요한 원인이며, 최근 젊은 층에서도 빈번하게 발견됩니다.
- **심방세동(AFib):** 혈전을 유발할 수 있는 불규칙한 심장 리듬입니다.
- **콜레스테롤 및 당뇨병:** 두 질환 모두 시간이 지남에 따라 혈관을 손상시킵니다.

뇌졸중 위험은 고령층에서 더 높지만, 젊은 층의 발병률도 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 전체 뇌졸중 환자의 10~15%는 18세에서 50세 사이의 연령대에서 발생합니다. 특히 18~64세 성인의 뇌졸중 유병률이 최근 꾸준히 증가하고 있습니다.

뇌졸중의 원인

- **허혈성 뇌졸중(가장 흔함):** 뇌로 가는 동맥이 혈전이나 지방 축적물(플라크)에 의해 막힐 때 발생합니다. 전체 뇌졸중의 약 87%가 이에 해당합니다.
- **출혈성 뇌졸중:** 뇌의 약해진 혈관이 터져 주변 조직으로 피가 새 때 발생합니다.
- **일과성 허혈 발작(TIA):** 흔히 “미니 뇌졸중”이라고 불리며, 혈류가 일시적으로 차단되는 현상입니다. 이는 향후 발생할 수 있는 대규모 뇌졸중의 강력한 경고 신호입니다. TIA도 즉각적인 응급 처치가 필요한 의료 응급 상황입니다. TIA 발생 후 치료 없이 방치하면 이후 뇌졸중 위험이 크게 높아집니다. TIA 증상이 수 분 내에 사라지더라도 즉시 911에 전화하거나 응급실을 방문하세요.

뇌졸중의 징후 및 증상: F.A.S.T.

의료 전문가들은 갑작스러운 증상을 식별하기 위해 ‘F.A.S.T.’라는 약어를 기억할 것을 강조합니다.

- **F (Face-얼굴 마비):** 얼굴 한쪽이 처지거나 감각이 없음.
- **A (Arm-팔 마비):** 한쪽 팔의 힘이 빠지거나 감각이 없음. 양팔을 올렸을 때 한쪽 팔이 아래로 처짐.
- **S (Speech-언어 장애):** 말이 어눌해지거나 말을 하지 못하며, 타인의 말을 이해하지 못함.

- **T (Time-시간):** 위의 증상 중 하나라도 나타나면 즉시 911에 전화하세요.

*갑자기 원인 불명의 심한 두통이 발생하면 즉시 911에 전화하세요. 출혈성 뇌졸중의 주요 신호일 수 있습니다.

뇌졸중 발생 시 대처 방법

뇌졸중 발생 직후의 시간을 **골든 타임(Golden Time)**이라고 합니다. 증상 발생 후 3시간 이내에 치료를 받기 시작하는 것이 핵심입니다. 환자에 따라 최대 4.5시간까지 치료가 가능하므로, 3시간이 지났더라도 주저하지 말고 즉시 **911**에 전화하세요. 뇌졸중 치료의 성패는 '얼마나 빨리 병원에 도착하느냐'에 달려 있습니다. 처치가 빠를수록 뇌손상을 최소화할 수 있으며, 골든 타임 내에 신속하게 조치를 취하는 것이 환자의 회복을 결정짓는 가장 결정적인 요소입니다.

1. **즉시 911에 전화하세요:** 직접 운전해서 병원에 가려고 하지 마십시오. 구급대원은 구급차 안에서 응급 처치를 시작할 수 있으며, 병원 도착 즉시 치료받을 수 있도록 '뇌졸중 팀'에 미리 연락을 취합니다.
2. **시간을 기록하세요:** 첫 증상이 나타난 정확한 시간을 파악하십시오. 이는 의료진이 환자에게 '혈전 용해제(tPA)'를 안전하게 투여할 수 있는지 판단하는 가장 중요한 정보가 됩니다.
3. **F.A.S.T. 상태를 확인하세요.**
4. **환자를 진정시키고 안전하게 보호하세요:**
 - **음식이나 음료를 주지 마세요:** 뇌졸중은 삼키는 능력에 영향을 주어 질식이나 흡인성 폐렴을 유발할 수 있습니다.
 - **아스피린을 주지 마세요:** 아스피린은 일부 심장마비에는 도움이 되지만, 만약 뇌졸중의 원인이 뇌출혈(출혈성)일 경우 치명적일 수 있습니다.

자세 유지: 환자가 의식이 있다면 옆으로 눕히고 머리를 약간 높여 혈류 흐름과 호흡을 돕습니다.

뇌졸중 회복 단계

- **급성기:** 발생 후 몇 시간 내의 단계로, 뇌졸중 진행을 멈추고 환자를 안정시키는 데 집중합니다.
- **아급성기:** 안정화 이후 수일에서 수주 간의 단계로, 손상 정도를 평가하고 2차 합병증을 예방합니다.
- **재활기:** 다양한 치료를 통해 상실된 기능을 되찾는 장기적인 과정입니다.

뇌졸중의 진단 및 치료

- **진단:** CT 또는 MRI 스캔을 통해 위치와 원인(혈전 혹은 출혈)을 파악합니다. 또한 경동맥 초음파나 심장 초음파를 통해 원인 이 된 혈전의 이동 경로를 확인합니다.
- **치료:** 허혈성 뇌졸중의 경우 골든 타임 내에 tPA와 같은 혈전 용해제를 투여합니다. 출혈성 뇌졸중은 혈관 수리나 뇌압 조절을 위한 수술이 필요할 수 있습니다. 큰 혈전의 경우, 혈전제거술(mechanical thrombectomy)을 통해 직접 혈전을 제거하는 수술도 시행됩니다.
- **재활:** 언어 치료, 물리 치료, 작업 치료를 통해 운동 기능과 의사소통 능력을 다시 학습합니다.

뇌졸중의 예방

고혈압 관리는 뇌졸중 예방에서 가장 중요한 단계입니다. 이외에도 다음과 같은 조치가 필요합니다:

- 심장 질환(특히 심방세동) 치료.
- 건강한 체중과 식단 유지.
- 금연 및 절주.
- 콜레스테롤 수치와 혈당을 정기 검진으로 확인하고 목표 범위 내로 유지합니다.

뇌졸중 회복의 삶

뇌졸중 회복은 퇴원 후에도 오랫동안 지속됩니다. 가정 내 안전 시설(안전 손잡이 등) 보완, 보행기 등 보조 기구 사용, 그리고 환자와 가족의 심리적 충격을 완화하기 위한 정서적 지원이 병행되어야 합니다.

지원 단체 (Support Groups)

- Americanstroke.org: 미국 뇌졸중 협회 – 커뮤니티 지원 그룹 찾기

참고 자료

- MedlinePlus.gov: 국립의학도서관 – 뇌졸중 정보
- NIA.nih.gov: 국립노화연구소 – 뇌졸중: 징후, 요인

PART II • 제 7 편

장기 요양 프로그램 (Long Term Care Program)

Long Term Care Program

장기 요양 케어 체계: LTC 개요, 재활 및 전문 간호 시설(Skilled Nursing), 요양원 케어(Nursing Home), 호스피스 완화의료, 성인 데이케어(Adult Day Care), 장기요양 옴부즈맨.

본 부문 총 6개 상세 안내 문서 수록

롱텀케어 (Long Term Care) 개요

롱텀케어는 단순히 질병 치료를 넘어, 신체적·인지적 제약으로 인해 일상생활(ADLs: 목욕, 옷 입기, 식사 등 일상생활 활동)을 스스로 수행하기 어려운 분들을 돕기 위한 포괄적인 지원 체계입니다.

롱텀케어 서비스 종류

거주형 시설 케어 (Residential Care)

- [어시스티드 리빙 \(Assisted Living\)](#)

독립적으로 생활하기 어려우나 일상생활 수준의 집중 의료는 필요하지 않은 분들을 위한 거주지입니다. 식사, 투약, 개인 위생 등에서 도움을 제공합니다. 비용은 주로 사비로 부담하며, 메디케이드 혜택이 제한적으로 적용될 수 있습니다.

- [넬싱홈 \(Nursing Home / Skilled Nursing Facility\)](#)

24시간 숙련된 간호 서비스와 지속적인 의료 감독이 필요한 분들을 위한 시설입니다. 메디케어는 단기 입소 비용을 일부 커버하며, 장기 입소 시에는 메디케이드 또는 사비로 부담하는 경우가 많습니다.

[전문 재활 및 간호 서비스 \(Rehabilitation and Skilled Nursing Care\)](#)

- 의학적으로 복잡한 처치(상처 관리, 정맥 주사)나 집중적인 재활(물리치료·작업치료·언어치료)이 필요한 경우 전문 의료진이 직접 제공하는 서비스입니다.

가정 및 지역사회 기반 서비스 (HCBS)

- [홈 헬스 케어 \(Home Health Care\)](#)

의사의 처방에 따라 간호사, 홈 헬스 에이드, 물리/작업치료사 등 전문인력이 가정을 방문하여 제공하는 의료 서비스입니다.

- [어덜트 데이 케어 \(Adult Day Care\)](#)

낮 동안 안전한 시설에서 사회적 활동과 건강 모니터링을 제공하며, 가족 간병인에게 휴식(Respite)을 제공합니다.

[호스피스 케어 \(Hospice Care\)](#)

- 호스피스 케어는 질병이 정상적 경과를 따를 때 기대 수명 6개월 이하로 의사에게 진단받은 말기 환자와 그 가족을 위한 특별한 형태의 케어입니다. 치료보다는 통증 완화(Palliative Care)와 신체적·정서적·영적 지지 서비스에 중점을 둡니다. 6개월 이후에도 의사의 재인증(recertification) 시 케어를 지속할 수 있습니다.

롱텀케어 시설 선택하기

- 전국 시설 검색: [Medicare.gov/find nursing homes](https://www.medicare.gov/find-nursing-homes)
- 뉴저지: [NJ.gov/health/ltc/find-facility](https://www.nj.gov/health/ltc/find-facility)

선택 시 참고 사항

- **5성급 등급 확인 (5-Star Quality Rating)**

[Medicare.gov Care Compare](#)에서 각 시설의 5성급 등급을 확인하세요. 등급은 세 가지 도메인으로 구성됩니다.

- 건강 검사 (Health Inspections)
- 직원 배치 (Staffing)
- 품질 지표 (Quality Measures)

- **조사 결과 보고서 (Survey Report) 확인**

시설 내 비치된 가장 최근의 주 정부 조사 보고서를 요청하거나, [Medicare.gov Care Compare](#) 및 주 정부 웹사이트에서 온라인으로도 확인할 수 있습니다.

- **롱텀케어 옴부즈맨 (Ombudsman) 문의**

롱텀케어 옴부즈맨은 주지사가 임명하는 독립 옹호 기관으로, 롱텀케어 시설 거주자의 권리를 보호하고 학대·방치·불만 사항을 조사합니다. 거주자 본인, 가족, 관계자 누구든 문의할 수 있습니다.

참고 자료

- [NIA.gov: 거주형 시설 가이드 \(어시스티드 리빙, 널싱홈 등\)](#)
- [NIA.gov: 롱텀케어란 무엇인가](#)
- [ACL.gov: 롱텀케어 개요 및 지역 서비스 연결](#)
- [Medicare.gov Care Compare: 전국 시설 검색 및 비교](#)
- [뉴저지 롱텀케어 옴부즈맨 \(NJLTCO\)](#)

어덜트 데이 케어 (Adult Day Care)

어덜트 데이 케어 (Adult Day Care)는 낮 시간 동안 고령자에게 안전한 환경과 돌봄을 제공하는 시설입니다. 가족들이 낮 동안 직장 생활을 하거나 휴식을 취할 수 있도록 돕는 필수적인 지역사회 서비스입니다.

주요 서비스 유형

어덜트 데이 케어는 크게 두 가지 모델로 운영되며, 치매·인지 특화 프로그램은 두 모델 모두에서 선택적으로 운영될 수 있습니다.

- **어덜트 소셜 데이 케어 (Adult Social Day Services):** 사교 활동, 레크리에이션, 식사 및 기본 돌봄 위주.
- **어덜트 메디컬 데이 케어 (Adult Day Health Services):** 간호사나 물리치료사가 상주하며, 투약 관리나 재활 치료 등 보다 전문적인 의료 서비스 제공. 의료적 케어나 널싱홈 케어가 필요한 분들에게 적합.
- **치매·인지 특화 데이 케어 (Alzheimer's/Dementia Adult Day Services)** 치매나 인지 저하가 있는 분들을 위해 설계된 안전한 환경과 인지 자극 프로그램 제공. 소셜·메디컬 데이 케어 모두에서 운영될 수 있으며, 시설마다 전문화 수준이 다를 수 있음.

비용 및 보험 적용

메디케어

오리지널 메디케어(파트 A, B)는 어덜트 데이 케어 비용을 지원하지 않습니다. 단, 일부 메디케어 어드밴티지(파트 C) 플랜은 어덜트 데이 케어를 제한적으로 커버할 수 있음.

**플랜마다 조건이 다르므로 사전에 확인 필요*

개인 부담

비용은 지역, 시설 유형, 제공 서비스에 따라 크게 다릅니다. 차량 운행비, 특수 식단, 이용 시간 외 추가 돌봄비가 별도로 청구될 수 있습니다. * 자세한 내용은 각 시설에 직접 문의하거나 [Eldercare Locator](#)를 통해 확인

롱텀케어 메디케이드 (MLTSS)

뉴저지에서는 메디케이드의 MLTSS 프로그램을 통해 어덜트 데이 케어 비용이 지원될 수 있습니다. NJ FamilyCare MCO(관리 보험사)가 서비스 제공자에게 비용을 지불하는 관리형 케어 방식입니다.

**자격 요건 및 신청 방법은 [롱텀케어 메디케이드 \(MLTSS\)](#) 에서 확인*

뉴저지 치매 어덜트 데이케어 보조금 (AADSP)

NJ DHS Division of Aging Services가 운영하는 치매 전용 지원 프로그램입니다. 알츠하이머 또는 관련 치매 진단을 받은 분들에게 어덜트 데이 케어 비용의 **20~100%**를 주당 최대 5일까지 보조합니다.

자격 요건

- 치매 진단
- 소득: 개인 연소득 \$50,256 이하, 부부 합산 \$58,632 이하 (2025년 기준)
- 현재 MLTSS 메디케이드·JACC 등 프로그램 미참여자

문의: NJ DHS Division of Aging Service, 609-438-4733 / nj.gov/humanservices/doas/services/a-k/aads/

뉴저지 간병 지원 프로그램 (JACC)

널싱홈 수준의 케어가 필요하지만 커뮤니티에서 생활하는 60세 이상 시니어에게 소셜 어덜트 데이 케어, 개인 돌봄 보조, 교통 서비스 등을 지원합니다. 소득 기준에 따라 본인 부담금이 있을 수 있습니다.

문의: 카운티 AAA/ADRC (Aging and Disability Resource Connection), 1-877-222-3737

*자세한 내용은 [뉴저지 간병 지원 프로그램 \(JACC\)](#) 에서 확인

VA (참전유공자) 혜택

등록된 재향군인의 경우 VA를 통한 어덜트 데이 케어 지원이 가능할 수 있습니다.

기타 지불 수단

롱텀케어 보험 (Long-Term Care Insurance) 개인 보험이 있다면 어덜트 데이 케어 비용을 청구할 수 있습니다.

*일부 플랜은 비용의 일부만 지원하므로 보험 약관 확인 필요.

시설 선택 기준

- **직원 대 이용자 비율:** 직원 한명당 이용자 비율이 낮은지 여부를 확인. 뉴저지 주 보건부(NJDOH) 인허가 기준이 최소 요건이며, 시설마다 차이가 있음.
- **직원 전문성:** 간호사 상주 여부, 치매 전문 데이 케어의 경우 관련 전문 직원 상주 여부
- **운송 서비스:** 집과 시설 간 안전한 차량 운행 가능 여부
- **인허가 및 검사 기록:** 뉴저지에서는 주 보건부의 인허가 필요.

*시설의 인허가 여부와 최근 검사 결과 확인: [Healthapps.nj.gov/facilities](https://healthapps.nj.gov/facilities)

버겐 카운티 한인 어덜트 데이 케어 센터

시설명	주소	연락처
<u>수선화 데이케어 (Bergen Adult Day Care Center)</u>	139 E Central Blvd, Palisades Park, NJ 07650	201-907-4680
<u>버겐한국요양원 (Bergen New Bridge Medical Center)</u>	230 E Ridgewood Ave, Paramus, NJ 07652	201-967-4000
<u>브로드웨이 성인데이케어센터 (Broadway Adult Day Care)</u>	24-20 Broadway, Fair Lawn, NJ 07410	201-797-1177
<u>골든 데이 케어 (Golden Adult Day Care)</u>	53-57 West Fort Lee Road, Bogota, NJ 07603	201-457-1007
<u>마그놀리아 어덜트 데이케어 (Magnolia Adult Day Care)</u>	2300 3rd Street, Fort Lee, NJ 07024	201-482-4500
<u>마이홈 데이케어 (My Home Adult Day Care Center Inc)</u>	37 Brook Avenue, Maywood, NJ 07607	201-291-8811
<u>정원 어덜트 메디컬 데이케어 (New Jersey Day Care Center-Serenity Gardens)</u>	105 Challenger Road, 6th Fl, Ridgefield Park, NJ 07660	201-773-9090
<u>뉴라이프 어덜트 메디컬 데이케어 (New Life Adult Medical Day Care)</u>	340 Evelyn Street, Paramus, NJ 07652	201-265-0606
<u>우리집 데이케어 센터 (Our Home Adult Day Care)</u>	475 Grand Avenue, Englewood, NJ 07631	201-731-3636
<u>수선화 시니어 데이케어 센터 (Peaceful Adult Medical Day Care Center)</u>	101 Industrial Avenue, Suite C & B, Little Ferry, NJ 07643	201-870-6265
<u>Sunshine Adult Day Health Care Center</u>	16 N. Washington Avenue, Bergenfield, NJ 07621	201-387-8500

참고 자료

- [Eldercare Locator \(ACL\) — 가까운 어덜트 데이케어 시설 찾기](#)
- [NIA.gov — 재가 서비스 및 어덜트 데이케어 선택 가이드](#)
- [NJ DHS — 뉴저지 MLTSS 프로그램 안내](#)
- [Bergen County Key Service Guide \(어덜트 데이 케어 정보 제공\) \(PDF\)](#)

호스피스 케어(Hospice Care)

호스피스 케어는 치료가 어려운 말기 환자가 남은 시간을 통증 없이 존엄하게 보낼 수 있도록 돕는 완화 의료(comfort care) 서비스입니다. 질병 자체를 고치기보다는 증상을 조절하고 환자와 가족의 심리적·영적 안정을 돕는 데 집중합니다.

서비스 유형 및 장소

호스피스는 특정 장소가 아니라 환자가 있는 곳 어디서나 제공되는 서비스입니다.

- **제공 장소:** 환자의 자택(가장 일반적), 어시스티드 리빙 시설, 널싱홈, 호스피스 전문 시설, 병원 등. 호스피스 케어팀이 판단하는 경우 단기 병원 입원도 가능합니다.
- **팀 기반 케어:** 의사, 간호사, 사회복지사, 상담가, 자원봉사자가 하나의 팀으로 환자와 가족의 신체적·정서적·사회적·영적 필요를 함께 돌봅니다.

비용 및 보험 적용

메디케어 (파트 A)

- **자격 요건 (아래 조건 모두 충족 시):**
 1. **말기 진단:** 호스피스 담당 의사와 주치의(있는 경우)가 질병이 정상적 경과를 따를 때 기대 수명이 **6개월 이하**라고 공동 인증해야 합니다. 주치의가 없는 경우 호스피스 담당 의사 단독 인증도 가능합니다.
 2. **호스피스 선택 선언:** 말기 질환에 대해 호스피스 케어를 선택하겠다는 선언서(Election Statement)에 서명해야 합니다.
 3. **인증 기관 선택:** 메디케어(CMS)에서 정식으로 인증한 호스피스 제공 기관을 이용해야 합니다.

**기간: 메디케어 호스피스 혜택은 90일 기간 2회 + 이후 60일 기간 무제한으로 이용 가능합니다. 6개월 이후에도 의사 재인증(recertification) 시 60일 단위로 계속 이용할 수 있습니다.*

**메디케어 호스피스 본인 부담:*

- 커버드 서비스 전반: \$0 (디덕터블 없음)
- 통증 완화 처방약(외래): \$5 이하 코페이
- 간병인 휴식 지원(Respite Care): 메디케어 승인 금액의 5% 코인슈어런스

롱텀케어 메디케이드 (MLTSS)

- **혜택 범위:** 전문 간호, 의사 진료, 통증 완화 약물, 의료 기기 등을 전액(또는 아주 적은 공동부담금) 지원합니다.

- **숙식비(Room and Board):** 메디케이드 자격을 별도로 충족하는 경우 널싱홈 숙식비도 지원될 수 있습니다. 주마다 규정이 다르므로 반드시 확인이 필요합니다.

*자세한 내용은 [롱텀케어 메디케이드\(MLTSS\)](#) 에서 확인

널싱홈 내 호스피스 이용 시

널싱홈에서 거주하며 호스피스 케어를 받는 경우 비용 부담 체계가 다릅니다.

- **호스피스 의료비:** 메디케어가 전액 부담합니다.
- **널싱홈 숙식비(Room and Board):** 메디케어가 보장하지 않습니다. 본인이 자비로 부담하거나, 롱텀케어 메디케이드 자격을 별도로 충족하는 경우 메디케이드를 통해 지원받을 수 있습니다.

참전유공자 (VA) 혜택

미군 퇴역 군인(Veterans)은 VA 의료 시스템을 통해 호스피스 케어를 받을 수 있습니다.

- **수혜 조건:** VA 의료 시스템에 등록된 모든 재향군인은 임상적으로 호스피스가 필요하다고 판단되면 이용 가능합니다. 호스피스 혜택 자체는 서비스 연계 장애 등급이나 소득 기준과 무관하게 제공됩니다.
- **비용 부담:** VA 또는 VA 계약 기관 모두 본인 코페이가 없습니다.
- **제공 장소:** 자택, VA 외래 클리닉, VA 입원 시설(Community Living Center 포함), 또는 VA 계약 지역사회 호스피스 기관에서 제공받을 수 있습니다.

* VA 의료 시스템 등록 방법은 [VA.gov](#) 에서 확인

개인 보험 및 롱텀케어 보험 (Private Insurance)

- **혜택 범위:** 대부분의 민간 보험사는 메디케어의 호스피스 모델을 따르므로 혜택이 유사하지만, 본인 부담금(Deductible)이나 공동부담금(Copay)이 발생할 수 있습니다.
- **롱텀케어 보험 (LTC Insurance):** 가입한 약관에 따라 널싱홈이나 자택에서의 호스피스 비용을 일일 한도 내에서 보장합니다.

채리티 케어 (Charity Care / Uninsured)

보험이 없고 경제적으로 어려운 분들을 위한 마지막 안전망입니다.

- 많은 비영리 호스피스 기관들은 기부금이나 재단 기금을 통해 무료 또는 할인된 비용으로 케어를 제공합니다.
- 환자의 수입과 자산 규모에 따라 비용을 차등 적용합니다.

* 무보험 상태에서 호스피스 케어가 필요한 경우, 비영리 호스피스 기관 또는 담당 사회복지사를 통해 별도 재정 지원을 문의하세요. (NJ Charity Care 문의: 1-866-588-5696)

처방약 혜택 (Medicare Part D) — 메디케어 별도 혜택

2026년 기준, 메디케어 파트 D 가입자는 **파트 D 커버 처방약**에 대해 연간 본인 부담 상한선이 **\$2,100**으로 제한됩니다. 상한선 도달 후에는 해당 연도 말까지 추가 본인 부담 없음.

**호스피스 이용 중 참고: 말기 질환 관련 약물은 이미 메디케어 호스피스 혜택을 통해 처방전당 최대 \$5 copay로 커버됩니다. Part D 상한(\$2,100)은 주로 말기 질환과 무관한 처방약에 적용됩니다. 또한 플랜 보험료(premium)와 Part B 적용 약물 (일부 주사제 등)은 상한 산정에 포함되지 않습니다.*

처방약 혜택 (메디케어 파트 A 및 D) — 메디케어 환자 대상

- **말기 질환 관련 약물:** 메디케어 파트 A가 커버합니다. 최대 \$5 코페이만 지불합니다.
- **이외 처방약:** 메디케어 파트 D가 커버합니다. 연 **\$2,100(2026년 기준)**의 디덕터블이 발생합니다.
- **메디케어 어드밴티지(파트 C) 소지자:** 별도의 메디케어 파트 D 가입 없이도 기존의 플랜으로도 약값 플랜을 유지할 수 있습니다. .
- **엑스트라 헬프(Extra Help):** 메디케이드 소지자는 메디케어 파트 D 약값 지원을 통해 호스피스 무관 질환의 약값도 거의 무료로 받으실 수 있습니다.

호스피스 케어 시설 찾기

- 전국 시설 검색: [Medicare.gov/find nursing homes](https://www.medicare.gov/find-nursing-homes)
- 뉴저지: [NJ.gov/health/hospice/find-facility](https://www.nj.gov/health/hospice/find-facility)

**호스피스 서비스는 언제든지 본인의 의사에 따라 중단하고 일반 치료로 돌아갈 수 있으며, 나중에 다시 신청하는 것도 가능합니다.*

버겐카운티 내 한국인 직원 상주 호스피스 시설

시설명	위치	연락처
Family of Caring Healthcare at Park Ridge, LLC	120 Noyes Drive, Park Ridge, NJ 07656	201-505-1777
Holy Name Medical Center	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3756

선택 시 참고 사항

- **5성급 등급 확인 (5-Star Quality Rating)**
[Medicare.gov Care Compare](https://www.medicare.gov/care-compare)에서 각 시설의 5성급 등급을 확인하세요. 등급은 세 가지 도메인으로 구성됩니다.
 - 건강 검사 (Health Inspections)
 - 직원 배치 (Staffing)

- 품질 지표 (Quality Measures)

- **조사 결과 보고서 (Survey Report) 확인**

시설 내 비치된 가장 최근의 주 정부 조사 보고서를 요청하거나, [Medicare.gov Care Compare](#) 및 주 정부 웹사이트에서 온라인으로도 확인할 수 있습니다.

- **롱텀케어 옴부즈맨 (Ombudsman) 문의**

롱텀케어 옴부즈맨은 주지사가 임명하는 독립 옹호 기관으로, 롱텀케어 시설 거주자의 권리를 보호하고 학대·방치·불만 사항을 조사합니다. 거주자 본인, 가족, 관계자 누구든 문의할 수 있습니다.

참고 자료

- [Medicare.gov — 호스피스 케어 보장 범위](#)
- [Medicare.gov Care Compare — 호스피스 기관 검색 및 비교](#)
- [Medicaid.gov — 호스피스 케어](#)
- [NIA.gov — 완화 의료와 호스피스 케어](#)
- [VA.gov — 호스피스 케어 \(참전유공자\)](#)

롱텀케어 옴부즈맨 (Long Term Care Ombudsman)

롱텀케어 옴부즈맨(Long-Term Care Ombudsman, NJLTCO)은 노인법(Older Americans Act)에 근거하여 감독이나 통제를 받지 않으며 주지사가 직접 임명하는 독립 기관입니다. 옴부즈맨은 60세 이상의 노인을 포함한 롱텀케어 시설 거주자가 양질의 케어를 받고 학대, 방임 및 착취로부터 보호받을 수 있도록 돕습니다.

**옴부즈맨의 모든 서비스는 무료입니다.*

법적 권한과 역할

- **비밀 보장 민원 접수:** 전화, 팩스, 우편, 이메일, 온라인 폼을 통해 누구나 민원을 접수할 수 있습니다. 모든 상담은 철저히 비밀이 유지되며, 익명 신고도 가능합니다.
- **독자적 조사 및 회부:** 접수된 민원을 조사하여 직접 해결하거나, 필요한 경우 뉴저지 보건부(NJDOH) 또는 지역사회부(NJDCA) 등 관할 규제 기관에 사건을 인계합니다. 메디케이드 사기나 범죄가 의심될 경우 지방 경찰, 카운티 검사, 또는 NJ 법무장관실에도 회부할 수 있습니다.
- **무제한 접근권:** 롱텀케어 시설의 노인 거주자를 언제든지 만날 수 있으며, 해당 거주자의 의료 및 행정 기록을 열람할 수 있는 완전한 권한을 가집니다.
- **청문회 개최 및 서류 요구:** 필요 시 공개 또는 비공개 청문회를 열고, 관련 서류나 증언을 법적으로 요구할 수 있습니다.
- **자립 지원:** 거주자 및 가족 협회와 협력하여 롱텀케어 거주자가 스스로 권익을 찾을 수 있도록 지원합니다.

문제 해결 절차

1. **민원 접수:** 거주자나 대리인이 민원을 접수합니다 (익명 신고 가능). 민원은 사건 발생 후 **최대 3개월 이내에** 접수해야 합니다.
2. **배정:** 접수된 민원은 담당 수퍼바이저의 검토를 거쳐 현장 조사관(Field Investigator/Advocate)에게 배정됩니다.
**옴부즈맨은 긴급 구조 기관이 아닙니다. 즉각적인 위험이 있는 응급 상황은 즉시 911에 신고하세요.*
3. **현장 조사:** 조사관은 예고 없이 시설을 방문하여 거주자 본인의 동의를 얻은 후 조사를 시작합니다.
4. **사실 확인:** 관련 기록을 검토하고 시설 직원 및 증인들과 인터뷰를 진행하여 객관적인 사실을 파악합니다.
5. **결과 조치:** 조사의 최우선 목표는 **거주자가 만족할 수 있는 방식으로 문제를 해결**하고, 거주자의 안전과 권리·존엄성이 지켜지도록 하는 것입니다. 학대나 방임이 확인되거나 의심될 경우, 관련 부서에 인계합니다.

**옴부즈맨은 현재 해당 시설에 거주 중인 분(또는 입원 후 복귀 예정인 분)만 지원 가능. 퇴소한 경우, 뉴저지 보건부(1-800-792-9770)에 문의*

주요 조사 대상

- **경제적 착취:** 자산 유용이나 금전적 피해.
- **부당한 전원 및 퇴소:** 절차를 무시한 강제 퇴소 명령.
- **부적절한 행동 제한 장치 사용:** 화학적·신체적 행동 제한 장치의 오남용.
- **학대 및 방임:** 신체적·언어적·정신적 학대, 신체·정신 건강 유지에 필요한 서비스 제공 거부, 불합리한 감금
- **낮은 서비스 품질:** 개인위생 관리 소홀, 도움 요청에 대한 느장 대응 등.
- **권리 및 존엄성 침해:** 거주자의 기본적인 인권이나 품위를 훼손하는 행위.

롱텀케어 옴부즈맨 주요 관할 시설

- 널싱홈 (Nursing Homes)
- 전문 재활 및 간호 시설 (Skilled Nursing & Rehab Facilities)
- 어시스티드 리빙 시설 (Assisted Living Facilities)
- 각종 어덜트 데이 케어 (Adult Day Care Centers)
- 주거형 건강 관리 시설 (Residential Health Care Facilities)
- 연속형 은퇴 주거 단지 (Continuing Care Retirement Community)
- 종합 병원 (Long-Term Acute Care Hospitals)
- 재향군인 병원 (Veterans' Hospitals)

*위 목록 외 시설의 문제는 아래 기관에 직접 문의하세요.

- **뉴저지 보건부(NJDOH):** 널싱홈·어시스티드 리빙 관련 / 1-800-792-9770
- **뉴저지 지역사회부(NJDCA):** 기타 시설 관련 / 609-984-1704

문의

- **뉴저지 롱텀케어 옴부즈맨 사무소 (NJ Long-Term Care Ombudsman)**
전화: 1-877-582-6995
- 팩스: 1-609-943-3479
- 이메일: ombudsman@ltco.nj.gov
- 온라인 민원: nj.gov/ooie/contact/contact-complaint.shtml
- 우편: NJ Long-Term Care Ombudsman, P.O. Box 852, Trenton, NJ 08625-0852

*응급 상황 시 즉시 911에 신고하세요.

참고 자료

- [NJ.gov 롱텀케어 옴부즈맨 공식 웹사이트](#)
- [NJ.gov 옴부즈맨 민원 접수 방법 안내](#)
- [NJ Department of Health — 롱텀케어 시설 검색](#)
- [ACL.gov — 전국 롱텀케어 옴부즈맨 프로그램 안내](#)

넬싱홈 케어 (Nursing Home Care)

넬싱홈은 24시간 전문 간호 인력이 상주하며 의료 처치와 일상생활 돌봄을 동시에 제공하는 시설입니다. 정부는 입소자의 안전과 케어 품질을 위해 엄격한 기준을 적용하고 있습니다.

주요 서비스

- **의료 및 간호:** 전문 간호사의 투약 관리, 상처 치료, 혈압 및 당뇨 체크 등.
- **재활 치료:** 신체 기능 회복을 위한 물리 치료, 작업 치료, 언어 치료.
- **일상 지원:** 스스로 하기 힘든 식사, 목욕, 옷 입기, 이동 지원.
- **식단 및 관리:** 영양사가 설계한 맞춤형 식단과 24시간 안전 모니터링.

비용 및 보험 적용

단기 요양

넬싱홈은 평생 거주하는 곳이라는 인식과 달리, 수술이나 입원 후 저하된 기력을 회복하고 안전한 귀가를 돕는 **전문 단기 재활 센터**로서의 역할을 함께 수행합니다.

*단기 요양시 비용 및 보험 적용은 [전문 재활 및 간호 서비스](#)에서 확인

장기 요양: 롱텀케어 메디케이드 (MLTSS)

메디케어의 100일 혜택이 끝난 후에도 계속 요양 시설 거주가 필요한 경우, 메디케이드 가입 환자는 롱텀케어 메디케이드를 통해 장기 지원을 받습니다.

- **보장 범위:** 메디케어와 달리 **기한 제한 없이** 장기 거주 비용(Room and Board)과 일상생활 보조 비용을 지원합니다.
- **재정적 심사 (Financial Eligibility):**
 - **소득 및 자산:**
 - 소득: 월 \$2,982(2026년 기준).
 - 자산: 개인 기준 **\$2,000 이하** (부부 \$3,000 이하)
 - 제외 자산: 거주 중인 주택(뉴저지의 경우 \$1,130,000 이하, 2026년 기준), 자동차 1대, 개인 소품 등.
 - **5년 조사 (5-Year Look-back):** 신청 시점으로부터 과거 5년간 자산을 가족에게 증여하거나 저가로 매각한 기록이 있는지 조사합니다.
- **임상적 심사 (Clinical Eligibility):**
 - 주정부에서 파견된 간호사가 환자의 상태를 직접 확인합니다.
 - 식사, 목욕, 이동 등 일상생활(ADLs) 중 최소 3가지 이상에서 타인의 도움이 반드시 필요하다는 판정을 받아야 합니다.

*배우자가 있는 경우, [커뮤니티 배우자\(Community Spouse\)](#)는 별도 자산 보호 기준(CSRA)에 따라 최대 \$162,660까지 자산을 보유할 수 있습니다(2026년 기준).

- **비용 구조:** 소득의 전부(개인 용돈 월 \$50 제외)를 시설 비용으로 납부하며, 부족한 나머지 금액을 롱텀케어 메디케이드가 지원합니다.

주의사항

- **신청 시점 및 소요 기간:** 단기 요양 종료 2~3개월 전부터 미리 준비합니다. 승인까지 3~9개월이 걸리고, 신청 시점으로 소급 적용됩니다.
- **단기 재활과 다름:** 이미 레귤러 메디케이드가 있더라도 롱텀케어 혜택을 받으려면 반드시 **MLTSS로의 전환 승인**을 따로 받아야 합니다.
- **전문가 상담 권장:** 5년 치 은행 기록 조사 등 심사가 매우 까다로우므로, 신청 전 반드시 전문 소셜 워커나 노인법 전문 변호사와 상담하시는 것이 안전합니다.

*자세한 내용은 [롱텀케어 메디케이드\(MLTSS\)](#)에서 확인

처방약 혜택 (메디케어 파트 D) — 메디케어 환자 대상

널싱홈에서 장기 요양 시 처방약은 메디케어 파트 D가 보장합니다.

- **본인 부담금 (2026):** 연 \$2,100. 상한선 도달 후에는 해당 연도 말까지 커버드 약품에 대한 추가 본인 부담 없음.
- **메디케어 어드밴티지(파트 C) 소지자:** 별도의 파트 D 가입 없이도 기존의 플랜으로도 약값 플랜을 유지할 수 있습니다.
- **파트 D 없는 환자:** 본인이 약값을 전액 부담하게 됩니다.
 - 널싱홈 거주자는 '**특별 가입 기간(SEP)**'에 해당하여 아무 때나 파트 D 보험을 가입하거나 본인에게 더 유리한 플랜으로 바꿀 수 있습니다.

널싱홈 시설 찾기

- 전국 시설 검색: [Medicare.gov Care Compare](#)
- 뉴저지 시설 검색: [healthapps.nj.gov/facilities/fssearch.aspx](#)

버겐카운티 주요 한국인 직원 상주 간호시설

시설명	위치	연락처
ExcelCare at Norwood	100 McClellan Street, Norwood, NJ 07648	201-768-6222
Family of Caring Healthcare at Park Ridge, LLC	120 Noyes Drive, Park Ridge, NJ 07656	201-505-1777
Holy Name Medical Center	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3756

선택 시 참고 사항

- **5성급 등급 확인 (5-Star Quality Rating)**

[Medicare.gov Care Compare](#)에서 각 시설의 5성급 등급을 확인하세요. 등급은 세 가지 도메인으로 구성됩니다.

- 건강 검사 (Health Inspections)
- 직원 배치 (Staffing)
- 품질 지표 (Quality Measures)

- **조사 결과 보고서 (Survey Report) 확인**

시설 내 비치된 가장 최근의 주 정부 조사 보고서를 요청하거나, [Medicare.gov Care Compare](#) 및 주 정부 웹사이트에서 온라인으로도 확인할 수 있습니다.

- **롱텀케어 옴부즈맨 (Ombudsman) 문의**

롱텀케어 옴부즈맨은 주지사가 임명하는 독립 옹호 기관으로, 롱텀케어 시설 거주자의 권리를 보호하고 학대·방치·불만 사항을 조사합니다. 거주자 본인, 가족, 관계자 누구든 문의할 수 있습니다.

입소자 및 가족이 알아야 할 권리

- **케어 플랜 참여:** 본인이나 가족이 치료 방향과 돌봄 계획 수립에 직접 참여할 권리.
- **자산 보호:** 본인의 자금을 스스로 관리하거나 시설에 관리를 맡길 때 투명하게 보고받을 권리.
- **부당 퇴소 방지:** 정당한 사유 없는 퇴소 조치에 대해 사전 서면 통보를 받고 항소할 권리.
- **학대 방지:** 신체적, 정신적 학대나 방치로부터 보호받을 권리. 학대로 지적된 시설은 [Medicare.gov Care Compare](#)에서 시설명 옆에 별도 경고 아이콘이 표시됩니다.

*자세한 내용은 [롱텀케어 옴부즈맨](#)에서 확인

참고 자료

- [NIA.gov](https://www.nia.gov) — [Assisted Living, Nursing Homes, and Other Residential Care](https://www.nia.gov)
- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov) [Care Compare: 전국 시설 검색 및 비교](https://www.medicare.gov)
- [NJ Department of Health \(nj.gov/health\)](https://nj.gov/health) — [뉴저지 롱텀케어 시설 검색](https://nj.gov/health)
- [뉴저지 롱텀케어 옴부즈맨 \(NJLTCO\)](https://www.njltpco.org).

전문 재활 및 간호 서비스 (Rehabilitation & Skilled Nursing)

전문 재활 및 간호 서비스는 질병, 부상 또는 장애로 인해 상실되거나 손상된 일상생활 기능과 기술을 유지, 회복, 향상 또는 악화 방지를 위한 전문 의료 서비스입니다.

65세 이상 시니어 또는 Medicare 대상 장애인을 포함하여, 수술·질병·부상에서 회복 중이며 일상으로의 복귀와 독립적인 생활을 목표로 하는 분들을 대상으로 합니다.

주요 서비스

- **Skilled Nursing (전문 간호):** 정맥 주사(IV), 상처 치료(Wound Care), 영양 공급 튜브 관리, 당뇨 및 복합 질환 모니터링 등 간호사 또는 전문 치료사의 기술이 필요한 처치.
- **Physical Therapy (물리 치료):** 보행 훈련, 근력 강화, 관절 가동 범위 회복 등 이동 능력 향상.
- **Occupational Therapy (작업 치료):** 식사, 옷 입기, 세면 등 일상적인 자립 생활을 위한 기능 재활
- **Speech Therapy (언어 치료):** 의사소통 회복 및 삼킴 장애(연하 곤란) 치료.

비용 및 보험 적용

서비스 유형에 따라 보험 적용 방식이 다릅니다. 메디케어는 두 가지 다른 재활 환경을 구분합니다.

- **전문 간호시설 (Skilled Nursing Facility):** 낄싱홈 내 단기 전문 케어
- **입원재활시설 (Inpatient Rehabilitation Facility):** 집중 재활 목적 입원형 재활 병원/병동

메디케어 (파트 A) — 단기 재활 중심

보장 조건 (아래 4가지 모두 충족 시)

1. **3일 연속 입원:** 전문 간호서비스의 경우 재활 시설 입소 전 최소 3일 연속 정식 병원 입원(Inpatient Admission) 기록 필수 (퇴원일 미포함). 정식 입원 전 응급실 체류 시간 및 관찰 케어(Observation Status) 기간은 3일 계산에서 제외됩니다. 입원재활시설에는 이 요건이 적용되지 않습니다.
*입원 상태 여부는 병원과 확인 필요
2. **30일 이내 입소:** 병원 퇴원 후 일반적으로 30일 이내에 재활 시설에 입소해야 합니다.
3. **전문 케어 필요 판단:** 담당 의사 또는 의료 제공자가 매일 전문 간호나 재활 치료가 필요하다고 판단해야 합니다. 해당 케어는 전문 간호사 또는 재활 치료사의 지도하에 제공되어야 합니다.
4. **메디케어 인증 시설:** 메디케어 인증을 받은 재활 시설에서 케어를 받아야 합니다.

본인 부담금 (혜택 기간 기준)

- **전문 간호시설 (Skilled Nursing Facility)**

- 1~20일: **\$0/일** (디덕터블 \$1,736, 입원 시 먼저 부담함)
- 21~100일: **\$217/일** 코인슈어런스 부담

- **입원재활시설 (Inpatient Rehabilitation Facility)**

- 1~60일: 디덕터블 **\$1,736** 먼저 부담 후 \$0/일
- 61~90일: **\$434/일**
- 91일 부터: **\$868/일**. 생애 예비일(Lifetime Reserve Days) 사용

*혜택 기간(Benefit Period)은 퇴원 후 전문 재활 및 간호 케어를 60일 연속으로 받지 않으면 종료됩니다. 새 혜택 기간이 시작되면 \$1,736 디덕터블을 다시 납부해야 합니다.

*시설 입소 중 발생하는 의사 진료비에는 메디케어 파트 B가 적용됩니다.

*코인슈어런스 수치는 매년 변동되므로 [Medicare.gov](https://www.medicare.gov)에서 최신 금액 확인 필요

*자세한 내용은 [메디케어 파트 A/B](#) 에서 확인

메디케어 어드밴티지 (파트 C) & 개인 보험

- **사전 승인:** 대부분의 메디케어 어드밴티지 및 개인 보험 플랜은 입소 전 사전 승인(Prior Authorization)을 요구합니다.

- 파트 C 가입 환자는 3일 입원 요건이 면제될 수 있습니다.
- 보험사와 계약된 지정 시설(In-network) 이용 시에만 혜택이 적용됩니다.

*사전 승인 절차, 입원 요건 여부는 플랜마다 상이하므로 사전에 개인 플랜 확인 필요

*자세한 내용은 [메디케어 파트 C](#) 에서 확인

메디갭 (Medigap)

메디갭 플랜 종류에 따라 21~100일 구간의 하루 \$217의 코인슈어런스를 지원합니다. 단, 모든 메디갭 플랜이 전문 간호 및 재활 시설 코인슈어런스를 커버하는 것은 아니므로 가입 전 플랜별 혜택을 반드시 비교해야 합니다.

* 메디갭은 재활 시설의 비의료적 장기 거주 비용(custodial care, room and board)은 커버하지 않음

*자세한 내용은 [메디갭\(Medigap\)](#) 에서 확인

메디케이드 (뉴저지 패밀리케어)

메디케어와 달리 메디케이드 가입 환자는 전문 재활 및 간호 시설 이용시 본인 부담금이 없습니다. 장기 요양으로 전환될 경우, 롱텀케어 메디케이드(MLTSS)로 변경됩니다.

* 64세 이하 뉴저지 패밀리케어 보유 환자가 재활이 장기화되어 100일을 넘기게 되면 롱텀케어 메디케이드(MLTSS)로 전환됩니다. 이때는 그동안 면제되었던 자산 심사가 새로 적용되므로 사전 대비가 필요합니다.

*자세한 내용은 [ACA 메디케이드](#) 에서 확인

개인 부담

보험 혜택이 종료되었거나 자격이 안 되는 경우 직접 비용을 지불합니다. 숙박비, 식비, 케어 비용 등이 포함되며 지역과 시설에 따라 비용 차이가 큼니다.

전문 재활 및 간호시설 찾기

- 전국 시설 검색: [Medicare.gov Care Compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- 뉴저지 시설 검색: [NJ.gov/health/ltc/find-facility](https://www.nj.gov/health/ltc/find-facility)

버겐카운티 주요 전문 재활 및 간호시설

시설명	위치	연락처
Bergen New Bridge Medical Center	Paramus	551-383-6019
Jewish Home at Rockleigh	Rockleigh	201-784-1414
Christian Health	Wyckoff	201-729-3711
The Actors' Fund Home	Englewood	201-871-8882
Emerson Health & Rehab Center	Emerson	201-265-3700
Maple Glen Center	Fair Lawn	201-797-9522
Oakland Rehabilitation & Healthcare Center	Oakland	201-337-3300

*각 시설의 정보는 [Medicare.gov Care Compare](https://www.medicare.gov/care-compare)에서 확인

참고 자료

- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov/care-compare): 전문 간호시설(SNF).
- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov/care-compare): 입원재활시설(IRF).
- [Medicare.gov: SNF 케어 비용 및 보장 범위 \(PDF\)](#).
- [Medicare.gov Care Compare](https://www.medicare.gov/care-compare): 전국 시설 검색 및 비교
- [CMS.gov](https://www.cms.gov): SNF 서비스 안내
- [Medicare.gov — 2026 메디케어 비용 요약 \(PDF\)](#).
- [Bergen County 주요 서비스 가이드 \(재활 시설 목록 포함\) \(PDF\)](#).
- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov/care-compare): Medigap 플랜 비교

PART II • 제 8 편

병원 케어 (Hospital Care)

Hospital Care

병원 및 응급 의료 서비스 이용 가이드: 앰불런스 응급 이송, 응급실(ER) 케어, 관찰 병동(Observation) vs 입원(Inpatient) 구분의 재정적 차이, 입원 재활 치료, 재택 의료 케어, 지역사회 보건, 사별 케어 (Bereavement Care).

본 부문 총 9개 상세 안내 문서 수록

구급차 서비스 (Ambulance Services)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조연이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

구급차 서비스는 환자의 건강 상태가 심각한 위험에 처해 있고 다른 수단으로는 안전한 이동이 불가능할 때, 병원이나 전문 간호 시설로 긴급 이송을 제공하는 서비스입니다. 이 서비스는 개인이 의료 시설로 이동하는 동안 즉각적인 의료 처치와 상태 안정을 위한 서비스를 받을 수 있도록 보장합니다.

의료적 응급 상황 정의(Emergency Medical Condition)

의료적 응급 상황이란 즉각적인 조치가 없으면 생명이나 신체 기능에 심각한 위험을 초래할 수 있는 상태로, 일반적인 보건 의식을 가진 사람이 상식적으로 판단했을 때 위험하다고 인정되는 상황을 의미합니다(Prudent Layperson Standard).

특히 구급차 서비스는 가슴 통증이나 호흡 곤란, 심각한 출혈, 의식 상실 등 환자의 생명이 위태롭거나 상태가 심각하여 일반 차량으로는 안전하게 이동할 수 없는 경우에 해당합니다.

보험 혜택

메디케어 파트 B

- **보장 기준:** 의료적으로 구급차가 반드시 필요한 상황일때 구급차 비용을 커버합니다.
- **비용급 상황 이송:** 투석이 필요한 말기 신부전 환자와 같이 구급차 이동이 의료적으로 필요하다는 의사의 소견서가 있는 경우 비용급 상황에서도 보장될 수 있습니다.
 - 비용급 이송이 30일내 여러번 발생할 경우 4회차부터는 메디케어의 사전 승인이 요구될 수 있습니다.
- **시설 제한:** 가장 가까운 적절한 시설로의 이송만 보장합니다. 환자의 요청으로 더 멀리 떨어진 시설로 이송할 경우, 발생하는 추가 비용은 환자가 부담해야 합니다.
- **항공 이송:** 지상 이송이 불가능한 지역이거나 먼 거리, 또는 심한 교통 정체와 같은 장애물로 인해 신속한 치료가 방해받을 수 있는 경우에 한해 비행기나 헬리콥터를 이용한 응급 이송이 보장됩니다.
- **부담 비용:** 환자는 디덕터블과 더불어 메디케어 승인 금액의 20% 코인슈어런스를 별도로 부담합니다. 파트 B의 코인슈어런스는 [Medigap](#) 을 통해 커버할 수 있습니다.

메디케어 어드밴티지 (파트 C)

- **보장 기준:** 오리지널 메디케어와 동일하게 의료적으로 구급차 이용이 반드시 필요한 응급 상황 시 지상 및 항공 구급차 비용을 보장합니다.

- **비용급 상황 이송:** 의사의 소견서가 있고 보험사의 사전 승인(Prior Authorization)을 받은 경우에 한해 보장됩니다. 일부 플랜은 일반 진료를 위한 비용급 운송(NEMT) 혜택을 추가로 제공하기도 합니다.
- **시설 제한:** 환자의 상태를 치료할 수 있는 **가장 가까운 적절한 시설**로의 이송만 보장하며, 네트워크 외부 업체나 더 먼 시설 이용 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
- **항공 이송:** 지상 이송이 불가능하거나 지연 시 환자의 상태가 위중해질 수 있는 긴급 상황에서만 보장되며, 지상 구급차보다 높은 부담금이 적용될 수 있습니다.
- **부담 비용:** 20% 코인슈어런스 대신 정해진 액수의 코페이를 지불하는 경우가 많으며, 연간 본인 부담 최대 한도(Maximum Out-of-Pocket)의 적용을 받습니다.

메디케이드

- **보장 기준:** 의료적 도움이 즉시 필요한 경우 지상 및 항공 구급차 서비스가 보장됩니다.
- **비용급 환자 이송(NEMT):** NJ FamilyCare 수혜자가 정기 진료, 투석, 재활 치료 등을 위해 병원을 오갈 때 제공되는 서비스입니다. 특별히 뉴저지에서 비용급 환자 이송은 **Modivcare(예약전화: 1-866-527-9933, tripcare.modivcare.com)**를 통해 조율됩니다. 진료를 위한 이동 서비스는 일반적으로 최소 2일 전에 미리 예약해야 합니다.

개인 보험

- **보장 기준:** 의료적 도움이 즉시 필요한 경우 지상 및 항공 구급차 서비스가 보장됩니다. 항공 구급차의 경우 플랜마다 조건이 다를 수 있습니다.
- **In-Network vs Out-of-Network:** 환자는 가입한 보험 플랜에 따라 정해진 코페이를 지불하게 됩니다. 뉴저지에서는 응급 상황 시 구급차 이용은 Out-of-Network 병원에서도 In-Network 비용을 지불합니다. 다만 구급차 서비스 In-Network 적용 기준은 주별로 상이할 수 있습니다.
- **사전 승인:** 응급 상황에는 필요하지 않지만, 시설 간 이송(예: 병원에서 전문 재활 센터로 이동)과 같은 비용급 상황에서는 보험사의 사전 승인(prior authorization)이 필요할 수 있습니다.

보험 유형별 구급차 커버 비용(2026)

보험 유형	디덕터블	코페이 및 코인슈어런스
메디케어 파트 B	\$283	메디케어 승인 금액의 20%
메디케이드	\$0	적격 서비스의 경우 통상 \$0
메디케어 어드밴티지 (파트C), 개인 보험	플랜별로 상이	플랜별로 상이; Out-of-network 병원도 In-network 비용 납부

***In-Network:** 보험사와 제휴된 의료기관 및 의료 제공자(의사, 전문 간호사, 물리 치료사 등).

***Out-of-Network** 는 보험사와 제휴되어있지 않기 때문에 본인 부담금이 크게 발생할 수 있습니다.

병원 및 의료기관 검색

- 미 전역 통합 리스트: [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- 뉴저지주 지역별 리스트: [Healthapps.nj.gov/facilities](https://www.healthapps.nj.gov/facilities)

버겐 카운티 내 응급 의료 센터

아래는 비응급 상황 연락처입니다. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 먼저 전화하세요.

병원 및 부서 이름	주소	전화번호	부서 웹사이트
버겐 뉴브릿지 병원 응급 센터 Bergen New Bridge Medical Center - Emergency Medical Services	230 East Ridgewood Avenue, Paramus, NJ 07652	201-967-4000	newbridgehealth.org/emergency-care
잉글우드병원 응급 센터 Englewood Health - Emergency Medical Services	350 Engle Street, Englewood, NJ 07631	201-894-3000	englewoodhealth.org/emergency-services
해켄색 패스캐벨리 병원 응급 센터 Hackensack Meridian Health Pascack Valley - Emergency Medical Services	250 Old Hook Road, Westwood, NJ 07675	201-383-1035	pascackmedicalcenter.com/emergency-care
해켄색 대학병원 응급실 Hackensack University Medical Center Emergency Medical Services	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-2000	hackensackmeridianhealth.org/emergency-care
홀리 네임 병원 구급대 Holy Name Medical Center BLS Ambulance	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org/emergencycare
밸리 병원 EMS 부서 The Valley Hospital EMS Fleet	4 Valley Health Plaza, Paramus, NJ 07652	201-447-8000	valleyhealth.com/emergency-services

참고 자료

- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov/care-compare): 구급차 서비스 (Medicare Part B)
- [NJ FamilyCare.org](https://www.njfamilycare.org)

- [NJ.gov: Modivcare 의료 이송 안내](#)

유가족 돌봄 (Bereavement Care)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

유가족 돌봄(Bereavement)은 사별 후 겪는 정신적·신체적 슬픔을 보듬는 과정으로, 전문가의 애도 상담이나 치료를 통해 상실의 고통을 건강하게 극복하도록 돕습니다. 사별의 아픔은 개인마다 차이가 있으나 가족과 주변의 지지, 그리고 적절한 심리 지원을 통해 일상으로의 회복을 지원받을 수 있습니다.

보험 혜택

메디케어 파트 A (Hospice Benefit)

- **보장 기준:** 유가족 돌봄은 시한부 판정(기대 수명 6개월 미만)을 받은 환자에게 제공되는 메디케어 호스피스 혜택에 포함되어 보장됩니다.
- **가족 지원:** 사회복지사, 성직자(채플린) 또는 사별 코디네이터가 유가족 또는 지인, 간병인에게 정서적·영적 지지를 제공하며, 이 상담 서비스는 환자 사망 후 최대 13개월까지 지속될 수 있습니다.
- **부담 비용:** 메디케어 인증 호스피스 프로그램을 통해 제공되는 유가족 돌봄에 대해서는 통상적으로 환자 및 유가족의 본인 부담금이 없습니다.

메디케어 어드밴티지 (파트 C)

- **보장 범위:** 메디케어 어드밴티지(파트 C)는 오리지널 메디케어(파트 A 및 B)가 제공하는 모든 혜택을 동일하게 보장합니다. 따라서 파트 A의 호스피스 혜택에 포함된 사별 케어 서비스가 동일하게 제공됩니다.
- **추가 혜택:** 일부 파트 C 플랜은 오리지널 메디케어에서 제공하는 기본 서비스 외에 '보충적 혜택(Supplemental Benefits)'을 통해 추가적인 Grief Counseling이나 유가족 지원 프로그램을 확대 제공하기도 합니다.
- **서비스 이용:** 파트 C 가입자가 호스피스 케어를 시작하더라도, 유가족 돌봄을 포함한 관련 서비스는 일반적으로 오리지널 메디케어(파트 A)를 통해 처리되며, 기존 파트 C 플랜은 기타 보충적 서비스나 처방약 보장(파트 D)을 지속적으로 관리합니다.
- **부담 비용:** 오리지널 메디케어의 호스피스 혜택을 통해 제공되는 표준 유가족 돌봄 서비스에 대해서는 일반적으로 유가족의 본인 부담금이 없습니다. 단, 플랜별로 제공되는 별도의 민간 상담 네트워크 이용 시에는 해당 플랜의 규정에 따릅니다.

메디케이드

- **호스피스 케어:** 의료적 필요성 기준을 충족하는 경우 유가족을 위한 유가족 돌봄을 포함한 호스피스 서비스를 보장합니다.
- **비용 분담:** 뉴저지 메디케이드 수혜자는 호스피스 팀을 통해 제공되는 유가족 돌봄 등 관련 서비스에 대해 일반적으로 본인 부담금이 없습니다.
- **완화 의료:** 지역사회 기반 완화 의료(CBPC) 혜택은 중증 질환을 가진 NJ FamilyCare 수급자(말기 진단 불필요)에게 증상 관리, 간병인 지원, 심리사회적 상담 등을 제공합니다. 호스피스와는 별도로 운영되며, 현재 치료를 유지하면서도 이용 가능합니다.

개인 보험

- **호스피스 혜택:** 대부분의 민간 보험 플랜은 메디케어의 지침을 따라 유가족 돌봄을 포함하는 호스피스 혜택을 제공합니다.
- **정신 건강 보장:** 호스피스 프로그램과 별개로 상담을 받을 경우, 해당 보험 플랜의 외래 정신 건강 보장 규정이 적용됩니다. 연방 법률에 따라 이러한 서비스는 일반 진료나 수술 혜택과 차별 없이 동등한 수준으로 보장받을 수 있습니다.
- **보장 연속성:** 가입자 사망으로 인해 보험 보장이 종료된 피부양자는 60일 이내에 새로운 보험 가입을 신청할 수 있는 특별 가입 기간(Special Enrollment Period)이 적용될 수 있습니다(마켓플레이스 플랜 기준). 고용주 플랜 피부양자는 COBRA 등 별도 옵션을 확인하시기 바랍니다.

보험 유형별 비용 분담 (2026)

보험 유형	디덕터블	코페이 및 코인슈어런스
메디케어 파트 A (호스피스)	호스피스의 경우 \$0	사별 상담의 경우 \$0
메디케이드	\$0	보장된 호스피스/사별 서비스의 경우 통상 \$0
메디케어 어드밴티지 (파트C), 개인 보험	플랜별로 상이	플랜별로 상이 ; 호스피스 서비스는 대개 본인 부담이 낮거나 \$0임

버겐 카운티 내 호스피스 및 사별 케어 제공 기관

병원 및 기관 이름	주소	전화번호	웹사이트
패밀리 오브 케어링 호스피스 Family of Caring Healthcare at Park Ridge *한국인 직원 상주	120 Noyes Drive, Park Ridge, NJ 07656	201-505-1777	familyofcaring.com/family-of-caring-at-park-ridge
홀리네임 병원 호스피스 Holy Name Hospice *한국인 직원 상주	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org
밸리 병원 호스피스 Valley Hospice	15 Essex Road, Paramus, NJ 07652	201-447-8000	valleyhealth.com
해켄색 대학 병원 호스피스 Hackensack University Medical Center Hospice	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-2000	vhackensackmeridianhealth.org
이노블 케어 (가정 방문) Ennoble Care	Serving Bergen County	800-548-3249	ennoblecare.com

문의

- 988lifeline.org 위기 상담 지원 핫라인 988 (전화 또는 문자)
- [AARP Grief and Loss Program](http://AARP.org): 800-687-2277
- [Vantage Health – Survivors After Suicide](http://VantageHealth.org) : 201-385-4400 / info@vantagejnj.org

참고 자료

- Medicare.gov: 호스피스 케어
- NJFamilyCare.org 개요
- [SAMHSA: Grieving Resources](http://SAMHSA.org)
- [NJ 211.org](http://NJ211.org)

커뮤니티 클리닉 (Community Clinics & Free Healthcare)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

보험이 없거나 경제적 여유가 없는 주민들을 위해 지역사회 클리닉에서 고품질의 의료 및 치과 서비스를 제공합니다. 이 기관들은 모든 지역 사회 구성원이 필수적인 의료 서비스를 받을 수 있도록 소득에 따른 차등 요금제(Sliding Fee Scale) 또는 무료 서비스를 운영하고 있습니다.

자선 클리닉 (Free and Charitable Clinics)

취약 계층 및 무보험자를 위해 의료, 치과, 검안, 정신 건강 서비스 등을 무료 혹은 저비용으로 제공하는 자원봉사자 기반 비영리 클리닉입니다.

- **Bergen Volunteer Medical Initiative (BVMI):** 버겐 카운티의 저소득 근로 무보험 성인(Working Uninsured)을 위해 무료 일차 진료(Primary Care), 예방·긴급 케어 및 전문의 연계 서비스를 제공하는 자원봉사자 기반 비영리 클리닉입니다. 만성 질환 관리, 여성 건강, 정신 건강 서비스를 포함합니다.
 - **자격 요건 (모두 만족):** 버겐 카운티 거주 성인(18세 이상) | 가구내 근로자 1인 이상 | 연방빈곤선(FPL) 250% 이하 소득 | 건강보험 미가입자 (메디케어·메디케이드 포함)

**자선 클리닉마다 자격 요건과 서비스 상이.*

이동 진료 서비스 (Mobile Health Units)

병원 방문이 어려운 지역 주민들을 위해 의료 장비를 갖춘 차량이 직접 찾아가 현장 진료를 제공합니다.

- **Zufall Health Mobile Medical:** 모리스, 워렌, 서섹스, 헌터돈, 에식스, 서머셋, 미들섹스 카운티 지역에 검진 및 일차 진료, 치과 서비스 등을 제공하는 이동식 클리닉입니다.

연방 공인 의료 센터 (Federally Qualified Health Centers, FQHC)

연방 공인 의료 센터(FQHC)는 미 보건자원서비스국(Health Resources and Services Administration, HRSA)으로부터 인증·지원을 받는 지역사회 기반 의료 기관으로 지역사회 주민들에게 종합적인 의료 서비스를 제공합니다.

연방 공인 의료 센터 이용 자격 요건은 기관마다 거의 동일합니다: 누구나 이용 가능 | 보험 미가입자는 소득이 연방빈곤기준(FPL) 200% 이하일 경우 소득 및 가족 수에 따른 진료비 책정 | 저소득층은 거의 무료로 가까운 요금만 부과 | 메디케어, 메디케이드, 개인 보험 수용

- **North Hudson Community Action Corporation Health Center (NHCAC):** 버겐 및 허드슨 카운티 내 여러 지역에서 운영됩니다. 성인 진료, 소아과, 치과 및 행동 건강 서비스를 제공합니다.

- **Zufall Health Center:** 모리스, 워렌, 서섹스, 헌터돈, 에섹스, 서머셋, 미들섹스 카운티 등에 저렴한 의료 서비스를 제공합니다. 일차 진료, 치과 서비스 및 만성 질환 관리를 전문으로 합니다.

종합병원 기반 서비스 및 지원

종합병원은 일반 의료 서비스 외에도 부속 외래 클리닉, 이동 진료 서비스, 병원비 지원 프로그램 등 지역사회 저소득층 주민 지원 프로그램을 제공합니다.

종합병원 부속 클리닉 (Hospital-Run Clinics)

- **Valley Health Family Care Center (Ridgewood):** 밸리 병원에서 운영하는 저비용 외래 클리닉(Outpatient Clinic)으로 경제적 여건이나 보험 유무와 관계없이 모든 연령대의 환자에게 양질의 의료 서비스를 제공합니다. 일차 진료(Primary Care)를 중심으로 소아과, 산부인과 검진, 만성 질환 관리 및 복약 상담 등 통합적인 케어를 지원합니다. 다국어 서비스와 상담원을 제공합니다.
- **Hackensack MH Internal Medicine Academic Practice (Hackensack):** 해켄색 대학 병원의 수련의들(Resident Doctors)이 전문의의 지도하에 진료를 제공하는 교육 기관 기반의 클리닉입니다. 성인 환자를 대상으로 내과 질환 관리 및 예방 진료를 제공하며, 보험 미가입자나 저소득층을 위한 유연한 비용 체계를 갖추고 있습니다.
- **Hackensack MH Adult Health Center (Glen Ridge):** 해켄색 병원 Mountainside Medical Center 캠퍼스에서 운영하는 글렌릿지 소재의 지역사회 클리닉입니다. 저소득 및 무보험 성인 환자 대상으로 일차 진료, 검진, 만성 질환 케어 등의 서비스를 제공합니다.

병원비 지원 프로그램 (Charity Care)

병원비 지원 프로그램(Charity Care)은 건강보험이 없거나 혜택이 부족한 저소득층을 위해 주 정부가 지정한 종합병원(Acute Care Hospitals)에서 제공하는 병원비 감면 프로그램입니다. Charity Care 는 보험은 아닙니다.

커뮤니티 클리닉 검색

- 전국자선클리닉 검색: NAFCclinics.org/find-clinic
- 연방공인의료센터(FQHC) 검색: HRSA.gov/Find a Health Center
- 뉴저지주 무료/저비용 의료 서비스 검색: NJ.gov/Free or Low Cost Medical Treatment
- 뉴저지주 커뮤니티 의료 기관 검색: <https://healthapps.nj.gov/fhs>

북부 뉴저지 커뮤니티 클리닉

기관	기관 유형	주소	전화번호	웹사이트
Bergen Volunteer Medical Initiative (BVMI)	자선 클리닉	75 Essex Street, Suite 100 Hackensack, NJ 07601	201-342-2478	bvmi.org
NHCAC Health Center - Englewood	연방 공인 의료 센터 (FQHC)	197 South Van Brunt Street Englewood, NJ 07631	201-210-0200 (대표전화)	nhcac.org
NHCAC Health Center - Hackensack	연방 공인 의료 센터 (FQHC)	25 East Salem Street Hackensack, NJ 07055	201-210-0200 (대표전화)	nhcac.org
NHCAC Health Center - Garfield	연방 공인 의료 센터 (FQHC)	535 Midland Ave Garfield, NJ 07026	201-210-0200 (대표전화)	nhcac.org
NHCAC Health Center - Passaic	연방 공인 의료 센터 (FQHC)	220 Passaic Street Passaic, NJ 07055	201-210-0200 (대표전화)	ennoblecare.com
NHCAC Health Center - West New York (Main Site)	연방 공인 의료 센터 (FQHC)	5301 Broadway West New York, NJ 07093	201-210-0200 (대표전화)	ennoblecare.com
Zufall Health Center - Morristown	연방 공인 의료 센터 (FQHC)	4 Atno Ave Morristown, NJ 07960	973-267-0002	zufallhealth.org
Zufall Health Center - Newton	연방 공인 의료 센터 (FQHC)	238 Spring Street Newton, NJ 07860	973-862-6650	zufallhealth.org

기관	기관 유형	주소	전화번호	웹사이트
Zufall Health Center - Plainsboro	연방 공인 의료 센터 (FQHC)	One Plainsboro Road Plainsboro, NJ 08536	609-853-7600	zufallhealth.org
Zufall Health Center - West Orange	연방 공인 의료 센터 (FQHC)	49 Mount Pleasant Ave West Orange, NJ 07052	973-325-2266	zufallhealth.org
Zufall Health Center - Mobile Medical	연방 공인 의료 센터 (FQHC) 이동식 클리닉	Middlesex, Morris, Sussex, Warren, Hunterdon, Somerset, and Essex Counties	973-328-3344	zufallhealth.org/about-us/locations/zufall-health-mobile-medical/
Valley Health Family Care Center	종합병원 부속 클리닉	223 N. Van Dien Ave Ridgewood, NJ 07450	201-689-3900	valleyhealth.com/services/family-care-center
Hackensack MH Internal Medicine Academic Practice	종합병원 부속 클리닉	385 Prospect Ave Suite 204 Hackensack, NJ 07061	551-996-9150	getcare.hackensackmeridianhealth.org/en/locations/hmh-internal-medicine-academic-practice-hackensack
Hackensack MH Mountainside Medical Center - Adult Health Center	종합병원 부속 클리닉	123 Highland Ave. Suite 201 Glen Ridge, NJ 07028	862-333-4700	mountainsidemedicalcenter.com/services/adult-health-center

참고 자료

- HRSA.gov 보건자원서비스국
- nafcclinics.org 전국자선클리닉협회
- NJ.gov – Charity Care 공식 안내

응급실 케어 (Emergency Room Care)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

응급실(Emergency Department) 서비스는 갑작스러운 질병이나 부상에 대해 즉각적인 평가와 치료를 제공합니다. 이러한 서비스는 환자의 건강이나 생명이 위험하여 상태를 안정시키기 위해 신속한 의료 개입이 필요한 경우에 필수적입니다.

보험 혜택

메디케어 파트 B

- **보장 기준:** 응급실 서비스는 일반적으로 메디케어 파트 B에 따라 외래 환자 서비스(outpatient)로 분류됩니다. 이는 환자가 관찰을 위해 응급실에서 하룻밤을 머무는 경우에도 적용됩니다.
- **관찰 서비스 (Observation Services):** 환자는 입원 치료가 필요한지 결정하기 위해 임상 의사결정 유닛(Clinical Decision Unit) 또는 관찰 상태에 머물 수 있습니다. 관찰 상태는 외래 서비스로 분류되어 파트 B가 적용되며 입원 필요 여부 결정은 통상 24~48시간 이내에 이루어집니다.
- **입원 치료로 전환:** 의사가 응급실 방문 후 3일 이내에 관련 질환으로 동일 병원에 정식 입원(inpatient)하게 되면 응급실 방문 코페이는 청구되지 않습니다. 입원 서비스는 메디케어 파트 A로 보장됩니다.
- **부담 비용:** 환자는 **파트 B 디덕터블(\$283; 2026년 기준)** 충족 후, 응급실 방문 코페이, 부수적인 응급 의료 서비스(X-ray 촬영, CT 스캔, 심전도-EKG 등) 코페이, 의사 서비스에 대한 메디케어 승인 금액 등 각각의 비용에 대해 20% 코인슈어런스를 부담합니다. 파트 B의 코인슈어런스는 [Medigap](#) 을 통해 커버할 수 있습니다.
- **처방약 보장 제외:** 응급실이나 관찰 병동에서 복용하는 처방약(평소 복용약 포함)은 파트 B가 아닌 **파트 D 플랜**으로 커버됩니다. 병원 약국이 환자 파트 D 플랜의 Out-of-network 일 경우, 비용을 전액 선결제한 후 보험사에 청구(Reimbursement)를 해야 할 수도 있습니다.

* 부수적인 응급 의료 서비스의 코페이는 당해 연도 파트 A 디덕터블(\$1,736; 2026년 기준) 금액을 초과하지 않습니다. 다만 여러 종류의 검사와 처치를 동시에 받을 경우 합산 코페이 금액은 이 한도를 넘을 수 있습니다.

*오리지널 메디케어(파트 A와 파트 B)는 원칙적으로 미국 외 응급 서비스를 보장하지 않습니다(일부 예외 상황 제외).

메디케어 어드밴티지 (파트 C)

- **보장 기준:** 부상, 갑작스러운 질병 또는 급격히 악화되는 증상 등 의학적 응급 상황이 발생했을 때 사전 승인이나 진료의뢰 없이 응급실 진료를 보장합니다.
- **네트워크 제한 없음:** 응급 상황 시에는 보험사와 계약된 네트워크 내 병원이 아니더라도 미국 내 어디서나 동일한 혜택 수준으로 진료를 받을 수 있습니다.
- **입원 시 비용 면제:** 응급실 진료 후 동일 병원에 정식 입원(inpatient)이 되는 경우, 응급실 코페이가 면제되고 해당 플랜의 비용 체계가 적용됩니다. 단, 관찰 상태는 외래로 분류되어 별도 비용이 발생할 수 있습니다.

- **부담 비용:** 20%의 코인슈어런스 대신 플랜별로 정해진 코페이를 지불하며, 이는 2026년 기준 In-network 연간 본인 부담 최대 한도액인 **\$9,250(Maximum Out-of-Pocket, MOOP)**에 합산됩니다.

**일부 어드밴티지 플랜은 해외 응급 상황에 대한 추가 보장을 제공합니다. 플랜별로 보장 여부 및 한도가 다르므로 반드시 플랜 정보 확인 필요.*

메디케이드

- **보장 기준:** 의료적 도움이 즉각적으로 필요한 경우 응급실 방문을 보장합니다.
- **비용 분담:** 뉴저지의 경우 의료적 필요성 기준을 충족하는 응급실 서비스에 대해 메디케이드 수혜자는 통상적으로 본인 부담금이 없습니다.
- **사전 승인:** 응급실 서비스에는 사전 승인이 필요하지 않습니다.

개인 보험

- **보장 기준:** 대부분의 개인 보험 플랜은 응급실 방문을 보장합니다.
- **In-Network vs Out-of-Network:** 환자는 가입한 보험 플랜에 따라 정해진 코페이를 지불하게됩니다. 뉴저지에서는 응급 상황 시 Out-of-Network 병원에서도 In-Network 비용을 지불합니다.

보험 유형별 비용 분담 (2026)

보험 유형	디덕터블	코페이 및 코인슈어런스
메디케어 파트 B	\$283	응급실 방문 코페이 + 의사 진료비 및 개별 검사에 대한 각각 20% 코인슈어런스
메디케이드	\$0	응급 서비스의 경우 통상 \$0
메디케어 어드밴티지 (파트C), 개인 보험	플랜별로 상이	플랜별로 상이; Out-of-network 병원도 In-network 비용 납부

**In-Network:* 보험사와 제휴된 의료기관 및 의료 제공자(의사, 전문 간호사, 물리 치료사 등).

**Out-of-Network* 는 보험사와 제휴되어있지 않기 때문에 본인 부담금이 크게 발생할 수 있습니다.

병원 및 의료기관 검색

- 미 전역 통합 리스트: [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- 뉴저지주 지역별 리스트: [Healthapps.nj.gov/facilities](https://www.healthapps.nj.gov/facilities)

버겐 카운티 내 응급 의료 서비스 제공 기관

아래는 비응급 상황 연락처입니다. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 먼저 전화하세요.

병원 및 부서 이름	주소	전화번호	부서 웹사이트
버겐 뉴브릿지 병원 응급 센터 Bergen New Bridge Medical Center Emergency Medical Services	230 East Ridgewood Avenue, Paramus, NJ 07652	201-967-4000	newbridgehealth.org/emergency-care
잉글우드병원 응급 센터 Englewood Hospital and Medical Center Emergency Medical Services	350 Engle Street, Englewood, NJ 07631	201-894-3000	englewoodhealth.org/emergency-services
해켄색 패스캐 밸리 병원 응급 센터 Hackensack Meridian Health-Pascack Valley Emergency Medical Services	250 Old Hook Road, Westwood, NJ 07675	201-383-1035	pascackmedicalcenter.com/emergency-care
해켄색 대학 병원 응급실 Hackensack University Medical Center Emergency Medical Services	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-2000	hackensackmeridianhealth.org/emergency-care
홀리 네임 병원 구급대 Holy Name Medical Center BLS Ambulance	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org/emergencycare
밸리 병원 응급 부서 The Valley Clinical Decision Unit	4 Valley Health Plaza, Paramus, NJ 07652	201-447-8000	valleyhealth.com/services/emergency-services

참고 자료

- [Medicare.gov: 응급실 비용 커버 안내](https://www.medicare.gov/emergency-costs)
- [Medicare.gov: 외래 서비스 커버 안내](https://www.medicare.gov/long-term-services)
- [NJ FamilyCare \(메디케이드\)](https://www.njfamilycare.com/)

입원 (Inpatient Admission)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

입원(Inpatient Admission)은 의사의 정식 입원 지시(Order)에 따라 병원에 입원한 환자에게 제공되는 의료 서비스를 의미합니다. 입원은 일반적으로 위중한 상태, 수술, 또는 하룻밤 이상 병원 치료와 의료진의 지속적인 모니터링이 필요한 경우에 해당합니다.

입원의 기준

환자는 의사의 입원 지시에 따라 정식으로 병원에 입원하는 순간부터 입원 환자로 간주됩니다. 응급실을 포함하여 병원 침대에서 하룻밤을 보냈다고 해서 자동으로 '입원 환자'가 되는 것은 아닙니다. 환자가 관찰 병동 케어(Observation Status)인 상태라면 외래 환자(Outpatient)로 분류될 수 있으며, 이는 본인 부담 비용과 전문 재활 및 간호 시설(Rehab & Skilled Nursing Facilities) 이용 시 메디케어(Medicare) 보장 여부에 영향을 미칠 수 있습니다. 관찰 병동에 머문 기간은 전문 재활 및 간호 시설에서 요구하는 3일 연속 입원 요건에 포함되지 않습니다.

보험 혜택

메디케어 파트 A (병원 시설 비용)

- **보장 범위:** 2인실 침대, 식사, 일반 간호, 입원 치료의 일부로 제공되는 약품, 기타 병원 서비스 및 용품을 보장합니다. (단, 개인실 사용이나 개인 간병인 등은 보장되지 않습니다.)
- **부담 비용:** 입원 디덕터블(\$1,736; 2026년 기준)을 환자가 먼저 부담합니다. 나머지는 파트 A에서 부담합니다.
- **혜택 기간:** 혜택 기간(Benefit Period)은 입원이 공식적으로 인정된 날부터 시작되며, 퇴원 후 60일 이내에 재입원하면 이전 입원과 하나의 주기로 합산되어 계산됩니다. 반면 퇴원 후 60일을 넘겨 재입원하면 새로운 혜택 주기가 시작되어 입원 디덕터블 \$1,736도 다시 발생합니다. 혜택 기간 횟수에는 제한이 없습니다.
- **일생의 예비일 (Lifetime Reserve Days):** 한 혜택 기간 내 입원이 90일을 넘길 때 사용할 수 있는 보너스 일수로, 평생 총 60일까지 추가 보장 혜택이 제공됩니다. 예비일을 모두 소진한 후에는 입원 비용 전액을 본인이 부담해야 합니다.

메디케어 파트 B (의사 진료 비용)

- **보장 범위:** 입원 중 받는 의사 진료 및 수술 서비스를 보장합니다.
- **부담 비용:** 연간 디덕터블(\$283; 2026년 기준)을 환자가 먼저 부담합니다. 이후 일반적으로 의사 진료비의 80%를 파트 B에서 부담하고 나머지 20%는 본인이 부담합니다.

*병원에 입원 중임에도 의사 비용은 파트 A 가 아닌 파트 B에서 별도로 청구됩니다.

메디케어 어드밴티지 (파트 C)

- **보장 범위:** 2인실 침대, 식사, 일반 간호, 입원 치료의 일부로 제공되는 약품, 기타 병원 서비스 및 용품을 보장합니다. 단, 개인실 사용이나 개인 간병인 등은 보장되지 않습니다.
- **사전 승인 (Prior Authorization):** 응급실을 통한 긴급 입원이 아닌 경우, 대부분의 어드밴티지 플랜은 입원 전 보험사의 사전 승인(PA)을 요구합니다. 승인 절차를 누락하면 비용 혜택이 제한될 수 있습니다.
- **In-Network 병원 이용:** 긴급 상황을 제외하고는 보험사와 계약된 In-network 병원을 이용해야 비용이 커버되며, 네트워크 밖 병원 이용 시 혜택이 보장되지 않거나 본인 부담금이 크게 발생할 수 있습니다.
- **부담 비용:** 오리지널 메디케어의 혜택 기간(Benefit Period) 방식 대신 입원 초기 며칠간 정해진 일일 copayment를 내는 플랜이 많습니다. 이후 기간은 보통 무료이며, 모든 비용은 연간 본인 부담 최대 한도(Maximum Out-of-Pocket)의 적용을 받습니다. 입원 비용 구조는 플랜마다 다르니 반드시 플랜 정보를 확인하세요.

메디케이드

- **보장 기준:** 메디케이드는 수혜 자격이 있는 거주자에게 의학적으로 필요한 모든 입원 진료 서비스를 보장합니다.
- **비용 분담:** 메디케이드 수혜자는 입원 서비스에 대해 통상적으로 본인이 부담하는 copayment가 없거나 매우 적습니다.
- **사전 승인:** 응급 상황이 아닌 선택적 입원의 경우, 해당 의료 시설이 의학적으로 적합한지 확인하기 위해 보험 플랜 또는 주 정부의 사전 승인이 필요할 수 있습니다.

* OBBBA(One Big Beautiful Bill Act) 법안 시행에 따라 메디케이드 자격 및 내용이 달라질 수 있으므로 [공식 웹사이트](#)에서 확인하세요.

개인 보험

- **보장 기준:** 대부분의 개인 보험 플랜은 입원 치료를 보장하지만, 응급 입원이 아닌 경우 사전 승인(Prior Authorization)을 요구하는 경우가 많습니다.
- **In-Network vs. Out-of-Network:** 네트워크 내 병원을 이용할 때 비용이 훨씬 저렴합니다. 네트워크 밖 병원 입원은 본인 부담금이 훨씬 높거나 선택적 수술의 경우 전혀 보장되지 않을 수 있습니다.
- **부담 비용:** 입원 초기 며칠간 정해진 일일 copayment를 내거나 입원 횟수당 정해진 deductible을 한 번에 부과하기도 합니다. 입원 비용 구조는 플랜마다 다르니 반드시 플랜 정보를 확인하세요.

보험 유형별 비용 분담 (2026)

보험 유형	디덕터블	코페이 및 코인슈어런스
메디케어 파트 A (병원 시설 비용)	\$1,736 (혜택 기간당)	1~60일: \$0 61~90일: 1일당 \$434 91일 이후: 1일당 \$868 (예비일) 예비일 소진후 전액 본인 부담
메디케어 파트 B (의사 진료 비용)	\$283	의사 진료비의 20%
메디케이드	\$0	의학적으로 필요한 서비스의 경우 \$0
메디케어 어드밴티지 (파트C), 개인 보험	플랜별로 상이	플랜별로 상이

***In-Network:** 보험사와 제휴된 의료기관 및 의료 제공자(의사, 전문 간호사, 물리 치료사 등).

***Out-of-Network** 는 보험사와 제휴되어있지 않기 때문에 본인 부담금이 크게 발생할 수 있습니다.

병원 및 의료기관 검색

***In-Network:** 보험사와 제휴된 의료기관 및 의료 제공자(의사, 전문 간호사, 물리 치료사 등).

***Out-of-Network** 는 보험사와 제휴되어있지 않기 때문에 본인 부담금이 크게 발생할 수 있습니다.

버겐 카운티 내 입원 치료 서비스 제공 기관

아래는 비응급 상황 연락처입니다. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 먼저 전화하세요.

병원 이름	주소	전화번호	웹사이트
버겐 뉴브릿지 메디컬 센터 Bergen New Bridge	230 East Ridgewood Avenue, Paramus, NJ 07652	201-967-4000	newbridgehealth.org
잉글우드병원 Englewood Health	350 Engle Street, Englewood, NJ 07631	201- 894-3000	englewoodhealth.org
해켄색 패스캐벨리 병원 Hackensack Meridian Health Pascack Valley	250 Old Hook Road, Westwood, NJ 07675	201- 383-1035	pascackmedicalcenter.com
해켄색 대학 병원 (Hackensack University Medical Center)	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-2000	hackensackmeridianhealth.org
홀리 네임 병원 (Holy Name Medical Center)	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org
밸리 병원 (The Valley Hospital)	4 Valley Health Plaza, Paramus, NJ 07652	201-447-8000	valleyhealth.com

참고 자료

- [Medicare.gov](http://www.Medicare.gov): 입원 환자 병원 치료 보장 안내
- [NJ FamilyCare.org](http://www.NJFamilyCare.org): 혜택 개요

입원 재활 케어 (Inpatient Rehabilitation Care)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

입원 재활 치료는 수술, 질병, 부상 후 회복을 돕는 집중적인 의료 서비스입니다. 의사와 치료사로 구성된 전문 팀의 통합 관리가 이루어지며, 매일 최소 3시간 이상의 강도 높은 재활(물리·작업·언어 치료 등)을 꾸준히 소화할 수 있는 환자를 대상으로 제공됩니다.

보험 혜택

메디케어 파트 A

- **보장 기준:** 입원 후 의사가 환자의 상태에 대해 집중적인 재활 치료, 지속적인 의료 감독, 그리고 여러 분야의 전문가로 구성된 통합 케어가 반드시 필요하다고 인정한 경우에 보장됩니다. 이 경우 전문 재활 병원이나 일반 병원의 지정된 입원 재활 부서에서 제공되어야 합니다.
- **보장 범위:** 2인실 침대, 식사, 일반 간호, 입원 치료의 일부로 제공되는 약품, 기타 병원 서비스 및 용품을 보장합니다. (단, 개인실 사용이나 개인 간병인 등은 보장되지 않습니다.)
- **자격 요건:** 대부분의 시설에서 자격을 갖춘 병원 입원 후 재활 시설로 전원되는 것이 표준 요건입니다. 단, 입원 재활 시설 (inpatient rehabilitation facilities)의 경우 치료의 강도에 따라 입원을 위한 특정 임상 기준이 적용될 수 있습니다.
- **보장 기간:** 메디케어는 한 혜택 기간(Benefit Period)을 최대 100일까지 보장합니다. 입원한 날부터 혜택 기간이 시작되며, 퇴원 후 60일 이내에 재입원하면 이전 입원과 하나의 주기로 합산되어 계산됩니다. 반면 퇴원 후 60일을 넘겨 재입원하면 새로운 혜택 주기가 시작되어 입원 일수가 다시 1일부터 리셋되며 디덕터블도 발생합니다.
- **부담 비용:** 파트 A 디덕터블 완납 후, 첫 20일까지는 코인슈어런스가 무료입니다. 21일부터 100일까지는 일일 공동 부담금이 발생합니다.

메디케어 어드밴티지 (파트 C)

- **보장 기준:** 심각한 질병, 부상 또는 수술(뇌졸중, 고관절 골절 등) 후 집중적인 재활이 필요하다는 의사의 소견이 있고, 하루 3시간 이상의 고강도 치료를 견딜 수 있는 상태여야 보장됩니다.
- **입원 요건:** 입원 재활 시설을 이용하려면 의사의 처방이 필수적이며, 의사 및 재활 전문 간호사의 24시간 모니터링과 통합 케어가 필요하다고 인정되어야 합니다.
- **사전 승인 (Prior Authorization):** 입원 재활은 비용이 높기 때문에 어드밴티지 플랜은 거의 예외 없이 입원 전 보험사의 사전 승인을 요구합니다. 승인 과정에서 환자의 재활 의지와 개선 가능성을 엄격히 심사할 수 있습니다.
- **재활 시설 종류:** 보험사와 계약된 네트워크 내의 전문 재활 병원 또는 일반 병원 내 재활 병동을 이용해야 하며, 전문 간호 시설보다 더 집중적이고 전문적인 치료를 제공합니다.
- **부담 비용:** 오리지널 메디케어의 디덕터블 방식과 달리, 입원 초기 며칠간 일일 코페이를 내는 경우가 많습니다. 이후 기간은 보통 무료이며, 모든 비용은 연간 본인 부담 최대 한도(Maximum Out-of-Pocket) 내에서 보호받습니다.

메디케이드

- **보장 기준:** 의사가 처방하고 의료적으로 필요한 경우 입원 재할 서비스를 보장합니다. 보장 항목에는 일반적으로 숙식, 간호 관리 및 재할 요법이 포함됩니다.
- **비용 부담:** 메디케이드 수혜자는 입원 서비스에 대해 본인 부담금이 없습니다.
- **사전 승인:** 뉴저지의 대부분의 메디케이드 관리 보험사(MCO)는 재할 시설 입원 전에 보험사의 사전 승인을 요구합니다.

개인 보험

- **보장 기준:** 대부분의 민간 보험 플랜은 입원 재할을 보장하지만, 보장 기간과 시설 유형은 개별 정책(Policy)에 따라 다릅니다.
- **In-Network vs Out-of-Network:** 환자는 특정 서비스에 대해 부당한 추가 비용 청구로부터 보호받습니다. 다만, 비용 급 입원 재할 시 비용 부담을 줄이려면 반드시 보험사와 계약된 In-Network 시설을 이용해야 합니다.
- **임상 검토:** 보험사는 종종 실시간 진료 리뷰(Concurrent Review)를 요구하며, 이는 입원 치료의 지속적인 필요성을 확인하기 위해 환자의 회복 상태를 정기적으로 점검하는 절차입니다.

**In-Network: 보험사와 제휴된 의료기관 및 의료 제공자(의사, 전문 간호사, 물리 치료사 등).*

**Out-of-Network 는 보험사와 제휴되어있지 않기 때문에 본인 부담금이 크게 발생할 수 있습니다.*

비용 부담 (2026)

보험 유형	디덕터블	코페이 및 코인슈어런스
메디케어 파트 A	\$1,736 (혜택 기간당)	1~60일: \$0 61~90일: 1일당 \$434 91일 이후: 1일당 \$868 (예비일)
메디케이드	\$0	의학적으로 필요한 서비스의 경우 \$0
메디케어 어드밴티지 (파트C), 개인 보험	플랜별로 상이	플랜별로 상이

병원 및 의료기관 검색

- 미 전역 통합 리스트: [Medicare.gov/care-compare](https://www.Medicare.gov/care-compare)
- 뉴저지주 지역별 리스트: [NJ DOH.gov/Choose the Hospitals](https://www.NJDOH.gov/Choose%20the%20Hospitals)

버겐 카운티 내 재할 병동 정보

아래는 비응급 상황 연락처입니다. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 먼저 전화하세요.

병원 및 부서 이름	주소	전화번호	부서 웹사이트
앨런데일 재활 및 헬스케어 센터 Allendale Rehabilitation & Healthcare Center	85 Harreton Rd, Allendale, NJ 07401	(201) 825-0660	allendalehc.com
크리스천 헬스 단기 재활 센터 Christian Health Bolger Short-Term Rehab	301 Sicomac Ave, Wyckoff, NJ 07481	(201) 848-5200	christianhealthnj.org
엔컴패스 헬스 재활 병원 Encompass Health Rehabilitation Hospital	250 Old Hook Road, Westwood, NJ 07675	(201) 358-5800	encompasshealth.com
잉글우드병원 응급 센터 Englewood Health Emergency Medical Services	350 Engle Street, Englewood, NJ 07631	(201) 894-3000	hackensackmeridianhealth.org
해켄색 대학 병원 재활 병동 Hackensack University Medical Center Rehab Unit	30 Prospect Ave, Hackensack, NJ 07601	(551) 996-5555	holyname.org
홀리 네임 병원 재활 병동 Holy Name Medical Center Rehab Unit	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	(201) 833-3000	kessler-rehab.com

Resources

- [Medicare.gov: Inpatient Rehabilitation Care](https://www.medicare.gov/inpatient-rehabilitation-care)
- [NJ FamilyCare: Member Benefits Overview](https://www.njfamilycare.com/member-benefits-overview)
- [Medicare.gov: Official Medicare Booklet: Medicare & You 2026](https://www.medicare.gov/official-medicare-booklet-medicare-you-2026)

메디컬 홈케어 (Medical Home Care)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조연이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

메디컬 홈케어(Medical home care)는 질병이나 부상 치료를 위해 병원이나 널싱홈이 아닌 환자의 자택에서 제공되는 의료 서비스입니다. 환자가 익숙한 환경에서 독립적인 생활을 유지하면서도 간호사나 치료사의 전문적인 관리를 받을 수 있도록 돕는 제도입니다.

메디컬 홈케어는 의사의 처방 하에 메디케어 또는 메디케이드 인증을 받은 홈 헬스 에이전시(Home Health Agency, HHA)를 통해 제공됩니다. 병원 운영 홈케어(Hospital-run Home Care), 방문 간호 서비스(Visiting Nurse), 물리·작업·언어 치료, 의료 사회 서비스 등이 포함됩니다.

목욕·식사 보조, 가사 지원 등 일상적인 돌봄을 제공하는 홈 서비스 기관은 [일반 홈케어](#)를 확인하세요.

보험 혜택

오리지널 메디케어 (파트 A & B)

- **보장 기준:** 오리지널 메디케어는 질병/부상으로 도움 없이 집을 떠나기 어렵고 통상적으로 집을 떠날 수 없으며 외출에 상당한 노력을 요하는 경우에 한해 보장합니다. 의사 또는 간호사 전문의(Nurse Practitioner)가 홈케어 필요성을 직접 평가(face-to-face)한 후 처방을 내려야 합니다. 이 평가는 케어 시작 90일 전 또는 시작 30일 이내에 이루어져야 합니다. 다만 단기·비정기적 외출(종교 행사, 의료 방문 등)은 허용됨
- **보장 파트:** 상황에 따라 메디케어 파트 A(입원 보험) 또는 파트 B(의료 보험)에서 비용을 담당합니다
- **입원 요건:** 파트 A와 파트 B 모두 홈케어를 보장할 수 있습니다. 입원 이력이 없어도 홈바운드 요건과 의사 처방을 충족하면 파트 B를 통해 보장받을 수 있습니다. 파트 A는 입원 후 또는 널싱홈(Skilled Nursing Facility) 이후 케어 상황에서 적용될 수 있습니다.
- **보장 범위 및 제한:**
 - **Rehab & Skilled Nursing:** 전문 재활 및 간호 홈케어는 의학적 필요성이 인정되고 홈바운드 요건을 충족하는 한 지속 보장됩니다 (횟수 상한 없음, 60일 주기 의사 재인증 필요).
 - **홈케어 서비스(Home health care):** 홈케어 서비스는 의학적 필요성이 인정되는 한 기간 제한 없이 보장됩니다 (60일 주기 의사 재인증 필요). 통상 하루 최대 8시간, 주 28시간 이하이며, 의료적 필요 시 주 최대 35시간(하루 8시간 미만 조건 유지)까지 일시적으로 확대될 수 있습니다.
 - **비보장 항목:** 24시간 간병 서비스, 식사 배달, 가사 노동(청소, 빨래), 쇼핑 등 의료와 무관한 일상 지원 서비스(Custodial Care)는 보장되지 않습니다.
- **부담 비용:** 승인된 홈케어 서비스에 대한 코페이는 없습니다. 단, 휠체어나 워커 등 내구 의료 장비(DME)가 수반될 경우 파트 B에서 20%의 코인슈런스가 발생합니다.

메디케어 어드밴티지 (파트 C)

- **보장 기준:** 오리지널 메디케어의 기본 혜택을 모두 포함하며, 플랜에 따라 추가적인 지원이 있을 수 있습니다.
- **추가 혜택:** 일부 플랜은 오리지널 메디케어에서 보장하지 않는 병원 동행이나 일부 가사 보조 서비스를 추가로 제공하기도 합니다.
- **In-Network vs Out-of-Network:** 보험사와 계약된 In-Network의 홈 케어 전문 기관을 이용해야 혜택이 적용됩니다.

**In-Network: 보험사와 제휴된 의료기관 및 의료 제공자(의사, 전문 간호사, 물리 치료사 등).*

**Out-of-Network 기관 이용 시 본인 부담이 크게 증가하거나, 플랜에 따라 아예 보장되지 않을 수 있습니다.*

*대부분의 메디케어 어드밴티지 플랜은 홈케어 서비스 이용 전 사전 승인(Prior Authorization)이 필요합니다. 서비스 시작 전 플랜에 확인 요망.

롱텀케어 메디케이드(MLTSS)

- **보장 기준:** 롱텀케어 메디케이드(MLTSS)는 요양원 수준의 케어가 필요하며(ADL 3가지 이상 도움 필요) 소득·자산 기준을 충족하는 메디케이드 수혜자에게 제공됩니다. 메디케어와 메디케이드를 동시에 보유한 이중 수혜자(Dual Eligible)의 경우, 스킬드 홈케어는 주로 메디케어, 장기 개인 간병은 MLTSS가 담당합니다.
- **비용 부담:** 수혜 요건을 충족하는 경우, 통상적으로 본인 부담금 없이 서비스를 이용할 수 있습니다.

*자세한 내용은 [롱텀케어 메디케이드](#) 에서 확인.

개인 보험

- **보장 기준:** 가입한 보험 플랜의 약관에 따라 보장 범위와 기간이 상이하므로 사전 확인이 필수적입니다.
- **사전 승인:** 대부분의 민간 보험사는 서비스를 받기 전 반드시 보험사에 사전 승인(Prior Authorization)을 받을 것을 요구합니다.

보험 유형별 비용 부담 (2026)

보험 유형	디덕터블	코인슈어런스
메디케어 (파트 A & B)	\$0 (승인된 서비스에 한함)	\$0 (DME의료 장비는 파트 B 디덕터블 \$283 충족 후 20% 코인슈어런스 발생)
롱텀케어 메디케이드(MLTSS)	\$0	\$0
메디케어 어드밴티지 (파트C), 개인 보험	플랜별로 상이	플랜별로 상이

홈케어 서비스 기관 검색

- 미 전역 통합 리스트: [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)

- 뉴저지주 홈케어 라이선스 검색: [NJ.gov 공식 홈케어 라이선스 조회](https://www.nj.gov/public-access/health-care/health-care-providers/health-care-providers-licensing)
- 뉴저지주 홈케어 인증위원회 등록 리스트: [cahcusa.org 홈케어조회](https://www.cahcusa.org/homecare)
- 미국 홈케어 협회(NACH) 등록 리스트: [Allianceforcareathome.org – find a provider](https://allianceforcareathome.org/find-a-provider)

버겐 카운티 내 메디컬 홈케어

기관명	전화번호	웹사이트
Adoration Home Health	973-365-5200	adorationhealth.com/location/adoration-home-health-clifton-new-jersey
Amedisys Home Health and Hospice Services	201-342-6311	locations.amedisys.com/nj
Ascend Home Health	201-358-2666	ascendhealth.com
홀리 네임 홈 헬스 서비스 (Holy Name Home Care)	201-833-3740	holyname.org/forseniors/home-health-care
잉글우드병원 홈케어 (VNA of Englewood)	201-894-3333	allianceforcareathome.org/nahc_provider/vna-of-englewood-home-health-hospice
해켄색 병원 홈케어 (Hackensack MH Home Health Care/Visiting Health Services NJ)	1-844-777-0711	hackensackmeridianhealth.org/en/services/home-health-care-service
밸리 홈케어 (Valley Home Care)	201-291-6000	valleyhealth.com/homecare

참고 자료

- [Medicare.gov: Home Health Services](https://www.medicare.gov/home-health-services)
- [Medicare.gov: What's not covered by Part A & Part B?](https://www.medicare.gov/what-not-covered-by-part-a-part-b)
- [NJ.gov MLTSS](https://www.nj.gov/public-access/health-care/health-care-providers/health-care-providers-licensing)

관찰 병동 케어 (Observation Care)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조연이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

관찰 병동 케어(Observation Care, 또는 Clinical Decision Unit)는 환자의 입원을 결정하기 전 병원 내에서 제공되는 단기 모니터링 및 평가, 치료를 포함한 병원 기반의 외래 환자(outpatient) 서비스입니다.

관찰 병동 특징

- **지속 시간:** 관찰 병동 케어는 짧은 기간 제공되는 서비스이며 입원 필요 여부 결정까지는 통상 24~48시간 이내에 이루어집니다.
- **입원 전환:** 의료 상태가 악화되거나 장기적인 치료가 필요한 경우 정식 입원(Inpatient Admission)으로 전환됩니다.
- **사후 관리 영향:** 관찰 병동에 머문 기간은 메디케어 보장에서 요구하는 전문 재활 및 간호 시설(rehab and skilled nursing facilities)로 가는데 필요한 3일 연속 입원 요건에 포함되지 않습니다.

보험 혜택

메디케어 파트 B

- **보장 기준:** 관찰 병동 케어는 외래 환자 서비스(outpatient)로 분류됩니다.
 - 메디케어 외래 관찰 통지서: 병원은 메디케어 수혜자가 24시간 이상 관찰 병동에 머물 경우, 해당 상태가 외래임을 알리는 Medicare Outpatient Observation Notice 통지서를 반드시 제공해야 합니다.
- **부담 비용:** 환자는 **파트 B 디덕터블(\$283; 2026년 기준)** 충족 후, 응급실 방문 코페이, 부수적인 응급 의료 서비스(X-ray 촬영, CT 스캔, 심전도-EKG 등) 코페이, 의사 서비스에 대한 메디케어 승인 금액 등 각각의 비용에 대해 20% 코인슈어런스를 부담합니다. 파트 B의 코인슈어런스는 [Medigap](#) 을 통해 커버할 수 있습니다.
- **처방약 보장 제외:** 응급실이나 관찰 병동에서 복용하는 처방약(평소 복용약 포함)은 파트 B가 아닌 **파트 D 플랜**으로 커버됩니다. 병원 약국이 환자 파트 D 플랜의 Out-of-network 일 경우, 비용을 전액 선결제한 후 보험사에 청구(Reimbursement)를 해야 할 수도 있습니다.
 - * 부수적인 응급 의료 서비스의 코페이는 당해 연도 파트 A 디덕터블(\$1,736; 2026년 기준) 금액을 초과하지 않습니다. 다만 여러 종류의 검사와 처치를 동시에 받을 경우 합산 코페이 금액은 이 한도를 넘을 수 있습니다.
 - *오리지널 메디케어(파트 A와 파트 B)는 원칙적으로 미국 외 응급 서비스를 보장하지 않습니다(일부 예외 상황 제외).

메디케어 어드밴티지 (파트 C)

- **보장 기준:** 관찰 병동 케어는 외래 환자 서비스(outpatient)로 분류됩니다.
 - 메디케어 어드밴티지 환자에게도 병원에서 메디케어 외래 관찰 통지서(MOON)를 반드시 제공합니다.

- **재활 시설 이동 조건:** 관찰 병동 케어 상태로 머문 기간은 전문 간호 시설 혜택을 받기 위한 3일 연속 입원 조건에 포함되지 않습니다.
 - 대부분의 메디케어 어드밴티지 플랜은 3일 입원 요건을 면제하는 경우가 있으니 반드시 플랜 정보를 확인하세요.
- **부담 비용:** 입원 디덕터블 대신 외래 진료 코페이가 적용됩니다. 검사나 약물 등 개별 서비스마다 코페이가 발생할 수 있으나 단일 서비스당 코페이는 통상 입원 디덕터블을 초과하지 않습니다.

메디케이드

- **보장 기준:** 환자의 상태를 평가하기 위해 의료적으로 필요하다고 판단되는 경우 관찰 병동 케어를 보장합니다.
- **비용 부담:** 뉴저지의 경우 자격 요건을 갖춘 대부분의 수혜자는 협약 병원에서 제공되는 관찰 병동 케어에 대해 본인이 부담하는 코페이가 없거나 매우 적습니다.
- **사전 승인:** 응급 상황을 통한 관찰 병동 케어의 경우 통상적으로 사전에 승인을 받을 필요는 없으나, 해당 기관은 정해진 통보 절차를 준수해야 합니다.

개인 보험

- **보장 기준:** 대부분의 개인 보험 플랜은 응급실 방문을 보장합니다.
- **In-Network vs Out-of-Network:** 환자는 가입한 보험 플랜에 따라 정해진 코페이를 지불하게 됩니다. 뉴저지에서는 Out-of-Network 관찰 병동에서도 In-Network 비용을 지불합니다.

보험 유형별 비용 부담 (2026)

보험 유형	디덕터블	코페이 및 코인슈어런스
메디케어 파트 B	\$283	관찰 케어 코페이 + 의사 진료비 및 개별 검사에 대한 각각 20%의 코인슈어런스
메디케이드	\$0	관찰 케어 서비스의 경우 통상 \$0 또는 소액; 주별로 상이
메디케어 어드밴티지 (파트C), 개인 보험	플랜별로 상이	플랜별로 상이; 응급 및 관찰 케어 시 In-Network 적용

***In-Network:** 보험사와 제휴된 의료기관 및 의료 제공자(의사, 전문 간호사, 물리 치료사 등).

***Out-of-Network:** 보험사와 제휴되어있지 않기 때문에 본인 부담금이 크게 발생할 수 있습니다.

병원 및 의료기관 검색

- 미 전역 통합 리스트: [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- 뉴저지주 지역별 리스트: [Healthapps.nj.gov/facilities](https://www.healthapps.nj.gov/facilities)

버겐 카운티 관찰 병동 케어 제공 기관

아래는 비응급 상황 연락처입니다. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 먼저 전화하세요.

병원 이름	주소	전화번호	웹사이트
버겐 뉴브리지 병원 응급 센터 Bergen New Bridge Medical Center Emergency Medical Services	230 East Ridgewood Avenue, Paramus, NJ 07652	201-967-4000	newbridgehealth.org/emergency-care
잉글우드병원 응급 센터 Englewood Hospital and Medical Center Emergency Medical Services	350 Engle Street, Englewood, NJ 07631	201-894-3000	englewoodhealth.org/emergency-services
해켄색 패스캐크 벨리 병원 응급 센터 Hackensack Meridian Health-Pascack Valley Emergency Medical Services	250 Old Hook Road, Westwood, NJ 07675	201-383-1035	pascackmedicalcenter.com/emergency-care
해켄색 대학 병원 응급실 Hackensack University Medical Center Emergency Medical Services	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-2000	hackensackmeridianhealth.org/emergency-care
홀리 네임 병원 응급실 Holy Name Medical Center Emergency Care Center	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org/emergencycare
밸리 병원 응급 부서 관찰 병동 유닛 The Valley Clinical Decision Unit	4 Valley Health Plaza, Paramus, NJ 07652	201-447-8000	valleyhealth.com/services/emergency-services

Resources

- [Medicaid.gov – Estate Recovery](https://www.medicaid.gov/estate-recovery)
- [NJ Medicaid Program and Estate Recovery – What You Should Know](#)

병원 진료 (Treatment)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 의학적 진단이나 조언이 필요한 경우 반드시 의료 전문가와 상담하십시오. 응급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

병원 진료는 주로 3개월 이상 지속되거나 재발하는 만성 통증 관리를 목적으로 하며, 전문적인 평가와 치료 계획을 포함한 통합 케어를 제공합니다. 이를 통해 통증을 체계적으로 관리함으로써 환자의 삶의 질을 실질적으로 향상시키는 데 목표를 둡니다.

보험 혜택

메디케어 파트 A (병원 시설 비용)

- **보장 범위:** 2인실 침대, 식사, 일반 간호, 입원 치료의 일부로 제공되는 약품, 기타 병원 서비스 및 용품을 보장합니다. (단, 개인실 사용이나 개인 간병인 등은 보장되지 않습니다.)
- **부담 비용:** 입원 디덕터블(\$1,736; 2026년 기준)을 환자가 먼저 부담합니다. 나머지는 파트 A에서 부담합니다.
- **혜택 기간:** 혜택 기간(Benefit Period)은 입원이 공식적으로 인정된 날부터 시작되며, 퇴원 후 60일 이내에 재입원하면 이전 입원과 하나의 주기로 합산되어 계산됩니다. 반면 퇴원 후 60일을 넘겨 재입원하면 새로운 혜택 주기가 시작되어 입원 디덕터블 \$1,736도 다시 발생합니다. 혜택 기간 횟수에는 제한이 없습니다.
- **일생의 예비일 (Lifetime Reserve Days):** 한 혜택 기간 내 입원이 90일을 넘길 때 사용할 수 있는 보너스 일수로, 평생 총 60일까지 추가 보장 혜택이 제공됩니다. 예비일을 모두 소진한 후에는 입원 비용 전액을 본인이 부담해야 합니다.

메디케어 파트 B

- **보장 기준:** 메디케어 파트 B는 외래 만성 통증 관리(CPM) 서비스를 보장합니다. 여기에는 진단, 통증 평가, 약물 관리 및 케어 조정이 포함됩니다.
- **통합 서비스:** 메디케어에 등록된 제공자가 시행하는 물리 치료, 작업 치료, 그리고 만성 요통(Chronic Lower Back Pain)에 한해서는 침술도 보장 범위에 포함됩니다.
- **부담 비용:** 연간 파트 B 디덕터블을 완납 후, 환자는 메디케어 승인 금액의 20%를 부담합니다. 병원 외래 클리닉에서 서비스를 받는 경우 별도의 코페이가 발생할 수 있습니다.
- **부담 비용:** 연간 디덕터블(\$283; 2026년 기준)을 환자가 먼저 부담합니다. 이후 일반적으로 의사 진료비의 80%를 파트 B에서 부담하고 나머지 20%는 본인이 부담합니다.

*병원에 입원 중임에도 의사 비용은 파트 A 가 아닌 파트 B에서 별도로 청구됩니다.

메디케어 어드밴티지 (파트 C)

- **보장 기준:** 3개월 이상 지속되거나 재발하는 만성 통증을 앓고 있는 환자를 대상으로, 의학적으로 필요하다고 인정되는 통합적인 통증 관리 서비스를 보장합니다.

- **보장 범위:** 통증 평가, 약물 관리(오피오이드 등 마약성 진통제 및 비마약성 약물), 물리 치료, 행동 건강 상담, 그리고 개별 맞춤형 치료 계획 수립 등 통증 완화를 위한 제반 서비스를 포함합니다.
- **사전 승인 및 한도:** 척추 주사(Epidural)나 신경 차단술 같은 특수 시술, 또는 마약성 진통제 처방 시 보험사의 사전 승인이 필요할 수 있으며, 물리 치료 등은 연간 이용 횟수에 제한이 있을 수 있습니다.
- **통합 케어 접근법:** 단순히 약물 처방에 그치지 않고, 전문의 및 치료사들이 협력하여 환자의 기능을 회복시키고 삶의 질을 높이는 통합적 관리 계획(Care Plan) 하에 진료가 이루어지는 것을 권장합니다.
- **부담 비용:** 서비스 종류에 따라 본인 코페이를 지불합니다. 모든 비용은 연간 본인 부담 최대 한도(Maximum Out-of-Pocket)에 포함되어 관리됩니다.

**보장 범위, 사전 승인 기준 등은 플랜마다 상이하므로 개인 플랜 확인 필요*

메디케이드

- **보장 기준:** 의료적으로 필요하다고 인정되는(Medically Necessary) 모든 치료를 보장합니다. 여기에는 전문의 진료, 수술, 물리 치료, 작업 치료, 그리고 통증 관리 서비스가 포함됩니다.
- **비용 부담:** 대부분의 메디케이드 가입자는 모든 진료를 무료로 받습니다. 소득 138% 연방빈곤선(FPL) 이하 성인은 본인 부담금이 없으며, CHIP 가입자만 소액의 코페이가 발생할 수 있습니다.
- **사전 승인:** 일부 전문 치료나 장기 요법은 메디케이드 관리 보험사(MCO)의 사전 승인이 필요할 수 있습니다.

** OBBBA(One Big Beautiful Bill Act) 법안 시행에 따라 메디케이드 자격 및 내용이 달라질 수 있으므로 [공식 웹사이트](#)에서 확인하세요.*

개인 보험

- **보장 기준:** 대부분의 개인 보험은 의료적으로 필요하다고 판단되는 주사 요법, 물리 치료 등을 포함한 만성 통증 치료를 보장합니다.
- **의료적 필요성:** 보험사는 일반적으로 약물이나 운동과 같은 기본 치료를 먼저 시도했다는 의사의 상세한 서류 증명을 요구합니다.
- **뉴저지 규정:** 뉴저지주법에 따라 의료진은 만성 통증에 대한 특정 약물을 처방할 때 환자와 공식적인 **통증 관리 계약**을 체결해야 하며, 3개월마다 치료 계획을 검토해야 합니다.
- **In-Network vs Out-of-Network:** 비용은 플랜에 따라 크게 달라지며, 본인 부담금을 최소화하기 위해서는 In-Network 병원을 이용하는 것이 필수적입니다.

**In-Network: 보험사와 제휴된 의료기관 및 의료 제공자(의사, 전문 간호사, 물리 치료사 등).*

**Out-of-Network 는 보험사와 제휴되어있지 않기 때문에 본인 부담금이 크게 발생할 수 있습니다.*

보험 유형별 비용 분담 (2026)

보험 유형	디덕터블	코페이 및 코인슈어런스
메디케어 파트 A (병원 시설 비용)	\$1,736 (혜택 기간당)	1~60일: \$0 61~90일: 1일당 \$434 91일 이후: 1일당 \$868 (예비일) 예비일 소진후 전액 본인 부담
메디케어 파트 B (의사 진료 비용)	\$283	의사 진료비의 20%
메디케이드	\$0	의학적으로 필요한 서비스의 경우 \$0
메디케어 어드밴티지 (파트C), 개인 보험	플랜별로 상이	플랜별로 상이

***In-Network:** 보험사와 제휴된 의료기관 및 의료 제공자(의사, 전문 간호사, 물리 치료사 등).

***Out-of-Network** 는 보험사와 제휴되어있지 않기 때문에 본인 부담금이 크게 발생할 수 있습니다.

병원 및 의료기관 검색

- 미 전역 통합 리스트: [Medicare.gov/care-compare](https://www.medicare.gov/care-compare)
- 뉴저지주 지역별 리스트: [Healthapps.nj.gov/facilities](https://www.healthapps.nj.gov/facilities)

버겐 카운티 내 병원

병원 이름	주소	전화번호	웹사이트
버겐 뉴브리지 메디컬 센터 Bergen New Bridge	230 East Ridgewood Avenue, Paramus, NJ 07652	201-967-4000	newbridgehealth.org
잉글우드병원 Englewood Health	350 Engle Street, Englewood, NJ 07631	201- 894-3000	englewoodhealth.org
해켄색 패스캐벨리 병원 Hackensack Meridian Health Pascack Valley	250 Old Hook Road, Westwood, NJ 07675	201- 383-1035	pascackmedicalcenter.com
해켄색 대학 병원 (Hackensack University Medical Center)	30 Prospect Avenue, Hackensack, NJ 07601	551-996-2000	hackensackmeridianhealth.org
홀리 네임 병원 (Holy Name Medical Center)	718 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666	201-833-3000	holyname.org
밸리 병원 (The Valley Hospital)	4 Valley Health Plaza, Paramus, NJ 07652	201-447-8000	valleyhealth.com

참고 자료

- [Medicare.gov: Chronic Pain Management & Treatment Services](http://www.Medicare.gov/ChronicPainManagement&TreatmentServices)
- [Medicare.gov: Pain Management Coverage](http://www.Medicare.gov/PainManagementCoverage)
- [NJ FamilyCare.org](http://www.NJFamilyCare.org)

주거·주택 (Housing)

Housing

시니어 및 서민 주거 복지: 시니어 아파트(HUD Section 202), 섹션 8 바우처, 어포더블 하우스링 (LIHTC), 은퇴자 전원 마을, 연속 돌봄 은퇴 커뮤니티(CCRC), 주거형 건강관리 시설, 어시스티드 리빙 (Assisted Living), 역모기지, 뉴저지 재산세 감면 제도(시니어 프리즈, ANCHOR, Stay NJ).

본 부문 총 12개 상세 안내 문서 수록

어포더블 하우징 (LIHTC)

저소득층 주택 세액 공제(Low-Income Housing Tax Credit, LIHTC) 프로그램은 연방 정부가 민간 개발사에 세액공제(Tax Credit)를 제공하고, 개발사는 이를 투자자에게 매각해 저렴한 임대주택을 건설·운영하는 프로그램으로 일반 공공주택과 달리 '지역 소득 수준'에 맞춘 고정 임대료 체계로 운영됩니다.

자격 요건

- **소득 한도:** 대부분의 LIHTC 단지는 지역 중간 소득(AMI) 50% 또는 60% 이하가 기준이며, 일부 단지는 평균소득 테스트(AIT)를 적용해 최대 80%까지 허용되기도 합니다.
- **자산 심사:** 은행 잔고, 주식, 부동산 등 자산에서 발생하는 수익(이자, 배당 등)은 연간 소득에 포함되어 소득 심사에 영향을 줄 수 있습니다.
- **직접 신청:** 각 아파트 관리 사무소 또는 해당 단지의 행정 대리인(Administrative Agent)을 통해 개별적으로 신청하며, 대기 명단(Waiting List) 확인이 필수입니다.

임대료 결정 원리

어포더블 하우징의 임대료는 개인 소득이 아닌, 해당 지역 중간 소득(Area Median Income, AMI)에 따라 미리 정해집니다.

- **고정 금액:** 임대료는 해당 AMI 비율 소득의 30%를 초과할 수 없는 수준으로 책정됩니다.
- **최소 소득 요건:** 정부 보조금이 매달 지급되지 않으므로, 세입자는 정해진 임대료를 지불할 수 있는 **최소한의 소득**이 있음을 증명해야 합니다.
- **임대료 조정:** HUD MTSP(Multifamily Tax Subsidy Projects) 한도 변화에 따라 임대료가 오를 수 있습니다. 단, 개별 단지 정책에 따라 달라질 수 있습니다.

뉴저지 (Region 1) 소득 제한 (2025)

해당 지역: Bergen, Hudson, Passaic, Sussex 카운티

어포더블 하우징 입주를 위해 가구원 수에 따른 연간 총소득(Gross Income)이 아래 금액 **이하**여야 합니다.

가구 인원	30% AMI (Very Low)	50% AMI (Low)	60% AMI (Typical LIHTC)	80% AMI (Moderate)
1인 가구	\$26,730	\$44,550	\$53,460	\$71,280
2인 가구	\$30,540	\$50,900	\$61,080	\$81,440
3인 가구	\$34,350	\$57,250	\$68,700	\$91,600
4인 가구	\$38,160	\$63,600	\$76,320	\$101,760
5인 가구	\$41,220	\$68,700	\$82,440	\$109,920

출처: HUD FY2025 MTSP Income Limits (huduser.gov/portal/datasets/mtsp.html)

최저 소득

정부에서 정한 최고 한도(위의 표) 외에, 아파트 관리실에서는 임대료 지불 능력을 확인하기 위해 보통 임대료의 2.5배에 해당하는 월 소득을 요구합니다.

뉴저지 (Region 1) 예상 임대료

유틸리티 포함 여부에 따라 달라질 수 있지만, 대략적인 가이드라인은 다음과 같습니다.

- 1 Bedroom (50% AMI 기준): 약 \$1,100 ~ \$1,200
- 2 Bedroom (50% AMI 기준): 약 \$1,350 ~ \$1,500
- 3 Bedroom (50% AMI 기준): 약 \$1,550 ~ \$1,750

소득 재인증(Recertification)

입주 후에도 매년 가구 소득과 구성원 변화를 관리 사무소에 보고해야 합니다.

- **140% 규칙 (세입자 보호):** 재심사 시 소득이 입주 당시 기준보다 높아졌더라도, 현재 적용되는 소득 한도(AMI 기반)의 140%를 초과하지 않는다면 계속 거주할 수 있습니다.
- **초과 시 조치:** 소득이 140%를 초과하더라도 즉시 퇴거당하지는 않습니다. 다만, 소득이 140%를 초과하면 건물 내 다음 공실 유닛은 자격 있는 저소득 가구에 배정되며, 본인 유닛은 임대료가 유지됩니다.

가구 구성원 변화 규정

- **가구원 추가:** 새로 들어오는 성인의 소득을 합산하여 자격 심사를 다시 받습니다. 승인 없는 동거는 리스 위반으로 퇴거 사유가 됩니다.
- **가구원 감소:** 가족이 나가서 유닛 크기에 비해 인원이 너무 적어지면 건물 정책에 따라 이동을 요청받을 수 있습니다 (단지마다 다름)

- **학생 가구 제한:** 가구원 전체가 '풀타임 학생(Full-time Student)'으로만 구성될 경우 입주 자격이 제한될 수 있습니다.
(단, 싱글 맘/대디, 복지 혜택 수혜자 등 예외 조항 존재)

신청 및 문의

- [NJHRC](#) (뉴저지 주택 리소스 센터)
 - 뉴저지주 전체의 공실 및 대기 명단 정보를 검색할 수 있는 가장 공신력 있는 사이트입니다.
- [Affordable Homes New Jersey \(CGP&H\)](#)
 - CGP&H는 뉴저지주 내 30개 이상 카운티의 어포더블 주택 행정 대리인으로, 프로필 등록 시 여러 대기 명단에 한 번에 지원 가능합니다
- [Piazza & Associates](#)
 - 각 타운별 전용 단지와 민간 아파트 정보를 상세히 제공하는 민간 사이트로, 지역별 소득 제한표를 확인하기 좋습니다.
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ.gov – Department of Community Affairs \(NJDCA\)](#)
- [NJ.gov – Housing and Mortgage Finance Agency \(NJHMFA\)](#)
- [Fair Share Housing Center: 세입자 권리 보호 비영리 단체](#)

앵커(ANCHOR)

앵커(Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters, ANCHOR)는 뉴저지 주민들의 재산세 부담을 완화하기 위해 매년 시행되는 재산세 경감 혜택 프로그램입니다. 혜택은 해당 연도의 거주 상태, 소득, 연령에 따라 결정됩니다.

자격 요건

ANCHOR는 주 정부가 정한 특정 기준일(보통 10월 1일) 당시에 뉴저지에 거주하며 해당 주택의 소유주 또는 세입자를 대상으로 합니다.

주택 소유주 (Homeowners)

- **자격:** 기준일 현재 뉴저지에 주택을 소유하고 실거주하며 재산세를 납부한 주민
- **혜택 금액:**
 - 연 소득 \$150,000 이하: \$1,500 (65세 이상은 \$1,750)
 - 연 소득 \$150,001~ \$250,000 이하: \$1,000 (65세 이상은 \$1,250)

세입자 (Renters)

- **자격:** 기준일 당시 뉴저지 내 임대 주택(지방 재산세 과세 대상)에 실거주하며 임대료를 납부한 주민. 단, 정부 소유·면세 주택·비영리 소유 면세 건물 세입자는 제외
- **혜택:**
 - 연 소득 \$150,000 이하: \$450 (65세 이상은 \$700)
 - 소득이 \$150,000을 초과하는 세입자는 일반적으로 혜택 대상에서 제외됩니다.

*사회보장번호(SSN)가 없는 경우에도 뉴저지 거주자로서 ITIN을 보유한 경우 신청 가능합니다.

신청 방법

- **일반 신청자 (65세 미만)**
 - 대부분의 적격자(65세 미만·비장애)는 주 정부가 자동으로 신청을 접수해 줍니다.
 - 확인서의 정보에 변경 사항이 없다면 별도의 조치 없이 자동 접수됩니다. 정보 수정이 필요하거나 확인서를 받지 못한 경우에만 온라인 또는 서면으로 직접 신청합니다.
- **시니어 및 장애 수급자 (65세 이상 또는 장애인 소셜 시큐리티 연금(SSDI), Railroad Retirement Disability 수급자)**
 - 정부가 자동으로 신청서를 제출해주지 않습니다. 매년 [PAS-1 통합 신청서](#)를 통해 직접 온라인 또는 서면으로 접수해야 합니다.

- 통합 신청서를 통해 ANCHOR, Senior Freeze(PTR), Stay NJ 혜택을 한 번에 검토받을 수 있어 누락 없는 혜택 수령이 가능합니다.
- **마감 기한:** 일반적으로 매년 10월말-11월초 사이 마감합니다.
- **준비 서류:**
 - 사회보장번호(SSN) 또는 ITIN
 - 해당 기준 연도의 뉴저지 총소득(Gross Income) 정보
 - 주택 소유주의 경우, 재산세 고지서상의 Block 및 Lot 번호

주의 사항

- Social Security는 뉴저지 Gross Income에 포함되지 않으므로, 이를 제외한 소득이 한도 이내인지 확인하십시오.
- 부부가 공동으로 소유하거나 세입자로 등록된 경우, 소득 합산액이 기준을 넘지 않아야 합니다.
- 온라인 신청 시 직접 입금(Direct Deposit)을 선택하면 종이 수표보다 더 빠르게 환급금을 받을 수 있습니다.

문의

- **ANCHOR 전용 핫라인:** 1-888-238-1233/609-826-4282
- **청각 장애인 지원 (Text Telephone):** 1-800-285-3036
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ Division of Taxation – ANCHOR Portal](#)
- [PAS-1 통합 신청 포털](#)

어시스티드 리빙 (Assisted Living)

어시스티드 리빙(Assisted Living)은 일상생활에서 어느 정도의 도움이 필요하지만, 일반적으로 24시간 집중 의료 간호보다는 일상 돌봄이 주로 필요한 분들을 위한 주거 형태입니다. 개인의 독립성을 최대한 존중하면서도, 24시간 상주하는 스태프를 통해 안전하고 품격 있는 생활을 지원받는 것이 핵심입니다.

서비스 및 특징

- **개인 맞춤형 돌봄 (ADLs):** 목욕, 옷 입기, 이동, 개인위생 등 일상생활(Activities of Daily Living)을 개별 필요도에 맞춰 지원합니다.
- **24시간 안전 관리:** 모든 유닛에 비상 호출 시스템이 갖춰져 있으며, 전문 인력이 24시간 상주하여 응급 상황에 즉각 대응합니다.
- **건강 및 투약 관리:** 간호사(RN/LPN)가 24시간 연락 가능한 체계를 갖추고 있으며, 시설에 따라 상근 간호사를 배치하기도 합니다. 약물 복용 관리 및 기본 건강 모니터링을 제공합니다.
- **품격 있는 식사:** 영양사가 설계한 균형 잡힌 식사를 다이닝 홀에서 제공하며, 특별한 식이 요법이 필요한 경우 맞춤 식단을 제공합니다.
- **풍성한 사교 프로그램:** 피트니스, 예술 활동, 야외 나들이, 교육 강좌 등 거주자의 인지 기능과 정서적 활력을 위한 다양한 프로그램을 운영합니다.

자격 요건

- **연령:** 뉴저지주 법령상 특정 연령 기준은 없으며, 각 시설이 자체적으로 입주 기준을 정합니다.
- **건강 상태:**
 - 어느 정도 거동이 가능하거나 보조 기구를 이용한 분이 적합하나, 상태에 따라 개별 시설과 협의가 필요합니다.
 - 24시간 집중 간호 감독이 필요하거나 의료적으로 불안정한 상태(medically unstable)인 경우에는 적합하지 않을 수 있으며, 이 경우 롱텀케어시설(Long-term Care Facility)로의 전원이 필요할 수 있습니다.
- **인지 상태:** 타인에게 위협이 되지 않는 수준의 인지 상태가 요구됩니다. (치매가 진행된 경우 단지 내 '메모리 케어(Memory Care)' 섹션으로 입주가 가능합니다.)
- **재정 지원:** 뉴저지에서는 롱텀케어 메디케이드(MLTSS)를 통해 자격이 되는 저소득 시니어에게 어시스티드 리빙 케어 비용 일부를 지원합니다. 단, 숙식비(Room & Board)는 포함되지 않습니다.

**입주 전 자격 요건은 해당 시설에 직접 확인 필요.*

선택 시 고려해야 할 점

- **Care Levels (단계별 비용):** 기본 비용 외에 본인에게 필요한 서비스(Care Level)에 따라 추가 비용이 어떻게 발생하는지 확인해야 합니다.
- **Staff-to-Resident Ratio:** 거주자 대비 관리 직원 수가 적절한지 확인하여 세심한 케어가 가능한지 판단하십시오.
- **Continuum of Care:** 건강이 악화되었을 때 같은 단지 내에서 요양 서비스(Skilled Nursing)로 전환이 가능한 시설인지 확인하는 것이 좋습니다.

뉴저지 어시스티드 리빙 시설

위치 (Town)	시설명 (Community Name)	주요 특징	연락처
Englewood	The Bristol at Englewood	럭셔리 어시스티드 리빙으로 고급 다이닝과 다양한 활동 프로그램을 제공. 활동적인 시니어를 위한 세련된 프로그램과 우수한 다이닝으로 유명함.	201-331-9204
Wyckoff	Courtyard at Longview (Christian Health)	100년 이상의 역사를 가진 비영리 재단 운영. 이익보다 케어의 질에 집중하며, 단지 내 전문 의료 시설 및 숙련 간호 시설이 함께 운영되어 의료 연계성이 우수함	201-528-1295
Tenafly	Brightview Tenafly	테너플라이의 수준 높은 커뮤니티 인프라를 누릴 수 있음. 교육·예술 프로그램이 풍부한 어시스티드 리빙.	201-228-3135
Old Tappan	Sunrise of Old Tappan	대형 시설과 달리 개인별 맞춤 케어와 정서적 유대감을 중시하는 Sunrise의 정통 철학이 잘 반영된 곳. 조용하고 품격 있는 주택가 위치.	848-317-8670
Montville	Mira Vie at Montville	현대적인 안전 시스템과 체계적인 투약 관리로 정평이 나 있음.	973-791-9649
West Caldwell	Crane's Mill	단순 어시스티드 리빙을 넘어 연속형 은퇴 주거 단지로 독립주거부터 전문 재활 및 간호 서비스까지 한 캠퍼스 내 제공. 건강 상태 변화에 따른 이동이 안정적.	973-276-6700

*시설 정보 및 서비스 내용은 변경될 수 있으니 입주 전 각 시설에 직접 확인 필요

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ.gov DOH 주거용 요양 시설 검색](#)
- [NJ MLTSS](#)
- [NJ.gov – 어시스트 리빙 시설 검색](#)
- [NJ 211.org](#)

연속형 은퇴 주거 단지 (Continuing Care Housing)

Continuing Care Housing, 흔히 CCRC(Continuing Care Retirement Community) 또는 Life Plan Community라고 불리는 이 주거 형태는 노후의 건강 상태 변화에 따라 한 단지 내에서 주거와 케어 서비스를 연속적으로 제공받는 종합 은퇴 단지입니다.

주요 특징은 독립 생활(Independent Living)로 시작해, 나이가 들어 도움이 필요해지면 어시스티드 리빙(Assisted Living) 그리고 전문 재활 및 간호 시설(Skilled Nursing Facilities) 단계로 단지 내에서 이동하며 케어를 보장받는다는 점입니다.

자격 요건

Continuing Care Housing은 일반 시니어 단지보다 입주 조건이 더 까다로운 편입니다.

- **연령:** 만 55세 이상이 일반적이며, 단지별로 상이할 수 있습니다.
- **건강 상태**
 - 입주 시점에 독립적인 생활(Independent Living)이 가능할 정도로 건강해야 합니다.
 - 입주 전 건강 검진과 인지 능력 테스트를 거치며, 이미 집중 케어가 필요한 상태라면 독립 생활 유닛 입주가 거절될 수 있습니다.
- **재정**
 - 고액의 입회비와 월 관리비를 감당할 수 있는 자산 및 수입 증명이 필요합니다.
 - 단지 측에서는 거주자가 평생 동안 비용을 지불할 수 있는지 재정 심사를 엄격히 진행합니다.
- **보험:** 메디케어(Medicare) 파트 A & B 및 Medigap 가입을 요구하는 경우가 많습니다.

**입주 전 개별 CCRC에 자격 요건 확인 필요.*

비용 구조

Continuing Care Housing은 초기 비용이 상당히 높습니다.

- **입회비 (Entrance Fee):** 지역과 유닛 크기에 따라 \$50,000~\$1,000,000 이상까지 단지별로 다양합니다. 이 금액은 나중에 일부 환불받을 수 있는 조건(Refundable)인지에 따라 총액이 달라집니다.
- **월 관리비:** 식사, 청소, 시설 이용, 보안 등이 포함되며 월 수천 달러 수준으로 단지 및 케어 수준에 따라 크게 다릅니다. (단지 직접 확인 필요)

계약 유형

비용과 서비스 범위에 따라 크게 세 가지 계약 방식으로 나뉩니다.

계약 유형	명칭	특징
Type A	Life Care	가장 비싸지만, 나중에 간호 시설로 옮겨도 월 관리비가 거의 오르지 않음. (의료비 위험 최소화)
Type B	Modified	입회비가 다소 저렴함. 간호 서비스가 필요할 때 일정 기간만 무료/할인되고 이후에는 추가 비용 발생.
Type C	Fee-for-Service	초기 비용이 가장 낮음. 하지만 케어 서비스가 필요해지면 시장가(Market Rate)를 전액 지불해야 함.

장점

- 배우자 중 한 명만 아파도 같은 단지 내에서 케어를 받으며 가까이 지낼 수 있음.
- 자녀들에게 부모 케어에 대한 재정적, 육체적 부담을 주지 않음.
- 예측 가능한 노후 의료 비용 (Type A 계약 시).

단점

- 매우 높은 초기 입주 비용.
- 단지의 재정이 불안정할 경우 입회비 환불이 어려울 수 있는 리스크.
- 건강할 때 미리 결정하고 입주해야 하므로 선제적 결단이 필요함.

뉴저지 연속형 은퇴 주거 단지

지역 (Town)	단지명 (Community Name)	주요 특징	연락처
Wyckoff	The Vista	기독교 정신 기반의 Christian Health가 운영. 버건 카운티 내 가장 현대적인 시설과 맞춤형 웰니스 시스템	201-689-5513
Pompton Plains	Cedar Crest	130에이커 부지의 대규모 단지. 자체 온사이트 메디컬 센터와 전담 의료진 시스템 보유	973-834-8513
Monroe	Monroe Village	Newsweek 선정 America's Best CCRCs 수상 이력. 먼로 지역의 탄탄한 인프라와 높은 커뮤니티 만족도	732-521-6400
Maplewood	Winchester Gardens	U.S. News 선정 '2026년 최우수 시설. 유서 깊은 건축물과 우아한 환경	973-762-5050
East Windsor	Meadow Lakes	2025 Newsweek 수상. 조용하고 지적인 생활 환경	609-448-4100
Basking Ridge	Fellowship Village	웰니스 및 건강 관리 프로그램 운영. 72에이커의 쾌적한 환경과 고품질 전문 간호 서비스 결합.	908-498-7302

입주 결정 전 NJ DCA의 CCRC Disclosure Statement를 반드시 검토하고, 재정 및 법률 전문가와 상담하시기 바랍니다.

문의

- AWCA에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ.gov – Department of Community Affairs\(DCA\) 하우징 관련 법률](#)
- [NJ.gov – DCA CCRC 소비자 가이드북 \(PDF\)](#)
- [NJ 211.org](#)

재산세 감면 프로그램 (Property Tax Relief Programs)

뉴저지주는 주택 소유주와 세입자의 세금 부담을 줄이기 위해 재산세 감면 절차를 통합했습니다. 특히 만 65세 이상 시니어 및 장애 수급자를 위해 도입된 PAS-1 통합 신청서는 단 한 번의 신청으로 세 가지 주요 혜택을 모두 검토받을 수 있는 방법입니다.

통합 신청(PAS-1) 대상 프로그램

프로그램명	주요 대상	혜택
Senior Freeze	65세 이상 또는 장애인 소셜 시큐리티(Social Security Disability), 철도퇴직 장애급여(Railroad Retirement Disability) 수급자	재산세 인상분 환급 (기준연도 대비 인상분만 환급)
ANCHOR	주택 소유주 및 세입자	(2025 과세연도 기준): - 주택 소유주 소득 ≤\$150K: \$1,500 (65세+ \$1,750) - 주택 소유주 소득 \$150K~\$250K: \$1,000 (65세 + \$1,250) - 세입자 소득 ≤\$150K: \$450 (65세+ \$700)
Stay NJ	만 65세 이상 주택 소유주 (장애 수급자 신분만으로는 자격 없음)	재산세의 50% — ANCHOR 및 Senior Freeze 수령액을 뺀 나머지 금액 지급. 2025년 최대 순지급 한도 \$6,500

주의사항

가장 주의해야 할 점은 신청 방식의 차이입니다. 본인의 상황에 따라 자동 접수 여부가 달라집니다.

- 만 65세 미만 일반 소유주/세입자 (ANCHOR만 해당):
 - 이전 수혜자는 주정부가 신청을 대신 처리해 'Confirmation Letter'를 발송합니다. 주소·계좌·정보 변경이 있는 경우 반드시 직접 신청해야 합니다.
- 만 65세 이상 시니어 또는 장애 수급자 (SSDI/SSI 등):
 - 신청서는 해마다 다시 신청해야 합니다.

- 주의: ANCHOR 혜택만 받는 경우라도 시니어라면 반드시 PAS-1 통합 신청서를 온라인 또는 서면으로 직접 제출해야 합니다.
- 소득이나 주택 소유 정보가 NJ-1040과 일치하지 않을 경우 지급이 지연될 수 있으므로 제출 전 반드시 대조하십시오.

자격 요건

- **연령 기준:** 신청하고자 하는 과세 연도 12월 31일 기준 만 65세 이상.
- **장애 수급자 기준:** 65세 미만이라도 사회보장국(SSA)으로부터 장애인 소셜 시큐리티(**SSDI**) 또는 철도퇴직 장애급여(Railroad Retirement Disability)를 수령 중인 경우 시니어와 동일한 자격으로 신청 가능합니다.
- **거주 요건:** 뉴저지 주에 주 주거지를 소유하거나 임대하고 있어야 합니다. (Senior Freeze의 경우 신청 과세 연도 포함 최소 3년 연속 뉴저지 거주 및 동일 주택 소유)

신청 방법

- 온라인 접수 (권장): propertytaxreliefapp.nj.gov 접속.
 - ID.me 본인 인증: 보안을 위해 운전면허증, 주정부 ID, 또는 여권을 통한 신원 확인이 필요합니다.
 - 65세 미만 ANCHOR 신청: [ANCHOR](#)
- 서류 준비: 사회보장번호(SSN) 또는 ITIN.
 - ANCHOR: NJ-1040 Line 29 총소득
 - Senior Freeze/Stay NJ: 별도 소득 계산 양식(비과세 소득 포함, PAS-1 지침 참고)
 - PAS-1 통합 신청자(65세+): 지난 2년간의 NJ-1040 및 재산세 고지서(County Code, Block/Lot/Qualifier, 세액) 필요

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ.gov Division of Taxation – 재산세 감면 프로그램](#)
- [PAS-1 통합 신청 포털](#)
- [NJ Division of Taxation – 재산세 감면 프로그램 FAQ](#)

재산세 환급 (PTR / Senior Freeze)

Senior Freeze라고도 하는 뉴저지 재산세 환급 제도(Property Tax Reimbursement, PTR)는 자격 요건을 갖춘 시니어와 장애인을 대상으로, 재산세가 인상된 만큼을 주 정부가 직접 환급해 주는 제도입니다. 이 프로그램의 핵심은 처음 자격을 갖춘 해의 재산세액(Base Year Amount)을 고정하고, 그보다 더 많이 낸 세금은 모두 돌려받는 것입니다.

자격 요건

- **연령 및 장애**
 - 대상 세금 연도(Tax Year) 12월 31일 기준 만 65세 이상
 - 사회보장국(SSA)으로부터 장애인 소셜 시큐리티 연금(Social Security Disability) 또는 철도퇴직 장애연금(Railroad Retirement Disability)을 본인 명의로 직접 수령해야 하며, 타인 대신 수령하는 경우는 제외됨 .
- **거주 요건:** 신청 연도 포함 최소 3년 이상 뉴저지에서 동일 주택을 소유하며 주 거주지로 거주해야 함.
재산세 납부: 신청 대상 각 연도의 재산세가 완납되어 있어야 합니다.

소득 제한

신청 연도 (Filing Year)	대상 소득 연도	소득 제한 (Gross Income)
2024년 신청	2023년 소득	\$163,050 이하
2025년 신청	2024년 소득	\$168,268 이하
2026년 신청	2025년 소득	\$172,475 이하

*소득의 정의: Social Security, 개인 연금(Pension), IRA 인출액 등을 모두 포함한 총소득(Gross Income) 기준입니다.

신청 방법 및 일정

- **신규 신청자 (PTR-1):** 처음 신청하는 경우 기준 연도를 설정하기 위해 2년간의 소득 및 세금 정보를 제출합니다.
- **기존 수혜자 (PTR-2):** 주 정부에서 미리 정보가 인쇄된 양식을 우편으로 보내줍니다.
- **통합 포털:** 정부가 자동으로 신청서를 제출해주지 않습니다. 매년 [PAS-1 통합 신청서](#)를 통해 직접 온라인 또는 서면으로 접수해야 Senior Freeze를 포함한 다른 시니어 혜택(Stay NJ, ANCHOR)을 함께 검토받을 수 있습니다.
- **마감 기한:** 일반적으로 매년 10월말-11월초 사이 마감합니다.
- **지급 시기:** 일반적으로 매년 7월 15일부터 신청 시기에 따라 순차적으로 지급됩니다.

주의사항

- **Stay NJ와의 중복:** Stay NJ는 Senior Freeze와 ANCHOR 혜택을 먼저 계산한 뒤 적용됩니다. 세 혜택의 합산액이 재산세의 50%(\$6,500 한도)를 초과하지 않도록 Stay NJ 금액이 조정됩니다.
- **이사 시 주의:** 뉴저지 내에서 이사를 하더라도 새로운 집에서 다시 3년의 소유 및 거주 기간을 채워야 다시 신청할 수 있습니다. 기존 연도도 새로 설정됩니다.
- **임대 주택:** 본인이 소유한 건물의 전체 가구 수가 4가구(4 Units)를 넘지 않아야 하며 직접 거주해야 합니다. 또한 상업용 유닛이 1개 초과인 건물은 제외됩니다.

문의

- 뉴저지주 공식 안내 전화: NJ Senior Freeze 1-800-882-6597
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ.gov – Division of Taxation – Senior Freeze\(PTR\)](#).
- [PAS-1 통합 신청 포털](#)

주거용 요양 시설 (Residential Health Care Facilities, RHCF)

주거형 요양 시설(RHCF)은 독립적인 생활은 어느 정도 가능하지만, 만성적인 질환이나 노령으로 인해 약간의 의료적 감독과 일상생활의 지원이 필요한 사람들을 위한 거주형 시설입니다.

흔히 자택 생활과 어시스티드 리빙(Assisted Living)의 중간 단계로 이해되며, 거주자에게 안전한 주거 환경과 함께 기본적인 건강 관리 서비스를 제공하는 것이 목적입니다.

서비스 및 지원 내용

주거형 요양 시설은 단순한 주거를 넘어 다음과 같은 감독형 건강 관리(Supervised Health Care) 서비스를 제공합니다.

- **24시간 감독:** 응급 상황을 대비하여 전문 인력이 상주하며 관리합니다.
- **건강 관리 서비스:** 혈압 체크, 투약 관리(Medication Management) 등 기본적인 의료 모니터링을 제공합니다.
- **일상생활 보조:** 식사 제공, 세탁, 청소 서비스 및 개인위생 지원이 포함됩니다.
- **사회적 활동:** 거주자들의 정서적 건강을 위한 다양한 레크리에이션 및 사교 프로그램을 운영합니다.
- **식이 관리:** 영양을 고려한 균형 잡힌 식단을 제공합니다 (일부 시설은 영양사 지도하에 운영)

자격 요건

- **연령:** 일반적으로 만 60세 이상 시니어를 대상으로 합니다.
- **건강 상태**
 - **의료적 필요성:** 병원에 입원할 정도는 아니지만, 집에서 혼자 살기에는 안전이 우려되거나 투약 관리 등 정기적인 도움이 필요한 상태여야 합니다.
 - **이동성:** 대부분의 RHCF는 스스로 또는 보조 기구(지팡이, 워커)를 이용하여 어느 정도 이동이 가능한 분들을 선호합니다.
 - **정신 건강:** 타인에게 위해를 가하지 않고, 공동생활이 가능한 인지 상태를 갖추어야 합니다. 심한 치매 또는 중증 정신질환이 있는 경우 전문 메모리 케어 또는 정신건강 전문 시설이 더 적합할 수 있습니다.
- **재정 증명:** 월 임대료 및 서비스 비용을 지불할 수 있는 경제적 능력을 심사합니다. 일반적으로 메디케이드의 적용을 받지 않습니다. 주거형 요양 시설 거주자의 약 40%가 SSI, 50%는 사비, 나머지는 Veterans Benefits 등을 활용합니다. SSI 수혜 여부는 사전에 확인하십시오.

**개별 시설마다 입주 자격 요건이 상이하므로 사전 확인 필요*

뉴저지 주거형 요양 시설

지역 (Town)	시설명 (Community Name)	특징	연락처
Allendale	Allendale Senior Living	버겐 카운티 소재 주거형 요양 시설로 기초 돌봄 서비스 제공.	201-825-0660
Montclair	Horizon Manor South	주거와 식사, 기초 건강 모니터링에 집중한 기초 돌봄 및 메모리 케어 제공. 가족 같은 소규모 공동체 분위기를 선호할 때 적합.	973-746-9047
Bloomfield	Job Haines Home	120년 이상의 역사를 가진 비영리 시설로, 별도의 주거형 요양 섹션 운영.	973-743-0792

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ.gov – DOH 주거용 요양 시설 검색](#)
- [NJ.gov – Residential Healthcare 시설 검색](#)
- [NJ 211.org](#)

시니어 전용 주거 단지 (Adult Retirement Communities)

Adult Retirement Communities는 흔히 액티브 어덜트 커뮤니티(Active Adult Communities) 또는 55+ 커뮤니티로 불리며, 건강하고 독립적인 생활이 가능한 시니어들을 위해 설계된 관리형 주거 단지입니다. 어시스티드 리빙(Assisted Living)이나 널싱홈과 달리, 이곳은 의료 서비스나 일상 활동 보조를 제공하지 않습니다. 대신, 비슷한 생애 주기에 있는 또래들과 함께 사회적으로 활기찬 생활을 영위할 수 있는 환경을 조성하는 데 중점을 둡니다. 이 단지들의 가장 큰 매력은 연령 제한을 통한 조용한 생활 환경, 리조트 스타일의 부대시설, 그리고 조경 관리나 제설 작업과 같은 번거로운 주택 유지보수 의무가 없다는 점에 있습니다. 이러한 커뮤니티는 수천 가구가 모인 대규모 계획 도시 형태부터 소규모 Gated Community까지 그 형태가 매우 다양합니다.

자격 요건

연령

- 연방법에 따라, 실제 거주 중인 유닛의 최소 80% 이상에 55세 이상 가구원이 1명 이상 거주해야 합니다.
- 62세 이상 커뮤니티는 별도의 HOPA(Housing for Older Persons Act) 면제 조항이 적용되며, 이 경우 *모든* 거주자가 예외 없이 62세 이상이어야 합니다. (80% 규칙이 아닌 100% 기준)
- 동거인은 일반적으로 만 18세 이상이어야 하며, 단지별 규정에 따라 상이할 수 있습니다.

미성년 거주 제한

- 대부분의 55+ 단지는 미성년 자녀의 영구 거주를 허용하지 않습니다. 단, 단지별 규약에 따라 다를 수 있으므로 입주 전 반드시 확인해야 합니다.
- 방문객 체류 기간은 단지별 규약(CC&R)에 따라 연간 2주~90일 수준까지 다양하며, 입주 전 반드시 확인해야 합니다.

독립 생활 능력

- 스스로 일상 관리가 가능한 독립적 거주자를 대상으로 합니다. 의료 서비스나 간병은 제공되지 않습니다.

재정 및 신분 증명

- 나이를 증명할 서류(여권, ID)와 함께 임대형은 소득·신용 심사, 소유형은 주택 구매 능력 심사가 필요하며, 구체적인 기준은 단지마다 다릅니다.

반려동물 규정

- 허용되더라도 무게 및 마릿수 제한이 있으므로 단지별 확인이 필요합니다.

주거 형태와 소유 구조

Adult Retirement Communities는 거주자의 예산과 선호도에 맞춰 다양한 주거 양식을 제공합니다. 사생활 보호를 원하는 이들에게는 단독 주택(Single-family detached)이 인기 있으며, 관리가 쉬운 집을 원하는 이들은 타운하우스, 빌라, 콘도미니엄을 선호합니다. 도심 지역에서는 고급 고층 아파트 형태로 운영되기도 합니다. 소유 구조 또한 다음과 같이 다양합니다.

- **단독 소유:** 거주자가 주택과 대지를 직접 소유하는 형태로, 전통적인 교외 단지에서 흔히 볼 수 있습니다.
- **콘도미니엄/Co-op:** 유닛 소유권을 직접 보유하거나 법인 주식(share)을 소유해 특정 유닛 거주권을 가지는 형태. 이 외에 공동 사용 공간이 있으며 HOA가 외관과 조경을 관리합니다.
- **임대형:** 고정 월세를 내면서 고급 부대시설을 누리는 프리미엄 임대 모델이 늘어나는 추세입니다.

뉴저지 시니어 전용 주거단지 (55+ 커뮤니티)

지역 (Town)	단지명 (Community Name)	주거 형태	주요 특징	연락처
Florham Park	Del Webb at Florham Park	단독 주택 + 타운하우스(어 테치드) + 콘도미니엄 (총 3가지 주거 유형)	대표적인 55+ 브랜드. 실내외 수영장, 스마트 홈 시스템, 전담 라이프 스타일 디렉터 상주.	973-969-3495
Wayne	Four Seasons at Wayne	1~2층 콘도(엘리베이터 접근 가능)	230유닛 규모의 55+ 게이티드 커뮤니티.	503-746-4122
Wanaque	Del Webb's Wanaque Reserve	아파트형 콘도	대규모 럭셔리 55+ 단지	1-800-870-0010
Livingston	The Pointe at Livingston	콘도 (게이티드)	조용하고 격식 있는 분위기이며, 입주 주민들 간의 커뮤니티 활동이 매우 활발함.	973-810-8208
Livingston	The Enclave at Livingston	임대 아파트(게이티드)	리빙스턴의 우수한 지역 인프라를 누리며, 조용하고 프라이빗한 주거를 선호하는 시니어들을 위한 전용 공간.	973-422-9300
Tinton Falls	Enclave at Tinton Falls	싱글 홈 (단독)	55+ 단독 주택 단지로, 정원 관리와 제설 등 모든 관리를 단지에서 대행하는 정통 럭셔리 실버 타운.	732-800-2005

***방문 시 확인 사항:** 주택 소유주 협회 (HOA)의 재정 상태(Reserve Funds)가 튼튼한지, 현재 주민들의 연령대가 본인과 잘 맞는지, 인근에 우수한 종합병원이 있는지 반드시 확인하십시오.

*단지별 정책(연령 기준, HOA 규정 등)은 변경될 수 있으니 입주 전 각 단지 관리사무소에 직접 확인.

문의

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ 211.org](http://NJ211.org)
- [NJ Housing Resource Center \(NJHRC\)](http://NJHousingResourceCenter.org)

리버스 모기지 (Reverse Mortgage)

리버스 모기지(Reverse Mortgage)는 62세 이상 고령자가 주택 자산(Equity)을 담보로 현금을 수령하면서 평생 거주할 수 있도록 설계된 대출입니다. 가장 대표적인 상품은 연방 주택청(FHA)이 보증하는 HECM(Home Equity Conversion Mortgage)입니다.

자격 요건

- **연령: 만 62세 이상** / 62세 미만 배우자는 비차입 배우자(Non-Borrowing Spouse)로 등록할 경우, HUD 자격 요건 충족 시 배우자 사망 후에도 거주권을 보호받을 수 있습니다. (별도 자격 요건 확인 필요)
- **거주 조건:** 해당 주택이 반드시 주 거주지(Principal Residence)여야 하며, 1년 중 6개월 이상 거주해야 합니다.
- **주택 자산:** 주택을 완전히 소유하고 있거나, 기존 모기지 잔액이 적어 리버스 모기지 대금으로 즉시 전액 상환이 가능해야 합니다.
- **재무 평가:** 대출 실행 전 차입자(Borrower)의 신용 이력, 소득·현금 흐름, 재산세·보험 납부 능력 등이 종합 평가되며, 미납 연방 채무가 있으면 대출이 제한될 수 있습니다.

대출 한도(2026)

- **최대 대출 한도:** \$1,249,125는 FHA가 대출 산정 시 인정하는 주택 가치의 최대 상한선이며, 실제 수령액은 나이·이자율·주택 가치 등에 따라 결정됩니다.
- **수령 방법:** 일시불, 월별 연금식 수령, 크레딧 라인(Line of Credit) 방식 중 선택할 수 있으며, 여러 방식을 혼합할 수도 있습니다.

필수 절차

리버스 모기지는 신청 전 주택도시개발부(HUD)의 승인 상담자와의 상담이 법적 의무입니다.

- **상담 내용:** 대출의 비용, 세금에 미치는 영향, 상속 문제 및 대안(Downsizing 등)을 검토합니다.
- 연방 HECM 규정에 따라 상담 완료 후 최소 3영업일이 지나야 대출 신청서 접수가 가능합니다.
- **상담 유효 기간:** HECM 상담 수료증은 발급일로부터 180일(calendar days) 동안 유효합니다.

주의사항

리버스 모기지는 '공짜'가 아닌 나중에 갚아야 할 대출임을 명심해야 합니다.

- **상환 시점:** 마지막 차입자가 사망, 주택 매각, 또는 연속으로 12개월 이상 집을 비울 때(예: 요양원 입소 등) 대출금 전액을 상환해야 합니다.

- **채무 불이행 위험:** 재산세 미납, 보험 미유지, 주택 관리 소홀 시 강제 퇴거 및 압류가 발생할 수 있습니다.
- **주택 가치 한도 내 상황 책임(Non-Recourse) 원칙:** 대출 잔액이 집값을 초과하더라도, 차입자나 상속인은 집값 이상의 금액을 갚을 책임이 없습니다.
 - 예시: 부모님이 돌아가신 시점에 대출금은 50만 달러인데 집값은 40만 달러로 떨어졌다면 상속인은 부족한 10만 달러를 갚을 필요가 없습니다.

상속인의 선택

차입자 사망일로부터 30일 이내에 집에 대한 의향을 Servicer에게 알려야 합니다. 단, 상속인이 Servicer에게 사망 사실을 최대한 빨리 알리는 것이 중요합니다.

- **선택 1: 집을 팔고 남은 차액 가지기**
 - 집을 팔아서 대출금(원금+이자)을 갚습니다.
 - (집값이 대출금보다 많으면) 차액은 상속인의 몫. (집값이 대출금보다 적으면) 대출 잔액이 집값보다 많은 경우, 집값의 95% 이상으로 매각하면 나머지 잔액은 FHA 보험으로 처리되어 상속인 추가 부담 없음.
- **선택 2: 대출금을 갚고 집을 유지하기**
 - 상속인이 집을 계속 소유하고 싶다면, 대출기관(lender)이 자료 제출 시 90일 연장을 승인할 수 있으며, 총 약 6개월까 지 처리 시간이 주어질 수 있습니다. 연장 승인 주체는 HUD가 아닌 lender입니다.
 - 집을 유지하려면 대출 잔액 전액 또는 집의 감정가(appraised value)의 95% 중 더 적은 금액을 납부하면 됩니다.
- **선택 3: 집의 소유권을 은행에 넘기기 (Deed in Lieu of Foreclosure)**
 - 집값보다 대출금이 더 많거나, 집을 파는 과정이 번거로운 경우 상속인이 자발적으로 소유권을 은행에 넘기는 방식입니다.

문의

- **HUD(미국 주택도시개발부):** 1-800-569-4287
- **Bergen County Reverse Mortgage Housing Counseling:** 201-336-7431
- **NJ Housing and Mortgage Finance Agency (NJHMFA):** 1-800-654-6873 – 시니어를 위한 주거 금융 프로그램 관리
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [HUD.gov](https://www.hud.gov) – 미국 주택도시개발부 승인 상담소 찾기
- [HUD.gov](https://www.hud.gov) – 미국주택도시개발부 HECM 공식 규정 및 대출 한도 확인
- [CFPB.gov](https://www.consumerfinance.gov) (소비자금융보호국) – 소비자 보호 가이드 및 위험 요소 안내

섹션 8 (Section 8)

섹션 8은 저소득층 가구가 민간 시장에서 안전하고 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있도록 연방 주택도시개발부(US Department of Housing and Urban Development, HUD)가 임대료의 일부를 지원하는 프로그램입니다. 정식 명칭은 주거 선택 바우처 (Housing Choice Voucher, HCV) 프로그램입니다.

섹션 8의 가장 큰 특징은 세입자가 부담하는 금액이 소득에 연동된다는 점입니다.

- 세입자는 일반적으로 월 조정 소득의 30%를 부담하며, 최초 입주 시 총 임대료가 정부 기준 (payment standard)를 초과하는 경우 세입자는 최대 40%까지 부담할 수 있습니다
- 지역 주택국(Public Housing Authority)은 주거 지원금(Housing Assistance Payment, HAP) 형태로 집주인에게 직접 지급합니다.

섹션 8의 두 가지 유형

구분	주거 선택 바우처 (Tenant-Based)	프로젝트 기반 바우처 (Project-Based)
대상	세입자(개인)에게 바우처 지급	특정 아파트 유닛에 보조금 지정
이동성	이사 시 바우처를 들고 갈 수 있음	이사 시 바우처는 해당 유닛에 남습니다. 단, PBV(Project-Based Voucher)에 한해 12개월 거주 후 테넌트 기반 바우처(tenant-based voucher)를 신청해 이주할 수 있습니다
집 선택	바우처를 받아주는 민간 주택 어디든 가능	지정된 아파트에 입주해야 혜택 발생
비고	보통 '섹션 8 바우처' 로 알려져 있음	시니어 아파트, 장애인 주거, 재개발 주택 등 PHA가 지정한 특정 유닛

자격 요건

- 소득 기준
 - 가구 연간 총소득(Annual Gross Income)이 해당 지역 중간 소득(AMI)의 50% 이하
 - 바우처의 75%는 중간 소득의 30% 이하인 '최저 소득층'에게 배정됩니다.
- 가구 구성: 62세 이상 시니어, 장애인, 자녀 있는 가구, 재향군인(Veterans) 등이 우선 고려 대상이 될 수 있습니다.
- 신분: 시민권자 또는 적격한 이민 신분(영주권자 등)

- **배제 사유:** 마약 관련 범죄, 성범죄 기록 등이 있는 경우 자격이 제한될 수 있습니다. 세부 기준은 PHA마다 다릅니다. 또한 과거 공공주택에서 퇴거 조치(Eviction)를 당한 기록이 있으면 자격이 제한될 수 있습니다.
- **자산 한도:** 순가족자산(Net Family Assets)이 \$105,574(2026년 기준)를 초과하거나, 거주 가능한 부동산을 소유한 경우 바우처 수혜가 제한될 수 있습니다.(차량·의료기기 등 필수 자산은 제외될 수 있음)
- **소득 공제:** 시니어·장애인 가구에 적용되는 소득 공제(의료비 등) 기준이 HOTMA(Housing Opportunity Through Modernization Act)규정에 따라 조정됩니다.

**PHA별 자격 요건이 상이할 수 있으므로 개별 확인*

신청 및 입주 절차

1. **신청서 접수:** 거주 희망 지역의 [공공주택국\(PHA\)](#)에 신청서를 제출합니다.
 - [뉴저지 버겐 카운티 주택국](#)에서 HABC가 운영하는 모든 주거 프로그램(섹션 8 바우처, 공공주택, 시니어 아파트 등)의 대기자 명단을 한 곳에서 확인하고 신청할 수 있습니다.
 - 단, 섹션 8(HCV) 바우처 대기자 명단 오픈 시기는 불규칙하며 수년간 닫혀있을 수 있습니다. HABC 공식 사이트를 수시로 확인해야 합니다.
2. **대기 명단(Waitlist) 등록:** 신청자가 많아 명단이 닫혀 있는 경우가 많으므로, 명단이 열릴 때 즉시 등록해야 합니다. (노인/장애인은 우선순위를 받을 수 있음)
3. **자격 심사 인터뷰:** 순번이 되면 공공주택국(PHA)에서 연락이 오며, 이때 소득, 자산, 가족 구성에 대한 증빙 서류를 제출하고 인터뷰를 진행합니다.
4. **바우처 발급:** 승인이 나면 바우처가 발행됩니다. 바우처 발급 후 최소 60일~최대 120일 이내에 주택을 찾아야 합니다. (PHA 재량으로 연장 가능)
5. **주택 검사(Inspection):** 집을 찾으면 집주인과 함께 입주 승인 요청서(RFTA)를 제출하고 해당 주택에 대해 공공주택국(PHA)으로부터 주택 안전 기준(HQS 또는 NSPIRE — PHA마다 다름) 검사를 받습니다.
6. **계약 체결:** 공공주택국(PHA)과 집주인 사이의 계약(HAP Contract), 세입자와 집주인 사이의 임대 계약이 동시에 체결됩니다.

문의

- [뉴저지 공공주택국\(PHA\) 타운별 연락처](#)
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [HUD.gov – Housing Choice Vouchers Fact Sheet](#)
- [NJ.gov – New Jersey Housing Authority Contact List](#)
- 버겐 카운티 섹션 8 공식 링크

- 공식 웹사이트: habcnj.org
- 신청 포털 (HCV Applicant Portal): habcnj.org/apply_for_housing
- 대기 명단 상태 확인: waitlistcheck.com

시니어 아파트 (Senior Apartments)

시니어 아파트는 62세 이상의 독립적인 생활이 가능한 노인들을 위해 설계된 주거 시설로, 의료 서비스나 간병 제공 없이 노인 친화적 설계와 사교 서비스를 갖춘 독립형 임대 아파트입니다.

소득 연동형

HUD (U.S. Department of Housing and Urban Development) Section 202(비영리 운영, HUD 보조) 와 Public Housing(PHA 운영) 등의 형태가 있으며 연방 정부(HUD)의 지원을 받는 대부분의 저소득층 시니어 아파트가 채택하는 방식입니다.

- 조정 후 월 소득(Adjusted Monthly Income)의 약 30%를 렌트비로 냅니다.
- 유틸리티: 전기, 가스 등 공과금이 포함되는 경우가 많으며, 포함되지 않을 경우 렌트비에서 일정 금액(Utility Allowance)을 차감해 주기도 합니다.

자격요건

- 가구원 중 한명이 만 62세 이상 미국 시민권자 또는 적격 비시민권자(영주권자 포함)
- 건물마다 다를 수 있으며, 일반적으로 HUD 주택 퇴거 이력 및 특정 범죄 기록이 심사됩니다.

소득 제한

가구원 수	30% AMI (Extremely Low)	50% AMI (Very Low)
1인 가구	약 \$28,850 이하	약 \$48,000 이하
2인 가구	약 \$32,950 이하	약 \$54,850 이하

이 수치는 HUD가 모든 연방 주택 지원 프로그램에 공통으로 사용하는 소득 기준입니다. 시니어 아파트의 자격 상한은 50% AMI(Very Low Income)이며, 30% AMI는 입주 우선순위 부여 기준입니다.

자산 제한

- **자산 한도:** 자산 한도(\$105,574, 2026년 기준)가 적용될 수 있으며, 건물마다 시행 여부가 다를 수 있으니 건물 담당자에게 확인해야 합니다.
- **주택 소유:** 거주 가능한 부동산을 소유한 경우 자격이 제한될 수 있으며, 장애 관련 예외 등이 인정될 수 있습니다

고정 임대료형 (LIHTC / Affordable Housing)

LIHTC(Low-Income Housing Tax Credit)는 연방 정부의 세제 혜택을 통해 민간 건설사가 저렴한 임대 주택을 공급하도록 장려하는 프로그램입니다.

- 소득의 30%를 내는 것이 아니라, 해당 지역의 중간 소득(AMI)에 따라 미리 정해진 고정 금액을 냅니다.
- 시장 가격보다는 훨씬 저렴하지만, 내 소득이 아주 적더라도 정해진 최소 렌트비는 지불해야 합니다. (보통 AMI의 50%~60% 수준에 맞춰진 금액)
- HUD가 매년 발표하는 지역 AMI 변화에 따라 렌트비가 조정될 수 있습니다.

신청

정보 수집

뉴저지는 온라인 또는 직접 해당 아파트를 찾아가서 신청해야 하며 대기자 명단(Waitlist)이 열리는 시기도 다르므로 미리 전화로 문의해야 합니다. 아래 사이트들을 수시로 체크하세요.

- **NJHRC (New Jersey Housing Resource Center):** njhrc.gov – 뉴저지 공식 주택 검색 사이트.
- **Affordable Homes New Jersey:** affordablehomesnewjersey.com – NJ DCA 승인 민간 행정 대리인 (CGP&H) 운영 사이트(일부 저소득 주택 대기자 명단 신청 가능)
- **지역 주택국 (Housing Authority):** 본인이 거주하는 카운티(예: Bergen 등)의 Housing Authority 웹사이트를 직접 방문해 'Senior Housing' 공고를 확인하세요. [뉴저지 공공주택국\(PHA\) 타운별 연락처](#)

대기자 명단 등록

대부분의 인기 지역은 대기 기간이 오래 걸릴 수 있습니다. 시니어 아파트는 여러 곳에 신청이 가능합니다.

문의

- [뉴저지 공공주택국\(PHA\) 타운별 연락처](#)
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- NJ.gov – [Housing Resource Center \(NJHRC\)](#)
- [Housing Authority of Bergen County \(HABC\)](#)
- Huduser.gov – [전국 소득 기준 자료](#)
- [HUD 지역별 AMI 기준 자료 \(PDF\)](#)

스테이 뉴저지 (Stay NJ)

Stay NJ는 뉴저지 시니어들이 높은 세금 부담 때문에 정든 집을 떠나지 않도록 돕기 위해 도입된 획기적인 재산세 경감 혜택 프로그램입니다. Stay NJ는 ANCHOR-Senior Freeze와 함께 운영되는 별도 혜택 프로그램으로, 세 프로그램의 합산 혜택이 재산세의 50%(최대 \$6,500)에 도달하도록 설계되어 있습니다.

환급액 산정

- 납부한 재산세의 50%에 해당하는 혜택을 지급합니다.
- 연간 재산세 최대 \$13,000 기준, 최대 \$6,500까지 환급 (재산세가 \$13,000 이상이어도 상한은 \$6,500)
- 산정 방식: Stay NJ 환급액은 단독으로 지급되는 것이 아니라, ANCHOR와 Senior Freeze 환급액을 먼저 합산한 후, 그 차액을 Stay NJ가 채워주는 방식입니다.
 - 예시: 재산세 \$10,000 → 목표 혜택 \$5,000. ANCHOR \$1,750 + Senior Freeze \$500 = \$2,250 수령 시, Stay NJ는 \$2,750 추가 지급

자격 요건

- **연령:** 신청 연도 기준 만 65세 이상인 자 (장애인 소셜 시큐리티 연금(SSDI)는 Stay NJ 해당 없음. Senior Freeze-ANCHOR는 별도 검토 가능)
- **소득:** 연간 총소득(Gross Income) \$500,000 이하
- **거주 요건:**
 - 해당 세금 연도 1월 1일~12월 31일 전체 기간 동안 뉴저지 내 본인 소유 주택에 거주. 단, 같은 해 뉴저지 내에서 이사한 경우 별도 Schedule 작성이 필요합니다.
 - 모바일 홈 소유자는 Stay NJ 자격이 없습니다. 단, Senior Freeze는 모바일 홈 포함, ANCHOR는 모바일 홈 소유자를 '세입자'로 취급하여 별도 신청 가능합니다.

신청 방법

- **신규 신청자:** [PAS-1 통합 신청서](#)를 통해 해당 연도 및 전년도 소득·재산세 정보를 제출합니다. (Senior Freeze 심사에 2년 치 소득이 사용됩니다)
- **재신청자:** Stay NJ는 매년 [PAS-1 통합 신청서](#)를 통해 직접 신청해야 합니다. 자동 신청 및 자동 우편 발송은 없습니다. 매년 온라인 또는 서면으로 접수해야 Stay NJ를 포함한 다른 시니어 혜택(ANCHOR, Senior Freeze)을 함께 검토받을 수 있습니다.

지급 방식

- Stay NJ는 분기별(2월·5월·8월·11월)로 균등 분할 지급됩니다.
- 온라인 신청자는 일부 혜택(주로 ANCHOR)에 한해 Direct Deposit 선택 가능. 종이 신청자는 모든 혜택을 수표로 수령합니다.
- 주 예산안과 신청 시기에 따라 매년 분기별 일정이 공지됩니다.

문의

- **Stay NJ 및 통합 신청 전용 핫라인:** 1-888-238-1233
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ Division of Taxation – Stay NJ Portal](#)
- [PAS-1 통합 신청 포털](#)

재택 케어 (In-Home Care)

In-Home Care

자택 내 독립 생활 지원: 개인 맞춤형 돌봄(PPP), 뉴저지 커뮤니티 케어기빙(JACC), 가족 간병인을 위한 휴식 돌봄(Respite Care), 가정 간호·요양(Home Health Care), 식사 배달(Meals on Wheels) 및 커뮤니티 무료 급식.

본 부문 총 6개 상세 안내 문서 수록

시니어 단체 급식(Congregate Meals)

시니어 단체 급식(Congregate Meals)은 시니어 센터, 교회, 학교, 커뮤니티 센터와 같은 그룹 환경에서 제공되는 영양가 있는 식사 서비스입니다. 이 프로그램은 고령층에게 건강한 음식을 제공하는 동시에 노인들 사이의 사회적 상호작용을 촉진하여 고립감을 해소하도록 설계되었습니다.

단순히 한 끼 식사를 해결하는 것을 넘어, 이웃과 소통하며 정서적 지지를 얻을 수 있는 중요한 커뮤니티의 역할을 수행합니다.

특징

- **영양 식단:** 노인법(OAA) 기준에 따라 미국 식이 지침(DGA) 및 영양소 섭취기준(DRI)을 충족하는 균형 잡힌 영양 식단을 제공.
- **사회적 참여:** 타인과의 교류를 통해 노년기 소외감을 줄이고 전반적인 웰빙을 개선합니다.
- **높은 접근성:** 시니어 센터, 종교시설, 커뮤니티 센터, 일부 협력 시설 등 다양한 장소.
- **부가 서비스 제공:** 단순 급식 외에도 웰니스 체크, 만성 질환 관리 교육, 낙상 예방 교육 등 유익한 프로그램을 함께 제공합니다.

자격 요건

- 60세 이상 또는 수혜자의 배우자 (연령 무관)
- 60세 이상 수혜자와 함께 거주하는 장애인 (연령 무관)
- 식사 시간 중 봉사하는 프로그램 자원봉사자

*세부 자격 요건은 지역 프로그램에 따라 다를 수 있으므로 ADRC에 문의.

비용

식사는 무료로 제공됩니다. 프로그램 지속을 위해 식사당 \$1.25의 자발적 기부를 권장하지만, 기부 여부와 관계없이 서비스가 제공됩니다. 기부 내역은 비공개로 처리됩니다.

신청 및 문의

- 사전 예약 필수: 장소별로 식사 수량이 한정되어 있어, 보통 24시간 전에 미리 예약해야 합니다.
- 거주 지역의 노인 및 장애인 지원 센터(ADRC) 연락
 - **버겐 카운티 노인국 (Bergen County Division of Senior Services)**
 - 주소: One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601

- 전화: 201-336-7400
- 이메일: seniors@bergencountynj.gov
- 뉴저지 **ADRC** 공통 무료전화: 1-877-222-3737
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org).

참고 자료

- [ACL.gov 영양 서비스 공식 안내](#)
- [버겐 카운티 공식 영양 서비스 정보](#)
- [버겐 카운티 시니어 점심 브로슈어 \(한국어\) \(PDF\)](#)

홈케어 (Home Health Care)

홈케어는 거동이 불편한 주민이 영양원 대신 본인의 자택에서 안전하게 일상생활을 영위할 수 있도록 전문 간병인을 파견하는 프로그램입니다.

특징

공인된 홈케어 에이전시 소속의 자격증이 있는 전문 간병인(Certified Home Health Aide, CHHA)이 자택으로 방문합니다. 에이전시는 뉴저지 보건부(Department of Health), 간병인(CHHA) 개인은 뉴저지 간호위원회(Board of Nursing)의 관리를 받습니다.

- 개인 위생 지원: 목욕, 머리 감기, 옷 입기, 구강 관리, 화장실 이용 보조.
- 이동 보조: 침대에서 휠체어로 이동, 실내외 걷기 보조.
- 영양 관리: 식사 준비, 식사 보조, 특별 식단 관리.
- 가사 지원: 환자가 사용하는 공간의 가벼운 청소, 세탁, 장비, 약 복용 일정 알림 (직접 투약은 불가).
- 전문성: 모든 서비스는 담당 간호사(RN)의 지도 아래 수립된 '간호 계획(Plan of Care)'에 따라 수행됩니다.

자격 요건 (2026년)

홈케어 서비스를 받기 위해서는 재정적 요건과 의료적 요건을 모두 충족해야 합니다.

재정적 요건

- 홈케어 서비스는 단순 일반 메디케이드(NJ FamilyCare)가 아닌 롱텀케어 메디케이드(MLTSS) 자격이 필요합니다. 일반 메디케이드를 보유하고 있어도 MLTSS 임상 평가를 통해 추가 등록이 필요합니다.
- 소득 기준: 월 수입 **\$2,982** 이하
수입이 초과될 경우 '소득 신탁(QIT)'을 통해 자격 확보 가능.
- 자산 기준: 총 자산 **\$2,000** 이하
거주 중인 주택과 자동차 1대는 자산 산정에서 제외됩니다.

의료적 요건

- **넬싱홈 입소 수준(Nursing Facility Level of Care):** 독립적인 생활이 불가능하여 최소 3가지 이상의 일상 활동(ADL)에서 타인의 도움이 반드시 필요하다는 임상 판정을 받아야 합니다.
- 의사 처방: 반드시 의사가 "홈케어 서비스가 필요하다"는 소견서를 발급해야 합니다.

신청 절차

1. 상담 및 사전 심사: 거주 카운티의 노인 및 장애인 지원 센터(ADRC)에 연락하여 초기 전화 스크리닝을 받습니다.
2. 카운티 사회복지국 (Board of Social Services)을 통한 재정 자격 심사(Medicaid)
3. 임상 평가: 관리 보험사(MCO) 소속 간호사가 직접 자택을 방문하여 환자의 상태(ADL)를 심사하고 주당 이용 가능한 시간을 결정합니다.
4. 에이전시 배정: 승인된 시간만큼 서비스를 제공할 홈케어 에이전시를 선택합니다.
5. 서비스 개시: 간병인이 파견되어 정해진 스케줄에 따라 케어를 시작합니다.

**홈케어 서비스의 처리 기간은 케이스마다 다릅니다. 긴급히 서비스가 필요한 경우 ADRC 또는 담당 CSSA(County Social Service Agency)에 긴급 처리(Fast-Track) 가능 여부를 문의하시기 바랍니다.*

문의

- 롱텀케어 메디케이드(MLTSS): 거주 지역의 노인 및 장애인 지원 센터(ADRC) 연락
 - **버겐 카운티 노인국 (Bergen County Division of Senior Services)**
 - 주소: One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
 - 전화: 201-336-7400
 - 이메일: seniors@bergencountynj.gov
 - **버겐 카운티 사회복지국 (Bergen County Board of Social Services)**
 - 주소: 218 Route 17 North, Rochelle Park, NJ 07662
 - 전화: 201-368-4200
 - **뉴저지 ADRC 공통 무료전화: 1-877-222-3737**
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다. (201-862-1665 / info@awcanj.org)
- **AWCA Homecare Agency**
 - 한국어: 201-862-9111
 - 중국어: 201-862-0006

참고 자료

[NJ.gov: 뉴저지주 장애인 서비스국\(DDS\) PCA 안내](#)

[NJ FamilyCare 온라인 신청](#)

[NJ.gov: 롱텀케어 메디케이드\(MLTSS\) 상세 안내](#)

[cahcusa.org: 홈케어 기관 검색](#)

[NJ.gov: 뉴저지주 공식 라이선스 조회](#)

[NJ.gov: 간병인\(CHHA\) 개요](#)

뉴저지 간병 지원 프로그램(JACC)

뉴저지 간병 지원 프로그램(Jersey Assistance for Community Caregiving, JACC)은 신체적으로 지원이 필요한 뉴저지 시니어들의 널싱홈 입소를 예방·지연하고, 자택에서 독립적인 생활을 유지할 수 있도록 지원하는 프로그램입니다. 이 프로그램은 노인들이 익숙한 환경에서 안전하고 독립적으로 생활할 수 있도록 돕는 다양한 맞춤형 서비스를 포함하고 있습니다.

혜택

- **케어 관리(Care Management):** 전담 케어 매니저가 개인별 맞춤형 케어 계획 수립.
- **개인 돌봄 서비스(Personal Care Assistance / Homecare Services):** 일상생활 활동(세면, 식사 등)에 대한 지원.
- **휴식 돌봄(Respite Care):** 가족 간병인에게 일시적인 휴식과 대리 돌봄을 제공.
- **가사일 지원(Chore Service):** 청소, 세탁, 심부름 등 일상 가사 보조 서비스.
- **주택 개조:** 안전성과 접근성을 높이기 위한 주거 환경 개선.(휠체어 경사로 설치, 출입문 확장, 욕조 교체)
- **특수 의료 장비 및 소모품:** 가정 간호에 필수적인 장비와 물품들을 제공.
- **개인 비상 응답 시스템:** 24시간 긴급 지원 요청이 가능한 시스템을 설치.
- **가정 배달 식사:** 노인들을 위한 영양가 있는 식사 배달 서비스를 지원.
- **어덜트 데이 케어:** 사회적 교류 및 의료적 지원이 있는 주간 프로그램을 이용.
- **교통 지원:** 병원에 방문할 때 필요한 이동 서비스 제공.
- 뉴저지가 해당 서비스 업체에 참여자 1인당 한 달에 최대 \$1,090(케어 관리 비용 별도)까지 대신 지불.

자격 요건

- **연령/대상:** 60세 이상 뉴저지 거주 시민권자 또는 적격 이민 신분자(Qualified Alien) -영주권자 포함, 단 비자 종류에 따라 자격 상이
- **거주 환경:** 자택 거주(널싱홈이나 타 시설 제외)
- **건강 상태:** 목욕, 화장실 이용, 착의, 이동 등 일상생활 (ADL) 중 최소 3가지 이상에서 도움이 필요하다고 임상 평가로 판정된 자.
- **메디케이드(NJ FamilyCare)** 또는 롱텀케어 메디케이드(MLTSS) 미수혜자.
- **자산 :** 유동 자산이 개인 \$40,000 이하 또는 부부 \$60,000 이하
- **소득(2026):** 연방 빈곤선 365% 이하(개인 월 \$4,855, 부부 월 \$6,582)
- **중복 수혜 금지 :** 뇌 트라우마 펀드(TBI), 알츠하이머 데이 케어(AADSP), 간병인 휴식 지원(SRCP), 개인 지원 서비스 프로그램(PASP) 중 하나라도 이미 혜택을 받고 있다면, JACC를 신청하기 전에 기존 프로그램을 중단하거나 JACC 대신 기존 프로그램을 계속 유지해야 합니다.
- 자격 요건을 갖출 경우, 가족이나 지인을 직접 케어 제공자로 고용할 수 있는 자기 주도 케어 옵션이 제공됩니다.

코페이(Copay)

JACC는 무료 프로그램이 아닙니다. 코페이는 참여자(및 배우자)의 소득을 기반으로 슬라이딩 스케일 방식으로 산정됩니다.

신청 및 문의

- 거주 지역의 노인 및 장애인 지원 센터(ADRC) 연락
 - 버겐 카운티 노인국 (Bergen County Division of Senior Services)
 - 주소: One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
 - 전화: 201-336-7400
 - 이메일: seniors@bergencountynj.gov
 - 뉴저지 ADRC 공통 무료전화: 1-877-222-3737
- AWCA에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

[NJ.gov: 뉴저지 JACC 프로그램](#)

가정 배달 서비스 (Meals on Wheels)

가정 배달 서비스(Meals on Wheels)는 식사를 시니어의 집으로 직접 배달함으로써 독립적인 생활을 돕고, 건강을 증진하며, 사회적 연결을 촉진하는 역할을 합니다.

단순히 음식을 전달하는 것을 넘어, 지역사회의 따뜻한 관심을 전달하며 많은 이들이 낯선 대신 자신의 집에서 오랫동안 건강하게 머무를 수 있도록 지원하는 복지 서비스입니다.

가정 배달 서비스 특징

- **가정 배달 식사:** 식사는 월~금(주 5일) 점심 시간대 배달. 영양사가 계획한 균형 잡힌 식단(주요리, 채소, 빵, 과일, 우유, 디저트 등)으로 구성
- **사회적 상호작용:** 자원봉사자들이 식사를 전달하며 말동무가 되어주고 건강 상태를 확인.
- **안전 및 웰빙 지원:** 노인들의 영양실조를 예방하고 독립성을 유지하며 안전하게 생활할 수 있도록 지원.
- **지역 사회 기반 운영:** 지역 내 다양한 비영리 단체와 자원봉사자들의 참여를 통해 운영.
- **비용:** 무료이나 식사당 \$1.25~\$3의 자발적 기부를 권장합니다. 기부 여부는 비밀이 보장되며 기부를 하지 않아도 서비스는 제공됩니다.
- 서비스 등록 후 6개월마다 담당자가 가정 방문하여 자격 유지 평가를 진행합니다.
*식사당 권장 기부 금액은 지역 및 운영 기관에 따라 상이합니다.

자격 요건

- 60세 이상 시니어 또는 수혜 자격자의 배우자 및 돌봄자(caregiver)도 신청 가능
- 장애인(18-59세): 신체적·정신적 장애(영구적 또는 일시적)로 인해 혼자 거주하며 스스로 식사 준비가 어려운 분. 의사의 소견서(Medical Necessity)나 장애 상태를 증명하는 서류만으로도 충분히 자격 심사가 가능.
- 타인의 도움 없이 외출 불가(Homebound), 스스로 식품 구매 또는 영양 식사 준비가 불가, 도움을 줄 가족·지인 없는 분, 하루 4시간을 초과하는 재가 지원 서비스를 받지 않는 분 (4시간 이하 수령자에 한해 자격 부여)
- 롱텀케어 메디케이드(MLTSS) 비수혜자

*지역 및 운영 기관에 따라 구체적인 자격 요건이 달라질 수 있습니다.

북부 뉴저지 내 가정 배달 서비스

배달 서비스 기관	전화번호	운영 시간	배달 서비스 지역
버겐 카운티 노인국 Bergen County Division of Senior Services	201-336-6000	월 ~ 금 8am ~ 4pm	Bergenfield, Cliffside Park, E. Rutherford, Edgewater, Englewood, Englewood Cliffs, Fort Lee, Leonia, Palisades Park, Ridgefield 등 33개 타운. 자세한 리스트는 링크 확인
Meals on Wheels North Jersey	201-358-0050	24시간 문의 가능	Alpine, Closter, Cresskill, Demarest, Dumont 등 32개 타운. 자세한 리스트는 링크 확인
Community Meals, Inc.	201-447-8295	월 ~ 금 10am ~2 pm	Allendale, Glen Rock, Ho-Ho-Kus, Midland Park, Ridgewood, Waldwick, Saddle River 일부 지역
Essex County Office of Senior Services	973-395-8375	월 ~ 금 10am ~2 pm	Essex County 전체
Jersey City Meals On Wheels	201-547-5750	월 ~ 금 8am ~ 4pm	Jersey City 전체
Middlesex County Nutrition Services	732-745-3295	월 ~ 금 8:30am ~ 2:30pm	Middlesex City 전체
Passaic County Nutrition Services	973-569-4099	월 ~ 금 8:30am ~ 4:30am	Passaic County 전체
Rockland County Meals on Wheels	845-624- 6325	월 ~ 금 9am ~5pm	Rockland County 전체
KCS NJ 가정 급식 배달 프로그램 *한식 제공	201-212-1054	월, 수, 금 점 심	Fort Lee, Leonia, Palisades Park 자세한 내용은 링크 확인

신청 및 문의

- [버겐 카운티 가정 배달 서비스 신청](#)
 - 거주 지역의 노인 및 장애인 지원 센터(ADRC) 연락

- **Meals on Wheels 직통:** 201-336-7420 (월-금 8:00 AM – 4:00 PM)
- **버겐 카운티 노인국 (Bergen County Division of Senior Services)**
 - 주소: One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
 - 전화: 201-336-7400
 - 이메일: seniors@bergencountynj.gov
- 뉴저지 **ADRC** 공통 무료전화: 1-877-222-3737
- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

[Meals on Wheels America 전국 프로그램 검색](#)

[Meals on Wheels North Jersey 북부 뉴저지 프로그램 검색](#)

[버겐 카운티 Meals on Wheels 안내](#)

[버겐 카운티 Meals on Wheels 온라인 신청서](#)

간병인 지정 프로그램(PPP)

간병인 지정 프로그램(Personal Preference Program, PPP)은 자격 요건을 갖춘 개인이 기존의 홈케어 에이전시(Home Health Care Agency) 이용 대신 자신의 개인 간병 서비스를 직접 관리할 수 있도록 허용하는 뉴저지 메디케이드(NJ FamilyCare) 프로그램입니다. 이 프로그램은 환자에게 자신의 간호에 대한 더 많은 통제권과 유연성, 선택권을 부여합니다.

특징

- **직접 고용:** 만 18세 이상의 배우자, 가족, 친척, 친구, 이웃 등을 직접 고용 가능. 단, 권한 대리인 (Authorized Representative)은 동시에 간병인(worker)이 될 수 없음. 간병인은 미국 내 합법적 취업 자격 필요.
- **자율적 운영:** 관리 보험사(MCO)가 승인한 예산 범위 내에서 간병인의 근무 일정과 급여를 설정할 수 있습니다.
- **월간 예산 지원:** 관리 보험사(MCO)가 승인한 간병 시간을 돈으로 환산한 뒤, 운영 수수료를 제외하고 남은 금액이 한 달 치 간병 예산이 됨.
- **유연한 자금 사용:** 독립적인 생활을 지원하는 승인된 물품 및 서비스 구매에 자금을 사용할 수 있습니다. 예: 세탁 서비스, 심부름 서비스, 독립 생활 보조 장비(전자레인지, 세탁기 등). 단, 전문 간호(Private Duty Nursing) 등 의료 서비스는 대상에서 제외됩니다.
- PPP와 기존 에이전시 개인 간병 보조(Personal Care Assistant, PCA) 서비스를 동시에 이용하는 것은 중복 수령으로 간주되어 허용되지 않습니다.

자격 요건

- 환자 본인이 NJ FamilyCare에 가입되어 있어야 합니다.
- 개인 간병 보조(PCA) 서비스가 최소 6개월 이상 필요하다는 의사 처방이 있어야 합니다.
- ADL(일상생활 활동: 목욕, 식사, 이동 등) 지원이 실질적으로 필요한 분. 미성년자도 요건 충족 시 신청 가능(보호자가 대리인 역할).
- 서비스를 직접 관리할 능력이 있거나, 권한 대리인(Authorized Representative)을 통해 관리가 가능해야 합니다.
- 개인 주택·아파트·그룹홈 등 지역사회 거주자 가능. 단, 보조 생활시설(assisted living), 성인 위탁 가정, 개인 간병 보조(PCA)가 서비스 패키지에 포함된 시설 거주자는 제외.

신청 및 문의

- **관리 보험사(MCO) 연락:** MCO에 연락하여 'PPP에 관심이 있다'고 말하거나 'PCA 평가(PCA Assessment)'를 신청하세요. MCO 케어 매니저가 맞춤형 서비스 선택 상담 (Options counseling)과 신청 절차를 안내합니다.
- **평가 및 PPP 선택:** 간호사 방문 평가 시, 에이전시 파견 대신 PPP(간병인 지정 프로그램)를 이용하겠다고 명확히 의사를 밝히십시오.

- MCO 승인 후, 배정된 재정 중개기관(Fiscal Intermediary)의 재정 상담사(Financial Consultant)가 예산 계획 수립과 등록 절차를 지원합니다.

관리 보험사 (MCO)	신청 및 문의 전화
Aetna Better Health	1-855-232-3596
Fidelis Care (구 WellCare)	1-855-642-6185 (3번 선택 후 2번 선택)
Horizon NJ Health	1-855-465-4777
UnitedHealthcare Community Plan	1-800-645-9409 (3번 선택)
Wellpoint (구 Amerigroup)	1-855-661-1996 (1번 선택)

- 뉴저지 주정부 – PPP 관련 직통 문의 (609-631-2481 / MAHS.PPP@dhs.nj.gov)
- AWCA에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [NJ.gov 뉴저지 PPP 공식 홈페이지](#)
- [NJ.gov 뉴저지 PPP 신청 전화번호 리스트](#)
- [NJ.gov 뉴저지 PPP 프로그램 개요\(Fact Sheet\)](#)

간병인 휴식 지원 (Respite Care)

간병인 휴식 지원(Respite Care)은 간병인을 위한 프로그램입니다. 서비스는 돌봄 수혜자(환자)에게 제공되지만, 목적은 간병인에게 쉬는 시간을 드리는 것입니다. 이 서비스는 간병인이 잠시 쉬는 동안에도 환자가 전문적인 간호와 감독을 받을 수 있도록 보장합니다.

간병인 휴식 지원 유형

간병인 휴식 지원은 환자의 상태와 Primary 간병인(주로 가족 간병인)의 상황에 따라 다양한 방식으로 제공될 수 있습니다:

- **가정 내 휴식 지원:** 전문 간병인이 자택으로 방문하여 환자를 돌보고 가사를 지원합니다.
- **어덜트 데이 케어:** 사회적 교류와 의료적 지원을 제공하는 구조화된 주간 프로그램입니다.
- **거주형 간병인 휴식 지원:** 환자가 집을 떠나 전문 시설에 며칠 또는 몇 주 동안 단기 체류하며 24시간 돌봄을 받는 서비스

혜택

- **간병인 스트레스 완화:** 지속적인 돌봄으로 인한 정신적, 신체적 번아웃을 예방합니다.
- **사회적 상호작용:** 돌봄을 받는 환자에게 새로운 사회적 접촉과 활동 기회를 제공합니다.
- **지속적인 케어 보장:** 간병인이 부재중일 때도 의료적 및 개인적 필요가 충족되도록 합니다.
- **개인 시간 확보:** 간병인이 본인의 병원 진료, 여행 또는 충분한 휴식을 취할 수 있게 돕습니다.

자격 요건 (환자 기준)

- **연령/대상:** 18세 이상 뉴저지 거주자
- **거주 환경:** 자택 거주(널싱홈이나 타 시설 제외)
- **건강 상태:** 기능적 장애(Functional Impairment)가 있으며, 담당 의사로부터 타인의 돌봄이 필요하다는 확인을 받은 분
- **간병 조건:** 배우자, 가족, 친구, 이웃 등 18세 이상의 무급 간병인으로부터 매일 기본적인 돌봄 및/또는 감독을 받는 분.
- **자산 :** 유동 자산이 개인 \$40,000 이하 또는 부부 \$60,000 이하
- **소득:** 개인 월 \$2,982, 부부 월 \$5,964 이하
- **타 프로그램 중복 참여:** 룬팀케어(MLTSS), 간병 지원 프로그램(JACC), 알츠하이머 데이 케어(AADSP), 공동 주거 서비스 프로그램(Congregate Housing Services Program, CHSP), 기타 NJ FamilyCare 프로그램에 참여하지 않는 분. JACC 와 AADSP 에서 Respite Care 로 전환 가능.

코페이(Copay)

Respite Care는 무료 프로그램이 아닙니다. 수혜자의 소득에 따라 서비스 비용의 0%에서 최대 25%까지 본인 부담금이 발생할 수 있습니다.

신청 및 문의

- 거주 지역의 노인 및 장애인 지원 센터(ADRC) 연락
 - 버겐 카운티 노인국 (Bergen County Division of Senior Services)
 - 주소: One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601
 - 전화: 201-336-7400
 - 이메일: seniors@bergencountynj.gov
 - 뉴저지 ADRC 공통 무료전화: 1-877-222-3737
- AWCA에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다. (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

[NIA.gov: 국립 노화 연구소 - 휴식 돌봄이란 무엇인가?](#)

[NJ.gov 휴식 돌봄 프로그램 \(SRCP\) 공식 안내](#)

[ARCH.net 전국 간병인 휴식 지원 서비스 검색 포털](#)

PART II • 제 11 편

시니어 권익 보호 (Senior Protection)

Senior Protection

노인 안전 및 권익 옹호: 성인 보호 서비스(APS), 시니어 대상 금융 사기 및 사이버 보안 예방, 권익 옹호
옴부즈맨, 노인을 위한 무료/저비용 법률 서비스.

본 부문 총 4개 상세 안내 문서 수록

성인 보호 서비스 (Adult Protective Services, APS)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 긴급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

성인 보호 서비스(APS)는 신체적·정신적 제약으로 인해 스스로를 보호하기 어려운 18세 이상의 취약 성인을 지원하는 국가 및 주 안전망 프로그램으로, 각 카운티 지정 APS 기관이 신고를 접수·조사·개입하여 피해자의 안전을 확보하고 필요한 지원 서비스와 연결시켜줍니다.

주요 개입 사유

- **신체적/정서적 학대:** 폭행, 위협, 언어 폭력 및 심리적 고통을 주는 행위
- **방임 및 자기 방임:** 필요한 식사, 약물, 위생 관리가 이루어지지 않거나 스스로를 돌보지 못하는 경우
- **경제적 착취:** 피해자의 자산을 부당하게 가로채거나 강압을 통해 착취하거나 허락없이 사용하는 행위

**APS 신고는 누구나 할 수 있으며 신고자의 신원은 법적으로 비밀이 보장됩니다. 특히 의료 전문가, 법 집행관, 소방관, 구급대원(EMT)는 의무신고 대상으로 지정되어있습니다.*

조사 및 지원 절차

- **신속한 현장 조사:** 신고 접수 후 **72시간(근무일 기준) 이내**에 APS 담당자가 가정을 방문하여 상황을 면밀히 조사합니다.
- **맞춤형 서비스 연결:** 위험 상황 제거를 위해 다음과 같은 서비스를 연결시켜 줍니다.
 - **의료 지원:** 긴급 치료 및 건강 관리 서비스 연결.
 - **주거 안전:** 필요한 경우 안전한 보호 시설이나 다른 주거지로의 이전 지원.
 - **재정 및 법률:** 재정 관리 대행 서비스 및 권익 보호를 위한 법률 상담 연결.

신고자 보호 제도

- **철저한 비밀 보장:** 신고자의 신원은 법적으로 강력하게 보호됩니다.
- **면책 특권:** 정당한 근거를 가지고 신고했다면, 추후 조사 결과와 상관없이 신고자는 법적 책임으로부터 면제됩니다.

APS 신고처

카운티	지정 APS 기관	주소	전화번호
Bergen	Bergen County Board of Social Services	218 Route 17 North Rochelle Park, NJ 07662	주간: 201-368-4300 야간: 1-800-624-0275
Essex	FOCUS Hispanic Center for Human Dev.	441-443 Broad St. Newark, NJ 07102	주간: 866-903-6287 야간: 911
Hudson	Hudson County Adult Protective Services	6100 Adams Street West New York, NJ 07093	주간: 201-537-5631 야간: 911
Middlesex	Family and Children's Service	191 Bath Avenue Long Branch, NJ 07740	주간: 732-745-3635 야간: 911
Passaic	Passaic County Board of Social Services	80 Hamilton Street Paterson, NJ 07505	주간: 973-592-1954 야간: 1-800-315-4561

참조 자료

- [NJ.gov APS 안내](https://www.nj.gov/aps/)
- [NYC.gov – APS 개요](https://www.nyc.gov/aps/)

시니어 법률 지원 (Legal Services for Seniors)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 긴급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

시니어 법률 서비스는 저소득층 시니어가 일상에서 직면할 수 있는 다양한 법적 문제에 대해 공정하고 전문적인 도움을 받을 수 있도록 무료 또는 저비용 법률 지원을 연결합니다.

주요 지원 분야

- **학대 대응:** 신체적·정서적 학대, 언어 폭력, 고립, 타인에 의한 위협 등으로부터 시니어를 보호하기 위한 법적 조치(접근 금지 명령 등) 및 상담 지원.
- **대리인 지정:** 재정·법적 대리인을 지정하는 위임장(Power of Attorney, POA) 작성, 의료 대리인 지정(Proxy Directive) 및 의료적 결정을 위한 Living Will 준비 지원.
- **주거권 보호:** 부당한 퇴거 위기 대응, 임대차 분쟁 및 주거 안정권 확보를 위한 법률 자문.
- **경제적 권익 보호:** 과도한 채무 문제 해결, 소비자 사기 피해에 대한 법적 대응 및 자산 보호.
- **정부 혜택 상담:** 메디케어, 메디케이드, 소셜 시큐리티 혜택 등 공공 급여 관련 신청 지원, 자격 확인 및 수급 거부 이의제기 법률 자문.

법률 지원 체계

- **성인 보호 서비스 (APS):** 18세 이상의 취약 및 피해 의심 성인을 대상으로 하며, 특히 장애나 노화로 인해 스스로를 보호하기 어려운 분들의 안전을 신속히 확보하고 필요한 서비스를 연계합니다.
 - 자세한 내용은 [성인 보호 서비스 \(APS\) 페이지](#) 확인.
- **Legal Services of New Jersey (LSNJ):** 뉴저지의 저소득층 주민을 위한 무료 민사 법률 핫라인을 운영하며, 시니어 관련 법률 문제도 지원합니다.
- **지역별 법률 대리:** 카운티별 법률 서비스 사무소나 공익 법률 단체들을 통해 구체적인 사건 수임 및 법정 대리 서비스를 연계합니다.
- **권익 옹호 교육:** 시니어가 스스로의 권리를 이해하고 법적 피해를 예방할 수 있도록 정기적인 교육 리소스를 제공합니다.

이용 절차

1. **상담 신청:** 전용 핫라인 또는 웹사이트를 통해 초기 상담 예약.
2. **자격 심사:** 가구 소득, 연령, 거주지 및 법적 문제의 성격에 따른 지원 자격 확인.
3. **전문가 배정 및 상담:** 해당 분야의 전문 변호사 또는 법률 전문가 배정 및 상담 진행.

상담 및 문의

- **LSNJ 핫라인:** 1-888-576-5529 | lsnjlawhotline.org | lsnj.org

- 뉴저지 버겐 카운티 **APS**: 201-368-4300 | 24시간 핫라인 1-800-624-0275
- 전국 가정폭력 핫라인: 1-800-799-7233 | thehotline.org/
- [NJ 211.org](http://NJ211.org): 시니어 법률 지원 서비스 검색 포털
- NNJLS.org – 버겐, 허드슨, 퍼새익 지역 공익 법률 지원 단체
- CHLP.org – 뉴저지 장애인 및 시니어 권익 옹호 단체

옴부즈맨 (Ombudsman)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 긴급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요.

옴부즈맨은 정부 기관, 요양 시설, 또는 특정 조직의 운영 과정에서 발생하는 불만 사항을 접수하여 중립적인 입장에서 조사하고 해결책을 제시하는 독립적인 권익 보호관입니다. 복잡한 행정 절차나 부당한 대우로 어려움을 겪는 시민들을 위해 공정하고 투명한 중재 역할을 수행합니다.

*옴부즈맨의 모든 서비스는 무료이며 익명성을 보장합니다.

주요 지원 분야

- **권익 보호 및 조사:** 행정 기관의 오류, 지연, 무응답 또는 부당한 결정에 대한 독립적인 조사 실시.
- **장기 요양 시설 감시:** 널싱홈 및 어시스트 리빙 거주자의 안전, 치료 질, 존엄성 유지 여부 확인.
- **갈등 중재:** 민원인과 기관 사이의 의사소통을 지원하고, 법적 소송으로 가기 전 비공식적이고 효율적인 해결 방안 모색.
- **정책 제언:** 반복되는 민원 사례를 분석하여 시스템적 개선안을 관련 정부 부처나 입법 기관에 권고.
- **정보 제공 및 교육:** 시민이 자신의 권리를 정확히 이해하고 관련 법규를 준수할 수 있도록 상담 및 리소스 제공.

옴부즈맨 운영 체계

옴부즈맨은 단일 기관이 아닙니다. 연방·주·지역 단위의 각 부처 및 분야별로 독립적으로 운영됩니다.

- **롱텀케어 옴부즈맨:** 롱텀케어 시설 거주자를 위해 시설 내 학대, 방임, 서비스 불만족 문제를 전문적으로 다룹니다.
 - 자세한 내용은 [롱텀케어 옴부즈맨](#) 페이지 확인.
- **정부 기관별 옴부즈맨:** 국무부(State Department)나 사회보장국(SSA) 등 각 부처 내 설치되어 해당 기관의 행정 서비스와 관련된 시민의 고충을 처리합니다.
- **독립성 및 비밀 유지:** 옴부즈맨은 해당 기관의 간섭을 받지 않는 독립된 지위를 가지며, 상담 내용과 제보자의 신원은 법령에 따라 철저히 비밀로 보장됩니다.

이용 절차

1. **민원 접수:** 전화, 이메일 또는 공식 웹사이트 양식을 통해 고충 내용 상세 접수.
2. **초기 검토:** 접수된 내용이 옴부즈맨의 조사 관할 범위에 해당되는지 확인 및 기초 자료 수집.
3. **조사 및 중재:** 관련 당사자 면담, 서류 검토 등을 통해 중립적인 조사 진행 및 해결책 권고.
4. **결과 통보:** 조사 결과 및 향후 조치 사항을 민원인에게 공식 전달.

상담 및 문의

- [State.gov: office of civil rights and ombudsman](https://www.state.gov/office-of-civil-rights-and-ombudsman)
- 뉴저지 주 장기 요양 ombudsman (NJ LTCO): 1-877-582-6995 | nj.gov/ooie/
- 뉴저지 주 복지국 ombudsman (DHS): 1-800-357-2260 | nj.gov/humanservices/
- 행정 컨퍼런스(ACUS) ombudsman 리소스: acus.gov/
- [NJ 211.org](https://nj211.org)

시니어 대상 사기 및 사이버 보안 (Senior Scam & Cyber Security)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 긴급 상황 발생 시 즉시 911로 전화하세요. 사기 피해 신고는 연방 노인 사기 핫라인 (1-833-372-8311, 평일 동부표준시 오전 6시-오후 11시)으로 전화하세요.

시니어 대상 사기 및 사이버 범죄는 일상적인 대인 관계를 악용하거나 디지털 환경을 통해 자산과 개인정보를 탈취하는 지능형 범죄입니다. 최근 정부기관(SSA, IRS 등) 사칭은 물론, AI를 활용한 목소리 변조 및 정교한 결제 유도 사례도 증가하고 있습니다. 변화하는 사기 수법을 인지하고 대응함으로써 일상과 디지털 환경 모두에서 스스로를 안전하게 보호하는 것이 중요합니다.

주요 사기 유형

- **정부 기관 사칭:** 사회보장국(SSA), 국세청(IRS), 또는 메디케어 직원의 신분을 도용하여 개인정보를 탈취하거나, 법적 조치를 빌미로 금전 송금을 압박하는 행위입니다.
- **금전 갈취 및 부당 유용:** 가족, 간병인, 법적 대리인 등 신뢰 관계를 이용하거나 고령자의 신체·인지적 취약성을 악용하여 재산을 탈취하는 행위입니다.
- **기술 지원 사기:** 기기의 보안 취약점이나 바이러스 감염을 경고하는 허위 팝업창을 송출하여 가짜 고객센터로 연결을 유도한 뒤, 원격 제어 소프트웨어를 통해 금융 정보를 탈취하고 자산을 인출하는 수법입니다.
- **허위 광고 및 소셜 미디어 사기:** 유명 인사의 명성을 도용하거나 무료 경품 당첨을 미끼로 한 허위 광고를 통해 개인정보 입력을 유도하고, 불법 투자 가입 또는 유료 서비스의 무단 결제를 발생시키는 행위입니다.
- **가족 사칭 긴급 자금 요구:** 자녀나 손주 등 직계 가족을 사칭하여 사고 또는 긴급 체포 등 급박한 위기 상황을 연출하고, 이성적 판단이 어려운 상태에서 즉각적인 자금 송금을 요구하는 수법입니다.
- **로맨스 스캠:** SNS 및 메신저를 통해 친밀감과 신뢰를 형성한 후, 이성적 호감을 이용하여 질병 치료비나 항공료 등 각종 허위 명목으로 반복적인 금전적 지원을 편취하는 행위입니다.
- **피싱 및 악성 링크:** 공공기관이나 배송 서비스 등을 사칭한 문자 메시지 내 악성 링크(URL) 클릭을 유도하여 기기를 해킹하고, 민감한 개인정보 및 금융 자산을 탈취하는 사이버 범죄입니다.

사기 예방 및 대응

- **모르는 번호의 전화나 문자는 먼저 끊고 직접 전화해 확인합니다.**
 - **먼저 끊습니다:** 정부 기관(SSA, IRS, 경찰 등)은 전화로 즉각적인 송금 요구, 체포 위협, 카드결제 등을 요구하지 않습니다. 수상한 전화는 즉시 끊습니다.
 - **직접 전화합니다:** 자녀나 손주가 사고를 당했다며 급히 돈을 보내라고 하면 일단 끊고 알고 있는 원래 번호로 직접 전화해서 사실을 확인합니다.

- 문자에 포함된 링크는 누르지 말고 앱은 설치하지 않습니다.
 - 문자 링크 주의: 택배 주소 확인이나 과태료 알림 문자에 포함된 링크는 절대로 누르지 않습니다.
 - 앱 설치 금지: 보안 목적 광고나 모르는 사람이 설치하라고 하는 앱은 절대로 설치하지 않습니다.
- 기프트 카드나 송금 요구는 100% 사기입니다.
 - 현금 결제 유도 거절: 어떤 공공기관이나 기업도 벌금이나 수수료를 기프트 카드, 비트코인, 현금 송금으로 요구하지 않습니다.
 - 원격 제어 허용 금지: 컴퓨터 화면에 경고창이 뜨고 화면에 나온 번호로 전화하라고 해도 절대 하지 마십시오. 모르는 사람이 내 컴퓨터나 휴대폰에 접속하게 해서는 안됩니다.
- 개인정보는 '절대' 공유하지 않습니다.
 - 비밀번호와 SSN 보호: 은행 비밀번호나 사회보장번호(SSN) 전체 자릿수는 가족이라도 함부로 알려주어서는 안됩니다.
 - SNS상 모르는 사람 조심: SNS를 통해 모르는 사람이 친근하게 연락와서 돈을 빌려달라거나 투자를 권유한다면 즉시 차단합니다.
- 피해가 의심되면 즉시 '도움'을 요청합니다.
 - 자책하지 않습니다: 사기를 당한 것은 피해자의 잘못이 아닙니다. 용기를 내어 즉시 주위에 알립니다.
 - 은행에 즉시 연락: 돈을 보냈거나 계좌 정보가 노출되었다면 즉시 거래 은행에 전화하여 **지급 정지**를 요청합니다.

주요 사기 유형 및 수법	관련 기관 및 신고처
정부 기관 사칭 SSA, IRS, 메디케어 직원을 사칭해 개인정보 탈취 및 금전 송금 압박	전국 노인 대상 사기 범죄 신고 센터 (National Elder Fraud Hotline) 1-833-372-8311 FTC: Report Fraud reportfraud.ftc.gov
금전 갈취 및 부당 유용 지인이나 대리인이 취약한 고령자를 기망·협박하여 재산을 무단 점유 및 사용	NJ Division of Consumer Affairs 1-800-242-5846 APS (Bergen County) 1-800-624-0275 201-368-4300
기술 지원 사기 가짜 바이러스 경고 팝업으로 원격 제어 앱 설치 유도 후 금융 자산 인출	FTC: Report Fraud reportfraud.ftc.gov NJ Division of Consumer Affairs 1-800-242-5846
허위 광고 및 소셜 미디어 유명 인사 도용 또는 경품 미끼로 개인정보 입력 유도 및 무단 결제 발생	FTC: Report Fraud reportfraud.ftc.gov NJ Division of Consumer Affairs 1-800-242-5846
가족 사칭 긴급 자금 요구 자녀·손주를 사칭해 사고나 체포 등 위기 상황을 연출하며 즉각 송금 요구	Local Police (911) National Elder Fraud Hotline 1-833-372-8311
로맨스 스캠 SNS에서 호감을 산 뒤 치료비, 항공료 명목으로 반복적인 금전 편취	FTC: Report Fraud reportfraud.ftc.gov
피싱 및 악성 링크 공공기관/배송 서비스 사칭 문자 내 링크(URL) 클릭 유도로 기기 해킹	FTC: Report Fraud reportfraud.ftc.gov

*긴급 상황 발생 시 즉시 911 또는 연방 노인 사기 핫라인(1-833-372-8311)으로 전화하세요.

문의 및 신고처

- 전국 노인 대상 사기 범죄 신고 센터: 1-833-372-8311
- FTC Reporting: reportfraud.ftc.gov
- NJ Division of Consumer Affairs: 1-800-242-5846

- **NJ Office of Attorney General:** 609-984-5828

참고 자료

- **FTC:** [identityTheft.gov](https://identitytheft.gov) | reportfraud.ftc.gov | donotcall.gov
- [OVC.gov](https://www.ovc.gov): [Helping Victims Find Their Justice](https://www.ovc.gov/helping-victims-find-their-justice)
- [NJ Consumer Affairs.gov](https://www.njconsumeraffairs.gov) | 973-504-6200
- [NJ OAG.gov](https://www.nj.oag.state.nj.us): [Office of Attorney General](https://www.nj.oag.state.nj.us)

PART II • 제 12 편

은퇴·노후 준비 (Retirement Planning)

Retirement Planning

은퇴 및 상속·법률 준비: 위임장(Power of Attorney), 사전 의료의향서(Advance Directive), 생전 유언(Living Will), 유언장(Will), 생전 신탁(Living Trust), 메디케이드 신탁, AARP 혜택, 고령친화도시, 노인 교통 이동 지원, 여가 생활, 역이민 안내.

본 부문 총 11개 상세 안내 문서 수록

AARP (은퇴자협회)

AARP는 50세 이상을 중심으로 미국 성인들의 삶의 질 향상을 위해 활동하는 미국 최대 규모의 비영리·비당파(nonpartisan) 단체이며 회원 가입은 18세 이상이면 누구든 가능합니다. 건강, 재정, 여가 등 노후 생활 전반에 걸친 방대한 리소스와 혜택을 제공합니다.

주요 지원 분야

- **재정 및 사기 방지:** 은퇴 자금 관리 가이드 제공 및 '사기 감시망(Fraud Watch Network)'을 통해 보이스피싱, 금융 사기 예방 교육 및 피해 신고 지원
- **건강 및 의료 정보:** 메디케어 비교 도구, 치매 및 간병(Caregiving) 리소스 제공과 시각·청각 건강 관련 할인 혜택 및 리소스 안내
- **생활비 절감 혜택:** 여행(호텔, 항공), 외식, 쇼핑, 자동차 및 주택 보험 등 다양한 분야의 회원 전용 할인 혜택 제공
- **취업 및 경력 지원:** 50세 이상 구직자를 위한 구직 도구, 기술 재교육 프로그램 및 AARP Employer Pledge 서약 고용주와의 구직 연결 서비스
- **운전자 안전 교육:** 시니어 맞춤형 안전 운전 교육(AARP Smart Driver™ Course) 과정을 온·오프라인으로 운영하여 사고 예방 및 보험료 할인 혜택 연계

지원 체계

- **AARP Foundation:** 저소득층 시니어를 위한 세무 지원(Tax-Aide), 주거 안정 및 식량 안보 지원 프로그램을 운영하는 자선 부문
 - **세무 지원(Tax-Aide):** 50세 이상 저·중소득층에 초점을 두나 연령·소득 제한 없이 누구나 무료 이용 가능. *AARP 회원이 아니어도 이용 가능
- **Fraud Watch Network:** 사기 전담 핫라인을 통해 최신 사기 수법을 공유하고 피해자들에게 실시간 대응 방법 안내
- **지부별 커뮤니티(AARP State Offices):** 뉴저지 등 각 주별 지부를 통해 지역 단위의 권익 옹호 활동 및 사교 이벤트 개최
- **AARP Publications:** AARP The Magazine(격월 발행) 및 AARP Bulletin(뉴스레터)을 통해 건강, 재정, 기술 트렌드에 관한 최신 정보를 제공

신청 및 문의

- [AARP](https://www.aarp.org/) / 1-888-687-2277
- [AARP 뉴저지 지부](#)
- [AARP 취업 자원 센터](#)

사전 의료 지시서 (Advance Directive)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 구체적인 상담은 반드시 전문가나 공식 기관과 하시기 바랍니다.

사전 의료 지시서(Advance Directive)는 향후 질병이나 사고로 인해 본인이 직접 의사를 결정하거나 표현할 수 없는 상황에 대비하여, 자신이 원하는 의료 처치의 범위와 대리인을 미리 지정해 두는 법적 문서입니다. 이는 본인의 존엄성을 지키고 가족들의 의사결정 부담을 덜어주는 필수적인 준비 과정입니다.

뉴저지주에서는 사전 의료 지시서는 담당 의사가 본인의 의사 결정 능력이 없다고 판단한 경우에만 효력이 발생합니다. 만 18세 이상이면 누구든지 사전 의료 지시서를 작성할 수 있습니다.

주요 특징

사전 의료 지시서는 일반적으로 다음 두 가지 요소를 포함하거나 각각 작성될 수 있습니다.

구분	주요 내용	역할
치료 지시서 (Instruction Directive-통칭: 연명의료계획서(Living Will))	특정 상황에서의 치료 중단 또는 지속 의사 명시	본인의 치료 지침 전달
의료 대리인 지정서 (Proxy Directive-Durable Power of Attorney for Healthcare)	본인을 대신해 의료 결정을 내릴 대리인 지정	법적 대리인의 결정권 보장

Five Wishes: 종합 사전 의료 지시서

비영리 단체 **Aging with Dignity**가 제작한 **Five Wishes**는 의료적인 결정뿐만 아니라 정서적, 개인적 소망을 담을 수 있습니다. 뉴저지를 비롯한 미국 대부분의 주에서 법적 효력을 갖고 있으며, 한국어를 포함한 31개의 언어로 제공되어 한인 시니어분들도 편리하게 작성하실 수 있습니다.

미국 50개 주 및 워싱턴 DC에서 법적 효력을 가지며, 다만 4개 주(Kansas, New Hampshire, Ohio, Texas)에서는 주 양식 첨부 등 추가 절차가 필요합니다.

**의료기관·호스피스를 통해 무료 수령 가능*

Five Wishes 구성 항목

1. 의료 대리인 지정 (The Health Care Agent)

본인이 결정을 내릴 수 없을 때 나를 대신해 의료진과 소통하며 최종 결정을 내릴 수 있는 대리인을 법적으로 지정합니다. 가족뿐만 아니라 친구도 가능합니다.

2. 원하는 의료 처치 시행 여부 (Medical Treatment Instructions)

심폐소생술, 인공호흡기 사용, 영양 공급 등 생명 연장 치료를 어느 단계까지 받을지 구체적으로 명시합니다.

3. 원하는 편안함의 정도 (How Comfortable I Want to Be)

통증 조절을 위한 약물 투여뿐만 아니라, 환자가 편안함을 느낄 수 있는 환경 조성(음악, 목욕, 침구 등)에 대한 구체적 요구사항입니다.

4. 원하는 보살핌 방식 (How I Want People to Treat Me)

의료진과 가족들이 환자를 대하는 방식, 가족의 동석 여부, 손을 잡아주는 행위, 종교적 지원 등 정서적인 배려 관련 사항들을 구체적으로 요청합니다.

5. 가족들에게 알리고 싶은 사항 (What I Want My Loved Ones to Know)

사랑하는 이들에게 남기는 마지막 메시지, 장례 절차, 그리고 본인의 삶이 어떻게 기억되기를 바라는지에 대한 철학적 유산을 담습니다.

작성 및 시행 절차 (뉴저지 기준)

- **의사 결정 및 상담:** 본인의 가치관을 정리하고 주치의 및 가족과 충분히 상의합니다.
- **서류 작성:** 뉴저지주 표준 양식 또는 **Five Wishes** 양식을 작성합니다.
 - [Five Wishes 공식 사이트](#)에서 구매(\$5) 또는 의료기관·호스피스 파트너를 통해 무료 수령 가능. *한국어 버전 제공
- **법적 요건 충족:** 18세 이상의 성인 증인 2명의 서명이 필요합니다.
 - 단, 지정한 의료 대리인은 증인이 될 수 없으며, 분쟁 예방을 위해 유산 상속인이 아닌 제3자를 증인으로 선택하는 것을 권장합니다.
 - **공증:** 증인 서명 대신 공증인(Notary Public) 또는 변호사 앞에서 서명·확인을 받을 수 있습니다.
- **보관 및 배포:** 원본은 본인이 안전하게 보관하되 사본(Copy)을 가족, 주치의, 의료 대리인(대체 대리인 포함), 입원 예정 병원에 전달합니다.
 - 원본은 쉽게 찾을 수 있는 안전한 곳에 보관하되, 잠금 장치가 있는 금고는 피하세요.

문의

기관명	주요 지원 내용	연락처
뉴저지 ADRC	카운티별 노인·장애인(18세 이상)·가족 돌봄 제공자 서비스 연결 및 상담	1-877-222-3737 *전화 시 자동으로 거주 카운티 담당자에게 연결
버겐 카운티 노인국 (Bergen County Division of Senior Services)	정보 제공 및 법률 서비스 리퍼럴	One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601 201-336-7400 seniors@bergencountynj.gov
NNJLS (북부 뉴저지 법률 서비스)	저소득·시니어·장애인 대상 무료 법률 지원 (소득 기준 적용)	190 Moore Street, Suite 100, Hackensack, NJ 07601 201-487-2166 NNJLS.ORG
LSNJ (뉴저지 대표 법률 지원 핫라인)	무료 법률 상담 및 정보 제공	1-888-576-5529 lsnjlawhotline.org

참고 자료

- [Medicare.gov](https://www.medicare.gov): 사전 의료 계획(ACP) 보험 급여 안내
- [뉴저지주 사전 의료 지시서 공식 페이지\(무료 지시서 양식 다운로드\)](#).
- [Five Wishes](#) 양식 구매 및 정보
- NJ211.org: 시니어 법률 지원 서비스 검색 포털

시니어 친화적 커뮤니티 (Age-Friendly Communities)

시니어 친화적 커뮤니티(Age-Friendly Communities)는 나이가 들어도 자신이 살던 곳에서 안전하고 건강하게, 그리고 활기차게 살아갈 수 있도록 물리적·사회적 환경을 조성하는 국제적 노력입니다. 시니어 친화적 커뮤니티의 기준은 세계보건기구(WHO)가 수립한 표준 가이드라인에 의해 적용됩니다.

주요 지원 분야

- **이동권 및 교통 (Bergen County Community Transportation):** 버겐 카운티 거주 60세 이상 시니어, 장애인 및 재향군인을 위한 무료 도어 투 도어(Door-to-door) 교통 서비스
 - 시니어 벤(Senior Van) 서비스 운영
- **주거 개조 및 안정:** 낙상 방지를 위한 손잡이 설치 등 주택 개조 지원과 시니어 전용 저소득층 아파트 확충 및 재산세 감면 정보 제공
- **사회 및 인적 연결:** 버겐 카운티 내 20여 개 시니어 센터를 통한 사교 프로그램 및 고립된 시니어를 위한 안부 전화 서비스
- **디지털 격차 해소:** 스마트폰, 태블릿 사용법 교육을 통해 시니어가 온라인 정부 혜택을 직접 신청하고 가족과 소통할 수 있도록 지원
- **안전한 보행 환경:** 횡단보도 신호 시간 연장, 보도 턱 낮추기, 공원 내 충분한 벤치 설치 등 물리적 환경 개선

지원 체계

- **AARP Network of Age-Friendly States and Communities:** 미국 전역의 도시들이 고령 친화 8대 영역(주거, 교통, 사회참여 등)을 개선하도록 기술적 가이드라인 제공
 - 세계보건기구(WHO)가 규정한 **고령 친화 8대 영역**의 개선을 지원:
 1. 외부 공간·건물
 2. 교통
 3. 주거
 4. 사회 참여
 5. 존중·사회적 포용
 6. 시민 참여·고용
 7. 정보·소통
 8. 지역사회 지원·보건 서비스
- **Age-Friendly NJ (AFNJ):** 버겐 카운티를 포함한 뉴저지 전역의 수십 개 커뮤니티가 참여하는 네트워크로, 고령 친화 모범 사례 공유

- **버겐 카운티 시니어 서비스국 (Division of Senior Services):** 카운티 차원의 고령 친화 정책을 총괄하며, 주요 서비스 가이드(Key Services Guide)를 통해 통합 리소스 제공
 - 버겐 카운티는 2022년 5월 AARP·WHO로부터 공식 시니어 친화적 커뮤니티로 지정

이용 방법

- **거주지 확인:** 본인의 타운이 고령 친화 사업을 운영 중인지 확인
- **서비스 신청:** 교통편 예약이나 주거 지원이 필요한 경우 카운티 또는 타운 시니어 센터에 전화로 서비스 신청
- **커뮤니티 참여:** 타운에서 실시하는 고령 친화 설문조사나 타운홀 미팅에 참여하여 필요한 개선 사항 건의

버겐 카운티 한인 지원 기관

기관명	주요 서비스	연락처
AWCA	시니어 액티비티 센터-사교 프로그램, 영양 점심(Congregate Meals), 건강 스크리닝. 홈케어 서비스(한국어 가능 홈 헬스 에이드 파견), 복지 상담 핫라인(한국어 상담 가능)	9 Genesee Ave., Teaneck, NJ 07666 201-862-1665 awcanj.org
패밀리터치 (Family Touch)	한인 대상 가족 상담·정신건강 교육 비영리 단체. 시니어 우울증·상담 프로그램 운영. 상담비 50% 지원, 소득 기준 조정 가능	218 Main St, Little Ferry, NJ 07643 201-242-4422 familytouchusa.org
기브 찬스 (Give Chances)	저소득층 아동·장애인 자원봉사. 방과후 교육·장애인 미술 프로그램 운영. *시니어가 멘토·자원봉사자로 참여 가능합니다.	500 Broad Ave, Palisades Park, NJ 07650 201-266-0640 givechances.org
뉴저지 한인회 (KAANJ)	1975년 설립 비영리 501(c)(3). 한인 커뮤니티 권익 옹호, 생활 정착 지원, 지역 네트워킹 및 문화 행사 운영	21 Grand Ave. #216-B, Palisades Park, NJ 07650 201-945-9456 kaanj.org
뉴저지 한인 상록회 (KASCA NJ)	한인 시니어의 건강·재정·행복 증진 프로그램 제공 비영리 단체. 사회 복지 상담센터, 의료 정보센터, 이미용 봉사, 경조 서비스 등 한인 시니어를 위한 통합 지원 프로그램 운영.	133 Fort Lee Rd. #3FL, Leonia, NJ 07605 201-945-2400 kascanj.org
뉴저지 시민참여센터 (KACE)	1996년 설립 비영리·비당파 단체. 유권자 교육, 시민 권익 옹호, 청년 리더십 개발, 풀뿌리 커뮤니티 조직 운영	263 Broad Ave., 2A Palisades Park, NJ 07650 201-488-4201 kace.org
KCS 뉴저지 (Korean Community Services of NJ)	1973년 설립 비영리 501(c)(3). 한인·아시아 이민자 대상 노인 복지(시니어 데이케어), 정신건강 상담, 이민 서비스, 인력 개발, 공중보건 프로그램 통합 제공. *소득·자격 기준 있음	100 Grove St., Tenafly, NJ 07670 201-541-1200 kcsus.org
뉴저지 민권센터 (MinKwon Center)	1984년 설립. 한인·아시아·이민자 커뮤니티 대상 사회복지 서비스, 이민 법률 지원, 시민권 신청 보조, 주거 권리, 복지 혜택 신청 (SNAP, HEAP), 시민 참여·유권자 교육 운영.	316 Broad Ave., 2nd Fl., Palisades Park, NJ 07650 201-546-4657 minkwon.org

신청 및 문의

- [버겐 카운티 시니어 서비스국](#) / 201-336-7400
- [Age-Friendly NJ \(AFNJ\)](#).
- [AARP Livable Communities-고령 친화 커뮤니티 자료, 가이드라인 및 지역 사례 검색](#)
- 버겐 카운티 교통 지원 (**Bergen County Community Transportation**): 201-368-5955 (시니어 셔틀 서비스)
- [NJ 211](#)

참고 자료

- [버겐 카운티 공식 시니어 서비스 가이드북 \(PDF\)](#).
- [버겐 카운티 사회복지 안내서 \(PDF\)](#).
- [WHO Age-Friendly World](#)

레저와 레크리에이션

규제적인 신체 활동과 사회적 교류는 고령자의 인지 기능을 보호하고 수명을 연장하는 핵심 요소입니다. 지역 사회의 시니어 센터는 이를 위한 다양한 프로그램을 제공합니다.

주요 활동

- **사회적 교류:** 친구들과의 게임(체스, 카드), 가족과의 화상 통화, 취미 동호회 가입.
- **학습 기회:** 요리, 미술, 외국어 수업 수강, 독서 또는 영화 클럽 참여, 악기 배우기.
- **지역사회 참여:** 학교·도서관·병원 자원봉사, 커뮤니티 정원 가꾸기, 합창단 활동.
- **신체 활동:** 정원 및 마당 가꾸기, 시니어 운동 수업, 친구와 산책하기, 수영.
- **스트레스 해소:** 독서, 마음챙김(Mindfulness) 연습, 타이치(태극권) 또는 요가.

시니어 센터

뉴저지 버겐 카운티 내 각 지역 별 시니어 센터는 다음과 같은 전문 프로그램을 운영하고 있습니다. 본인의 관심사와 건강 상태에 맞춰 참여해 보세요.

• 건강 및 웰니스 (Health & Wellness)

- **영양 점심 식사 (Congregate Meals):** 영양사가 설계한 균형 잡힌 점심 식사를 저렴한 가격(권장 기부금 형태)에 제공합니다. 거동이 불편한 경우 [Meals on Wheels](#) 배달 서비스와 연계됩니다.
- **전문 운동 프로그램:**
 - **SilverSneakers:** 일부 Medicare Advantage·Supplement 플랜 가입자에게 무료 제공되는 피트니스 프로그램.
*본인 보험 플랜의 포함 여부 확인 권장
 - **낙상 방지 교육:** 시니어 사고의 주요 원인인 낙상을 예방하기 위한 균형 감각 훈련
 - **Zumba Gold & Chair Yoga:** 관절에 무리가 가지 않는 댄스와 요가 수업
- **건강 검진(Health Screening):** 정기적인 혈압 측정, 당뇨 체크, 독감 및 코로나19 예방 접종 안내

• 평생 학습 및 취미 (Lifelong Learning)

- **디지털 리터러시:** 스마트폰 활용법, 영상 통화(Zoom/FaceTime), 온라인 बैं킹 이용 및 사기/스캠(Scam) 예방 교육
- **예술 및 공예:** 수채화, 서예, 뜨개질, 종이접기 등 손재주를 활용한 인지 기능 강화
- **언어 수업:** 영어(ESL) 클래스는 물론, 다문화 커뮤니티가 발달한 버겐 카운티 특유의 언어 교환 프로그램

• 교통 편의 (Transportation)

- **셔틀 서비스:** 센터 방문, 인근 식료품점 쇼핑, 병원 진료를 위한 시니어 전용 셔틀버스를 운행합니다. (사전 예약 필수)

버겐 카운티 내 시니어 센터

센터명	주소	전화번호
AWCA Senior Activity Center	9 Genesee Ave., Teaneck, NJ 07666	201-862-1665
Bergenfield Senior Center	293 Murray Hill Ter., Bergenfield, NJ 07621	201-387-7212
East Rutherford Senior Center	147 Hackensack St., East Rutherford, NJ 07073	201-935-8920
Elmwood Park Senior Center	387 Market St., Elmwood Park, NJ 07407	201-796-3342
Garfield Senior Center	480 Vreeland Ave., Garfield, NJ 07026	973-478-0502
KCS New Jersey Social Adult Daycare (*민간 운영 시설)	100 Grove St., Tenafly, NJ 07670	201-541-1200 x 111
North Arlington Senior Center	11 Bayard Ave., North Arlington, NJ 07031	201-998-5636
Northwest Senior Center	46-50 Center St., Midland Park, NJ 07432	201-445-5690
Ridgefield Park Senior Center	159 Park St., Ridgefield Park, NJ 07660	201-641-7170
Wallington Senior Center	24 Union Blvd., Wallington, NJ 07057	973-777-5815

문의

- 버겐 카운티 시니어 서비스국: 201-336-7400
- [AARP 공식 웹사이트](#)
- **NJ11:** 211 (지역 사회 서비스 연결)
- [NJ Division of Parks & Forestry:](#) 시니어 패스(주립공원 무료 입장) 관련 문
 - 62세 이상 뉴저지 거주자

- 1-800-843-6420

- **AWCA**에서 관련 상담을 무료로 제공해 드립니다 (201-862-1665 / info@awcanj.org)

참고 자료

- [버겐 카운티 직영 시니어 센터 목록](#)
- [버겐 카운티 공식 시니어 서비스 가이드북 \(PDF\)](#)

리빙 트러스트 (Living Trust)

본 내용은 정보 제공만을 목적으로 합니다. 구체적인 상담은 반드시 전문가나 공식 기관과 하시기 바랍니다.

리빙 트러스트(Living Trust/생전신탁)란 자산 소유자(위탁자)가 생전에 자신의 자산을 관리할 권한을 **관리인(Trustee)**에게 법적으로 이전하는 형태를 말합니다. 사후에 자산이 어떻게 관리되고 배분될지를 미리 지정함으로써 유연장을 보완하는 역할을 합니다.

리빙 트러스트의 종류

- **취소 가능 신탁(Revocable Trust):** 가장 일반적인 형태입니다. 위탁자가 살아있는 동안 언제든지 내용을 수정하거나 취소할 수 있으며, 재산에 대한 완전한 통제권을 유지합니다.
- **취소 불가능 신탁(Irrevocable Trust):** 일단 설정하면 수정이 매우 어렵습니다. 주로 상속세 절감이나 메디케이드(Medicaid) 자격 유지를 위한 자산 보호 목적으로 사용됩니다.

리빙 트러스트의 장점

법원 검인(Probate) 절차 배제

유언장은 대리 법원(Surrogate's Court)을 통한 검인(Probate) 절차가 필요합니다. 뉴저지의 검인 절차는 타 주에 비해 상대적으로 간단하지만, 리빙 트러스트를 이용하면 이 절차 없이 자산을 즉시 수혜자에게 이전할 수 있습니다.

사생활 보호(Privacy)

리빙 트러스트는 비공개 문서로 유지되므로 자산 규모나 분배 내용이 외부로 공개되지 않습니다. 유언장은 법원에 제출되는 순간 공적 기록(Public Record)이 되어 누구나 열람할 수 있습니다.

유고 시 자산 관리(Incapacity Planning)

치매나 사고로 본인이 재산을 관리할 수 없게 될 때, 법원의 재산 후견(Conservatorship) 절차 없이도 미리 정한 후임 수탁자(Successor Trustee)가 즉시 재산 관리를 대행할 수 있습니다.

미성년 자녀의 재산 보호

리빙 트러스트를 통해 자녀가 특정 연령이 될 때까지 재산을 나누어 지급하도록 조건을 설정할 수 있어 자녀의 경제적 자립을 돕기에 유리합니다.

리빙 트러스트 작성 시 참고 사항

- **높은 설정 및 관리 비용:** 신탁을 설정하고 유지하는 데는 상당한 초기 비용과 행정적 노력이 소요됩니다. 자산 규모가 크지 않은 경우, 신탁 유지비가 검인 비용보다 더 많이 들 수 있습니다.

- **유언장의 필요성:** 리빙 트러스트를 만들더라도 **보완용 유언장(Pour-over Will)**은 반드시 필요합니다. 신탁 명의로 옮기지 못한 누락 자산을 사후에 신탁으로 귀속시키기 위함입니다.
- **신탁 자산 이전(Funding):** 신탁 서류만 만드는 것은 의미가 없습니다. 부동산(Deed), 은행 계좌 등의 명의를 반드시 **신탁 이름(The [Name] Living Trust)**으로 변경해야 효력이 발생합니다.
- **대안 옵션:** 리빙 트러스트 외에도 **POD(Payable on Death)**, **TOD(Transfer on Death)** 등 저렴하고 간단한 자산 이전 방법이 있습니다.
- **전문가 선택:** **NNJLS(Northeast New Jersey Legal Services)** 등 소득 기준 충족 시 무료 법률 지원을 받을 수 있는 기관이나 검증된 **유산 상속 전문 변호사(Estate Planning Attorney)**에게 직접 조언을 구하세요.

문의

기관명	주요 지원 내용	연락처
뉴저지 ADRC	카운티별 노인·장애인(18세 이상)·가족 돌봄 제 공사 서비스 연결 및 상담	1-877-222-3737 (전 카운티 노인·장애인 서비스 통합 안내) *전화 시 자동으로 거주 카운티 담당자에게 연결
버겐 카운티 노인국 (Bergen County Division of Senior Services)	정보 제공 및 법률 서비스 리퍼럴	One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601 201-336-7400 seniors@bergencountynj.gov
NNJLS (북부 뉴저지 법률 서비스)	저소득·시니어·장애인 대상 무료 법률 지원 (소 득 기준 적용)	190 Moore Street, Suite 100, Hackensack, NJ 07601 201-487-2166 NNJLS.ORG
LSNJ (뉴저지 대표 법률 지원 핫라인)	무료 법률 상담 및 정보 제공	1-888-576-5529 lsnjlawhotline.org

참고 자료

[NJ.gov – Estates and Trusts \(PDF\)](#).

연명의료계획서 (Living Will)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 구체적인 상담은 반드시 전문가나 공식 기관과 하시기 바랍니다.

연명의료계획서(Living Will, 공식 명칭은 Instruction Directive)는 사전 의료 지시서(Advance Directive)의 일부로, 본인이 특정 상황에서 원하거나 원하지 않는 의료 처치를 직접 명시하는 문서입니다. 담당 의사가 본인의 의사결정 능력 상실을 공식 평가한 경우에만 효력이 발생합니다. 이는 가족과 의료진이 환자의 가치관을 존중하며 최선의 결정을 내릴 수 있도록 돕는 중요한 근거가 됩니다.

주요 특징

- **생명 유지 장치 사용 여부:** 심폐소생술 (CPR), 인공호흡기 사용 등 생명을 강제로 연장하기 위한 처치에 대한 구체적인 거부 또는 수락 의사
- **영양 및 수분 공급:** 스스로 섭취가 불가능할 때 인공 영양 공급관 (Feeding Tube)이나 정맥 주사를 통한 영양 공급을 지속 할지 여부
- **신장 투석:** 신장 기능 정지 시 투석기를 통한 혈액 정화 치료 시행 여부
- **통증 완화 치료 (Hospice/Palliative Care):** 생명 연장보다는 통증 조절과 품위 있는 마무리를 위한 편안한 케어에 집중 할 것인지에 대한 선택

Living Will 의 역할

- **자기 결정권 보장:** 본인의 평소 가치관과 종교적 신념에 따른 의료적 선택권을 법적으로 보호받습니다.
- **가족의 심리적 부담 경감:** 위급 상황에서 가족들이 치료 방향을 두고 겪을 수 있는 죄책감이나 갈등을 사전에 방지합니다.
- **명확한 의료 지침 제공:** 의료진에게 환자의 의사를 명확히 전달하여 불필요하거나 원치 않는 과잉 진료를 예방합니다.

작성 및 시행 절차

개인, 법률 대리인, 정부 기관, 병원등에서 문의 또는 신청할 수 있습니다. (본인이 직접 작성할 수 있으며, 변호사나 의사 없이도 가능합니다.)

*작성 지원이 필요한 경우 아래 기관에 문의하세요.

1. **의사 결정:** 본인이 원하는 치료의 범위를 충분히 고민하고 가족 및 주치의와 상의합니다.
2. **문서 작성:** 뉴저지는 특정 양식을 강제하지 않으므로 NJ 보건부 표준 양식, Five Wishes 양식, 또는 직접 작성한 문서도 유효합니다. (일반적으로 의료 대리인 지정서와 함께 작성되는 경우가 많습니다.)
3. **법적 요건 충족:** 18세 이상 성인 증인 2명의 서명(지정된 의료 대리인 제외) 또는 공증인·변호사 앞 서명 중 하나를 선택 하면 됩니다.
 - 공증은 의무가 아닙니다.

4. **보관 및 공유:** 사본을 주치의, 가족, 그리고 지정된 의료 대리인에게 전달합니다

- 원본은 쉽게 찾을 수 있는 곳에 보관하세요.
- **잠금 장치가 있는 금고나 안전금고(Safe Deposit Box)에는 보관하지 마세요.**

POLST: 공식 의료 명령서

POLST(Practitioner Orders for Life-Sustaining Treatment)는 연명의료계획서 같이 사전 의료 지시서(Advance Directive)와 함께 사용되는 **실제 의료 지시서(Medical Order)**입니다. 사전 의료 지시서가 본인의 “희망 사항”을 담은 문서라면, POLST는 그 희망 사항을 바탕으로 **담당 의사(또는 전문 간호사·의사 보조원)가 서명한 공식 의료 명령서**입니다. 응급 상황에서 구급대원, 응급실 의료진, 요양원 직원 등 누구든 즉시 확인하고 따를 수 있는 구속력 있는 문서입니다.

***POLST는 사전 의료 지시서나 연명의료계획서를 대체하지 않습니다. 사전 의료 지시서로 큰 방향을 정하고, POLST로 응급 현장에서 즉시 적용 가능한 구체적 지시를 명확히 합니다.**

언제 POLST가 필요한가요?

POLST는 모든 사람이 작성하는 문서가 아닙니다. 다음에 해당하는 경우 주치의와 상담을 권장합니다.

- 중증 만성 진행성 질환자 또는 기대 여명 5년 미만인 경우
- 뇌성마비 또는 통탄케어 시설에 입소할 예정인 경우
- 자택 호스피스 서비스를 받고 있는 경우
- 고령으로 인해 응급 상황의 가능성이 높아진 경우

의료 처치 범위 코드

- **전체 소생술 시행(Full Code)**
 - 심장 정지나 호흡 중단 시 가능한 모든 소생 처치를 시행합니다.
 - 심폐소생술(CPR), 인공호흡기, 제세동기 등을 포함
 - 별도의 지시가 없을 경우 병원의 기본 처치입니다.
- **심폐소생술 거부(DNR-Do Not Resuscitate)**
 - 심장이 멈추거나 호흡이 중단되었을 때 CPR을 시행하지 않도록 지시합니다.
 - 단, 그 외 치료(산소 공급, 약물 투여, 통증 완화 등)는 계속됩니다.
- **삽관 거부(DNI-Do Not Intubate)**
 - 기도에 튜브를 삽입해 인공호흡기에 연결하는 처치(기관삽관)를 거부합니다.
 - DNR과 별개로 지정할 수 있으며, DNI만 지정한 경우 CPR은 시행될 수 있습니다.
- **입원 거부(DNH-Do Not Hospitalize)**

- 응급 상황이 발생해도 병원 입원 없이 현재 거주지(주택, 널싱홈 등)에서 완화 치료(Comfort Care)를 받도록 지시합니다.
- 주로 호스피스 환자나 널싱홈 거주 환자에게 적용됩니다.

작성된 POLST 양식(초록색 용지)은 눈에 잘 띄는 곳(냉장고 문, 침대 옆, 등)에 보관하고, 사본을 의료 대리인에게 전달하세요.

문의

기관명	주요 지원 내용	연락처
뉴저지 ADRC	카운티별 노인·장애인(18세 이상)·가족 돌봄 제 공사 서비스 연결 및 상담	1-877-222-3737 (전 카운티 노인·장애인 서비스 통합 안내) *전화 시 자동으로 거주 카운티 담당자에게 연결
버겐 카운티 노인국 (Bergen County Division of Senior Services)	정보 제공 및 법률 서비스 리퍼럴	One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601 201-336-7400 seniors@bergencountynj.gov
NNJLS (북부 뉴저지 법률 서비스)	저소득·시니어·장애인 대상 무료 법률 지원 (소 득 기준 적용)	190 Moore Street, Suite 100, Hackensack, NJ 07601 201-487-2166 NNJLS.ORG
LSNJ (뉴저지 대표 법률 지원 핫라인)	무료 법률 상담 및 정보 제공	1-888-576-5529 lsnjlawhotline.org

참고 자료

- Medlineplus.gov – Advance Care Directive 개요
- NJ.gov – Advance Directive 개요
- NJ.gov – Living Will (Instruction Directive) 공식 양식(PDF)
- [NJ 211.org](http://NJ211.org)–주거·의료·법률 등 NJ 사회 복지 서비스 통합 검색 포털
- [Five Wishes](#)
- [Five Wishes – 양식 샘플 \(PDF\)](#)
- NJ.gov – POLST 설명

메디케이드 트러스트 (Medicaid Trusts)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 구체적인 신청은 반드시 전문 변호사 또는 자산 관리 전문가와 상담하시기 바랍니다.

메디케이드 신탁(Medicaid Trusts)은 시니어나 장애를 가진 개인이 정부 혜택 자격을 유지하면서도 자산을 안전하게 보호하고 관리할 수 있도록 돕는 법적 장치입니다. 목적과 상황에 따라 적절한 신탁 유형을 선택하는 것이 중요합니다.

주요 특징

- **취소 가능 신탁 (Revocable Trusts):** 설정자가 언제든지 수정·해지 가능하여 유연성이 높고 검인 절차 회피에 유용합니다. 단, 메디케이드 자격 심사에서는 자산으로 간주되므로 메디케이드 자산 보호 목적에는 적합하지 않습니다.
- **취소 불가능 신탁 (Irrevocable Trusts):** 한번 설정하면 원칙적으로 수정이나 취소가 불가능한 신탁입니다. 본인에게 지급될 가능성이 있는 부분은 여전히 자산으로 간주될 수 있으나, 올바르게 설정할 경우 **메디케이드 자격 확보를 위한 자산 보호**에 매우 효과적입니다.
- **풀드 신탁 (Pooled Trusts):** 비영리 단체가 관리하는 신탁으로, 모든 연령의 장애인이 이용 가능합니다. 여러 가입자의 자산을 공동으로 투자하여 수익을 높이되, **계좌는 개별적으로 관리**됩니다. 뉴저지에서 소득이 메디케이드 상한을 초과하는 경우에는 별도의 자격 소득 신탁(QIT/Miller Trust)을 사용합니다. 풀드 신탁은 주로 장애인의 자산을 보호하여 메디케이드 자격을 유지하면서 삶의 질을 높이는 데 활용됩니다.
 - 모든 연령의 장애인이 이용 가능하나, 65세 이상이 자산을 이전하는 경우 메디케이드 룩백 패널티(Look-back Penalty)가 적용될 수 있으므로 반드시 전문가와 상담하세요.
- **자격 소득 신탁 (Qualified Income Trust, QIT / Miller Trust):** 뉴저지에서 월 소득이 메디케이드 상한 \$2,982(2026년 기준)을 초과하는 경우, 초과 소득을 QIT에 예치하여 메디케이드 자격을 유지할 수 있습니다.

*매년 변경, [뉴저지 DHS](#) 최신 기준 확인 권장

장점

- **자산 보호:** 고가의 치료비나 간병비로 인해 재산이 소진되는 것을 방지하고 후대에 자산을 상속할 수 있는 기반을 마련합니다.
 - 메디케이드는 55세 이후 제공된 서비스 비용을 수혜자 사망 후 유산에서 회수할 수 있습니다.
 - 단, 배우자 생존 중이거나 21세 미만·장애 자녀가 있는 경우 회수가 연기됩니다.
 - 적절한 신탁 설정은 이 회수로부터 자산을 보호하는 데도 도움이 됩니다.
 - **수혜 자격 유지:** 메디케이드의 엄격한 자산 및 소득 제한 규정을 준수하면서도 필요한 복지 혜택을 받을 수 있도록 돕습니다.
 - 2026년 기준: 개인 자산 한도 \$2,000 · 소득 한도 월 \$2,982
- *매년 변경, [뉴저지 DHS](#) 최신 기준 확인 권장

- **전문적인 관리:** 특히 풀드 신탁의 경우 전문 비영리 단체가 자산을 관리하므로 투명하고 안정적인 운영이 가능합니다.
- **장기 요양 계획:** 룩백 기간(Look-back Period)은 롱텀케어 메디케이드(MLTSS) 신청 시점으로부터 과거 60개월(5년) 간의 자산 이전 내역을 심사하는 기간입니다. 이 기간 내에 공정 시장 가치 이하로 자산을 이전하면 수혜 지연 패널티가 부과됩니다. 이를 고려해 사전 계획이 필요합니다.

이용 및 설정 절차

1. **전문가 상담:** 전문 변호사를 통해 본인의 자산 상황과 메디케이드 수혜 가능성을 정밀 분석합니다.
2. **신탁 유형 결정:** 자산 규모, 건강 상태, 가족 구성원의 필요에 맞는 최적의 신탁 모델을 선택합니다.
3. **법적 문서 작성 및 공증:** 신탁 유형에 따라 법적 요건이 다릅니다. 일반 신탁은 공증이 권장되며, QIT(자격 소득 신탁)는 뉴저지 DHS 승인 양식 작성 및 별도 은행 계좌 개설이 필요합니다.
4. **자산 이전 (Funding):** 부동산, 예금 등의 자산을 신탁 계좌로 명의 변경하여 신탁 설정을 완료합니다.

문의

기관명	주요 지원 내용	연락처
뉴저지 ADRC	카운티별 노인·장애인(18세 이상)·가족 돌봄 제 공사 서비스 연결 및 상담	1-877-222-3737 (전 카운티 노인·장애인 서비스 통합 안내) *전화 시 자동으로 거주 카운티 담당자에게 연결
버겐 카운티 노인국 (Bergen County Division of Senior Services)	정보 제공 및 법률 서비스 리퍼럴	One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601 201-336-7400 seniors@bergencountynj.gov
NNJLS (북부 뉴저지 법률 서비스)	저소득·시니어·장애인 대상 무료 법률 지원 (소 득 기준 적용)	190 Moore Street, Suite 100, Hackensack, NJ 07601 201-487-2166 NNJLS.ORG
LSNJ (뉴저지 대표 법률 지원 핫라인)	무료 법률 상담 및 정보 제공	1-888-576-5529 lsnjlawhotline.org

참고 자료

- NJ.gov – Qualified Income Trusts
- [NJ.gov – Estates and Trusts \(PDF\)](#).

위임장 (Power of Attorney, POA)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 구체적인 상담은 반드시 전문가나 공식 기관과 하시기 바랍니다.

위임장(Power of Attorney)은 본인(위임인)이 신체적·정신적 사유 또는 부재 등의 이유로 직접 결정을 내릴 수 없을 때, 신뢰할 수 있는 제3자(대리인)에게 본인을 대신하여 법적·금융적·의료적 권한을 행사할 수 있도록 자격을 부여하는 법적 문서입니다. 이는 예기치 못한 상황에 대비하여 본인의 의사를 보호하고 권익을 유지하기 위한 필수적인 절차입니다.

*뉴저지 법상 대리인은 뉴저지주 위임장 관련 법령에 따라 반드시 **만 18세 이상 성인**이어야 하며, 법적으로 판단 능력이 있는 자여야 합니다.

주요 특징

- **유연한 설정:** 특정 기간 동안만 유효한 **일시적 위임**이나, 특정 조건 하에서만 발동되는 위임 등 목적에 맞게 설정할 수 있습니다.
- **수정 및 철회:** 위임인은 법적인 판단 능력이 있는 한 언제든지 서면으로 위임을 수정·철회할 수 있으며, 이를 대리인 및 관련 기관에 통보해야 합니다.
- **법적 지속성:** 뉴저지와 뉴욕에서는 위임장의 경우 위임인이 판단 능력을 잃으면 효력이 소멸됩니다. (주마다 상이)
 - 따라서 위임인의 판단 능력 상실 후에도 효력이 지속되도록 하려면 반드시 **지속적 위임장(Durable POA)** 임을 문서에 명시해야 합니다.

대리인의 주요 권한

- **재정 및 법률 관련 결정:** 은행 계좌 관리, 자산 매매, 세금 신고, 계약 체결 등.
- **건강 및 의료 관련 결정:** 치료 방법 선택, 수술 동의, 병원 입퇴원 결정 등 (Medical POA).
 - 뉴저지에서는 의료 위임장을 **Proxy Directive (Durable Power of Attorney for Health Care)**라 하며, 이는 **사전 의료 지시서(Advance Directive)**의 일부입니다.
- **돌봄 및 간병 관련 결정:** 일상적인 거주지 결정 및 개인 복지 서비스 선택.
- **교육 관련 결정:** 미성년 자녀 또는 본인의 교육 서비스 및 학업 관련 권한 대행.
- **여행 및 일정 관리:** 여행 계획 수립, 여권 관리 및 이동 관련 행정 처리.

위임장 작성 시 주의사항

- **신뢰성:** 위임인은 본인의 이익을 최우선으로 고려해야 하므로, 가장 신뢰할 수 있는 인물을 대리인으로 선택해야 합니다. 위임인(위임장을 작성하는 본인)도 만 18세 이상이며, 작성 당시 판단 능력 있는 상태여야 합니다.
- **공증 필요:** 뉴저지주에서 금융 위임장(Financial POA)은 반드시 공증인(Notary Public) 앞에서 서명해야 법적 효력이 발생합니다. 의료 위임장(Proxy Directive)의 경우 성인 증인 2명 또는 공증이 필요합니다.

- **유효 기간:** 위임인이 사망하면 위임장 효력은 즉시 종료됩니다. 이후 자산 처리 등은 유언장(Will) 또는 유산 절차(Estate Process)를 통해 진행됩니다.

*Financial POA 작성 시 참고용 공식 양식은 별도 없으며, 전문가 상담 권장

문의

기관명	주요 지원 내용	연락처
뉴저지 ADRC	카운티별 노인·장애인(18세 이상)·가족 돌봄 제 공사 서비스 연결 및 상담	1-877-222-3737 *전화 시 자동으로 거주 카운티 담당자에게 연결
버겐 카운티 노인국 (Bergen County Division of Senior Services)	정보 제공 및 법률 서비스 리퍼럴	One Bergen County Plaza, 2nd Floor, Hackensack, NJ 07601 201-336-7400 seniors@bergencountynj.gov
NNJLS (북부 뉴저지 법률 서비스)	저소득·시니어·장애인 대상 무료 법률 지원 (소 득 기준 적용)	190 Moore Street, Suite 100, Hackensack, NJ 07601 201-487-2166 NNJLS.org
LSNJ (뉴저지 대표 법률 지원 핫라인)	무료 법률 상담 및 정보 제공	1-888-576-5529 lsnjlawhotline.org

참고 자료

- [NJ 보건부 — 사전 의료 지시서\(Proxy Directive\) 공식 양식 \(PDF\)](#).
- NJ211.org: 시니어 법률 지원 서비스 검색 포털

역이민 (영주귀국 및 국적 회복)

본 내용은 정보 제공만을 목적으로 합니다. 구체적인 절차와 법적 효력은 반드시 대한민국 재외동포청, 출입국관리사무소 및 관련 전문가와 상담하시기 바랍니다.

역이민이란 해외에 거주하던 재외동포가 생활 근거지를 다시 대한민국으로 옮겨 정착하는 과정을 의미합니다. 법적으로는 '영주귀국' 신고와 '국적 회복' 절차를 포함하며, 이에 따른 세무, 의료보험, 복지 혜택의 변화를 사전에 파악하는 것이 중요합니다.

어떤 상황에서 무엇이 유리한가요?

이런 분들에게 '복수국적' 유지가 유리합니다.

- 미국 연금을 수령하시는 분: SSA 연금을 안정적으로 받으면서 한국의 저렴한 우수한 의료 서비스를 누리고 싶은 경우.
- 자녀가 미국에 거주하는 분: 가족 방문을 위해 언제든 미국에 장기 체류할 가능성이 있는 경우.
- 미국 내 자산이 있는 분: 미국 내 부동산이나 투자 자산의 관리 및 상속이 필요한 경우.

이런 분들에게 '신분 포기'가 유리합니다.

- 자산 규모가 큰 분: 미국 세법의 복잡한 보고 의무와 이중 과세 부담을 완전히 덜어내고 싶은 경우. (단, 포기세 진단 필수)
- 미국 재입국 의사가 없는 분: 건강이나 개인 사정으로 더 이상 미국으로 돌아갈 계획이 전혀 없는 경우.
- 한국 내 독점적 혜택 희망: 공직 진출이나 특정 국가 보안 관련 업무 등 외국 국적이 걸림돌이 되는 특수 상황.

절차

- 영주귀국 신고: 재외국민이 한국에 영주할 목적으로 귀국했을 때 체류지 관할 출입국·외국인 관서에 신고하는 절차
- 국적 회복(만 65세 이상): 미국 시민권자인 경우, 만 65세 이후 한국에 입국하여 '외국국적불행사 서약'을 통해 한국 국적을 회복하고 복수국적을 유지할 수 있음
- 거소증(국내거소신고증) 발급: 국적 회복 전 혹은 시민권자 신분으로 장기 체류 시 한국 내 주민등록증을 대신하여 금융, 의료 거래에 사용

검토 분야

*아래 포기세 항목 및 최종 세금 보고, 공식 포기 절차, 한국 국적 확인 절차는 <2. 미국 신분 포기 상황>에 해당하는 내용입니다. <1. 미국 시민권 유지 상황>, <3. 미국 영주권 유지 상황>에는 해외금융계좌 보고(FBAR/FATCA) 및 이중과세 항목이 공통 적용됩니다.

1. 세무 및 자산 관리(Taxation)

- **미국 국적 포기세(Expatriation Tax):** 일정 자산 규모 이상의 시민권자가 국적을 포기할 때 발생할 수 있는 세무 의무를 점검해야 합니다.
 - **순자산 기준:** 포기 시점 순자산 \$2,000,000 이상
 - **소득세 기준:** 포기 전 5년간 연평균 미국 세액 초과 (2025년 \$206,000 / 2026년 \$211,000 — 매년 조정)
 - **신고 의무 미이행:** 포기 전 5년간 미국 세금 신고 의무를 이행하지 않은 경우
 - *자산이 적어도 적용되므로, 반드시 5년치 신고 이행 여부를 사전에 확인 필요*
- **해외금융계좌 보고 (FBAR/FATCA):** 한국으로 이주 후에도 미국 시민권이나 영주권을 유지하는 경우, 한국 내 계좌 정보를 매년 미국 국세청(IRS)에 보고해야 합니다.
 - **포기 전:** 포기 연도까지의 미국 세금 신고를 최신 상태로 유지합니다.
 - **해외금융계좌 보고(FBAR) 및 FATCA 보고 의무도 포기 시점까지 이행합니다.**
- **한미 이중과세 방지:** 연금이나 임대 소득에 대해 어느 국가에 세금을 납부할지 한미 조세조약에 따른 전문가 상담이 필수적입니다.

2. 최종 세금 보고(포기 다음 해)

- **Form 8854(Initial and Annual Expatriation Statement)**를 IRS에 제출합니다. 이 서류가 제출되어야 미국과의 세금 관계가 공식적으로 종료됩니다.
 - *Form 8854를 미제출할 경우 연간 \$10,000의 벌금이 부과될 수 있으며, 미국 세금 의무가 지속됩니다.*

3. 공식 포기 절차

- **시민권자의 경우:**
 - 주한 미국 대사관(또는 미국 내 영사관)을 예약하여 국적 포기 면담을 진행 (대기 수개월 소요 가능)
 - 포기의 법적 의미와 결과를 충분히 이해했는지 영사 면담을 통해 확인
 - **공식 국적 포기 선서(Oath of Renunciation)**를 진행하고 **국적 포기 증서(Certificate of Loss of Nationality, CLN)**를 수령합니다.
 - **수수료:** \$450 (2026년 4월 13일부 적용 – 이전 \$2,350에서 인하)
- **영주권자의 경우:**
 - **I-407(Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status)** 양식을 작성하여 이민국 또는 주한 미국 대사관에 제출합니다.
 - 별도의 면담 없이 서류 제출만으로 처리되며, 영주권 카드(Green Card)를 함께 반납합니다.

4. 한국 국적 확인 또는 회복

- **이미 한국 국적을 보유하고 있는 경우:** 별도 절차 없이 주민등록 복구 신청
- **한국 국적이 상실된 경우:** 출입국관리사무소 또는 재외동포청에 국적 회복 신청(소요 기간 약 6개월~1년)
- 주민센터에서 주민등록증을 발급받고 건강보험 등 복지 혜택 신청을 시작합니다.

5. 의료보험 및 복지 혜택

- **국민건강보험:** 한국 입국 후 일정 기간(보통 6개월) 체류하거나, 영주귀국 신고 후 즉시 가입 자격을 얻을 수 있습니다.
- **기초연금 및 노인 복지:** 한국 국적 회복 후 주민등록이 완료되면 소득 기준에 따라 기초연금, 지하철 무임승차 제도 등 시니어 복지 혜택을 받을 수 있습니다.

6. 소셜 시큐리티 수령

- 한국에 거주하더라도 자격 요건을 갖춘 경우 미국 소셜 시큐리티를 계속 수령할 수 있습니다.
 - 단, 시민권자와 영주권자의 수령 조건이 다를 수 있으므로 SSA(Social Security Administration)와의 확인이 필요합니다.

7. 거주지 마련 및 이사

- **이사화물 면세:** 해외 거주 1년 이상이며 귀국 후 6개월 이내 반입하는 경우 면세 대상이 될 수 있습니다. 세부 요건은 관세청(1544-1285 / customs.go.kr)에 사전 문의

주의 사항

- **서류 준비의 철저함:** 미국에서 발행된 출생증명서, 혼인관계증명서, 범죄경력증명서(FBI Check) 등은 반드시 **아포스티유(Apostille)** 인증을 받아야 한국 기관에서 효력을 발휘합니다.
- **영주권 유지 여부:** 영주권자가 한국에 장기 체류할 경우 미국 영주권 의사가 없는 것으로 간주될 수 있으므로, 재입국 허가서(Re-entry Permit) 신청 여부를 결정해야 합니다.
- **신분증의 공백:** 국적 회복 과정 중 미국 여권과 한국 신분증 사이의 행정적 공백 기간을 고려하여 금융 거래 등을 미리 정리해야 합니다.

역이민 상황별 비교

상황 1. 미국 시민권 유지 & 대한민국 국적 회복 (복수국적)

미국 국적을 취득하여 한국 국적이 상실되었으나, 미국 시민권을 유지하면서 다시 한국 국적을 회복하는 경우

주요 절차

1. 사전 준비(출국 3~6개월 전):

- **FBI 범죄경력증명서 발급:** FBI로부터 범죄경력증명서를 발급받은 후, 반드시 미 국무부의 아포스티유(Apostille) 인증을 받아야 합니다. (유효기간 6개월)
- **서류 준비:** 시민권 증서, 혼인관계증명서 등 주요 서류의 원본과 사본을 준비합니다.
- **세무 점검:** 한국 거주 중에도 미국 세금 신고(IRS)와 해외금융계좌 보고(FBAR/FATCA) 의무가 지속됨을 인지하고 CPA와 상담합니다.
- **미국 내 자산 정리:** 은행 계좌 유지 여부, 부동산 처분, 우편물 수령지 변경(포워딩 서비스) 등을 완료합니다.
- **SSA 해외 수령 준비:** 미국 연금의 한국 내 수령 계좌(외화 통장 등)를 미리 구상해 둡니다.

2. 한국 입국 및 국적 상실 신고:

- **미국 여권으로 입국:** 한국 입국 시에는 반드시 미국 여권을 사용합니다. (무비자 입국 시 통상 90일 체류 가능)

- **국적 상실 신고:** 과거 시민권 취득 시 상실된 한국 국적을 행정적으로 정리하는 절차입니다. 관할 출입국관리사무소 또는 재외동포청 서비스 센터를 방문합니다.
- 가족관계등록부가 정리되지 않은 경우 국적 회복 절차를 시작할 수 없습니다.

3. 거소증 발급 및 국적 회복 신청 (만 65세 이상)

- **F-4(재외동포) 비자 및 거소신고:** 한국 내에서 장기 체류하며 금융·의료 서비스를 이용하기 위해 거소증(국내거소신고증)을 먼저 발급받습니다.
- **국적 회복 신청:** 거소증 발급 후 출입국관리사무소에 국적 회복 신청서를 제출합니다.
- **소요 기간:** 약 6개월~1년 소요 (법무부 처리량에 따라 변동)
- **국적 회복 허가 통지:** 법무부로부터 허가 통지서를 받으면 관할 읍·면·동사무소를 방문합니다.

4. 외국국적불행사 서약 및 주민등록

- **불행사 서약:** 허가 통지서를 받은 후 반드시 1년 이내에 출입국관리사무소에서 “한국 내에서는 미국 시민권자로서의 권리를 행사하지 않겠다”는 서약을 합니다.
 - 1년 기한을 초과하면 국적 회복 허가가 취소될 수 있습니다.
- **주민등록증 발급:** 서약 확인서를 가지고 주민센터를 방문하여 주민등록증을 발급받습니다. 이 시점부터 한국과 미국 여권을 모두 보유하게 됩니다.
- **거소증 반납:** 국적 회복이 완료되면 기존 거소증은 반납하며, 이후 한국 출입국 시에는 한국 여권을 사용해야 합니다.

5. 사후 정착 절차

- **건강보험 가입:** 주민등록 완료 후 즉시 건강보험공단을 방문하여 가입 자격을 확인합니다.
- **기초연금 신청:** 만 65세 이상이며 소득 기준을 충족할 경우 주민센터에서 신청합니다.
 - (2026년 기준: 단독가구 월 소득인정액 247만 원 이하. 매년 보건복지부 고시로 변경 — 최신 기준은 bokjiro.go.kr에서 확인. 미국 SSA 연금도 소득 합산 대상이 될 수 있으므로 사전 확인 필요)
- **미국 연금 해외 수령 신청:** 한국 주소와 계좌 정보를 미국 사회보장국(SSA)에 업데이트합니다.

장점	단점
양국 복지 혜택: 한국의 의료보험, 시니어 혜택(지하철 무임 등) 과 미국의 사회보장연금(SSA)을 동시에 누릴 수 있습니다.	이중 세금 신고: 한국 거주 중에도 전 세계 소득에 대해 미국 IRS에 매년 세금 신고를 해야 합니다.
거주의 자유: 비자 걱정 없이 미국과 한국을 자유롭게 왕래하고 양국에서 무기한 체류할 수 있습니다.	금융 거래 제약: FATCA(해외금융계좌신고법)로 인해 한국 내 일부 은행 이용이나 자산 관리에 복잡한 행정 절차가 따를 수 있습니다.
재산권 행사: 양국에서 부동산 취득, 상속 및 증여 시 각국의 법적 보호를 온전히 받습니다.	신분 불행사 서약: 한국 내에서는 미국인으로서의 권리를 주장할 수 없습니다.

상황 2. 미국 신분 포기 & 대한민국 시민권 유지/회복/취득

미국 시민권 또는 영주권을 완전히 포기하고 한국 국적으로만 정착하는 경우

주요 절차

1. 세무 사전 준비(출국 6개월~1년 전):

- CPA 또는 세무 전문가와 상담하여 아래 세 가지 기준 중 하나라도 해당하는지 확인합니다. 하나라도 해당하면 '적용 대상(Covered Expatriate)'으로 분류되어 포기세가 부과될 수 있습니다.
 - **순자산 기준:** 포기 시점 순자산 \$2,000,000 이상
 - **소득세 기준:** 포기 전 5년간 연평균 미국 세액 초과(2025년 \$206,000 / 2026년 \$211,000 – 매년 조정)
 - **신고 의무 미이행:** 포기 전 5년간 미국 세금 신고 의무를 이행하지 않은 경우
 - 자산이 적어도 적용되므로, 반드시 5년치 신고 이행 여부를 사전에 확인 필요

2. 미국 세금 신고 완료(포기 전)

- **해외금융계좌 보고 (FBAR/FATCA):** 포기 연도까지의 미국 세금 신고를 최신 상태로 유지하고, 해외금융계좌 보고 (FBAR) 및 FATCA 보고 의무도 포기 시점까지 이행합니다.

3. 공식 포기 절차

- **시민권자의 경우:**
 - 주한 미국 대사관(또는 미국 내 영사관)을 예약하여 국적 포기 면담을 진행 (대기 수개월 소요 가능)
 - 포기의 법적 의미와 결과를 충분히 이해했는지 영사 면담을 통해 확인
 - **공식 국적 포기 선서(Oath of Renunciation)**를 진행하고 **국적 포기 증서(Certificate of Loss of Nationality, CLN)**를 수령합니다.
 - **수수료:** \$450 (2026년 4월 13일부 적용 – 이전 \$2,350에서 인하)
- **영주권자의 경우:**
 - **I-407(Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status)** 양식을 작성하여 이민국 또는 주한 미국 대사관에 제출합니다.
 - 별도의 면담 없이 서류 제출만으로 처리되며, 영주권 카드(Green Card)를 함께 반납합니다.

4. 최종 세금 보고(포기 다음 해)

- **Form 8854(Initial and Annual Expatriation Statement)**를 IRS에 제출합니다. 이 서류가 제출되어야 미국과의 세금 관계가 공식적으로 종료됩니다.
 - *Form 8854를 미제출할 경우 연간 \$10,000의 벌금이 부과될 수 있으며, 미국 세금 의무가 지속됩니다.*

5. 한국 국적 확인 또는 회복

- **이미 한국 국적을 보유하고 있는 경우:** 별도 절차 없이 주민등록 복구 신청
- **한국 국적이 상실된 경우:** 출입국관리사무소 또는 재외동포청에 국적 회복 신청(소요 기간 약 6개월~1년)
- 주민센터에서 주민등록증을 발급받고 건강보험·기초연금 등 복지 혜택을 신청합니다.

장점	단점
세무 의무 종료: 더 이상 미국 IRS에 소득 신고나 해외 금융계좌(FBAR) 보고를 할 필요가 없습니다.	미국 재입국 제약: 향후 미국 방문 시 무비자(ESTA) 또는 방문 비자를 받아야 하며, 체류 기간에 제한이 생깁니다.
행정적 간소화: 한국인으로서의 신분만 관리하면 되므로 금융 및 부동산 거래가 단순해집니다.	포기세 (Exit Tax): 자산 규모가 큰 경우, 신분 포기 시점에 자산을 양도한 것으로 간주하여 세금이 부과될 수 있습니다.
정서적 안정: 한국 사회의 완전한 구성원으로서 정착하는 느낌을 줍니다.	복구 불가능: 한 번 포기한 시민권은 나중에 다시 되찾기가 매우 어렵습니다.

상황 3. 미국 영주권 유지 & 대한민국 시민권 유지/회복/취득

미국 영주권자가 한국으로 돌아가되, 영주권 신분을 유지하는 경우입니다.

주요 절차

1. 재입국 허가서(Re-entry Permit) 신청 (출국 전 필수)

- **I-131(Application for Travel Document)**을 미국내에서 USCIS에 신청합니다.
- 반드시 한국 출국 전, 미국에 있는 동안 신청해야 합니다. 지문 채취(Biometrics) 예약까지 완료한 후 출국해야 하며, 출국 후에는 신청이 불가합니다.
- 유효기간은 통상 2년이며, 이 기간 내에 미국에 재입국해야 영주권이 유지됩니다.
 - 재입국 허가서를 받지 않고 1년 이상 해외 체류 시 영주권을 잃을 수 있습니다.

2. 한국 입국 및 영주귀국 신고

- 재입국 허가서를 지참하고 한국에 입국합니다.
- 체류지 관할 출입국관리사무소 또는 재외동포청 서비스 센터에 **영주귀국 신고**를 합니다.
- 영주귀국 신고 후 '재외국민'에서 '거주자'로 신분이 변동되며 주민등록이 복구됩니다.
 - 영주권자는 일반 주민등록증이 아닌 **재외국민 주민등록증**을 사용하게 되며, 일부 행정 서비스에서 차이가 있을 수 있습니다.

3. 건강보험 및 복지 혜택 가입

- 주민등록 복구 즉시 **국민건강보험 가입**이 가능합니다.
- 만 65세 이상이며 소득 기준을 충족하면 주민센터에서 **기초연금 신청**이 가능합니다.
 - 미국 SSA 연금도 한국내 소득으로 합산될 수 있으므로 기초연금 수급 여부는 사전 확인이 필요합니다.

4. 미국 세무 의무 지속 이행

- 영주권자는 한국 체류 중에도 미국 세법상 거주자 지위를 유지합니다.
- 한국에서 발생한 소득(근로소득, 임대소득, 연금 등)도 미국 IRS에 신고해야 합니다.
- 한국 내 금융계좌 잔액 합산이 연중 최고액 기준 **\$10,000 이상**이면 **FBAR(FinCEN Form 114)** 보고 의무가, **FATCA** 기준에 해당하면 **Form 8938** 신고 의무가 지속됩니다.

- **FATCA 기준:** 한국 거주 개인 신고자의 경우 연말(12월 31일) \$200,000 이상 또는 연중 \$300,000 이상이면 **Form 8938** 신고 의무 발생 (미국 내 거주자 기준 \$50,000/\$75,000과 다름 — 결혼 여부 신고 방법에 따라 기준 상이, IRS 또는 CPA 확인 권장)

5. 재입국 허가서 갱신 및 장기 계획

- 유효기간(2년) 만료 전에 미국에 입국하여 영주권 유지 사실을 확인받아야 합니다.
- 필요 시 미국 체류 중 새 재입국 허가서(I-131)를 재신청합니다.
 - 반복 갱신 시 이민국이 “실질적 거주 의사 없음”으로 판단하여 영주권을 박탈할 위험이 있습니다. 장기적으로는 **시민권 취득** 또는 **영주권 포기(상황 2)** 중 하나를 선택하는 것이 현실적입니다.

장점	단점
미국 거주권 보존: 나중에 다시 미국으로 돌아가 살고 싶을 때를 위한 대비책(Backup Plan)이 됩니다.	유지의 어려움: 2년마다 재입국 허가서(Re-entry Permit)를 갱신해야 하며, 계속 반복할 경우 영주권이 박탈될 위험이 있습니다.
한국 건강보험: 영주귀국 신고를 통해 한국 건강보험 혜택을 즉시 받을 수 있습니다.	모호한 신분: 한국에서는 '재외국민'으로 분류되어 주민등록증 대신 재외국민 주민등록증을 사용하게 됩니다.
	이중 세무 의무: 한국 체류 중에도 미국 IRS에 소득 신고와 해외금융계좌 보고(FBAR 및 FATCA 보고) 의무가 지속됩니다.

주요 기관 및 문의

	문의 기관	주요 내용	연락처
한국 정부 기관	재외동포청 (OKA)	영주귀국, 국적회복, 재외동포 서비스 종합 안내 (2023년 신설)	oka.go.kr +82-2-6747-0404
	하이코리아 (Hi Korea)	법무부. 국내거소신고, 출입국 관리, 비자 관련 정보 및 온라인 신청.	hikorea.go.kr 국번없이 1345
	주뉴욕 대한민국 총영사관	국적 상실/회복 신고, 아포스티유(Apostille) 인증, 여권 업무.	overseas.mofa.go.kr/us-newyork-ko/index.do 646-674-6000
	국민건강보험공단 (NHIS)	재외동포 건강보험 가입 및 자격 문의. 귀국 후 즉시 가입 가능 여부 확인.	nhis.or.kr +82-1577-1000
미국 연방 기관	미국 사회보장국 (SSA)	해외 거주자 연금 수령 자격 및 한국 계좌 송금 신청 문의.	ssa.gov/foreign 800-772-1213
뉴저지 한인 커뮤니티	뉴저지 한인회 (KAANJ)	1975년 설립 비영리 501(c)(3). 역이민 한인 커뮤니 티 연결, 생활 정착 지원, 지역 자원 안내.	21 Grand Ave. #216-B, Palisades Park, NJ 07650 201-945-9456 kaanj.org/

시니어 교통 서비스 (Senior Transportation)

시니어를 위한 교통 지원은 시니어들에게 안전하고 편리한 이동 수단을 무료 또는 저렴하게 제공하는 서비스입니다. 이를 통해 시니어들이 독립적인 생활을 유지하고 사회적 고립을 방지하며 의료 기관 방문이 용이하도록 도움을 주고 있습니다.

주요 특징

- **도어 투 도어(Door-to-Door)**
 - **맞춤형 픽업:** 집앞에서 목적지까지 안전하고 편리하게 이동할 수 있습니다.
 - **보조 지원:** 승하차 시 운전기사의 부축이나 휠체어 리프트 등을 요청할 수 있습니다.
- **비용 혜택**
 - **무료 이용:** 카운티나 타운 셔틀 이용료는 대부분 무료이거나 소정의 기부금(Suggested Donation)을 받습니다.
 - **저렴한 비용:** 민간 교통 단체들은 저렴한 비용으로 서비스를 제공합니다.
- **예약제 서비스**
 - **스케줄 예약:** 미리 예약해야 하며 정해진 시간에 맞춰 차량이 도착하고 출발합니다.
 - **모니터링 시스템:** 일부 서비스는 실시간 차량 위치 확인이 가능하여 가족이나 보호자가 시니어의 이동 과정을 지켜볼 수 있습니다.

버겐 카운티 주요 교통 서비스 안내

서비스 구분	버겐 카운티 직영 셔틀 (Community Transportation)	EZ Ride (비영리 교통관리협회·TMA)	NJ Transit (공공 대중교통)	타운 시니어 셔틀 (거주지 전용)
대상	60세 이상 시니어 / 18세 이상 장애인 / 재향군인	18세 이상 성인	Reduced Fare: Seniors (62+). Access Link: Individuals with disabilities unable to use fixed-route transit.	Seniors residing in the specific municipality.
서비스 안내	시니어 센터, 병원, 슈퍼마켓, 등.	Uber/Lyft 차량, 자체 셔틀 차량 제공	버스, 기차, 경전철(Light Rail) 등 주 전역 이동 / 장애인용 Access Link 차량 제공 *MicroLink 는 현재 파일럿 서비스 중에 있습니다.	시니어 센터, 병원, 슈퍼마켓, 몰 등 지역 내 순환
비용	무료	유료 (할인가격)	Reduced Fare: 버스·기차 50% 할인 Access Link: 별도 유료(버스 요금 기준, Reduced Fare 카드 사용 불가)	무료 (또는 소정의 기부금)
이용 방법	카운티 교통국 사전 등록 및 예약	사전 등록 후 전화: 201-939-4242 ext.4 *실시간 요청 *예약 불필요	Reduced Fare: 시니어 ID 또는 Medicare Card 제 시 Access Link: 사전 예약 필수 (973-491-4224)	거주지 시청(Town Hall)에 노선 및 시간 문의
연락처	201-368-5955	201-939-4242	Reduced Fare: 973-275-5555 Access Link: 973-491-4224	Fort Lee: 201-592-3500 ext. 1518 Palisades Park: 201-585-4114 Teaneck: 201-837-7130 ext. 7040

*NJ Transit의 MicroLink(집에서 버스 정류장까지 이동) 프로그램은 현재 무료 파일럿 서비스 중에 있습니다. 자세한 내용은 [공식 페이지](#) 를 참조하세요.

참고 사항

- **사전 예약:** 대부분의 카운티 및 시 운영 서비스는 최소 며칠~2주전 예약이 필요합니다.
- **경유지 확인:** 카운티나 지역 셔틀은 해당 지역내에서만 운영합니다.
- **동승자 정책:** 휠체어 사용 여부나 보호자 동반의 경우 사전 예약 시 반드시 알려야 합니다.

참고 자료

- [NJ DOT — 뉴저지 교통관리협회\(TMA\) 디렉토리](#)
- [NJ Transit — 시니어·장애인 할인 요금 프로그램 \(Reduced Fare\)](#)
- [NJ.gov — 장애인·시니어 교통 서비스 신청 안내](#)
- [EZRide.org Bergen County Mobility Guide \(PDF\)](#)
- [NJ Transit Access Link — 장애인 대중교통 대체 서비스](#)
- [버겐 카운티 커뮤니티 교통 서비스 안내 가이드 \(2025 PDF\)](#)
- [NJ 211 — 뉴저지 교통 서비스 종합 안내](#)

유언장 (Will)

본 콘텐츠는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 구체적인 상담은 반드시 전문가나 공식 기관과 하시기 바랍니다.

유언장(Will)은 본인의 사후에 자산 배분, 미성년 자녀의 양육권, 집행인 지정 등 개인의 최종 의사를 법적으로 명시하는 문서입니다. 유언장을 통해 남겨진 가족 간의 혼란과 분쟁을 방지하고 법원이 아닌 본인의 의지에 따라 유산이 관리되도록 합니다.

만 18세 이상이며 정신적으로 판단 능력이 있는 성인은 누구든지 유언장을 작성할 수 있습니다.

주요 특징

- **자산 분배의 명확성:** 부동산, 은행 계좌, 개인 소장품 등 모든 자산의 수혜자를 본인이 직접 지정합니다.
 - 뉴저지는 유산세(Estate Tax)가 없지만 **상속세(Inheritance Tax)**가 있습니다. 배우자, 자녀, 부모, 손자녀 등 직계 가족(Class A 수혜자)은 면제되며, 형제자매·친구 등 Class C·D 수혜자에게는 세율이 적용될 수 있습니다.

**세무 전문가와 상담을 권장*

- **미성년자 보호:** 부모 사후 미성년 자녀를 돌볼 법적 가디언(Guardian)을 미리 지정하여 자녀의 복지를 보호합니다.
- **유산 집행인(Executor) 선임:** 유언장의 내용을 성실히 이행할 신뢰할 수 있는 인물 또는 기관을 지정합니다.
- **법적 절차 간소화:** 유언장이 없을 경우 주법(Intestacy Laws)에 따라 자산이 배분되며, 법원이 상속 절차를 임의로 주관합니다. 유언장이 있으면 본인의 의사에 따라 자산이 분배되며, 이를 위해 유산 관련 **대리 법원(Surrogate Court)**를 통한 **검인(Probate)** 절차를 거칩니다.

주요 포함 항목

- **집행인 지정:** 장례 절차, 세금 납부, 자산 전달 등 유언의 전 과정을 관리할 대리인을 설정합니다.
- **수혜자(Beneficiaries) 명시:** 자산을 물려받을 개인 또는 자선 단체를 구체적으로 명기합니다.
- **가디언 설정:** 18세 미만 자녀가 있을 경우, 부모를 대신해 양육할 보호자를 지정합니다.
- **부채 및 세금 정산:** 사후 발생할 수 있는 미결제 부채나 상속세 지불 방식에 대한 지침을 포함합니다.
- **잔여 재산(Residuary Clause) 처리:** 명시되지 않은 기타 모든 재산에 대한 처리 방향을 결정합니다.

주의사항

- **자필 유언장(Holographic Will):** 서명 및 핵심 내용 전체를 자필로 작성한 경우(Holographic Will)는 증인 없이도 유효하나, 오류 위험이 있어 일반적으로 권장되지 않습니다.
- **정신적 판단 능력(Testamentary Capacity):** 작성 당시 본인이 문서의 의미를 충분히 이해하는 온전한 정신 상태여야 합니다.

- **증인 및 공증:** 뉴저지 법에 따라 유언장에는 반드시 2명의 성인 증인 서명이 필요합니다.
 - 공증은 의무가 아니지만, 공증을 통해 '자기 증명 유언장(Self-Proving Will)'으로 등록하면 사후 검인 절차에서 증인 출석이 면제되어 절차가 간소화됩니다.
 - 수혜자도 증인이 될 수 있으나, 분쟁 방지를 위해 유산을 물려받지 않는 제3자를 증인으로 선택하는 것이 권장됩니다.
- **지속적 업데이트:** 결혼, 이혼, 출산, 자산의 큰 변화가 있을 경우 내용을 수정(Codicil)하거나 새로 작성해야 합니다.
- **안전한 보관:** 원본은 안전한 곳에 보관하되, 집행인이 필요할 때 즉시 찾을 수 있도록 위치를 공유해야 합니다. **뉴저지 유언장 등록소(Will Registry)**는 자발적 등록 서비스로, 유언장의 존재 및 보관 위치를 사전에 등록해 분실·분쟁을 예방할 수 있습니다
 - **뉴저지 유언장 등록소(Will Registry):** 등록·열람 각 \$10.

문의

기관명	주요 역할 및 내용	연락처
뉴저지 유언장 등록소 (Secretary of State Will Registry)	유언장의 존재 및 보관 위치 사전 등록 자발적 등록 서비스 안내 및 신청 *등록·열람 각 \$10	우편 신청: PO Box 300, Trenton, NJ 08625-0300 (*수표 또는 머니오더 \$10 동봉) 609-777-2581 nj.gov/state/archives/catstate.html
버겐 카운티 대리법원 (Surrogate's Court)	유언장 검인(Probate), 유산 집행, 후견인 선임 등 유산 관련 법적 절차 주관 *한국어 안내 자료 제공	Two Bergen County Plaza, Suite 5000 Hackensack, NJ 07601 201-336-6700
NNJLS (북부 뉴저지 법률 서비스)	저소득·시니어·장애인 대상 무료 법률 지원 (소득 기준 적용)	190 Moore Street, Suite 100, Hackensack, NJ 07601 201-487-2166 NNJLS.ORG
LSNJ (뉴저지 대표 법률 지원 핫라인)	무료 법률 상담 및 정보 제공	1-888-576-5529 lsnjlawhotline.org

참고 자료

- NJ.gov 뉴저지 유언장 등록소
- NIH.gov – Getting Your Affairs in Order Checklist
- [NCOA\(National Council on Aging, 비영리\)](http://NCOA.org) — Estate Planning 체크리스트 및 가이드